



МЕНТАЛЬНЕ ЗДОРОВ'Я ТА ЖИТТЄСТІЙКІСТЬ ОСОБИСТОСТІ

Монографія



**АКАДЕМІЯ ПРАЦІ,
СОЦІАЛЬНИХ ВІДНОСИН І
ТУРИЗМУ**

МЕНТАЛЬНЕ ЗДОРОВ'Я ТА ЖИТТЄСТІЙКІСТЬ ОСОБИСТОСТІ

Монографія

За загальною редакцією
Г. А. Пріба, Л. Є. Бегези

Київ-2026

УДК: 159.9:613.86

ББК: 88.37

*Затверджено Вченою радою Академії праці,
соціальних відносин і туризму (протокол № 5 від 16.12.2026 р.)*

*Затверджено Експертною радою Європейської психологічної асоціації
(протокол № 6 від 18.12.2026 р.)*

Рецензенти:

Бочелюк В.Й. – доктор психологічних наук, професор, заслужений працівник освіти України, професор кафедри практичної та соціальної психології ПВНЗ «Європейський університет».

Власенко О.О. – доктор психологічних наук, доцент, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, кафедра психології, філософії та суспільних наук, завідувач кафедри.

Раєвська Я. М. – доктор психологічних наук, професор, Міжрегіональна Академія управління персоналом, Навчально-науковий інститут психології та соціальних наук, директор.

Ментальне здоров'я та життєстійкість особистості : колективна монографія. Академія праці, соціальних відносин і туризму / За заг. ред. : Г. А. Пріба, Л. Є. Бегези – Київ : ФО-П Гуляєва В.М., 2026. 470 с.

ISBN 978-617-8181-72-7

DOI 10.5281/zenodo.18451183

У представленій колективній монографії викладено результати науково-дослідної роботи науково-педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти зі спеціальності С4 «Психологія» кафедри психології Академії праці, соціальних відносин і туризму у 2025–2026 роках.

Теоретичні моделі та науково-практичні розробки, що викладено у монографії, будуть цікаві фахівцям сфер психо-соціального напрямку в якості методичного підґрунтя при супроводі психічного здоров'я та резильєнтності особистості. Монографія стане допоміжним науково-методичним інструментарієм для здобувачів вищої освіти зі спеціальності С4 «Психологія», психологів-практиків, а також буде цікавими для використання у навчальній фаховій підготовці кваліфікованих кадрів на етапі перед- та післядипломної освіти.

Розповсюджувати і тиражувати без офіційного дозволу Академії праці, соціальних відносин і туризму забороняється.

Матеріали друкуються в авторській редакції. Автори несуть відповідальність за достовірність фактичних даних і мовностилістичний рівень матеріалів.

ЗМІСТ

ВСТУП.....	8
------------	---

ЧАСТИНА 1.

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТА ПРАКТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕНТАЛЬНОГО ЗДОРОВ'Я ТА ЖИТТЄСТІЙКОСТІ ОСОБИСТОСТІ

Вплив темпераменту та гендерних особливостей на поведінку у конфлікті	10
<i>Абдрахімов Р.А, Грігоріані Д.</i>	
Клінічно орієнтована модель медичного забезпечення в умовах збройного конфлікту.....	17
<i>Аймедов К.В., Неводчіков О.І.</i>	
Професійна рефлексія як компонента ресурсності особистості	32
<i>Бегеза Л.Є.</i>	
Психологічні особливості організації системи мотивації професійного самоздійснення фахівців юридичної сфери.....	42
<i>Бегеза Л.Є., Сербін Ю.В., Зубленко А.А</i>	
Життєстійкість особистості в умовах війни: соціально-психологічні чинники та ресурси	54
<i>Бегеза Л.Є., Янович Р.Є.</i>	
Психологічні особливості впливу самооцінки на мотиваційну сферу юнаків	61
<i>Борець О.А., Бондар С.С., Карнаух Т.В.</i>	
Функціонально-структурна модель емоційного інтелекту жінок-мігранток у контексті соціально-психологічної адаптації.....	71
<i>Борець О.А., Мироновська О.В.</i>	
Особливості якості сну у осіб із підвищеним рівнем тривожності.....	85
<i>Борець О.А., Рудова А.Г.</i>	
Емоційного вигорання та управління емоціями військовослужбовцями.....	94
<i>Бохонкова Ю.О., Бузько Т.М.</i>	
Вплив соціально-психологічних чинників на жінок у період грудного вигодовування.....	102
<i>Воробей В. О.</i>	

Аналіз небезпечних психосоціальних чинників ризику стресу працівників під час військової агресії	113
<i>Гільперт Н.М., Горошко Н.О.</i>	
Психологічні наслідки тривалого стресу: емоційне вигорання волонтерів	123
<i>Добровольська В.О., Бондар С.С., Жигинас Ю.Б.</i>	
Психологічні механізми подолання стресу	135
<i>Житинська М.О., Кириленко Р.В.</i>	
Теоретичні концепції психоаналізу у вивченні психологічних факторів розладу харчової поведінки.....	151
<i>Зінченко І.А.</i>	
Розвиток інструментів психологічної діагностики стрес-індукованих станів у дорослих цивільних під час війни	164
<i>Ларіонова Н.А.</i>	
Психологія формування стратегії посттравматичного зростання у осіб, постраждалих від конфліктів у суспільстві	172
<i>Лосієвська О. Г., Доценко Н.М.</i>	
Посттравматичне зростання особистості раннього дорослого віку у гендерному вимірі	188
<i>Лосієвська О.Г., Холодова С. Г.</i>	
Особливості сенсомоторного розвитку у дітей дошкільного віку	212
<i>Мілютіна К. Л., Гаврилюк Т. О.</i>	
Стійкість до стресу та її вплив на рівень психологічного благополуччя у працівників фармацевтичних компаній під час війни.....	224
<i>Мілютіна К. Л., Кулик О.П.</i>	
Вибір копінг-стратегії приватними підприємцями в умовах стресостійкості	233
<i>Мошенский В.С., Годунов В.Ю.</i>	
Особливості психічних станів внутрішньо переміщених осіб	242
<i>Московко Н. М., Білоус В.С.</i>	
Вплив психосоціальної дезадаптації в ситуації невизначеності на формування девіантної поведінки особистості	248
<i>Пріб Г.А.</i>	

Теоретико-емпіричний аналіз психоемоційних станів жінок зрілого репродуктивного віку.....	262
<i>Рубан Г.О.</i>	
Інноваційні підходи у соціальній інтеграції та психологічній адаптації українців у новому соціокультурному середовищі	278
<i>Тарасенко О.І.</i>	
Оцінка результатів розвитку конкурентоспроможної особистості в сучасному суспільстві.....	284
<i>Франчук І. В., Бондар С.І., Петько Л.В.</i>	
Особливості ціннісних орієнтацій щодо сім'ї та шлюбу у сім'ях, де є діти з розладами аутистичного спектра	295
<i>Царгородська А.О.</i>	
Психоемоційні особливості осіб, які працюють з групами ризику інфікування ВІЛ.....	308
<i>Чумаченко Н.Л., Лапінська Т.В.</i>	
Рольова компетентність, як чинник успішного вирішення особистістю життєвих проблем	313
<i>Морозова О.В., Шевченко Н.В.</i>	
Сучасні інтегративні моделі формування та розвитку аддикції.....	321
<i>Шевченко С.М.</i>	
Внутрішньо-особистісні чинники, що впливають на вибір стратегії поведінки апліканта у процесі пошуку роботи	333
<i>Шинкар В. О.</i>	
Емпіричне дослідження емоційного вигорання науково-педагогічних працівників медичних закладів вищої освіти.....	342
<i>Яременко Л.М., Жук А.В.</i>	
ВИСНОВКИ	354

ЧАСТИНА 2.

МАТЕРІАЛИ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «MENTAL HEALTH: ОСОБИСТІСНИЙ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВИМІРИ»

Психологічні чинники емоційного вигорання у викладачів медичних університетів.....	361
<i>Бегеза Л.Є., Жук А.В., Яременко Л.М.</i>	

Психологічні чинники виникнення та переживання стресу у фахівців медичної сфери	365
<i>Борець О.А., Карнаух Т.В.</i>	
Емоційний інтелект як фактор адаптації жінок у міграційних умовах	370
<i>Борець О.А., Мироновська О.В.</i>	
Взаємозв'язок порушення сну з тривожними станами	374
<i>Борець О.А., Рудова А.Г.</i>	
Психологічні особливості комунікації матері та дитини в період грудного вигодовування.....	378
<i>Воробей В.О.</i>	
Особливості сенсомоторного розвитку дітей дошкільного віку	383
<i>Гаврилюк Т.О.</i>	
Копінг-стратегії приватних підприємців в умовах стресостійкості.....	387
<i>Годунов В.Ю.</i>	
Рекомендації у роботі з молоддю щодо профілактики конфліктних ситуацій	392
<i>Грігоріані Д.</i>	
Психологічні наслідки тривалого стресу: емоційне вигорання волонтерів	396
<i>Добровольська В.О.</i>	
Minimizing the impact of challenges faced by internally displaced persons in Ukraine	400
<i>Harkavets S.O.</i>	
Психологічні механізми подолання стресу	405
<i>Житинська М.О., Кириленко Р.В.</i>	
Життестійкість особистості в умовах війни: соціально-психологічні чинники та можливості розвитку	411
<i>Житинська М.О., Янович Р.Є.</i>	
Розлади харчової поведінки у жінок середнього віку: комплексний підхід до аналізу.....	415
<i>Зінченко І.А.</i>	

Професійна спрямованість та самоздійснення фахівців юридичної сфери.....	419
<i>Зубленко А.А.</i>	
Стресостійкість та психологічне благополуччя у працівників фармацевтичних компаній під час війни	425
<i>Кулик О.</i>	
Інструменти психологічної діагностики стрес-індукованих станів у дорослих під час війни.....	429
<i>Ларіонова Н.А.</i>	
Особливості уваги та тривожності у внутрішньо переміщених осіб.....	432
<i>Московко Н.М.</i>	
Тривожність як чинник психічних станів вагітних жінок зрілого репродуктивного віку.....	437
<i>Рубан Г.О.</i>	
Дослідження психологічних чинників розвитку конкурентоспроможної особистості.....	443
<i>Франчук І.В.</i>	
Особливості ціннісних орієнтацій щодо сім'ї та шлюбу у сім'ях, де є діти з розладами аутистичного спектру	450
<i>Царгородська А.О.</i>	
Особливості емоційного реагування осіб, які працюють з групами ризику інфікування ВІЛ.....	453
<i>Чумаченко Н.Л.</i>	
Аспекти рольової компетентності, як чинника успішного вирішення особистістю життєвих проблем	459
<i>Шевченко Н.В.</i>	
Особистісні чинники, що впливають на вибір стратегії поведінки апліканта у процесі пошуку роботи	464
<i>Шинкар В.О.</i>	

ВСТУП

Військова агресія проти України спричинила значні людські втрати серед мирного населення, руйнування економіки та глибокі моральні й психологічні страждання громадян. Очевидним є те, що українське суспільство упродовж тривалого часу долатиме наслідки війни пов'язані з психічним здоров'ям.

Сприймаючи актуальність проблеми в Україні за ініціативи першої леді Олени Зеленської започаткована Всеукраїнська програма ментального здоров'я «Ти як?», що спрямована на розбудову якісної системи надання послуг у сфері психосоціальної підтримки та розвиток культури піклування про ментальне здоров'я.

У виступі Прем'єр-міністерки України Юлії Свириденко 18 серпня 2025 року окреслено актуальність напрямів досліджень, що відповідають програмі дій уряду України – «Ключові кроки в освіті та науці», де уряд підтримуватиме розробку технологій, спрямованих на національну безпеку та сталий розвиток, до яких віднесено охорона здоров'я, у тому числі ментальне.

В Україні 15 січня 2025 року Верховна Рада ухвалила Закон №12030 «Про систему охорони психічного здоров'я», метою якого є створення сучасної, ефективної та злагодженої системи, яка відповідатиме європейським нормам та стандартам й працюватиме для всіх громадян країни. Закон забезпечує доступ до якісних послуг, захист прав людей із психічними розладами та іншими проблемами, що стосуються психічного здоров'я, запобігання виникненню психічних розладів й усунення шкідливих факторів, що впливають на психічне здоров'я українців. Даний закон узгоджується з пріоритетними завданнями Європейського Союзу у сфері реагування на виклики психічного здоров'я та ґрунтується на рекомендаціях Європейської комісії щодо інтеграції питань психічного здоров'я в усі напрями національної політики. В умовах сучасних викликів та суспільних потреб напрацьовано ґрунтовний науково-практичний

доробок, що висвітлює результати досліджень ментального здоров'я та життєстійкості особистості. З метою адекватного реагування на актуальні запити сьогодення укладено колективну монографію «Ментальне здоров'я та життєстійкість особистості». Видання містить низку практичних розробок, кожна з яких постає як інструментарій, опанування яким забезпечує фахівцям можливість ефективної роботи з різними категоріями клієнтів. Особливе значення матеріали мають у контексті впровадження нових підходів надання психологічних послуг. Перша частина монографії складається з розділів, присвячених теоретичним засадам та практичним підходам до забезпечення ментального здоров'я та життєстійкості особистості. У другій частині монографії викладено матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Mental health: особистісний та організаційний виміри», яка відбувалася 10 жовтня 2025 року в Європейській психологічній асоціації в Україні, місті Києві та була присвячена Всесвітньому дню психічного здоров'я.

Запропоновані матеріали становлять науково-методичний інструментарій, призначений для використання у професійній діяльності практичних психологів та соціальних працівників. Вони можуть бути корисними здобувачам вищої освіти за спеціальностями «Клінічна психологія», «Психологія бізнесу та управління», а також становитимуть інтерес для науковців і фахівців, які досліджують проблематику становлення та самоактуалізації особистості.

ЧАСТИНА 1.

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТА ПРАКТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕНТАЛЬНОГО ЗДОРОВ'Я ТА ТА ЖИТТЄСТІЙКОСТІ ОСОБИСТОСТІ

Вплив темпераменту та гендерних особливостей на поведінку у конфлікті

Абдрыхімов Р.А.

*доктор медичних наук, професор,
Академія праці, соціальних відносин і туризму, м. Київ*

Грігоріані Д.

*Здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти
Академія праці, соціальних відносин і туризму, м. Київ*

Актуальність. Зростання агресивних тенденцій серед молоді становить одну з актуальних проблем сучасного суспільства. Молодіжний вік (18–25 років) є періодом, що охоплює як фізіологічні, так і психічні аспекти розвитку особистості. Цей етап характеризується підвищеною чутливістю до виникнення конфліктних ситуацій, що зумовлює необхідність своєчасного спрямування конфліктної поведінки у конструктивне русло, орієнтоване на пошук взаємоприйнятних рішень [1-4]. Важливо враховувати, що молода людина функціонує у соціальній групі, члени якої відрізняються індивідуальними особливостями: темпераментом, комунікативними характеристиками, схильністю до агресивних реакцій, а також власними ідеями, поглядами та переконаннями. У процесі міжособистісної взаємодії відбувається зіткнення цих позицій, що нерідко призводить до суперечок і конфліктів. Кожна особистість, маючи власний набір індивідуальних рис, демонструє різні моделі поведінки: від стриманої та агресивної до прямолінійної чи гнучкої. У конфліктній ситуації це проявляється у вигляді специфічного «репертуару поведінки», який визначає способи реагування на стресогенні чинники [4-8]. Таким чином, проблема агресивності та конфліктності молоді набуває особливої актуальності саме в цей період, коли темпераментні прояви мають найбільш інтенсивне вираження. Як зазначають І. Ю. Кулагіна та В. М. Колюцький, юність і молодість становлять своєрідний «третій

світ», що існує між дитинством та дорослістю, у межах якого індивід поступово набуває ознак реальної дорослості. На відміну від дорослих, молоді люди зазвичай не володіють достатнім життєвим досвідом у сфері розв'язання конфліктів. У цьому контексті дослідження взаємозв'язку між особистісними характеристиками студентів та їхнім вибором стратегій поведінки у конфліктних ситуаціях має значний практичний потенціал. Воно може сприяти формуванню у молоді конструктивних моделей реагування, адекватних конкретним умовам, а також розширенню їхнього поведінкового репертуару [1-8].

Мета дослідження. Дослідити вплив темпераменту та гендерних особливостей на поведінку в конфлікті. **Методи дослідження.** Дослідження проводилося зі здобувачами Академії праці, соціальних відносин та туризму. Всього прийняло участь 158 молодих осіб. Для участі у дослідженні усі опитуванні надалі інформаційну згоду на участь у дослідженні. Групу А склали 80 осіб чоловічого полу. Групу Б склали 78 жінок. Для реалізації дослідження обрано наступні методики: 1) Особистісний опитувальник Г. Айзенка; 2) Опитувальник А. Баса–А. Дарки; 3) Діагностики схильності особистості до конфліктної поведінки; 4) Методика психологічної діагностики копінг-поведінки Е. Хейма. Статистична обробка даних проводилася за допомогою розрахунку t – критерію Стьюдента. Аналіз отриманих даних дозволив виявити основні типи темпераменту досліджених студентів, їх агресивні і ворожі реакції, схильність до опозиційної поведінки, схильності особистості до конфліктної поведінки.

Результати дослідження. За основними соціально-демографічними показниками вибірка є репрезентативною та надає можливість досліджувати показники визначені у завданнях дослідження. Першим етапом дослідження стало дослідження типу темпераменту студентів за методикою Г. Айзенка. Даний етап дозволив порівняти структуру наявних видів темпераменту у досліджуваній вибірці студентів. В цілому за типом темпераменту за гендерним складом студентів значно не відрізнялися. Проте, флегматик у хлопців склав 13,92 %, у

дівчат 17,09 %. Кількість студентів з типом темпераменту «Сангвінік» виявилося найменше – 8,23 % у хлопців та 6,33 у дівчат. У подальшому проведено розрахунок відхилення від середнього типів темпераменту у досліджених студентів, де виявлено, що критичне значення (t_{Kp}) $p \leq 0.05$ дорівнює 2.45, а $p \leq 0.01$ дорівнює 3.71. Тобто отримане значення $t(0.1)$ знаходиться в зоні незначущості.

Наступним у дослідженні стало виявлення агресивних і ворожих реакцій, схильність до опозиційної поведінки за допомогою опитувальник А. Баса–А. Дарки. Розподіл агресивних і ворожих реакцій, схильність до опозиційної поведінки у студентів виявив, що у юнаків на відміну від дівчат виявлено більш виражену фізичну агресію – 12,35 % та підозрілість 12,35 %. У дівчат відповідно 7,79 % та 7,79 %. У свою чергу у дівчат за результатами дослідження переважали роздратованість 19,40, негативізм 11,69 %, образливість 19,46. У хлопців відповідно 16,05 %, 8,64 %, 14,81 %.

У рамках аналізу результатів досліджено відхилення від середнього та квадратного відхилення агресивних і ворожих реакцій, схильності до опозиційної поведінки, встановлено, що критичне значення (t_{Kp}) $p \leq 0.05$ дорівнює 2.18, а $p \leq 0.01$ дорівнює 3.05. Тобто отримане емпіричне значення $t(0.1)$ знаходиться в зоні незначущості.

Наступним етапом у дослідженні стало діагностики схильності особистості до конфліктної поведінки. Виявлено, що існує 3 варіанту розвитку конфлікту:

1. Позитивний – ситуація співробітництва обох сторін обумовлює виграш;
2. Негативний – при уникненні конфлікту жодна зі сторін не досягне успіху;
3. Позитивно-негативний – при якому застуючи конкуренцію, пристосування і компроміс або один учасник виявляється у виграші, а інший програє, або програють обидва, тому що йдуть на компромісні поступки.

Дослідження особистісної схильності до конфліктної поведінки у студентів відображено у табл. 1.

З представлених у табл. 1 даних видно, що у юнаків на відміну від дівчат більше виражено суперництво – 27,78 % та компроміс – 20,83 %. У дівчат відповідно 23,26 % та 17,44 %. У свою чергу у дівчат за результатами дослідження переважали уникнення – 20,93 % та пристосування – 18,6 %. У хлопців відповідно 16,67 % та 15,28 %.

Таблиця 1

Структура особистісної схильності до конфліктної поведінки у студентів

Показники	Досліджувані групи			
	А	Б	А	Б
	N	N	%	%
Суперництво	21	18	27,78	23,26
Співпраця	15	16	19,44	19,77
Компроміс	17	14	20,83	17,44
Уникання	14	16	16,67	20,93
Пристосування	16	14	15,28	18,6
Всього	80	78	100,0	100,0

Аналіз відхилення від середнього та квадратного відхилення показників особистісної схильності до конфліктної поведінки у студентів представлено у табл. 2.

Таблиця 2

Відхилення від середнього та квадратного відхилення показників особистісної схильності до конфліктної поведінки у студентів

№	Вибірки		Відхилення від середнього		Квадрати відхилень	
	Досліджувані групи					
	А	Б	А	Б	А	Б
1	20	20	5,6	2,8	31,36	7,84
2	14	17	-0,4	-0,2	0,16	0,04
3	15	15	0,6	-2,2	0,36	4,84
4	12	18	-2,4	0,8	5,76	0,64
5	11	16	-3,4	-1,2	11,56	1,44
Суми:	72	86	-0	0	49,2	14,8
Середнє:	14,4	17,2	—	—	—	—

З представлених у табл. 2. даних видно, що критичне значення ($t_{кр}$) $p \leq 0.05$ дорівнює 2.31, а $p \leq 0.01$ дорівнює 3.36. Тобто отримане емпіричне значення t (1.6) знаходиться в зоні незначущості. За результатами проведеного дослідження можна зробити узагальнення, що в цілому за типом темпераменту за гендерним складом студентів не мають суттєвих відмінностей.

Кількість студентів з типом темпераменту «Сангвінік» виявилось менше всього – 8,23 % у хлопців та 6,33 у дівчат. Також у юнаків на відміну від дівчат була більш яскраво виражена фізична агресія – 12,35 % та підозрілість 12,35 %. У дівчат відповідно 7,79 % та 7,79 %. За результатами дослідження у дівчат переважали такі якості як: роздратованість 19,40, негативізм 11,69 % та образливість 19,46. У хлопців показники з цих якостей, порівнянню з результатами дівчат, трохи нижче, відповідно 16,05 %, 8,64 %, 14,81 %.

За тестом схильності особистості до поведінки в конфлікті за результатами яких було визначено що у юнаків, на відміну від дівчат більше виражено суперництво – 27,78 % та компроміс – 20,83 %. У дівчат за стилем суперництва – 23,26 % та 17,44 %, що свідчить про низьку готовність (в порівнянні з хлопцями) дівчат йти на компроміси в конфліктних ситуаціях, але в свою чергу вони переважають за стилем уникнення – 20,93 % та пристосування – 18,6 %. Хлопці зайняли іншу позицію за результатами стилю уникнення – 16,67 % та 15,28 % за стилем пристосування.

Останнім етапом дослідженні стало вивчення копінг-поведінки та конфліктної поведінки за допомогою методики психологічної діагностики копінг-поведінки Е. Хейма в адаптації Л.І. Вассермана. За результатом аналізу даних, представлених у табл. 3, видно, що у юнаків в цілому серед когнітивних копінг-стратегій переважали: збереження самовладання 4,4 %, проблемний аналіз 4,8 %, установка власних цінностей 4,0 %. Серед емоційних копінг-стратегій у юнаків переважали відповідно: протест 3,0 %, покірність 4,8 %, самозвинувачення 3,0 %. Серед поведінкових копінг-стратегій у юнаків

переважали відповідно: конструктивна активність 3,6 %, звернення 5,7 %. Серед когнітивних копінг-стратегій у дівчат переважали: установка власної цінності 5,2 %. Серед емоційних копінг-стратегій у дівчат переважали відповідно: протест 4,2 %, емоційна розрядка 4,2 %, придушення емоцій 4,7 %, пасивна кооперація 4,5 %. Серед поведінкових копінг-стратегій у дівчат переважали відповідно: активне уникнення 5,1 %, співпраця 5,0 %, звернення 6,4 % ($p \leq 0,05$).

Висновки. В цілому види та структура копінгів у юнаків розподілилися наступним чином: когнітивний компонент: адаптивні 14,2 %, відносно адаптивні 7,1 %, не адаптивні 12,1 %. Емоційний компонент: адаптивні 9,2 %, відносно адаптивні 8,3 %, не адаптивні 15,8 %. Поведінковий компонент: адаптивні 12,9 %, відносно адаптивні 12,9 %, не адаптивні 7,5 %. У дівчат відповідно: когнітивний компонент: адаптивні 10,3 %, відносно адаптивні 10,7 %, не адаптивні 12,4 %. Емоційний компонент: адаптивні 8,5 %, відносно адаптивні 9,4 %, не адаптивні 15,4 %. Поведінковий компонент: адаптивні 16,2 %, відносно адаптивні 7,7 %, не адаптивні 9,4 % ($p \leq 0,05$).

Список використаних джерел.

1. Горностай П.П. Особистість та роль: Рольовий підхід у соціальній психології особистості/П.П. Горностай – К.: Інтерпрес ЛТД, 2017. 312 с.
2. Москаленко В. В., Романова В. Г. Особливості структури гендерних образів в уявленнях підлітків // Психологія. Зб. наукових праць НПУ ім. М. Драгоманова. Вип. 14. К.: НПУ ім. Драгоманова, 2001. С. 138 – 153.
3. Романова В. Г. Дослідження андрогінності в гендерній ідентифікації підлітків // Психологія. Зб. наукових праць НПУ ім. М. Драгоманова. Вип. 13. – К.: НПУ ім. Драгоманова, 2001. С. 292 – 309.
4. American Hieritage Dictionary of English Language/параметри доступу до сайту: <http://americanheritage.yourdictionary.com/>
5. Lazarus, RS, Smith, C.A. (1990). Emotion and adaptation. In: L.A. Pervin (Ed.) Handbook of personality: Theory and research (pp. 609–637). New York: Guilford.

6. Haan, N. (1965). Coping and defense mechanisms related to personality inventories. *Journal of Consulting Psychology*, 29, 373–378.

7. Войцеховська О. Сучасні напрямки досліджень копінг–стратегій особистості / О. Войцеховська, Г. Закалик // Педагогіка та психологія професійної освіти. 2022. №2. С. 95 – 104.

8. Compas B.E. Coping with stress під час дитинства і adolescence: проблеми, прогрес, і потенційний в теорії і розвідки / B.E.Compas, J.K.Connor–Smith, H.Saltsman, A.H.Thomsen, M.E.Wadsworth // *Psychological Bulletin*. 2001. Vol.127, №1. P. 87 – 127.

Клінічно орієнтована модель медичного забезпечення в умовах збройного конфлікту

Аймедов К.В.

Міністерство оборони України, заступник начальника військово-медичного управління, доктор медичних наук, професор, м. Київ

Неводчіков О.І.

полковник, старший викладач кафедри планування та штабних процедур НАТО інституту професійної військової освіти «Вишкіл Лідерів» Національного університету оборони України, м. Київ

Анотація. У дослідженні здійснено комплексний науково-теоретичний та клінічно орієнтований аналіз особливостей функціонування системи медичної допомоги в умовах збройного конфлікту. Основну увагу зосереджено на ролі клінічної медицини в забезпеченні безперервності лікувального процесу, ефективності надання медичної допомоги пацієнтам із бойовою травмою, політравмою, поєднаною соматичною та психічною патологією, а також на проблемах організації інтенсивної терапії, профілактики ускладнень і медичної реабілітації. У роботі проаналізовано клінічні виклики, пов'язані з масовими санітарними втратами, високою частотою інфекційних ускладнень, антибіотикорезистентністю та зростанням психосоматичних розладів. Обґрунтовано необхідність інтеграції соматичної та психіатричної допомоги, міждисциплінарної взаємодії медичних фахівців і адаптації клінічних протоколів до умов підвищеного навантаження на систему охорони здоров'я. Окрему увагу приділено ролі реабілітації як завершального етапу клінічного маршруту пацієнта та чинника зниження інвалідизації. Матеріали даної роботи можуть бути використані у практичній діяльності лікарів, організаторів охорони здоров'я, а також у системі підготовки та підвищення кваліфікації медичних кадрів.

Ключові слова: клінічна медицина; медична допомога; бойова травма; політравма; інтенсивна терапія; психічне здоров'я; інфекційні ускладнення; медична реабілітація; система охорони здоров'я; безперервність лікування.

Aymedov C. V.
Ministry of Defence of Ukraine, Deputy Head of the Military Medical Department,
Doctor of Medical Sciences, Professor, Kyiv

Nevodchikov O.I.
Colonel, Senior Instructor, Department of NATO Planning and Staff Procedures,
Professional Military Education Institute «Leadership School», National Defense
University of Ukraine, Kyiv

Clinically oriented model of medical support in conditions of armed conflict

Abstract. The study presents a comprehensive scientific-theoretical and clinically oriented analysis of the functioning of healthcare systems under conditions of armed conflict. Particular attention is paid to the role of clinical medicine in ensuring continuity of care and the effectiveness of medical treatment for patients with combat-related injuries, polytrauma, and combined somatic and mental disorders, as well as to the organization of intensive care, prevention of complications, and medical rehabilitation. The paper analyzes clinical challenges associated with mass casualty events, a high incidence of infectious complications, antimicrobial resistance, and an increasing prevalence of psychosomatic disorders. The necessity of integrating somatic and psychiatric care, strengthening interdisciplinary cooperation among medical professionals, and adapting clinical protocols to conditions of increased strain on healthcare systems is substantiated. Special emphasis is placed on the role of rehabilitation as the final stage of the patient care pathway and as a key factor in reducing long-term disability. The materials of this study may be used in clinical practice, healthcare management, and in the education and advanced training of medical professionals.

Keywords: clinical medicine; healthcare delivery; combat injury; polytrauma; intensive care; mental health; infectious complications; medical rehabilitation; healthcare system; continuity of care.

Актуальність. Сучасні збройні конфлікти характеризуються високою інтенсивністю бойових дій, широким застосуванням високоточної зброї, ураженням цивільної інфраструктури та залученням значної кількості цивільного населення до зони безпосереднього впливу воєнних дій. У цих умовах система медичного забезпечення перестає виконувати виключно допоміжну функцію і перетворюється на один із ключових елементів збереження людського потенціалу, стійкості суспільства та функціонування держави в цілому. Особливої актуальності набуває питання організації медичної допомоги в умовах масових санітарних втрат, поєднання бойової травми з хронічними захворюваннями, психотравматичними розладами та ускладненим перебігом соматичної патології.

У межах сучасних конфліктів медицина стикається з принципово новими викликами, серед яких домінують множинні та комбіновані ураження, політравма, вибухові й мінно-вибухові пошкодження, масивні крововтрати, інфекційні ускладнення, а також значне зростання частоти психічних та психосоматичних розладів. За цих умов ефективність медичної допомоги визначається не лише рівнем індивідуальної клінічної майстерності лікаря, а й здатністю системи охорони здоров'я забезпечити безперервність лікувально-діагностичного процесу, раціональне використання ресурсів та своєчасну медичну евакуацію пацієнтів між рівнями надання допомоги.

Особливе місце в цьому процесі займає клінічна медицина як науково-практична основа прийняття рішень у системі медичного управління. Саме клінічні протоколи, алгоритми лікування, стандарти інтенсивної терапії та хірургічної допомоги формують підґрунтя для планування медичних ресурсів, кадрового забезпечення та логістики медичної допомоги. Водночас досвід сучасних воєнних конфліктів, зокрема в Україні, засвідчує, що наявність клінічних знань без належної системної організації медичної служби не забезпечує необхідного рівня збереження життя та здоров'я поранених і хворих.

У цьому контексті медичне забезпечення слід розглядати як багаторівневу систему, що поєднує клінічну медицину, організацію охорони здоров'я, медичну логістику, епідеміологічний контроль, реабілітацію та психічне здоров'я. Такий підхід дозволяє відійти від вузького трактування медицини як реакції на травму і перейти до комплексного бачення здоров'я людини в умовах тривалого впливу стресогенних чинників, фізичних ушкоджень та соціальних потрясінь.

Актуальність даного дослідження зумовлена необхідністю переосмислення ролі клінічної медицини в системі медичного забезпечення в умовах воєнного стану. Йдеться не лише про лікування бойових поранень, а й про ведення пацієнтів із загостренням серцево-судинних, ендокринних, гастроентерологічних, неврологічних та психічних захворювань, які значно ускладнюють перебіг травми та впливають на результати лікування. Відсутність інтегрованого підходу до таких пацієнтів призводить до зростання летальності, інвалідизації та довготривалих медико-соціальних наслідків.

Мета дослідження. Науково-теоретичне та клінічно орієнтоване обґрунтування ролі клінічної медицини в системі медичного забезпечення в умовах збройного конфлікту, а також визначення основних напрямів удосконалення організації медичної допомоги, безперервності лікувального процесу та реабілітації пацієнтів із бойовою травмою, поєднаною соматичною та психічною патологією. *Об'єкт дослідження* є система медичного забезпечення та надання клінічної медичної допомоги в умовах збройного конфлікту як складова національної системи охорони здоров'я. *Предмет дослідження* є клінічні, організаційні та медико-реабілітаційні аспекти надання медичної допомоги пацієнтам із бойовою травмою, політравмою, поєднаною соматичною та психічною патологією в умовах тривалого кризового навантаження на систему охорони здоров'я.

Розгляд медичного забезпечення крізь призму клінічної медицини дозволяє виокремити його як цілісну клінічно-організаційну систему, спрямовану на збереження життя, мінімізацію ускладнень та відновлення функціонального стану

пацієнтів. У цій системі ключову роль відіграє наступність між етапами надання медичної допомоги, що забезпечує логічний і безперервний рух пацієнта від моменту отримання ушкодження до завершення реабілітаційного лікування [4, 9, 12].

Клінічна практика в умовах бойових дій демонструє, що основними детермінантами виживання пацієнтів є раннє розпізнавання загрозливих станів, своєчасний контроль кровотечі, адекватне знеболення, стабілізація дихання та гемодинаміки, а також профілактика інфекційних ускладнень. Усі ці заходи базуються на клінічних принципах доказової медицини, однак потребують адаптації до умов дефіциту ресурсів, обмеженого часу та високого навантаження на медичний персонал [7, 13]. Окремої уваги потребує питання поєднання гострої травматичної патології з хронічними соматичними захворюваннями. У значної частини пацієнтів, які зазнали поранень, в анамнезі наявні артеріальна гіпертензія, ішемічна хвороба серця, цукровий діабет, хронічні захворювання легень або ниркова недостатність [5, 10, 13]. Такі коморбідні стани суттєво впливають на тактику лікування, обмежують можливості хірургічного втручання та підвищують ризик післяопераційних ускладнень.

Подальший розвиток клінічної медицини в умовах збройного конфлікту неможливий без урахування специфіки бойової травми, яка принципово відрізняється від ушкоджень мирного часу за механізмом виникнення, тяжкістю перебігу та спектром ускладнень. Вибухові, мінно-вибухові та уламкові ураження характеризуються високою енергією впливу, що призводить до множинних пошкоджень тканин, поєднання відкритих і закритих травм, значної зони первинного та вторинного некрозу. З клінічної точки зору такі ушкодження формують складні випадки політравми, що потребують мультидисциплінарного підходу та негайної координації дій лікарів різних спеціальностей.

Клінічний перебіг політравми в умовах масових надходжень постраждалих часто ускладнюється розвитком геморагічного шоку, гострої дихальної

недостатності, коагулопатії та метаболічних порушень. У цьому контексті рання інтенсивна терапія набуває визначального значення. Своєчасне відновлення об'єму циркулюючої крові, корекція кислотно-лужного стану, контроль гіпотермії та адекватне знеболення є базовими клінічними принципами, що знижують летальність і покращують віддалені результати лікування. Особливу увагу необхідно приділяти тактиці damage control, яка дозволяє мінімізувати обсяг хірургічних втручань на ранніх етапах і зосередитися на стабілізації життєво важливих функцій організму [3, 8, 11, 12].

Роль анестезіології та інтенсивної терапії в системі медичного забезпечення виходить далеко за межі операційної. Саме від якості післяопераційного ведення пацієнтів, адекватного моніторингу та своєчасного реагування на ускладнення залежить прогноз для життя і функціонального відновлення. В умовах тривалого перебування пацієнтів у відділеннях інтенсивної терапії зростає ризик розвитку вентиляційно-асоційованих пневмоній, сепсису, гострого ураження нирок та поліорганної недостатності, що потребує чітких клінічних алгоритмів і міждисциплінарної взаємодії [4, 5].

Інфекційні ускладнення залишаються однією з провідних причин несприятливих наслідків при лікуванні бойових ушкоджень. Масивне забруднення ран, наявність сторонніх тіл, тривала ішемія тканин і порушення імунної відповіді створюють сприятливі умови для розвитку локальних та генералізованих інфекцій. Особливої складності набуває проблема антибіотикорезистентності, яка в умовах тривалих бойових дій і частого емпіричного застосування антибактеріальних препаратів швидко прогресує. З клінічної точки зору це вимагає впровадження раціональних схем антибіотикотерапії, мікробіологічного моніторингу та жорсткого контролю інфекцій у медичних закладах [7].

Не менш важливим аспектом клінічної медицини в умовах війни є психічне здоров'я пацієнтів. Гострі стресові реакції, посттравматичні стресові розлади, тривожні та депресивні стани часто поєднуються з соматичною патологією і

суттєво ускладнюють лікувальний процес. Ігнорування психічного компоненту захворювання призводить до погіршення комплаєнсу, затримки реабілітації та зниження якості життя після виписки зі стаціонару. Саме тому інтеграція психіатричної та психологічної допомоги в загальний клінічний маршрут пацієнта є необхідною умовою сучасного підходу до лікування [1, 6, 10].

Окремого розгляду потребує проблема медичної реабілітації, яка виступає завершальним, але не менш важливим етапом клінічного процесу. Пацієнти з ампутаціями, тяжкими ураженнями опорно-рухового апарату, черепно-мозковими травмами та пошкодженнями спинного мозку потребують тривалої мультидисциплінарної реабілітації, що поєднує фізичну терапію, ерготерапію, медикаментозне лікування та психосоціальну підтримку. Ефективність реабілітації значною мірою залежить від її раннього початку та безперервності між стаціонарним і амбулаторним етапами [1].

З позицій клінічної медицини медичне забезпечення в умовах війни слід розглядати не як сукупність окремих медичних заходів, а як безперервний клінічний маршрут пацієнта, що охоплює діагностику, лікування, інтенсивну терапію, профілактику ускладнень та реабілітацію. Такий підхід дозволяє мінімізувати втрати, підвищити ефективність використання ресурсів і забезпечити довготривалі позитивні результати лікування.

Важливим компонентом ефективної медичної допомоги в умовах воєнного стану є чітка організація клінічних маршрутів пацієнтів, що забезпечує безперервність лікування та наступність між різними рівнями надання медичної допомоги. З клінічної точки зору маршрут пацієнта починається з моменту первинного контакту з медичним працівником і продовжується до повного завершення лікування або стабілізації стану з подальшим амбулаторним спостереженням. Порушення будь-якої ланки цього маршруту неминуче призводить до погіршення клінічних результатів, зростання частоти ускладнень та повторних госпіталізацій [2, 6, 12].

У сучасних умовах особливої актуальності набуває інтеграція військової та цивільної систем охорони здоров'я. Значна частина пацієнтів після первинного лікування та стабілізації стану переводиться до цивільних медичних закладів, де продовжується їхнє лікування, реабілітація та диспансерне спостереження. Це вимагає уніфікації клінічних протоколів, стандартизації медичної документації та забезпечення безперервного обміну клінічно значущою інформацією між закладами охорони здоров'я різного підпорядкування. З клінічної позиції відсутність такої інтеграції ускладнює прийняття рішень, призводить до дублювання обстежень і підвищує ризик медикаментозних помилок [7, 11].

Суттєвим викликом для клінічної медицини в умовах війни є кадрове забезпечення системи охорони здоров'я. Тривале емоційне напруження, високе фізичне навантаження, дефіцит часу та ресурсів сприяють розвитку професійного вигорання серед медичних працівників, що безпосередньо впливає на якість медичної допомоги. Збереження професійної ефективності лікарів і середнього медичного персоналу потребує впровадження програм психологічної підтримки, раціонального розподілу навантаження та безперервного професійного навчання з урахуванням специфіки бойової травми та ургентних станів.

Окрему роль у підвищенні якості клінічної допомоги відіграє система підготовки та перепідготовки медичних кадрів. Практика сучасної медицини в умовах війни вимагає від лікарів не лише ґрунтовних знань із клінічних дисциплін, а й уміння швидко приймати рішення в умовах невизначеності, працювати з великою кількістю пацієнтів та ефективно взаємодіяти в мультидисциплінарних командах. У цьому контексті особливого значення набуває симуляційне навчання, відпрацювання алгоритмів дій при масових надходженнях постраждалих, а також навчання з інтенсивної терапії, травматології та невідкладної медицини [3, 6, 10, 12].

З клінічної точки зору важливим аспектом є також медикаментозне забезпечення лікувального процесу. В умовах обмеженого доступу до препаратів і

перебоїв у постачанні зростає значення раціональної фармакотерапії, заснованої на принципах доказової медицини. Особливо це стосується знеболювальних засобів, антибактеріальних препаратів, засобів для інтенсивної терапії та лікування хронічних захворювань. Недостатня увага до цих аспектів призводить до погіршення контролю болю, прогресування інфекційних процесів і декомпенсації супутньої патології [2, 9].

Водночас слід наголосити, що клінічна медицина в умовах війни не може обмежуватися лише лікуванням гострих станів. Значна кількість пацієнтів потребує довготривалого спостереження, корекції терапії та профілактики віддалених ускладнень. Це стосується як пацієнтів із тяжкими травмами, так і осіб із загостренням хронічних захворювань, що виникають на тлі тривалого психоемоційного стресу, порушення режиму лікування та обмеженого доступу до медичної допомоги. У цьому контексті особливу роль відіграє первинна ланка охорони здоров'я, яка забезпечує безперервність клінічного нагляду та своєчасне направлення пацієнтів до спеціалізованих закладів [10, 13].

Таким чином, клінічна медицина в умовах воєнного стану постає як багатовимірна система, що поєднує ургентну допомогу, стаціонарне лікування, інтенсивну терапію, психічне здоров'я та реабілітацію. Її ефективність визначається не лише рівнем розвитку окремих клінічних напрямів, а й здатністю системи охорони здоров'я забезпечити цілісність, наступність і адаптивність лікувального процесу в умовах тривалих кризових навантажень.

Узагальнюючи викладене, слід наголосити, що сучасна клінічна медицина в умовах збройного конфлікту виходить за межі традиційних уявлень про лікування гострої травми та невідкладних станів. Вона трансформується у складну, багаторівневу систему, у центрі якої перебуває пацієнт із його індивідуальними клінічними особливостями, супутніми захворюваннями, психоемоційним станом та довготривалими наслідками перенесених ушкоджень. Такий підхід вимагає переорієнтації медичного мислення з епізодичного реагування на патологічний

стан до безперервного клінічного супроводу людини на всіх етапах лікування й відновлення.

Клінічний досвід, набутий у період воєнного стану, переконливо свідчить, що результативність лікування значною мірою залежить від ранньої діагностики, своєчасного початку терапії та узгодженості дій між різними спеціалістами. Політравма, комбіновані ураження, поєднання травматичних ушкоджень із декомпенсованими хронічними захворюваннями формують складні клінічні сценарії, які потребують міждисциплінарного підходу, клінічного мислення високого рівня та адаптації стандартних протоколів до реальних умов надання допомоги. У цьому контексті особливого значення набуває роль клінічних алгоритмів, що дозволяють зберігати якість медичної допомоги навіть за умов дефіциту часу й ресурсів [6, 11].

Важливою складовою сучасної клінічної медицини є інтеграція соматичного та психічного здоров'я. Психічні розлади, що виникають або загострюються в умовах війни, істотно впливають на перебіг соматичних захворювань, уповільнюють процес одужання та ускладнюють реабілітацію. Ігнорування психоемоційного компоненту захворювання призводить до хронізації патологічних станів, зниження ефективності лікування та погіршення якості життя пацієнтів. Тому сучасна клінічна модель надання допомоги повинна передбачати системне залучення фахівців з психічного здоров'я на всіх етапах лікувального процесу [3, 7, 9].

Не менш важливим аспектом є довготривала медична реабілітація, яка набуває стратегічного значення в умовах масових ушкоджень і зростання рівня інвалідизації. Реабілітація повинна розпочинатися на ранніх етапах лікування та продовжуватися після виписки зі стаціонару, забезпечуючи відновлення функціональних можливостей, соціальну адаптацію та повернення пацієнтів до максимально можливого рівня самостійності. У цьому контексті особливої уваги потребує розвиток мультидисциплінарних реабілітаційних команд, які поєднують

лікарів різних спеціальностей, фізичних терапевтів, психологів і соціальних працівників.

З позицій організації охорони здоров'я клінічна медицина в умовах війни потребує гнучкої, адаптивної системи управління, здатної швидко реагувати на зміну навантаження, забезпечувати перерозподіл ресурсів і підтримувати безперервність надання допомоги. Ефективність такої системи визначається не лише матеріально-технічним забезпеченням, а й якістю підготовки медичних кадрів, рівнем міжвідомчої взаємодії та здатністю інтегрувати цивільну й спеціалізовану медичну допомогу в єдиний клінічний простір [1, 5, 11, 13].

Отже, клінічна медицина в умовах збройного конфлікту постає як ключовий чинник збереження життя, здоров'я та людського потенціалу. Її розвиток потребує системного підходу, що поєднує досягнення доказової медицини, ефективну організацію охорони здоров'я та орієнтацію на довготривалі медико-соціальні наслідки. Представлений у роботі клінічно орієнтований підхід може бути використаний як науково-методична основа для вдосконалення системи медичної допомоги в умовах тривалих кризових навантажень та формування стійкої, пацієнтоорієнтованої моделі сучасної медицини.

Висновки. Установлено, що в умовах збройного конфлікту клінічна медицина функціонує в режимі тривалого кризового навантаження, що зумовлює її трансформацію з переважно реактивної системи надання допомоги у комплексну модель безперервного клінічного супроводу пацієнтів. Ця модель охоплює ургентну медичну допомогу, спеціалізоване та високоспеціалізоване лікування, інтенсивну терапію, профілактику ускладнень, лікування супутньої соматичної та психічної патології, а також довготривалу медичну реабілітацію.

Доведено, що бойова травма та політравма мають специфічні клінічні особливості, які визначають тяжкість перебігу захворювання, високий ризик ускладнень і необхідність застосування мультидисциплінарного підходу. Поєднання травматичних ушкоджень із хронічними соматичними

захворюваннями суттєво ускладнює лікувальну тактику, підвищує ризик декомпенсації життєво важливих функцій і потребує індивідуалізації клінічних рішень.

Обґрунтовано, що своєчасна діагностика та ранній початок лікування є визначальними чинниками зниження летальності та тяжкості віддалених наслідків. Ефективність клінічної допомоги значною мірою залежить від здатності системи охорони здоров'я забезпечити швидке прийняття рішень, наступність між рівнями надання допомоги та раціональне використання наявних ресурсів в умовах підвищеного навантаження.

Установлено, що інтенсивна терапія відіграє ключову роль у лікуванні пацієнтів із тяжкими ушкодженнями та критичними станами. Адекватна підтримка життєво важливих функцій, контроль гемодинаміки, дихання та метаболічних порушень, а також своєчасна профілактика вторинних ускладнень є необхідними умовами стабілізації стану пацієнтів і створення передумов для подальшого лікування та реабілітації.

Доведено, що інфекційні ускладнення, зокрема сепсис, гнійно-запальні процеси та внутрішньолікарняні інфекції, залишаються одними з основних причин несприятливих клінічних наслідків у пацієнтів із бойовою травмою. Зростання антибіотикорезистентності вимагає впровадження принципів раціональної антимікробної терапії, мікробіологічного моніторингу та системного контролю інфекцій у закладах охорони здоров'я.

Визначено, що психічні та психосоматичні розлади, які виникають або загострюються в умовах тривалого стресу, суттєво впливають на перебіг соматичних захворювань і результати лікування. Інтеграція психіатричної та психологічної допомоги в загальний клінічний маршрут пацієнта є необхідною умовою підвищення комплаєнсу, скорочення термінів лікування та покращення якості життя.

Обґрунтовано, що медична реабілітація повинна розглядатися як невід’ємна складова лікувального процесу, а не як його завершальний етап. Ранній початок реабілітаційних заходів, мультидисциплінарний підхід та забезпечення безперервності між стаціонарним і амбулаторним етапами сприяють зниженню рівня інвалідизації та відновленню функціональної незалежності пацієнтів.

Установлено, що ефективність клінічної медицини в умовах збройного конфлікту значною мірою залежить від кадрового потенціалу системи охорони здоров’я. Високе професійне навантаження, емоційне виснаження та ризик професійного вигорання серед медичних працівників потребують впровадження програм психологічної підтримки, безперервного професійного розвитку та оптимізації організації праці.

Доведено, що безперервність клінічного маршруту пацієнта забезпечується за умови ефективної взаємодії між різними рівнями медичної допомоги та інтеграції цивільної системи охорони здоров’я. Уніфікація клінічних протоколів, стандартизація медичної документації та обмін клінічно значущою інформацією є ключовими чинниками підвищення якості лікування.

Підтверджено, що формування клінічно орієнтованої, пацієнтоцентричної моделі медичного забезпечення в умовах збройного конфлікту є необхідною передумовою збереження людського потенціалу та стійкості системи охорони здоров’я. Запропонований у дослідженні підхід може слугувати науково-методичною основою для подальшого вдосконалення організації клінічної медичної допомоги в умовах тривалих кризових викликів.

Список використаних джерел.

1. Аймедов К.В., Пономарьов В.І., Чемер Ю.П. Стійкість, резильєнтність та відновлення: ментальне здоров’я військових : навчальний посібник. Харків : НТУ «ХПІ», 2025. 96 с.
2. Бадюк М.І., Жупан Б.Б., Солярик В.В., Ковида Д.В. Оптимізація лікувально-евакуаційного забезпечення військових частин Збройних Сил України

оперативно-тактичного рівня в умовах антитерористичної операції. Військова медицина України. 2015. Т. 15, № 1. С. 11–15.

3. Верб А.В. Застосування стабілізаційних пунктів в системі лікувально-евакуаційного забезпечення антитерористичної операції. Проблеми військової охорони здоров'я. 2017. Вип. 47. С. 263–270.

4. Верб А.В., Хорошун Е.М., Стриженко В.І., Булах О.Ю., Гульпа В.С. Концептуальні підходи до побудови сучасної системи управління медичним забезпеченням у контексті реформування Збройних Сил України. Військова медицина України. 2016. Т. 16, № 1. С. 5–14.

5. Галушка А.М., Жаховський В.О., Лівінський В.Г. Медичне забезпечення Збройних сил України: досвід, здобутки, перспективи. Український журнал військової медицини. 2021. №1. С. 28–35.

6. Доктрина «Медичні сили Збройних Сил України», затверджена Головнокомандувачем Збройних Сил України 13.11.2020 року.

7. Івчук В.М., Стриженко В.І., Ричка О.В., Ляшенко О.О., Галан О.В. Дослідження факторів впливу на створення організаційно-штатної структури медичної служби військових частин видів (родів) Збройних Сил України. Український журнал військової медицини. 2015. №1. С. 41–49.

8. Лозовий М.Г., Воробйов О.М., Власов І.О., Чапля М.М. Досвід організації медичного забезпечення військ (сил) в операції об'єднаних сил. Modern Information Technologies in the Sphere of Security and Defence. 2021. №1(40). С. 69–74.

9. Медичне забезпечення антитерористичної операції: науково-організаційні та медико-соціальні аспекти : збірник наукових праць / за заг. ред. академіків НАН України Цимбалюка В.І. та Сердюка А.М. К. : ДП «НВЦ «Пріоритети», 2016. 316 с.

10. Москалюк О.В. Аналіз модульного підходу при формуванні медичних підрозділів швидкого реагування на II рівні надання медичної допомоги країн

альянсу НАТО. Вісник Вінницького національного медичного університету. 2021. № 4. С. 640–644.

11. Остащенко Т.М., Жаховський В.О., Лівінський В.Г. Сучасні підходи до управління Медичними силами Збройних Сил України. Український журнал військової медицини. 2021. №1. С. 14–25.

12. Савицький В.Л., Майданюк В.П., Власенко О.М., Стриженко В.І., Булах О.Ю. Медичне забезпечення Збройних Сил України в антитерористичній операції: досвід та напрямки його удосконалення. Військова медицина України. 2015. №1. С. 5–11.

13. Хоменко І.П., Король С.О., Халік С.В., Шаповалов В.Ю., Єнін Р.В., Герасименко О.С., Тertiшний С.В. Клінічно-епідеміологічний аналіз структури бойової хірургічної травми при проведенні антитерористичної операції / операції Об'єднаних сил на сході України. Український журнал військової медицини. 2021. №1. С. 5–13.

Професійна рефлексія як компонента ресурсності особистості

Бегеза Л.Є.

*Доктор психологічних наук, професор
Академія праці, соціальних відносин і туризму, м. Київ*

Актуальність. Сучасні соціально-економічні та професійні особливості діяльності особистості характеризуються підвищеним рівнем невизначеності, емоційного напруження, зростанням вимог до професійної компетентності фахівця. Актуальною є проблематика збереження й розвитку психологічної та професійної ресурсності особистості як чинника професійної діяльності й ментального здоров'я. Дослідження професійної рефлексії у процесі професіогенезу психолога набуває значущості в умовах воєнного стану, оскільки рефлексія є одним із компонентів професійного розвитку фахівця. Професійна рефлексія забезпечує здатність психолога до усвідомлення власних психоемоційних станів, когнітивних установок і професійних дій, що є необхідним для розуміння запитів клієнтів, прийняття рішень та надання якісної психологічної допомоги в кризових умовах.

Водночас професійна рефлексія є важливим чинником особистісного і професійного саморозвитку психолога, оскільки сприяє глибшому самопізнанню, розвитку стресостійкості, емоційної регуляції та здатності до професійного самовідновлення. В умовах воєнного стану, коли психологи часто працюють з травматичним досвідом, втратами та психоемоційними станами, рефлексія виконує функцію профілактики професійного вигорання.

Професійна рефлексія є складним багаторівневим процесом, який потребує цілеспрямованої підготовки та систематичного розвитку. Тому, психологи у освітньому процесі мають опановувати не лише теоретичні уявлення про сутність і механізми рефлексії, а також набували практичних навичок рефлексивної діяльності. Одним із важливих внутрішніх ресурсів особистості є професійна

рефлексія, яка забезпечує усвідомлення власних дій, переживань і професійного досвіду.

Мета дослідження. Проаналізувати теоретичні підходи до визначення поняття «професійна рефлексія» та обґрунтувати особливості даного феномену як компоненти ресурсності психологів в умовах професійної діяльності.

Результати дослідження. У філософському дискурсі поняття «рефлексія» розглядається як характеристика свідомості, пов'язана із здатністю суб'єкта усвідомлювати власну діяльність, мислення та ціннісні орієнтації (Р. Декарт); як механізм самосвідомості; як внутрішнє спостереження розуму за власними актами мислення (Г. Гегель, Е. Гусерль, І. Кант, Ж.-П. Сартр). Професійна рефлексія науковцями-мислителями розуміється як самопізнання суб'єкта, що критично осмислюється щодо власної ролі, цінностей та етичних орієнтирів у процесі професійного становлення та подальшої професійної діяльності.

У педагогічних дослідження професійної діяльності педагогічних працівників поняття професійної рефлексії зачасти розглядається як компонента структури професійної компетентності педагога. Згідно з науково-концептуальними позиціями І. Д. Бега, І. А. Зязюна, М. М. Марусинець, О. Я. Савченко, В. А. Семиченко професійна рефлексія виступає механізмом усвідомлення педагогом власної професійної діяльності, розвитку стратегій взаємодії з учнями, результатами педагогічної взаємодії та самовдосконалення. Т. С. Рябова трактує професійну рефлексію як інтегральну якість особистості, що забезпечує зв'язок між теоретичними знаннями, професійним досвідом і ціннісно-мотиваційними орієнтаціями вчителя. Вона розглядає рефлексію як умову розвитку педагогічного мислення і творчості. Л. М. Карамушкою, професійна рефлексія педагогічного працівника розглядається як чинник професійного саморозвитку, покращення якості педагогічної діяльності та попередження професійного вигорання.

Отже, у філософії професійна рефлексія постає як інструмент екзистенційного самопізнання, що має аксіологічний і смислотворчий вимір, тоді як у педагогіці – як процес аналітичного осмислення власних дій, установок і результатів професійної діяльності з метою її вдосконалення.

У психологічних дослідженнях поняття «рефлексія» інтерпретується як багаторівневий психічний механізм, що забезпечує процеси самопізнання [8], самоаналізу та саморегуляції особистості [6].

У психологічних дискурсах рефлексія також розглядається як один із механізмів усвідомлення та регуляції професійної діяльності особистості; як внутрішній психічний процес, що забезпечує осмислення суб'єктом підстав, умов і результатів власної діяльності, а також сприяє її цілеспрямованості й саморегуляції. Науковці підкреслюють, що саме рефлексія виступає психологічним підґрунтям усвідомленого професійного розвитку, дозволяючи особистості аналізувати власні дії, коригувати поведінку та підвищувати ефективність діяльності.

У контексті ресурсного підходу рефлексія трактується як здатність особистості усвідомлювати та переосмислювати власні внутрішні й зовнішні ресурси, що сприяє ефективному подоланню стресових ситуацій і професійних криз. Окремого аналізу теоретичних розробок та систематизації потребує вектор професійної рефлексії особистості: професійна рефлексія професійної діяльності психолога, що може бути ресурсом його професійного розвитку.

Науковцями професійна рефлексія психолога досліджується у трьох аспектах: як професіогенез/процес професійного розвитку, модальність психоемоційної сфери і професійна компетентність фахівця.

М. Варбан визначено наступні модули рефлексії професійного становлення особистості:

- предметний – рефлексія структури професійних інтересів, цілей, очікувань особистості; рефлексія навчально-професійних дій, результатів, досягнень; рефлексія професійно важливих якостей;

- змістовий – рефлексія в процесі професіоналізації; проблеми і протиріччя професійного становлення; чуттєве переживання та самооцінка виявлених, усвідомлених структурних одиниць Я;

- операційний – інтелектуальна, рефлексивна і практично-дійова активність задля знаходження, аналізу, синтезу, насичення змісту Я [7].

Українськими дослідниками, Л. М. Карамушкою, О. М. Кокуном, С. Д. Максименком, В. Г. Панком, Н. В. Пророк, Н. В. Чепелевою та ін., професійна рефлексія розглядається як системоформуючий компонент професійної діяльності психолога, що забезпечує інтеграцію особистісних характеристик і професійних компетентностей фахівця. Вона виступає важливим психологічним механізмом усвідомлення, аналізу та переосмислення власного професійного досвіду, регуляції діяльності відповідно до вимог професійного середовища, а також є одним із механізмів професійного становлення психолога.

Професійна рефлексія у діяльності психолога реалізується через низку взаємопов'язаних функцій. *Проективна функція* полягає у цілеспрямованому прогнозуванні, проєктуванні та моделюванні структурно-функціональної системи професійної діяльності, що дає змогу визначати стратегії та тактики професійної поведінки. *Організаторська функція* забезпечує впорядкування й координацію найефективніших способів професійної взаємодії, сприяючи оптимізації комунікативних процесів та підвищенню результативності психологічної допомоги. *Змістовна та творча функція* відображає здатність психолога до глибокого осмислення змісту власної діяльності, формування усвідомлених професійних дій і розвитку творчого підходу до розв'язання складних психологічних завдань. *Мотиваційна функція* зумовлює спрямованість професійної активності на досягнення особистісно й соціально значущих цілей,

визначаючи смислову наповненість діяльності та орієнтацію на її кінцевий результат. *Корекційна функція* проявляється у здатності фахівця до критичної оцінки власної професійної діяльності, своєчасного внесення змін, перебудови й удосконалення професійних дій відповідно до отриманого досвіду та змінних умов професійного контексту.

Таким чином, професійна рефлексія психолога розглядається як цілісний, усвідомлений і систематичний процес самоаналізу та осмислення власної професійної діяльності, спрямований на пізнання й оцінку індивідуальних когнітивних процесів, емоційних реакцій, ціннісно-смислових орієнтацій, а також тих видів та методів, які здійснює фахівець у професійній діяльності. Зазначений процес передбачає визначення впливу професійних дій психолога на характер міжособистісної взаємодії з клієнтами, якість психологічної діагностики, ефективність планування та реалізації психокорекційних і психотерапевтичних втручань. Професійна рефлексія включає механізми самоконтролю та критичного мислення, узагальнення й інтерпретацію професійного досвіду, дотримання етичних норм і чинного законодавства, а також сприяє розвитку професійних компетентностей шляхом супервізії, безперервного навчання та науково-методичного обґрунтування професійних рішень.

Узагальнюючи вищезазначене, професійна рефлексія може стати особистісним ресурсом професійного розвитку психолога, оскільки сприяє усвідомленню власних бар'єрів і потенціалу, формуванню здатності до саморегуляції та розвитку професійної ефективності.

Ресурсність особистості розглядається як інтегративна характеристика, що відображає сукупність внутрішніх психологічних можливостей і особистісних якостей, які забезпечують ефективне функціонування фахівця в умовах підвищених професійних вимог, емоційного навантаження та стресу. У структурі ресурсності особистості психолога професійна рефлексія виконує низку взаємопов'язаних функцій. Зокрема, усвідомлювальна функція забезпечує глибше

осмислення власного професійного досвіду, дій і переживань; регулятивна функція пов'язана з корекцією професійної поведінки та прийняттям обґрунтованих професійних рішень; ресурсозберігальна функція сприяє профілактиці емоційного виснаження та професійного вигорання; розвивальна функція забезпечує умови для безперервного професійного зростання та самовдосконалення.

Завдяки розвиненій професійній рефлексії психолога набуває компетентності не лише фіксувати труднощі й обмеження професійної діяльності, але й трансформувати їх у джерело особистісного та професійного розвитку. Такий рефлексивний підхід сприяє посиленню психологічної ресурсності, підвищенню адаптивності та резильєнтності фахівця в умовах інтенсивного професійного навантаження. До структури психологічних ресурсів належать емоційна стабільність, мотиваційна спрямованість, розвинені механізми саморегуляції, життєстійкість та рефлексивність, що в сукупності створюють підґрунтя для сталого професійного зростання психолога.

Ресурсність психолога доцільно розглядати як багатовимірну, динамічну систему внутрішніх психологічних ресурсів, що забезпечують стійкість, ефективність і розвиток професійної діяльності фахівця. У межах рефлексивного підходу ресурсність постає не лише як сукупність індивідуально-психологічних якостей, а як результат і водночас умова професійної рефлексії психолога. Відповідно, модель ресурсності психолога доцільно розглядати як структурно-функціональну єдність взаємопов'язаних компонентів професійної рефлексії.

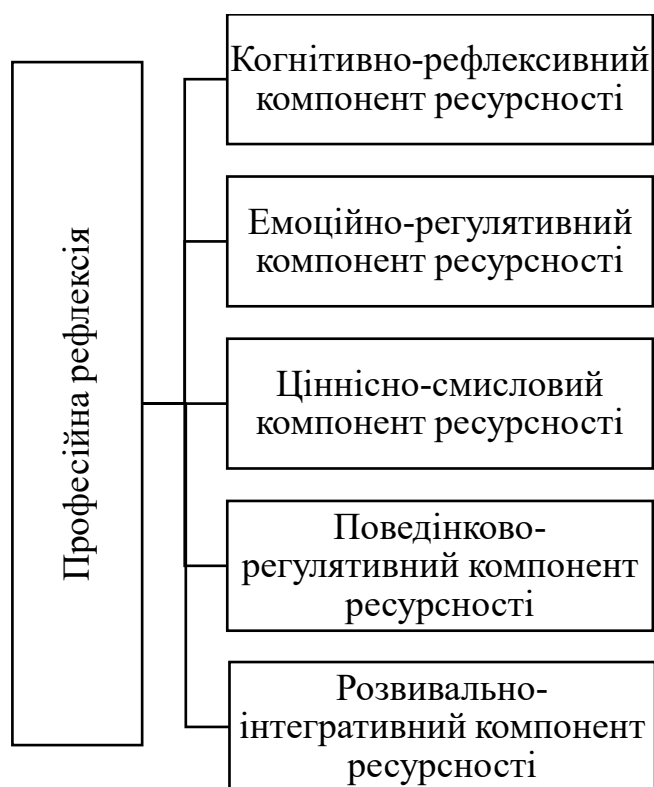


Рис. 1. Модель ресурсності психолога як компоненти професійної рефлексії

1. *Когнітивно-рефлексивний компонент ресурсності* охоплює здатність психолога до усвідомленого аналізу власної професійної діяльності, мисленнєвих процесів, теоретичних уявлень і методологічних підходів. Він включає критичне мислення, метакогнітивні навички, уміння виявляти обмеження власних знань і професійних дій, а також готовність до їх переосмислення. У структурі ресурсності цей компонент виконує функцію інтелектуального ресурсу, що забезпечує критичне розуміння професійних завдань, обґрунтованість рішень і здатність до інновацій у психологічній практиці.

2. *Емоційно-регулятивний компонент ресурсності* відображає здатність психолога усвідомлювати, приймати та регулювати власні емоційні стани, що виникають у процесі професійної взаємодії. Він передбачає розвиток емоційної стабільності, толерантності до невизначеності, здатності до емпатії без втрати професійних меж, а також навичок емоційної саморегуляції. У контексті

професійної рефлексії цей компонент виступає важливим ресурсом збереження психологічного благополуччя та запобігання емоційному виснаженню і професійному вигоранню.

3. *Ціннісно-смисловий компонент ресурсності* – усвідомлення психологом власних професійних цінностей, етичних принципів і смислів професійної діяльності. Він забезпечує внутрішню узгодженість між особистісними переконаннями та професійними стандартами, сприяє формуванню відповідального ставлення до клієнта і професії загалом. У структурі ресурсності цей компонент виконує мотиваційно-підтримувальну функцію, забезпечуючи стійкість професійної ідентичності та збереження внутрішньої мотивації до професійного розвитку.

4. *Поведінково-регулятивний компонент ресурсності* відображає здатність психолога трансформувати результати рефлексії у конкретні професійні дії. Він включає навички самоконтролю, гнучкість професійної поведінки, здатність до планування, корекції та оцінювання ефективності власної діяльності. У межах моделі ресурсності цей компонент забезпечує практичну реалізацію рефлексивних процесів і сприяє підвищенню результативності психологічної допомоги.

5. *Розвивально-інтегративний компонент ресурсності* характеризує здатність психолога інтегрувати професійний досвід, результати рефлексії та зовнішні ресурси (супервізію, професійне навчання, міждисциплінарну взаємодію) у цілісну систему особистісно-професійного розвитку. Він забезпечує динамічний характер ресурсності, сприяє професійній адаптації та безперервному професійному зростанню в умовах змінних вимог психологічної практики. Запропонована модель ресурсності психолога як системи компонентів професійної рефлексії відображає взаємозв'язок когнітивних, емоційних, ціннісних і поведінкових аспектів професійної діяльності. Професійна рефлексія у цій моделі виступає системоутворювальним механізмом, який забезпечує

актуалізацію, збереження та розвиток психологічних ресурсів, сприяючи професійній зрілості, стійкості та ефективності психолога.

Висновки. Здійснено теоретичний аналіз феномену професійної рефлексії як важливої складової ресурсності особистості. Встановлено, що професійна рефлексія є системоутворювальним психологічним механізмом, який забезпечує усвідомлення, збереження та розвиток внутрішніх психологічних ресурсів фахівця. Її сформованість сприяє підвищенню адаптаційного потенціалу, професійної ефективності особистості в умовах зростаючих професійних вимог. Проаналізовано основні підходи до трактування професійної рефлексії в психологічній науці та визначено її значущу роль у процесах саморегуляції, професійного становлення та діяльності. Обґрунтовано, що професійна рефлексія функціонує як внутрішній психологічний ресурс, який сприяє усвідомленню й інтеграції власного професійного досвіду, подоланню професійних труднощів та підвищенню адаптаційних можливостей особистості. Аналіз праць дозволив розглядати рефлексію як інтегративну властивість особистості, що зумовлює розвиток суб'єктності, відповідальності та здатності до саморозвитку. У цьому контексті рефлексія постає необхідною умовою ефективної саморегуляції поведінки, професійного розвитку та досягнення особистісної й професійної зрілості. Вона визначається як внутрішній механізм усвідомлення підстав і результатів діяльності, який забезпечує її цілеспрямований, контрольований і регульований характер.

Узагальнюючи результати теоретичного аналізу, професійну рефлексію доцільно визначати як системну здатність особистості до свідомого самоспостереження, аналізу та переосмислення власної професійної діяльності, що слугує підґрунтям для саморозвитку, самореалізації та формування професійної ідентичності. Наукові дослідження засвідчують, що рефлексія є важливим компонентом саморозвитку психологів, сприяє підвищенню рівня їхніх професійних компетентностей, якості психологічної допомоги та здатності до усвідомленої професійної діяльності. Перспективи подальших наукових розвідок убачаються в

емпіричному вивченні взаємозв'язку професійної рефлексії та компонентами ресурсності особистості, а також у розробці та впровадженні ефективних форм і методів розвитку рефлексивних навичок у процесі професійної підготовки психологів.

Список використаних джерел.

1. Завгородня О. В. Рефлексія як чинник професійного становлення психолога. *Психологія і суспільство*. 2014. № 3. С. 85–92.
2. Карамушка Л.М. Психічне здоров'я персоналу організацій в умовах війни : Навч.-методичний посібник. К.: Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 2023. 125 с.
3. Кокун О. М. Психологія професійного становлення сучасного фахівця: монографія. К.: ДП «Інформ.-аналіт. Агентство. 2012. 200 с.
4. Максименко С. Д. Психологія особистості : Київ : КММ, 2006. 296 с.
5. Максименко С. Д. Генеза здійснення особистості. Київ : КММ, 2006. 240с.
6. Найдьонова Л. М. Групова рефлексія як механізм реконструкції соціальних настановлень : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05. Київ, 2014. 246 с.
URL: <https://core.ac.uk/download/pdf/77241836.pdf>.
7. Островерхов Д. М. Рефлексивність як чинник розвитку особистості психолога-консультанта. Кв.робота. Запоріжжя. 2022. 73 с. URL: <https://dspace.znu.edu.ua/xmlui/handle/12345/11554>
8. Павелків Р. В. Рефлексія як механізм формування індивідуальної свідомості та діяльності особистості. Вісник післядипломної освіти. «серія «соціальні та оведінкові науки». 2019. № 8 (37). С. 84–98.
[https://doi.org/10.32405/2522-9931-8\(37\)-84-98](https://doi.org/10.32405/2522-9931-8(37)-84-98).
9. Панок В. В. Професійна діяльність практичного психолога : теорія і практика. Київ : Ніка-Центр, 2015. 368 с.
10. Пріб Г.А. Психологічні особливості та рівень задоволеності працю персоналом організацій в ситуації невизначеності. Колективна монографія. За заг. ред. : Г.А. Пріба, Л.Є. Бегези. Київ : Ф-ОП Гуляєв О.В., 2025. 392 с.

Психологічні особливості організації системи мотивації професійного самоздійснення фахівців юридичної сфери

Бегеза Л.Є.

*Доктор психологічних наук, професор
Академія праці, соціальних відносин і туризму, м. Київ*

Сербін Ю.В.

*Кандидат психологічних наук, доцент
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля*

Зубленко А.А

*Здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти
Академія праці, соціальних відносин і туризму, м. Київ*

Актуальність. Професійне самоздійснення є комплексним процесом, що передбачає реалізацію особистісного та професійного потенціалу фахівця в процесі трудової діяльності. Для фахівців юридичної сфери, які працюють в умовах високої соціальної відповідальності та значного навантаження, формування ефективної системи мотивації стає важливим чинником підтримки професійної активності та задоволеності роботою.

Організація системи мотивації професійного самоздійснення передбачає поєднання внутрішніх (індивідуально-психологічних) та зовнішніх (соціально-психологічних) стимулів. Внутрішні мотиви включають прагнення до професійного зростання, самовдосконалення, реалізацію цінностей справедливості та правової культури, а також розвитком компетентностей та професійній галузі. Зовнішні чинники мотивації охоплюють систему матеріального і нематеріального стимулювання, включно з фінансовим заохоченням, можливістю кар'єрного зростання, участю у професійних проектах, підвищенням статусу в колективі та професійній спільноті.

Мета дослідження. Теоретично проаналізувати та обґрунтувати структурно-функціональне моделювання практико-психологічних підходів до організації мотивації професійного й особистісного самоздійснення фахівців

юридичної сфери з урахуванням соціально-психологічних чинників професійної діяльності.

Результати дослідження. Для ефективного впровадження системи мотивації необхідно враховувати індивідуальні особливості фахівців, їхній рівень професійного самоздійснення та потребу в розвитку. Практичною основою може слугувати поетапна структура мотиваційної підтримки:

1. Діагностика професійних потреб та потенціалу фахівців – оцінювання рівня професійної компетентності, мотивації до розвитку та ступеня задоволеності професійною діяльністю.

2. Індивідуальне планування професійного зростання – формування персональних планів розвитку, участь у тренінгах, семінарах, професійних конференціях.

3. Система стимулювання та винагороди – розробка системи матеріальних і нематеріальних заохочень, що враховує досягнення фахівця та рівень його самоздійснення.

4. Формування підтримуючого професійного середовища – створення умов для колективної взаємодії, обміну досвідом та підтримки ініціативи, що підвищує внутрішню мотивацію.

5. Моніторинг та корекція мотиваційних механізмів – аналіз ефективності системи мотивації та внесення змін відповідно до потреб фахівців та стратегічних цілей організації.

Таким чином, ефективна організація системи мотивації професійного самоздійснення фахівців юридичної сфери ґрунтується на поєднанні внутрішніх стимулів та зовнішніх заохочень, індивідуальному підході до розвитку співробітників та контролі ефективності мотиваційних заходів. Такий підхід сприяє підвищенню професійної компетентності, задоволеності працею та стійкості до професійного стресу, що актуально в умовах юридичної практики.

Запропонована модель організації мотивації фахівців юридичної сфери (рис. 1.) ґрунтується на поєднанні індивідуально-психологічного та організаційного підходів. На рисунку 1 представлено структурно-функціональну модель, що демонструє організацію забезпечення професійного та особистісного самоздійснення фахівця. Модель має п'ять взаємопов'язаних рівнів, які представляють систему стимулювання професійного й особистісного розвитку, та відображає послідовність і взаємозв'язок основних мотиваційних механізмів. Також Модель може функціонувати як циклічна система, де кожен рівень впливає на наступний, а зворотний зв'язок забезпечує постійне коригування і адаптацію до змін зовнішнього середовища та індивідуально-психологічних особливостей фахівця.

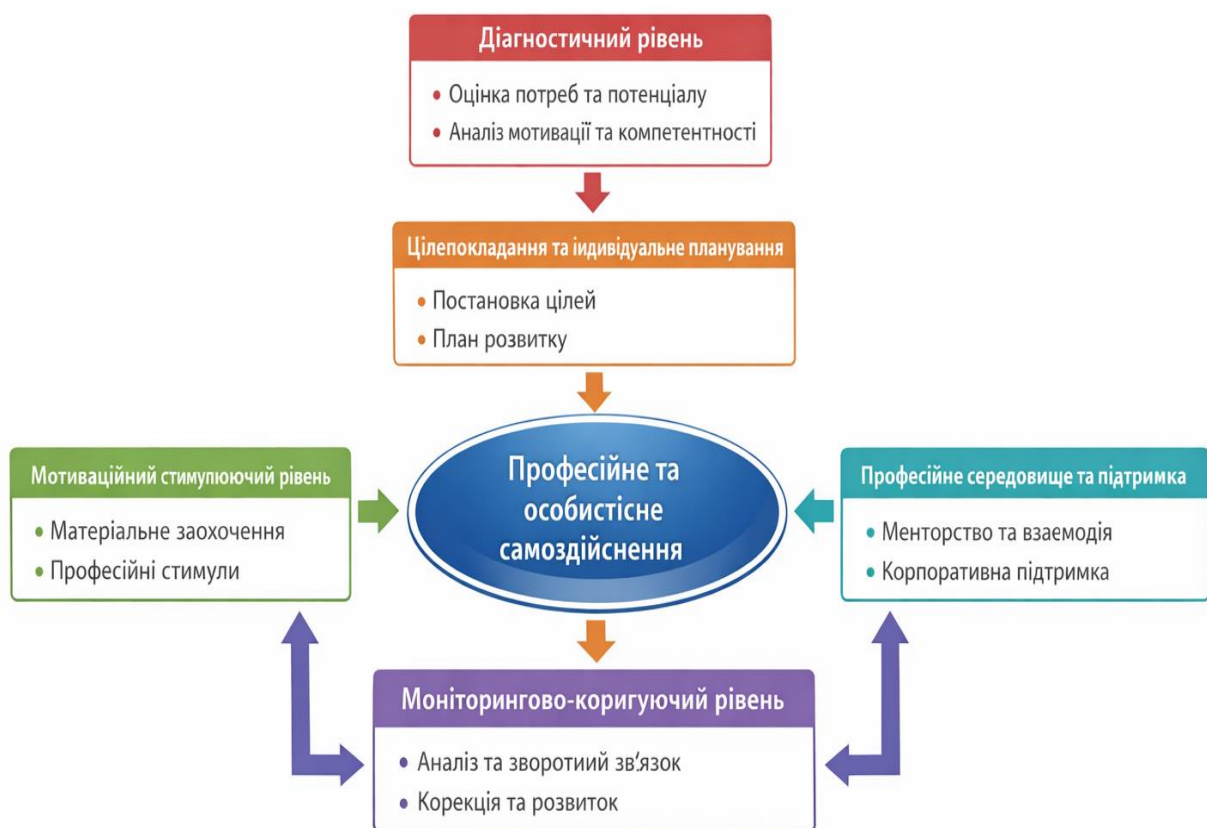


Рис. 1. Модель організації мотивації фахівців юридичної сфери до професійного та особистісного самоздійснення

Діагностичний рівень визначає потреби та мотиви фахівця, що дозволяє проаналізувати індивідуальну траєкторію його професійного розвитку. Цей рівень є першим компонентом моделі та передбачає використання опитувальників, психодіагностичних методик для визначення професійних потреб і потенціалу фахівця; вивчення рівня мотивації та готовності до особистісного і професійного зростання, професійної компетентності, задоволеності професійною діяльністю й суб'єктивного відчуття професійної ефективності. Діагностика дозволяє уникнути формального підходу до мотивації. Результати даного етапу слугують підґрунтям для побудови індивідуалізованих мотиваційних впливів і запобігають формальному підходу до професійного стимулювання.

Рівень цілепокладання та індивідуального планування, на основі результатів діагностики, формується індивідуальна траєкторія професійного розвитку фахівця, орієнтовану як на професійний, так і на особистісний розвиток, що може формувати індивідуальне відчуття професійного самоздійснення.

Формування персонального плану (індивідуальної / особистісної траєкторії) професійного розвитку включає встановлення коротко- та довгострокових цілей професійного та особистісного зростання, напрями підвищення кваліфікації, участь у професійних заходах (тренінги, курси підвищення кваліфікації, професійні проекти й ін.) та розвиток особистісних ресурсів.

На даному рівні результати діагностики є підґрунтям у визначенні конкретних цілей професійного розвитку: охоплює процес постановки реалістичних і професійно значущих цілей, а також розробку індивідуальних планів розвитку. Цей компонент забезпечує усвідомленість професійного зростання та сприяє підвищенню внутрішньої мотивації фахівців юридичної сфери.

Мотиваційний стимулюючий рівень спрямований на психологічну підтримку професійної умотивованості та закріплення досягнутих результатів. Він включає систему матеріальних і професійних стимулів, які враховують

індивідуальні досягнення фахівця, рівень його самоздійснення та внесок у діяльність організації. Також відбувається інтеграція внутрішніх (реалізація цінностей професії, самовдосконалення, задоволення від професійних успіхів) та зовнішніх (матеріальне заохочення, премії, кар'єрне просування, публічне визнання досягнень) стимулів, що забезпечує баланс між задоволенням потреб та досягненням цілей організації. Стимулювання розглядається не лише як засіб зовнішнього впливу, а як механізм підтримки професійної активності. А мотиватори визначаються не як самоціль, а як засіб підтримки довготривалої професійної мотивації. Модель передбачає поєднання матеріальних і нематеріальних стимулів, що корелюють із досягненнями фахівця, рівнем його самоздійснення та внеском у розвиток організації.

Рівень професійного середовища та підтримки відображає соціально-психологічний контекст професійної діяльності; демонструє підтримку колективу та професійних спільнот; створення атмосфери співпраці, обміну досвідом та професійної взаємної підтримки; менторство та наставництво, спрямоване на розвиток компетентності та мотивації; формування корпоративних традицій, які стимулюють активність і ініціативність, що підвищує внутрішню мотивацію та сприяє розвитку професійної ідентичності. Тобто, на даному рівні забезпечуються соціально-психологічні умови для професійного зростання: атмосфера довіри, можливість обміну досвідом, підтримка ініціативності та автономії у прийнятті рішень. Саме соціально-професійне середовище виступає домінуючим чинником внутрішньої мотивації та професійної ідентифікації. Підтримуюче середовище підсилює внутрішню мотивацію та сприяє професійному самоздійсненню.

Моніторингово-коригуючий рівень мотиваційних механізмів забезпечує систематичний аналіз ефективності мотиваційних заходів (своєчасне виявлення проблем та внесення необхідних змін); корекція планів та стимулів відповідно до змін у потребах фахівців і стратегічних цілей організації; використання зворотного зв'язку для підвищення адаптивності системи мотивації.

Завершальний елемент моделі має зворотний зв'язок із усіма попередніми компонентами. Він передбачає регулярний аналіз ефективності мотиваційної системи, оцінювання змін у професійному самоздійсненні фахівців та внесення коректив відповідно до актуальних потреб і стратегічних цілей організації. Наявність цього рівня дозволяє своєчасно реагувати на зміни професійних потреб фахівців і підтримувати ефективність мотиваційної системи в довготривалій перспективі.

Таким чином, модель організації мотивації фахівців юридичної сфери є динамічною, багаторівневою та орієнтованою на розвиток як професійного, так і особистісного самоздійснення. Модель дозволяє не тільки підвищувати рівень професійного самоздійснення, але й сприяє особистісному розвитку фахівців, формуючи мотивованих, компетентних та соціально відповідальних фахівців.

Логічним продовженням реалізації компонентів «Моделі організації мотивації фахівців юридичної сфери до професійного та особистісного самоздійснення» та їх психологічного супроводу стала розробка програми занять з елементами тренінгу, яка спрямована на розвиток мотивації фахівців юридичної сфери до професійного й особистісного самоздійснення – «Програма розвитку мотиваційного потенціалу самореалізації фахівців юридичної сфери».

Мета «Програма розвитку мотиваційного потенціалу самореалізації фахівців юридичної сфери»: сприяти формуванню та активізації внутрішніх мотиваційних ресурсів, необхідних для професійної самореалізації фахівців юридичної галузі, шляхом розвитку ціннісно-сміслових орієнтацій, підвищення рівня самоефективності та актуалізації досягальних мотивів, що забезпечують інтеграцію особистісного потенціалу в контексті професійної діяльності.

Завдання «Програма розвитку мотиваційного потенціалу самореалізації фахівців юридичної сфери»:

1. Розвиток установок на самопізнання і саморозвиток особистості:

- сприяння усвідомленню учасниками ідентичності як основи особистісної рефлексії;
- розширення знань про себе та інших членів групи з метою розвитку міжособистісної взаємодії;
- актуалізація процесу самопізнання, визначення зони найближчого особистісного розвитку та потенціалу самореалізації;
- формування навичок ефективної самопрезентації як засобу конструктивної соціальної взаємодії;
- зниження рівня емоційної та поведінкової напруженості, розвиток здатності до вербального самовираження, необхідного для аналізу власного «Я».

2. Сформувати усвідомлення значущості саморозвитку як умови професійної успішності; стимулювати рефлексію щодо власних цілей, цінностей і внутрішніх ресурсів у контексті юридичної діяльності.

3. Розвивати мотиваційні установки, спрямовані на професійне зростання та самореалізацію; актуалізувати внутрішню мотивацію до досягнення, компетентності та відповідальності.

4. Підвищити рівень суб'єктивної самоефективності; сприяти формуванню впевненості у власних професійних здібностях та здатності до подолання труднощів.

5. Формувати навички саморегуляції та самоменеджменту; розвивати здатність до постановки цілей, планування, контролю та корекції власної діяльності.

6. Інтегрувати мотиваційні ресурси в систему професійної ідентичності; забезпечити узгодження мотиваційних орієнтацій із етичними нормами, професійними стандартами та соціальними очікуваннями.

Одним із занять з елементами тренінгу може бути заняття на тему: *«Самопрезентація як інструмент самовираження особистості»*.

Цільове спрямування заняття: формування навичок конструктивної самопрезентації та усвідомлення власного образу «Я» в соціальній взаємодії.

Завдання:

- розвиток індивідуальних рис учасників через вербальні та невербальні засоби;
- аналіз впливу самопрезентації на міжособистісне сприйняття;
- формування навичок самовираження.

Методи: інтерактивні вправи, рольові ігри, елементи техніки «соціальний портрет».

Очікувані результати: підвищення впевненості у комунікативних здібностях, зниження емоційної скрутості.

Таблиця 1

Організаційна структура заняття з елементами тренінгу

Карта заняття	Цільове спрямування вправи
Вправа «Усвідомлення особистісних ресурсів у досягненні цілей»	Актуалізація досвіду власних досягнень і особистісних ресурсів як психологічної основи самопрезентації.
Вправа «Рефлексія внутрішніх психологічних бар'єрів самопрезентації»	Усвідомлення внутрішніх обмежень і установок, що ускладнюють процес самовираження, та зниження їх впливу на поведінку в ситуаціях самопрезентації.
Вправа «Структурування особистісних і життєвих цілей»	Усвідомлення та впорядкування життєвих і професійних цілей як змістовної основи формування цілісного образу «Я» у самопрезентації.
Вправа «Рефлексивний аналіз ключових подій життєвого досвіду»	Осмислення значущих подій особистого життєвого досвіду та їх ролі у формуванні індивідуального стилю самовираження.
Вправа «Проектування образу майбутнього «Я»	Формування уявлень про бажаний образ себе в майбутньому як орієнтиру для особистісного й професійного самовираження.
Вправа «Усвідомлення життєвих перспектив і стратегій самореалізації»	Аналіз життєвих перспектив і можливих стратегій самореалізації з метою забезпечення цілісності та послідовності самопрезентації.
Підсумкове обговорення «Рефлексія досвіду самопрезентації»	Інтеграція емоційного та когнітивного досвіду заняття, вербалізація емоцій і закріплення навичок усвідомленого самовираження.

Вправа «Усвідомлення особистісних ресурсів у досягненні цілей».

Мета: актуалізація уявлень учасників про власні досягнення як основу самопрезентації.

Хід вправи. Учасникам пропонується індивідуально проаналізувати власний досвід досягнення значущих цілей і письмово зафіксувати приклади успішних результатів, особистісних якостей і ресурсів, які цьому сприяли. Після завершення індивідуальної роботи проводиться обговорення у малих групах.

У процесі групової рефлексії увага акцентується на тому, як усвідомлення власних досягнень підвищує впевненість у собі та впливає на здатність до ефективного самовираження у міжособистісній взаємодії.

Вправа «Рефлексія внутрішніх психологічних бар'єрів самопрезентації».

Мета: усвідомлення внутрішніх обмежень (бар'єрів), що ускладнюють процес самопрезентації, та зниження їх психологічного впливу.

Хід вправи. Учасникам пропонується письмово визначити думки, установки або емоційні стани, які є бар'єром у презентації себе в соціальних або професійних ситуаціях. Далі проводиться обговорення в парах із фокусом на пошук альтернативних, більш конструктивних інтерпретацій.

Під час загального обговорення тренер звертає увагу на зв'язок між внутрішніми обмеженнями, самооцінкою та стилем самопрезентації.

Вправа «Структурування особистісних і життєвих цілей».

Мета: усвідомлення системи життєвих цілей як змістовної основи для формування цілісного образу «Я» у самопрезентації.

Інструкція. Учасникам пропонується індивідуально визначити короткострокові та довгострокові життєві цілі, після чого згрупувати їх за значущістю. Робота продовжується у малих групах, де учасники обговорюють спільні ціннісні орієнтири та індивідуальні відмінності.

У ході обговорення акцент робиться на тому, як чітке усвідомлення власних цілей сприяє змістовній і переконливій самопрезентації.

Вправа «Рефлексивний аналіз ключових подій життєвого досвіду».

Мета: усвідомлення значущих життєвих подій як складових особистісної історії, що формує індивідуальний стиль самовираження.

Хід вправи. Учасникам пропонується письмово визначити кілька ключових подій власного життя, які вплинули на їхній особистісний розвиток. Після цього відбувається обговорення в малих групах із фокусом на тому, як ці події можуть бути інтегровані в усвідомлену самопрезентацію.

Під час рефлексії ведучий звертає увагу на значення життєвого досвіду у формуванні автентичного образу себе.

Вправа «Проектування образу майбутнього «Я»

Мета: формування уявлень про бажаний образ себе в майбутньому як орієнтиру для особистісного та професійного самовираження.

Хід вправи. Учасникам пропонується уявити себе в перспективі кількох років і письмово описати власний образ, досягнення та стиль взаємодії з оточенням. Далі проводиться групове обговорення з акцентом на узгодженість образу майбутнього з поточними цілями та ресурсами.

У процесі обговорення підкреслюється роль уявлення про майбутнє у формуванні впевненості та цілісності самопрезентації.

Вправа «Усвідомлення життєвих перспектив і стратегій самореалізації»

Мета: усвідомлення життєвих перспектив як підґрунтя для стратегічного планування самопрезентації та самореалізації.

Хід вправи. Учасникам пропонується визначити можливі сценарії власного життєвого та професійного розвитку й проаналізувати їх з позиції особистісних цінностей. Робота завершується груповим обговоренням.

Увага зосереджується на тому, як усвідомлення життєвих перспектив сприяє більш усвідомленому, послідовному та впевненому самовираженню.

Підсумкова вправа «Рефлексія досвіду самопрезентації»

Мета: інтеграція емоційного та когнітивного досвіду, отриманого під час заняття.

Інструкція. Учасникам пропонується поділитися власними враженнями, думками та усвідомленнями щодо процесу самопрезентації, а також висловити зауваження чи побажання щодо заняття.

Обговорення спрямоване на закріплення отриманого досвіду та підвищення усвідомленості власного стилю самовираження.

Висновки. На основі теоретичного аналізу психологічної літератури професійне самоздійснення фахівців юридичної сфери визначається як динамічний процес формування і розвитку особистісно-професійної траєкторії діяльності фахівця під впливом як індивідуально-психологічних, так і соціально-психологічних чинників. Обґрунтування п'ятирівневої моделі організації мотивації фахівців юридичної сфери до професійного та особистісного самоздійснення забезпечує послідовність професійного розвитку: від діагностики мотиваційної сфери та професійних потреб до розробки мотиваційних впливів на основі зворотного зв'язку. Такий підхід дозволяє уникнути формалізації мотивації, підвищує її психологічну адресність і сприяє формуванню усвідомленої внутрішньої мотивації до професійного зростання. Організаційно-мотивуючу роль у підтримці професійного самоздійснення фахівця юридичної сфери відіграє соціально-професійне середовище, яке виступає джерелом внутрішньо-особистісної мотивації, професійної ідентифікації та соціально-психологічної адаптованості. Психологічний клімат колективу, наставництво, можливість обміну досвідом і визнання професійних досягнень покращують ефективність як матеріальних, так і нематеріальних факторів мотивації. Запропоновані «Модель організації мотивації фахівців юридичної сфери до професійного та особистісного самоздійснення» і «Програма розвитку мотиваційного потенціалу самореалізації фахівців юридичної сфери» можуть бути системним підходом для побудови ефективних систем мотивації в

юридичних організаціях, спрямованих не лише на підвищення результативності діяльності, а й на підтримку особистісного розвитку, професійної стійкості та задоволеності працею фахівців. Перспективи подальших досліджень вбачаються в емпіричній перевірці ефективності запропонованої моделі та програмного супроводу в різних умовах юридичної практики.

Список використаних джерел.

1. Бочелюк В.Й., Панов М.С., Панов Т.С. Зміст і психологічні особливості професійної діяльності юриста. Перспективи та інновації науки. 2023. Вип. 14 (32), 613–626. DOI: [https://doi.org/10.52058/2786-4952-2023-14\(32\)-613-626](https://doi.org/10.52058/2786-4952-2023-14(32)-613-626) URL: <https://perspectives.pp.ua/index.php/pis/article/view/6909>
2. Калаур І.Р., Слома В.М., Гнатів О.Б. Особливості професійної мотивації студентів-юристів. Science and Education. 2017. № 9. С. 94–98. URL: <https://scienceandeducation.pdpu.edu.ua/articles/2017-9-doc/2017-9-st14>
3. Кононенко С. В. Вплив правової свідомості на особистість фахівця юридичного профілю. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. 2013. Вип. 3. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadps_2013_3_31.
4. Ненашева Я.В. Психологічні чинники професійної деформації юристів. Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2024. 69 с. URL: <https://dspace.znu.edu.ua/jspui/bitstream/12345/24908/1/%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%AF.%20%D0%92..pdf>
5. Панов М. С. Психологічні особливості професійної діяльності юриста. Матеріали конференцій МЦНД, (м. Івано-Франківськ, 13 вер.2024 р.). Івано-Франківськ, 2024. С. 188–192. URL: <https://archives.mcnd.org.ua/index.php/conference-proceeding/article/view/176>

Життєстійкість особистості в умовах війни: соціально-психологічні чинники та ресурси

Бегеца Л.Є.

*Доктор психологічних наук, професор
Академія праці, соціальних відносин і туризму, м. Київ*

Янович Р.Є.

*Здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти
Академія праці, соціальних відносин і туризму, м. Київ*

Актуальність. Сучасний етап розвитку українського суспільства характеризується тривалим перебуванням у ситуації воєнної нестабільності, що суттєво трансформує умови життєдіяльності особистості. Повномасштабна війна в Україні спричинила різке зростання рівня стресу, невизначеності та психоемоційного напруження, що проявляється у переживаннях тривоги, страху, втрати безпеки, а також у порушеннях психічного благополуччя. Військові дії, вимушене переміщення, руйнування соціальних зв'язків і загроза життю актуалізують проблему збереження психічного здоров'я та адаптації людини до екстремальних умов.

За таких обставин особистість змушена брати на себе підвищену відповідальність за власну життєдіяльність, шукати внутрішні ресурси для подолання кризових ситуацій і підтримання ефективності професійної та соціальної активності. Особливої значущості набуває здатність людини не лише витримувати вплив тривалого стресу, а й зберігати активну життєву позицію, смислову залученість до життя та готовність до прийняття складних рішень. Саме ці характеристики відображає феномен життєстійкості особистості.

Життєстійкість розглядається в сучасній психологічній науці як інтегральний ресурс, що забезпечує адаптацію до складних життєвих обставин, збереження внутрішньої рівноваги та можливість особистісного зростання в умовах кризи. Вона тісно пов'язана зі смисложиттєвими орієнтаціями,

особистісною зрілістю, суб'єктною активністю та здатністю до саморегуляції. У воєнному контексті життєстійкість набуває особливої актуальності, оскільки сприяє переосмисленню травматичного досвіду й збереженню психологічної цілісності особистості.

Окрему увагу в цьому контексті привертають співробітники гуманітарних організацій, професійна діяльність яких відбувається в умовах постійного емоційного напруження, контакту з людським горем, втратами та високим рівнем відповідальності. Тривала робота в кризових умовах підвищує ризик емоційного вигорання, виснаження та дезадаптації, що зумовлює необхідність вивчення психологічних чинників життєстійкості цієї професійної групи та пошуку ефективних шляхів її розвитку.

Мета дослідження. Теоретичне обґрунтування та емпіричне вивчення соціально-психологічних чинників формування життєстійкості особистості в умовах війни, а також аналіз ролі усвідомлення особистісних ресурсів у забезпеченні психологічної стійкості співробітників гуманітарних організацій.

Результати дослідження. Теоретичний аналіз наукових джерел свідчить, що життєстійкість є багатовимірним психологічним утворенням, яке формується впродовж усього життєвого шляху особистості та виконує низку важливих функцій, зокрема адаптивну, регулятивну та захисну. У межах екзистенціальної психології життєстійкість розглядається як здатність особистості приймати невизначеність буття, брати відповідальність за власний вибір і зберігати залученість до життя попри наявність загроз і втрат. Ресурсний підхід підкреслює роль життєстійкості як внутрішнього потенціалу, що активізується залежно від вимог ситуації та забезпечує ефективне подолання труднощів.

Згідно з концепцією С. Мадді, життєстійкість включає три взаємопов'язані компоненти: залученість, контроль і прийняття виклику. Залученість відображає смислову включеність особистості в події власного життя та протистоїть відчуттю відчуження й апатії. Контроль пов'язаний із переконаністю у можливості впливати

на перебіг подій і знижує ризик формування безпорадності. Прийняття виклику виявляється у готовності сприймати зміни як можливість для розвитку, а не як загрозу. Узгоджене функціонування цих компонентів сприяє зниженню суб'єктивної загрозливості стресових подій і активізації адаптивних копінг-стратегій.

Емпіричне дослідження було проведене за участю співробітників міжнародної гуманітарної організації, які працюють у різних регіонах України. Для вивчення рівня життестійкості та пов'язаних із нею психологічних характеристик було застосовано комплекс психодіагностичних методик, зокрема тест життестійкості С. Мадді, тест-опитувальник особистісної зрілості, модифікаційний варіант методики «Незакінчені речення», а також глибинні напівструктуровані інтерв'ю.

Аналіз кількісних даних показав, що досліджувані з вищим рівнем життестійкості характеризуються більш вираженою суб'єктною позицією, високим рівнем внутрішнього контролю та відповідальності за власні дії. Вони демонструють здатність до осмислення складного життєвого досвіду, активне використання внутрішніх ресурсів і збереження професійної ефективності в умовах тривалого стресу. Для цієї групи характерними є орієнтація на майбутнє, гнучкість у прийнятті рішень і готовність до особистісних змін.

У респондентів із нижчим рівнем життестійкості виявлено тенденцію до зниження відчуття контролю над подіями, емоційного виснаження та труднощів у смисловому осмисленні травматичних подій. Якісний аналіз результатів глибинних інтерв'ю засвідчив, що для таких осіб більш характерними є переживання безпорадності, тривоги та потреба в зовнішній підтримці. При цьому недостатнє усвідомлення власних ресурсів ускладнює процес адаптації та підвищує ризик дезадаптивних реакцій.

Важливим результатом дослідження є встановлення значущої ролі усвідомлення особистісних ресурсів у формуванні життестійкості. Усвідомлення

власних можливостей, цінностей і життєвих смислів сприяє підвищенню рівня особистісної зрілості, активізації внутрішнього контролю та формуванню відповідального ставлення до життєвих обставин. Саме усвідомлення ресурсів виступає психологічним механізмом, який забезпечує перехід від пасивного переживання стресу до активного подолання кризових ситуацій.

Отримані результати підтверджують доцільність розробки та впровадження цілеспрямованих психологічних програм, спрямованих на розвиток життєстійкості, актуалізацію внутрішніх ресурсів і формування навичок саморегуляції у співробітників гуманітарних організацій.

Життєстійкість як інтегративний ресурс особистості в умовах тривалої кризи. У сучасних умовах тривалих соціальних потрясінь життєстійкість особистості постає не лише як окрема психологічна характеристика, а як інтегративний ресурс, що забезпечує цілісне функціонування людини в умовах невизначеності, загрози та постійного стресу. Війна як хронічний стресогенний чинник впливає не лише на емоційний стан особистості, а й на систему цінностей, життєвих смислів, уявлення про майбутнє та власні можливості. За таких обставин життєстійкість виконує роль внутрішнього регулятора, який дозволяє людині зберігати психологічну рівновагу, підтримувати відчуття контролю над життєвими подіями та залишатися залученою до соціальної й професійної діяльності.

У межах ресурсного підходу життєстійкість розглядається як динамічна система особистісних ресурсів, що актуалізуються у відповідь на вимоги середовища. Вона не є сталою величиною, а змінюється залежно від життєвого досвіду, рівня усвідомлення власних можливостей і характеру соціальної підтримки. Саме тому в умовах війни життєстійкість набуває особливого значення як фактор, що знижує ризик розвитку психоемоційного виснаження, тривожних і депресивних станів, а також професійного вигорання.

Дослідники наголошують, що життєстійкість не зводиться до простого «витримування» труднощів. Вона передбачає активну позицію особистості щодо

подолання кризових обставин, готовність брати відповідальність за власні рішення та здатність інтегрувати травматичний досвід у загальну картину життєвого шляху. У цьому сенсі життєстійкість виступає психологічною умовою особистісного зростання, оскільки дозволяє трансформувати негативний досвід у джерело нових смислів і можливостей.

Соціально-психологічні чинники життєстійкості співробітників гуманітарних організацій. Професійна діяльність співробітників гуманітарних організацій у воєнний час пов'язана з постійною взаємодією з кризовими ситуаціями, стражданнями інших людей, моральними дилемами та високим рівнем відповідальності. Такі умови створюють підвищене психологічне навантаження і потребують мобілізації значних внутрішніх ресурсів. У цьому контексті життєстійкість виступає важливою умовою збереження професійної ефективності та психологічного благополуччя.

Серед ключових соціально-психологічних чинників життєстійкості співробітників гуманітарних організацій особливе місце займають рівень соціальної підтримки, характер міжособистісних взаємин у колективі, наявність чітких професійних цінностей і відчуття значущості власної діяльності. Підтримувальне соціальне середовище сприяє зниженню суб'єктивного переживання стресу, тоді як ізоляція та відсутність емоційного зворотного зв'язку можуть посилювати відчуття виснаження й безпорадності.

Важливим чинником життєстійкості є також професійна ідентичність, яка забезпечує усвідомлення сенсу власної діяльності та її суспільної значущості. Усвідомлення того, що професійні зусилля мають реальний вплив на життя інших людей, сприяє підтриманню внутрішньої мотивації та залученості до діяльності навіть у складних умовах. Таким чином, життєстійкість співробітників гуманітарних організацій формується на перетині особистісних і соціальних ресурсів.

Психологічні механізми усвідомлення особистісних ресурсів як умова розвитку життєстійкості. Результати емпіричного дослідження засвідчили, що усвідомлення особистісних ресурсів є одним із ключових психологічних механізмів формування життєстійкості. Усвідомлення ресурсів передбачає здатність особистості ідентифікувати власні сильні сторони, цінності, життєві смисли та можливості впливу на перебіг подій. Така усвідомленість сприяє формуванню суб'єктної позиції та знижує ризик пасивного реагування на стрес.

Особи з високим рівнем усвідомлення власних ресурсів демонструють більшу гнучкість у подоланні труднощів, здатність до рефлексії та схильність до конструктивних копінг-стратегій. Вони частіше інтерпретують кризові події не як загрозу, а як виклик, що відповідає компоненту «прийняття виклику» у структурі життєстійкості. Натомість недостатнє усвідомлення ресурсів пов'язане з переживанням безпорадності, зниженням внутрішнього контролю та емоційним виснаженням.

Таким чином, розвиток життєстійкості доцільно розглядати як процес, що включає не лише формування навичок подолання стресу, а й поглиблення самопізнання, рефлексії та смислотворення. Психологічні інтервенції, спрямовані на актуалізацію особистісних ресурсів, можуть істотно підвищувати рівень життєстійкості та сприяти збереженню психічного здоров'я в умовах тривалої кризи.

Висновки. Життєстійкість особистості є інтегральною психологічною характеристикою, що забезпечує здатність людини адаптуватися до тривалих кризових умов, зберігати психічне здоров'я та ефективність діяльності. В умовах війни життєстійкість виступає ключовим ресурсом подолання психоемоційного напруження, сприяючи переосмисленню травматичного досвіду та збереженню смислової залученості до життя. Структурними компонентами життєстійкості є залученість, контроль і прийняття виклику, узгоджена взаємодія яких знижує суб'єктивну загрозовість стресових подій і активізує адаптивні копінг-стратегії.

Емпірично встановлено, що високий рівень життєстійкості пов'язаний з усвідомленням особистісних ресурсів, особистісною зрілістю та сформованою суб'єктною позицією. Недостатній рівень усвідомлення власних ресурсів ускладнює процес адаптації до кризових умов і підвищує ризик емоційного виснаження та дезадаптивних реакцій. Розвиток життєстійкості можливий шляхом цілеспрямованої психологічної роботи, спрямованої на актуалізацію внутрішніх ресурсів, формування відповідальності та смисложиттєвих орієнтацій. Результати дослідження можуть бути використані в практиці психологічного супроводу співробітників гуманітарних організацій і в розробці програм розвитку життєстійкості особистості в умовах тривалої соціальної кризи.

Список використаних джерел.

1. Бех І. Д. Особистість у просторі духовного розвитку. Київ : Академвидав, 2012. 256 с.
2. Карамушка Л. М. Психологія управління. Київ : Міленіум, 2018. 384 с.
3. Кокун О. М. Психологічні ресурси особистості в умовах стресу. Київ : Інтерсервіс, 2020. 234 с.
4. Леонтєва Д. Р. Психологія смислу. Київ : Академвидав, 2019. 487 с.
5. Максименко С. Д. Генеза здійснення особистості. Київ : КММ, 2006. 240 с.
6. Титаренко Т. М. Життєстійкість особистості: соціально-психологічний аналіз. Київ : Каравела, 2017. 312 с.
7. Чепелева Н. В. Наративні практики в психологічній допомозі. Київ : Педагогічна думка, 2015. 176 с.
8. Maddi S. R. Hardiness: The courage to grow from stresses. *Journal of Positive Psychology*. 2006. С. 160–168.
9. Maddi S. R., Khoshaba D. M. Resilience at work. New York : AMACOM, 2005. 213 с.
10. Frankl V. Man's Search for Meaning. Boston : Beacon Press, 2006. 184 с.

Психологічні особливості впливу самооцінки на мотиваційну сферу юнаків

Борець О.А.

*Доктор філософії з спеціальності «Психологія»
Академія праці, соціальних відносин і туризму, м. Київ*

Бондар С.С.

*Доктор філософії з спеціальності «Психологія»
Академія праці, соціальних відносин і туризму, м. Київ*

Карнаух Т.В.

*Здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти
Академія праці, соціальних відносин і туризму, м. Київ*

Актуальність. Виключним надбанням людини є її здатність до самооцінювання та самоставлення, що дає можливість пізнавати та усвідомлювати себе як суб'єкта дій, стаючи об'єктом безпосереднього ставлення до самої себе. Підсумковим продуктом процесу самопізнання є, по-перше, динамічна система уявлень людини про себе, свої можливості, якості і місце серед інших людей; по-друге, те, чого досягає в своєму житті людина, у вирішальній мірі залежить від розвитку її мотивації, що виявляється в сукупності спонукань, які викликають активність особистості та визначають її спрямованість. Період юнацтва є визначальним у формуванні внутрішньої позиції, життєвих планів, досягнення нового рівня розвитку самосвідомості та самоповаги; визначенням свого місця у житті. Саме у періоді ранньої юності йде інтенсивний процес становлення образу «Я», тобто цілісного уявлення людини про себе і свої можливості. На основі цього формується самооцінка, яка є регулятором поведінки та діяльності, забезпечує суб'єктну активність у діяльності, виконує функції мобілізації власних сил. Самооцінка допомагає визначатися юнаку з актуальними потребами та бажаннями, тому у цьому аспекті варто говорити і про мотивацію, яка є невід'ємною частиною становлення особистості юнака, адже саме спираючись на власні спонукання, він здатен обирати напрямки свого подальшого

особистісного зростання. Таким чином, мотиваційна сфера пов'язана з розвитком самосвідомості, усвідомлення положення власного «Я» в системі суспільних відносин людини. Особливості самооцінки в юнацькому віці аналізуються в роботах Р.Бернса, О. Бодальова, І. Кона, М. Лісіної, А. Реана, В. Століна, П. Чамати та інших. Дослідники підкреслюють значимість позитивної загальної самооцінки для тієї чи іншої діяльності, мотивації та саморефлексії юнаків. Особливості мотивації в юнацькому віці у розкрито у працях Л. Анциферової, Л. Божович, Ю. Горбенко, Є. Ільїна, Д. Леонтьєва, Р. Немова, Т. Яновської тощо. Зокрема Ю. Горбенко зазначає, що формулювання своєї Я-концепції та кристалізація світогляду є системоутворюючими факторами для метасистемного рівня організації мотиваційної сфери юнака. В той же час, аналізуючи праці, присвячені взаємозв'язку самооцінки юнака з його мотиваційною сферою, приходимо до висновку, що більшість з них розкривають вплив самооцінки на мотивацію учбової та навчально-професійної діяльності (Д. Ельконін, В. Горбунова, В. Климчук, А. Липкіна та ін.) [1–7].

Мета дослідження. Теоретичне обґрунтування та емпіричному дослідженні психологічних особливостей впливу самооцінки на мотиваційну сферу особистості в юнацькому віці. *Методи дослідження:* теоретичні методи: аналіз, узагальнення, систематизація та інтерпретація наукових джерел; емпіричні методи: бесіда, опитування, психодіагностичні методики: для виявлення рівню самооцінки: «Методика діагностики самооцінки»; для виявлення рівня мотивації схвалення: методика «Оцінка потреби у схваленні Марлоу–Крауна»; для виявлення рівня мотивації до успіху: методика «Мотивація до успіху» Т. Елерса; для виявлення рівня мотивації до уникнення невдач: методика «Мотивація до уникнення невдач» Т. Елерса. З метою визначення особливостей впливу самооцінки на мотиваційну сферу юнаків, було проведено емпіричне дослідження. На констатувальному етапі взяли участь 40 студентів віком від 18 до 21 року (22 особи жіночої статі та 18 осіб чоловічої статі) вищих навчальних закладів міста Києва.

Результати дослідження. За результатами методики діагностики самооцінки було визначено, що 15,0 % респондентів мають завищений рівень самооцінки 60,0 % відносяться до представників середнього рівня, та 25,0 % юнаків мають занижений рівень самооцінки. Більше половини юнаків мають середній рівень розвитку самооцінки та, відповідно до цього, адекватно оцінюють свої здобутки та самих себе. Це дозволяє юнакам реалістично дивитися на ситуацію, не потерпати від неадекватних думок щодо себе та використовувати свою самооцінку в якості інструменту для досягнення своїх цілей. При цьому майже третина сучасних юнаків мають занижений рівень самооцінки, що говорить про них, як про невпевнених в собі та своїх силах особистостей. Та лише одна шоста юнаків мають завищену самооцінку, що також говорить про невміння правильно оцінити результати своєї діяльності та порівнювати себе з іншими. Також за результатами даної методики, було з'ясовано, що 25,0 % респондентів мають високий рівень прояву домагань, у той час як 65,0 % мають середній рівень, та лише 10,0 % досліджуваних виявили низький рівень прояву домагань. Більшість сучасних юнаків здатна адекватно ставити собі цілі, відповідні до своїх можливостей та вмінь, а також мають оптимальне уявлення про свої можливості, що є важливим чинником особистісного зростання.

У той же час у четвертій частини юнаків наявне нереалістичне, некритичне ставлення до власних можливостей. Слід також зазначити, що лише десята частина сучасних юнаків мають низький рівень домагань, що також говорить про те, що більшість сучасних юнаків не схильна ставити перед собою цілі нижчі за свої можливості. Відповідно до результатів, зазначених вище, було також виявлено різницю між рівнем розвитку самооцінки та рівнем прояву домагань респондентів. Відповідно до цього було виявлено наступне: у 15,0 % різниця між рівнем розвитку самооцінкою та рівнем прояву домагань є низькою, у 60,0 % – помірною, та лише у 25,0 % вона є високою. Для шостої частини сучасних юнаків рівень домагань не є стимулом для розвитку, у той час як у чверті сучасних юнаків

з високою різницею між рівнем самооцінки та рівнем домагань може простежуватися конфлікт між тим, до чого людина прагне та якою насправді вважає себе.

Та все ж таки у більшості юнаків рівниці між даними показниками є помірною, що говорить про адекватність виставлених цілей. За результатами методики «Оцінка потреби у схваленні Марлоу–Крауна» було виявлено, що 20,0 % респондентів мають високий рівень прояву мотивації схвалення, у той час як половина (50,0 %) респондентів мають прояв даного показника якості на середньому рівні, та 30,0 % – на низькому рівні. Виявлено, що п'ята частина сучасних юнаків мають високий рівень прояву мотивації схвалення. Такі люди характеризуються бажанням видавати себе за когось іншого: для них є важливим, аби інші їх підтримували та схвалювали, що час від часу може загострюватися настільки, що людині значно простіше стає відмовитися від власних бажань та вподобань, аніж стикнутися з неприйняттям та докорами оточуючих. У той же час половина сучасних юнаків мають помірний прояв мотивації схвалення, що говорить про них як про таких, що бажають виглядати в очах оточуючих адекватно, «нормально», так, як властиво більшості людям та є соціально прийнятним. Одночасно з цим такі люди залишають собі простір для самостійності в судженнях про себе, що дозволяє їм бути лабільними та не губити себе остаточно під натиском суспільних очікувань.

Разом із цим, у третини респондентів було діагностовано низький рівень прояву мотивації схвалення з боку інших людей. Тобто такі юнаки проявляють незалежність від оточуючих настільки, що може здатися, ніби вони повністю ігнорують соціальні думки щодо себе. Також можна говорити про те, що їм не властива категоричність суджень на свою адресу та вони не намагаються виглядати в очах оточуючих краще, ніж є насправді і тим самим вони можуть займати свою позицію за межами соціального схвалення.

За методикою «Мотивація до успіху» Т. Елерса було виявлено, що 5,0 %

досліджуваних отримали дуже високий рівень вираження мотивації успіху, у той час як 25,0 % виявили високий рівень вираження даного типу мотивації, а середній рівень було діагностовано у 45,0 % особистостей юнацького віку. При цьому низький рівень вираження мотивації успіху мають 25,0 %. Так, лише двадцята частина сучасних юнаків мають дуже високий рівень прояву мотивації до успіху, що характеризує їх як таких, які беруться за будь-яку справу заради перемоги. Для таких юнаків перспектива успіху вагоміша за перешкоди, через що вони мають високу готовність до ризику. У той ж час чверть осіб юнацького віку продемонструвала високий рівень прояву мотивації успіху, який відрізняється низьким переживанням надії на успіх, адже респонденти з таким рівнем прояву надають перевагу ілепокладанню, аніж розмірковуванням про досягнення можливих висот. Вони є активними, ініціативними та наполегливими у своїй діяльності, їх продуктивність не залежить від зовнішнього контролю. При виконанні проблемних та важких завдань результативність діяльності таких юнаків, як правило, покращується. Також ці юнаки мають силу волі, самоконтроль несуть відповідальність за свої дії, що неодмінно підвищує їхню успішність під час вирішення завдань. Вони не бояться помилок та здатні до ризику. Середній рівень прояву мотивації до успіху було констатовано майже у половини сучасних юнаків, що говорить про помірну орієнтацію на переживання надії на успіх та готовність до ризику. Такі люди у разі виникнення у них важливої для них потреби або бажання, готові докладати зусилля заради досягнення своєї мети, проте вони не забувають і про можливі перешкоди, труднощі на своєму шляху, а тому тверезо оцінюють ризики. Низький рівень прояву мотивації успіху властивий чверті осіб юнацького віку та говорить про те, що такі люди не готові ризикувати заради власних цілей та нерідко обирають шлях надії на успіх, аніж плідній праці з метою його досягнення.

У свою чергу, за методикою «Мотивація до уникнення невдач» Т. Елерса були отримані такі результати: дуже високий рівень вираження мотивації до

уникнення невдач було виявлено у 15,0 %, у той час як високий рівень – у 20,0 % осіб юнацького віку. Середній рівень вираження даного типу мотивації було діагностовано у 55,0 % респондентів, а 10,0 % юнаків мають низький рівень вираження мотивації до уникнення невдач.

Встановлено, що шоста частина осіб юнацького віку має дуже високий рівень прояву мотивації до уникнення невдач, що свідчить про те, що вони схильні проявляти низьку готовність до ризику, адже бажають максимально зберегти ті умови, в яких перебувають наразі. Незалежно від своїх бажань, втрата комфорту та відчуття стабільності занадто сильно лякає таких юнаків, а страх невдачі підсилює побоювання втратити все та не отримати нічого натомість. У той же час, п'ята частина респондентів має високий рівень прояву мотивації до уникнення невдач, що говорить про те, що такі юнаки здатні на певні ризики тоді, коли їхнє бажання досягнення певної мети достатньо сильне, аби покинути особистісну зону комфорту. Середній рівень прояву мотивації до уникнення невдач представлений більше, ніж у половини досліджуваних та говорить про помірну готовність таких юнаків ризикувати. Вони згодні та готові покинути безпечні та стабільні для себе умови за наявності чіткої аргументації щодо бажаних цілей, проте у той же час не є схильними заглиблюватися в афективні ейфорійні стани без урахування ризику невдач. Низький рівень прояву мотивації до уникнення невдач представлений лише десятою частиною респондентів, що говорить про відсутність у більшості представників даної вікової групи прагнень без роздумів та обмірковувань залишати свою зону комфорту та встрягати у неперевірені та ненадійні справи.

Таким чином більшість юнаків (60,0 %) мають середній рівень розвитку самооцінки, що свідчить про реалістичну, адекватну самооцінку. Такі юнаки, оцінюють себе, свої здібності, моральні якості та вчинки реалістично, відповідно до ситуації. Вони можуть ставитися до себе критично і правильно співвіднести свої сили із завданнями різної складності та з вимогами навколишніх. Окрім того,

більшість юнаків (65,0 %) продемонстрували середній рівень прояву домагань, що свідчить про впевненість у своїх силах, про постановку цілей адекватних можливостям, прагнення до поліпшення своїх досягнень, наполегливість та продуктивність.

Половина респондентів 50,0 % продемонстрували середній рівень прояву мотивації схвалення, що свідчить про прагнення юнаків виглядати перед оточуючими такими, якими є насправді, що властиво більшості людей і є оптимальним показником соціальної бажаності. Прояв показника мотивації досягнення успіху у 45,0 % респондентів знаходиться на середньому рівні, засвідчує про достатню сформованість усіх компонентів мотивації, про прагнення до опанування знаннями й навичками, про докладання зусиль для досягнення бажаного результату; при цьому порівну (по 25,0 %) юнаків виявилось як таких, що мають високий рівень (мислять позитивно, їх життєвий напрямок направлений на розкриття своєї особистості в задуманих проектах, а не на уникнення невдач; є активними, ініціативними та наполегливими) у та одночасно низький рівень прояву мотивації до успіху (орієнтовані лише на формальний результат своєї діяльності). Більшість юнаків 55,0 % продемонстрували середній рівень прояву мотивації до уникнення невдач, що свідчить про деяке занепокоєння, страх перед невдачею, ставлять перед собою цілі, що дозволяють уникати не схвалення і почуватися у безпеці.

Аналіз зв'язку та впливу рівня розвитку самооцінки з рівнями прояву мотивації схвалення, мотивації досягнення успіху та мотивації уникнення невдач у юнаків виявив наступне. Зв'язок між рівнем розвитку самооцінки та рівнем прояву мотивації схвалення було виявлено обернений кореляційний зв'язок на рівні значимості 0,01 ($p \leq 0,01$). Між рівнем розвитку самооцінки та рівнем прояву мотивації успіху було виявлено прямий кореляційний зв'язок на рівні значимості 0,01 ($p \leq 0,01$). Між рівнем розвитку самооцінки та рівнем прояву мотивації до уникнення невдач було виявлено обернений кореляційний зв'язок на рівні

значимості 0,01 ($p \leq 0,01$). Між рівнем прояву домагань та рівнем прояву мотивації схвалення було виявлено обернений кореляційний зв'язок на рівні значимості 0,01 ($p \leq 0,01$). Між рівнем прояву домагань та рівнем прояву мотивації успіху було виявлено прямий кореляційний зв'язок на рівні значимості 0,01 ($p \leq 0,01$). Між рівнем прояву домагань та рівнем прояву мотивації до уникнення невдач було виявлено обернений кореляційний зв'язок на рівні значимості 0,01 ($p \leq 0,01$).

Так, наявність оберненого кореляційного зв'язку між рівнем розвитку самооцінки та рівнем прояву мотивації схвалення говорить про те, що чим вищий рівень розвитку самооцінки особистості юнацького віку, тим нижчим є рівень прояву у них мотивації схвалення. Це пояснюється тим, що з підвищенням рівня самооцінки людина стає більш впевненою у собі. Вона починає вірити у власну значимість, унікальність та цінність, та починає з більшою позитивністю відноситися до власних проявів. В результаті цього вона починає менше спиратися на думки та схвалення оточуючих, та потребує лише адекватної підтримки зі сторони інших, адже стає сама для себе підтримкою також. З підвищенням самооцінки людині легше себе проявляти, не спираючись при цьому на соціальні стандарти як єдино вірні. Результат регресійного аналізу довів наявність впливу самооцінки на рівень вираження мотивації схвалення (додаток В). У той же час наявність оберненого кореляційного зв'язку між рівнем прояву домагань та рівнем прояву мотивації схвалення говорить про те, що чим вищий рівень домагань особи юнацького віку, тим нижчим є рівень прояву у них мотивації схвалення. Це пояснюється тим, що людина з підвищенням рівня домагань починає адекватно ставити собі цілі та починає їх поважати, в результаті чого юнак стає менш готовим відмовлятися від них заради соціальних стандартів.

Наявність прямого кореляційного зв'язку між рівнем розвитку самооцінки та рівнем прояву мотивації успіху свідчить про те, що чим вищий рівень самооцінки особистості юнацького віку, тим вищим є рівень прояву у них мотивації успіху. Це пояснюється тим, що з підвищенням рівня самооцінки юнак

здатен надавати перевагу цілепокладанню, аніж розмірковуванням про досягнення можливих цілей. Люди з високою самооцінку вірять у свою здатність досягти успіху, через що докладають чимало зусиль для того аби їхні плани справдилися.

Наявність прямого кореляційного зв'язку між рівнем прояву домагань та рівнем прояву мотивації успіху говорить про те, що чим вищий рівень прояву домагань осіб юнацького віку, тим вищим є рівень прояву у них мотивації успіху. Це пояснюється тим, що з підвищенням рівня домагань людина ставить собі більш складні цілі та адекватно оцінює можливість їхніх досягнень, в результаті чого вона здатна орієнтуватися на успішне виконання поставлених завдань, адже впевнена, що має для цього усі ресурси.

Наявність оберненого кореляційного зв'язку між рівнем розвитку самооцінки та рівнем прояву мотивації до уникнення невдач свідчить про те, що чим вищий рівень самооцінки осіб юнацького віку, тим нижчим є рівень прояву у них мотивації до уникнення невдач. Це пояснюється тим, що з підвищенням рівня розвитку самооцінки людина здатна віднаходити сили у собі, а не в підвищеній потребі стабільності та безпеці. У такому випадку людина здатна вийти із своєї зони комфорту, адже відчуває себе впевненою в собі і в ситуаціях, що відрізняються від звичних.

Наявність оберненого кореляційного зв'язку між рівнем прояву домагань та рівнем прояву мотивації до уникнення невдач говорить про те, що чим вищий рівень домагань особи юнацького віку, тим нижчим є рівень прояву у них мотивації до уникнення невдач. Це пояснюється тим, що чим вищим є рівень домагань, тим важливішими для людини є досягнення власних цілей за особистісні страхи. Вихід із звичного середовища (зони комфорту) має змогу стати аргументованою необхідністю, а також побоювання щодо втрати стабільності свого життєвого устрою відступають на інший план, поки основну увагу юнак приділяє своїм планам та задумам.

Висновки. У більшості юнаків було виявлено середній рівень розвитку самооцінки, розвитку мотивації, прояву домагань, прояву мотивації до схвалення, прояву мотивації досягнення успіху та мотивації до уникнення невдач, що підпадає під визначення норми самооцінки і про достатню сформованість усіх компонентів мотивації даного вікового періоду. В той же час, у майже половини юнаків все ж таки спостерігаються проблеми з самооцінкою у бік її заниження або завищення, а майже у кожного четвертого є висока залежність від думки оточуючих і у кожного п'ятого високий рівень прояву мотивації до уникнення невдач. Особливості впливу рівня розвитку самооцінки на складові мотиваційної сфери юнаків проявляються в тому, що чим вищий рівень розвитку самооцінки, тим нижчим є рівень прояву мотивації схвалення та мотивації до уникнення невдач, і тим вищим є рівень прояву мотивації успіху; чим вищий рівень прояву домагань, тим нижчим є рівень прояву мотивації схвалення та мотивації до уникнення невдач, і тим вищим є рівень прояву мотивації до успіху.

Список використаних джерел.

1. Горностаї П.П. Особистість та роль. Рольовий підхід у соціальній психології особистості. Київ: Інтерпрес ЛТД, 2007. 312 с.
2. Карамушка Л.М. Рольова гра.// Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України ; головний ред. В.Г. Кремень. К. : Юрінком Інтер, 2008. 1040 с.
3. Киричук О.В., Тарасюк С.О. Психологічні особливості Я–концепції безробітного : навч.-метод. посіб. К. : ІПК ДСЗУ, 2012. 148 с.
4. Маслоу А. Самоактуалізація / пров. з англ. Психологія особистості. Тексти/під ред. Ю. Б. Гіппенрейтер, А. А. Пухиря. К.: 1982. С. 108–118.
5. Erikson E. G. Identity: youth and crisis.: Progress, 1996. 344 p.
6. Murray H. A. Explorations in Personality: A Clinical and Experimental Study of Fifty Men of College Age. N. Y. : Oxford University Press, 1938. P. 145.
7. Self-esteem: The puzzle of low self-regard / Ed. by R. F. Baumeister. New York, London, 1993.

Функціонально-структурна модель емоційного інтелекту жінок-мігранток у контексті соціально-психологічної адаптації

Борець О.А.

*Доктор філософії з спеціальності «Психологія»
Академія праці, соціальних відносин і туризму, м. Київ*

Мироновська О.В.

*Здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти
Академія праці, соціальних відносин і туризму, м. Київ*

Актуальність. Сучасний світ переживає затяжний період соціально-політичної нестабільності, що супроводжується зростанням кількості воєнних конфліктів, економічних криз і масштабних суспільних змін. Особливо гостро це відчулося після початку повномасштабної збройної агресії російської федерації проти України, яка спричинила безпрецедентну хвилю вимушеної міграції. За даними Міжнародної організації з міграції, понад шість мільйонів українців були змушені залишити свої домівки, і значну частину з них становлять жінки працездатного віку, часто разом із дітьми на утриманні.

Жінки-мігрантки належать до найбільш уразливих категорій населення, адже їхнє життя змінюється одночасно у багатьох вимірах – від побутового та емоційного до професійного. Вони втрачають звичне оточення, робоче місце й професійний статус, підтримку сім'ї та близьких, а також нерідко стикаються з обмеженим доступом до медичної й психологічної допомоги. Мовний бар'єр, культурні відмінності та ризик дискримінації утворюють комплекс взаємопов'язаних викликів. На відміну від добровільної міграції, вимушене переселення є для людини кризою, яка виходить за межі звичного життєвого сценарію, і часто супроводжується підвищеною тривожністю, почуттям ізоляції, фрустрацією та зниженням психологічної стійкості.

Додатковими перешкодами на шляху адаптації стають труднощі в налагодженні нових соціальних контактів, невизначеність правового статусу та

відсутність відчуття належності до спільноти. У таких умовах особливої ваги набуває емоційний інтелект – здатність усвідомлювати, розпізнавати та регулювати власні емоційні стани, розуміти емоції інших і будувати конструктивну взаємодію. Розвинений емоційний інтелект допомагає зберігати внутрішню рівновагу, встановлювати довірливі стосунки, підтримувати психологічну стійкість і долати соціокультурні бар'єри. Саме він може стати важливим психологічним ресурсом, який сприяє не лише емоційній стабільності, а й успішній соціальній інтеграції.

Вивчення емоційного інтелекту в контексті вимушеної міграції дозволяє глибше зрозуміти механізми соціально-психологічної адаптації жінок-мігранток та визначити ефективні інструменти її підтримки. Саме в поєднанні особистісних ресурсів і здатності до емоційної саморегуляції можна побачити основу функціонально-структурної моделі емоційного інтелекту, яка відіграє провідну роль у подоланні кризових викликів та відновленні внутрішньої рівноваги.

Науковий інтерес до феномену емоційного інтелекту значно активізувався у другій половині XX ст., особливо після фундаментальних праць Дж. Майєра та П. Саловея. Ці дослідники окреслили емоційний інтелект як здатність людини розпізнавати, інтерпретувати та регулювати емоційні стани власні й чужі, заклавши основу так званої «моделі здібностей». Розвиток цієї концепції у співпраці з Д. Карузо дозволив виокремити чотири її ключові компоненти: сприйняття емоцій, їхнє використання у процесах мислення, розуміння емоційної динаміки та ефективне управління емоційними проявами [1; 4; 10].

Подальше розширення теоретичної бази відбувалося під впливом ідей Г. Гарднера про множинний інтелект, у межах, яких особливого значення набули міжособистісний та внутрішньоособистісний інтелекти. Перший безпосередньо пов'язаний зі здатністю до емпатії та налагодження соціальних взаємодій, другий – із самопізнанням і внутрішньою саморегуляцією [1].

Вагомий внесок у прикладний вимір дослідження здійснив Д. Гоулман, автор «змішаної моделі» емоційного інтелекту, яка інтегрує когнітивні здібності та особистісні риси. Він виділив п'ять базових компетентностей: самосвідомість, уміння управляти власними станами, внутрішню мотивацію, емпатійність та соціальні навички [13]. У випадку жінок-мігранток саме ці характеристики мають вирішальне значення, адже вони впливають на процеси соціальної адаптації, інтеграції в нові професійні спільноти та збереження психологічної стійкості.

Інший важливий підхід, розроблений Р. Бар-Оном, розглядає емоційний інтелект як інтегральну систему міжособистісних і внутрішньоособистісних умінь, здатності до адаптації, стресостійкості та підтримання позитивного емоційного фону [112]. Ця модель особливо релевантна в умовах вимушеної міграції, де ефективна адаптація залежить не лише від когнітивних ресурсів, а й від здатності долати психологічні та соціальні виклики. Концепція емоційної грамотності К. Штайнера зосереджує увагу на розвитку морально-емоційних якостей – щирості, відповідальності, здатності до співпереживання та формування безпечної емоційної комунікації. Запропоновані ним п'ять ключових умінь (усвідомлення емоцій, емпатія, контроль емоційних реакцій, відповідальність за власні стани та ефективна взаємодія) створюють основу для налагодження соціальних контактів і подолання культурного бар'єра в приймаючому середовищі [4].

В українських дослідженнях емоційний інтелект розглядається в тісному зв'язку зі стійкістю до стресу. Так, І. Андрєєва акцентує на емоційній регуляції як складнику психологічної культури, Н. Манойлова підкреслює важливість розвитку емоційної культури в умовах інформаційного перевантаження, а Е. Почтарьова аналізує значення емоційної компетентності для творчої та інноваційної діяльності [1].

Проблематика міграційного досвіду вивчалася у працях О. Блінової, яка розкриває соціально-психологічні чинники подолання кризових станів вимушених переселенців, та І. Галян і І. М. Євченко, що наголошують на впливі

підвищеної тривожності та емоційного напруження на процес адаптації [4; 5]. Л. Карамушка [6] у своїх дослідженнях виявила, що у внутрішньо переміщених осіб часто фіксуються порушення емоційної регуляції, а О. Овсянікова [10] визначила комунікативні та емоційні навички як ключові інструменти інтеграції жінок-мігранток. І. Пилипенко [11] акцентує на впливі емоційної стабільності та соціальної підтримки на суб'єктивне благополуччя жінок у новому середовищі. Схожі висновки подає Н. Науменко [9], відзначаючи роль емоційного інтелекту у запобіганні професійному вигоранню. Практичні аналітичні огляди О. Гладунова [2] та О. Малиновської [8] висвітлюють труднощі працевлаштування, мовні бар'єри та проблеми визнання кваліфікацій, що додатково ускладнює інтеграцію мігранток у професійне середовище.

Міжнародні емпіричні дані, зокрема результати роботи Hodge L., Morda R., Castro A. P., Bamforth J., Jones A., підтверджують: жінки-біженки з високим рівнем емоційної гнучкості та навичками саморегуляції легше долають дискримінацію та міжкультурні непорозуміння [14]. Європейські опитування українців (2023) демонструють, що понад 70,0 % респондентів вважають мовний бар'єр ключовою перепорою працевлаштування, а третина повідомляє про дискримінаційні випадки.

Таким чином, аналіз наукових та емпіричних джерел дозволяє зробити висновок, що емоційний інтелект виконує функцію адаптивного ресурсу, що сприяє інтеграції жінок-мігранток у нове соціокультурне та професійне середовище, підтримує психологічну рівновагу та сприяє збереженню професійної ідентичності. Подальші дослідження цього напрямку мають значний потенціал для створення дієвих програм соціально-психологічної підтримки.

Мета дослідження. На основі аналізу сучасних концептуальних підходів до визначення емоційного інтелекту як соціально-психологічного феномену побудувати його функціонально-структурну модель, що дасть змогу обґрунтовано підібрати діагностичний інструментарій та визначити роль емоційного інтелекту

як ключового чинника соціально-психологічної адаптації жінок-мігранток в умовах вимушеної міграції. *Методи дослідження.* Методологічну основу становить аналіз вітчизняних і зарубіжних наукових джерел з питань емоційного інтелекту, соціально-психологічної адаптації та міграційних процесів. Використано методи порівняльного та логіко-семантичного аналізу, а також елементи контент-аналізу звітів міжнародних організацій, що досліджують становище жінок у міграційних умовах.

Результати дослідження. Дослідження соціально-психологічної адаптації жінок-мігранток у сучасних умовах неможливе без урахування тих психологічних ресурсів, які допомагають їм долати труднощі інтеграції в нове середовище. Одним із таких ресурсів, що має комплексний і багатовимірний характер, є емоційний інтелект. Його роль особливо зростає тоді, коли зміна країни проживання відбувається не за власним бажанням, а з причин, пов'язаних із війною, соціальною або економічною кризою. Потрапляючи до незнайомого культурного простору, жінки опиняються перед низкою завдань – від пошуку засобів комунікації та відновлення соціальних зв'язків до формування нових моделей повсякденного життя й професійної реалізації.

У таких ситуаціях емоційний інтелект виступає не лише внутрішнім психологічним механізмом регуляції, а й своєрідним «містком» між особистістю та новим соціумом. Здатність точно розпізнавати й називати власні емоції, розуміти почуття інших, адаптивно реагувати на зміни та будувати конструктивну взаємодію створює основу для ефективної інтеграції. Це особливо важливо у випадку вимушеної міграції, коли людині доводиться швидко орієнтуватися в умовах культурної відмінності та браку звичних систем підтримки.

Наукові підходи до вивчення емоційного інтелекту демонструють значне різноманіття моделей і трактувань. Як відзначає К. Макссьом у своїй роботі, сучасна наука розглядає емоційний інтелект крізь призму кількох провідних

концептуальних моделей, кожна з яких пропонує власну структуру компонентів і специфічні методи вимірювання, а саме:

– *модель здібностей* Дж. Мейєра, П. Саловея та Д. Карузо розуміє емоційний інтелект як набір когнітивних умінь, що охоплюють сприйняття й вираження емоцій, їх використання у процесі мислення та свідоме управління ними. Для оцінки цих здібностей створено тест MSEIT, який базується на завданнях із правильними відповідями, подібних до тестів інтелекту. Хоча цей підхід має сильні сторони, він також зазнає критики через надмірну орієнтацію на когнітивну складову й певні обмеження об'єктивності;

– *змішана модель* Д. Гоулмана поєднує когнітивні, особистісні та соціальні компетентності, серед яких – самосвідомість, самоконтроль, соціальна чуйність та управління відносинами. Її вимірюють за допомогою методики Emotional Competence Inventory, орієнтованої переважно на сферу менеджменту та лідерства;

– *модель Р. Бар-Она* визначає емоційний інтелект як сукупність некогнітивних навичок і здібностей, що сприяють ефективному подоланню стресу та збереженню психологічного благополуччя. У її структурі виокремлюють п'ять ключових компонентів: внутрішньо-особистісний, міжособистісний, адаптивність, регуляцію стресу та загальний настрій. Інструментом вимірювання виступає опитувальник EQ, який, однак, відзначається суб'єктивністю оцінок;

– *когнітивна модель* Д. В. Люсіна зосереджує увагу на розумінні й регуляції як власних, так і чужих емоцій, виключаючи особистісні риси з переліку складників EI. Для оцінки використовується опитувальник «EmIn», простий у застосуванні, але такий, що потребує додаткової перевірки валідності;

– *диспозиційна модель* К. В. Петридеса та А. Фернгема інтегрує попередні напрацювання, але робить акцент на стабільних особистісних рисах, що впливають на емоційне функціонування. Оцінювання здійснюється за допомогою

методики TEIQue, яка має повну, скорочену та дитячу версії, але викликає дискусії щодо об'єктивності результатів;

– *інформаційно-перероблювальна модель* Е. Л. Носенко описує емоційний інтелект як ієрархічну систему, у якій виокремлюють три рівні розвитку – низький, середній і високий. Вони відповідають різним рівням складності психічного відображення активності людини та взаємодії з навколишнім світом [7].

Порівняльний аналіз зарубіжних і вітчизняних підходів свідчить: хоча існує чимало різних трактувань, усі вони сходяться на розумінні емоційного інтелекту як здатності розпізнавати та регулювати емоційні стани, оптимізуючи власну поведінку та взаємодію з іншими. Дискусійним залишається лише питання деталізації його компонентів. У контексті соціально-психологічної адаптації жінок-мігранток постає необхідність створення практично орієнтованої функціонально-структурної моделі емоційного інтелекту, здатної врахувати специфіку їхніх потреб і стати основою для ефективної діагностики та розвитку цього ресурсу з метою підтримки адаптаційних процесів у новому середовищі.

Спираючись на узагальнення К. Макс'юм та результати критичного аналізу сучасних вітчизняних і зарубіжних досліджень, доцільним видається розроблення авторської функціонально-структурної моделі емоційного інтелекту, адаптованої до особливостей життя та викликів, з якими стикаються жінки-мігрантки. Модель враховує специфіку соціально-психологічної адаптації в умовах вимушеного переселення і поєднує внутрішньо-особистісні та міжособистісні аспекти емоційної компетентності. Важливо підкреслити, що всі структурні компоненти взаємопов'язані: розвиток лише одного з них не забезпечить належного результату. Натомість модель дозволяє добирати цілісний комплекс вправ та визначати їхню послідовність для поступового формування необхідних навичок і якостей.

Запропонована структура включає дев'ять взаємопов'язаних компонентів: усвідомлення власних емоцій, управління власними емоціями, емпатія, розпізнавання емоцій інших, регуляція емоцій у міжособистісних стосунках, самомотивація, внутрішній контроль, адаптивна поведінка у стресових ситуаціях, інтеграція емоційного досвіду в процес прийняття рішень.

Кожен із цих компонентів відіграє окрему, але взаємодоповнювальну роль у процесі соціально-психологічної адаптації жінок-мігранток. Їхній добір не є випадковим: у структурі поєднані як класичні елементи, відображені у відомих теоріях емоційного інтелекту (Д. Гоулман, П. Саловей, Дж. Маєр), так і показники, що спеціально враховують особливості адаптації у міграційних умовах [13]. Такий підхід охоплює як внутрішні, так і зовнішні аспекти емоційного інтелекту, доводячи їх значущість для ефективної інтеграції у нове середовище:

1. *Усвідомлення власних емоцій* є однією з базових передумов успішної соціально-психологічної адаптації. Коли жінка здатна чітко ідентифікувати власні емоційні стани – наприклад, розрізнити миттєве роздратування, викликане дрібною незручністю, від глибинної тривоги, що пов'язана з невизначеністю майбутнього, – вона отримує можливість своєчасно локалізувати джерело стресу. Це, у свою чергу, сприяє збереженню емоційної рівноваги, адекватнішому реагуванню на зміни середовища та зменшенню ризику емоційного вигорання.

2. *Керування власними емоціями* передбачає здатність свідомо впливати на інтенсивність, тривалість і способи їхнього вираження. У ситуаціях, коли мігрантка стикається з культурними відмінностями, адміністративними труднощами чи непередбачуваними міжособистісними напруженнями, вміння регулювати емоційні реакції дає змогу зберігати конструктивність у спілкуванні та запобігати деструктивним конфліктам. Це стає фундаментом для формування довіри у нових соціальних зв'язках.

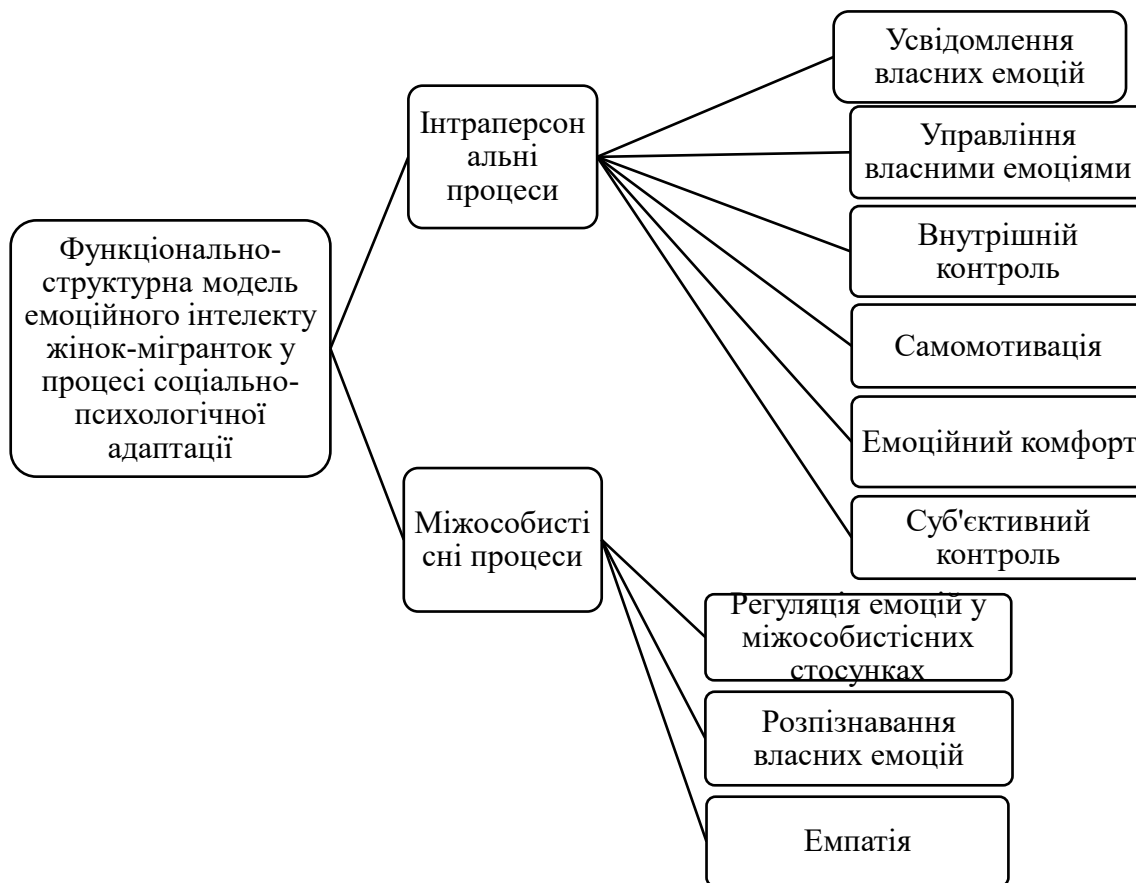


Рис. 1. Функціонально-структурна модель емоційного інтелекту жінок-мігранток у процесі соціально-психологічної адаптації

3. *Емпатія* виступає важливим інструментом встановлення взаєморозуміння, адже дозволяє точніше відчувати внутрішній стан іншої людини. У процесі адаптації в новій культурі ця здатність нерідко стає «містком» до соціальної інтеграції, оскільки сприяє виникненню контактів, заснованих на взаємоповазі, прийнятті та підтримці. Для багатьох жінок-мігранток емпатійне сприйняття допомагає подолати відчуття соціальної ізоляції та підвищує їхню включеність у спільноту.

4. *Розпізнавання емоцій інших* має більш когнітивно-аналітичний характер і пов'язане з умінням точно ідентифікувати вербальні та невербальні сигнали – інтонацію, тембр голосу, жести, міміку. За умови мовного бар'єра ця

навичка набуває особливого значення, адже здатна компенсувати обмеження у словесній комунікації та прискорити процес встановлення довірливих відносин.

5. *Регуляція емоцій у міжособистісних стосунках* передбачає здатність підтримувати сприятливий емоційний клімат у взаємодії, що унеможливорює або мінімізує ймовірність конфліктів. У випадку жінок-мігранток такий ресурс сприяє зміцненню соціальних зв'язків, формуванню стабільних міжособистісних контактів і створенню відчуття особистої безпеки в новому середовищі.

6. *Самотивація* виступає внутрішнім рушійним фактором, який підтримує активність навіть у ситуаціях підвищеного емоційного чи побутового навантаження. Завдяки цій якості жінка зберігає здатність ставити перед собою цілі, планувати майбутнє та подолати психологічну інерцію, що часто виникає унаслідок різкої зміни звичного способу життя.

7. *Внутрішній контроль* – це орієнтація у власних діях на особистісні цінності та переконання, а не лише на зовнішні обставини. Він допомагає зберігати цілісність «Я-концепції», а також підвищує стійкість до негативних впливів середовища. У контексті міграції ця здатність виступає запорукою психологічної автономії.

8. *Адаптивна поведінка у стресових ситуаціях* виявляється у гнучкості, здатності швидко змінювати стратегії реагування залежно від умов. Це дає змогу не лише ефективно діяти в непередбачуваних обставинах, а й швидше відновлювати внутрішню рівновагу після кризових подій.

9. *Інтеграція емоційного досвіду у процес прийняття рішень* означає врахування емоційних чинників поряд із когнітивними під час вибору стратегії поведінки. Такий підхід сприяє ухваленню більш усвідомлених, зважених і життєво релевантних рішень, що особливо важливо у процесі пристосування до нових соціальних умов.

Запропонована модель емоційного інтелекту є не лише інструментом для його діагностики, а й методологічною основою для дослідження впливу окремих

його компонентів на успішність адаптаційних процесів. Вона дозволяє всебічно оцінити як емоційно-когнітивні, так і регулятивно-вольові ресурси особистості, виявити сильні сторони та зони вразливості у сфері емоційної компетентності, а також сформулювати практичні рекомендації для психологічної підтримки. Таким чином, дослідження, засноване на цій моделі, може сприяти більш глибокому розумінню механізмів соціально-психологічної адаптації та стати базою для створення програм, спрямованих на підвищення емоційної стійкості й загального благополуччя жінок, які пережили досвід вимушеної міграції.

Висновки. Аналіз теоретичних і емпіричних досліджень свідчить, що емоційний інтелект є ключовим психологічним ресурсом, який визначає успішність соціально-психологічної адаптації жінок-мігранток у новому середовищі. Його розвиток сприяє подоланню стресу, збереженню внутрішньої рівноваги, формуванню конструктивних соціальних зв'язків і підтриманню професійної ідентичності, що особливо важливо в умовах вимушеного переселення. Запропонована функціонально-структурна модель емоційного інтелекту враховує як внутрішньо-особистісні, так і міжособистісні аспекти емоційної компетентності, об'єднуючи дев'ять взаємопов'язаних компонентів – від усвідомлення та регуляції власних емоцій до інтеграції емоційного досвіду у процес прийняття рішень. Її перевага полягає в комплексності та практичній спрямованості, що дозволяє не лише діагностувати рівень розвитку емоційного інтелекту, але й визначати напрями його цілеспрямованого удосконалення. Таким чином, модель може слугувати теоретичною та методичною основою для створення програм психологічної підтримки, спрямованих на розвиток емоційної стійкості та підвищення ефективності адаптаційних процесів жінок-мігранток. Її застосування відкриває можливості для більш адресної допомоги, сприяє зміцненню особистісних ресурсів та забезпечує умови для гармонійної інтеграції в нове соціокультурне й професійне середовище.

Список використаних джерел.

1. Блінова О. Є. Соціально-психологічні чинники подолання кризи ідентичності вимушених мігрантів. Особистість як суб'єкт подолання кризових ситуацій: психологічна теорія і практика: монографія. Кн. 2. Суми: Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2017. С. 162–180.
2. Вимушені переселенки з України в європейські країни: нова реальність / О. О. Гладунов та ін. Прес-конференція від 15.11.2022. Інтернет-видання «Укрінформ». URL: <https://www.ukrinform.ua/rubric-presshall/3613887-prezentacia-rezultativ-doslidzenna-vimusheni-pereselenki-z-ukraini-v-evropejskikraini-nova-realnist.html>
3. Всеєвропейське дослідження українців у Європі, серпень 2023 року: аналітичний звіт. Київ, 2023. 48 с. URL: https://ratinggroup.ua/research/ukraine/vseevropeyskoe_issledovanie_ukraincev_v_evrope.html (дата звернення: 18.05.2025).
4. Галян І. Психологічні особливості особистості, що перебуває в кризовому стані. Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (28.03.2019 р., м. Суми). Суми: Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. С. 42–44.
5. Євченко І. М. Емоційний стан українців під час російсько-української війни. Психологічні виміри особистісної взаємодії суб'єктів освітнього простору в контексті гуманістичної парадигми. 2022. 45 с.
6. Карамушка Л. М., Карамушка Т. В. Емпіричне дослідження особливостей психічного здоров'я вимушених «внутрішніх» переселенців в умовах війни. Організаційна психологія. Економічна психологія. 2022. Вип. 2(26). С. 48–59. DOI: <https://doi.org/10.31108/2.2022.2.26.6> (дата звернення: 01.08.2025).
7. Максџом К.В. Емоційний інтелект: основні концептуальні підходи та структурна модель соціально-психологічного феномену. Актуальні проблеми психології: збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка

НАПН України. Т. VI: Психологія обдарованості. Вип. 14. Київ; Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2018. С. 348–355.

8. Малиновська О. Все про міграцію і мігрантів під час війни: підсумки 2022 року WARcast. Інтернет-видання «Інститут стратегічних досліджень». URL: <https://niss.gov.ua/news/video/vse-pro-mihratsiyu-i-mihrantivpid-chas-viyny-pidsumky-2022-roku-warcast> (дата звернення: 10.07.2025).

9. Науменко Н. П. Особливості негативних психічних станів та індивідуальних характеристик у структурі професійного здоров'я підприємців під час пандемії і війни. Психологічне забезпечення професійного здоров'я особистості: колективна монографія / ред. С. М. Миронця. Київ, 2024. С. 176–213.

10. Овсянікова О. Г. Соціально-психологічна адаптація жінок в умовах вимушеної міграції. Теоретичні та практичні дослідження молодих вчених: матеріали XVIII Міжнар. наук.-практ. конф. магістрантів та аспірантів (19–22 листопада 2024 р., м. Харків). Харків: ХПІ, 2024.

11. Пилипенко І. Внутрішні та зовнішні детермінанти суб'єктивного благополуччя жінок в умовах вимушеної міграції: теоретичний аспект. Київський журнал сучасної психології та психотерапії. 2024. № 8. С. 86–99. DOI: <https://doi.org/10.48020/mppj.2024.02.07> (дата звернення: 18.05.2025).

12. Bar-On R., Parker J. D. A. (Eds.). Emotional and Social Intelligence: Insights from the Emotional Quotient Inventory (EQ-i). In: *Handbook of Emotional Intelligence*. San Francisco: Jossey-Bass, 2000.

13. Goleman D. Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ. New York : Bantam Books, 1995. 352 p.

14. Hodge L., Morda R., Castro A. P., Bamforth J., Jones A. F. Fostering Women's Empowerment: Training Pathways for Economic Inclusion. URL: <https://vuir.vu.edu.au/id/eprint/46635> (дата звернення: 11.04.2025).

15. Joseph D. L., Newman D. A. Emotional intelligence: An integrative meta-analysis and cascading model. *Journal of Applied Psychology*. 2010. Vol. 95(1). P. 54–78.
16. Schutte N. S., Malouff J. M., Hall L. E. et al. Development and validation of a measure of emotional intelligence. *Personality and Individual Differences*. 1998. Vol. 25(2). P. 167–177.

Особливості якості сну у осіб із підвищеним рівнем тривожності

Борець О.А.

*Доктор філософії з спеціальності «Психологія»
Академія праці, соціальних відносин і туризму, м. Київ*

Рудова А.Г.

*Здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти
Академія праці, соціальних відносин і туризму, м. Київ*

Актуальність. Сон є життєво важливим чинником здоров'я та благополуччя дітей, підлітків і дорослих. Здоровий сон відіграє ключову роль у забезпеченні когнітивних функцій, емоційної стабільності, психічного здоров'я, а також у підтриманні серцево-судинної, цереброваскулярної та метаболічної систем. Достатня тривалість і належна якість сну також мають важливе значення для зниження ризику нещасних випадків і травм, пов'язаних із сонливістю та втомою, зокрема виробничих і дорожньо-транспортних пригод.

Короткочасне недосипання, хронічне обмеження сну, порушення циркадних ритмів і неліковані розлади сну можуть мати глибокий і негативний вплив на фізичне та психічне здоров'я, емоційний стан і громадську безпеку. Хронічна недостатність сну асоціюється з підвищеним ризиком смертності та робить внесок як в індивідуальний ризик, так і в загальний суспільний тягар, пов'язаний із поширенням низки медичних епідемій, зокрема серцево-судинних захворювань, цукрового діабету, ожиріння та онкологічних хвороб. Наукові дані свідчать, що збільшення тривалості нічного сну має позитивний вплив на здоров'я, зокрема сприяє зниженню рівня психоемоційного напруження та тривожності. Водночас здоровий сон передбачає не лише достатню тривалість, а й відповідний час засинання, регулярність, відсутність розладів сну та його належну якість [5].

У попередні десятиліття досліджень сну науковці здебільшого зосереджувалися на обмеженому колі проблем, розглядаючи сон переважно з

позицій патології, а не як складову позитивно орієнтованого підходу до здоров'я. Найчастіше об'єктом досліджень були коротка та надмірно тривала тривалість сну; серед симптомів переважали прояви безсоння, зокрема труднощі із засинанням, підтриманням сну та передчасні пробудження, а найпоширенішим діагностованим розладом залишалося апное сну [5].

Епідеміологічні дані щодо зазначених показників сну формують тривожну картину. Зокрема, чинні рекомендації консенсусних експертних груп вказують на необхідність тривалості сну не менше ніж 7 годин на добу для дорослого населення, однак, за даними Центрів контролю та профілактики захворювань (CDC), близько 35 % дорослих не дотримуються цієї рекомендації. Симптоми безсоння охоплюють труднощі із засинанням, підтриманням сну або занадто раннє пробудження, про які повідомляють респонденти. Розлад безсоння визначається як стійка наявність зазначених симптомів протягом певного часу (зазвичай від 1 до 3 місяців), що супроводжується вираженим дискомфортом або порушенням функціонування у стані неспання. За різними оцінками, від 30,0 % до 35,0 % дорослого населення у світі повідомляють про симптоми безсоння, тоді як приблизно 10,0 % відповідають діагностичним критеріям цього розладу.

Обструктивне апное сну (ОАС) є ще одним поширеним порушенням сну, що має суттєве значення для громадського здоров'я. Воно характеризується повторюваними епізодами припинення дихання (апное) або зменшення повітряного потоку (гіпопное) під час сну за умови збереження дихальних зусиль. Такі епізоди призводять до періодичної гіпоксемії та багаторазових пробуджень, що може негативно впливати на функціонування серцево-судинної системи. Оцінки поширеності ОАС значно варіюють – від 3,0 % до 10,0 % загальної популяції, водночас розлад залишається значною мірою недіагностованим, особливо серед осіб з надмірною масою тіла, людей похилого віку та окремих соціально вразливих груп. Наведені дані підкреслюють багатовимірну природу сну та свідчать про те, що несприятливі характеристики сну, його симптоми й

розлади є поширеними та мають суттєві наслідки для системи громадського здоров'я.

Концепція здоров'я сну забезпечує цілісне розуміння багатьох характеристик сну, зокрема його тривалості, безперервності, часу, рівня пильності та суб'єктивного задоволення. Зміцнення здоров'я сну розглядається як недостатньо використана можливість у сфері громадського здоров'я, яка має суттєві наслідки для широкого спектра ключових показників фізичного та психічного благополуччя. Концепція здоров'я сну є особливо релевантною для осіб із підвищеним рівнем тривожності, оскільки дозволяє оцінювати не лише тривалість сну, а й його суб'єктивну якість та відновлювальний потенціал.

Багатовимірне здоров'я сну враховує не лише індивідуальні особливості, а й ширший соціально-екологічний контекст, у якому відбувається сон. Ця перспектива відповідає двом ключовим досягненням сучасної науки про сон: визнанню суттєвих нерівностей у показниках сну, що відображають расові, етнічні та соціально-економічні відмінності, а також усвідомленню того, що детермінанти здоров'я сну виходять за межі індивідуальних чинників і включають впливи соціального середовища.

Таким чином, здоров'я сну постає не лише як важливий індикатор загального стану здоров'я та соціальної рівності, але й як перспективна сфера для багаторівневих профілактичних і корекційних втручань [3].

В умовах соціальної нестабільності, хронічного стресу та інформаційного перевантаження порушення якості сну дедалі частіше спостерігаються серед дорослого населення, у тому числі серед осіб без клінічно встановлених психічних розладів. Такі порушення знижують адаптаційні можливості особистості та підвищують ризик розвитку емоційного виснаження.

У таких умовах порушення сну нерідко поєднуються з підвищеним рівнем тривожності, яка виступає одним із ключових психологічних чинників дезадаптації. Підвищений рівень тривожності супроводжується хронічною

психофізіологічною активацією, соматичним напруженням і труднощами емоційної саморегуляції, що істотно ускладнює процеси розслаблення та засинання.

Сучасні дослідження свідчать, що функція сну у регуляції емоцій є визначальною, а також відіграє ключову роль у регулюванні реакцій на стрес і запальні процеси. Повноцінний нічний сон має вирішальне значення для психічного здоров'я. Хоча сон є необхідним для підтримання гомеостазу та нейропластичності мозку, його порушення, зокрема безсоння, можуть сприяти формуванню стану алостатичного перевантаження, що негативно впливає на мозкову пластичність, емоційні, імунні та ендокринні механізми й може відігравати анксіогенну роль. Низка досліджень підтверджує двонаправлений характер цього зв'язку: симптоми психічних розладів, зокрема тривожних, призводять до порушень сну, тоді як розлади сну, насамперед безсоння, можуть виступати чинником ризику розвитку тривожних розладів [4].

У межах психосоматичного підходу порушення сну розглядаються як прояви дисбалансу між психоемоційним станом особистості та функціонуванням організму. Тривожність у цьому контексті постає як чинник накопиченого емоційного дистресу, який знаходить відображення у вегетативних і соматичних симптомах, зокрема у розладах сну [1].

Особливої актуальності набуває дослідження якості сну в осіб із підвищеним рівнем тривожності в дорослому неклінічному контингенті, оскільки ця група часто залишається поза межами спеціалізованої допомоги, попри наявність стійких психоемоційних труднощів, і тому становить важливу цільову групу психологічної профілактики. Аналіз особливостей сну в таких осіб дозволяє глибше зрозуміти механізми порушень ментального здоров'я та окреслити перспективні напрями психологічної профілактики.

Мета дослідження. Виявлення та аналіз особливостей якості сну у дорослих осіб із підвищеним рівнем тривожності, а також визначення характеру

порушень окремих компонентів сну. *Методи дослідження.* У дослідженні взяли участь 51 особа віком від 18 до 55 років. Добір респондентів здійснювався на добровільній основі з дотриманням принципів анонімності та конфіденційності. Усі учасники надали інформовану згоду на участь у дослідженні. Опитування проводилося в дистанційному форматі з використанням електронних анкет, що забезпечило анонімність відповідей та зменшило вплив зовнішніх чинників на результати дослідження. Респондентам пропонувалося пройти психодіагностичне обстеження, спрямоване на оцінку рівня тривожності та якості сну за останній місяць. Заповнення анкет не обмежувалося жорсткими часовими рамками, що дозволяло учасникам відповідати у зручному для них темпі. Для оцінки рівня тривожності застосовувалася шкала особистісної тривоги Спілбергера (State-Trait Anxiety Inventory, STAI) [2], що дозволяє визначити стабільну схильність особистості до переживання тривожних станів. Методика широко застосовується в психологічних дослідженнях, характеризується високою валідністю та надійністю і дає змогу диференціювати осіб із нормальним та підвищеним рівнем тривожності. Оцінка якості сну проводилася за допомогою Пітсбурзького опитувальника якості сну (Pittsburgh Sleep Quality Index, PSQI) [2]. Методика спрямована на комплексну оцінку суб'єктивної якості сну та включає аналіз семи компонентів: суб'єктивної якості сну, латентності засинання, тривалості сну, ефективності сну, порушень сну, використання снодійних засобів та порушень денного функціонування. Інтегральний показник PSQI дозволяє визначити загальний рівень якості сну, де значення понад порогове вказують на наявність порушень. У межах дослідження особлива увага приділялася таким компонентам PSQI, як латентність засинання та денне функціонування, оскільки вони вважаються найбільш чутливими до впливу тривожності та відображають як нічні, так і денні прояви порушень сну. Для аналізу показників якості сну було сформовано підгрупу осіб із підвищеним рівнем тривожності, до якої увійшли 34 респонденти. Саме ця група була використана для подальшого аналізу показників

якості сну. Статистична обробка отриманих даних мала описовий характер і передбачала аналіз кількісних та відсоткових показників.

Результати дослідження. За результатами шкали особистісної тривожності Спілбергера у 34 із 51 респондента, що становить 66,7 % вибірки, було виявлено підвищений рівень тривожності. Саме ця підгрупа була обрана для подальшого детального аналізу показників якості сну, оскільки підвищена тривожність розглядається як один із провідних психологічних чинників порушень сну.

Аналіз інтегрального показника якості сну за Пітсбурзьким опитувальником (PSQI) у групі осіб із підвищеним рівнем тривожності більшість респондентів продемонстрували порушену якість сну. Добру якість сну ($PSQI \leq 5$) мали лише 4 особи (11,8 %), тоді як у 30 осіб (88,2 %) показник перевищував порогове значення, що свідчить про наявність порушень сну.

Для детальнішого аналізу особливостей сну було розглянуто окремі компоненти Пітсбурзького опитувальника, зокрема латентність засинання та порушення денного функціонування, які вважаються найбільш чутливими до впливу тривожності. Аналіз показав, що порушення латентності засинання (наявність балів ≥ 1) було виявлено у 32 із 34 осіб із підвищеним рівнем тривожності, що становить 94,1 % підгрупи. Це свідчить про значні труднощі із засинанням, які можуть бути пов'язані з підвищеною психофізіологічною активацією, напруженням та нав'язливими тривожними думками у вечірній і нічний час.

Аналогічні результати було отримано й щодо порушень денного функціонування. У 32 респондентів (94,1 %) було зафіксовано негативний вплив якості сну на самопочуття та функціонування протягом дня, що проявлялося у відчутті втоми, зниженні працездатності, труднощах концентрації уваги та підвищеній емоційній виснаженості. Така висока частота денних проявів порушень сну свідчить про те, що проблеми зі сном у осіб із підвищеним рівнем тривожності мають не лише нічний, а й пролонгований денний характер.

Загалом результати проведеного дослідження засвідчили, що у більшості осіб із підвищеним рівнем тривожності спостерігається системний характер порушень сну, який охоплює як процес засинання, так і відновлювальну функцію нічного сну. Отримані дані свідчать про те, що порушення сну в цієї категорії респондентів не обмежуються окремими епізодичними труднощами, а мають комплексний і стійкий характер.

Особливо вираженими виявилися труднощі, пов'язані з латентністю засинання. Значна частка осіб із підвищеним рівнем тривожності повідомляла про подовження часу, необхідного для засинання, що може бути пов'язано з підвищеною психофізіологічною активацією, напруженням та нав'язливими тривожними думками у вечірній час. Такі особливості свідчать про порушення механізмів релаксації та переходу організму в стан, необхідний для повноцінного початку сну.

Водночас результати аналізу компонентів якості сну показали, що порушення не обмежуються лише нічним періодом, а мають виражені денні наслідки. У більшості респондентів із підвищеним рівнем тривожності зафіксовано порушення денного функціонування, які проявлялися у відчутті постійної втоми, зниженні працездатності, труднощах концентрації уваги та емоційному виснаженні. Це вказує на зниження відновлювального потенціалу сну та недостатню компенсацію психоемоційних і фізіологічних ресурсів організму.

Поєднання труднощів із засинанням і зниження ефективності денного функціонування дозволяє розглядати порушення сну в осіб із підвищеним рівнем тривожності як цілісний психофізіологічний феномен. Такий характер порушень свідчить про тісний взаємозв'язок між емоційною сферою та регуляцією циклу «сон – неспання», за якого тривожність може виступати як чинником ініціації розладів сну, так і фактором, що підтримує їх хронічний перебіг.

Таким чином, результати дослідження підтверджують, що порушення сну в осіб із підвищеним рівнем тривожності мають комплексний характер і

проявляються як у нічний, так і в денний період. Це підкреслює доцільність урахування психологічних чинників, зокрема рівня тривожності, при оцінці якості сну та плануванні профілактичних і корекційних психологічних заходів у дорослій неклінічній популяції.

Висновки. Проведене дослідження дозволило узагальнити особливості якості сну у дорослих осіб із підвищеним рівнем тривожності та виявити найбільш вразливі компоненти сну в межах неклінічної популяції. Виявлені закономірності створюють підґрунтя для формулювання узагальнених висновків щодо взаємозв'язку тривожності та якості сну. У більшості досліджуваних осіб було виявлено підвищений рівень тривожності, що підтверджує поширеність тривожних проявів у дорослій неклінічній популяції та актуальність вивчення їх впливу на ментальне здоров'я.

Встановлено, що переважна більшість осіб із підвищеним рівнем тривожності мають порушену якість сну. Найбільш вираженими є труднощі із засинанням і порушення денного функціонування, що свідчить про зниження відновлювальної функції сну.

Отримані результати підтверджують тісний взаємозв'язок між тривожністю та якістю сну й підкреслюють доцільність розробки психологічних профілактичних і корекційних заходів, спрямованих на зниження тривожності та покращення якості сну.

Список використаних джерел.

1. Чабан О. С. Психосоматична діагностика та психотерапія. Київ: Медкнига, 2018. 304 с.
2. Практична психосоматика: діагностичні шкали : навч. посіб. /за заг. ред. О. О. Чабана, О. О. Хаустової. 2-ге вид., випр. і допов. Київ: Медкнига, 2019. 112 с. ISBN 978-966-1597-65-4.

3. Hale L., Troxel W., Buysse D. Sleep health: An opportunity for public health to address health equity // Sleep Health. 2020. Vol. 6, № 4. P. 498–500. DOI: <https://doi.org/10.1146/annurev-publhealth-040119-094412>.
4. Palagini L., Hertenstein E., Riemann D., Nissen C. Insomnia, anxiety, and related disorders: A systematic review // Sleep Medicine Reviews. 2024. Vol. 72. Art. 101873. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.nsa.2024.103936>.
5. Ramar K., Malhotra R. K., Carden K. A. та ін. Sleep is essential to health: An American Academy of Sleep Medicine position statement // Journal of Clinical Sleep Medicine. 2021. Vol. 17, № 10. P. 2115–2119. DOI: <https://doi.org/10.5664/jcsm.9476>.

Емоційного вигорання та управління емоціями військовослужбовцями

Бохонкова Ю.О.

*Доктор психологічних наук, професор
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля*

Бузько Т.М.

*Здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти
Академія праці, соціальних відносин і туризму, м. Київ*

Актуальність. У сучасних умовах, позначених військовими діями, економічними кризами, стресами та різкими соціальними змінами на тлі стрімкого розвитку інформаційно-комп'ютерних технологій, уникнути негативних емоцій практично неможливо. Емоції постають як різноманітні переживання особистості, у яких відображаються її життєві взаємини із зовнішнім світом та іншими людьми.

Емоції є одним із провідних механізмів внутрішньої регуляції психічної діяльності та поведінки, спрямованих на задоволення актуальних потреб. Вони виконують сигнальну функцію, інформуючи про благополучний чи неблагополучний розвиток подій, визначеність становища особистості в системі предметних і міжособистісних взаємин. Емоції забезпечують регулювання та корекцію поведінки в умовах спілкування й діяльності. Водночас окремі емоційні стани можуть мати деструктивний вплив на соціальну поведінку особистості, ускладнюючи її адаптацію та взаємодію з оточенням.. Тому необхідно навчитися керувати емоціями, не дозволяти їм руйнувати міжособистісні відносини людини в соціумі. Окремі дослідники-психологи визначають як «вік меланхолії», адаптація особистості потребує не лише адекватного розуміння ситуації та сприйняття дійсності, а й уміння ефективно управляти власними емоціями. Саме розвиток емоційної саморегуляції дозволяє долати надмірний стрес у умовах збройного конфлікту та знижувати ризики виникнення психосоматичних захворювань. У цьому контексті дослідження проблеми психології управління емоціями

військовослужбовців набуває особливої актуальності та практичної значущості [1–5].

Емоції належать до найдавніших за походженням психічних станів і процесів. Основоположник наукової психології В. Вундт зазначав, що кількість емоційних проявів, а точніше відтінків емоційного тону відчуттів, є настільки великою, що навіть мовні засоби не мають достатнього арсеналу для їхнього точного визначення. Водночас у межах теорії диференціальних емоцій К. Ізарда основну мотиваційну систему людського існування утворюють десять базових емоцій: радість, сум, гнів, відраза, презирство, страх, сором, зніяковілість, провина, подив та інтерес [1–5]. Дослідженню емоцій та почуттів особистості присвячено наукові праці М. Й. Варія, Л. С. Виготського, В. К. Вілюнаса, Є. В. Заїки, А. С. Нікіфорова [6–13]. Питання розробки та застосування адаптивних антистресових психотехнологій висвітлено у працях А. М. Гриненко, О. М. Кокуна, М. Перре, В. М. Петюха, Г. Сельє, Л. В. Торгової, [6-13]. Проблема психології управління емоціями була предметом дослідження як вітчизняних, так і зарубіжних учених (В. Вундт, В. Джемс, К. Ізард, П. Куттер, Дж. Уотсон та ін.) [1–13]. Проте й сьогодні вона залишається недостатньо розкритою. У сучасній науковій літературі феномен управління емоціями досліджено неповною мірою: не з'ясовано, чи є тотожними поняття «регуляція емоцій», «саморегуляція» та «управління емоціями»; чи відрізняються концепти «управління емоціями» у межах та поза межами емоційного інтелекту; чи має управління емоціями власні складові, чи є одноплановим конструктом. У зв'язку з цим дипломна робота присвячена теоретико-методологічному та практичному аналізу психологічного феномену управління емоціями [1–13].

Мета дослідження. Визначення негативних проявів емоційного реагування військовослужбовців. *Методи дослідження.* З метою вивчення психологічних особливостей розвитку навичок управління емоціями військовослужбовців використано наступний інструментарій: методика діагностики «перешкод» у встановленні емоційних контактів (фактори: невміння управляти емоціями,

неадекватний прояв емоцій, «негнучкість» емоцій, домінування негативних емоцій, небажання зближуватися з людьми); методика «Діагностики рівня емоційного вигорання», методика «Визначення психічного «вигорання», методика «Синдром «вигорання» в професіях системи «людина – людина». Також використано *методи обробки наукових даних* (якісні і кількісні, серед останніх – спеціальні методи математичної статистики). *Експериментальна база дослідження* – у дослідженні взяли участь 50 військовослужбовців (40 жінок, 10 чоловіків).

Результати дослідження. За результатами дослідження, у 68,0 % військовослужбовців емоції не перешкоджають процесу спілкування, у 14,0 % виявлено труднощі у повсякденній комунікації, а у 18,0 % емоційні стани ускладнюють взаємодію з оточенням. Найбільшою перешкодою у встановленні емоційних контактів є невміння керувати власними емоціями та дозувати їх 20,0 % досліджуваних. На другому місці – домінування негативних емоцій 16,0 %, на третьому – неадекватне емоційне вираження та небажання зближуватися з людьми на емоційній основі 12,0 %. Останню групу становлять військовослужбовці з негнучкими, нерозвинутими та невиразними емоціями 8,0 %. Згідно з методикою діагностики рівня емоційного вигорання, у 72,0 % досліджуваних синдром емоційного вигорання відсутній. У 10,0 % військовослужбовців зафіксовано середній рівень емоційного вигорання, тоді як у 14,0 % – високий рівень, а у 4,0 % – критичний рівень емоційного вигорання, що потребує особливої уваги.

Відсутність симптомів емоційного вигорання зафіксовано у 58–88,0 % досліджуваних, залежно від типу симптому. Найменш вираженими серед військовослужбовців є такі прояви, як тривога і депресія, емоційний дефіцит, стан «загнаності у кут», незадоволеність собою та емоційне відчуження. Їхня частота коливається у межах 12–18,0 %. Водночас більшість військовослужбовців 42,0 % демонструють різні ступені вираженості психосоматичних та психовегетативних

порушень: у 10,0 % симптом перебуває на стадії формування, а у 32,0 % – вже сформований. Зазначені порушення проявляються на рівні фізичного та психічного самопочуття. Їх виникнення часто пов'язане з умовно-рефлекторними зв'язками негативних властивостей професійної діяльності, що провокують відхилення у соматичних та психічних станах.

Одним із симптомів, що безпосередньо пов'язаний із розвитком уміння управляти емоціями, є неадекватне вибіркове емоційне реагування, яке виявлено у 38,0 % досліджуваних. Це є характерною ознакою емоційного вигорання, коли військовослужбовець перестає розрізняти принципово відмінні явища, демонструючи економію емоцій та неадекватні реакції. У 2,0 % військовослужбовців спостерігаються симптоми переживання психотравмуючих обставин, розширення сфери економії емоцій та деперсоналізації. Домінуючими проявами у структурі синдрому емоційного вигорання є: психосоматичні та психовегетативні порушення 24,0 % досліджуваних – критичний рівень, симптом неадекватного вибіркового емоційного реагування 12,0 % – критичний рівень, симптом особистісного відчуження та деперсоналізації 14,0 % – критичний рівень.

За результатами дослідження, проведеного за методикою «Визначення психічного вигорання», високий рівень індексу психічного вигорання на роботі виявлено у 7,0 % досліджуваних, а критичний рівень – у 18,0 % військовослужбовців. У 32,0 % респондентів, які демонструють значні прояви психоемоційного виснаження, ці стани мають специфічні особливості, що проявляються на трьох системно-структурних рівнях.

Результати дослідження за методикою «Синдром «вигорання» в професіях системи «людина–людина» корелюють з результатами діагностики емоційного вигорання за двома попередніми методиками.

За результатами дослідження емоційне виснаження (емоційний дефіцит, емоційне відчуження, неадекватне вибіркове емоційне реагування, психоемоційне виснаження) виявлено: низький рівень – у 71,0 % досліджуваних; середній рівень

– у 17,0 %; високий рівень – у 12,0 %. Деперсоналізація: низький рівень – у 75,0 % досліджуваних; середній рівень – у 13,0 %; високий рівень – у 12,0 %.

Редукція особистих досягнень (редукція професійних обов'язків та професійна мотивація) виглядала наступним чином: низький рівень – у 76,0 % досліджуваних; середній рівень – у 10,0 %; високий рівень – у 14,0 %.

Результати діагностики свідчать, що значний відсоток досліджуваних знаходиться на різних стадіях і має симптоми емоційного вигорання роботі, недостатньо володіють навичками управління емоціями. Кореляційний аналіз підтвердив значиму кореляцію між даними, тому висунута на початку дослідження гіпотеза про те, що невміння військовослужбовців управляти емоціями призводить до їх професійного вигорання, – підтвердилась.

Невміння військовослужбовців управляти власними емоціями призводить до деперсоналізації, особистісного відчуження та особистісного віддалення. Коефіцієнти кореляції між умінням управляти емоціями та зазначеними проявами становлять: для деперсоналізації та особистісного відчуження – 0,80, для особистісного віддалення – 0,78. Деперсоналізація проявляється у деформації міжособистісних стосунків, що виражається у повній або частковій втраті інтересу до людини як суб'єкта професійної діяльності, що є неприпустимим у роботі військовослужбовців. Неадекватне вибіркове емоційне реагування, яке має 90,0 % кореляції з умінням управляти емоціями, є характерною ознакою емоційного вигорання. У цьому випадку військовослужбовець перестає розрізняти принципово відмінні явища, демонструючи економію емоцій та неадекватні реакції. З метою попередження розвитку даного симптому необхідно формувати антистресові вміння, навички адекватного прояву емоцій на основі критичного аналізу ситуації, а також здатність утримуватися від перенесення негативних емоцій на оточення.

Економічний прояв емоцій одного військовослужбовця може бути сприйнятий колегами та відвідувачами як негативне ставлення до них.

Неадекватне вибіркове емоційне реагування може проявлятися як у надмірній вираженості позитивного настрою, так і в агресивних реакціях. У будь-якому випадку така поведінка спричиняє фрустрацію та ускладнює соціальну взаємодію. З метою допомоги військовослужбовцям на шляху вироблення індивідуальних програм розвитку уміння управління емоціями нами досліджено психологічні теорії та психотерапевтичні напрями, базові вчення науковців з даної проблеми та узагальнено практичні рекомендації у другому розділі. З метою допомоги психологам нами описано групову програму тренінгу управління емоціями.

Висновок. Досліджено аналіз особливостей розвитку навичок управління емоціями військовослужбовців в сучасних умовах життя. Надано рекомендації військовослужбовцям, щодо зниження негативних проявів емоційного реагування у професійній діяльності та розвитку навичок конструктивного управління емоціями з метою профілактики професійного вигорання. Проведено кореляційний аналіз взаємозв'язку розвитку уміння управляти емоціями та емоційного вигорання військовослужбовців у професійній діяльності, розроблено тренінгові заняття для військовослужбовців з метою розвитку вміння управління емоціями.

Список використаних джерел.

1. Блінов О.А. Психологія бойового стресу : дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.04. Інститут психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. Київ, 2020. 660 с.
2. Варій М. Й. Загальна психологія : навч. посіб. для студ. психол. і педагог. спеціальностей. Львів : Край, 2005. 592 с.
3. Демидюк В.М. Психологічні чинники запобігання емоційному вигоранню військовослужбовців в умовах довготривалих збройних конфліктів. *Наукові записки Національного університету «Острозька академія»*. 2021. № 12, С. 102–106.

4. Ємельяненко Л. М., Петюх В. М., Торгова Л. В., Гриненко А. М. Конфліктологія : навч. посіб. / за заг. ред. В. М. Петюха, Л. В. Торгової. Київ : КНЕУ, 2003. 315 с.
5. Забезпечення психологічної стійкості військовослужбовців в умовах бойових дій : метод. посіб. / О. М. Кокун, В. В. Клочков, В. М. Мороз, І. О. Пішко, Н. С. Лозінська. Київ-Одеса : Фенікс, 2022. 128 с.
6. Климчук В. О. Психологія посттравматичного зростання: монографія. Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. Кропивницький : Імекс–ЛТД, 2021. 158 с.
7. Кокун О.М., Пішко І.О., Лозінська Н.С., Олійник В.О., Хоружий С.М., Ларіонов С.О., Сириця М.В. Особливості надання психологічної допомоги військовослужбовцям, ветеранам та членам їхніх сімей цивільними психологами : метод. посіб. К. : 7БЦ, 2023. 175 с.
8. Кокун О.М., Агаєв Н.А., Пішко І.О., Лозінська Н.С., Остапчук В.В. Психологічна робота з військовослужбовцями - учасниками АТО на етапі відновлення: метод. посіб. К.: НДЦ ГП ЗСУ, 2017. 282 с.
9. Корольчук В. М. Психологія стресостійкості особистості: дис. д-ра психол. наук: 19.00.01. Київ. 2009. 511 с.
10. Методичний посібник для соціальних працівників: Посилення спроможності соціальних працівників здійснювати психосоціальну підтримку ветеранів та їх сімей з питань психічного здоров'я / Горбунова В., Савиченко О., Тичина І., Портницька Н. 2022. 61 с.
11. Осьодло В. Теорія і практика психологічної допомоги та реабілітації : підручник. Київ: НУОУ ім. Івана Черняхівського. 2019. 416 с.
12. Психологічна допомога постраждалим внаслідок кризових травматичних подій : метод. посіб. / З. Г. Кісарчук, Я. М. Омельченко, Г. П. Лазос, Л. І. Литвиненко, Царенко Л. Г.; за ред. З. Г. Кісарчук. К. : ТОВ Видавництво «Логос». 207 с.

13. Раєвська Я., Твердохліб Н. Психологія стресостійкості військовослужбовців: теоретичний дискурс. *Наукові праці Міжрегіональної академії управління персоналом*. Психологія. 2023. Вип. 3(59).
14. Хоружий С.М., Лозінська Н.С., Пішко І.О., Олійник В.О., Сириця М.В. Практикум з індивідуального психологічного консультування військовослужбовців, ветеранів та членів їхніх сімей : навч.-метод. посіб. К. : ТОВ «7БЦ», 2023. 90 с.

Вплив соціально-психологічних чинників на жінок у період грудного вигодовування

Воробей В. О.

Кандидат медичних наук

*Здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти
Академія праці, соціальних відносин і туризму, м. Київ*

Актуальність. Грудне вигодовування є не лише домінуючим чинником фізіологічного забезпечення потреб немовляти, але й механізмом у формуванні первинної прив'язаності та психоемоційної взаємодії матері та дитини. З перших хвилин життя дитини соматичний та емоційний контакт визначають та формують зв'язок, що у подальшому впливає на розвиток довіри та регуляції емоцій. Для жінки-матері процес вигодовування виступає джерелом внутрішнього спокою та психічної рівноваги. Водночас, соціально-психологічні чинники: підтримка сім'ї, культурні установки, економічні умови та доступність професійної допомоги, значно впливають на процес грудного вигодовування. В умовах воєнного стану ці чинники зазнають трансформацій та обтяжуються стрес-факторами, що створює ризики для психоемоційного благополуччя матері та дитини. Наукове вивчення впливу соціально-психологічних детермінант у кризових умовах є актуальним запитом для розробки програм психоемоційної підтримки жінок-годувальниць та збереження здоров'я дитини.

Мета дослідження. Визначити та проаналізувати соціально-психологічні чинники, що впливають на жінок у період грудного вигодовування в стресогенних умовах.

Результати дослідження. У фізіологічному забезпеченні потреб немовляти грудне вигодовування відіграє переважну роль, а також формує психоемоційну взаємодію між матір'ю та дитиною. Цей процес сприяє формуванню стабільного емоційного зв'язку, що характеризується високим рівнем довіри та взаємної емоційної регуляції. Для матері грудне вигодовування є джерелом емоційного

спокою та психічної врівноваженості. У перші хвилини після народження між породіллею та немовлям закладається базовий «каркас» їхньої подальшої взаємодії. У перинатальній психології визначаються, насамперед, два взаємопов'язані рівні контакту – соматичний/психосоматичний і психоемоційний.

Психосоматичний контакт/взаємодія характеризується такими модальностями, як:

1. *Шкірний контакт («skin-to-skin»)* – при безпосередньому прикладанні немовляти до грудей або живота матері: у дитини стабілізується дихання, серцевий ритм, температура тіла; у жінки активується вироблення окситоцину («гормон прив'язаності», «гормон любові», оскільки відповідає за емоційний зв'язок, довіру, турботу, може впливати на характер соціальних зв'язків, бере участь у лактації (вироблення та виділення молока молочними залозами). На психологічному рівні це перший досвід тілесної безпеки: «зі мною все гаразд, я в контакті».

2. *Грудне прикладання / грудне вигодовування / сенсорний контакт.* Перші спроби прикладання до грудей поєднують соматичний і поведінковий рівні, а не лише фізіологічну потребу в харчуванні. Важливі психоемоційна взаємодія: близькість тіл, тепло, запах, голос, ритмічні рухи. Запах матері стає для немовляти орієнтиром безпеки. Він ідентифікується зі станом заспокоєння і зниження напруги. У цей період формується перший ранній, але стійкий маркер «свого» дорослого.

3. *Тактильний контакт рук матері* – погладжування, обійми, легке притримування голови чи спини немовляти – первинна тілесна комунікація, які формують відчуття безпеки та тілесної підтримки. Через дотик дитина отримує інформацію про ритм, силу, передбачуваність контакту, що згодом стає основою здатності заспокоюватися поруч із матір'ю.

Для психоемоційного контакту характерні такі модальності:

1. *Емоційне прийняття дитини.* Різні емоції та почуття, залежно від фізичного стану (недосипання, втома, стрес). Особистісна ідентифікація у ставленні до дитини: «це моя дитина (син/дочка)», що має регулятивну функцію рольової комунікації між матір'ю та дитиною.

2. *Емоційний тон матері.* Інтонація голосу, міміка, загальний емоційний стан жінки зчитуються немовлям на тілесному рівні. Спокій, м'якість, зацікавленість формують відчуття передбачуваності; напруження або відстороненість – навпаки, можуть формувати чи підсилювати тривогу.

3. *Зоровий контакт.* Нетривалий зоровий контакт виконує функції як для матері, так і дитини: діагностичну, прогностично-діяльнісну. Емоційний контекст зорового контакту слугує регулятором отриманої інформації: тривожність, спокій, емоційна рівновага.

4. *Аудіокомунікація (взаємодія матері з дитиною засобами голосу).* Перші слова, навіть, якщо вони прості й емоційні, виконують функцію емоційного «містка». Голос матері швидко стає для дитини регулятором психоемоційного стану, та закріплюється у подальшій оцінній взаємодії «мати – дитина».

Таким чином, соматичний контакт у перші хвилини після народження створює у дитини відчуття фізичної безпеки й регуляції, а емоційний – формує первинну довіру та взаємодію. Разом вони закладають підґрунтя прив'язаності, стилю материнської чутливості й способу, у який дитина надалі сприйматиме контакт з близькою людиною. Саме тому ці перші хвилини мають значення, яке виходить далеко за межі фізіології. Перинатальні психологи вказують, що у період перших 10–12 місяців між матір'ю та дитиною формується емоційний зв'язок, через який психоемоційний стан дитини значною мірою залежить від емоційного фону матері. Такий зв'язок реалізується через тілесний контакт, зорову фіксацію, голосову модуляцію та ритм годування. Викладена думка є продовженням наукових розвідок у пре- та перинатальній психології та підтвердженням ґрунтовних розробок та досліджень лікарів (В. В. Безрук, В. В. Брич, М. І. Веля, І.

С. Семань-Мінько, І. Д. Шкробанець), лікарів-педіатрів (Ю. М. Нечитайло), неонатологів (Л. М. Слободян), акушерів-гінекологів (М. Д. Гресько, Л. В. Ринжук), неврологів (Н. В. Васильєва) та наша власна практика демонструють, що «... ГВ має унікальний позитивний вплив на здоров'я дитини та організм матері-годувальниці... та є багатовекторним: нутритивне забезпечення, біологічна підтримка та захист; психоемоційна взаємодія із матір'ю-годувальницею – формування пари «мати – дитина» [1]. Основні соціально-психологічні чинники, що впливають на жінок-годувальниць у період грудного вигодовування, включають рівень підтримки сім'ї та соціального середовища, емоційний стан матері, культурні установки щодо материнства та доступність професійної допомоги. В умовах воєнного стану традиційні соціально-психологічні чинники, що впливають на жінок-годувальниць в період ГВ, зазнають значних трансформацій та обтяжуються стрес-факторами. Науковий аналіз соціально-психологічних чинників, що впливають на жінок-годувальниць в умовах воєнного стану дозволив виділити низку домінуючих детермінант (рис.1).

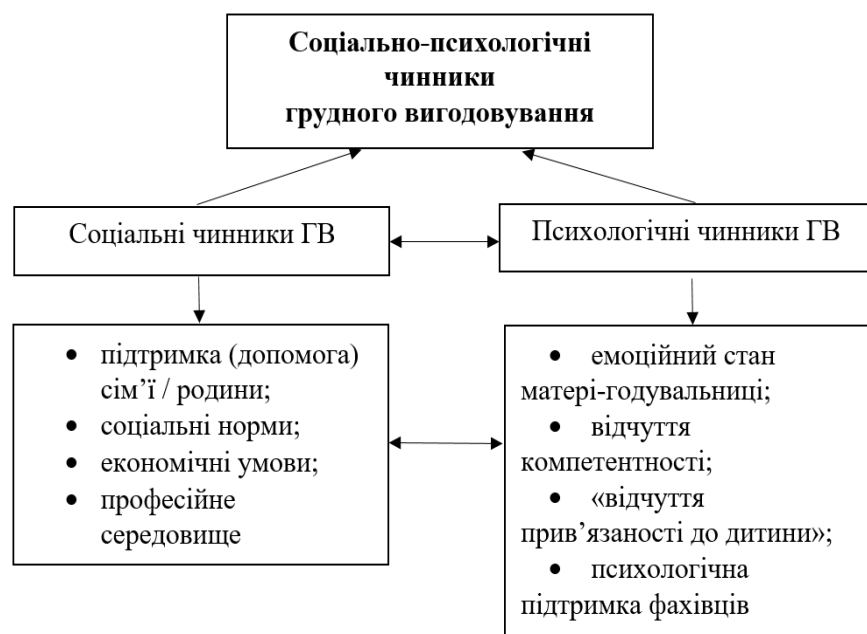


Рис. 1. Соціально-психологічні чинники, що впливають на жінок-годувальниць

Основні соціальні чинники:

– підтримка (допомога) сім'ї / родини: наявність допомоги від партнера, родичів чи друзів (зниження ризику післяпологової депресії, полегшення адаптації до нової ролі) [3]; у той же час, жінки-годувальниці можуть мати статус внутрішньо-переміщеної особи, чи дружини військовослужбовця, що може передбачати розлуку з партнерами (через мобілізацію) та родичами, призводять до дефіциту практичної допомоги та емоційної підтримки.

– соціальні норми та культурні очікування: у суспільствах, де грудне вигодовування вважається нормою, жінки відчують менший тиск і більше впевненості [2]; у кризових умовах потреба в забезпеченні базової безпеки та харчування дитини може тимчасово зміщувати фокус із довгострокових переваг ГВ, попри його безпечність та доступність, у ситуацію невизначеності;

– економічні умови: фінансова стабільність зменшує стрес, тоді як матеріальні труднощі впливають на психоемоційний стан жінки, і як наслідок, можуть ускладнювати процес вигодовування; економічна нестабільність, фінансові труднощі, обтяжені війною, та доступ до сумішей, створює ризик нестачі материнського молока (на фоні стрес-факторів), та відсутності замінників грудного молока.

– професійне середовище: наявність декретної відпустки, організація лактаційного процесу та процедур (можливість зціджування молока на робочому місці, гнучкий графік роботи та ін.) сприяють продовженню грудного вигодовування;

обмеження доступу до медичної допомоги та консультацій (руйнування інфраструктури, період окупації/деокупації, дистантність медичних закладів, або мовні бар'єри – у ситуації жінок-біженок за кордоном, ускладнюють отримання консультацій медичних працівників та психологів (перинатальних психологів).

Психологічні чинники.

– емоційний стан матері-годувальниці: післяпологова тривога, «бебі-блюз» чи депресія можуть негативно впливати на мотивацію та здатність годувати [3];

– відчуття компетентності: жінки, які обізнані у особливостях та правилах ГВ, рідше стикаються з труднощами.

– «відчуття прив'язаності до дитини»: грудне вигодовування активує нейроендокринні механізми «заспокоєння й прив'язаності», що зміцнює емоційний зв'язок матері й немовляти.

– психологічна підтримка фахівців: консультації фахівців-лікарів, психолога чи значущої людини допомагає матері-годувальниці швидше адаптуватись до нових життєвих обставин і швидше долати страхи та невпевненість.

Як свідчить практика, спостерігається взаємозв'язок та взаємодія соціальних та психологічних чинників, що впливають на жінку в період ГВ, а саме:

– сімейна/родинна/соціальна підтримка + внутрішній стан: навіть при високій мотивації жінки, відсутність соціальної підтримки може призвести до раннього припинення вигодовування.

– освітні програми: тренінги та інформаційні кампанії підвищують рівень знань і впевненість матері, зменшуючи вплив негативних стереотипів.

– мережа взаємодопомоги: спільноти матерів створюють простір для обміну досвідом, що знижує відчуття ізоляції.

Для вивчення впливу соціально-психологічних чинників на психоемоційний стан жінок у період лактації було застосовано валідну україномовну версію опитувальника Multidimensional Scale of Perceived Social Support – MSPSS [4]. Структура MSPSS включає три субшкали, кожна з яких містить чотири пункти. Субшкала «Сім'я» спрямована на оцінювання сприйнятої підтримки з боку членів родини та дозволяє визначити, наскільки жінка відчуває

себе прийнятою, зрозумілою та підкріпленою у найближчому сімейному колі. Субшкала «Друзі» відображає рівень підтримки з боку дружнього оточення, що в післяпологовий період може виконувати функцію емоційного розвантаження та соціального ресурсу. Субшкала «Близькі люди» оцінює підтримку з боку значущих осіб, поза межами формальних родинних чи дружніх зв'язків, що є особливо актуальним в умовах зміненої соціальної структури. Таким чином, застосування MSPSS забезпечує можливість комплексного аналізу сприйнятої соціальної підтримки жінок-годувальниць у післяпологовий період та її зв'язків із показниками психоемоційного стану й адаптаційних ресурсів.

Таблиця 1

Показники соціальної підтримки за шкалою MSPSS

Шкала MSPSS	M ± SD	Me	Q1–Q3
Підтримка сім'ї	5,82 ± 0,86	6,0	5,3–6,5
Підтримка друзів	4,97 ± 1,01	5,0	4,3–5,7
Підтримка значущих інших	5,41 ± 0,93	5,5	4,8–6,2
Загальний показник MSPSS	5,40 ± 0,79	5,5	4,9–6,1

Отримані результати свідчать про достатньо високий рівень сприйнятої соціальної підтримки у вибірці жінок-годувальниць. Найвищі показники зафіксовані за субшкалою «Підтримка сім'ї» ($M = 5,82$; $Me = 6,0$), що є закономірним з огляду на сімейний статус більшості досліджуваних та специфіку післяпологового періоду. Таким чином, сім'я виступає головним джерелом підтримки у післяпологовий період. Найнижчі значення характерні для субшкали «Підтримка друзів» ($M = 4,97$; $Me = 5,0$), що може відображати звуження соціальних контактів жінок у перші місяці після народження дитини та переорієнтацію на сімейну систему підтримки. Щодо соціальної підтримки жінок залежно від типу вигодовування дитини (табл. 2). Грудне вигодовування асоціюється з більшою підтримкою сім'ї та значущих інших. Штучне

вигодовування супроводжується дефіцитом підтримки, що може відображати як об'єктивну нестачу ресурсів, так і суб'єктивне відчуття ізоляції. Аналіз показників сприйнятої соціальної підтримки за шкалою MSPSS залежно від типу вигодовування дитини засвідчив наявність відмінностей між досліджуваними групами жінок у післяпологовий період.

Таблиця 2

Показники MSPSS залежно від типу вигодовування дитини

Тип вигодовування	n	Підтримка сім'ї (Me)	Підтримка друзів (Me)	Значущі інші (Me)	Загальний MSPSS (Me)
Виключно грудне вигодовування (1–5 міс.)	43	6,2	5,3	5,9	5,8
Змішане вигодовування (6–7(8) міс.)	29	5,8	5,0	5,4	5,4
Штучне вигодовування	22	5,1	4,5	4,9	4,9

У групі жінок, які здійснювали виключно грудне вигодовування протягом 1–5 місяців ($n = 43$), зафіксовано найвищі медіанні значення за всіма компонентами соціальної підтримки. Зокрема, медіана показника підтримки з боку сім'ї становила 6,2 бала, підтримки друзів – 5,3 бала, підтримки з боку значущих інших – 5,9 бала. Загальний показник сприйнятої соціальної підтримки в цій групі також був найвищим ($Me = 5,8$). Отримані результати свідчать про високий рівень суб'єктивно сприйнятої доступності та соціальної підтримки у жінок, які підтримували виключно грудне вигодовування.

У групі жінок зі змішаним типом вигодовування ($n = 29$) медіанні значення за всіма показниками MSPSS були нижчими порівняно з групою виключно грудного вигодовування, насамперед за субшкалами друзів та значущих інших. Так, медіана підтримки з боку сім'ї становила 5,8 бала, підтримки друзів – 5,0 бала, підтримки з боку значущих інших – 5,4 бала, а загальний показник MSPSS –

5,4 бала. Така динаміка може вказувати на дещо нижчий рівень сприйнятої соціальної підтримки у жінок цієї групи, що може бути пов'язано з більшими труднощами в організації догляду за дитиною та вигодовуванням у післяпологовий період.

Найнижчі показники сприйнятої соціальної підтримки за всіма субшкалами MSPSS виявлено у групі жінок, діти яких перебували на штучному вигодовуванні ($n = 22$). Медіана підтримки з боку сім'ї в цій групі становила 5,1 бала, підтримки друзів – 4,5 бала, підтримки з боку значущих інших – 4,9 бала, тоді як загальний показник MSPSS дорівнював 4,9 бала. Це свідчить про відносно нижчу суб'єктивну оцінку соціальної підтримки з боку різних соціальних джерел у жінок цієї групи. Загалом простежується тенденція до зниження рівня сприйнятої соціальної підтримки зі зміною типу вигодовування від виключно грудного до штучного. Найвищі показники за всіма субшкалами MSPSS характерні для жінок, які здійснювали виключно грудне вигодовування, тоді як найнижчі – для жінок, які використовували штучне вигодовування. Отримані результати підтверджують припущення про значущу роль соціальної підтримки у процесі організації та підтримання грудного вигодовування в післяпологовий період, особливо в умовах підвищеного стресового навантаження.

Висновки. Отримані результати свідчать, що тип вигодовування пов'язаний насамперед із варіативністю сімейної підтримки та підтримки з боку значущих інших, тоді як соціальна підтримка друзів виявляється відносно незалежною від цього чинника.

Найвищі показники соціальної підтримки характерні для жінок, які здійснюють виключно грудне вигодовування, тоді як у групі штучного вигодовування зафіксовано найнижчі значення.

Отримані дані свідчать про значущу роль соціального оточення як ресурсу психологічної адаптації жінок-годувальниць у післяпологовий період. Таким чином, соціально-психологічні чинники мають комплексний вплив на

психоемоційний стан жінки-годувальниці та визначають успішність грудного вигодовування: емоційна стабільність, підтримка сім'ї та суспільства, культурні установки й доступність професійної допомоги та ін. Важливо розглядати їх у взаємозв'язку, адже саме баланс між внутрішніми ресурсами жінки та зовнішнім середовищем забезпечує здоровий розвиток дитини й психологічне благополуччя матері.

Список використаних джерел.

1. Безрук В., Семань-Мінько І., Шкробанець І., Булик Т., Ринжук Л., Гресько М., Васильєва Н., Веля М. Менеджмент підтримки грудного вигодовування в умовах війни. *Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина*. 2024. Том 14. № 2 (52), с.145–150. <https://doi.org/10.24061/2413-4260.XIV.2.52.2024.20>
2. Головатюк Я. Фізіологічні та психологічні переваги грудного вигодовування. URL: <http://uoz.gov.ua/2024/08/07/>
3. Козар О. Як грудне вигодовування підтримує психічне здоров'я матері та дитини? URL: <https://www.bsmu.edu.ua/blog/yak-grudne-vygodovuvannya-pidtrymuje-psyhichne-zdorovya-materi-ta-dytyny/>
4. Мельник Ю. Б., Стаднік А. В. Багатомірна шкала сприйняття соціальної підтримки: метод. посіб. (укр. версія). Харків: ХОГОКЗ. 2023. 12 с. <https://doi.org/10.26697/melnyk.stadnik.6.2023> URL: culturehealth.org+1
5. Alcorn K. L., O'Donovan A., Patrick J. C., Creedy D. K., Devilly G. J. A prospective longitudinal study of the prevalence of post-traumatic stress disorder resulting from childbirth events. *Psychological Medicine*. 2010. Vol. 40, № 11. pp. 1849–1859. DOI: 10.1017/S0033291709992224.
6. Binns, C., Lee, M. Breastfeeding and the human milk microbiome. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 2019, 16 (23), pp. 1–11.

7. Hahn-Holbrook, J., Schetter, C., Haselton, M. Breastfeeding and maternal mental health. *Annual Review of Clinical Psychology*, 2019, 15, pp. 277–304. URL: https://www.researchgate.net/profile/Jennifer-Hahn-Holbrook/publication/304223203_The_Advantages_and_Disadvantages_of_Breastfeeding_for_Maternal_Mental_and_Physical_Health/links/584f390408aed95c2509981b/The-Advantages-and-Disadvantages-of-Breastfeeding-for-Maternal-Mental-and-Physical-Health.pdf?origin=publication_detail
8. Fallon, V., Groves, R., Halford, J., Harrold, J. Postpartum anxiety and infant-feeding outcomes. *Journal of Human Lactation*, 2017, 33 (1), pp. 269–276.

Аналіз небезпечних психосоціальних чинників ризику стресу працівників під час військової агресії

Гільперт Н.М.

кандидат економічних наук

*Здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти
Академія праці, соціальних відносин і туризму, м. Київ*

Горошко Н.О.

*Асистент, Національний технічний університет
«Дніпровська політехніка», м. Дніпро*

Актуальність. Прийняття Закону «Про систему охорони психічного здоров'я» [1] є важливим кроком у протидії глибокої кризи ментального здоров'я, що спричинено наслідками російської агресії. Даний Закон слугуватиме орієнтиром для роботодавців при формуванні культури безпеки на підприємстві. Культура безпеки визначається як рівень розвитку особистості та суспільства, що виражається в наданні пріоритетного значення питанням безпеки в системі індивідуальних і соціальних цінностей, поширеності моделей безпечної поведінки як у повсякденних умовах, так і в ситуаціях загрози чи надзвичайних подій, а також у ступені захищеності в усіх сферах життєдіяльності; або як стан розвитку особистості, соціальної групи чи суспільства, що відображається у ставленні до питань безпеки життя і діяльності та проявляється в активних практичних діях, спрямованих на зниження рівня ризиків [5].

Забезпечення психологічного добробуту працівників в мирний час потребує значних зусиль, а початок повномасштабної війни спричинив масштабну психологічну кризу, що виходить за межі гострої реакції на стрес і виникає необхідність акумулювати максимум ресурсу для зменшення впливу на здоров'я людини.

Аналіз психоемоційного стану цивільного населення на другому та третьому роках війни виявляє складну картину, що вимагає глибокого розуміння

природи травми та її наслідків. Це дозволить знайти шляхи зменшення впливу психосоціальних ризиків на здоров'я людини.

Керування психосоціальними ризиками є досить динамічною сферою, зростання уваги до якої свідчить про розуміння того, що психосоціальне благополуччя працівників є ключовим фактором не лише для їхнього здоров'я, а й для ефективності та успіху організації в цілому.

Психосоціальні ризики розглядаються не як ізольовані чинники, а як взаємопов'язана система, що включає організаційну культуру, управління, зміст роботи та соціальний контекст. Встановлено, що взаємодія кількох ризиків одночасно може посилювати їхній негативний вплив на здоров'я працівників.

Слід відмітити, що більшість досліджень присвячені виключно пошуку причин втрати психічного здоров'я через оцінювання ризику переживання стресу, тоді як визначенню дієвих запобіжних заходів, що можна зробити через ранжування небезпечних психосоціальних чинників, приділяється досить не багато уваги [4]. Цим визначається актуальність розгляду ієрархії психосоціальних небезпечних чинників тяжкості наслідків стресу, що дозволить своєчасно визначити результативні запобіжні заходи відповідно до викликів, які постали перед українським суспільством внаслідок повномасштабного вторгнення.

Мета дослідження. Визначення ієрархії небезпечних психосоціальних чинників, що визначають тяжкість наслідків стресу у працівників під час військової агресії.

Результати дослідження. На найвищому рівні ієрархії знаходяться психосоціальні чинники, які атакують фундаментальні основи психологічного добробуту людини: безпеку, стабільність та надію на майбутнє. Дані досліджень, проведених у 2024–2025 роках, вказують на те, що саме ці чинники є найпотужнішими предикторами одночасно для всіх трьох ключових наслідків

стресу – тривожності, депресії та посттравматичних стресових розладів (далі – ПТСР) [2].

Економічна невизначеність в умовах війни виходить далеко за межі фінансових труднощів, перетворюючись на потужний психологічний стресор. Аналіз показує, що як реальна втрата роботи, так і страх її втратити є однаково токсичними для психічного здоров'я [2].

Страх окупації є ще одним потужним універсальним предиктором, сила якого полягає в загрозі не лише фізичній безпеці, а й фундаментальним аспектам особистості: свободі, автономії, культурній ідентичності та людській гідності.

Найбільш небезпечним психологічним чинником, що знаходиться на самій вершині ієрархії, є «відсутність перспектив у майбутньому». Цей чинник демонструє найвищі показники зв'язку з депресією і є надзвичайно сильним предиктором тривожності [2]. Його руйнівна сила полягає в тому, що він знищує надію – ключовий ресурс для подолання будь-яких труднощів.

На другому рівні ієрархії розташовані психосоціальні чинники, які мають більш специфічний ефект, впливаючи на один або два наслідки стресу, а не на всі три одночасно. Цей рівень включає конкретні травматичні втрати та чинники середовища, які діють як підсилювачі основних екзистенційних загроз. Втрата домівки та соціальних зв'язків є одними з найбільш болісних проявів війни, що руйнують основи стабільності особистості і символізує руйнування всього звичного життя, що призводить до глибокого горя, безнадії та розхитування світогляду, що є характерним для депресивних та посттравматичних станів. Втрата друзів внаслідок воєнних подій, у свою чергу, є специфічним предиктором і пояснюється тим, що раптова, насильницька втрата близьких людей є гострою травматичною подією, яка може викликати інтрузивні спогади, почуття провини та інші симптоми, характерні для посттравматичного стресу. Втрата друзів також означає руйнування мережі соціальної підтримки, що є ключовим буфером у

подоланні стресу, залишаючи людину ще більш вразливою до наслідків травми [2].

В умовах гібридної війни інформаційний простір має прямий вплив на психічне здоров'я. Надмірне споживання медіа-ресурсів виступає предиктором тривожності, але не депресії [2]. Ця специфічність вказує на конкретний механізм впливу медіа: вони діють як джерело опосередкованої травматизації та підсилювач загроз.

Третій рівень представлений чинниками, які при певних стратегіях подолання стресу, що на перший погляд здаються адаптивними, в умовах хронічного виснаження можуть перетворюватися на додаткові джерела стресу. Ресурс «альтернативна роботі діяльність (додаткова робота)» виявляється позитивним предиктором для всіх трьох станів: тривожності, депресії та ПТСР. Це ілюструє, як спроба компенсувати фінансову нестабільність або відволіктися через додаткову роботу на тлі загального виснаження призводить до перевантаження та емоційного вигорання, погіршуючи загальний стан. Ще більш потужним парадоксальним чинником є «зміна пріоритетів стосунків у житті». Хоча це може бути необхідним процесом адаптації, він виступає сильним позитивним предиктором тривожності, депресії та ПТСР [2]. Це відкриття виявляє приховану напругу в соціальній сфері. З одного боку, наявність стабільної підтримки є захисним сприятливим психосоціальним чинником. З іншого – сам процес реконфігурації соціальної мережі (розрив стосунків через політичні розбіжності, втрата старих друзів, переоцінка цінностей) є надзвичайно енергозатратним та емоційно болісним. Він вимагає значних когнітивних та емоційних зусиль, що в умовах виснаження стає самостійним джерелом травматизації. Це вказує на те, що соціальна підтримка не є монолітним поняттям: стан наявності підтримки є захисним, але процес її здобуття, збереження чи відновлення під час кризи є значним стресором. На основі теоретико-аналітичного аналізу вторинних емпіричних даних Фролової Н. В. [2] побудована ієрархічна

модель психосоціальних чинників, що впливають на тяжкість наслідків переживання стресу. Ця модель структурує небезпечні психосоціальні чинники у логічну систему (табл. 1).

Таблиця 1

Рівні ієрархії небезпечних психосоціальних чинників

Рівень	Назва рівня	Опис рівня	Психосоціальні чинники
1	Екзистенційні загрози (Двигун дистресу)	На першому рівні на вершині ієрархії знаходяться універсальні предиктори, які підривають фундаментальні психологічні потреби в безпеці, стабільності та надії. Ці небезпечні психосоціальні чинники є першопричиною та найпотужнішим джерелом психологічного страждання населення.	– відсутність перспектив у майбутньому, – страх окупації, – страх втрати роботи.
2	Гострі травматичні події та підсилювачі середовища (Прояви загрози)	На другому рівні є конкретні втрати та зовнішні стресори, які є прямим наслідком або посилюються небезпечними психосоціальними чинниками першого рівня. Вони роблять екзистенційну загрозу відчутною та реальною.	– фактична втрата роботи, – втрата домівки, – втрата друзів, – надмірне споживання медіа.
3	Деадаптивний копінг та реляційний стрес (Поведінкова реакція)	На третьому рівні знаходяться поведінкові патерни та процеси, які, хоч і можуть бути спрямовані на адаптацію, в умовах хронічного виснаження функціонують як додаткові стресори.	– залучення до додаткової роботи, – процес зміни пріоритетів у стосунках.

Створення збалансованої моделі потребує проведення аналізу не лише небезпечних психосоціальних чинників, що посилюють ймовірність настання переживання стресу, а й тих, що сприяють стійкості (резильєнтності) та пом'якшують негативні наслідки травми. Ці сприятливі (захисні) психосоціальні чинники формують фундамент, на якому базується здатність особистості та суспільства протистояти викликам війни (табл. 2).

Сприятливі (захисні) психосоціальні чинники

Назва групи сприятливих (захисних) психосоціальні чинники	Опис	Психосоціальні чинники
Медіатори стійкості (Буферна система)	Ця група представляє сприятливі (захисні) психосоціальні чинники, які можуть пом'якшувати вплив стресорів на всіх трьох рівнях ієрархії (табл. 1), підвищуючи здатність до опору та відновлення.	Наявність дітей, спілкування з близькими, національна ідентичність, фізична активність.

Соціальна підтримка на різних рівнях – від мікрорівня близьких стосунків до макрорівня національної єдності – виступає потужним буфером проти травматичного стресу. «Спілкування з близькими» демонструє значущий негативний зв'язок із тривожністю, депресією та ПТСР, виступаючи «опорою» для подолання цих станів [2].

Це підтверджує класичну теорію про важливість соціальної підтримки як джерела емоційної регуляції, практичної допомоги та підтвердження власної значущості. На колективному рівні високий рівень «національної ідентичності» діє як «психологічно захисний» механізм, знижуючи рівень тривоги та депресії [4]. З початком повномасштабного вторгнення національна символіка, мова та культура стали потужними об'єднуючими сприятливими (захисними) психосоціальними чинниками.

Відчуття приналежності до великої спільноти, що бореться за спільні цінності, надає сенс стражданням, протидіє почуттю ізоляції та безпорадності, а також мобілізує на активні дії, що є важливим антидотом до апатії та депресії. Наявність дітей виявилася одним із найпотужніших сприятливих (захисних) психосоціальних чинників, що демонструє сильний негативний зв'язок із тривожністю, депресією та ПТСР [2].

Цікаво, що цей ефект змінився з часом: якщо на початку війни наявність дітей асоціювалася з додатковим дистресом, то через два роки вона стала джерелом стійкості. Механізм цього явища полягає в тому, що турбота про дітей надає життю чітку мету та структуру. Вона змушує батьків мобілізувати всі ресурси, переключати увагу з власних переживань на потреби дитини та підтримувати щоденну рутину, що є надзвичайно важливим для стабілізації психіки в хаотичних умовах. Діти стають джерелом «додаткової уваги» та «фактом стійкості до тривалої травматизації», не дозволяючи зануритися в особисті переживання та відчай.

Фізична активність виступає сприятливим (захисним) психосоціальним чинником та ефективним інструментом для боротьби з депресивними станами, маючи значущий негативний зв'язок із депресією. Хоча вона не є універсальним сприятливим (захисним) психосоціальним чинником від усіх наслідків стресу, її роль у подоланні депресії є ключовою [2].

Це пояснюється як біохімічними механізмами (вироблення ендорфінів), так і психологічними – поведінковою активацією, яка допомагає боротися з апатією, ангедонією та відчуттям безсилля, що є ядром депресивного досвіду. В табл. 3 представлена ієрархія небезпечних психосоціальних чинників, яка визначена за тяжкістю наслідків: тривожність, депресія та ПТСР, сформована на основі даних досліджень [2].

**Ієрархія психосоціальних чинників, яка побудована
за тяжкістю наслідків стресу**

Рівень в ієрархії	Назва психосоціального чинника	Тип психосоціального чинника небезпечний/сприятливий (захисний)	Наслідок(и) стресу
Рівень I	Відсутність перспектив у майбутньому	Надзвичайно небезпечний	Важка депресія, ПТСР (тривожність)
	Страх окупації		
	Страх втрати роботи		
Рівень II	Втрата роботи	Високо небезпечний	Різні різновиди депресії, Неускладнений ПТСР (тривожність)
	Втрата домівки		
	Втрата друзів		
	Споживання медіа ресурсів		
Рівень III	Зміна пріоритетів стосунків	Помірно небезпечний	Тривожність, Депресія, (можливий ПТСР)
	Додаткова робота		

Представлена ієрархія небезпечних психосоціальних чинників дозволяє перейти від простої констатації проблеми до розробки цілеспрямованих та науково обґрунтованих дій щодо психологічної допомоги цивільному населенню України. Таким чином це встановлює поступовість оцінки психосоціальних ризиків.

Оскільки ключовими рушіями психологічного дистресу є екзистенційні загрози, пов'язані з майбутнім та економічною стабільністю, психологічна допомога не може бути ефективною в ізоляції від соціальної підтримки.

Звідси необхідно розробити та впровадити спеціалізовані програми підтримки для осіб, які зазнали гострих травматичних втрат (втрата житла, близьких). Водночас, на державному рівні та через громадські ініціативи слід просувати концепцію «інформаційної гігієни» – навчання навичкам дозованого та критичного споживання інформації для зменшення рівня опосередкованої травматизації. При цьому психологічні та освітні програми мають бути

спрямовані на підвищення обізнаності населення про парадоксальну природу деяких копінг-стратегій. Людей необхідно навчати розпізнавати ознаки вигорання від надмірної діяльності та надавати їм інструменти для управління стресом, пов'язаним із необхідністю перебудови соціальних зв'язків [3]. Дії втручання мають активно спиратися на виявлені сприятливі (захисні) психосоціальні чинники, для чого необхідно:

- створити платформи та ініціативи, що зміцнюють родинні та громадські зв'язки;
- забезпечити підтримку батьківства як ключового чинника стійкості через спеціалізовані сервіси та консультації;
- проводити промоцію національної культури, історії та мови для подальшого зміцнення колективної ідентичності;
- забезпечити доступ до безпечних місць для занять фізичною активністю як дієвого засобу боротьби з депресією.

Психологічна допомога працівникам в умовах тривалої війни повинна бути комплексною, гнучкою та базуватися на розумінні ієрархії небезпечних психосоціальних чинників для зниження рівня стресу працівників. Це визначає необхідність інвестування у впровадження дієвих методів, що допоможуть ідентифікувати небезпечні психосоціальні чинники на підприємствах та керувати психосоціальними ризиками.

Висновки. До найбільш значущих небезпечних психосоціальних чинників тяжкості наслідків стресу відносять всеосяжні екзистенційні загрози, які атакують фундаментальні основи психологічного добробуту людини: безпеку, стабільність та надію на майбутнє. Запропонована ієрархія небезпечних психосоціальних чинників тяжкості наслідків стресу, що демонструє зв'язок психологічний стан людини в умовах війни та комплексом окремих стресорів, які пов'язані складною динамікою між екзистенційними страхами, реальними втратами, поведінковими реакціями та наявними ресурсами стійкості. Ключовими рушіями психологічного

дистресу є екзистенційні загрози, пов'язані з майбутнім та економічною стабільністю. Програми, спрямовані на працевлаштування, перекваліфікацію, фінансову допомогу та створення довгострокових економічних перспектив, мають розглядатися як першочергові заходи для збереження психічного здоров'я.

Список використаних джерел.

1. Закон України «Про систему охорони психічного здоров'я в Україні» від 15 січня 2025 року № 4223-IX.
2. Фролова Н. В. Психологічні особливості травматичного досвіду українців під час війни. Психологія і суспільство. 2024. No 1. С. 188–196
3. Фролова Н. В. Структурна модель психологічної допомоги цивільному населенню під час війни в Україні. Габітус. 2025. No 69. С. 253–258.
4. Фролова Н.В. Феномен колективної травми в контексті сучасного українського досвіду її проживання. Габітус. 2023. No 46. С. 199–203.
5. Шароватова О. П., Цимбал Б. М., Гільперт В. В. Соціально-психологічні аспекти розвитку культури безпеки працівників. Науковий Журнал Метінвест Політехніки. Серія: Технічні науки. Спецвипуск, присвячений 5-річчю Технічного університету «Метінвест Політехніка». 2025. No 4. С. 370–376.

Психологічні наслідки тривалого стресу: емоційне вигорання волонтерів

*Добровольська В.О.
Здобувач другого(магістерського) рівня вищої освіти
Академія праці, соціальних відносин і туризму, м. Київ*

*Бондар С.С.
Доктор філософії з спеціальності «Психологія»
Академія праці, соціальних відносин і туризму, м. Київ*

*Жигинас Ю.Б.
Старший викладач кафедри психології
Академія праці, соціальних відносин і туризму, м. Київ*

Актуальність. У сучасних соціальних умовах проблема збереження ментального здоров'я особистості набуває особливої актуальності. Постійні соціальні, економічні та безпекові виклики зумовлюють тривалий вплив стресогенних факторів на людину, що негативно позначається на її психологічному благополуччі, емоційній стабільності та здатності до ефективної життєдіяльності. У психологічній науці тривалий (хронічний) стрес розглядається як один із домінуючих чинників розвитку дезадаптивних станів, що порушують внутрішню рівновагу особистості та знижують її життєстійкість.

Поняття «емоційне вигорання» у психологічній науці визначається як стійкий психоемоційний стан, який формується внаслідок впливу стресогенних факторів протягом тривалого часу і супроводжується переважною емоційних, когнітивних і особистісних ресурсів [1, 2]. У структурі емоційного вигорання виділяються компоненти: емоційне виснаження; деперсоналізація; зниження відчуття особистісних досягнень [3].

У зарубіжній психології феномен емоційного вигорання був концептуалізований С. Джексоном, М. Лейтером, К. Маслачем, як багатовимірний синдром, що виникає внаслідок тривалого емоційного перенапруження у процесі міжособистісної взаємодії та допоміжної діяльності. Автори підкреслюють, що

емоційне виснаження є центральним компонентом вигорання, який запускає подальші дезадаптивні зміни [5, с. 12–14]. В українській психологічній науці проблема емоційного вигорання ґрунтовно досліджується у працях О. М. Кокуна, який розглядає вигорання як наслідок хронічного стресу та дисбалансу між вимогами діяльності й ресурсами особистості [2, с. 174–176]. С. Д. Максименко акцентує увагу на особистісних механізмах виснаження та ролі психологічної саморегуляції у подоланні стресових станів [3].

При дослідженні емоційного вигорання особливої уваги набувають професії типу «людина-людина» до якої відноситься волонтерська діяльність, яка в останні роки набула масового характеру та стала важливим соціально-психологічним ресурсом підтримки суспільства. Волонтери часто перебувають у ситуаціях підвищеного емоційного напруження, пов'язаного з необхідністю надання допомоги людям, які переживають кризові, травматичні, екстремальні життєві обставини. Високий рівень відповідальності, інтенсивна міжособистісна взаємодія, дефіцит відновлювальних ресурсів і тривалість стресового впливу створюють умови для поступового виснаження психологічних ресурсів волонтерів. Таким чином, актуалізується проблема емоційного вигорання як одного з найбільш поширених психологічних наслідків тривалого стресу. Емоційне вигорання волонтерів розглядається як складний психоемоційний феномен, що проявляється у стані емоційного виснаження, зниженні рівня особистісної ефективності, втраті мотивації та формуванні негативного ставлення до власної діяльності. Для волонтерів, діяльність яких ґрунтується на емпатії, альтруїзмі та високій емоційній залученості, ризик розвитку емоційного вигорання є особливо високим.

Незважаючи на зростання наукового інтересу до проблеми емоційного вигорання в представників допомагаючих професій, питання психологічних наслідків тривалого стресу саме у волонтерів залишається недостатньо систематизованим. Більшість досліджень зосереджені на професійних групах,

тоді як волонтерська діяльність має свою специфіку, що потребує окремого наукового аналізу. Це зумовлює необхідність поглибленого дослідження механізмів формування емоційного вигорання у волонтерів та виявлення його основних психологічних проявів.

Проблема емоційного вигорання традиційно досліджувалась у представників допомагаючих професій, діяльність яких пов'язана з високим рівнем міжособистісної взаємодії та емоційної залученості. Зокрема, емоційне вигорання вивчалось у психологів, медичних працівників, соціальних працівників, педагогів, рятувальників і фахівців кризових служб [4; 8].

У цих професійних групах емоційне вигорання розглядається як результат тривалого контакту з проблемами, стражданнями та травматичним досвідом інших людей, що зумовлює виснаження психологічних ресурсів та підвищує ризик дезадаптації.

Проблематика тривалого стресу та його психологічних наслідків представлена у працях вітчизняних і зарубіжних дослідників. У працях українських учених, зокрема А. Я. Боднар, О. М. Кокуна, С. Д. Максименка, розкрито теоретичні засади розуміння стресу, його вплив на психоемоційний стан особистості та механізми психологічної адаптації в умовах підвищеного навантаження [1; 2; 3].

Феномен емоційного вигорання ґрунтовно досліджувався у працях зарубіжних науковців К. Маслач, С. Джексон, М. Лейтера, які розглядали вигорання як багатовимірний синдром, що включає емоційне виснаження, деперсоналізацію та зниження відчуття особистісних досягнень [4; 5]. Значний внесок у вивчення взаємозв'язку стресу та виснаження зробили також С. Хобфолл, А. Баккер, Е. Демеруті, які обґрунтували роль психологічних ресурсів особистості у подоланні тривалого стресу [6; 9].

Окремі аспекти психологічних наслідків допомагаючої діяльності, зокрема вторинної травматизації та співчуттєвого виснаження, висвітлені у працях Ч.

Фіглі, який досліджував вплив регулярного контакту з травматичним досвідом інших осіб на психоемоційний стан фахівців і волонтерів [8].

У психологічній науці тривалий (хронічний) стрес розглядається як стан, що виникає внаслідок пролонгованого впливу стресогенних чинників та перевищення адаптаційних можливостей особистості. На відміну від гострого стресу, який може виконувати мобілізаційну функцію, тривалий стрес характеризується поступовим виснаженням психічних і фізіологічних ресурсів, що негативно позначається на емоційній сфері, когнітивному функціонуванні та поведінкових реакціях особистості [1, с. 20].

За концепцією збереження ресурсів С. Хобфолла, ключовим механізмом негативного впливу тривалого стресу є втрата або загроза втрати значущих ресурсів – емоційних, особистісних, соціальних [6, с. 15]. У ситуації, коли особистість не має можливості відновити витрачені ресурси, формується стійкий стан психоемоційного напруження, що з часом призводить до розвитку дезадаптивних станів. Цей підхід є особливо релевантним для аналізу волонтерської діяльності, оскільки вона часто передбачає інтенсивну емоційну віддачу за умов обмежених можливостей відновлення.

У межах дослідження психологічних наслідків тривалого стресу особливе місце посідає феномен емоційного вигорання. Класичне визначення цього явища було запропоноване С. Джексоном, М. Лейтером, К. Маслачем, які розглядали емоційне вигорання як багатовимірний синдром, що включає емоційне виснаження, деперсоналізацію та зниження відчуття особистісних досягнень [5, с. 32]. Емоційне виснаження проявляється у відчутті спустошеності та втоми, деперсоналізація – у формуванні відстороненого або цинічного ставлення до інших, а зниження особистісної ефективності – у втраті віри у власну професійну чи соціальну значущість.

Подальші дослідження уточнили роль організаційних та особистісних чинників у формуванні вигорання. Зокрема, у межах теорії вимог і ресурсів праці

А. Баккера та Е. Демеруті емоційне вигорання розглядається як наслідок дисбалансу між високими вимогами діяльності та недостатністю ресурсів для їх подолання [9]. Хоча ця модель була розроблена переважно для аналізу професійної діяльності, її положення можуть бути адаптовані до волонтерської сфери, де вимоги часто є неформалізованими, але емоційно надзвичайно інтенсивними.

Волонтери мають загрозу вигорання, оскільки їхня робота має різні унікальні характеристики. Ця робота не передбачає чітких часових рамок для виконання завдань, системи робочої підтримки чи стандартної оплати, на відміну від професійної роботи. Волонтери влаштовуються на роботу, тому що хочуть розпалити свій рівень співчуття і таким чином повністю поглинутися розумінням та підтримкою проблем інших людей. Швидке споживання емоційної енергії волонтерів відбувається, коли вони стикаються з тривалими стресовими ситуаціями. Втома від співчуття та вторинний травматичний стрес – це два компоненти проблеми, які аналізує К. Фіглі у своєму дослідженні.

Основна ідея дослідника полягає в тому, що у людей, які постійно стають свідками травматичних подій інших людей, розвиваються симптоми вигорання, що нагадують посттравматичний стресовий розлад. Волонтери, які працюють у надзвичайних ситуаціях, вважають цей елемент своєї роботи дуже критичним. Таким чином, теоретичний аналіз наукових підходів дозволяє зробити висновок, що емоційне вигорання волонтерів слід розглядати як складний психологічний наслідок тривалого стресу, зумовлений поєднанням високих емоційних вимог, обмежених ресурсів та специфіки допоміжної діяльності, що обґрунтовує необхідність подальшого аналізу особливостей прояву емоційного вигорання у волонтерів та пошуку ефективних шляхів його профілактики.

Мета дослідження. Теоретично проаналізувати психологічні наслідки тривалого стресу, що впливають на виникнення емоційного вигорання волонтерів.

Результати дослідження. Аналіз результатів теоретичного дослідження засвідчує, що тривалий стрес є важливим чинником формування емоційного вигорання у волонтерів. Отримані узагальнення дозволяють констатувати, що систематичний вплив стресогенних факторів у процесі волонтерської діяльності призводить до поступового виснаження емоційних ресурсів особистості, що узгоджується з положеннями теорії збереження ресурсів С. Хобфолла [6, с. 131–133]. Згідно з цією теорією, саме тривала втрата або загроза втрати значущих ресурсів є ключовим механізмом розвитку стресових і дезадаптивних станів.

У структурі емоційного вигорання найбільш вираженим компонентом виявляється емоційне виснаження, що проявляється у відчутті хронічної втоми, зниженні емоційної залученості та відчутті спустошеності. Подібні прояви розглядаються К. Масlach як центральний елемент синдрому вигорання, який виникає внаслідок тривалого перевантаження емоційної сфери [5, с. 12–14]. Для волонтерів емоційне виснаження посилюється постійною необхідністю надавати підтримку іншим за умов обмеженого часу для відновлення власних ресурсів.

За результатами міжнародних досліджень із використанням адаптованих версій опитувальника Maslach Burnout Inventory [5] 37,4 % волонтерів мають високий рівень емоційного виснаження, тоді як 62,6 % демонструють середній або низький рівень цього показника. Такий розподіл свідчить про те, що більш ніж третина волонтерів перебуває у стані значного психоемоційного перевантаження. Емоційне виснаження, за К. Масlach, є базовим компонентом синдрому емоційного вигорання і формується внаслідок тривалого впливу емоційно насичених стресових чинників [5, с. 12–14]. Для волонтерської діяльності це має особливе значення, оскільки вона передбачає систематичне надання допомоги іншим без чітко регламентованих меж робочого часу та без гарантованих механізмів психологічного відновлення.

Висока частка осіб, 37,4 % волонтерів, із вираженим емоційним виснаженням підтверджує положення теорії збереження ресурсів С. Хобфолла,

відповідно до якої тривалий стрес призводить до поступової втрати емоційних і особистісних ресурсів, а відсутність їх відновлення спричиняє формування дезадаптивних психоемоційних станів [6, с. 131–133]. Таким чином, наведені дані демонструють об'єктивну наявність ризику розвитку емоційного вигорання у значної частини волонтерів.

Аналіз отриманих результатів також свідчить про наявність проявів деперсоналізації, які виражаються у формуванні емоційної дистанції, зниженні емпатійної чутливості та прагненні обмежити міжособистісні контакти. За Маслач і Лейтером, деперсоналізація виконує захисну функцію, дозволяючи особистості тимчасово зменшити емоційне навантаження, однак у довгостроковій перспективі вона негативно впливає на якість діяльності та психологічне благополуччя [4, с. 286–288]. У контексті волонтерської діяльності цей механізм може призводити до втрати мотиваційної основи допомоги та внутрішнього конфлікту між цінностями й реальними можливостями особистості.

Ще одним важливим аспектом емоційного вигорання є зниження відчуття особистісної ефективності, що проявляється у сумнівах щодо власної значущості та результативності волонтерської діяльності. Як зазначає О. М. Кокун, зниження суб'єктивної оцінки власних досягнень є наслідком тривалого перебування у стані емоційного напруження та відсутності позитивного зворотного зв'язку [2, с. 174–176]. Для волонтерів це може бути пов'язано з неможливістю швидко побачити результати своєї допомоги або з відчуттям безсилля перед масштабом проблем, з якими вони стикаються.

Інтерпретація результатів дослідження теорії вимог і ресурсів А. Баккера та Е. Демеруті дозволяє розглядати емоційне вигорання волонтерів як наслідок дисбалансу між високими емоційними вимогами діяльності та недостатністю ресурсів для їх компенсації [9, с. 276–278]. В умовах, коли волонтерська діяльність не супроводжується чітко структурованою системою підтримки, цей дисбаланс

стає особливо вираженим і сприяє формуванню стійкого стану психоемоційного виснаження.

Окремої уваги заслуговує вплив вторинної травматизації на формування емоційного вигорання у волонтерів. Ч. Фіглі розглядає вторинну травматизацію як наслідок систематичного емпатійного залучення до переживань осіб, які зазнали травматичних подій, що призводить до внутрішнього відтворення їхнього досвіду та емоційних реакцій [8, с. 23–25]. За таких умов накопичення вторинного стресу зумовлює підвищене емоційне напруження, порушення емоційної регуляції та поступове виснаження психологічних ресурсів, що безпосередньо сприяє розвитку емоційного вигорання.

У волонтерській діяльності ризик вторинної травматизації посилюється відсутністю чітко структурованих меж допомоги, нерегламентованістю навантаження та браком системної психологічної підтримки. Це створює умови, за яких волонтери тривалий час залишаються у стані емоційної включеності без достатніх можливостей для відновлення, що підвищує ймовірність переходу вторинного стресу у стійкі прояви емоційного виснаження та деперсоналізації. Таким чином, вторинна травматизація виступає не лише супутнім явищем, а одним із вагомих психологічних механізмів формування емоційного вигорання у волонтерів [8, с. 23–25].

У межах даного дослідження, можна визначити, що емоційне вигорання волонтерів розглядається як стійкий психоемоційний стан, що формується внаслідок пролонгованого стресового впливу у процесі волонтерської діяльності та зумовлюється хронічним перевищенням вимог над наявними психологічними ресурсами особистості. Цей стан проявляється у прогресивному виснаженні емоційних ресурсів, зниженні мотивації до здійснення допоміжної діяльності, формуванні захисної емоційної дистанції у міжособистісній взаємодії, а також у зменшенні суб'єктивного відчуття особистісної ефективності та значущості власного внеску.

На відміну від професійного вигорання, емоційне вигорання волонтерів має низку специфічних особливостей, пов'язаних із характером волонтерської діяльності. Зокрема, воно формується за умов високої емоційної залученості, альтруїстичної мотивації та постійного контакту з кризовими або травматичними ситуаціями інших людей, що підвищує ризик вторинної травматизації. Водночас волонтерська діяльність зазвичай не має чітко регламентованих часових меж, структурованих вимог до навантаження та системи регулярної психологічної підтримки, що обмежує можливості своєчасного відновлення психоемоційних ресурсів.

Специфіка емоційного вигорання волонтерів полягає у поєднанні високої емоційної відповідальності та інтенсивної емпатійної взаємодії з недостатнім рівнем зовнішньої підтримки та саморегуляції, що сприяє накопиченню психоемоційного виснаження та підвищує ймовірність розвитку стійких дезадаптивних станів.

Власне емпіричне дослідження було спрямоване на вивчення особливостей прояву емоційного вигорання у волонтерів в умовах тривалого стресу. У дослідженні взяли участь 80 осіб, залучених до волонтерської діяльності різного спрямування. Усі респонденти мали досвід тривалого перебування в умовах підвищеного психоемоційного навантаження, пов'язаного з наданням допомоги людям у кризових життєвих ситуаціях. Для діагностики емоційного вигорання використовувалися стандартизовані психодіагностичні методики, зокрема Maslach Burnout Inventory [4] у адаптованій формі, що дозволяє оцінити рівень емоційного виснаження, деперсоналізації та зниження відчуття особистісних досягнень. Додатково застосовувалися методи аналізу суб'єктивного рівня психоемоційного напруження, що дало змогу комплексно охарактеризувати стан волонтерів у контексті тривалого стресового впливу.

Аналіз отриманих результатів засвідчив, що у значної частини респондентів наявні прояви емоційного вигорання різного ступеня вираженості. Найбільш

поширеним компонентом виявилось емоційне виснаження, яке проявлялося у відчутті хронічної втоми, зниженні емоційної залученості та потребі в емоційній дистанції. Результати свідчать про поступове виснаження психологічних ресурсів волонтерів унаслідок тривалого стресового впливу.

Крім того, у частини волонтерів спостерігалось зниження відчуття особистісної ефективності, що проявлялося у сумнівах щодо значущості власної діяльності та її результативності. Це може бути пов'язано з відсутністю швидкого зворотного зв'язку, неможливістю безпосередньо оцінити результати допомоги та постійним зіткненням із масштабом проблем, які перевищують індивідуальні можливості волонтера.

Отримані результати також вказують на наявність тенденцій до формування емоційної дистанції як захисного механізму, спрямованого на зменшення психоемоційного навантаження. Водночас тривале використання такого механізму може негативно впливати на мотивацію до волонтерської діяльності та підвищувати ризик подальшого розвитку емоційного вигорання.

Загалом результати емпіричного дослідження підтверджують, що емоційне вигорання волонтерів формується під впливом тривалого стресу та має комплексний характер, поєднуючи емоційне виснаження, зниження мотивації та зменшення відчуття особистісної ефективності. Це підкреслює необхідність системної психологічної підтримки волонтерів та впровадження профілактичних заходів, спрямованих на збереження їхнього ментального здоров'я.

Висновки. Проведений аналіз наукових джерел показав, що тривалий стрес суттєво впливає на ментальне здоров'я особистості та поступово підриває її психологічні ресурси. Якщо короточасний стрес може активізувати та мобілізувати внутрішні сили, то його тривалий вплив, навпаки, призводить до накопичення втоми, емоційного напруження та зниження здатності до ефективної адаптації. Саме за таких умов формується емоційне вигорання як стійкий психоемоційний стан.

Узагальнення сучасних теоретичних підходів дозволило розглядати емоційне вигорання як складний і багатовимірний феномен, що поєднує емоційне виснаження, емоційну відстороненість та зниження відчуття власної ефективності. Аналіз концепцій зарубіжних і вітчизняних дослідників засвідчив, що вирішальним чинником у розвитку вигорання є тривалий дисбаланс між вимогами діяльності та можливостями особистості відновлювати власні ресурси.

Узагальнені результати емпіричного дослідження підтвердили, що проблема емоційного вигорання є поширеною серед волонтерів. Виявлені прояви емоційного виснаження, зниження мотивації та формування емоційної дистанції свідчать про системний характер цього явища. Особливо вразливими виявляються волонтери, діяльність яких пов'язана з тривалим перебуванням у стресових або травматичних умовах, де емоційне навантаження поєднується з високою відповідальністю та обмеженими можливостями для відновлення. Інтерпретація результатів з позицій теорії збереження ресурсів дозволяє зробити висновок, що емоційне вигорання волонтерів формується як наслідок поступової втрати психологічних ресурсів за відсутності достатньої підтримки та відновлення. Важливу роль у цьому процесі відіграє вторинна травматизація, яка виникає внаслідок постійного контакту з чужим болем і переживаннями та посилює емоційне виснаження. Практичне значення отриманих результатів полягає у підкресленні необхідності системної психологічної підтримки волонтерів. Важливими напрямками такої підтримки є психоосвіта, розвиток навичок саморегуляції, створення умов для емоційного відновлення та впровадження психологічного супроводу у волонтерській діяльності. Це сприятиме збереженню ментального здоров'я волонтерів і підвищенню стійкості їхньої допоміжної діяльності. Перспективи подальших досліджень пов'язані з поглибленим емпіричним аналізом психологічних механізмів тривалого стресу у волонтерській діяльності та з оцінкою ефективності програм психологічної підтримки,

спрямованих на збереження життєстійкості та психологічного благополуччя волонтерів.

Список використаних джерел.

1. Боднар А. Я. Психологія стресу: теорія та практика : навчальний посібник. Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2021. 256 с.
2. Кокун О. М. Професійне вигорання: теорія, діагностика, профілактика : монографія. Київ : Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, 2019. 304 с.
3. Максименко С. Д. Психологія особистості : підручник. Київ : Кондор, 2020. 520 с.
4. Maslach C., Leiter M. P. Burnout and engagement in the workplace: A contextual analysis. In: Advances in Motivation Science. Vol. 1. San Diego : Elsevier, 2016. P. 275–302.
5. Maslach C., Jackson S. E., Leiter M. P. Maslach Burnout Inventory Manual. 4th ed. Palo Alto, CA : Mind Garden, 2018. 44 p.
6. Hobfoll S. E. Conservation of resources theory: Its implication for stress, health, and resilience. In: The Oxford Handbook of Stress and Mental Health. Oxford : Oxford University Press, 2018. P. 127–147.
7. Thoits P. A. Stress and health: Major findings and policy implications. Journal of Health and Social Behavior. 2010. Vol. 51 (Suppl.). P. S41–S53.
8. Figley C. R. Compassion fatigue: Coping with secondary traumatic stress disorder in those who treat the traumatized. New York : Routledge, 2015. 268 p.
9. Southwick S. M., Bonanno G. A., Masten A. S., Panter-Brick C., Yehuda R. Resilience definitions, theory, and challenges: Interdisciplinary perspectives. European Journal of Psychotraumatology. 2014. Vol. 5. P. 25338.

Психологічні механізми подолання стресу

Житинська М.О.

*кандидат педагогічних наук, доцент
Академія праці, соціальних відносин і туризму м. Київ*

Кириленко Р.В.

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти

Актуальність. Сучасний етап розвитку українського суспільства характеризується безпрецедентним рівнем психоемоційного напруження, зумовленим тривалим перебуванням країни в умовах повномасштабної війни. Військові дії, масові втрати та втрати близьких, розлука, вимушене переміщення населення, тривала невизначеність, втрата домівок, постійні повітряні тривоги, руйнування інфраструктури, загроза життю та безпеці близьких стали постійними стресогенними чинниками для мільйонів людей.

Саме в таких умовах стрес перестає бути ситуативним явищем і набуває хронічного, накопичувального характеру, що безпосередньо впливає на психічне здоров'я спеціалістів та якість наданої ними допомоги.

Актуальність обраної теми зумовлена тим, що у фокусі сучасних досліджень дедалі частіше перебуває не лише стан людей, які переживають втрату, а й психологічний стан фахівців, які з ними працюють. Доведено, що систематичний контакт із переживаннями горя, болю та безпорадності створює підвищений ризик розвитку хронічного стресу, співпереживального виснаження, вторинної травматизації та професійного вигорання. У разі відсутності ефективних механізмів подолання стресу це призводить не лише до погіршення самопочуття спеціалістів, а й до зниження професійної ефективності, емоційного відсторонення та скорочення тривалості професійного функціонування. Особливу наукову та практичну цінність мають методи, спрямовані не лише на зниження симптомів стресу, а й на активацію внутрішніх ресурсів особистості, відновлення

відчуття контролю, смислу та суб'єктності. Одним із таких сучасних напрямів є використання арт-терапевтичних підходів, які, за даними досліджень, сприяють зниженню рівня психоемоційного напруження, покращенню саморегуляції та формуванню адаптивних стратегій подолання стресу.

Мета дослідження. Дослідити психологічні механізми подолання стресу у фахівців, які працюють з жінками, що проживають втрату, в умовах арттерапевтичного простору Центру Життєстійкості.

Результати дослідження. Проблема стресу посідає одне з центральних місць у сучасній психологічній науці, оскільки пов'язана з вивченням адаптаційних можливостей людини, механізмів реагування на складні життєві обставини та збереження психічного здоров'я в умовах підвищених вимог середовища.

Незважаючи на широку представленість поняття стресу в наукових дослідженнях, його зміст і трактування зазнавали суттєвих змін залежно від розвитку теоретичних підходів та міждисциплінарних впливів. Згідно з сучасними дослідженнями, психологічний зміст утворення стресу включає поєднання когнітивних, емоційних та поведінкових компонентів, які взаємодіють між собою в динамічному процесі [1].

Когнітивний компонент пов'язаний із сприйняттям, інтерпретацією та оцінкою ситуації; емоційний – з переживанням напруги, тривоги, страху або безпорадності; поведінковий – з вибором стратегій реагування та копіngu. Саме порушення балансу між вимогами ситуації та доступними психологічними ресурсами зумовлює формування стресового стану.

Важливою особливістю утворення стресу є його накопичувальний характер. Наукові дані свідчать, що стрес може формуватися не лише внаслідок інтенсивних одиничних подій, а й під впливом тривалих або повторюваних стресорів, які поступово виснажують психічні ресурси особистості [2]. У таких умовах навіть незначні додаткові навантаження можуть спричиняти виражені стресові реакції,

що свідчить про зниження адаптаційних можливостей. Особливу роль у формуванні стресу відіграє емоційне залучення особистості в ситуацію. Дослідження показують, що ситуації, пов'язані з міжособистісними стосунками, втратами, відповідальністю за інших людей та моральними дилемами, мають підвищений стресогенний потенціал [7].

Це положення є особливо важливим для розуміння механізмів утворення стресу у фахівців допомагаючих професій, діяльність яких передбачає постійний контакт із переживаннями горя, болю та втрати інших людей. Сучасні психологічні підходи також підкреслюють роль хронічного стресу, який формується в умовах тривалої невизначеності, постійної напруги та відсутності можливості повноцінного відновлення [3]. У таких випадках стрес перестає виконувати адаптаційну функцію і набуває дезадаптивного характеру, що проявляється у вигляді емоційного виснаження, зниження мотивації та порушень психоемоційної рівноваги. Таке трактування підкреслює універсальність стресу та його значення для адаптації людини до змінних умов середовища. Враховуючи наукові підходи, можна зазначити, що в сучасній психології стрес розглядається як складний психофізіологічний і психологічний процес, який виникає у відповідь на вимоги зовнішнього або внутрішнього середовища та визначається суб'єктивною оцінкою цих вимог як значущих або загрозливих.

Важливою характеристикою стресу є його залежність від індивідуальних ресурсів особистості, що зумовлює варіативність стресових реакцій і потребу в дослідженні психологічних механізмів подолання стресу. Розглядаючи основні науково обґрунтовані механізми подолання стресу, можемо зазначити, що в сучасній психології вони розглядаються як багаторівнева система взаємопов'язаних когнітивних, емоційних, поведінкових, соціальних і фізіологічних процесів, які забезпечують регуляцію стресової відповіді та підтримання адаптації в умовах підвищеного навантаження. Враховуючи підходи, які охоплюють індивідуальний, груповий та організаційний рівні втручання, що

відповідає сучасному багаторівневому розумінню стресу як біопсихосоціального феномена, можемо провести аналіз наукових джерел, які свідчить, що жоден із наведених підходів не розглядається як універсальний або ізольований.

Найбільш стійкий позитивний ефект досягається за умови інтеграції психотерапевтичних, психосоціальних і тілесно-орієнтованих методів у межах комплексних програм. Особливе значення мають організаційні чинники та психосоціальний контекст, які здатні як посилювати, так і пом'якшувати індивідуальні стресові реакції (табл. 1).

Таблиця 1

**Доказові напрями подолання сучасних форм стресу
(за даними систематичних оглядів і мета-аналізів 2019–2025 рр.)**

№	Напрямок / механізм подолання стресу	Доказово підтверджений вплив	Рівень застосування	Наукове обґрунтування (узагальнено)
1	Когнітивно-поведінкові інтервенції (CBT)	Асоціюються зі зниженням симптомів тривоги й депресії, підвищенням психологічної резильєнтності та адаптаційних навичок у різних групах населення	Індивідуальний, груповий	Систематичні огляди та мета-аналізи підтверджують ефективність СВТ-орієнтованих програм у широкому спектрі стресових станів
2	Майндфулнес-орієнтовані інтервенції (MBI)	Статистично значуще зниження симптомів стресу, емоційного вигорання та тривоги; покращення емоційної регуляції	Індивідуальний, груповий	Мета-аналізи демонструють особливу ефективність у працівників охорони здоров'я та допомагаючих професій
3	Інтервенції з профілактики secondary traumatic stress / compassion fatigue	Зменшення рівня співпереживального виснаження, вторинної травматизації та професійного вигорання	Індивідуальний, груповий, організаційний	Систематичні огляди (2024–2025) підтверджують ефективність поєднання емоційної регуляції, супервізії, груп підтримки та організаційних змін

№	Напрямок / механізм подолання стресу	Доказово підтверджений вплив	Рівень застосування	Наукове обґрунтування (узагальнено)
4	Арт-терапевтичні та творчі підходи	Зниження тривожності, симптомів ПТСР, покращення емоційної регуляції та суб'єктивного відновлення ресурсів	Індивідуальний, груповий	Мета-аналізи розглядають арт-терапію як допоміжний і ресурсний компонент комплексних програм подолання стресу
5	Комплексні програми на робочому місці	Зниження рівня робочого стресу та ризику професійного вигорання; покращення психосоціального клімату	Організаційний	Рекомендації ВООЗ (2022) підкреслюють ключову роль оцінки психосоціальних ризиків, супервізії та підтримки персоналу
6	Фізичні та тілесні підходи	Асоціація з регуляцією НРА-осі, зниженням алостатичного навантаження та покращенням загального самопочуття	Індивідуальний	Оглядові дослідження підтверджують ефективність фізичної активності, сну та тілесної регуляції як доповнення до психотерапії

У розвитку практичної психології тривалий час домінував підхід, орієнтований переважно на зниження фізіологічного напруження та корекцію поведінкових реакцій у відповідь на стресові впливи. Така орієнтація була зумовлена впливом ранніх фізіологічних і поведінкових моделей стресу, в межах яких адаптація розглядалася насамперед як відновлення функціональної рівноваги організму. Для фахівців, професійна діяльність яких пов'язана з роботою з втратою та травматичним досвідом, особливого значення набувають регулярні профілактичні програми. До них належать супервізія, підтримуючі групи, тренінги емоційної регуляції та створення ресурсних просторів, зокрема арттерапевтичних сесій, що інтегруються в рутинну професійну практику. Такі

заходи сприяють зниженню ризику хронічного стресу, вторинної травматизації та професійного вигорання. Водночас сучасні дослідження підкреслюють, що індивідуальні стратегії профілактики стресу (майндфулнес-практики, фізична активність, навички когнітивної та емоційної регуляції) мають бути підтримані змінами на рівні організації праці. За відсутності таких змін зростає ризик непрямого «перекладання» відповідальності за подолання стресу виключно на працівника, що знижує ефективність індивідуальних втручань і обмежує їх довготривалий профілактичний ефект.

Переживання втрати жінками як психологічний контекст формування стресових навантажень. Переживання втрати близької людини є одним із найінтенсивніших психотравмувальних досвідів, що суттєво впливає на психоемоційний стан особистості та активує комплексні стресові реакції. У психологічній науці втрата розглядається як подія високої стресогенності, яка порушує емоційну рівновагу, систему життєвих смислів і базове відчуття безпеки, вимагаючи від людини значних адаптаційних ресурсів [9].

В умовах повномасштабної війни в Україні переживання втрати відбувається на тлі тривалого загальносоціального стресу, що значно ускладнює процес психологічної адаптації та підвищує ризик хронізації стресових станів. Це стало подією безпрецедентного масштабу для українського суспільства та спричинило глибокі гуманітарні, соціальні й психологічні наслідки.

У сучасній психологічній науці переживання втрати розглядається як складний, динамічний процес адаптації, що охоплює емоційні, когнітивні, поведінкові та соціальні компоненти. Класичні стадійні моделі горювання, які історично описували послідовні фази реагування на втрату, у сучасних дослідженнях поступилися процесуальним і траєкторним підходам, що підкреслюють індивідуальну варіативність переживання горя. Важливе місце в сучасних підходах посідає когнітивний вимір переживання втрати. Наукові дані свідчать, що інтерпретація втрати, румінативні процеси та порушення сенсової

інтеграції події мають вирішальне значення для формування тривалих стресових станів. Дослідження останніх років показують, що труднощі в осмисленні втрати, збереження відчуття несправедливості або втрати контролю асоціюються з підвищеним рівнем тривоги, депресивної симптоматики та загального психологічного дистрес. Натомість когнітивна гнучкість і поступове переосмислення досвіду втрати розглядаються як чинники, що сприяють адаптації.

Переживання втрати близької людини є одним із найпотужніших стресогенних чинників у житті людини, оскільки воно одночасно порушує емоційну рівновагу, систему життєвих смислів і відчуття базової безпеки. У психологічній науці втрата розглядається як подія високої стресової інтенсивності, що потребує значних адаптаційних ресурсів і супроводжується тривалими психоемоційними навантаженнями [2]. В умовах повномасштабної війни в Україні ці навантаження набувають особливої глибини та комплексності, оскільки поєднуються з тривалою невизначеністю, загрозою повторних втрат і хронічним стресовим фоном.

1. Характер стресових навантажень при переживанні втрати. Сучасні дослідження засвідчують, що втрата близької людини активує багаторівневу стресову реакцію, яка включає емоційні, когнітивні, фізіологічні та поведінкові компоненти. На емоційному рівні домінують інтенсивні переживання суму, болю, тривоги, провини та безпорадності. Когнітивний рівень характеризується румінаціями, нав'язливими думками про обставини втрати та порушенням базових уявлень про справедливість і передбачуваність світу [2].

В українському контексті особливу групу становлять матері, дружини та сестри військовослужбовців, які загинули, зникли безвісти або перебувають у полоні. Дослідження, проведені в Україні після 2022 року, вказують, що переживання втрати або невизначеної втрати (*ambiguous loss*) супроводжується поєднанням гострого горя та хронічного стресу очікування [8]. Невизначеність

статусу близької людини суттєво ускладнює процес адаптації, оскільки позбавляє можливості завершення горювання та підтримує постійну психоемоційну напругу. Для матерів і дружин військовослужбовців характерними є підвищений рівень тривоги, соматизація стресу, емоційне виснаження та труднощі у відновленні життєвих перспектив.

Стресові навантаження, пов'язані з втратою, в Україні посилюються соціальним контекстом війни: вимушеним переміщенням, економічною нестабільністю, обмеженим доступом до ресурсів підтримки та постійною інформаційною експозицією до травматичного контенту. За даними ВООЗ та українських досліджень, саме поєднання індивідуальної втрати з колективною травмою значно підвищує ризик хронізації стресових станів. Можемо зазначити, що переживання втрати в сучасній Україні формує специфічний тип стресового навантаження, який має затяжний характер і потребує комплексного психологічного підходу. Усвідомлення цих особливостей є необхідною передумовою для подальшого аналізу механізмів психологічної допомоги та обґрунтування використання методів, спрямованих на емоційну регуляцію й відновлення, зокрема арттерапевтичних підходів.

Сучасні наукові підходи розглядають горювання не лише як емоційну реакцію на втрату, а як тривалий адаптаційний процес, у межах якого активуються психологічні, фізіологічні та соціальні механізми реагування на стрес [1, 2]. На початкових етапах після втрати стресова реакція має переважно гострий характер і проявляється у вигляді інтенсивних емоційних переживань, підвищеної тривожності, порушень сну, концентрації та соматичних симптомів. Такі реакції вважаються нормативними та відповідають мобілізаційній функції стресу, спрямованій на адаптацію до різкої життєвої зміни [3]. Однак за певних умов цей процес може втрачати адаптивний характер і переходити у хронічне стресове навантаження.

Систематичні огляди останніх років засвідчують, що ключовим чинником такої трансформації є тривале збереження високої психофізіологічної напруги, коли ресурси відновлення не компенсують інтенсивність переживань. Хронізація стресу у процесі горювання пов'язується з поєднанням кількох механізмів: повторюваної когнітивної фіксації на втраті, порушень емоційної регуляції, зниження соціальної підтримки та накопичення вторинних стресорів (економічних, рольових, екзистенційних).

Важливу роль у цьому процесі відіграють когнітивні механізми. Дослідження показують, що стійкі румінативні процеси, труднощі інтеграції втрати у життєву історію та збереження відчуття незворотної загрози або несправедливості корелюють із підвищеним рівнем загального дистресу та симптомів тривоги й депресії. За таких умов горювання перестає бути процесом поступового зменшення напруги і трансформується у постійне джерело стресового навантаження.

Паралельно з психологічними змінами фіксуються фізіологічні наслідки тривалого горювання. Сучасні дослідження підтверджують, що в осіб, які переживають втрату з високим рівнем дистресу, спостерігаються ознаки дисрегуляції стресових систем, зокрема гіпоталамо-гіпофізарно-наднирникової осі, а також підвищені маркери запальних процесів. Такі зміни розглядаються як біологічне підґрунтя хронічного стресу та пояснюють підвищений ризик соматичних і психосоматичних порушень у період тривалого горювання.

Після того як переживання втрати трансформується з гострої емоційної реакції у тривале стресове навантаження, визначальним стає питання не лише наявності підтримки, а якості психологічних механізмів, які забезпечують адаптацію. Сучасні дослідження свідчать, що подолання втрати не є пасивним «згасанням» емоцій, а складним процесом активної психічної перебудови, у межах якої ключову роль відіграють регуляторні, когнітивні, нейрофізіологічні та смислові механізми.

Трансформація переживання втрати у хронічне стресове навантаження

Рівень процесу	Основні прояви	Науково підтверджені наслідки
Гостре горювання	Інтенсивні емоції, тривога, соматичні реакції	Нормативна стресова реакція, мобілізація ресурсів
Когнітивна фіксація на втраті	Румінація, порушення сенсової інтеграції	Підвищення дистресу, ризик хронізації
Порушення емоційної регуляції	Тривале напруження, емоційне виснаження	Зростання тривоги, депресивних симптомів
Фізіологічна дисрегуляція	Активация стресових систем, запальні маркери	Хронічний стрес, соматичні ризики
Соціальне ускладнення	Зниження підтримки, рольові перевантаження	Погіршення адаптації, зниження резильєнтності

Ключові психологічні механізми, які забезпечують адаптацію до втрати та запобігають формуванню хронічного стресового навантаження зображені на рис. 1. Кожен механізм відображає окремий рівень психологічного функціонування та підтверджений сучасними науковими дослідженнями.

Арттерапія та емоційна регуляція у фахівців, які працюють із втратою – психологічне обґрунтування.

Розглянуті вище багатовимірні стресові навантаження, що виникають у процесі переживання втрати, мають значення не лише для осіб, які безпосередньо зазнали втрати, а й для фахівців, що надають їм психологічну допомогу. У сучасних дослідженнях підкреслюється, що тривалий контакт із чужим горем, травматичними наративами та інтенсивними емоційними переживаннями клієнтів формує у фахівців специфічний тип професійного стресу, який може супроводжуватися емоційним виснаженням, вторинною травматизацією та порушенням власних механізмів емоційної регуляції [9].

Специфіка стресових переживань фахівців та ресурси їх подолання в арттерапевтичному просторі. На відміну від загальнопопуляційного стресу,

стресові переживання фахівців допомагаючих професій мають якісно іншу природу, зумовлену постійним емпатичним контактом із травматичним досвідом клієнтів. Дослідження останніх років засвідчують, що тривала робота з темами смерті, втрати та горювання асоціюється з підвищеним ризиком розвитку вторинної травматизації, співпереживального виснаження (compassion fatigue) та професійного вигорання [11].



Рис. 1. Узагальнена схема механізмів, що допомагають справлятися з втратою

Ці стани не є прямим наслідком інтенсивності робочого навантаження, а формуються як результат кумулятивного впливу емоційної залученості, відповідальності за психологічний стан клієнтів і обмежених можливостей для повноцінного відновлення.

Проведений теоретичний аналіз феномену стресу та психологічних особливостей переживання втрати дозволяє розглядати стрес не лише як універсальну реакцію на екстремальні події, а як складний багаторівневий процес,

що формується у взаємодії індивідуальних, соціальних і професійних чинників. Особливої уваги в цьому контексті потребує професійна діяльність фахівців, які систематично працюють з людьми, що переживають втрату, оскільки їхній психоемоційний стан формується під впливом специфічних умов такої роботи.

Разом із тим, сучасні дослідження підкреслюють, що подолання професійного стресу не зводиться до індивідуальних копінг-стратегій або епізодичних форм підтримки. Ефективними виявляються **ресурсні середовища**, у межах яких поєднуються емоційна регуляція, смислова інтеграція досвіду та тілесна стабілізація. У цьому контексті особливий інтерес становить арттерапевтичний простір, який розглядається не лише як метод роботи з клієнтами, а як середовище психологічного відновлення самих фахівців.

Наукові огляди засвідчують, що арттерапевтичні та експресивні практики сприяють зниженню емоційної напруги, покращенню емоційної регуляції та відновленню відчуття контролю в осіб, які зазнають тривалого стресового навантаження [5; 6]. Важливо, що ці ефекти реалізуються через невербальні канали, сенсорну регуляцію та символічну репрезентацію досвіду, що є особливо значущим у роботі з травматичним і втратним матеріалом.

У межах сучасних підходів до подолання хронічного професійного стресу дедалі більшої уваги набуває не лише зміст психологічних інтервенцій, а й умови, в яких відбувається відновлення фахівця. Дослідження свідчать, що середовище, у якому здійснюється професійна діяльність і супровід, може виконувати самостійну регуляторну функцію, знижуючи рівень емоційного та психофізіологічного напруження [11]. У цьому контексті особливого значення набуває арттерапевтичний простір Центр життєстійкості, який функціонує як спеціально організоване ресурсне середовище для фахівців, що працюють із втратою.

Арттерапевтичний простір Центру Життєстійкості доцільно розглядати не як сукупність окремих технік чи вправ, а як цілісну систему умов, що забезпечує

можливість емоційної регуляції, сенсорної стабілізації та смислової інтеграції професійного досвіду. На відміну від традиційних форм психологічної підтримки, які орієнтовані переважно на вербальну рефлексію, арттерапевтичний простір активізує невербальні канали переживання, що є особливо важливим у роботі з втратами та травматичним матеріалом.

Таблиця 3

**Ресурси подолання стресу у фахівців допомагаючих професій: від
індивідуальних зусиль до ресурсного середовища**

Рівень ресурсів	Зміст ресурсів	Психологічна функція	Значення для фахівців, що працюють з втратою
Індивідуальні ресурси	Емоційна регуляція, когнітивна переоцінка, усвідомлення власних емоцій, копінг-стратегії, тілесна саморегуляція	Зниження емоційної реактивності, стабілізація афективного стану, профілактика румінацій і виснаження	Дозволяють фахівцеві зберігати внутрішню рівновагу в умовах постійного контакту з болем, горем і травматичними історіями клієнтів
Міжособистісні ресурси	Професійна супервізія, інтервізія, групи підтримки, колегіальне обговорення складних випадків	Нормалізація професійних переживань, зниження ізоляції, корекція надмірної відповідальності	Зменшують ризик вторинної травматизації та співпереживального виснаження, підтримують професійну ідентичність
Організаційні ресурси	Робочі умови, навантаження, політики турботи про персонал, доступ до психологічної допомоги, регламент супервізій	Структурна підтримка, зниження хронічного стресу, підвищення відчуття безпеки й передбачуваності	Запобігають накопиченню стресу, пов'язаного з перевантаженням і розмитими професійними межами
Середовищні (просторові) ресурси	Арттерапевтичний простір, безпечне фізичне середовище, символічно насичений простір, умови для невербального вираження	Сенсорна стабілізація, відновлення емоційної регуляції, інтеграція переживань	Створюють умови для відновлення фахівця не лише на рівні усвідомлення, а й на тілесно-емоційному рівні

Наукові огляди підтверджують, що експресивні та арт-орієнтовані середовища сприяють зниженню рівня симпатичної активації, покращенню емоційної регуляції та відновленню відчуття контролю у осіб, які перебувають під тривалим стресовим навантаженням. Для фахівців допомагаючих професій це означає можливість безпечного контакту з власними переживаннями, без необхідності їх раціоналізації чи негайного «професійного опрацювання». Важливою характеристикою арттерапевтичного простору Центру Життестійкості є його середовища підтримка меж між професійною роллю та особистим досвідом фахівця. Перебування у структурованому, емоційно безпечному просторі дозволяє тимчасово вийти з позиції постійної емпатичної залученості та відновити внутрішній баланс, що, за даними досліджень, є критично важливим чинником профілактики вторинної травматизації та співпереживального виснаження. Окрім цього, арттерапевтичний простір Центру Життестійкості інтегрує індивідуальні та міжособистісні ресурси подолання стресу. Груповий формат занять створює умови для нормалізації професійних переживань, зниження відчуття ізоляції та формування досвіду колективної підтримки, тоді як індивідуальна творча діяльність сприяє відновленню контакту з власними внутрішніми ресурсами. Таким чином, простір виконує функцію **медіатора** між особистісними процесами фахівця та організаційним контекстом його професійної діяльності. Отже, арттерапевтичний простір Центру Життестійкості можна розглядати як ресурсне середовище багаторівневої дії, що створює умови для зниження кумулятивного стресового навантаження, відновлення емоційної регуляції та підтримки професійної життєздатності фахівців, які працюють з втратою. Саме ця інтегративна функція простору обґрунтовує доцільність його використання як контексту для емпіричного дослідження психологічних механізмів подолання стресу у фахівців допомагаючих професій. У ході аналізу встановлено, що стрес фахівців, залучених до роботи з втратою, має якісно відмінний характер порівняно із загальним професійним стресом. Йдеться не про реакцію на окремі робочі

труднощі, а про накопичувальний, хронічний процес, що формується внаслідок тривалого емпатичного контакту з горем, болем і травматичним досвідом клієнтів. Показано, що ключовими проявами такого стресу є вторинна травматизація, співпереживальне виснаження (compassion fatigue) та емоційне вигорання, які не існують ізольовано, а взаємно підсилюють одне одного. Їх формування зумовлене поєднанням емоційної інфекції, професійних румінацій («чи достатньо я допоміг?»), поступового розмивання меж між професійною роллю та особистим переживанням, а також тілесних проявів напруги й хронічної втоми. Теоретичний аналіз також засвідчив, що подолання такого стресу не може бути зведене виключно до індивідуальних зусиль фахівця. Ефективна профілактика й відновлення можливі лише за умови багаторівневої системи ресурсів, яка включає індивідуальні механізми емоційної регуляції, міжособистісну підтримку (супервізію, групи підтримки), організаційні умови та спеціально створене середовище. У цьому контексті обґрунтовано показано, що арттерапевтичний простір доцільно розглядати не лише як окрему методику психологічної допомоги, а як ресурсне середовище, здатне підтримувати фахівця на кількох рівнях одночасно. Арттерапевтичний простір забезпечує безпечну рамку, створює можливості для невербального вираження складного досвіду, знижує когнітивне перевантаження та сприяє відновленню почуття контролю й суб'єктності. Результати теоретичного аналізу підтверджують, що арттерапевтичний простір є науково обґрунтованим ресурсом подолання стресу у фахівців, які працюють із втратою, і може розглядатися як важливий компонент системи професійної підтримки в умовах тривалої соціальної та психологічної напруги. Саме це зумовлює доцільність подальшого емпіричного дослідження психологічних механізмів подолання стресу у фахівців в умовах арттерапевтичного простору Центру Життестійкості.

Список використаних джерел.

1. Сельє Г. Стрес життя. – Нью-Йорк : McGraw-Hill, 1956. – 516 с.

2. Лазарус Р. С., Фолкман С. Стрес, оцінка та подолання. – Нью-Йорк : Springer Publishing Company, 1984. – 445 с.
3. Фолкман С. Стрес: процеси оцінки та подолання // Журнал здоров'я та соціальної поведінки. – 2011. – Т. 52, № 4. – С. 478–485.
4. Всесвітня організація охорони здоров'я. Настанови ВООЗ щодо психічного здоров'я на робочому місці. – Женева : Всесвітня організація охорони здоров'я, 2022. – 188 с.
5. Бонанно Дж. А. Втрата, травма та людська резильєнтність // Американський психолог. – 2004. – Т. 59, № 1. – С. 20–28.
6. Мбїйдзенюю Н. Е. та ін. Стрес, гіпоталамо-гіпофізарно-наднирникова вісь і поведінка // Фронтири психіатрії. – 2024. – Т. 15. – DOI: додається у фінальній версії роботи.
7. Ейсма М. К. та ін. Поширеність тривалого розладу горювання та проблемного горя: систематичний огляд і мета-аналіз // Європейський журнал психотравматології. – 2025. – Т. 16, № 1.
8. Янн П. та ін. Травматична втрата: систематичний огляд потенційних факторів ризику, що диференціюють ПТСР і тривалий розлад горювання // BMC Psychiatry. – 2024. – Т. 24.
9. Парк С. та ін. Самотність після втрати: роль статі особи, що пережила втрату (лонгітюдний аналіз) // Міжнародний журнал геріатричної психіатрії. – 2025. – Т. 40.
10. Фіглі К. Р. Співпереживальне виснаження: хронічна відсутність самодогляду у психотерапевтів // Журнал клінічної психології. – 2002. – Т. 58, № 11. – С. 1433–1441.
11. Генсел Дж. М., Руїс К., Фінні К., Д'юа К. С. Мета-аналіз факторів ризику вторинного травматичного стресу в терапевтичній роботі // Журнал травматичного стресу. – 2015. – Т. 28, № 2. – С. 83–91.

Теоретичні концепції психоаналізу у вивченні психологічних факторів розладу харчової поведінки

Зінченко І.А.

*Здобувач другого(магістерського) рівня вищої освіти
Академія праці, соціальних відносин і туризму, м. Київ*

Актуальність. Розлади харчової поведінки – складна та багатопланова проблема клінічної психології та психіатрії. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, їхня поширеність неухильно зростає, особливо серед підлітків та молоді. Актуальність розгляду розладів харчової поведінки (РХП) крізь призму психоаналізу обумовлена як зростанням їх поширеності, так й обмеженістю домінуючих нині ефективних терапевтичних моделей. Значний розвиток психіатричних, психологічних та нейробіологічних досліджень даного розладу дозволив сформувати різні програми терапії. Однак навіть найзатребуваніші сучасні терапевтичні підходи, насамперед когнітивно-поведінкова терапія та фармакотерапія, зосереджені переважно на редукції симптомів та корекції поведінкових порушень. Такий підхід часто призводить до повернення цього розладу або до появи інших симптомів. Це відбувається у зв'язку з тим, що він не враховує глибинні психологічні механізми, символічні значення їжі та образу тіла, а також внутрішньопсихічні конфлікти, що зумовлюють цю патологію. У зв'язку з цим зростає потреба в теоретичних моделях, здатних вийти за межі суто симптомоорієнтованого пояснення. Синтез класичних і сучасних психоаналітичних концепцій дозволить глибше осмислити психологічні чинники РХП і позначити перспективи комплексної психотерапії, орієнтованої не лише на усунення симптомів, а й на глибоке опрацювання несвідомих психічних процесів, що визначають ці розлади.

Мета дослідження. Проаналізувати погляди різних психоаналітичних шкіл на психогенну природу розладу харчової поведінки та визначити основні вектори психотерапевтичної роботи. *Матеріал та методи дослідження.* Для досягнення

поставленої мети проводився теоретичний аналіз зарубіжної та вітчизняної літератури із психоаналітичних досліджень розладу харчової поведінки.

Результати дослідження. *Класичні психоаналітичні концепції.* Психоаналітичне дослідження глибинних процесів розвитку психіки людини дозволило розглядати розлади харчової поведінки крізь призму теорії психосексуального розвитку та структурної моделі психіки [3]. Зигмунд Фройд, засновник психоаналізу, хоча і не присвячував окремі роботи розладам харчової поведінки, заклав фундаментальні основи для їх психоаналітичного розуміння. У його теорії психосексуального розвитку оральна стадія відіграє ключову роль у формуванні майбутніх патернів харчової поведінки.

Оральна стадія розвитку, що охоплює ранній постнатальний період життя дитини, є критично важливою для формування її первинних об'єктних відносин, механізмів афективної регуляції та способів отримання задоволення. Порушення на цьому етапі розвитку, як у формі дефіциту, так і у формі надмірного задоволення оральних потреб, можуть призводити до фіксації. Регресія до оральної стадії розвитку, на якій дитина була зафіксована внаслідок будь-якої фрустрації, в подальшому проявляється в патологічних харчових патернах: в переїданні, у відмові від їжі або адиктивній поведінці.

З точки зору структурної теорії класичного психоаналізу, розлади харчової поведінки інтерпретуються як компромісні утворення, що виникають в результаті конфлікту між інстанціями психічного апарату. У цьому конфлікті Его, намагаючись протистояти потягам Ід, вимогам Супер-Его і реальності, формує різні механізми захисту. При нервовій анорексії домінує гіперконтроль, що реалізується через заперечення тілесних потреб і афектів, витіснення та інтелектуалізація, тоді як при булімії частіше спостерігаються розщеплення, проективна ідентифікація та інші примітивні захисти.

Теорія об'єктних відносин. Значний внесок у розуміння психодинамічних механізмів РХП зробили представники школи об'єктних відносин (М. Кляйн, Д.

Віннікотт, М. Маллер та ін.), позначивши провідне значення ранніх відносин з первинним об'єктом для розвитку психіки. Ключову роль у цьому контексті відіграють концепції Мелані Кляйн. Її вчення про параноїдно-шизоїдну та депресивну позиції є потужним інструментарієм для розуміння природи РХП [7].

Параноїдно-шизоїдна позиція (перші місяці життя) характеризується тим, що дитина дуже інтенсивно переживає тривогу переслідування і знищення. Для захисту від цієї тривоги в психіці дитини задіюються механізми розщеплення і проекції, в результаті чого первинний об'єкт розщеплюється на «хороший» (груди, що годують) і «поганий» (груди, що фруструють), залежно від того, задовольняє він потреби дитини чи ні.

При розладі харчової поведінки спостерігається фіксація на цій позиції, внаслідок чого їжа і власне тіло набувають символічного значення розщепленого первинного об'єкта. При анорексії їжа проективно наділяється загрозливими якостями і як «поганий» об'єкт відкидається, тоді як при булімії відбувається чергування ідеалізації (переїдання) і знецінення (очищення). Власне тіло теж стає об'єктом проекції, сприймається як ненависне і чуже, яке треба контролювати і карати.

Здатність до інтеграції «хороших» і «поганих» аспектів первинного об'єкта в єдине характеризує перехід до більш зрілої депресивної позиції. У випадку з РХП цей процес порушений, відносини з їжею і власним тілом стають єдиним способом розігрування відносин з первинним об'єктом.

Ці уявлення отримали свій розвиток у концепціях Дональда Віннікотта про «досить хорошу матір», «холдинг» і «перехідний об'єкт». Холдинг – це прояв материнської турботи про дитину через фізичну та емоційну підтримку, дуже важливі для розвитку дитини в перші місяці її життя. При хорошому холдингу «досить хороша мама» контентує емоційні переживання дитини, допомагає їй їх ідентифікувати і переробити.

Перехідний простір – це простір між матір'ю і дитиною, за допомогою якого відбувається первинна сепарація дитини, і в якому дитина може переживати ілюзію контролю і відкривати зовнішню реальність. Якщо мати поглинаюча або недоступна – це заважає дитині знайти здорову автономію. У пацієнтів з РХП порушений перехідний простір, тому для зниження тривоги вторгнення і покинутості, в якості перехідних об'єктів, вони використовують їжу і тіло [9].

Маргарет Малер у своїй теорії описала складний шлях сепарації-індивідуації (включає фази диференціації, практики, зближення та консолідації) і зазначила, що порушення на будь-якому з цих етапів призводить до неможливості формування цілісного «Я» (і цілісного уявлення про об'єкт), проблемам із самооцінкою та емоційною нестабільністю.

Ця теорія дає ключ до розуміння складних відносин з об'єктом прихильності у людей з РХП. При анорексії спостерігається фіксація на фазі зближення, коли дитині не вдається відновити здорову близькість з матір'ю і зближення породжує страх поглинання. Тому людина з анорексією буде вибудовувати дистанцію через відмову від їжі. При булімії спостерігається невирішений конфлікт між потребою в злитті (переїдання) і потребою в сепарації (очищення) [8].

Ці теоретичні конструкти підтверджують роботи Хільди Брух. На основі своїх досліджень розладів харчової поведінки вона відзначала, що пацієнти з РХП мають дифузну ідентичність, порушення автономії та нездатність розпізнавати тілесні відчуття (голод, ситість) та емоції. Це пов'язано з тим, що дитина не отримувала адекватної реакції з боку матері на свої потреби [4].

Его-психологічний підхід. Представники Его-психології (А. Фрейд, Х. Хартман, Е. Якобсон та ін.) акцентують увагу на ролі функцій Его (психічної інстанції) у формуванні психопатології. У контексті аналізу розладів харчової поведінки цей підхід дозволяє інтерпретувати симптоматику як прямий наслідок порушень адаптивних і регуляторних функцій Его.

Варто зазначити, що для пацієнтів з РХП характерний дефіцит ключових Его-функцій, таких як адекватне тестування реальності (клінічно це проявляється в спотвореному сприйнятті власного тіла), регуляція афектів та імпульсів. Через порушення процесів автономії та інтеграції підтримується внутрішня нестабільність, що змушує особистість залежати від патологічних способів саморегуляції.

Окремої уваги в рамках Его-психологічної моделі заслуговує специфіка захисних механізмів при різних формах РХП. Так, при нервовій анорексії клінічна картина відрізняється домінуванням obsесивних захистів: інтелектуалізація, раціоналізація, ізоляція афекту, реактивне утворення, а також витіснення і заперечення. Ці захисти дозволяють впоратися з натиском деструктивних імпульсів і афектів через контроль, жорсткі правила і спотворені уявлення про турботу про себе. Навпаки, при булімії спостерігається переважання більш примітивних захистів: розщеплення, проєктивна ідентифікація і дисоціація. Саме ці механізми обумовлюють характерні для булімії коливання між ідеалізацією і знеціненням об'єктів, різкі емоційні перепади, втрату контролю в епізодах переїдання і очищення.

Лаканівський підхід до розладів харчової поведінки. Концепція психічного функціонування за Жаком Лаканом істотно відрізняється від класичного психоаналізу і відкриває нові можливості для осмислення розладів харчової поведінки. У центрі уваги знаходиться суб'єкт, що конституюється через мову, бажання Іншого і взаємодію трьох регістрів психічного досвіду – Реального, Символічного і Уявного.

Лаканівська топологія психіки дозволяє зрозуміти складні відносини пацієнтів з РХП до власного тіла. У регістрі Реального тіло постає як щось несимволізоване, травматичне, при анорексії воно стає локусом *jouissance* – специфічного задоволення, насолоди-в-стражданні, пов'язаної з потягом до смерті. У Символічному регістрі тіло структурується мовою і соціальними

дискурсами, що породжують суперечливі вимоги, які не піддаються інтеграції. В Уявному реєстрі спостерігається розрив між дзеркальним образом і внутрішнім тілесним досвідом, що проявляється в стійкому спотворенні образу тіла [1].

Ключовим поняттям у теорії Лакана є об'єкт *petit a* (об'єкт малого *a*) – об'єкт-причина бажання, який ніколи не може бути досягнутий повністю. Бажання принципово відрізняється від потреби: якщо потреба може бути задоволена конкретним об'єктом, зокрема їжею, то бажання завжди спрямоване на щось інше – на визнання і відповідь з боку Іншого. Саме в цій напрузі між потребою, вимогою і бажанням формуються умови виникнення симптомів РХП.

У випадку розладів харчової поведінки їжа перестає бути лише засобом задоволення біологічної потреби і набуває символічного значення у вимозі, адресованій Іншому, насамперед материнській фігурі.

При анорексії відмова від їжі є радикальним актом відновлення своєї суб'єктної позиції. Їжа переживається як знак контролю або поглинання з боку Іншого, а її відмова стає способом затвердити межу між «Я» і материнським бажанням. Виснажене тіло при цьому стає місцем локалізації *jouissance* – насолоди, що виникає через голод, контроль і наближення до межі.

При булімії клінічна картина вибудовується навколо циклу переїдання і очищення, що має ритуалізований характер. Переїдання є спробою інкорпорації Іншого, воно підтримує фантазію про заповнення внутрішньої порожнечі, тоді як очищення є актом вигнання об'єкта, який не зміг задовольнити бажане. *Jouissance* в даному випадку досягається інтенсивністю тілесних переживань і чергуванням втрати та відновлення контролю.

Окремої уваги для розуміння РХП заслуговує концепція Імені-Батька. Лакан пропонує термін Імені-Батька як символічної функції, що вводить Закон і забезпечує сепарацію від материнського бажання. Недостатність цієї функції ускладнює символічне відокремлення суб'єкта і сприяє формуванню симптомів, в яких їжа стає засобом регулювання відносин з Іншим: при анорексії – через

тотальну відмову («ні» материнському Іншому), тоді як при булімії – через коливання між поглинанням і вигнанням. Таким чином, симптом РХП для суб'єкта не є патологією, а стає способом затвердити свою суб'єктність.

Концепція несвідомого образу тіла. Вивчаючи психогенні причини розладів харчової поведінки, не можна не відзначити оригінальну психоаналітичну концепцію несвідомого образу тіла, запропоновану Франсуазою Дольто. На відміну від нейрофізіологічної схеми тіла і візуального образу, несвідомий образ тіла розглядається як динамічна, інтерсуб'єктивна структура, що формується в полі мови, бажання і ранніх об'єктних відносин. За Дольто, образ тіла є «втіленням суб'єкта бажання» в історії його лібідінальних зв'язків. Він являє собою живу пам'ять про значущі відносини з Іншим, закарбовану в тілесному досвіді. Образ тіла структурується через тілесні взаємодії, погляд і слово, за допомогою яких батьківські фігури звертаються до дитини.

У пацієнтів з розладами харчової поведінки спостерігаються глибокі порушення несвідомого образу тіла. Дольто описувала випадки, коли образ тіла виявлявся «кастрованим» або «фрагментованим» внаслідок раннього травматичного досвіду [5].

Ключовою в теорії Дольто є концепція символічних кастрацій – неминучих втрат і сепарацій, через які проходить дитина в процесі розвитку. Вона виділяла: пуповинну кастрацію – народження і сепарацію від материнського тіла; оральну кастрацію – відлучення від грудей; анальну кастрацію – прийняття правил чистоти; первинну генітальну кастрацію – усвідомлення статевої відмінності; едіпову кастрацію – відмову від інцестуозного об'єкта.

Кожна з цих кастрацій, за умови своєчасного та адекватного здійснення, дозволяє суб'єкту перейти на новий рівень суб'єктивації. Травматичні або несвоєчасні (передчасні або пізні) кастрації залишають «сліди» на образі тіла і створюють умови для подальших порушень. Незавершена оральна кастрація порушує процес символічної сепарації від материнського об'єкта, що згодом може

призвести до формування патологічних форм розігрування конфліктів за допомогою відносин з їжею.

Сучасні психоаналітичні підходи до розуміння РХП. Інший підхід до вивчення природи РХП виявляється в сучасних дослідженнях, що розглядають ці розлади, перш за все, як наслідок порушень афективної регуляції, що формуються в контексті ранніх відносин. Афективна регуляція – це здатність модулювати інтенсивність, тривалість і вираженість емоційних станів відповідно до ситуації. Вона формується завдяки досвіду адекватного емоційного відображення з боку значущого Іншого. У пацієнтів з РХП часто виявляється алекситимія – обмежена здатність ідентифікувати, диференціювати та вербалізувати власні емоційні переживання. Емоційні стани при цьому переживаються як неясний тілесний дискомфорт, позбавлений символічного уявлення. Відсутність емоційної диференціації призводить до сприйняття афекту як загрозливого і нестерпного, внаслідок чого харчова поведінка набуває регуляторної функції. Наприклад, відмова від їжі може призводити до емоційного «оніміння» і зниження внутрішньої напруги, переїдання – до короточасного полегшення, а очищення – до суб'єктивного відчуття звільнення від нестерпних станів. Всі ці дії замінюють собою психічну переробку афекту.

Вагомий внесок у ці дослідження зробив Пітер Фонагі та його колеги, запропонувавши теорію менталізації. Менталізація розглядається як здатність осмислювати власні та чужі психічні стани і формується в умовах надійних прив'язаностей, де внутрішній досвід дитини визнається і відображається Іншим [6]. При РХП цей процес суттєво порушений, що ускладнює символічну переробку афектів.

Різні клінічні форми РХП пов'язані зі специфічними порушеннями менталізації. При анорексії часто спостерігається псевдоменталізація – інтелектуалізовані роздуми про емоції без доступу до їхніх переживань. При булімії здатність до менталізації різко знижується в моменти афективного

перевантаження, що призводить до імпульсивних дій і втрати самоконтролю. У таких станах тіло і їжа стають основними засобами регулювання емоцій, які не можуть бути усвідомлені і символізовані.

Психоаналітична психотерапія розладів харчової поведінки. Специфіка терапевтичних відносин і феномен перенесення. Психоаналітична психотерапія розладів харчової поведінки вимагає особливої чутливості до структури терапевтичних відносин, оскільки саме в них актуалізуються ранні об'єктні патерни пацієнта. Особи з РХП схильні переносити на терапевта амбівалентні переживання, пов'язані зі страхом контролю і вторгнення, прагненням до злиття і одночасно – з інтенсивним опором залежності. Перенесення в даній клінічній групі відрізняється високою насиченістю, часто поляризованістю і вимагає ретельного опрацювання.

У випадках нервової анорексії нерідко домінує негативний перенос, при якому терапевт переживається як фігура, що загрожує автономії пацієнта, його тілесним і психічним кордонам. При булімії характерний ідеалізуючий перенос з подальшим різким знеціненням. Терапевтична робота повинна бути спрямована на інтеграцію суперечливих репрезентацій об'єкта і зниження рівня розщеплення.

Крім перенесення, важливим елементом терапії РХП є контрпереносні реакції терапевта. Контрперенесення – це почуття, емоції, фантазії і тілесні відчуття терапевта по відношенню до пацієнта і його перенесення, що виникають в процесі терапевтичної взаємодії. Аналіз контрперенесення є цінним діагностичним інструментом, що дозволяє терапевту глибше зрозуміти, які саме об'єктні відносини пацієнт несвідомо прагне відтворити і реактивувати в терапевтичних відносинах. Робота з пацієнтами з РХП супроводжується інтенсивними контрпереносними реакціями – страхом, почуттям безсилля, фрустрацією, бажанням рятувати або навпаки закінчити терапію.

Регулярна супервізія та особистий психоаналіз терапевта є абсолютно необхідними та незамінними умовами якісної та безпечної роботи з пацієнтами з

РХП. Це пов'язано з тим, що дані пацієнти нерідко викликають у терапевта інтенсивні регресивні реакції, які загострюють його власні невирішені внутрішні конфлікти і вразливості, особливо пов'язані з їжею, образом тіла, питаннями контролю, автономії і залежності у відносинах.

Інтерпретація та розуміння символічного значення симптомів. Психоаналітична робота з РХП відрізняється від інших напрямків психотерапії тим, що вона орієнтована не на усунення симптомів, а на розкриття їх несвідомого змісту. Харчова поведінка в терапії розглядається як мова, за допомогою якої пацієнт «говорить» про конфлікт (травму, дефіцит), що не піддається символізації.

Тому особливо важливим аспектом психотерапевтичної техніки при роботі з розладами харчової поведінки є інтерпретації, які вводяться обережно, дозовано і делікатно з урахуванням високої чутливості пацієнтів до вторгнення. На початкових етапах терапії пріоритет віддається підтримуючі інтервенції та інтерпретації поверхневих захистів. Перехід до глибинних інтерпретацій, спрямованих на аналіз перенесення і реконструкцію ранніх об'єктних відносин, стає можливим лише на більш пізніх етапах лікування – після зміцнення терапевтичного альянсу.

Лаканівська терапія РХП: напрямки роботи. У лаканівському підході мета терапії – створити простір, де пацієнт зможе артикулювати своє справжнє бажання. Це дозволяє перевести *jouissance* (насолада-страждання) в символічний реєстр слів. Завдяки цьому тілесне страждання поступово втрачає функцію єдиного носія надмірної насолоди, відкриваючи можливість його психічної переробки і трансформації.

Робота з образом тіла і тілесним Я є невід'ємною частиною психоаналітичної терапії РХП. Мова йде не про прямі тілесні техніки, а про дослідження того, яким чином суб'єкт відчуває, переживає, усвідомлює, символізує своє тіло. Центральним завданням є відновлення інтероцептивної

усвідомленості – здатності розпізнавати сигнали голоду, насичення, напруги і втоми та співвідносити їх з емоційними станами.

Дисморфофобні переживання розглядаються як наслідок проєктивних процесів: ненависть до тіла нерідко відображає агресію по відношенню до інтерналізованого об'єкта або до власного Я. Допмагаючи пацієнту усвідомити ці проєкції і повернути їх у сферу психічного, терапевт сприяє інтеграції та зниженню розщеплення між психікою і тілом.

Розвиток менталізації та афективної усвідомленості. Сучасна психоаналітична психотерапія РХП приділяє велику увагу розвитку менталізаційних здібностей. Терапевт допомагає пацієнту ідентифікувати емоції, усвідомлювати їх зв'язок з подіями і створювати простір між імпульсом і дією. Цей процес сприяє поступовій інтерналізації здатності до саморегуляції і зниженню потреби в симптоматичних формах регуляції афектів.

Висновки. Психоаналітичні теорії надають глибоке і багатовимірне розуміння розладів харчової поведінки; психоаналіз пропонує потужну концептуальну рамку для осмислення психогенної природи РХП. В рамках психоаналізу РХП постає не як ізольоване поведінкове порушення, а як складне психічне утворення, тісно пов'язані з процесами становлення особистості, формування ідентичності та способами вибудовування відносин з Іншим. Такий підхід дозволяє розглядати симптом РХП в контексті цілісної психічної організації суб'єкта. У психоаналітичній парадигмі симптоми розладу харчової поведінки завжди мають глибинне символічне значення. Вони постають як сцена, на якій розігруються фундаментальні психічні конфлікти – сепарації та індивідуації, автономії та залежності, формування ідентичності та меж Я. Центральне місце в етіології РХП займають ранні об'єктні відносини, перш за все взаємодія з первинною материнською фігурою. Надмірна інтрузивність, емоційна недоступність, непослідовність або амбівалентність у цих ранніх відносинах створюють умови для формування крихкого образу себе і власного тіла, дефіциту базової довіри і ненадійної прихильності. Надалі це

проявляється порушеннями менталізації та афективної регуляції, що істотно ускладнює здатність суб'єкта витримувати та осмислювати власні внутрішні стани.

РХП також характеризуються специфічними структурними дефіцитами Его і переважанням примітивних захисних механізмів. Такі особливості психічної організації унеможливлюють швидку симптоматичну корекцію і вимагають тривалої психоаналітичної роботи, спрямованої не на поверхнєве усунення симптомів, а на глибинні зміни в структурі особистості.

Особливий внесок у розуміння РХП робить лаканівська концептуалізація, що дозволяє розкрити унікальну суб'єктивну позицію пацієнта. У цьому підході симптом постає як несвідома відповідь суб'єкта на фундаментальні питання бажання, ідентичності та відносин з Іншим. Важливим теоретичним доповненням є концепція образу тіла Ф. Дольто, яка показує, що порушення при РХП не обмежуються когнітивними спотвореннями сприйняття, а мають глибоке коріння в несвідомій структурі тілесності. Порушення символічних кастрацій, наявність деформацій образу тіла – все це вказує на необхідність глибинної психоаналітичної роботи, спрямованої не на корекцію сприйняття, а на реконструкцію та інтеграцію образу тіла через терапевтичні відносини. Інтеграція різних психоаналітичних перспектив – від класичного фрейдизму через теорію об'єктних відносин до лаканівського структурного психоаналізу і теорії образу тіла – дозволяє створити багатовимірну модель РХП. Ця модель враховує як інтрапсихічні конфлікти, так і інтерсуб'єктивні аспекти; як несвідомі фантазії, так і структурні порушення Его; як символічні значення симптому, так і соматичні аспекти тілесного досвіду. Така інтегративна перспектива є найбільш продуктивною для клінічної роботи.

У цьому контексті психоаналітична психотерапія розладів харчової поведінки набуває особливої специфіки. Вона передбачає підвищену увагу до терапевтичних відносин, тонку роботу з перенесенням і контрперенесенням, а також розвиток

менталізації та інтеграцію тілесного і психічного досвіду. Психоаналітична терапія дозволяє вийти за межі суто симптоматичного підходу і побачити за проявами розладу живого суб'єкта з унікальною життєвою історією, складною внутрішньою динамікою і неповторним способом переживання власного тіла, бажань і відносин. Таке бачення дозволяє терапевту ставитися до симптому з повагою і обережністю, не прагнучи до його негайного усунення, а намагаючись зрозуміти його функцію в психічній економіці пацієнта. Саме таке уважне і етично мотивоване ставлення до суб'єктивності пацієнта формує основу справжньої терапевтичної допомоги.

Список використаних джерел.

1. Рус А. Лакан. Вступ до структурного психоаналізу / пер. з нім. К. Поліщук. Київ: Komubook, 2022. 224 с.
2. Фройд З. Нарис психоаналізу / пер. з нім. Є. Буцикін. Київ: VERBA Publishing, 2025. 208 с.
3. Фройд З. Психологія сексуальності / пер. з нім. Є. Тарнавський. Харків: Фоліо, 2025. 160 с.
4. Bruch H. The Golden Cage: The Enigma of Anorexia Nervosa. Harvard University Press; 2001. 174 p.
5. Dolto F. The unconscious body image / пер. з франц. S. Bailly. London : Routledge, 2023. 312 p.
6. Fonagy P., Target M. Attachment and reflective function: Their role in self-organization. Development and Psychopathology, 2002. 700 p.
7. Klein M. The psycho-analysis of children. London: Vintage, 1997. 393 p.
8. Mahler M., Pine F., Bergman A. The psychological birth of the human infant. New York: Basic Books; 1995.
9. Winnicott D. W. Playing and reality. London: Routledge, 2005. 196 p.

Розвиток інструментів психологічної діагностики стрес-індукованих станів у дорослих цивільних під час війни

Ларіонова Н.А.

Кандидат медичних наук

*Здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти
Академія праці, соціальних відносин і туризму, м. Київ*

Актуальність. Воєнні конфлікти є потужним чинником масового психологічного впливу, який формує специфічні умови для розвитку стрес-індукованих станів у цивільного населення. На відміну від локальних кризових подій, війна створює тривалий, хронічний стресовий контекст, у якому поєднуються загрози фізичній безпеці, втрати, вимушені міграційні процеси, соціально-економічна нестабільність, інформаційне перенавантаження та невизначеність майбутнього. За таких умов психологічні реакції цивільних осіб не обмежуються короткотривалою адаптацією, а часто набувають системного характеру, впливаючи на психічне здоров'я, поведінку, соматичне самопочуття та соціальне функціонування [5, с. 45–48].

У сучасних війнах, зокрема в умовах повномасштабної війни в Україні, психологічні наслідки торкаються широких верств цивільного населення незалежно від безпосередньої участі у бойових діях. Постійні повітряні тривоги, загроза обстрілів, порушення базових умов життя, тривога за близьких, економічні втрати та соціальна фрагментація формують умови для розвитку тривожних, депресивних, посттравматичних і психосоматичних проявів. У цьому контексті зростає потреба в ефективних, чутливих та етично безпечних інструментах психологічної діагностики, здатних виявляти стрес-індуковані стани на ранніх етапах [2, с. 112–118, 4, с. 1092–1096].

Разом із тим війна суттєво змінює вимоги до діагностичних підходів. Традиційні клінічні моделі, орієнтовані на індивідуальну психіатричну оцінку, виявляються недостатніми для роботи з масовими цивільними вибірками.

Актуалізується потреба у скринінгових методах, які можуть застосовуватися дистанційно, швидко, з мінімальним ризиком повторної травматизації та з урахуванням соціально-культурного контексту. Саме тому аналіз розвитку інструментів психологічної діагностики у воєнний час набуває особливої наукової та практичної значущості [6, с. 3–6].

Мета дослідження. Дослідити інструменти психологічної діагностики стрес-індукованих станів у дорослих цивільних під час війни.

Результати дослідження. *Історичний аспект розвитку психологічної діагностики стресу у воєнний час.* Перші систематичні спроби осмислення психологічних наслідків війни пов'язані з подіями Першої світової війни, коли було описано феномен так званого «бойового шоку». У цей період стресові реакції розглядалися переважно як фізіологічні або неврологічні порушення, а діагностика ґрунтувалася на клінічному спостереженні та описі симптомів. Цивільне населення майже не включалося в поле психологічного аналізу, оскільки домінувала уява про війну як про травматичний досвід насамперед для військових [1, с. 271–276, 5, с. 45–48].

Під час Другої світової війни відбувається поступовий зсув у розумінні психологічних наслідків воєнних подій. З'являються більш структуровані підходи до оцінювання емоційних і поведінкових порушень, розвиваються стандартизовані клінічні інтерв'ю та перші шкали симптомів. Водночас цивільні особи починають розглядатися як група підвищеного ризику, особливо в контексті бомбардувань, евакуації та втрат. Проте діагностика й надалі залишалася фрагментарною і залежною від клінічного контексту.

Суттєвий етап у розвитку діагностики пов'язаний із післявоєнним періодом та формуванням концепції посттравматичного стресового розладу. Включення ПТСР до діагностичних класифікацій сприяло стандартизації критеріїв та розвитку самозвітних шкал, що дозволяли кількісно оцінювати інтенсивність симптомів. Саме в цей період відбувається перехід від описових клінічних підходів до більш формалізованих інструментів психологічної діагностики [9, с. 489–498, 1, с. 271–276].

Наприкінці ХХ – на початку ХХІ століття зростає усвідомлення того, що психологічні наслідки війни для цивільного населення можуть бути не менш тривалими і складними, ніж для військових. Це зумовлює розвиток коротких скринінгових методик, придатних для застосування у великих вибірках, гуманітарних програмах та дослідженнях громадського здоров'я. Таким чином, історичний розвиток діагностики демонструє поступовий перехід від індивідуалізованої клінічної оцінки до популяційного підходу з використанням стандартизованих інструментів.

Еволюція діагностичних підходів у контексті сучасної війни. Сучасні воєнні конфлікти характеризуються не лише фізичними руйнуваннями, а й масштабним психологічним впливом, що потребує нових діагностичних рішень. У порівнянні з довоєнним періодом, коли психологічна діагностика здійснювалася переважно в умовах стабільної інфраструктури, війна змушує адаптувати інструменти до умов обмеженого доступу, дистанційної взаємодії та підвищеної вразливості респондентів.

Еволюція діагностики у цей період полягає у зсуві фокусу від виключно симптомно-орієнтованих моделей до більш комплексного розуміння стрес-індукованих станів, що включає як негативні прояви, так і ресурси адаптації. Зростає значення коротких самозвітних шкал, які можуть бути інтегровані в онлайн-формати, а також поєднання кількісних методів з якісним аналізом контексту переживань. Такий підхід створює підґрунтя для подальшого розвитку діагностичних інструментів, адаптованих до умов тривалого воєнного стресу у цивільного населення [3, с. 513–520].

Сучасні діагностичні шкали стрес-індукованих станів та їх порівняння. У сучасній психологічній практиці та дослідженнях стрес-індукованих станів у цивільного населення під час війни центральне місце посідають стандартизовані самозвітні шкали. Їх застосування зумовлене необхідністю швидкого, чутливого та відносно безпечного оцінювання психоемоційного стану великих вибірок осіб у ситуаціях, коли повноцінне клінічне інтерв'ю є утрудненим або неможливим. В

умовах війни такі інструменти виконують передусім скринінгову функцію, дозволяючи виявити осіб із підвищеним ризиком розвитку психічних порушень та спрямувати їх до подальшої допомоги.

Однією з найбільш валідизованих шкал для оцінки посттравматичної симптоматики є PCL-5 (PTSD Checklist for DSM-5). Вона ґрунтується на діагностичних критеріях ПТСР і дозволяє оцінити інтенсивність симптомів у чотирьох кластерах: нав'язливі переживання, уникання, негативні зміни когніцій і настрою, гіперзбудження. У воєнному контексті PCL-5 є особливо корисною для цивільних осіб, які зазнали безпосереднього або опосередкованого травматичного впливу (обстріли, втрати, вимушене переміщення). Водночас обмеженням шкали є її вузька фокусованість саме на травматичному досвіді, що не дозволяє охопити ширший спектр стрес-індукованих станів, пов'язаних із хронічною напругою.

Для більш комплексної оцінки емоційних порушень у цивільних вибірках широко застосовується DASS-21 (Depression, Anxiety and Stress Scale). Ця шкала дозволяє одночасно вимірювати рівень депресії, тривоги та стресу, що робить її зручною для диференціації симптомів у ситуаціях, коли клінічна картина є змішаною. У воєнних умовах DASS-21 особливо цінна для виявлення хронічного емоційного напруження, пов'язаного з тривалими стресорами, а не лише з окремими травматичними подіями. Її перевагою є універсальність, проте вона не дає змоги чітко ідентифікувати специфічні посттравматичні симптоми [6, с. 5–8, 4, с. 606–610].

Шкала GAD-7 (Generalized Anxiety Disorder-7) орієнтована на оцінку генералізованої тривоги та є ефективним інструментом для виявлення стійкого тривожного фону, характерного для цивільного населення в умовах тривалої війни. Вона відзначається простотою, високою чутливістю та зручністю застосування в онлайн-форматах. GAD-7 доцільна для використання у первинному скринінгу, однак її вузька спрямованість обмежує можливості комплексної оцінки психоемоційного стану [8, с. 1092–1096].

Для діагностики депресивної симптоматики широко використовується PHQ-9 (Patient Health Questionnaire-9). Цей інструмент дозволяє оцінити частоту та вираженість основних депресивних симптомів і є особливо корисним у поєднанні з іншими шкалами. У воєнному контексті PHQ-9 допомагає виявляти як реактивні депресивні стани, так і ризик більш глибоких афективних порушень. Разом з тим застосування шкали потребує обережності через наявність пунктів, пов'язаних із суїцидальними думками, що вимагає додаткових етичних заходів і алгоритмів реагування [4, с. 606–610].

Порівняльний аналіз зазначених інструментів свідчить, що жодна зі шкал не може вважатися універсальною. PCL-5 є оптимальною для оцінки травматичного впливу, DASS-21 – для комплексного аналізу емоційних станів, GAD-7 і PHQ-9 – для цільового скринінгу тривоги та депресії відповідно. У дослідженнях цивільного населення під час війни найбільш доцільним є комбінований підхід, що дозволяє охопити як гострі, так і хронічні прояви стресу [6, с. 5–8].

Діагностика психосоматичних проявів стресу. Окрему групу стрес-індукованих станів у цивільних під час війни становлять психосоматичні порушення. Хронічний стрес часто проявляється через тілесні симптоми, зокрема головний біль, м'язову напругу, серцево-судинні скарги, порушення сну, апетиту та функціонування шлунково-кишкового тракту. Такі прояви можуть не усвідомлюватися як психологічні, що ускладнює їх виявлення та корекцію [2, с. 112–118]. Діагностика психосоматичних станів передбачає інтеграцію самозвітних методів, клінічного інтерв'ю та аналізу медичної інформації. У воєнний час особливо важливо використовувати інструменти, які дозволяють виявляти зв'язок між емоційним напруженням і соматичними симптомами без повторної травматизації респондента. Такий підхід підкреслює необхідність комплексної оцінки стрес-індукованих станів, що виходить за межі суто психологічних симптомів і враховує тілесний вимір переживань.

Цифрові та ai-інструменти у діагностиці стрес-індукованих станів.

Сучасні воєнні умови суттєво прискорили впровадження цифрових технологій у сферу психологічної діагностики. Обмежений доступ до очних консультацій, висока мобільність населення та потреба в масовому скринінгу зумовили активне використання онлайн-опитувальників, мобільних застосунків і дистанційних платформ для оцінки психоемоційного стану цивільних осіб. Цифрові інструменти дозволяють швидко збирати дані, охоплювати великі вибірки та забезпечувати відносну анонімність, що підвищує готовність людей брати участь у дослідженнях [7, с. 2–6]. Окремим напрямом розвитку є застосування інструментів штучного інтелекту в психологічній діагностиці. Алгоритми машинного навчання використовуються для аналізу мовлення, письмових відповідей, патернів поведінки та динаміки самозвітних даних. У воєнному контексті такі підходи відкривають перспективи раннього виявлення змін психоемоційного стану та прогнозування ризиків розвитку стрес-індукованих порушень. Водночас використання AI-інструментів потребує обережності з огляду на етичні питання, конфіденційність даних і недопущення заміни професійної психологічної оцінки автоматизованими рішеннями [7, с. 6–10].

Таким чином, цифрові та AI-методи доцільно розглядати не як альтернативу класичній діагностиці, а як доповнення до неї, особливо у ситуаціях масового скринінгу та моніторингу психічного стану цивільного населення під час війни [7, с. 2–6].

Вікові, гендерні та соціальні особливості діагностики. Інтерпретація результатів психологічної діагностики стрес-індукованих станів потребує врахування вікових, гендерних і соціальних відмінностей. Молоді дорослі частіше демонструють підвищений рівень тривоги, інформаційне перенавантаження та емоційну нестабільність, що пов'язано з високою інтенсивністю медіаспоживання та невизначеністю життєвих перспектив. Особи середнього та старшого віку схильні до соматизації стресу, що вимагає поєднання психологічної та медичної діагностики.

Гендерні відмінності проявляються у вищих показниках тривожних і депресивних симптомів у жінок, тоді як у чоловіків частіше спостерігаються поведінкові реакції, емоційне пригнічення або психосоматичні скарги. Соціальні чинники, зокрема досвід внутрішнього переміщення, рівень соціальної підтримки, економічна нестабільність і формат зайнятості, також впливають на результати діагностики. У зв'язку з цим використання стандартизованих шкал потребує контекстуальної інтерпретації та доповнення ресурсно-орієнтованими інструментами.

Опитувальник «стійкість до стресу» як ресурсний компонент діагностики.

На відміну від симптомно-орієнтованих шкал, опитувальник «Стойкість до стресу» спрямований на оцінку психологічних ресурсів, які забезпечують адаптацію в умовах тривалого стресу. Він дозволяє оцінити здатність до емоційної регуляції, самоконтролю, витривалості та збереження ефективності діяльності під тиском зовнішніх обставин. У воєнний час такий підхід є особливо важливим, оскільки дозволяє змістити фокус із виключно патологічних проявів на ресурси особистості.

У майбутньому емпіричному дослідженні передбачається використання цього опитувальника для анкетування 70 цивільних добровольців – жителів обласних центрів України. Аналіз показників стійкості до стресу у віковому та гендерному розрізі дозволить виявити групи підвищеного ризику та групи з вищим адаптаційним потенціалом, що має важливе практичне значення для розроблення програм психологічної підтримки.

Висновки. Розвиток інструментів психологічної діагностики стрес-індукованих станів у воєнний час відображає перехід від вузької клінічної оцінки до багаторівневого, масштабованого та ресурсно-орієнтованого підходу. Поєднання класичних діагностичних шкал, оцінки психосоматичних проявів, цифрових технологій і вимірювання стресостійкості створює підґрунтя для ефективної діагностики психологічного стану цивільного населення під час війни та

розроблення практичних стратегій психологічної підтримки [3, с. 513–520, 9, с. 88–92].

Список використаних джерел.

1. American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5). Washington, DC : APA, 2013.
2. Antonovsky A. Health, Stress, and Coping. San Francisco : Jossey-Bass, 1979.
3. Hobfoll S. E. Conservation of Resources. American Psychologist. 1989.
4. Kroenke K., Spitzer R. L., Williams J. B. The PHQ-9. Journal of General Internal Medicine. 2001.
5. Lazarus R. S., Folkman S. Stress, Appraisal, and Coping. New York : Springer, 1984.
6. Lovibond S. H., Lovibond P. F. Manual for the Depression Anxiety Stress Scales (DASS-21). Sydney, 1995.
7. Miner A. S. et al. Smart Technologies for Mental Health Assessment. npj Digital Medicine. 2019.
8. Карамушка Л. М. Психологія професійного стресу. Київ : Либідь, 2019.
9. Бочелюк В. Й., Панов М. С. Психологія стресу та стресостійкості. Київ, 2020.

Психологія формування стратегії посттравматичного зростання у осіб, постраждалих від конфліктів у суспільстві

*Лосієвська О. Г.
доктор психологічних наук, професор
Східноукраїнський національний університет
імені Володимира Даля, м. Київ*

*Доценко Н.М.
Здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти
Східноукраїнський національний університет
імені Володимира Даля, м. Київ*

Актуальність. У сучасних умовах глибоких соціальних трансформацій, зумовлених збройними конфліктами та війнами, особливої актуальності набуває дослідження механізмів психологічної адаптації та відновлення особистості, яка пережила травматичний досвід. Російсько-українська війна, що триває з 2014 року, спричинила масову травматизацію населення України, висунувши на перший план потребу не лише в лікуванні патологічних наслідків (посттравматичного стресового розладу), але й у розумінні та сприянні потенціалу позитивної трансформації – посттравматичного зростання (ПТЗ). Актуальність теми зумовлена нагальною потребою розробки дієвих, науково обґрунтованих стратегій та програм підтримки для величезної кількості людей (військовослужбовців, ветеранів, внутрішньо переміщених осіб, цивільних), які змушені будувати життя після травми. Це передбачає перехід від суто патогенетичної моделі психологічної допомоги до салютогенної, орієнтованої на ресурси, зміцнення стійкості та фасилітацію особистісного розвитку в умовах кризи. Термін «травма» має грецьке коріння та дослівно означає «рана». У психологічному контексті це комплексний феномен, який узагальнено можна описати як різноманітні пошкодження психіки, які порушують її нормальний стан, породжують психічний дискомфорт і є причиною виникнення неврозів та інших захворювань.

Сутність психологічної травми полягає у глибокому порушенні психіки, спричиненому подією, що загрожує життю, цілісності або базовому відчуттю безпеки людини. Як «рана», вона руйнує звичну картину світу, викликаючи інтенсивні страждання, втрату контролю та почуття вразливості. Подібні події (від насильства та війни до раптових втрат) створюють нову, часто лякаючу реальність, що розділяє життя на «до» і «після», провокуючи екзистенційну кризу та потребу в пошуку сенсу.

В науковій літературі поняття «психічна травма» з'явилося вперше наприкінці XIX століття. Про природу та сутність поняття «психотравма» в своїх публікаціях пише Зігмунд Фройд, який зазначав, що психологічна травма являє собою переживання, що призводить за короткий час до такого сильного збільшення подразнення, що звільнення від нього або його нормальна переробка не вдаються, від чого можуть наступити тривалі порушення у витраті енергії [5].

Традиційно психологія акцентувала на патологічних наслідках травми, зокрема посттравматичному стресовому розладі (ПТСР), який проявляється у вигляді нав'язливих спогадів, уникнення та гіперзбудження. Це серйозний стан, що потребує професійної допомоги, і його ризик особливо високий серед тих, хто пережив конфлікт чи насильство.

Однак травма має подвійну природу. Як зазначає О. Туриніна, поряд із загрозою та руйнуванням, вона також може стати каталізатором розвитку стійкості, мужності та створювати умови для позитивних змін [4].

Саме цей потенціал і становить суть посттравматичного зростання (ПТЗ). Посттравматичне зростання – це не заперечення болю чи відсутність страждань, а трансформаційний процес, що розгортається поряд з ними. Воно є результатом активної боротьби з наслідками травми та глибокої когнітивної переробки досвіду. ПТЗ не є синонімом резильєнтності (простої стійкості чи відновлення), а передбачає якісний стрибок уперед, вихід на новий рівень розуміння себе та світу.

Таким чином, травма та посттравматичне зростання – дві сторони одного складного процесу. Травма руйнує стару схему світу, створюючи тиск, біль і потребу в осмисленні. Посттравматичне зростання є можливим результатом конструктивної боротьби з цим викликом, коли людина не просто латає «рану», але й будує нову, більш зрілу, глибшу історію про себе та своє місце у світі. Цей шлях залежить від внутрішніх ресурсів (оптимізму, відкритості), соціальної підтримки та активних стратегій подолання, що дозволяють переосмислити досвід і перетворити страждання на джерело сили та нових смислів.

Концепція посттравматичного зростання (ПТЗ) ґрунтується на давній філософській і культурній ідеї про те, що страждання може бути джерелом позитивної трансформації людини. Проте як наукова теорія вона сформувалася лише в останні десятиліття ХХ століття.

Одним з перших дослідників феномену особистого зростання, був Н. Фінкель, який ввів термін «Т-S конверсія», вказавши на можливість перетворення травми (Trauma) в силу (Strength) через когнітивну переробку досвіду. Важливим емпіричним кроком стали дослідження С. Джозефа, Р. Вільямса та В. Юле після катастрофи порому Herald of Free Enterprise (1987), які показали, що значна частина постраждалих (43 %) повідомила, що їх погляди на життя змінилися на краще. Це призвело до створення першого інструменту для вимірювання як негативних, так і позитивних змін після травми (С. Джозеф, Р. Вільямс, В. Юле, The Changes in Outlook Questionnaire (CiOQ), який використовується зараз і в наукових дослідженнях, і в психотерапевтичній практиці.

Концепція посттравматичного зростання (ПТЗ) (Posttraumatic Growth Inventory, PTGI) була вперше розроблена в середині 90-х років R. G. Tedeschi та L. G. Calhoun. Вони систематизували поняття та дали класичне визначення посттравматичного зростання як позитивних психологічних змін, що відбулися в

результаті боротьби з травматичними або надзвичайно складними життєвими обставинами.

R. G. Tedeshi та L. G. Calhoun розробили базовий діагностичний інструмент для вимірювання посттравматичного зростання, оцінки позитивних результатів, про які повідомляють особи, які пережили травматичні події – Posttraumatic Growth Inventory (PTGI). Концепція, запропонована науковцями, полягає в тому, що посттравматичне зростання – це не відсутність дистресу, а позитивний розвиток, який можливий попри наявність травматичного досвіду. Вони запропонували п'ять основних доменів (сфери), в яких проявляється ПТЗ: нові можливості (new possibilities), міжособистісні взаємини (relating to others), особиста сила (personal strength), духовні зміни (spiritual change), глибше цінування життя (appreciation of life) [6; 7].

Українські вчені проводять адаптацію інструментів (PTGI, CD-RISC-10 та ін.), досліджують прояви ПТЗ у різних групах населення (військовослужбовці, діти, вимушені переселенці) та розробляють практики психологічного супроводу, орієнтовані на ресурси та зростання. Ця робота має велике значення для подолання наслідків колективної травми та відбудови суспільства. Так, Д. Зубовським у 2018 році здійснив адаптацію опитувальника Posttraumatic Growth Inventory (PTGI) для українських військовослужбовців – учасників АТО українським науковцем зі зміною п'ятифакторної структури оригінальної методики на трифакторну адаптованої версії: 1) зміни у сприйнятті власного «Я» / нові можливості; 2) міжособистісні відносини; 3) життєва філософія [3].

Апробація україномовної версії “Опитувальника посттравматичного зростання” на учасниках Антитерористичної операції (АТО) відбулась серед офіцерів Національного університету оборони України імені Івана Черняхівського, які в 2014 -2015 роках перебували в зоні проведення антитерористичної операції.

Н. Школіна, І. Шаповал, І. Орлова, І. Кедик, М. Станіславчук провели адаптацію та валідизацію україномовної версії шкали стресостійкості Коннора-Девідсона-10 (CD-RISC-10), здійснивши апробацію у хворих на анкілозивний спондиліт.

І. Сазонова досліджувала посттравматичне зростання дітей, постраждалих внаслідок воєнних дій, підлітків.

Науковці Н. Калка, В. Бліхар, М. Цивінська, Л. Кузо, А. Марчук, Г. Католик аналіз стійкості та життєздатності в контексті впливу різних травматичних подій. Зокрема, окреслено вплив таких подій та явищ, як війна та військова агресія, які українці переживають з початку вторгнення військ російської федерації.

Л. Музичко проводила дослідження проявів резильєнтності та посттравматичного зростання в осіб, які переживають тривалий стрес, зумовлений пандемією, а згодом і воєнними діями на території України.

В. Олійник приділяє увагу дослідженню посттравматичного зростання у військовослужбовців з різним бойовим досвідом, у працівників правоохоронних органів та членів сімей військовослужбовців після початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну.

Також дослідженням посттравматичного зростання як основою психологічного супроводу учасників бойових дій займається Н. Харитонova. Формування комплексних теоретичних моделей, здатних адекватно пояснити механізми та діалектику посттравматичного зростання (ПТЗ), залишається однією з науково-практичних проблем сучасної психології травми. Незважаючи на значний емпіричний прогрес, наукова спільнота продовжує пошук інтегративних концептуальних рамок, що могли б об'єднати різнорівневі детермінанти цього феномену. Критичний аналіз цих концептуальних підходів дозволяє виявити як їхні унікальні внески в розуміння природи ПТЗ, так і перспективи для подальшої теоретичної інтеграції [1].

Таким чином, ПТЗ є складною, багаторівневою концепцією, що пройшла шлях від філософської інтуїції до емпірично обґрунтованої наукової теорії з розвиненим інструментарієм. Її інтеграція в практику психологічної допомоги дозволяє змістити фокус з лікування патології на підтримку потенціалу особистісної трансформації та відновлення.

Мета дослідження. Дослідити формування стратегії посттравматичного зростання у осіб, постраждалих від конфліктів у суспільстві.

Матеріал та методи дослідження. У дослідженні взяли участь 30 респондентів. З них жінки – 23 респондентки, що складає 76,67 % вибірки, чоловіки – 7 респондентів, що складає 23,33 % вибірки. Загалом віковий діапазон вибірки респондентів склав від 18 до старше 60 років (див. табл. 1). Найбільша група – 51-60 років (33,33 % вибірки). Респондентів віком від 18 до 30 років – 20 %; від 31 до 40 років – 6,67 %, від 41 до 50 років – 26,67 %, старше 60 років – 13,33 %

Результати дослідження. Проведений психологічний та статистичний аналіз дозволив виявити наступні ключові закономірності щодо взаємозв'язку посттравматичного зростання (ПТЗ), сприйнятого стресу та резильєнтності. За рівнем посттравматичного зростання (ПТЗ), переважна більшість респондентів (73,34 %) демонструє середній або високий рівень ПТЗ. Це свідчить про значний потенціал до позитивної психологічної трансформації після травматичних подій. Конкретно: 43,34 % мають середній рівень, а 30,00 % – високий. Лише 26,66 % опитаних показали низький рівень зростання (див. табл. 1).

Таблиця 1

**Рівень посттравматичного зростання у респондентів за Опитувальником
посттравматичного зростання (PTGI) з розподілом за статтю**

Рівень посттравматичного зростання	Стать					
	Чоловіки		Жінки		Всього	
	n	%	n	%	n	%
Низький рівень	1	14,29	7	30,43	8	26,66
Середній рівень	4	57,14	9	39,14	13	43,34
Високий рівень	2	28,57	7	30,43	9	30,00
Всього	7	100,0	23	100,0	30	100,0

Статеві відмінності незначні, але жінки демонструють дещо вищий середній показник ПТЗ (49,74 бали) порівняно з чоловіками (47,71 бал). Це може вказувати на більшу схильність жінок до рефлексивного осмислення досвіду та використання соціальної підтримки для перетворення стресу в зростання.

Віковий аналіз виявляє найвищі показники ПТЗ у групах 41–50 та 51–60 років (50 % учасників у цих групах мають високий рівень). Це свідчить про те, що досвід і життєва мудрість можуть бути важливими ресурсами для посттравматичного зростання (див. табл. 2).

Таблиця 2

**Рівень посттравматичного зростання у респондентів за Опитувальником
посттравматичного зростання (PTGI), з розподілом за віком**

Рівень посттравматичного зростання	Вік, роки									
	18-30		31-40		41-50		51-60		60 ≥	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Низький рівень	1	16,67	1	50,0	2	25,0	2	20,0	2	50,0
Середній рівень	4	66,66	1	50,0	2	25,0	5	50,0	1	25,0
Високий рівень	1	16,67	–	–	4	50,0	3	30,0	1	25,0
Всього	6	100,0	2	100,0	8	100,0	10	100,0	4	100,0

За рівнем сприйнятого стресу (PSS-10) домінуючим у вибірці є помірний рівень стресу (73,34 % респондентів). Це відповідає науковим уявленням про оптимальний рівень стресу, який може активізувати адаптаційні механізми та сприяти зростанню. Одночасно виявлено групу ризику: 23,33 % учасників мають високий показник «сильно сприйнятий стрес» за шкалою сприйняття стресу, що вказує на потребу в цілеспрямованій психологічній підтримці (див. табл. 3).

Таблиця 3

Рівень сприйняття стресу респондентами за Шкалою сприйнятого стресу (PSS-10), з розподілом за статтю

Рівень сприйняття	Стать					
	Чоловіки		Жінки		Всього	
	n	%	n	%	n	%
Слабо сприйнятий стрес	—	—	1	4,35	1	3,33
Помірно сприйнятий стрес	5	71,43	17	73,91	20	73,34
Сильно сприйнятий стрес	2	28,57	5	21,74	9	23,33
Всього	7	100,0	23	100,0	30	100,0

Виявлено чітку вікову тенденцію: рівень стресу статистично зростає з віком. Найвищі середні показники спостерігаються в групах «старше 60» (27 балів) та «51–60» (23,89 балів), тоді як молодші групи (18–30, 31–40 років) демонструють нижчий рівень стресового навантаження (див. табл. 4).

Рівень сприйняття стресу респондентами за Шкалою сприйнятого стресу (PSS-10), з розподілом за віком

Рівень сприйняття	Вік, роки									
	18-30		31-40		41-50		51-60		60 ≥	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Слабо сприйнятий стрес	–	–	1	50,0	–	–	–	%	–	–
Помірно сприйнятий стрес	6	100	1	50,0	6	75,0	8	80,0	1	25,0
Сильно сприйнятий стрес	–	–	–	–	2	25,0	2	20,0	3	75,0
Всього	6	100,0	2	100,0	8	100,0	10	100,0	4	100,0

Статеві відмінності в сприйнятті стресу мінімальні (середній бал у чоловіків – 23,71, у жінок – 23,35).

За результатами (показниками) рівня резильєнтності (CD-RISC-10). Половина вибірки (50 %) має середній, вищий за середній або високий рівень резильєнтності, що свідчить про хорошу здатність до опору стресу та відновлення. При цьому 30 % мають високий рівень, що є позитивним показником.

Окрему увагу потребує група з нижчим за середній рівнем резильєнтності (30 % вибірки). Ці особи можуть бути більш вразливими до негативних наслідків стресу (див. табл. 5). Чоловіки демонструють дещо вищий середній рівень стресостійкості (26,71 бал) порівняно з жінками (24,78 бал).

Таблиця 5

Рівень резильєнтності респондентів за Шкалою стресостійкості Коннора-Девідсона-10 (CD-RISC-10), з розподілом за статтю

Рівень резильєнтності	Стать					
	Чоловіки		Жінки		Всього	
	n	%	n	n	%	n
Низький	—	—	1	4,36	1	3,33
Нижчий за середній	2	28,57	7	30,43	9	30,0
Середній	1	14,29	4	17,39	5	16,67
Вищий за середній	2	28,57	4	17,39	6	20,0
Високий	2	28,57	7	30,43	9	30,0
Всього	7	100,0	23	100,0	30	100,0

Вікова динаміка неоднозначна: найвищі показники резильєнтності спостерігаються в групі 51–60 років (40 % мають високий рівень), що контрастує з високим рівнем стресу в цій же групі. Це може свідчити про те, що саме резильєнтність дозволяє їм трансформувати стресовий досвід. Група «старше 60» показує найбільшу варіативність і включає єдиний випадок низької резильєнтності (див. табл. 6).

Таблиця 6

Рівень резильєнтності респондентів за Шкалою стресостійкості Коннора-Девідсона-10 (CD-RISC-10), з розподілом за віком

Рівень резильєнтності	Вік, роки									
	18-30		31-40		41-50		51-60		60 ≥	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Низький	—	—	—	—	—	—	—	—	1	25,0
Нижчий за середній	2	33,3	—	—	1	12,5	4	40,0	2	50,0
Середній	1	16,6	—	—	3	37,5	1	10,0	—	—
Вищий за середній	1	16,6	2	100,0	2	25,0	1	10,0	—	—
Високий	2	33,3	—	—	2	25,0	4	40,0	1	25,0
Всього	6	100,0	2	100,0	8	100,0	10	100,0	4	100,0

Резильєнтність виступає ключовим фактором, що опосередковує зв'язок між стресом і ПТЗ. Це підтверджується тим, що група 51–60 років, маючи високий стрес, демонструє і високі показники як резильєнтності, так і ПТЗ. Їхня психологічна стійкість дозволяє перетворювати стресовий досвід у джерело зростання.

Помірний стрес у більшості респондентів не є перешкодою для ПТЗ, а навпаки, може виконувати функцію виклику, що активізує адаптивні ресурси особистості.

Стрес зростає з віком, але рівень ПТЗ не знижується пропорційно. Це підтверджує, що на здатність до зростання впливають не стільки інтенсивність стресу, скільки внутрішні ресурси (резильєнтність) та наявність стратегій його подолання.

Результати констатувального експерименту підтверджують гіпотезу про тісний взаємозв'язок між посттравматичним зростанням, сприйнятим стресом та резильєнтністю. Вибірку в цілому можна охарактеризувати як адаптивну, зі значним потенціалом до позитивної трансформації після травми. Одночасно виявлено групи, що потребують підвищеної психологічної уваги: особи з високим рівнем стресу та низькою резильєнтністю, особливо у старшому віці. Ці дані обґрунтовують необхідність розробки та впровадження цілеспрямованих програм (на кшталт запропонованого соціально-психологічного тренінгу), спрямованих на розвиток резильєнтності та фасилітацію стратегій посттравматичного зростання.

Проведений теоретичний аналіз та розробка програми експериментального дослідження дозволяють сформулювати наступні висновки.

Стратегії посттравматичного зростання (ПТЗ) являють собою комплексний, багаторівневий феномен, що формується на перетині когнітивних, емоційних, соціальних, поведінкових та екзистенційних процесів. Найефективнішими є інтегративні стратегії, що поєднують внутрішню роботу з осмислення травми

(когнітивна переоцінка, побудова нового наративу) із зовнішньою активністю (соціальна взаємодія, проактивна поведінка, допомога іншим).

Ключовими механізмами ПТЗ виступають: когнітивна переоцінка травматичного досвіду та конструювання нового змістовного поля; отримання та надання багаторівневої соціальної підтримки, особливо в групах взаємодопомоги; використання релігійно-духовних практик для смислової трансценденції травми; реалізація проактивної та просоціальної поведінки; застосування креативних практик та технік самоспостереження (mindfulness) для психоемоційної регуляції та інтеграції досвіду; отримання структурованої професійної психотерапевтичної допомоги.

Сучасна діагностика ПТЗ ґрунтується на низці стандартизованих інструментів, серед яких центральне місце посідає Опитувальник посттравматичного зростання (PTGI) Р. Тедеші та Л. Калхау, що дозволяє оцінити позитивні зміни у п'яти ключових сферах: нові можливості, відносини з іншими, особиста сила, духовні зміни та цінування життя.

Для експериментального дослідження обрано комплекс психодіагностичних методик, що дозволяє всебічно оцінити як сам феномен ПТЗ (PTGI), так і пов'язані з ним конструкти: рівень стресу (Шкала сприйнятого стресу PSS-10) та особистісний ресурс опору (Шкала стресостійкості Коннора-Девідсона CD-RISC-10). Цей комплексний підхід дозволить не лише констатувати наявність зростання, а й проаналізувати його зв'язок зі стресовим навантаженням та індивідуальною стійкістю.

У ході емпіричного дослідження було проаналізовано психологічні особливості респондентів за трьома ключовими параметрами: рівнем посттравматичного зростання, рівнем сприйнятого стресу та рівнем резильєнтності. Отримані результати дозволяють сформулювати такі узагальнені висновки.

Вибірка для констатувального експерименту складається переважно з жінок (76,67 %), а найбільша вікова група – 51–60 років (33,33 %). Такий розподіл суттєво впливає на інтерпретацію результатів, оскільки: вік є значущим фактором у рівні сприйнятого стресу.

Це дозволяє розглядати вибірку як репрезентативну щодо аналізу психологічних реакцій людей зрілого та пізнього віку, постраждалих від стресогенних чи травматичних подій.

Переважна більшість респондентів (73,34 %) продемонстрували середній або високий рівень посттравматичного зростання, що свідчить про здатність адаптуватися до складних життєвих подій та значний потенціал психологічної трансформації після складних подій. Жінки показали дещо вищий середній показник посттравматичного зростання порівняно з чоловіками, що може вказувати на більшу схильність до рефлексії, ширшими соціальними мережами підтримки, культурними чинниками переживання та вираження емоцій та трансформації стресових подій у позитивні зміни. Чоловіки демонструють дещо кращу стресостійкість. Старші вікові групи виявляють більшу варіативність у показниках резильєнтності.

Це дозволяє зробити висновок, що у вибірці загалом простежується тенденція до конструктивної інтеграції травматичного досвіду до формування позитивних змін, що є надзвичайно важливим у контексті відновлення після конфлікту.

При тестуванні рівня стресу більшість респондентів (73,34 %) перебувають у зоні помірного рівня стресу, що є типовим показником для ситуацій довготривалих соціальних чи життєвих викликів. Високий рівень сприйнятого стресу виявлено у 23,33 % респондентів, що свідчить про потребу у додатковій психологічній або соціальній підтримці, оскільки може ускладнювати відновлення та впливати на психосоматичний стан. Аналіз вікових груп показав, що рівень стресу підвищується з віком, досягаючи найвищих значень у групі 60+.

Це вказує на вікову вразливість та можливе зниження ресурсів подолання у старших учасників, що вимагає додаткових заходів психосоціальної підтримки та програм зміцнення стресостійкості.

Висновок. Загалом отримані дані дають підстави стверджувати, що респонденти здебільшого перебувають у зоні керованого, адаптивного стресу, який не є деструктивним, але потребує відстеження в окремих групах ризику. Половина респондентів (50 %) продемонструвала вищий за середній або високий рівень резильєнтності, що свідчить про їхню здатність зберігати ефективне функціонування у стресових умовах та швидко відновлюватися після психологічних потрясінь. При цьому 30 % учасників показали нижчий за середній рівень резильєнтності, що підкреслює наявність групи, яка потребує додаткової уваги. Єдиний випадок низького рівня резильєнтності зафіксовано у респондентки віком 60+, що підтверджує вікові тенденції до зниження адаптивних ресурсів. Отже, в цілому вибірку можна охарактеризувати як ресурсну та психологічно стійку, з потенціалом до конструктивного подолання життєвих викликів.

Отримані результати демонструють узгоджену картину психологічного функціонування вибірки: посттравматичне зростання позитивно пов'язане з резильєнтністю. Чим вищий рівень резильєнтності, тим більша ймовірність трансформації травматичних подій у позитивні особистісні зміни. Помірний рівень стресу не знижує, а інколи навіть стимулює посттравматичне зростання, виступаючи тригером адаптивних механізмів. Резильєнтність виконує буферну (захисну) функцію, пом'якшуючи вплив стресу та сприяючи конструктивній інтеграції досвіду. Стрес з віком зростає, але рівень ПТЗ не падає пропорційно, що опосередковано підтверджує вплив інших чинників – життєвого досвіду, соціальної підтримки, сформованих копінг-стратегій.

Таким чином, модель взаємодії «стрес – резильєнтність – посттравматичне зростання» у цій вибірці працює узгоджено і відповідає сучасним теоретичним

підходам. Дослідження показало, що респонденти характеризуються загалом високим адаптивним потенціалом, помірним рівнем стресу та схильністю до посттравматичного зростання. Це свідчить про здатність вибірки ефективно мобілізувати внутрішні ресурси у відповідь на складні життєві події. Водночас окремі групи – особливо старші учасники та респонденти з нижчими показниками резильєнтності – потребують додаткової психологічної підтримки [2]. Загалом отримані результати вказують на гармонійне функціонування ключових психологічних компонентів, що забезпечують відновлення, адаптацію та конструктивне особистісне зростання після стресових і травматичних подій.

Список використаних джерел.

1. Готич В. О. Посттравматичне зростання: концептуалізація поняття, огляд теоретичних моделей. *Волинський національний університет імені Лесі Українки Психологічні студії*. 2023. № 1. С. 21-28 URL: https://www.academia.edu/105205263/посттравматичне_зростання_концептуалізація_поняття_огляд_теоретичних_моделей
2. Доценко Н. М. Психологія формування стратегії посттравматичного зростання у осіб, постраждалих від конфліктів у суспільстві : магістерська робота. Східноукраїнський Національний Університет імені Володимира Даля. – Київ, 2025. – 96 с.
3. Зубовський Д. С. Особистісне зростання учасників АТО у посттравматичний період: дис. ...канд. псих. наук: 19.00.09. Київ, 2019. 285 с. URL: <https://nuou.org.ua/assets/dissertations/diser/diser-zubovskyi.pdf>
4. Туриніна О. Л. Психологія травмуючих ситуацій : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Київ : ДП «Вид. дім Персонал», 2017. 160 с. URL: https://document.kdu.edu.ua/info_zab/053_1436.pdf
5. Шапар В. Б. Сучасний тлумачний психологічний словник. Харків: Прапор, 2007. 640 с. URL: <https://archive.org/details/psycholoh2007/page/546/mode/2up>

6. Tedeschi R. G., Calhoun L. G. The Posttraumatic Growth Inventory: Measuring the positive legacy of trauma. Journal of traumatic stress. 1996. Vol. 9, no. 3. P. 455-471. URL: <https://sites.charlotte.edu/ptgi/wp-content/uploads/sites/9/2015/01/The-Posttraumatic-Growth-Inventory-Measuring-the-positive-legacy-of-trauma.pdf>

7. Tedeschi, R. G., Calhoun, L. G. Trauma and Transformation: Growing in the Aftermath of Suffering. Thousand Oaks: SAGE Publications, Inc., 1995. 175 p. URL: <https://sk.sagepub.com/book/mono/trauma-and-transformation/toc>

Посттравматичне зростання особистості раннього дорослого віку у гендерному вимірі

*Лосієвська О.Г.
доктор психологічних наук, професор
Східноукраїнський національний університет
імені Володимира Даля, м. Київ*

*Холодова С. Г.
Здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти
Східноукраїнський національний університет
імені Володимира Даля, м. Київ*

Актуальність. Сучасне суспільство характеризується зростанням кількості складних життєвих ситуацій та викликів, які значно впливають на психологічне здоров'я та благополуччя особистості. Вивчення посттравматичного зростання крізь призму гендерних особливостей актуалізується на всіх етапах вікового та професійного розвитку особистості, що сприяє поглибленню розуміння механізмів психологічної адаптації та трансформації. Гендерна ідентичність як структурний компонент самосвідомості зумовлює характер переживання травматичних подій, підходи до організації власних ресурсів та визначення життєвих і професійних орієнтирів. Вона впливає на те, як людина активує внутрішні можливості у процесі подолання труднощів, що, у свою чергу, створює умови для розвитку посттравматичного зростання. Водночас дослідження гендерних відмінностей у формуванні посттравматичного зростання залишається недостатньо вивченим, що актуалізує необхідність комплексного наукового аналізу цієї проблематики.

Події, що відбуваються в Україні протягом останніх років, докорінно змінили життя населення: війна, окупація, руйнування домівок, втрата близьких, вимушене переселення в більш безпечні регіони країни або за кордон, адаптація до нових умов, тривале перебування без світла чи звичайного доступу до послуг. Особливого психологічного навантаження зазнають військовослужбовці, які

перебувають на фронті та щодня зіштовхуються з екстремальними умовами, ризиком для життя й високим емоційним виснаженням. Все це створило безпрецедентну ситуацію, у якій кожен змушений заново вибудовувати власну реальність.

Сучасність надає особливої актуальності дослідженням посттравматичного зростання особистості. Протягом останніх століть увага науковців в галузі психічного здоров'я переважно фокусувалась на негативних наслідках травматичних подій. Особлива увага приділялася дослідженню посттравматичного стресового розладу.

Ідея про те, що страждання можуть призводити до особистісного зростання, існує давно. Вона присутня у багатьох релігійних та філософських коріннях. Проте наукове вивчення цього явища почалося порівняно недавно.

В. Франкл наголошував, що навіть якщо життя сповнене болю та випробувань, людина має здатність знайти в цьому стражданні сенс та перетворити свій біль у внутрішнє зростання [13].

Серед перших наукових напрацювань варто відзначити дослідження Н. Фінкеля, проведені у 1974-1975 рр. Вчений виявив, що травматичні події в житті людини можуть перетворюватися на поштовх до особистісного розвитку. Цей феномен він назвав Т-S конверсією, тобто процесом трансформації травми (Т – trauma) у силу для зростання (S – stren), який відбувається завдяки когнітивному переосмисленню події [3].

Важливою віхою у вивченні позитивних наслідків травматичних переживань стала робота С. Джозефа, пов'язана з дослідженням наслідків корабельної катастрофи Herald of Free Enterprise (1987р.). Результати засвідчили, що майже половина (43 %) тих, хто вижив, повідомили про позитивні зміни у своєму житті, що стало поштовхом до створення інструменту, який дозволяв оцінювати як негативні, так і позитивні зміни після травматичних подій [1].

До 1996 року в наукових публікаціях використовувалися різні терміни для опису позитивних змін після травми: «позитивні психологічні зміни», «зростання, пов'язане зі стресом», «розцвітання», «позитивний побічний ефект», «відкриття життєвих смислів», «сприйнята вигода» [3].

Засновниками терміну «посттравматичне зростання» вважаються Р. Тедескі разом із Л. Калхун. Так у своїй науковій праці у 1996 р. вони вперше систематично описали явище позитивних змін після пережитої травми й розробили інструмент для його емпіричного вимірювання [16].

За визначенням Р. Тедескі та Л. Калхуна, посттравматичне зростання – це сукупність позитивних психологічних змін, які виникають у процесі осмислення та подолання наслідків травматичних подій. Автори підкреслюють, що це не просто повернення до попереднього рівня функціонування, а якісна трансформація особистості, яка виходить за межі початкового стану [17].

Отже, важливо чітко розмежовувати поняття резильєнтності та посттравматичного зростання, оскільки вони відображають різні психологічні процеси реагування на травматичний досвід. Резильєнтність пов'язана насамперед зі здатністю особистості зберігати стабільність і відновлювати попередній рівень функціонування після стресових подій. Натомість посттравматичне зростання передбачає якісні особистісні зміни, що виникають внаслідок глибинного переосмислення пережитої травми. Таким чином, резильєнтність орієнтована на збереження психологічної рівноваги, тоді як посттравматичне зростання передбачає вихід за межі попереднього рівня розвитку [11].

Концепція посттравматичного зростання, запропонована Р. Тедескі та Л. Калхуном, ґрунтується на емпіричних спостереженнях, які свідчать про те, що після переживання надзвичайно складних життєвих випробувань люди нерідко повідомляють про позитивні зміни у власному житті. Такі зміни були зафіксовані серед жертв зґвалтування, людей, які пережили втрату близьких, пацієнтів з

онкологічними захворюваннями, а також тих, хто зазнав інших травматичних подій.

На думку авторів, посттравматичне зростання характеризується розвитком нових можливостей, поглибленням стосунків з іншими людьми, зміцненням відчуття особистої сили, духовними змінами та збільшенням цінності життя [17]. Саме ці п'ять доменів стали основою для створення спеціального інструменту – опитувальника, що дає змогу оцінити рівень посттравматичного зростання в різних життєвих вимірах, який дозволяє оцінити рівень посттравматичного зростання у різних життєвих вимірах.

Описуючи механізм посттравматичного зростання Р. Тедескі та Л. Калхун зазначають, що зростання не є прямим наслідком травми. Воно виникає внаслідок внутрішньої діяльності особистості, спрямованої на прийняття та засвоєння нової життєвої реальності. Ключову роль у формуванні посттравматичного зростання відіграє когнітивна обробка травматичного досвіду, яка відбувається у два етапи. На початковому етапі домінують автоматичні, нав'язливі думки, що супроводжуються сильним емоційним напруженням і підтримують активність когнітивної системи. За умови конструктивного перебігу цього процесу з часом відбувається перехід до навмисної когнітивної обробки, яка проявляється у новий сенс [18].

Науковці зазначають, що посттравматичне зростання і психологічний дистрес не є протилежними явищами. Навпаки, вони можуть співіснувати як відносно незалежні виміри психічного функціонування. Переживання зростання не означає автоматичного зменшення страждання та болю, так само як наявність дистресу не виключає можливості позитивних змін. Дослідження показують, що особи, які одночасно усвідомлюють як позитивні, так і негативні наслідки травматичного досвіду, часто демонструють вищий рівень посттравматичного зростання.

У вітчизняному науковому середовищі дослідження посттравматичного зростання набули особливої актуальності починаючи з 2014 року у зв'язку з проведенням антитерористичної операції на сході України. Серед провідних українських науковців цього напрямку слід відзначити Д. Зубовського, В. Килимчука, Г. Лазос, С. Лукомську, Ю. Назара, Т. Титаренко та Н. Харитонову.

Г. Лазос провела ґрунтовне дослідження феномену посттравматичного зростання, систематизуючи термінологічний апарат та аналізуючи провідні теоретичні концепції. Особлива увага приділялась тому, як травматичний досвід перетворюється на позитивні зміни через переосмислення пережитого та зміну життєвих пріоритетів [5].

На думку дослідниці, різні теоретичні підходи до посттравматичного зростання не суперечать, а взаємодоповнюють один одного, створюючи цілісну картину феномену. Г. Лазос переконливо обґрунтувала відмінність між посттравматичним зростанням та резильєнтністю, підкресливши, що зростання передбачає якісні трансформації особистості, які виходять за межі простого відновлення. На основі проведеного аналізу дослідниця визначила ключові орієнтири для практичної роботи з людьми, які пережили травму. Це пошук внутрішніх ресурсів, побудова підтримувальних стосунків у терапії та сприяння особистісному зростанню через переосмислення пережитого досвіду [5].

Т. Титаренко розробила власний підхід до проблеми посттравматичних змін, який вона називає «посттравматичним життєтворенням» [9].

На переконання Т. Титаренко, посттравматичне життєтворення пов'язане з особливостями побудови власного життя після травми, зокрема під впливом військових подій та пандемії COVID-19, що зумовлюють зміни у сприйнятті людиною свого минулого, теперішнього і майбутнього [8].

Т. Титаренко вважає, що важливою умовою посттравматичного життєтворення є здатність людини переосмислювати свій травматичний досвід. Це допомагає їй ставати стійкішою. На її думку, коли людина переосмислює свою

життєву історію, змінюється не лише сам текст історії, а й вона сама. Поступово оновлюється її ідентичність. Дослідниця зазначає, що у такій новій історії виникає зв'язок між минулим, теперішніми травматичними подіями та уявним майбутнім. Коли травма стає усвідомленою частиною власної історії, людина менше залежить від чужих оцінок і очікувань та стає більш самостійною у своїх рішеннях і життєвих виборах [8].

На думку Т. Титаренко до чинників посттравматичного зростання відносяться внутрішні ресурси людини: її оптимізм, що допомагає активно розвиватись навіть у складних обставинах; релігійність та духовність, які допомагають переосмислити життєві події у широкому контексті та знайти нові сенси; оцінка загрози допомагає особистості мобілізувати необхідні ресурси, визначити стратегії подолання та прийняти конструктивне рішення. Важливою також є здатність позитивно переосмислювати подію як процес глибокого самовдосконалення внаслідок переоцінки початкових переконань та перебудови власних уявлень про світ.

Т. Титаренко зазначає, що ефективне подолання наслідків травматичних подій ґрунтується на цілісному переосмисленні пережитого досвіду. Центральне місце в цьому процесі посідає розвиток здатності до позитивної переоцінки складних життєвих ситуацій. Йдеться про вміння бачити в травматичних подіях не лише джерело втрат, а й потенціал для особистісних змін і зростання [9].

У своїй роботі Т. Титаренко використовує поняття «антикрихкості особистості», яке описує, як здатність людини не просто долати травматичні події, а ставати сильнішою завдяки цьому досвіду. Спираючись на ідеї Н. Талеба, вона зазначає, що всередині кожної особистості є частка крихкості та частка антикрихкості. Особистості з вираженою антикрихкістю демонструють вищу здатність до подолання травматичних переживань. Вони не прагнуть відновити стан, який існував до травми, а приймають зміни своїх потреб, внаслідок чого стають психологічно міцнішими [9].

Т. Титаренко розробила концепцію соціально-психологічного супроводу як медіатора особистісного життєтворення, що передбачає відновлення психологічного здоров'я, життєстійкості та покращення стосунків з оточенням [8].

Підхід Т. Титаренко відрізняється від класичної концепції посттравматичного зростання більшим акцентом на активному конструюванні життя та українському контексті воєнної травми.

На думку Т. Титаренко, посттравматичне зростання проявляється у чотирьох ключових вимірах: зміцненні та поглибленні стосунків із близькими; самопізнання; посилення відчуття вдячності за життя; прагнення до самореалізації [9].

В. Климчук, спираючись на аналіз сучасних зарубіжних досліджень, узагальнив наукові підходи до розуміння чинників посттравматичного зростання. Провідне місце серед них посідає когнітивна оцінка травматичного досвіду, зокрема сприйняття людиною рівня загрози та можливості контролю над ситуацією. Результати досліджень свідчать, що позитивне переосмислення пережитого сприяє особистісному зростанню, тоді як прийняття травматичної події створює умови для внутрішніх змін. Оптимістичний погляд на життя суттєво підвищує імовірність зростання після травми, а релігійність та духовність часто виступають додатковою опорою. Саме ці якості допомагають людині знайти глибший сенс у пережитому та інтегрувати його у свій життєвий досвід [4].

Результати емпіричних досліджень свідчать, що травматичні події низької інтенсивності не призводять до глибоких особистісних змін. У таких ситуаціях людина справляється з викликами за допомогою звичних копінг-стратегій. Водночас надмірний рівень стресу може блокувати потенціал зростання. Це зумовлено дезорганізацією системи психологічного подолання. Натомість помірний рівень стресу є найбільш сприятливим для особистісного розвитку. Він ставить під сумнів сформовані уявлення про світ. Водночас особистість зберігає

достатній рівень психологічних ресурсів для їх переосмислення та переоцінки. Це дає змогу сформувати нову, більш цілісну картину реальності.

В. Килимчук наголошує на критичному значенні зовнішніх факторів. Дослідження підтверджують, що підтримка близьких людей відіграє вирішальну роль у процесі зростання, а допомога від громади та держави створює безпечне середовище для одужання. За наявності такої всебічної підтримки психіка отримує необхідні ресурси не лише для відновлення, а й для справжнього посттравматичного зростання. Таким чином, В. Килимчук підкреслює необхідність брати до уваги не лише індивідуальні психологічні фактори, але й соціальний контекст, у якому відбувається процес зцілення після травми [3].

Ранній дорослий вік – це ключовий етап психосоціального розвитку особистості, що охоплює період від 20 до 40 років і характеризується активним входженням у доросле життя, формуванням стабільної ідентичності, життєвої стратегії та системи цінностей. У цей період відбувається реалізація головних життєвих завдань – професійного самовизначення, побудови близьких міжособистісних стосунків, створення сім'ї та закріплення соціальних ролей.

В психологічній науці період ранньої дорослості поділяється на дві послідовні фази розвитку.

Перша фаза триває приблизно від 20 до 30 років. Молода людина перебуває на старті реалізації власних життєвих задумів, намагаючись узгодити свої очікування з реальними можливостями. У цей період людина досягає фізіологічної зрілості, що забезпечує її репродуктивну готовність.

Ранній дорослий вік особистості відзначається активними процесами формування та усвідомлення власної ідентичності. Характерною рисою цього віку є нерівномірний розвиток. Молода доросла людина може спочатку відчувати впевненість у своїх життєвих виборах, згодом проходити через етап сумнівів і переоцінки, а потім знову повертатися до більшої визначеності. Така мінливість є природною, адже особистість у цей період змушена ухвалювати важливі

професійні й особистісні рішення, ще не маючи повністю сформованого уявлення про себе.

За концепцією Д. Левінсона, перша фаза ранньої дорослості характеризується активним пошуком свого місця в житті, особистість ще не визначилась з життєвим вибором, але залишається відкритою до змін. На думку автора, ключовими завданнями цієї фази є здобуття освіти, початок трудової діяльності, встановлення близьких стосунків, формування власної системи цінностей [19].

Друга фаза раннього дорослого віку (30-40 років) характеризується стабілізацією життєвої структури, закріпленням професійного статусу та соціальних і сімейних ролей, зростанням відповідальності й орієнтацією на реалізацію довгострокових цілей [19]. Важливим психологічним новоутворенням цього періоду стає генеративність, що проявляється у турботі про інших, наставництві та активній участі в суспільному житті. Самосприйняття особистості набуває цілісного характеру та інтегрує особистісне, сімейне й професійне Я. Професійна діяльність виступає провідним чинником особистісного зростання та соціального статусу. Попри завершення фізичного розвитку, інтелектуальні можливості продовжують вдосконалюватися, зростає здатність ефективно використовувати наявні ресурси й гнучко реагувати на складні життєві ситуації.

Гендерний аспект посттравматичного зростання (ПТЗ) є надзвичайно цікавою дослідницькою темою. Чоловіки й жінки не просто по-різному переживають травматичні події, вони також по-різному трансформують цей досвід у напрямку особистісного розвитку.

На відміну від біологічної статі, гендер є соціокультурним конструктом. Він охоплює психологічні, соціальні та культурні характеристики, які суспільство традиційно пов'язує з чоловіками та жінками. Саме ці гендерні особливості визначають, яким чином людина справляється з травматичними подіями і як формуються позитивні зміни в її житті після пережитого.

Суттєвий внесок у розуміння гендеру здійснила С. Бем, запропонувавши концепцію андрогінності. У межах цієї концепції маскулінність і фемінність розглядаються не як протилежні полюси однієї шкали, а як відносно незалежні виміри особистості. Відповідно, індивід може одночасно поєднувати маскулінні та фемінні риси, що формує андрогінний тип гендерної ідентичності [14].

На думку С. Бем, виражена гендерна типізація призводить до обмеження поведінкових можливостей особистості. Індивід орієнтується на усталені соціальні норми чоловічої та жіночої поведінки й уникає проявів, які не відповідають цим нормам. У результаті жорстке дотримання гендерних стереотипів зменшує варіативність поведінки та ускладнює вільний вибір способів реагування в різних життєвих ситуаціях.

С. Бем наполягала, що андрогінність має певні психологічні переваги. Андрогінна особистість може гнучко використовувати найкращі якості обох гендерних ролей залежно від конкретної ситуації. Дослідниця вважала, що така андрогінія допомагає людині краще адаптуватися в суспільстві. Численні зарубіжні дослідження підтвердили, що андрогінні особистості демонструють гнучкість у поведінці в різних ситуаціях, мають високу самоповагу, виражену мотивацію досягнення, успішно виконують батьківські обов'язки, задоволені своїми шлюбними стосунками та відчують психологічне благополуччя [12].

Дослідження гендерних відмінностей у проявах посттравматичного зростання демонструють низку цікавих особливостей. Вагоме аналітичне значення має метааналіз, здійснений дослідницькою групою за участю Р. Тедескі та

Л. Калхуна [15]. Узагальнивши результати 70 емпіричних досліджень із загальною вибіркою 16 076 учасників, автори встановили, що жінки загалом демонструють вищі показники посттравматичного зростання порівняно з чоловіками. Водночас виявлено вікову залежність цього ефекту. Зі збільшенням віку респондентів гендерні відмінності посилюються. У вибірках дорослих

старше 35 років різниця між жінками і чоловіками є більш вираженою, ніж у групах осіб віком від 18 до 34 років [15].

Для України, особливо в контексті триваючої війни, гендерні аспекти посттравматичного зростання набувають особливого значення. Так команда вітчизняних науковців у своєму дослідженні встановила суттєві гендерні відмінності у стратегіях подолання травматичного досвіду серед військових і ветеранів війни. Дослідники з'ясували, що жінки і чоловіки раннього дорослого віку по-різному справляються зі стресом і травмами. Жінки зазвичай шукають підтримки у близьких людей і намагаються поділитися своїми переживаннями, зазвичай не приховують своїх емоцій, їм важливо висловитися, поговорити про те, що їх турбує. Тоді як чоловіки частіше або намагаються не думати про проблему взагалі, або намагаються розв'язати її самостійно [10].

В. Зливков та С. Лукомська у своєму дослідженні проаналізували особливості посттравматичного зростання студентів, які переїхали з тимчасово окупованих на підконтрольні Україні території. Загалом у дослідженні взяли участь 86 осіб, з них 42 чоловіка та 44 жінки. Результати показали, що всі учасники демонструють високий рівень посттравматичного зростання. Це свідчить про те, що молодь здатна переосмислювати свій травматичний досвід і знаходити в ньому можливості для власного розвитку. Єдина статистично значуща відмінність між чоловіками та жінками стосується показника нових можливостей, він виявився вищим у чоловіків. Це може вказувати на те, що представники різних гендерних груп по-різному адаптуються до травматичних подій. Варто також звернути увагу на те, що дослідники виявили високий рівень підвищення цінності життя як у чоловіків, так і у жінок, що є важливим показником позитивних змін після пережитої травми [2].

В. Манічева і О. Сидоренко досліджували психологічні особливості представників різних гендерних типів у ранньому дорослому віці [6]. За висновками дослідження, маскулінні чоловіки мають помірну особистісну

тривожність при низькій ситуативній тривожності, низьку комунікативну толерантність і обмежену здатність розпізнавати невербальні сигнали. Жінки маскулінного типу характеризуються високою самооцінкою, низькою особистісною тривожністю, але також зниженою комунікативною толерантністю та перцептивно-невербальною компетентністю.

Чоловіки фемінного типу мають підвищений рівень особистої тривожності. Жінки фемінного типу позитивно себе сприймають, демонструють високу комунікативну толерантність і добре розпізнають невербальні сигнали, однак характеризуються високою особистою тривожністю.

Андрогінні чоловіки показують збалансовані середні показники як особистісної, так і ситуативної тривожності, середній рівень комунікативної толерантності та перцептивно-невербальної компетентності. Жінки андрогінного типу мають помірну тривожність обох типів, їхня комунікативна толерантність коливається від високої до середньої, а перцептивно-невербальна компетентність перебуває на середньому рівні [6].

В. С. Братців під керівництвом В. А. Гупаловської дослідили гендерні особливості посттравматичного зростання на вибірці з 80 учасників (39 чоловіків і 41 жінка). За допомогою кластерного аналізу вони виділили три групи, які відрізнялися за смисложиттєвими орієнтаціями та особистісною силою [1].

Перша група з високими показниками включала приблизно порівну чоловіків і жінок. Ці респонденти демонстрували виражену особистісну силу, внутрішню міцність і здатність приймати самостійні рішення. До другої групи входили переважно жінки з середніми показниками особистісної сили. Третя група складалася здебільшого з чоловіків і мала найнижчі показники як сенсожиттєвих орієнтацій, так і особистісної сили. Дослідження виявило наступну гендерну специфіку ПТЗ: жінки зосереджувалися переважно на розвитку міжособистісних стосунків, тоді як чоловіки надавали більшого значення особистим досягненням [1].

Подальший етап нашого дослідження було спрямовано на організацію та проведення емпіричного дослідження, метою якого є виявлення гендерних особливостей посттравматичного зростання особистості раннього дорослого віку. Для реалізації поставлених завдань сформовано відповідну вибірку респондентів та підібрано комплекс психодіагностичних методик, що дозволяють оцінити рівень посттравматичного зростання у поєднанні з показниками гендерної ідентичності, емоційного стану та ціннісно-смислової сфери особистості.

Мета дослідження. Дослідити посттравматичне зростання особистості раннього дорослого віку у гендерному вимірі.

Матеріал та методи дослідження. У дослідженні взяли участь 30 респондентів віком від 30 до 38 років, що відповідає ранньому дорослому віку. Серед них 18 жінок (60 % від загальної вибірки) та 12 чоловіків (40 % від загальної вибірки). З огляду на складність феномену посттравматичного зростання та потребу дослідити його гендерні особливості, ми обрали чотири психодіагностичні методики, що доповнюють одна одну. Кожна з них дає змогу оцінити окремий аспект психологічного функціонування особистості, а разом вони формують цілісне уявлення про процес посттравматичного зростання:

1. Статеворольовий опитувальник С. Бем;
2. Опитувальник посттравматичного зростання Р. Тедескі та Л. Калхуна;
3. Шкала тривоги Ч. Спілбергера;
4. Методика «Ціннісних орієнтацій» М. Рокича.

Результати дослідження. Для визначення типу гендерної ідентичності було використано статеворольовий опитувальник С. Бем, який дозволяє виявити рівень маскулінності, фемінності та андрогінності особистості. Аналіз отриманих даних дозволив виявити наступний розподіл типів гендерної ідентичності серед респондентів. Дані наведено в табл. 1.

**Розподіл типів гендерної ідентичності за статтю
(Статєво-рольовий опитувальник С. Бем)**

Загальна вибірка n=30, у %			
Тип гендерної ідентичності	жінки (n=18)	чоловіки (n=12)	разом (n=30)
Маскулінний (IS < -1)	–	3 (25,0 %)	3 (10,0 %)
Андрогінний (IS від -1 до +1)	18 (100,0 %)	9 (75,0 %)	27 (90,0 %)
Фемінінний (IS > +1)	–	–	–

Як видно з табл. 1, домінуючим типом гендерної ідентичності у досліджуваній вибірці (n=30) є андрогінний тип, який виявлено у 27 респондентів, це складає 90 % досліджуваних. Це свідчить про те, що більшість учасників дослідження демонструють гармонійне поєднання маскулінних та фемінних психологічних характеристик.

У групі жінок-респонденток спостерігається повна відсутність полярних типів гендерної ідентичності. Всі 18 учасниць (100 %) виявили андрогінний тип, що характеризується збалансованістю або помірною перевагою маскулінних чи фемінних рис.

У групі чоловіків-респондентів виявлено більше різновидів гендерної ідентичності, ніж у жіночій вибірці: 9 осіб (75 % від n=12) виявили андрогінність; 3 респонденти (25 % від n=12) виявили маскулінний тип гендерної ідентичності, що може свідчити про наявність підгрупи чоловіків з вираженою прихильністю до традиційних маскулінних норм поведінки.

Аналіз результатів дослідження за методикою посттравматичного зростання Р. Тадескі та Л. Калхуна, показав, що більшість респондентів демонструють позитивні зміни внаслідок переживання травматичного досвіду.

В табл. 2 наведено аналіз розподілу респондентів жіночої групи за рівнями посттравматичного зростання (див. табл. 2).

Розподіл респондентів за рівнями посттравматичного зростання в жіночій групі (Опитувальник ПТЗ Р. Тадескі та Л. Калхуна)

Жіноча виборка, n=18, %			
Шкала	Низький рівень	Середній рівень	Високий рівень
Ставлення до інших	4 (22,2 %)	14 (77,8 %)	–
Нові можливості	7 (38,9 %)	6 (33,3 %)	5 (27,8 %)
Сила особистості	7 (38,9 %)	9 (50,0 %)	2 (11,1 %)
Духовні зміни	15 (83,3 %)	2 (11,1 %)	1 (5,6 %)
Підвищення цінності життя	3 (16,7 %)	9 (50,0 %)	6 (33,3 %)
Загальний індекс ПТЗ	3 (16,7 %)	12 (66,7 %)	3 (16,7 %)

Результати дослідження жіночої підгрупи (n=18) виявляють наступні особливості посттравматичного зростання: за шкалою «Ставлення до інших» у жінок не зафіксовано високих показників, натомість 77,8 % респонденток (14 осіб з n=18) демонструють середній рівень, що може свідчити про поступові, але стабільні зміни у міжособистісних стосунках.

За шкалою «Підвищення цінності життя» спостерігається найбільша частка високих показників (33,3 %), що підкреслює переоцінку життєвих пріоритетів.

Шкала «Духовні зміни» залишається найменш вираженою (83,3 % з n=18 мають низький рівень). Загальний індекс ПТЗ показує, що більшість жінок – 66,7 % (12 осіб з n=18) перебувають на середньому рівні посттравматичного зростання, демонструючи рівномірний розподіл між низькими (16,7 %) та високими (16,7 %) показниками, що свідчить про різну вираженість процесів посттравматичного зростання в жіночій вибірці.

В табл. 3 наведено аналіз розподілу респондентів чоловічої вибірки за рівнями посттравматичного зростання (див. табл. 3).

Таблиця 3

Розподіл респондентів за рівнями посттравматичного зростання в чоловічій вибірці (Опитувальник ПТЗ Р. Тадескі та Л. Калхуна)

Чоловіча виборка, n=12, у %			
Шкала	Низький рівень	Середній рівень	Високий рівень
Ставлення до інших	3 (25,0 %)	7 (58,3 %)	2 (16,7 %)
Нові можливості	1 (8,3 %)	2 (16,7 %)	9 (75,0 %)
Сила особистості	1 (8,3 %)	11 (91,7 %)	–
Духовні зміни	8 (66,7 %)	4 (33,3 %)	–
Підвищення цінності життя	1 (8,3 %)	6 (50,0 %)	5 (41,7 %)
Загальний індекс ПТЗ	1 (8,3 %)	6 (50,0 %)	5 (41,7 %)

Чоловіча підгрупа (n=12) виявляє помітні відмінності в посттравматичному зростанні порівняно з жінками. Особливо виділяється шкала «Нові можливості», де 9 чоловіків (75,0 % від n=12) показали високі результати, що говорить про їхню готовність змінювати своє життя і шукати нові шляхи після травми.

Цікаво, що за шкалою «Сила особистості» жоден чоловік не потрапив до категорії високих показників, хоча більшість – 11 осіб (91,7 % від n=12) мають середній рівень. Це може означати, що усвідомлення власної внутрішньої сили відбувається у чоловіків поступово.

Духовні зміни також залишаються найменш вираженими (66,7 % від n=12 мають низький рівень), проте чоловіки мають вищі показники за цією шкалою порівняно з жінками (83,3 % від n=18). Загальний індекс ПТЗ показує, що 41,7 % чоловіків досягли високого рівня посттравматичного зростання, що значно перевищує аналогічний показник у жіночій підгрупі та може свідчити про більш інтенсивні процеси посттравматичної трансформації у чоловічій вибірці.

Для наочної візуалізації гендерних особливостей посттравматичного зростання було обрано показники високого рівня за всіма шкалами методики посттравматичного зростання Р. Тадескі та Л. Калхуна (рис. 1).

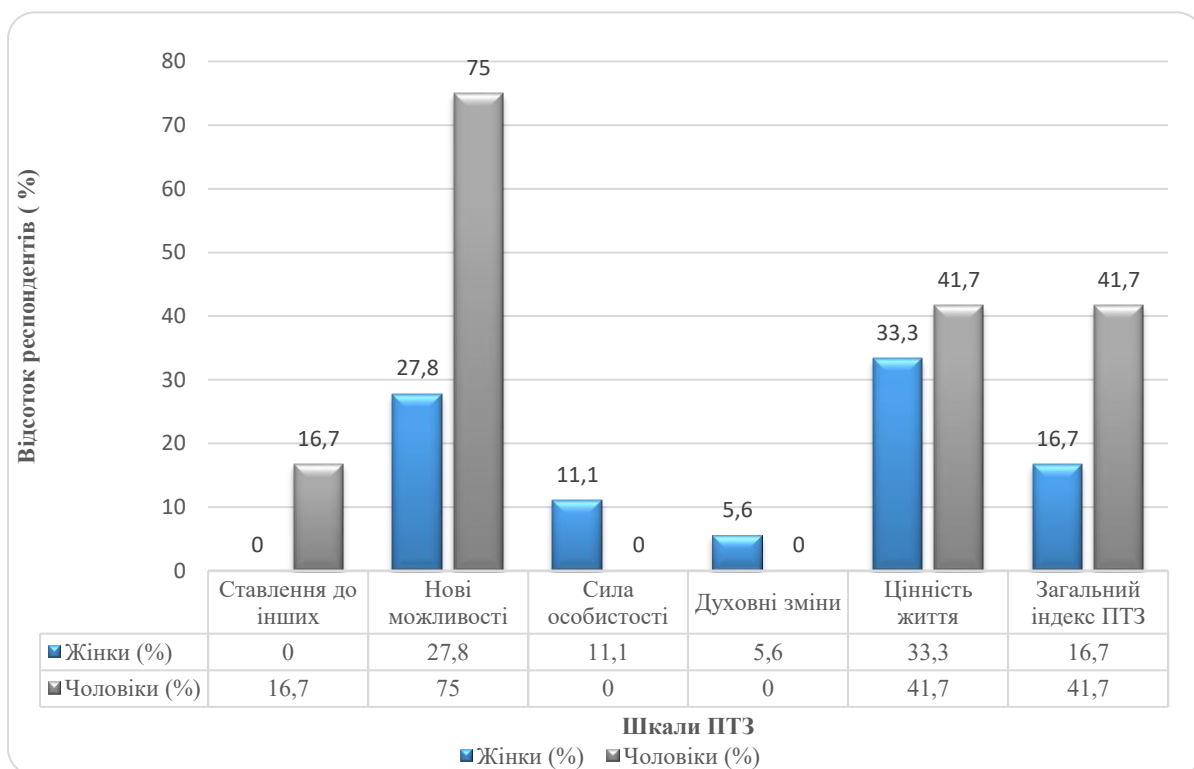


Рис. 1. Порівняння високого рівня ПТЗ у гендерному розрізі за шкалами ПТЗ за методикою Р. Тадескі та Л. Калхуна

Діаграма показує порівняння показників високого рівня особистісного зростання у жінок і чоловіків за всіма шкалами методики посттравматичного зростання Р. Тадескі та Л. Калхуна. Високий рівень обрано для візуалізації, оскільки він найяскравіше демонструє гендерні особливості позитивних особистісних змін після травматичного досвіду. Діаграма наочно показує, що чоловіки частіше досягають високого рівня за шкалою «Нові можливості», тоді як жінки – за шкалою «Підвищення цінності життя». Ця інформація має важливе

значення для розробки диференційованих підходів у психологічній роботі з особами, які пережили травматичні події.

Для дослідження рівня тривожності респондентів було проведено психодіагностичну методику «Шкала тривожності» Ч. Спілбергера, яка дозволяє диференційовано виміряти реактивну (ситуативну) та особистісну тривожність. У табл. 4 наведено зведений аналіз отриманих даних із кількісними та процентними показниками за гендерними групами (див. табл. 4).

Таблиця 4

**Описова статистика показників тривожності за гендерними групами
(методика «Шкала тривожності» Ч. Спілбергера)**

Розподіл респондентів за рівнем реактивної тривожності				
Рівень тривожності	Жінки, n=18	Жінки (%)	Чоловіки, n=12	Чоловіки (%)
Низький	—	—	—	—
Помірний	13	72,2	4	33,3
Високий	5	27,8	8	66,7
Розподіл респондентів за рівнем особистісної тривожності				
Рівень тривожності	Жінки (осіб)	Жінки (%) n=18	Чоловіки (осіб)	Чоловіки (%) n=12
Низький	—	—	—	—
Помірний	13	72,2	8	66,7
Високий	5	27,8	4	33,3

Результати показали цікаві гендерні відмінності. Більшість жінок (13 осіб, 72,2 %) мають помірний рівень реактивної тривожності, і лише у 5 жінок (27,8 %) цей показник високий. У чоловіків картина протилежна: 8 респондентів (66,7 %) демонструють високу реактивну тривожність, а помірну – тільки 4 особи (33,3 %). Тобто чоловіча група нашої вибірки більш схильна гостро реагувати на стресові ситуації. Щодо особистісної тривожності як стійкої індивідуальної риси, то розподіл демонструє наступні результати. В групі жінок-респонденток 13 осіб (72,2 %) мають помірний рівень, 5 осіб (27,8 %) – високий. Серед чоловіків помірну особистісну тривожність виявлено у 8 респондентів (66,7 %), а високу –

у 4 осіб (33,3 %). Загалом, дослідження виявило помітні гендерні особливості у переживанні тривожності. Чоловіки досліджуваної вибірки виявилися більш схильними до високих показників тривожності, особливо реактивної. Цей результат показує, що чоловіки раннього дорослого віку можуть гостріше реагувати на стресові ситуації, ніж прийнято вважати. Окрему увагу слід приділити респондентам із високим рівнем тривожності. Такі показники свідчать про підвищену чутливість до ситуацій оцінювання, невпевненість у власних можливостях і потребу в психологічній підтримці. Для них важливо знизити вплив стресових ситуацій та зміцнити віру у власні сили.

Для вивчення ціннісних орієнтацій респондентів раннього дорослого віку було використано методику «Ціннісних орієнтацій» М. Рокича, яка дозволяє виявити ієрархію термінальних цінностей (життєві цілі) та інструментальних цінностей (засоби їх досягнення). Проаналізуємо ієрархії цінностей за кожною гендерною групою, яка наведена в табл. 5.

Таблиця 5

Ієрархія цінностей у жінок за методикою «Ціннісні орієнтації» М. Рокича

Ранг	Термінальні цінності (цілі) жінки	Термінальні цінності (цілі) чоловіки	Інструментальні цінності (засоби) жінки	Інструментальні цінності (засоби) чоловіки
1	Здоров'я	Щасливе сімейне життя	Відповідальність	Раціоналізм
2	Любов	Свобода	Життєрадісність	Відповідальність
3	Впевненість у собі	Здоров'я	Раціоналізм	Життєрадісність
4	Цікава робота	Любов	Незалежність	Вихованість
5	Свобода	Матеріально забезпечене життя	Ефективність у справах	Незалежність
6	Матеріально забезпечене життя	Активне діяльне життя	Чесність	Ретельність
7	Життєва мудрість	Цікава робота	Акуратність	Освіченість
8	Щасливе сімейне життя	Впевненість у собі	Ретельність	Самоконтроль

Продовження таблиці 5

Ранг	Термінальні цінності (цілі) жінки	Термінальні цінності (цілі) чоловіки	Інструментальні цінності (засоби) жінки	Інструментальні цінності (засоби) чоловіки
9	Активне діяльне життя	Життєва мудрість	Освіченість	Широта поглядів
10	Наявність гарних і вірних друзів	Продуктивне життя	Широта поглядів	Чесність
11	Розвиток	Розвиток	Сміливість у відстоюванні думки	Акуратність
12	Продуктивне життя	Пізнання	Тверда воля	Ефективність у справах
13	Пізнання	Наявність гарних і вірних друзів	Терпимість	Сміливість у відстоюванні думки
14	Суспільне визнання	Розваги	Високі запити	Терпимість
15	Краса природи і мистецтва	Суспільне визнання	Самоконтроль	Чуйність
16	Розваги	Краса природи і мистецтва	Непримиренність до недоліків	Високі запити
17	Щастя інших	Щастя інших	Вихованість	Непримиренність до недоліків
18	Творчість	Творчість	Чуйність	Тверда воля

Отримана ієрархія термінальних цінностей жінок відображає переосмислення життєвих пріоритетів, характерне для осіб, які пережили травматичні події: пріоритетність здоров'я, міжособистісних стосунків, впевненості у собі та професійної самореалізації свідчить про формування нової системи особистісних цінностей, яка поєднує завдання відновлення з основними завданнями раннього дорослого віку.

Отримана структура інструментальних цінностей у жіночій вибірці характеризується пріоритетністю відповідальності, життєрадісності та раціоналізму, що свідчить про орієнтацію жінок на активне саморегулювання поведінки, збереження позитивного емоційного фону та усвідомлене прийняття життєвих рішень у процесі подолання наслідків травматичного досвіду.

Отримана ієрархія термінальних цінностей відображає гендерну специфіку переживання травми у чоловічій вибірці: пріоритетність сімейного життя,

свободи та здоров'я свідчить про переорієнтацію на базові життєві цінності та прагнення до відновлення стабільності через сімейні стосунки.

Отримана структура інструментальних цінностей у чоловічій вибірці відображає гендерну специфіку процесів адаптації після травми: пріоритетність раціоналізму, відповідальності та життєрадісності свідчить про когнітивні стратегії осмислення досвіду та прагнення до емоційної стабілізації. Порівняно з жіночою вибіркою, де відповідальність посіла перше місце, а раціоналізм – третє, у чоловіків спостерігається більша орієнтація на раціональний аналіз ситуації як провідний спосіб подолання травматичного досвіду, що узгоджується з основними завданнями особистісного розвитку в ранньому дорослому віці.

Емпіричні дані дослідження засвідчили наявність гендерних особливостей у проявах посттравматичного зростання та тривожності у особистості раннього дорослого віці. У вибірці ($n=30$) домінує андрогінний тип гендерної ідентичності, що може вказувати на більшу поведінкову гнучкість респондентів у складних життєвих обставинах. Порівняльний аналіз за методикою ПТЗ Р. Тадескі та Л. Калхуна показав, що жінки частіше демонструють високі показники за шкалою «Підвищення цінності життя», тоді як у чоловіків більш вираженими є «Нові можливості» та загальний високий рівень ПТЗ. Водночас у чоловічій групі зафіксовано вищі показники реактивної тривожності, що підкреслює потребу враховувати емоційні реакції на стрес поряд із потенціалом позитивних змін.

Аналіз ціннісних орієнтацій показав, що як чоловіки, так і жінки зосереджуються на основних життєвих цінностях, важливих для раннього дорослого віку, зокрема на збереженні здоров'я, побудові близьких стосунків, досягненні стабільності та особистісній самореалізації. У виборі способів досягнення цих цілей для обох груп провідними є відповідальність, раціональність і життєрадісність. Водночас у чоловіків більш вираженою є орієнтація на раціональне осмислення ситуації як основний спосіб подолання труднощів, тоді як жінки більше уваги приділяють саморегуляції та підтриманню

позитивного емоційного стану. Отримані результати свідчать про доцільність урахування гендерних особливостей у процесі надання психологічної допомоги, зокрема відмінностей у переживанні травми, рівнях тривожності та ціннісно-смысловій сфері особистості.

Список використаних джерел.

1. Братців В. Гендерні особливості посттравматичного зростання / В. Братців, В. Гупаловська. Collection of Scientific Papers: матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. «Scientific practice: modern and classical research methods» (Бостон, США, 22 груд. 2023 р.). 2024. С. 336-339.
2. Зливков В. Л., Лукомська С. О. Соціальна та особистісна мілітарна ідентичність українців в умовах війни. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». 2023. № 3. С. 28-34.
3. Климчук В. О. Посттравматичне зростання та як можна йому сприяти. Наука і освіта. Психологія. 2016. № 5. С. 46-52.
4. Климчук В. О. Психологія посттравматичного зростання: монографія / В. О. Климчук; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. Кропивницький: Імекс-ЛТД, 2020. 125 с.
5. Лазос Г. П. Посттравматичне зростання: теоретичні моделі, нові перспективи для практики / Актуальні проблеми психології: зб. наук. праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. Т. 1 : Організаційна, економічна та соціальна психологія. Вип. 45. 2016. С. 120-126.
6. Манічева В. В. Гендерні особливості конфліктної поведінки у ранньому дорослому віці / Освіта і наука – 2024: зб. наук. пр. учасників звіт.-наук. конф. студентів та аспірантів Ф-ту психології УДУ ім. М. Драгоманова, 9-11 квіт. 2024 р. Київ, 2024. С. 1-2.
7. Назар Ю. О. Концептуальні підходи до розуміння феномену посттравматичного зростання особистості / Психологія і особистість. 2024. № 1 (25). С. 58-98.

8. Титаренко Т. М. Життєстійкість особистості в умовах життєвих криз. *Психологія і суспільство*, 2020. № 4. С. 17-24.
9. Титаренко Т. М. Посттравматичне життєтворення особистості: шляхи відновлення та розвитку / *Психологія і суспільство*. 2020. № 2. С. 9-20.
10. Шинкарук О. А., Андрєєва О.В, Бишевець Н.Г. Гендер і посттравматичний стресовий розлад: науковий погляд на відмінності й засоби подолання військовослужбовцями та ветеранами війни з використанням засобів рухової активності й кіберспорту. *Науковий журнал Національного університету фізичного виховання і спорту України*. 2025. № 1. С. 131-139.
11. Шпонько Д. М. Резильєнтність і посттравматичне зростання як механізми протистояння стресу / *Науково-практична конференція «Особистість у просторі проблем ХХІ століття»*: програма і матеріали, 25 травня 2023 року, Київ, Україна. Київ: Національний університет «Києво-Могилянська академія», 2023. С. 64-65.
12. Холодова С. Вплив гендерних особливостей на формування посттравматичного зростання у особистості раннього дорослого віку: магістерська робота. – Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля. Київ. 2025. 115 с.
13. Франкл В. Людина в пошуках справжнього сенсу: психотерапія і людський досвід у концтаборі / пер. з англ. А. Глухової. Київ: Наш формат, 2017. 200 с.
14. Bem S. L. The measurement of psychological androgyny. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*. 1974. Vol. 42, No. 2. P. 155-162.
15. Gender differences in self-reported posttraumatic growth: A meta-analysis / T. Vishnevsky et al. *Psychology of Women Quarterly*. 2010. Vol. 34, No. 1. P. 110-120.
16. Joseph S., Williams R., Yule W. Changes in outlook following disaster: The preliminary development of a measure to assess positive and negative responses. *Journal of Traumatic Stress*. 1993. Vol. 6, № 2. P. 271-287.

17. Tedeschi R. G., Calhoun L. G. The Posttraumatic Growth Inventory: Measuring the positive legacy of trauma / R. G. Tedeschi, L. G. Calhoun. Journal of Traumatic Stress. 1996. Vol. 9, № 3. P. 455-471.
18. Tedeschi R. G., Calhoun L. G. Posttraumatic growth: Conceptual foundations and empirical evidence. Psychological Inquiry. 2004. Vol. 15, № 1. P. 1-18.
19. Levinson D. J. *The seasons of a man's life*. New York : Alfred A. Knopf, 1978. 363 p.

Особливості сенсомоторного розвитку у дітей дошкільного віку

Мілютіна К. Л.

*Доктор психологічних наук, професор
Академія праці, соціальних відносин і туризму, м. Київ*

Гаврилюк Т. О.

*Здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти
Академія праці, соціальних відносин і туризму, м. Київ*

Актуальність. Незважаючи на значну увагу до сенсомоторного розвитку дітей дошкільного віку, залишається актуальною проблема недостатньої індивідуалізації підходів у сучасних дошкільних закладах. Готовність дитини до школи вимагає не лише базових моторних навичок, а й високого рівня координації, зорово-моторної синхронізації та дрібної моторики, які безпосередньо впливають на успішність навчання. Однак на практиці спостерігається розрив між теоретичними розробками та їх реалізацією: обмежений арсенал діагностичних і корекційних методик, а також недостатня обізнаність педагогів ускладнюють своєчасне виявлення та подолання труднощів у розвитку дитини. Це вимагає поглибленого вивчення особливостей сенсомоторного розвитку та розробки ефективних методів його підтримки в освітньому процесі.

Мета дослідження. Виявити особливості сенсомоторного розвитку дітей дошкільного віку, проаналізувати ефективність сучасних підходів (сенсомоторного, сенсорно-інтегративного, мультисенсорного) та обґрунтувати оптимальні педагогічні умови для формування зорово-моторної координації, просторового сприйняття, грубої та дрібної моторики.

Результати дослідження. Зважаючи на те, що дошкільний вік – найбільш сензитивний період розвитку, важливо максимально розкрити потенціал кожної дитини, адже будь-які нереалізовані можливості у цей час пізніше складно, а інколи і неможливо компенсувати. У цьому контексті, сенсомоторний розвиток (від лат.

sensus -відчуття та motor – рух, координація сенсорних і моторних компонентів діяльності), не є винятком на думку Кучерак І. В. та Грама Н. Г., оскільки за відсутності систематичних корекційно-розвиткових занять або ж їх недостатнього об'єму чи якості, у майбутньому виникатимуть складнощі щодо подальшого навчання і розвитку дитини [9, 3]. Слободян Л. розглядає сенсорний розвиток дитини, як процес становлення відчуттів і сприймань дитини, формування уявлень про форму, колір, розмір та положення предметів у просторі. Він становить фундамент її розумового розвитку. Чуттєве пізнання має виключне важливе значення у дошкільному дитинстві, яке є найбільш сприятливим періодом формування і вдосконалення діяльності органів чуття, нагромадження уявлень про оточуючий світ. Психологічна готовність дитини до шкільного навчання – це один із найважливіших підсумків психічного розвитку особистості в період дошкільного дитинства [12].

З наукової роботи Горелик О. сенсорне виховання – це система педагогічних впливів, спрямованих на формування способів чуттєвого пізнання і вдосконалення відчуттів і сприймань. Сенсорне виховання передбачає спеціальну роботу щодо ознайомлення дітей із сенсорними еталонами, а також спеціальними способами зіставлення якостей предметів, що сприймаються, із засвоєними зразками, тобто способами обстеження предметів. Для виділення певних груп якостей потрібні як прості, так і більш складні (перцептивні) дії [2]. Іноді мозок людини не може впорядкувати отримані сенсорні імпульси, тому уявлення про себе та навколишній світ стають досить невиразними. Мозок неправильно інтерпретує інформацію та не може налаштувати гармонію зовнішнього світу з внутрішнім. Це позначається як на подальшому навчанні, так і на поведінці дитини. Порушення сенсорної інтеграції, витоки яких часто простежуються ще в дошкільному віці, можуть призводити до мовленнєвих проблем, затримок розвитку мовлення, труднощів з читанням та утруднень у відтворенні окремих звуків і складів, що висвітлено

науковцями Bellocchi, S., Muneaux, M., Huau, A., Leveque, Y., Jover, M., Ducrot, S. [15].

Сенсорний розвиток дошкільників є важливою складовою їхнього загального формування, адже у цьому віці відбувається активне становлення сенсорних систем, відповідальних за сприйняття та обробку чуттєвої інформації.

Найбільш ефективним способом стимуляції сенсорного розвитку, за даними фахівців, виступають спеціально організовані реабілітаційні заняття, які проводять кваліфіковані фахівці у сенсорних кімнатах, обладнаних стимулюючими матеріалами для розвитку тактильної, зорової, слухової та рухової чутливості. Особливої уваги заслуговують дидактичні ігри, інтегровані в заняття: вони допомагають закріпити отримані навички, розвиваючи дрібну моторику, увагу та пам'ять. Комплексний підхід, що поєднує роботу в сенсорних кімнатах та ігрові методики, забезпечує не лише корекцію можливих порушень, а й формування стійких навичок саморегуляції та соціальної адаптації.

Сенсорна моторика – це не просто механічне поєднання відчуттів і рухів, а живий, динамічний процес, який допомагає дитині пізнавати світ через дотик, рух і сприйняття. У ранньому дошкільному віці, коли кожен новий жест чи маніпуляція з предметом відкриває для малюка безліч можливостей, саме ця взаємодія формує основу для розуміння простору, форми, кольору та розмірів. Від точних рухів пальців до координованих дій, які готують руку до письма – все це не лише тренування м'язів, а й розвиток мозку, що вчиться аналізувати, запам'ятовувати та концентруватися.

Процес пізнання світу у дошкільному віці тісно пов'язаний із формуванням сенсорних здібностей дитини. На цьому етапі розвитку важливо не лише накопичення уявлень про властивості предметів – колір, форму, фактуру, звук – а й опанування практичних дій, які дозволяють диференціювати та аналізувати ці властивості. Саме таке поєднання теоретичних знань та практичних навичок забезпечує повноцінне сприйняття навколишньої дійсності. З віком у

дошкільників спостерігається підвищення чутливості сенсорних систем: покращується зір, здатність розрізняти відтінки, розвивається слухова та тактильна чутливість. Ці зміни є наслідком активного засвоєння нових способів обстеження предметів, що дозволяє дитині глибше пізнавати їх характеристики та взаємозв'язки.

Зорово-моторна координація – це тонкий механізм, завдяки якому дитина вчиться узгоджувати те, що бачить, з тим, як рухається. Коли малюк намагається влучити олівцем у контур малюнка, ловить м'яч чи складає пазл, його мозок не просто обробляє візуальну інформацію, а й миттєво перетворює її на точні рухи рук, пальців, навіть всього тіла. Цей процес не лише тренує руховий контроль – здатність свідомо керувати своїми діями, – а й формує м'язову пам'ять, яка згодом дозволяє виконувати складні завдання автоматично, не витрачаючи зайвих зусиль на обдумування кожного кроку.

Варто зазначити, що саме через такі вправи дитина не тільки вдосконалює фізичні навички, а й розвиває когнітивні: адже для успішного виконання завдання їй доводиться концентрувати увагу, запам'ятовувати послідовність дій і швидко адаптуватися до змін.

Розвиток аналітичного сприймання у дошкільників передбачає не лише розпізнавання окремих ознак предметів, а й уміння співвідносити їх між собою. Наприклад, дитина може легко визначити колір або форму окремо, але значно складніше їй дається аналіз об'єктів, де ці властивості поєднуються – як у візерунках, природних текстурах чи художніх композиціях.

У повсякденному житті та мистецтві кольори, форми та розміри ніколи не існують ізольовано – вони утворюють складні комбінації, які вимагають від дитини не просто розрізнення, а виділення окремих елементів, порівняння та встановлення зв'язків між ними. Саме тому важливо не обмежуватися вивченням базових ознак, а формувати вміння сприймати їх у контексті, розуміючи, як вони взаємодіють у реальних об'єктах.

Узагальнюючи результати психологічних досліджень, відомий український психолог Г. С. Костюк пише: «Процес сприймання відбувається ефективніше, коли перед дітьми ставляться спеціальні завдання, проводяться спостереження, які спонукають їх придивлятися чи прислухатися до нових об'єктів, виділяти їх характерні ознаки, об'єднувати в єдине ціле, означати певними словами. У таких ситуаціях у дітей швидше розвивається спостережливість, ніж тоді, коли сприймання наочних об'єктів є тільки ілюстрацією готових відомостей, які повідомляє педагог. На думку Стасюк Л. показниками розвитку спостережливості є вдосконалення перцептивного аналізу й синтезу об'єктів, виділення й об'єднання в єдине ціле малопомітних їх ознак і властивостей, підвищення точності словесного їх опису, формування настанови на спостереження» [13].

Нижник Т. О. схиляється до думки, що сенсорна інтеграція – це складний процес, в результаті якого нервова система отримує різного роду інформацію від рецепторів сенсорних систем організму (зорової, слухової, нюхової, смакової, пропріоцептивної, вестибулярної), організує отримані відчуття та надає адекватну відповідь [10, с. 112].

Вивчення психолого-педагогічної літератури виявило існування кількох наукових підходів до розвитку сенсорної інтеграції та корекції її порушень у дітей, зокрема з особливими освітніми потребами. Серед них виділяються сенсомоторний, сенсорно-інтегративний та мультисенсорний підходи, кожен з яких пропонує власні методи роботи із сенсорними системами дитини.

У статті Компанець Н. розглядається проекція проблем розвитку дитини на рівні з навчальною пірамідою С. Шеленберга і М. Вільямса перший фундаментальний рівень навчання спирається на сенсорні системи дитини: пропріоцептивну, вестибулярну, нюхову, зорову, слухову, смакову, тактильну. В цей період організм насичується зовнішніми сенсорними подразниками. На другому сенсомоторному рівні формується орієнтація в схемі свого тіла, просторі, вдосконалюється рівновага, моторне планування. Рухова активність забезпечує

цілісне сприймання предметів, явищ і інтегрує їх у внутрішні відчуття дитини. Саме на цьому етапі чуттєве пізнання формує образне сприймання дійсності [6, с. 65-66].

Заплатинська А. Б. в своїй роботі описує висновки відомого фізіолога І. Сеченова, який наголошував на тому, що кожне сприйняття відбувається на основі чуттєвих даних відчуттів, завдяки цьому з'являються певні образи, якими надалі оперують увага, пам'ять, мислення, почуття, емоції; визнавав роль моторної активності людини в сприйнятті навколишніх явищ. В. Бехтерев відмічав постійні зміни в діяльності центральної нервової системи через постійний вплив на органи чуття зовнішніх і внутрішніх подразників. Про залежність правильного функціонування сенсорних систем і розвитку вищих психічних функцій наголошували в своїх наукових працях О. Запорожець та Л. Виготський [4, с. 49].

З досвіду роботи Кривоніс М. Л., Дроботій О. Л. та експериментального дослідження, спрямованого на виявлення закономірностей розвитку сприймання в онтогенезі, передували розробці системи сенсомоторного розвитку (Б. Ананьєв, Л. Венгер, Л. Виготський, Т. Гіневська, О. Запорожець, В. Зінченко, А. Лурія та ін.). В результаті було встановлено, що розвиток сприймання відбувається шляхом формування перцептивних дій, що зорієнтовані на практичну діяльність людини. У розвиненому сприйманні це є дії обстеження і зіставлення об'єктів із суспільно виробленими мірками – сенсорними еталонами (О. Запорожець). Свого часу, Л. Венгер розробив систему роботи із сенсорного виховання дошкільників, в основі якої закладені два шляхи засвоєння сенсорних еталонів – перцептивний та інтелектуальний [11, с. 5-6].

Серед відомих педагогів, що започаткували систему сенсомоторного розвитку дітей вважають М. Монтессорі. Науковиця спиралася на досвід французьких лікарів Ж. Ітара та Е. Сегена в роботі з дітьми з інтелектуальними порушеннями, де особлива увага приділялась розвитку моторики та органів чуття, що є обов'язковою умовою пізнання оточуючого світу. Система сенсомоторного розвитку М. Монтессорі сприяла не тільки чуттєвому пізнанню дитини, але й

передбачала оволодіння новими засобами предметно-пізнавальної діяльності. Такий підхід значно розширював межі сприймання дитини, розвивав увагу, пам'ять, рухову активність, покращував мисленнєві процеси. Методологічне підґрунтя М. Монтессорі полягає в розробці системи сенсорних вправ та створенні розвивального «педагогічного середовища», яке вирізняється багатством, насиченням дидактичного матеріалу, спрямованим на розвиток сенсорних здібностей дошкільнят. Філософською основою методу М. Монтессорі був особистісно-орієнтовний підхід в організації виховної діяльності з дітьми дошкільного віку, що і досі відповідає сучасній концепції розвитку та є актуальним, що підкреслено в науковій роботі Бадер С. О., Єпіхіна М. А., Гречишкіна І. А. [1].

Сенсомоторний підхід зосереджений на розвитку моторних реакцій, які виникають як відповідь на сенсорні стимули. Такий підхід не лише сприяє формуванню рухових навичок, а й створює необхідні умови для активного пізнання дитиною навколишнього світу. Завдяки цьому дитина не просто сприймає інформацію, а й навчається ефективно взаємодіяти з об'єктами та явищами, що оточують її.

Сенсорний розвиток є фундаментом подальшої пізнавальної діяльності дитини у віці від 3 до 7 років, наголошує Нижник Т. О. Однак, цей процес може утруднювати низька пізнавальна активність дітей. Витоки цієї проблеми лежать в основі недостатньої мотивації до пізнання у різних категорій дітей дошкільного віку, в тому числі і дітей з психофізичними порушеннями. Підґрунтям відсутності поштовху до вивчення навколишнього можуть бути фізіологічні процеси, такі, як органічні ураження ЦНС та мінімальна мозкова дисфункція (ММД), яка проявляється частіше за все в порушенні уваги, пам'яті, сприйманні, розладах мовлення та поведінки. Взаємодія з даною категорією дітей вимагає від педагогів знання не тільки методів та прийомів навчання, але й механізмів порушення сенсорної і мовленнєвої системи дитини [10].

Засновницею класичної концепції сенсорної інтеграції є Джин Айрес (Dr. Jean Ayres). Вона визначала сенсорну інтеграцію як «неврологічний процес, що організує відчуття, як від особистого тіла, так і від зовнішніх подразників, і робить можливим використання тіла в конкретних ситуаціях». Таким чином, її головною задачею було виокремити декілька типів дисфункції у дітей з сенсомоторними труднощами в навчанні та розробити для цих груп відповідні терапевтичні стратегії. Теорія сенсорної інтеграції складається з трьох елементів : теорії (описання процесів, що відбуваються на рівні ЦНС), методів оцінювання сенсорної інтеграції, терапевтичного підходу [14, с. 36].

Метод сенсорної інтеграції охоплює не лише зовнішні (екстероцептивні), а й внутрішні (інтероцептивні) сенсорні системи, забезпечуючи комплексний вплив на сприйняття дитини. Екстерорецептори відповідають за обробку зовнішніх стимулів – зорових, слухових, смакових та тактильних, тоді як інтерецептори реагують на сигнали, що надходять від внутрішніх органів і тканин – стану судин, легень, шлунку, м'язів. Це сприяє не лише кращій адаптації дитини до зовнішніх умов, а й формуванню внутрішньої рівноваги, що особливо важливо для дітей з особливими освітніми потребами.

На відміну від сенсомоторного підходу, який зосереджений на специфічних моторних реакціях та сенсорній стимуляції відчуттів, метод сенсорної інтеграції допускає включення сенсорних відчуттів в контекст свідомих, самостійних, адаптивних форм взаємодії. Акцент робиться на інтеграції вестибулярних, пропріоцептивних та тактильних відчуттів, що потребує спеціального обладнання та прийомів роботи. Зокрема, застосування різних видів гойдалок, спеціальних жилетів та ін., що є відмінною ознакою цього терапевтичного підходу. З статті Bandy A., Shelly J. Lane, Elizabeth A. Murrey. така терапія призводить до росту внутрішньої потреби у дитини відшукувати види діяльності, пов'язані з саморозвитком, що, в свою чергу, сприяє сенсорній інтеграції, [14, с. 48]. Мультисенсорний підхід в організації освітнього процесу в

зкладах дошкільної освіти представлений в Україні технологією І. Карабаєвої «Чую, бачу, роблю». Обов'язковим елементом цієї технології є розвивальне середовище з обладнанням, яке дозволяє поєднання різних стимулів – кольору, запаху, музики, тактильних відчуттів, що забезпечує надходження багатоканальної інформації до дітей та цілісність сприйняття [5].

Світові дослідження останніх років, зокрема в роботі Camarata S., Miller L. J., Wallace M. T., показали нове спрямування у вивченні мультисенсорного підходу на розвиток дитини – появі мультисенсорної інтеграції. Мультисенсорна інтеграція – це розділ сучасної неврології, який вивчає здатність мозку інтегрувати та інтерпретувати вхідні дані від декількох сенсорних систем. Терміни «сенсорна інтеграція» та «мультисенсорна інтеграція» мають різне теоретичне та емпіричне походження, але перебувають у міцному концептуальному зв'язку. Дослідження мультисенсорної інтеграції виявляють односенсорні реакції двох або більше первинних органів чуття (наприклад, зору і слуху) та згодом порівнюють окремі реакції з ефектами, які спостерігаються при об'єднанні вхідних сигналів, тобто, по суті виступають маркерами різних порушень сенсорної обробки. Цей метод може бути використаний у діагностичних цілях для оцінки інтеграції та диференціації впливу різної сенсорної інформації на дітей з психофізичними порушеннями [16].

В епоху розвитку цифрових комунікацій, іноземні науковці Cornelio P., Velasco C., Obrist M. Схиляються до думки, що застосування даної технології носить диджеталізований характер і виглядає як злиття фізичних і цифрових (віртуальних) впливів на мозок. На сьогоднішній день, цифрові стереоскопічні дисплеї стали більш об'ємними, так, що візуальний контент більше не обмежується 2D-екранами, нові тактильні прилади забезпечують тактильну стимуляцію без фізичного контакту, нюхові інтерфейси представляють запахи синхронно з подіями, що відбуваються в віртуальному середовищі, а нові смакові інтерфейси представлені за допомогою левітованих стимулів (принципами

акустики задля доставки смакових відчуттів на язик дитини). На тактильні відчуття, окрім застосування спеціальних рукавичок, можна впливати за допомогою сфокусованого ультразвуку. Такий формат мультисенсорного підходу щодо розвитку сенсорної інтеграції у дітей дошкільного віку є надсучасним, але позитивний вплив такого методу ще недостатньо вивчений і потребує більш змістовних досліджень в цьому напрямку [17].

Висновки. Мультисенсорний підхід виявляється найефективнішим завдяки одночасному залученню різних сенсорних каналів, що забезпечує глибше та повніше сприйняття інформації. Аналіз наукових джерел підтверджує, що всі методи сенсорної інтеграції впливають на підкоркові структури мозку, оптимізуючи роботу центральної нервової системи та сприяючи психомоторному прогресу. Поліпшення сенсорної обробки позитивно позначається на мотивації дитини, розвитку вищих психічних функцій та формуванні її впевненості. Комбінування різних підходів особливо актуальне в умовах інклюзивної освіти, де важливо враховувати індивідуальні особливості кожного дошкільника. Перспективи подальших досліджень пов'язані з уточненням діагностичних критеріїв, розробкою методів оцінювання сенсорної інтеграції та створенням ефективних педагогічних умов для її розвитку. Сенсорне виховання, як фундамент навчальної готовності та соціальної адаптації, розвиває моторику, сприйняття, координацію, контроль рухів та пам'ять. Індивідуалізація навчання та акцент на активному чуттєвому пізнанні сприяють формуванню аналітичного сприйняття, уваги, мислення та пам'яті, а спеціально розроблені завдання підвищують спостережливість і точність словесного опису, створюючи міцну основу для подальшого пізнавального розвитку дитини.

Список використаних джерел.

1. Бадер С. О., Єпіхіна М. А., Гречишкіна І. А. Взаємодія закладів дошкільної освіти з родинами дітей раннього віку на засадах монтессорі-педагогіки. Науковий вісник ужгородського університету. серія: «педагогіка.

соціальна робота». 2025. № 2 (57). С. 1-5. URL: <http://visnyk-ped.uzhnu.edu.ua/article/view/342551>

2. Горелик О. Сенсорне виховання та його вплив на гармонійний розвиток дітей старшого дошкільного віку. Формування життєвої компетентності осіб з особливими освітніми потребами в системі позашкільної, спеціальної та інклюзивної освіти. Збірник наукових праць. 2024. С. 37-41. URL: <https://dspace.hnpu.edu.ua/server/api/core/bitstreams/d13bfbe6-a69c-4c0c-a9b9-44001389b5ba/content>

3. Грама Н. Г. Сенсорний розвиток дітей раннього віку: теорія і практика : монографія / Н. Г. Грама; Державний заклад «Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського». Одеса. 2018. 239 с. URL: [http://dspace.pdpu.edu.ua/bitstream/123456789/2024/1/Sensory %20Development.pdf](http://dspace.pdpu.edu.ua/bitstream/123456789/2024/1/Sensory%20Development.pdf)

4. Заплатинська А. Б. Становлення поняття «сенсорна інтеграція» у корекційній педагогіці. Корекційна та соціальна педагогіка і психологія. 2023. С. 48–57.

5. Карабаєва І. І. Інтелектуально обдаровані дошкільнята: підтримка та супровід / І. І. Карабаєва, А. В. Пасічник // – К. : Шкільний світ, 2011. – 128 с.

6. Компанець Н. Проекція проблем розвитку дитини на рівні піраміди навчання Вільямса та Шеленбергера. Особлива дитина: навчання і виховання. 2017. № 1. С. 60–69.

7. Кучерак І. В. Інноваційна складова підготовки майбутніх логопедів: досвід та перспективи // Розвиток освіти і науки: проблеми, теорія, досвід і перспективи: матер. II заоч. Всеукр. наук.-практ. конф. Електронне видання / за ред. В. Ф. Русакова, І. М. Зарішняк. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2021. 224 с. 222 с., с. 202-204.

8. Кучерак І. В. Інноваційна складова підготовки майбутніх логопедів: досвід та перспективи // Розвиток освіти і науки: проблеми, теорія, досвід і перспективи: матер. II заоч. Всеукр. наук.-практ. конф. Електронне видання / за

ред. В. Ф. Русакова, І. М. Зарішняк. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2021. 224 с. 222 с., с. 202-204.

9. Кучерак І. В. Сенсомоторний розвиток онлайн дітей-білінгвів дошкільного віку зі стертою дизартрією. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2023. № 89. С. 1-4.

10. Нижник Т. О. Підходи щодо розвитку та корекції сенсорної інтеграції у дітей дошкільного віку. Інноваційна педагогіка. Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій. 2023. Т. 1, № 56. С. 111-116. URL: <https://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/13178/1/Титулка%20%20Євгенія%20Дементьєва.pdf>

11. Сенсорний розвиток: з досвіду роботи. 3-4 роки/ упоряд. Кривоніс М. Л., Дроботій О. Л. та ін.. Харків: Ранок, 2022. 240 с.

12. Слободян Л. Особливості розвитку сенсорики у дошкільників з розумовою відсталістю. Актуальні питання корекційної освіти. Педагогічні науки. 2024. Вип. 4. С. 323-330.

13. Стасюк Л. Теоретичні аспекти розвитку дітей дошкільного віку з особливими потребами. Педагогічний часопис Волині. 2015. С. 75-80.

14. Bandy A., Shelly J. Lane, Elizabeth A. Murrey. Sensory Integration: theory and practice. 2nd ed. Philadelphia: F. A. Davis, 2002. 496 p.

15. Bellocchi, S., Muneaux, M., Huau, A., Leveque, Y., Jover, M., Ducrot, S. Exploring the link between visual perception, visual-motor integration, and reading in normal developing and impaired children using DTVP-2. Dyslexia, 23 (3), 2020. pp. 296-315.

16. Camarata S., Miller L. J., Wallace M. T. Evaluating Sensory Integration/Sensory Processing Treatment: Issues and Analysis. Fronter in Integrative Neuroscience. 2020. Vol. 14. P.

17. Cornelio P., Velasco C., Obrist M. Multisensory Integration as per Technological Advances: a review. Fronter in Integrative Neuroscience. 2021. Vol. 15. P. 1-14. URL: <https://doi.org/10.3389/fnins.2021.652611>.

Стійкість до стресу та її вплив на рівень психологічного благополуччя у працівників фармацевтичних компаній під час війни

Мілютіна К. Л.

*Доктор психологічних наук, професор
Академія праці, соціальних відносин і туризму, м. Київ*

Кулик О.П.

*Здобувач другого(магістерського) рівня вищої освіти
Академія праці, соціальних відносин і туризму, м. Київ*

Актуальність. Повномасштабна війна в Україні створила унікальний за інтенсивністю та тривалістю контекст стресового впливу, який поєднує загрози фізичній безпеці, вимушені зміни способу життя, фінансову нестабільність, розрив соціальних зв'язків, інформаційну перенасиченість та постійну невизначеність. У таких умовах стрес перестає бути короткотривалою реакцією на окремі події та набуває рис хронічного процесу, що впливає на психічне здоров'я, працездатність і якість життя.

Працівники фармацевтичних компаній становлять професійну групу, для якої воєнний період пов'язаний не лише з загальними стресорами, але й зі специфічними професійними викликами: забезпеченням безперервності ланцюгів постачання, підтриманням стандартів якості, комунікацією із медичною спільнотою та населенням, роботою в умовах дефіциту, перебудовою операційних процесів, ризиками для персоналу та корпоративної інфраструктури. Високий рівень відповідальності, обмеження часу, необхідність швидких рішень та моральні дилеми (наприклад, пріоритизація поставок, робота під час повітряних тривог) підсилюють напруження і створюють передумови для зниження психологічного благополуччя [5, с. 1092–1096].

Водночас кризові умови актуалізують роль психологічних ресурсів – насамперед стійкості до стресу – як здатності зберігати ефективність діяльності, емоційну рівновагу та позитивне функціонування, попри значні навантаження.

Розуміння того, як саме стресостійкість пов'язана з психологічним благополуччям, є важливим як для теорії клінічної психології, так і для практики організаційної підтримки персоналу в критичній інфраструктурі. Стаття присвячена теоретичному обґрунтуванню такого дослідження та опису його методичного дизайну [7, с. 515–520]. Актуальність теми визначається сукупністю соціальних, професійних та клініко-психологічних чинників. По-перше, воєнний період супроводжується зростанням поширеності тривожних і депресивних симптомів, соматизації, порушень сну, професійного вигорання, що безпосередньо впливає на продуктивність праці та безпеку процесів у сферах, пов'язаних із охороною здоров'я [4, с. 606–610].

По-друге, працівники фармацевтичних компаній є ключовою ланкою системи забезпечення медичної допомоги: зниження їх психологічного благополуччя може позначатися на якості управлінських і операційних рішень, взаємодії у командах, дотриманні протоколів, а отже – на доступності та безпечності лікарських засобів.

По-третє, саме поняття «психологічного благополуччя» в сучасній науці виходить за межі «відсутності симптомів» і включає позитивні показники функціонування – енергійність, інтерес до життя, відчуття сенсу, здатність підтримувати соціальні зв'язки, задоволення діяльністю. Для фармацевтичних працівників, які працюють у режимі постійних змін, збереження таких показників є критичним для стійкості організацій і людського капіталу.

По-четверте, у вітчизняному науковому просторі недостатньо досліджень, присвячених саме фармацевтичній галузі у воєнному контексті: переважно увага зосереджується на військових, медичних працівниках, волонтерах. Отже, розширення емпіричної бази щодо працівників фармацевтичних компаній має як наукову, так і практичну цінність.

Теоретичні підходи до розуміння стресу. Класичний фізіологічний підхід Г. Сельє трактує стрес як неспецифічну реакцію організму на вимоги середовища,

описуючи загальний адаптаційний синдром (тривога – резистентність – виснаження). Для психологічного аналізу важливо, що тривале перебування на стадії резистентності за відсутності відновлення ресурсів підвищує ризик виснаження, що проявляється зниженням працездатності, емоційною лабільністю та соматичними скаргами [6, с. 112–118].

Когнітивно-оцінювальний підхід Р. Лазаруса і С. Фолкман акцентує роль первинної та вторинної оцінки: людина оцінює значущість події (загроза/виклик/втрата) та власні ресурси для подолання. У цій логіці стрес є не лише «подією», а результатом взаємодії між вимогами середовища і доступними ресурсами, а отже може бути модифікований через зміни в оцінці, копінгу, підтримці, навичках саморегуляції [2, с. 54–58].

Ресурсний підхід (зокрема теорія збереження ресурсів С. Хобфолла) розглядає стрес як наслідок втрати ресурсів, загрози втрати або недостатнього приросту ресурсів після інвестицій. У воєнному контексті втрати можуть бути багаторівневими: матеріальні, соціальні, часові, емоційні, статусні. Для працівників фармацевтичних компаній значущою є також «ресурсна» складова організації – чіткість процедур, підтримка керівництва, доступ до безпечних умов праці, передбачуваність змін.

У сучасній психології підкреслюється багатовимірність стресу: розрізняють гострий, хронічний, травматичний стрес; професійний стрес; стрес, пов'язаний із моральними дилемами. Це особливо важливо для аналізу праці в критичних галузях, де людина може бути одночасно під впливом зовнішніх загроз і внутрішньоорганізаційних навантажень.

Стійкість до стресу: структура та механізми. Стійкість до стресу (стресостійкість) доцільно розглядати як інтегративний ресурс, що включає:

(1) емоційно-регуляторний компонент (здатність стабілізувати емоційні реакції, відновлювати рівновагу, толерувати невизначеність);

(2) когнітивний компонент (гнучкість мислення, реалістична оцінка ситуації, здатність до планування та переоцінки) [2, с. 54–58].

(3) мотиваційно-смісловий компонент (наявність значущих цілей, відчуття професійної місії, внутрішня мотивація);

(4) поведінковий компонент (ефективні копінг-стратегії, навички самоорганізації, використання підтримки);

(5) соціальний компонент (мережа підтримки, довіра до команди, якість комунікації).

З позицій клінічної психології важливо підкреслити, що стресостійкість не означає «відсутність переживань». Йдеться про здатність переживати складні емоції без дезорганізації, зберігати функціонування і поступово відновлюватися.

Механізми стійкості включають навички емоційної регуляції (наприклад, усвідомлене дихання, відтермінування імпульсивних реакцій), когнітивну переоцінку (перехід від катастрофізації до планування), підтримувальні соціальні взаємодії та здорові поведінкові стратегії (сон, режим, фізична активність) [2, с. 54–58].

У воєнному контексті особливої ваги набуває компонент толерантності невизначеності та здатності діяти за неповної інформації, що прямо стосується операційних процесів фармацевтичних компаній. Також зростає значущість моральної стійкості – здатності зберігати професійні та етичні стандарти, попри дефіцит і тиск часу. Саме ці компоненти можуть бути пов'язані з більш високим рівнем благополуччя.

Психологічне благополуччя: концепції та операціоналізація. Психологічне благополуччя в сучасній науці описується в межах двох основних традицій. Гедоністичний підхід фокусується на переживанні позитивних емоцій, задоволеності життям та балансі афектів. Евдемоністичний підхід (К. Ріфф) підкреслює позитивне функціонування: самоприйняття, автономію, особистісне зростання, цілеспрямованість, позитивні стосунки, контроль над середовищем.

Для прикладних досліджень у професійних групах важливі короткі та валідні інструменти. Індекс благополуччя ВООЗ-5 (WHO-5) оцінює суб'єктивне відчуття благополуччя через п'ять тверджень про енергійність, життєвий тонус, інтерес, спокій та відпочинок. Це скринінговий інструмент, який широко застосовується у клінічних і популяційних дослідженнях. Його перевага – чутливість до змін емоційного стану та можливість швидкого використання в організаціях.

Психологічне благополуччя працівників у воєнний час доцільно розглядати як результат взаємодії індивідуальних ресурсів (стресостійкість, копінг, смислотворення) та організаційних умов (підтримка керівництва, ясність ролей, безпечне середовище, справедливість, якість комунікації). Отже, у дослідженні важливо не лише зафіксувати рівень благополуччя, а й інтерпретувати його в контексті наявних ресурсів і навантажень.

Професійні стресори у фармацевтичних компаніях під час війни. Професійний стрес працівників фармацевтичних компаній у воєнний період має кілька рівнів.

Організаційний рівень включає: нестабільність постачання, зміни у ланцюгах логістики, нерівномірність попиту, обмеження часу на планування, необхідність швидкої адаптації до нових регуляторних і безпекових вимог, переведення частини процесів у віддалений формат та одночасне забезпечення якості.

Рівень взаємодії із зовнішніми стейкхолдерами включає комунікацію з медичними закладами, аптеками, пацієнтами, волонтерськими структурами, а також роботу з претензіями й очікуваннями в умовах дефіциту. Це може супроводжуватися емоційним тиском, агресивними комунікаціями, відчуттям відповідальності за наслідки затримок або нестачі препаратів.

Індивідуальний рівень включає загрозу обстрілів, повітряні тривоги, перебої з електроенергією, проблеми з транспортом, тривогу за близьких,

інформаційне перевантаження та накопичену втому. Для частини працівників додаються фактори переміщення, зміни місця проживання, порушення соціальної підтримки. Усе це підсилює ризик хронічного стресу та зниження благополуччя.

Отже, саме у цій професійній групі стресостійкість може виступати «буфером», що пом'якшує негативний вплив стресорів на благополуччя. Емпіричне дослідження має уточнити, наскільки вираженим є цей зв'язок і які практичні рекомендації можна запропонувати організаціям.

Методологічні засади дослідження. У відповідності до методичних рекомендацій щодо кваліфікаційних робіт, підготовка теоретичної частини передбачає обґрунтування актуальності теми, постановку мети і завдань, визначення об'єкта і предмета та вибір методів (методик) дослідження.

У статті ці компоненти структуровано як методологічна основа майбутнього емпіричного етапу [9, с. 18–22].

Мета дослідження. Теоретично та емпірично вивчити вплив стійкості до стресу на рівень психологічного благополуччя у працівників фармацевтичних компаній під час війни.

Гіпотетичне припущення (для подальшого емпіричного етапу): вищий рівень стійкості до стресу асоційований з вищим рівнем психологічного благополуччя (WHO-5).

Методи дослідження. Для досягнення мети використовується комплекс теоретичних та емпіричних методів. Теоретичний блок включає аналіз, синтез, узагальнення та систематизацію наукових джерел. Емпіричний блок передбачає застосування двох стандартизованих інструментів:

1) Опитувальник «Стійкість до стресу». Методика дозволяє оцінити індивідуальні відмінності у здатності протистояти стресовим впливам, емоційну врівноваженість, здатність до саморегуляції та адаптації. Використання цього опитувальника відповідає предмету дослідження, оскільки надає кількісний показник ключової незалежної змінної.

2) Індекс благополуччя ВООЗ-5 (WHO-5). Інструмент є лаконічним, валідним і придатним для скринінгових оцінок благополуччя у дорослих. WHO-5 відображає позитивні аспекти суб'єктивного функціонування, що дозволяє дослідити залежну змінну – психологічне благополуччя.

Вибір саме цих методик зумовлений їхньою практичною зручністю, стандартизованістю, чутливістю до змін емоційного стану та можливістю проведення статистичного аналізу. Для обробки даних планується застосування описової статистики (середні, медіани, стандартні відхилення), перевірки нормальності розподілу та кореляційного аналізу (Пірсона або Спірмена залежно від умов). За потреби може бути використана лінійна регресія для оцінки внеску стресостійкості у варіацію благополуччя [2, с. 54–58].

Вибірка: 70 працівників фармацевтичних компаній, що відповідає мінімальним рекомендаціям щодо емпіричних досліджень у психології та дозволяє отримувати статистично інформативні результати для кореляційного аналізу. Додатково планується зібрати соціально-демографічні дані (вік, стать, стаж, посада, формат роботи) для опису вибірки та контролю потенційних впливів.

Етичні засади та організаційні аспекти. Проведення опитування передбачає дотримання принципів добровільності участі, інформованої згоди, конфіденційності та анонімності.

Респондентам надається коротке пояснення мети дослідження, гарантії нерозголошення персональних даних та право відмовитися від участі на будь-якому етапі без негативних наслідків. Під час презентації результатів виключається будь-яка інформація, що може ідентифікувати конкретних осіб або компанії.

З огляду на воєнний контекст, важливо мінімізувати потенційне повторне переживання травматичного досвіду. Тому інструменти відбираються таким чином, щоб не містити прямих запитань про травматичні події, а фокусуватися на

загальному стані та ресурсах. За необхідності респондентам буде надано інформацію про доступні ресурси психологічної підтримки (корпоративні програми, консультативні служби, контакти психологів).

Практична значущість очікуваних результатів. Очікувані результати мають потенційну практичну цінність для кількох рівнів. На рівні організаційного управління вони можуть бути основою для формування програм підтримки персоналу: тренінгів стрес-менеджменту, навчання навичкам саморегуляції, розвитку психологічної безпеки в командах, покращення комунікації та запобігання вигоранню.

На рівні клінічної психології результати можуть сприяти ранньому виявленню груп ризику (низьке благополуччя за WHO-5) та побудові профілактичних маршрутів допомоги. На рівні соціальної політики та професійних стандартів дані можуть підсилити аргументацію щодо необхідності системної підтримки працівників критичних галузей в умовах тривалих криз.

Таким чином, дослідження має не лише теоретичну, а й прикладну спрямованість, відповідає актуальним потребам практики та може бути використане для формування рекомендацій у фармацевтичних компаніях.

Висновки. Теоретико-методологічний аналіз засвідчує, що в умовах війни працівники фармацевтичних компаній перебувають під впливом комплексу професійних і загальносоціальних стресорів, які підвищують ризики зниження психологічного благополуччя. Стійкість до стресу розглядається як інтегративний ресурс, що включає емоційну регуляцію, когнітивну гнучкість, смислотворення, копінг-стратегії та соціальну підтримку і може виконувати буферну функцію щодо негативного впливу стресу на благополуччя [2, с. 54–58]. Запропонований дизайн майбутнього емпіричного дослідження (N=70) із застосуванням опитувальника «Стійкість до стресу» та WHO-5 є методично обґрунтованим і дозволить оцінити характер зв'язку між стресостійкістю та психологічним благополуччям. Отримані результати можуть стати підґрунтям для розроблення

практичних програм психологічної підтримки персоналу фармацевтичних компаній у період війни.

Список використаних джерел.

1. Сельє Г. Стрес без дистресу. Київ : Основи, 2002. 256 с.
2. Lazarus R. S., Folkman S. Stress, Appraisal, and Coping. New York : Springer, 1984. 445 p.
3. Weathers F. W. et al. The PTSD Checklist for DSM-5 (PCL-5). Journal of Traumatic Stress. 2013.
4. Kroenke K., Spitzer R. L., Williams J. B. The PHQ-9. Journal of General Internal Medicine. 2001.
5. Spitzer R. L. et al. The GAD-7. Archives of Internal Medicine. 2006.
6. Antonovsky A. Health, Stress, and Coping. San Francisco : Jossey-Bass, 1979.
7. Hobfoll S. E. Conservation of Resources. American Psychologist. 1989.
8. Miner A. S. et al. Smart Technologies for Mental Health Assessment. npj Digital Medicine. 2019.
9. Методичні рекомендації до підготовки та захисту кваліфікаційних робіт Київ, 2025.

Вибір копінг-стратегії приватними підприємцями в умовах стресостійкості

Мошенский В.С.

Кандидат технічних наук

Академія праці, соціальних відносин і туризму, м. Київ

Годунов В.Ю.

Здобувач другого(магістерського) рівня вищої освіти

Академія праці, соціальних відносин і туризму, м. Київ

Актуальність. У сучасному суспільстві практично неможливо уявити життєдіяльність людини поза постійним впливом стресогенних чинників. Наукові дослідження засвідчують, що ключова проблема полягає не стільки у самому феномені стресу, скільки у його багатоманітності, яка проявляється за джерелами виникнення, тривалістю, інтенсивністю та специфікою психофізіологічних реакцій. Додатковим ускладнюючим фактором виступає безперервне прагнення людства до соціально-економічного та технологічного прогресу, що значно обмежує можливості точного прогнозування появи й розвитку стресових станів. Унаслідок цього формується широкий спектр їхніх проявів – професійний, інформаційний, комунікативний та інші. Відтак, особливої актуальності набуває дослідження феномену стресостійкості як здатності індивіда протидіяти негативному впливу стресогенних факторів та запобігати формуванню патологічних станів [1-5]. У сучасних умовах приватні підприємці різних галузей економіки відіграють провідну роль, оскільки їхня професійна затребуваність безпосередньо корелює з рівнем конкурентоспроможності. Остання розглядається як інтегральна характеристика фахівця, що поєднує компетентність, гнучкість, здатність до швидкої адаптації та ефективного вирішення професійних завдань. Формування конкурентоспроможності значною мірою детермінується розвитком особистісних якостей, які забезпечують постійне вдосконалення професійної майстерності та реалізацію внутрішнього потенціалу. Серед таких якостей особливе місце посідає стресостійкість, що визначає

здатність індивіда протистояти численним стресогенним впливам як у професійній діяльності, так і в особистому житті [6-9].

Актуальність дослідження зумовлена тим, що підприємницька діяльність потребує не лише високого рівня професійної компетентності, а й специфічних психологічних характеристик, серед яких стресостійкість виступає однією з ключових. Попри високий попит на підприємців, рівень конкуренції у бізнес-середовищі залишається значним. Крім того, сучасна підприємницька практика передбачає не лише створення якісного продукту, а й ефективне управління командою, що забезпечує його реалізацію. Досягнення успіху в цих умовах можливе лише за наявності стійких психологічних якостей, які дозволяють підприємцю досягати професійних цілей навіть у складних та непередбачуваних ситуаціях. Таким чином, стресостійкість може бути визначена як інтегральна характеристика психічного розвитку особистості, що формується у процесі онтогенезу на основі генетично зумовлених індивідуальних властивостей у контексті конкретного соціального середовища. Як інтегративна властивість вона передбачає взаємодію з усіма структурними компонентами психіки як у момент дії стресогенних факторів, так і після їхнього завершення [1-9].

Мета дослідження. Виявити психологічні особливості впливу стресостійкості особистості на вибір копінг-стратегії. *Методи дослідження.* Емпіричне дослідження впливу стресостійкості на вибір копінг-стратегії приватних підприємців було проведено на вибірці, яка склала 56 приватних підприємців. Середній вік опитуваних – 28,6 років, середній стаж роботи приватним підприємцем – 5,5 років. Емпіричне дослідження проводилося у три етапи. На першому, підготовчому етапі, було підібрано пакет психодіагностичних методик. Укладений психодіагностичний інструментарій включав наступні методики: шкала організаційного стресу Д. Макліна; методика «Копінг-стратегії в стресових ситуаціях» С. Нормана, Д. Ендлера, Д. Джеймса, М. Паркера; методика «Проактивні стратегії копінг-поведінки» Е.Грінгласа, Р.; методика «Стилі гумору» Р. Мартіна.

Результати дослідження. Для приватних підприємців у цілому характерна середня стрес-толерантність або стресостійкість і схильність до поведінки типу «АБ» (71,4 %). Даний тип поведінки відрізняє активна і цілеспрямована діловитість, вміння збалансувати ділову активність, напружену роботу зі зміною занять і вміло організованим відпочинком, різнобічність інтересів. Приватні підприємці типу «АБ» не показують явну схильність до домінування, але в певних ситуаціях і обставинах впевнено беруть на себе роль лідера; для них характерна емоційна стабільність і передбачуваність в поведінці, відносна стійкість до дії стресогенних чинників, добра пристосованість до різних видів діяльності. У 8,9 % опитуваних спостерігається низька стрес-толерантність і схильність до поведінки типу «А». Люди типу «А» здатні до тривалої боротьби за досягнення мети при істотному зовнішньому опорі, схильні до суперництва. Для них типові діяльність «на знос» і невміння відпочивати, відчуття постійної нестачі часу, високі рівні ворожості і відкритої агресії при спілкуванні з іншими особами. Дослідники виділяють такі аргументи на користь позитивних властивостей поведінки типу «А», як високі здібності до досягнення цілей і паралельного виконання багатьох видів роботи. Для 19,7 % респондентів характерна висока стрес-толерантність і схильність до поведінки типу «Б» – «іммунного» типу поведінки. Люди даного типу поведінки характеризуються менш інтенсивною життєвою активністю, вони вміють чергувати роботу і відпочинок, добре порівнюють свої життєві устремління і наявні у них для цього можливості.

За методикою «Копінг-стратегії в стресових ситуаціях» С. Нормана, Д. Ендлера, Д. Джеймса, М. Паркера 75,0 % приватних підприємців виявлено високий рівень проблемно-орієнтованої копінг-стратегії. Дана копінг-стратегія є продуктивною і спирається на когнітивні (пізнавальні) ресурси. Проблемно-орієнтована копінг-стратегія спрямована на раціональний аналіз проблеми та пов'язана зі створенням, а так само виконанням плану вирішення важкої ситуації. Використання даної копінг-поведінки підвищує відчуття міри контролю над ситуацією і, як наслідок, знижує рівень негативних емоцій. Високий рівень емоційно-орієнтованої копінг-стратегії мають 12,5

% приватних підприємців. Емоційно-орієнтована копінг-стратегія – ця стратегія долаючої поведінки заснована на позитивній переоцінці ситуації, пошуку позитивних моментів, зниженні і знеціненні значущості подій. Вона пов'язана з емоційною сферою. Емоційно-орієнтована копінг-стратегія, на думку більшості дослідників, не є продуктивною, проте в деяких випадках допомагає впоратися зі стресовою ситуацією.

У 8,9 % приватних підприємців виявлено високий рівень вираженості стратегії, орієнтованої на уникнення. Копінг-стратегія, орієнтована на уникнення – багатьма дослідниками розглядається як непродуктивна стратегія і характеризується як спрямованість зусиль на втечу, уникнення чи відхід від проблеми. Проте, потрібно відзначити, що бажання піти від вирішення виниклих труднощів у деяких випадках може бути адаптованою реакцією. Це стосується, наприклад, конфліктних ситуацій, коли активна поведінка в виниклих обставинах може тільки погіршити ситуацію і привести до ще більших негативних наслідків. Тому стратегія уникнення також може бути продуктивною. Але в разі тривалих конфліктів вона буде непродуктивною. Високий рівень копінг-стратегії «відволікання» спостерігається у 1,8 % респондентів даної вибірки. Копінг-стратегія «відволікання» характеризується як спрямованість зусиль на відділення від ситуації і зниження її значущості. Схильність відмовлятися від пов'язаної зі стресами активності, відволікатися від ситуацій. Так само, слід зазначити, що в деяких випадках дана стратегія допомагає впоратися зі стресовою ситуацією. Для 1,8 % приватних підприємців даної вибірки характерний високий рівень копінг-стратегії «пошук соціальної підтримки». Дана стратегія багатьма дослідниками однозначно не оцінюється як продуктивна або непродуктивна. Ця копінг-стратегія спрямована на пошук інформаційної, предметної та емоційної підтримки від інших людей.

За допомогою методики «Проактивні стратегії копінг-поведінки» Е.Грінгласа, Р. Шварцера і С.Тауберта у 42,9 % приватних підприємців виявлено високий рівень стратегії «проактивне подолання». Проактивне подолання – це

процес визначення мети, тобто постановка важливих для особистості цілей, а також процес саморегуляції по досягненню цих цілей, що включає когнітивну і поведінкову складові. Суть проактивного подолання полягає в зусиллях по формуванню загальних ресурсів, які сприяють досягненню важливих цілей і сприяють особистісному зростанню. У 17,9 % приватних підприємців спостерігаємо високий рівень стратегії «рефлексивне подолання». Рефлексивне подолання – уявлення і роздуми про можливі поведінкові альтернативи шляхом порівняння їх можливої ефективності. Включає в себе оцінку можливих стрес-факторів, аналіз проблем і наявних ресурсів, генерування передбачуваного плану дій, прогноз ймовірного результату діяльності і вибір способів її виконання.

Для 1,8 % приватних підприємців даної вибірки характерний високий рівень стратегії «стратегічне планування». Стратегічне планування – це процес створення чітко продуманого плану дій, в якому найбільш масштабні цілі поділяються на підцілі (дерево цілей), управління досягненням яких стає більш доступним. У 21,3 % приватних підприємців спостерігаємо високий рівень стратегії «превентивне подолання». Превентивне подолання – є передбачення потенційних стресорів і підготовку дій по нейтралізації негативних наслідків до того, як настане можлива стресова подія. Така невизначеність стимулює людину використовувати широкий спектр копінг-поведінки (накопичення грошових коштів, страхування, підтримку здорового способу життя та ін.). У 12,5 % приватних підприємців можна спостерігати високий рівень стратегії «пошук інструментальної підтримки». Пошук інструментальної підтримки – отримання інформації, порад і зворотного зв'язку від безпосереднього соціального оточення людини в період подолання стресів.

Для 3,6 % приватних підприємців даної вибірки характерний високий рівень стратегії «пошук емоційної підтримки». Пошук емоційної підтримки орієнтований на регуляцію емоційного дистресу шляхом поділу почуттів з іншими, пошуку співчуття і спілкування з людьми з безпосереднього соціального оточення людини.

За допомогою «Стилі гумору» Р. Мартіна у 80,4 % приватних підприємців виявлено високий рівень афіліативного стилю гумору. Даний стиль гумору зв'язується з екстраверсією, відкритістю новому досвіду, оптимізмом, життєрадісністю, з успішністю встановлення і підтримання міжособистісних відносин, задоволеністю якістю життя, переважанням позитивних емоцій і гарного настрою. У 5,4 % приватних підприємців можна спостерігати високий рівень самопідтримувального стилю гумору. Самопідтримувальний (спрямований на себе) стиль гумору передбачає оптимістичний погляд на життя, вміння зберігати почуття гумору перед лицем труднощів і проблем, тобто є регулятором емоцій і механізмом подолання стресу. У порівнянні з афіліативним, самопідтримувальний гумор виконує, в першу чергу, інтрапсихічну функцію і тому не так сильно пов'язаний з екстраверсією. Він має негативний зв'язок з нейротизмом і позитивно корелює з оптимізмом, відкритістю новому досвіду, самоцінністю і задоволеністю якістю життя, з успішністю встановлення і підтримання міжособистісних відносин. Треба зазначити, що самопідтримувальний і афіліативний стилі гумору є здоровими і ефективними. Для 7,1 % приватних підприємців даної вибірки характерний високий рівень агресивного стилю гумору. Агресивний гумор (деструктивний, спрямований на інших) включає в себе сарказм, глузування, жартування, він може бути використаний в цілях маніпуляції іншими. Люди з агресивним стилем гумору часто не можуть впоратися з бажанням жартувати, навіть якщо жарт може когось образити. Цей стиль гумору позитивно пов'язаний з нейротизмом, ворожістю, гнівом і агресією і негативно – з задоволеністю міжособистісними відносинами, дружелюбністю, соціальною компетентністю, здатністю надавати емоційну підтримку іншій людині і ефективністю гумору як копінг-стратегії. У 7,1 % приватних підприємців бачимо високий рівень самопринизливого стилю гумору. Самопринизливий стиль (деструктивний, спрямований на себе) означає використання гумору, спрямованого проти самого себе, з метою здобуття розташування значущих інших. Такі люди, запобігаючи перед оточуючими, дозволяють їм робити себе об'єктом жартів і готові

розділити з ними цей сміх. Хоча вони можуть сприйматися як дотепні і веселі, за цим стоять низька самооцінка і загострена потреба в прийнятті. Самопринизливий стиль гумору позитивно пов'язується з нейротизмом, депресією, тривогою і негативно – з задоволеністю міжособистісними відносинами, якістю життя, психологічним благополуччям, самоцінністю. Таким чином, у результаті аналізу даних, одержаних при дослідженні взаємозв'язку між стресостійкістю та стилями гумору в приватних підприємців підтвердилась гіпотеза, що низький рівень стресостійкості прямо корелює з агресивним та самопринизливим стилями гумору, які є особливими стратегіями копінг-поведінки.

Висновки. Домінуючими стратегіями копінг-поведінки в приватних підприємців є «проблемно-орієнтована» (75,0 %), «емоційно-орієнтована» (12,5 %) та «копінг-стратегія, орієнтована на уникнення» (8,9 %). Копінг-стратегії «відволікання» (1,8 %) та «пошук соціальної підтримки» (1,8 %) – стратегії, що найменше обираються приватних підприємців. У результаті вивчення взаємозв'язку між рівнем стресостійкості та копінг-стратегіями в приватних підприємців було встановлено, що приватні підприємці з низькою стресостійкістю у меншій мірі застосовують проблемно-орієнтовану копінг-стратегію ($r_s = -0,417$, $p \leq 0,01$) та частіше обирають копінг-стратегію, орієнтовану на уникнення ($r_s = 0,278$, $p \leq 0,05$). Результати дослідження проактивних стратегій копінг-поведінки свідчать про те, що 42,9 % приватних підприємців обирають «проактивне подолання», 17,9 % – «рефлексивне подолання», 1,8 % – «стратегічне планування», 21,3 % – «превентивне подолання», 12,5 % – «пошук інструментальної підтримки», та 3,6 % – «пошук емоційної підтримки». У результаті вивчення взаємозв'язку між рівнем стресостійкості та проактивними копінг-стратегіями було виявлено, що чим нижче рівень стресостійкості, тим рідше приватних підприємців звертаються до проактивних стратегій копінг-поведінки, таких як «проактивне подолання» ($r_s = -0,614$, $p \leq 0,01$), «рефлексивне подолання» ($r_s = -0,486$, $p \leq 0,01$), «стратегічне планування» ($r_s = -0,295$, $p \leq 0,05$), «превентивне подолання» ($r_s = -0,289$, $p \leq 0,05$), «пошук інструментальної

підтримки» ($r_s = -0,306$, $p \leq 0,05$) та «пошук емоційної підтримки» ($r_s = -0,370$, $p \leq 0,01$). Результати вивчення стилів гумору як можливих копінг-стратегій в умовах стресу свідчать про те, що для 80,4 % приватних підприємців характерний високий рівень афіліативного стилю гумору. У 5,4 % приватних підприємців можна спостерігати високий рівень самопідтримувального стилю гумору. Для 7,1 % приватних підприємців даної вибірки характерний високий рівень агресивного стилю гумору. У 7,1 % приватних підприємців встановлено високий рівень самопринизливого стилю гумору. У результаті вивчення взаємозв'язку між рівнем стресостійкості та стилями гумору було встановлено, що низький рівень стресостійкості у приватних підприємців прямо корелює з агресивним ($r_s = 0,326$, $p \leq 0,01$) та самопринизливим ($r_s = 0,249$, $p \leq 0,05$) стилями гумору, які є непродуктивними стратегіями в подоланні стресових ситуацій.

Список використаних джерел.

1. Аршава І. Ф. Емоційна стійкість людини та її діагностика: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. психол. наук: спец 19.00.02 «Психофізіологія» І. Я. Аршава. – К.: Інститут психології ім. Г.С. Костюка АПН України, 2007. – 38 с.
2. Чала О. О. Вплив копінг-стратегій на деструктивну конфліктність представників юнацького віку / О. О. Чала // Педагогічна освіта: теорія та практика. Педагогіка. Психологія: зб. наук. пр. – 2010. – Вип. 2 (14). – С. 95-98.
3. Сікунка С. Теоретичний аналіз психологічних факторів формування стресостійкості як умова психологічного здоров'я [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://naub.oa.edu.ua/2014/teoretychnyj-analiz-psyholohichnyh-chynnykiv-formuvannya-stresostijkosti-yak-umova-psyholohichnoho>
4. Вдовиченко О. В. Особливості копінг-поведінки особистості в життєвих та професійних ситуаціях / О. В. Вдовиченко // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер. : Психологічні науки. – 2013. – Вип. 114. – С. 17-20.

5. Корнієнко І. О. Стратегії копінг-поведінки особистості студента у ситуації неспіху : Автореф. дис. канд. психол. наук : 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. – Інститут психології ім. Г. С. Костюка АПН України/І. О. Корнієнко. – К., 2010. – 20 с.
6. Циганчук Т. В. Динаміка переживання стресу студентів: індивідуально–психологічні характеристики / Т. В. Циганчук // Актуальні проблеми психології : зб. наук. пр. / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України; за ред. Максименка С. Д.. – 2010. – Вип. X(16). – С. 564-574.
7. Шепель К. Особливості прояву копінг-стратегій особистості у процесі соціальної взаємодії / К. Шепель // Психолінгвістика. Психологія Мовознавство. Соціальні комунікації : Збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. «Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди». – Переяслав-Хмельницький, 2010. – Вип. 5. – С. 80-84.
8. Білова М. Є. Психологічні особливості осіб з різним рівнем стресостійкості (на прикладі працівників стресогенних професій): автореф. дис. канд. психол. наук : 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології» / М. Є. Білова // Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2007. – 20 с.
9. Кокун О. М. Психологія професійного становлення сучасного фахівця: монографія / О. М. Кокун – К. : Інформ.–аналіт. агентство, 2012. – 199 с.

Особливості психічних станів внутрішньо переміщених осіб

Московко Н. М.

*Здобувач другого(магістерського) рівня вищої освіти
Академія праці, соціальних відносин і туризму, м. Київ*

Білоус В.С

*Кандидат медичних наук
Академія праці, соціальних відносин і туризму, м. Київ*

Актуальність. Різні внутрішні і зовнішні подразники, діючи на людину, обумовлюють її психічний стан, який може мати як позитивне, так і негативне забарвлення. Поняття «психічний стан» пов'язане з певною своєрідністю переживання та поведінки, яка виражається у психічній діяльності в цілому і впливає певний час на її динаміку та перебіг. Вона залежить від загальної всебічної оцінки ситуації, а щодо стимуляційного аспекту даної ситуації, то охоплює також значення мінімальних стимулів повернення якихось «ключів», пов'язаних з емоційною пам'яттю (минулим емоційним досвідом). Психічні стани можуть позитивно впливати на виконувану діяльність, на процес спілкування, а можуть і дезорганізовувати їх, тобто здійснювати регулюючий вплив, оскільки виникнення того чи іншого стану пов'язане зі зміною діяльності, що, власне, і зумовило виділення такої категорії психічного, привернуло до неї увагу [1–5]. Зміни, які відбулися за останні роки в Україні визначили високу актуальність проблеми внутрішньої міграції. На відміну від добровільної зміни місця проживання (у пошуках, наприклад, покращення життєвих умов), люди переїжджають вимушено, як правило, внаслідок військових дій, утисків влади, дискримінації за національною ознакою або релігійним переконанням. Початковий конфлікт між відсутністю позитивної мотивації до переїзду і фізичною неможливістю подальшого перебування на малій батьківщині, травматизація психіки, обумовлена причинами та історією міграції, а також труднощі адаптації на новому місці визначають формування вельми специфічного досвіду внутрішньо переміщених осіб, який виходить за рамки звичайного і повсякденного [3–5]. Проблема надання психологічної допомоги

біженцям, переселенцям чи їх психологічного супроводу не нова для світу, проте є зовсім актуальною і неопанованою для вітчизняних фахівців. Тим не менш, незважаючи на гостроту проблеми і широку поширеність пограничних форм невротичних розладів у внутрішньо переміщених осіб, їх соціальної дезадаптації, досліджень по темі особливостей психічних станів внутрішньо переміщених осіб та порушень соціально-психологічної адаптації, мало, що й робить наше дослідження досить актуальним. Ключове значення у зв'язку з цим набувають дослідження психічних станів, процесів, що відбуваються з людиною, яка внутрішньо змінює своє колишнє соціокультурне середовище, їх вплив на психічне здоров'я, процеси адаптації особистості до кардинальних змін у нових для неї умовах. У науковій літературі існують дослідження, присвячені вивченню мігрантів (зовнішніх та внутрішніх) та особливостей їх адаптації та взаємодії з населенням приймаючої сторони. Однак маловивченими залишаються, донині, їх психологічні стани. Так само маловивченою категорією залишаються внутрішньо переміщені особи у зв'язку з бойовими діями всередині країни.

Мета дослідження. Дослідити особливості психічних станів внутрішньо переміщених осіб. *Методи дослідження.* Комплексне дослідження психічних станів внутрішньо переміщених осіб проводилося за допомогою наступних методик: 1. Методика дослідження концентрації уваги; 2. Дослідження тривожності (Ч. Спілбергер); 3. Методика дослідження емоційного відгуку; 4. Методика дослідження самопочуття, активності, настрою (САН). В кваліфікаційній роботі використовувався якісний та кількісний аналіз отриманих результатів а також методи математичної статистики перевірки запропонованої гіпотези.

Результати дослідження. В результаті проведення емпірично дослідження обстежено 43 внутрішньо переміщених особи жіночої та чоловічої статі, яким на протязі місяця надавалася комплексна кваліфікована соціально-психологічна допомога. На початку дослідження у внутрішньо переміщених осіб спостерігалися низький рівень самопочуття, активності та настрою, низький

рівень особистісної та реактивної тривожності, знижений рівень уваги тощо. Отже, до комплексної психологічної роботи з внутрішньо переміщеними особами у досліджуваних спостерігався: середній рівень концентрації уваги у 44,0 % досліджуваних, 44,0 % досліджуваних мали низький рівень особистісної тривожності, у 67,0 % внутрішньо переміщених осіб була висока реактивна тривожність, 30,0 % людей мали низький рівень емоційного відгуку. Після комплексної роботи можна відзначити, що високий рівень концентрації уваги прослідковувався вже у 49,0 % досліджуваних, у 67,0 % виявився низький рівень особистісної тривожності, 49,0 % внутрішньо переміщених осіб проявили середній рівень реактивної тривожності, 42,0 % – нормальний рівень емоційного відгуку. Окрім того, до дослідження у внутрішньо переміщених осіб виявилися низькі рівні самопочуття, активності та настрою – 72,0 %, 81,0 % та 91,0 % відповідно. Після впливів було відмічено, що дані рівні зросли до високого у 70,0 %, 70,0 % та 65,0 % досліджуваних відповідно показникам САН.

Після комплексної роботи з внутрішньо переміщеними особами нами було відмічено, що усі досліджені показники психічних станів значно покращилися та підвищилися. То ж можемо стверджувати, що психічні стани набувають змін внаслідок комплексної роботи. Наша гіпотеза була підтверджена методами математичної статистики в психології. Для того, щоб ефективно організувати роботу з психологічної допомоги внутрішньо переміщеним особам, необхідно мати чітке розуміння їхніх психічних станів, спричинених травматичною ситуацією. Події, які примушують людей зриватись з місць, залишати свої домівки, настільки виходять за межі нормального життя, що відчувається, як надзвичайно стресові для всіх, хто опинився в таких ситуаціях (незважаючи на те, чи від'їжджали вони через тривожні відчуття, чи через реальну загрозу життю під час розгортання військових дій). Психологи так само мають зважати на те, що переселенці опиняються у таких стресових умовах щонайменше декілька разів: до переселення, під час переселення і після свого переселення. Тому, вважаємо, що усі державні установи а також

волонтерські пункти мають бути готові до надання психологічної допомоги вимушеним переселенцям задля вчасної стабілізації психічних станів та адаптації. Як правило, ситуація, що змусила людину до втечі, не виникає раптово, а є кульмінацією щодо розтягнутого у часі процесу переслідування або утисків. У життєвій історії більшості внутрішньо переміщених осіб є присутньою не тільки обставина, яка викликає значний дистрес – необхідність адаптації на новому місці, а й досвід перебування у районі бойових дій.

Перенісши тяготи і незручності переїзду, на новому місці вимушені переселенці зазвичай стикаються з такими негативними соціальними явищами, як низька толерантність приймаючої території, фобії до мігрантів. Переселення сприймається ними як ситуація депривації та ізоляції – таким чином, сукупність зовнішніх обставин, що характеризують вимушену міграцію як важку життєву ситуацію, детермінує високий рівень стресу у середовищі внутрішньо переміщених осіб, який посилюється у ряді випадків проявами посттравматичного стресу, викликаного драматичним минулим багатьох з них. При описі переживань подібного роду в психології традиційно прийнято використовувати поняття «психологічна травма», «соціальний стрес», «розлади адаптації», «пограничні розлади». Аналіз літературних джерел, власні роздуми привели до розуміння психологічних наслідків переживання вимушеної міграції як стану психосоціального стресу високої інтенсивності, триваючого тривалий проміжок часу, що є результатом впливу важких життєвих обставин на особистість вимушеного переселенця. Отже, вони не тільки стали свідками бойових дій, втратили близьких, житло, майно, роботу, а й змушені звикати до нового, незвичного для них середовища, невизначеності у сьогоденні і майбутньому, а отримані при цьому психотравми і психічне перенапруження привели їх до різних форм психологічної дезадаптації. Психологічний механізм трансформації образу світу і способу життя людей представляється як зміни у свідомості, які потребують корекції форм поведінки, що становлять спосіб життя людини, і перебудови ціннісно-смыслових складових образу світу людини. Готовність до зміни способу життя проявляється у

здатності людини прийняти цілісність власного Я, ідентифікувати себе з собою та іншими людьми, утримувати внутрішній порядок і стиль власного життя. На поведінковому рівні – це виступає як процес вирішення сукупності життєво-значущих проблем, що відобразиться і на способі життя, його зміцненні або динаміці. Практичним аспектом є запропонування психологічні рекомендації щодо роботи з внутрішньо переміщеними особами.

Висновки. Виявлено, що до комплексної психологічної роботи з вимушеними переселенцями у досліджуваних спостерігався: середній рівень концентрації уваги у 44,0 % досліджуваних, 44,0 % досліджуваних мали низький рівень особистісної тривожності, у 67,0 % внутрішньо переміщених осіб була висока реактивна тривожність, 30,0 % людей мали низький рівень емоційного відгуку. Після комплексної роботи можна відзначити, що високий рівень концентрації уваги прослідковувався вже у 49,0 % досліджуваних, у 67,0 % виявився низький рівень особистісної тривожності, 49,0 % внутрішньо переміщених осіб проявили середній рівень реактивної тривожності, 42,0 % – нормальний рівень емоційного відгуку. Окрім того, до дослідження у внутрішньо переміщених осіб виявився низькі рівні самопочуття, активності та настрою – 72,0 %, 81,0 % та 91,0 % відповідно. Після впливів було виявлено, що дані рівні зросли до високого у 70,0 %, 70,0 % та 65,0 % досліджуваних відповідно показникам САН. Дослідження підтвердило гіпотезу про те, що психологічна адаптація внутрішньо переміщених осіб до нових умов соціально-економічного середовища буде проходити успішніше, позитивно відбиватиметься на психічних станах якщо процес взаємодії з новим середовищем буде заснований на результатах комплексної всебічної кваліфікованої допомоги психологів, соціальних працівників, волонтерів тощо.

Список використаних джерел.

1. Внутрішньо переміщені особи: від подолання перешкод до стратегії успіху: монографія / О. Ф. Новікова, О. І. Амоша, В. П. Антонюк та ін. ; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. Київ, 2016. 448 с.
2. Гридковець Л., Вебер Т., Журавльова Н., Запорожець О., Климишин

О., Креймейер Д., Мокроусова А., Пророк Н., Сиротич Н., Сіренко Т., Царенко Л., Шапошник Н. Основи реабілітаційної психології: подолання наслідків кризи. Навчальний посібник. Том 3. Київ, 2018. 236 с.

3. Закон України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», грудень 2015 р. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1706-18#Text>

4. Приб Г.А. Психологічна підтримка працевлаштування внутрішньо переміщених осіб. Ментальне здоров'я особистості та організації : колективна монографія. АПСВТ / За заг. ред. : Г. А. Приба, Л. Є. Бегези. Київ : Вид-во «Лів-принт», 2024. С. 293–303. <http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.29969.61284>

5. Приб Г.А., Бегеза Л.Є. Сприяння федерації професійних спілок України у наданні підтримки внутрішньо переміщеним особам в Україні. Техн. звіт РО 40405574 від 16.01.2023 р. АПСВТ. 2023. 29 с. <http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.36478.97606>

Вплив психосоціальної дезадаптації в ситуації невизначеності на формування девіантної поведінки особистості

Пріб Г.А.

Доктор медичних наук, професор

проректор з наукової роботи

Академія праці, соціальних відносин і туризму

<https://orcid.org/0000-0003-1163-5469>

Анотація. У статті представлено результати дослідження впливу психосоціальної дезадаптації в ситуації невизначеності на формування девіантної поведінки особистості. Виявлено, що високий рівень тривожності та фрустрації спостерігається частіше у жінок, ніж у чоловіків, а високий рівень агресивності встановлюють частіше у чоловік ($p \leq 0,05$). Встановлено, що жінкам властивий вищий показник ригідності психіки, а чоловікам низький рівень, який дозволяв бути більш мобільними у ситуації невизначеності. Визначено, що у чоловіків показники готовності до подолання соціальних норм та правил, а також схильність до адиктивної поведінки є вищими. У свою чергу жінки мали підвищену схильність до саморуйнівної поведінки. Дослідження самооцінки психічних станів виявило низький рівень агресії у жінок та чоловіків, проте рівень вольового контролю емоційних реакцій був вище у жінок. Зазначено, що психосоціальна дезадаптація в ситуації невизначеності впливає на формування девіантних форм поведінки особистості. Перспективами подальшого наукового пошуку визначено дослідження взаємозв'язку психологічних особливостей та рівня задоволеності особистості в ситуації невизначеності.

Ключові слова: дезадаптація, невизначеність, психосоціальна, девіантна поведінка, особистість, самооцінка, психічні стани, схильність, тривожність, фрустрація, емоції, агресія, саморуйнівна поведінка.

Hlib A. Prib
Doctor of medical Science, Professor
Vice-Rector of Science and Research,
Academy of Labour Social Relations and Tourism,
<https://orcid.org/0000-0003-1163-5469>

The effect of psychosocial disadaptation in a situation of uncertainty on the formation of a personality with deviant behavior

Abstract. The article presents the results of a study on the effect of psychosocial disadaptation in a situation of uncertainty on the development of deviant behavior. A higher level of anxiety and frustration was observed in women than in men, while a high level of aggressiveness was observed in men ($p \leq 0.05$). It was found that women are characterized by the highest level of mental rigidity and men by a decrease, which allows them to be more mobile in a situation of uncertainty. It was found that men had higher indicators of willingness to overcome social norms and rules, as well as a tendency towards addictive behavior. In general, women had a higher tendency to self-destructive behavior. The study of self-assessment of psychological conditions revealed a low level of aggression in both women and men, but the level of self-control of emotional reactions was higher in women. It is noted that psychosocial disadaptation in a situation of uncertainty influences the formation of deviant forms of personal behavior. Perspectives for further scientific research are the study of the relationship between psychological characteristics and the level of personality satisfaction in a situation of uncertainty.

Key words: disadaptation, uncertainty, psychosocial, deviant behavior, personality, self-esteem, mental conditions, tendency, anxiety, frustration, emotions, aggression, self-destructive behavior.

Постанова проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями. У зв'язку з військовими діями у нашій країні деякі особистості гостро переживають неможливість задоволення особистісних потреб і інтересів, отримання бажаної освіти чи роботи, зміну ціннісних орієнтацій і суспільних норм, що можна класифікувати як ситуацію невизначеності у якій порушені адаптаційні процеси до оточуючого її середовища. Психосоціальна дезадаптація особистості проявляється станом у якому виявляється неспроможність задовольнити власні потреби, самоствердитись, реалізуватись прийнятним для даного середовища засобом. Така особистість зазнає страждань або порушує встановлені норми та правила поведінки задовольняючи потреби способом, що завдає шкоди йому або суспільству. Психологічна та соціальна дезадаптації є наслідком порушення процесу активного пристосування людини до умов середовища, під час якого вона, з одного боку, набуває якостей, необхідних для життя в певних умовах, формує відповідний вимогам середовища та власним особливостям стиль поведінки, а з іншого, змінює умови власного середовища у відповідності до своїх потреб і можливостей. Можна зазначити, що проблема психосоціальної дезадаптації посилюється у ситуації невизначеності, коли існує брак або суперечливість та нечіткість інформації. В умовах війни сукупність дезадаптивних явищ та невизначеності може призводити до формування у особистості відхилень від суспільних норм (правових, моральних, естетичних, етичних), що в цілому можна класифікувати як девіантну поведінку. Дослідження такої поведінки та розробка заходів її корекції на наш погляд відповідає важливому науковому та практичному завданню – реалізації плану заходів із Концепції розвитку охорони психічного здоров'я на період до 2030 року затвердженому КМ України № 1215-р. від 6 жовтня 2021 р [1].

Аналіз досліджень і публікацій та виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячена стаття. Сучасні парадигми

суспільного розвитку потребують пошуку інноваційного й актуального категоріального апарату психологічної науки. До цієї площини належить поняття «невизначеність», яке є багатозначним, що дозволяє екстраполювати його на різні соціально-психологічні феномени [2]. Аналіз наукової літератури дозволяє побачити, що проблему невизначеності в різних її контекстах, вивчали як зарубіжні (С. Баднер, Р. Бріслін, Н. Нортон, Е. Френкель-Брунсвік,

Р. Халлман, та ін.), так і українські вчені (Л. Бурлачук, А. Гусєв,

С. Максименко, Є. Носенко, П. Лушин, М. Шаповал). У сучасних умовах не тільки і не стільки об'єктивні параметри інформаційного поля задають характеристики ситуації невизначеності, скільки особливості, які суб'єкт може приписувати ситуації, оцінювати її як більш-менш визначену [2].

Причини психосоціальної дезадаптації в умовах війни приховані в невідповідності між умовами життєдіяльності й можливостями індивіда. Невизначеність не дозволяє або заважає особистості задовольнити свої потреби, у свою чергу особа через власні якості нездатна використати можливості, що їй надає середовище, пристосуватися до його умов і вимог або змінити ці умови. Дезадаптація може настати як результат різкої зміни умов середовища, до якої індивід виявився не готовим, або відбуватися поступово коли людина тривалий час зазнає негативного впливу середовища або власної поведінки. У напружений час соціальних та економічних криз, впливу військових дій та пов'язаних з ними стресів – усе це стає факторами, що викликають негативні емоції та стани [3, 4, 5].

Сучасні знання про девіантну поведінку особистості дозволяють стверджувати, що ми маємо справу з надзвичайно складною формою соціальної поведінки особистості, детермінованою системою взаємозалежних факторів. Для того, щоб поведінка окремого індивіда або групи осіб була визнана девіантною, необхідно, щоб вона відповідала таким критеріям: була порушенням найважливіших для певного суспільства норм; викликала негативну оцінку з боку

інших людей, наносила реальну шкоду безпосередньо людині та (або) оточуючим, повторювалася, була пов'язана із соціальною дезадаптацією людини (була наслідком дезадаптації, поглиблювала її чи призводила до дезадаптації) [6, 7].

Форма психосоціальної дезадаптації та ступінь її вираженості є визначальними характеристиками девіантної поведінки. Вони можуть бути незначними, тобто не завдавати шкоди соціуму й самій людині, або ж тотально руйнувати життєдіяльність особи і бути небезпечними для суспільства. Можна стверджувати, що обумовлює девіантну поведінку та сприяє її розвитку наступне:

- недостатність розвитку особистості в цілому (але не патологія) – саме це стає на заваді правильного самоаналізу поведінки і прогнозування її наслідків;
- недостатність «самостійного мислення», внаслідок чого людина стає більш конформісткою і навіюваною;
- низька пізнавальна діяльність, збіднення і нестійкість духовних потреб.

Отже можна зазначити, що в основі девіантної поведінки може спостерігатися психосоціальна дезадаптація, але єдиною і достатньою умовою вона не є. Девіантна поведінка, як соціальний феномен у її різноманітних проявах, може володіти своєю власною природою і не співвідноситися з процесом дезадаптації. В той же час психосоціальна дезадаптація особистості є одним з суттєвих і впливових факторів розвитку поведінки, що відхиляється від різного роду соціальних норм.

Психотравмуючий вплив стану безробіття у певної категорії людей викликає різні порушення упорядкованих комунікативних стереотипів і призводить до стану дезадаптації, а також до порушень конкретних соціально-психологічних взаємин. Зазначені симптоми складають основу так званого синдрому соціально-психологічної дезадаптації [6, 7].

Безумовні «лідери» серед психологічних проблем у ситуації невизначеності – це невпевненість в завтрашньому дні і відчуття залежності від зовнішніх обставин. Професійна, економічна, психологічна дезадаптації, розвиваючись

одночасно або послідовно, з часом призводять до соціокультурної дезадаптації, що виявляється в нездатності чи неготовності, а також в небажанні суб'єкта розділяти цінності і норми, прийняті в суспільстві.

В ситуації невизначеності для особистості змінюється життєва орієнтація, розхитуються моральні установки, як наслідок, виникають психосоціальні проблеми. Крім зовнішніх змін, у особистості в ситуації невизначеності, відбуваються внутрішні зміни, перш за все в мотивації. Під мотивами поведінки зазвичай розуміються спонукання до діяльності, пов'язані із задоволенням потреб людини. Існує відносний пріоритет актуалізації мотивів: для того щоб поведінка людини визначалося потребами високого рівня, спочатку повинні бути задоволені потреби нижчого рівня. Наприклад, при втраті роботи утруднюється реалізація потреб нижчих рівнів у зв'язку із зменшенням фінансових можливостей. Різко обмежується реалізація потреби в соціальних контактах. Особистість втрачає можливість задовольняти потреби вищих рівнів – потреби в самореалізації і в досягненнях. Подібне незадоволення потреб викликає стан дискомфорту, страждання, незадоволення, неспокій, а також часто призводить до девіантної поведінки (адиктивної, делінквентної, агресивної тощо). До невирішених раніше частин проблеми впливу психосоціальної дезадаптації в ситуації невизначеності на формування девіантної поведінки особистості можна віднести існуючі прогалини щодо розуміння рівня тривожності та фрустрації, а також схильності до поведінки, яка відхиляється.

Мета дослідження. Вивчення психосоціальної дезадаптації особистості в ситуації невизначеності та її вплив на формування й розвиток девіантних форм поведінки в залежності від статі.

Матеріал дослідження. Дослідження проведено у період 2022–2024 рр. До дослідження залучені жінки 35 осіб та чоловіки 40 осіб. Вік досліджуваних осіб 30–50 років. Дослідження проведено з дотриманням принципів етики Американської психологічної асоціації [8], «Кодексу етики» протокол № 10 від

14.07.2016 [9], «Положення про академічну доброчесність Академії праці, соціальних відносин і туризму» протокол № 7 від 12.04.2018 р. [10]. Методи дослідження. Даний етап виконувався за допомогою методики «Самооцінка психічних станів» Г. Айзенка та «Діагностування схильності до поведінки, яка відхиляється» [11]. Аналіз, обробка і підрахунок процентних характеристик і коефіцієнтів кореляції здійснювалися за допомогою програми SPSS 10.0.5 for Windows [12].

Результати дослідження. Першим етапом стало дослідження методикою «Самооцінка психічних станів» Г. Айзенка. Так, високий рівень тривожності виявлено, у 52,0 % жінок, яка проявлялася у хвилюванні, підвищеному занепокоєнні, поганому сні, очікуванні поганого з боку оточуючих. Середній рівень тривожності притаманний 36,0 % жінок і 92,0 % чоловікам. Низький рівень відповідно 12,0 % та 8,0 %, тобто в середньому кожна десята особистість в ситуації невизначеності не залежно від статі тривожності не виявляє ($p \leq 0,05$).

Дослідження фрустрації виявило наступне: середній рівень встановлено у 64,0 % жінок та 44,0 % чоловіків. Низький рівень у 36,0 % жінок та 56,0 % чоловіків ($p \leq 0,05$). Такі показники від норми не відхиляються. Високий рівень фрустрації не виявлено у жодного досліджуваного обох вибірок, що свідчить про те, що досліджувані, опинившись в ситуації невизначеності особистість розглядає ситуацію як тимчасову.

Дослідження агресивності виявило наступне: високий рівень агресивності встановлено у 12,0 % жінок та 32,0 % чоловіків, що свідчить про невитриманість у спілкуванні, внаслідок чого виникати конфліктні ситуації з оточуючими. Так званий допустимий (середній) рівень агресивності встановлено у 32,0 % жінок на 52,0 % чоловіків. «Поведінка без агресії» виявлена відповідно у 56,0 % жінок на 4,0 % чоловіків, що свідчать про більш агресивну поведінку чоловіків ($p \leq 0,05$). Дослідження ригідності виявлено, що 40,0 % жінок та 20,0 % чоловіків присутній високий рівень ригідності, що свідчить про фіксованість на певних об'єктах та

важкість перенесення будь-яких змін в життєвих планах. У 52,0 % жінок та 64,0 % чоловіків виявлено середній рівень ригідності. Відповідно у 8,0 % жінок та 16,0 % чоловіків – низький. У таких безробітних відсутня зайва фіксація на об'єктах, вони вільно змінювали свої плани і наміри ($p \leq 0,05$). Узагальнюючи можна зазначити, що жінки мають більш високий рівень тривожності та ригідності, в той час як чоловіки при самооцінці психічних станів показали більш високий рівень агресивності. Крім того, високий рівень ригідності у жінок вдвічі більший, ніж у чоловіків, а рівень агресивності чоловіків майже втричі вищий за аналогічний показник у жінок. Показник фрустрованості у вибірках досліджуваних як жінок, так і чоловіків не досяг високого рівня.

Другим етапом стало дослідження, поведінки, яка відхиляється опитувальником «Діагностика схильності до поведінки, яка відхиляється». Результати за шкалами виглядали наступним чином:

1. Шкала установки на соціально бажані відповіді. Дана шкала призначена для вимірювання готовності досліджуваного представляти себе в найбільш сприятливому світлі з точки зору соціальної бажаності. Показники від 50 до 60 Т–балів свідчать про помірної тенденції давати при заповненні опитувальника соціально-бажані відповіді. Такі результати отримані від 40,0 % досліджуваних жінок та 48,0 % чоловіків ($p \leq 0,05$). Показники понад 60 балів свідчать про тенденцію випробуваного демонструвати суворе дотримання навіть малозначних соціальних норм, умисному прагненні показати себе в кращому світлі, про настороженість по відношенню до ситуації обстеження. Серед досліджуваних результати в даному діапазоні спостерігаються у 32,0 % жінок та 36,0 % чоловіків ($p \leq 0,05$). Результати, що знаходяться в діапазоні 70–89 балів свідчать про високу настороженість випробуваного по відношенню до психодіагностичної ситуації і про сумнівну достовірності результатів за основними шкалами, таких серед досліджуваних жінок виявилось 28,0 %, серед чоловіків – 16,0 % ($p \leq 0,05$). В цілому можна зазначити, що серед чоловіків та жінок виявлено перевищення

сумарного первинного балу за шкалою соціальної бажаності значення (11 первинних балів). Показники нижче 50 Т-балів свідчили про не схильність приховувати власні норми і цінності, коригувати свої відповіді в напрямку соціальної бажаності. Одночасно високі показники по службовій шкалі і по основних шкалах свідчать про дисоціацію у свідомості випробуваного відомих йому і реальних норм поведінки ($p \leq 0,05$).

2. Шкала схильності до подолання норм і правил. Дана шкала призначена для вимірювання схильності досліджуваного до подолання будь-яких норм і правил, схильності до заперечення загальноприйнятих норм і цінностей, зразків поведінки. Результати в діапазоні 50–60 Т-балів склав у жінок – 16,0 %, чоловіків – 20,0 % ($p \leq 0,05$), що свідчали про вираженість нонконформістської установки, схильність протиставляти власні норми і цінності груповим, тенденції «порушувати спокій», шукати труднощі, які можна було б подолати. У 20,0 % жінок та 28,0 % чоловіків ($p \leq 0,05$) показники в діапазоні 60–70

Т-балів, свідчали про надзвичайну вираженість нонконформістських тенденцій, прояві негативізму. Результати нижче 50 Т-балів, які виявлено у 64,0 % жінок та 52,0 % чоловіків ($p \leq 0,05$) свідчать про наявність конформних установок, схильності слідувати стереотипам і загальноприйнятим нормам поведінки.

3. Шкала схильності до адиктивної поведінки. Шкала призначена для вимірювання готовності особи реалізувати адиктивну поведінку. Результати в діапазоні 50–70 Т-балів за даною шкалою свідчали про схильність досліджених до відходу від реальності за допомогою зміни свого психічного стану, про схильність до ілюзорно-компенсаторного способу вирішення особистісних проблем ($p \leq 0,05$). Результати показували про орієнтацію на чуттєву сторону життя, про наявність «сенсорної спраги», про гедоністично орієнтовані норми і цінності. Серед досліджуваних отримані показники розподілилися наступним чином: жінки – 52,0 %, чоловіки – 60,0 % ($p \leq 0,05$). Показники понад 70 Т-балів

свідчить про наявність вираженої психологічної потреби в адиктивних станах, що необхідно з'ясовувати, використовуючи додаткові психодіагностичні засоби. Показники нижче 50 Т-балів свідчив про невиразність вище перелічених тенденцій, або про гарний соціальний контроль поведінкових реакцій. За результатами дослідження в дану категорію увійшли 28,0 % жінок та 12,0 % чоловіків ($p \leq 0,05$).

4. Шкала схильності до саморуйнівної поведінки. Дана шкала призначена для вимірювання готовності реалізувати різні форми аутоагресивної поведінки.

Показники нижче 50 Т-балів по даній шкалі свідчать про відсутність готовності до реалізації саморуйнується поведінки, про відсутність тенденції до соматизації тривоги, відсутності схильності до реалізації комплексів провини в поведінкових реакціях. За отриманими даними такі результати показали 32,0 % жінок і 24,0 % чоловіків, які знаходяться в ситуації невизначеності ($p \leq 0,05$). Результати, що знаходяться в діапазоні 50–70 Т-балів свідчать про низьку цінність власного життя, схильності до ризику, вираженої потреби в гострих відчуттях. Досліджувані розподілилися наступним чином: схильні до саморуйнівної поведінки 60,0 % жінок та 76,0 % чоловіків ($p \leq 0,05$). Результати понад 70 Т-балів свідчать про сумнівну достовірність результатів, яку виявлено у 8,0 % жінок ($p \leq 0,05$).

5. Шкала схильності до агресії та насильства. Дана шкала призначена для вимірювання готовності випробуваного до реалізації агресивних тенденцій у поведінці. Показники нижче 50 Т-балів, свідчать про невиразність агресивних тенденцій, про неприйнятність насильства як засобу вирішення проблем, про не типовість агресії як способу виходу з фруструючої ситуації. Низькі показники за даною шкалою в поєднанні з високими показниками за шкалою соціальної бажаності свідчать про високий рівень соціального контролю поведінкових реакцій. Серед досліджуваних до цієї категорії віднесено 72,0 % жінок ($p \leq 0,05$). Показники в діапазоні 50–60 Т-балів, що свідчать про наявність агресивних

тенденцій, продемонстрували 24,0 % жінок та 72,0 % чоловіків ($p \leq 0,05$). Показники, що знаходяться в діапазоні 60–70 Т-балів, свідчать про агресивну спрямованості особистості у взаємовідносинах з іншими людьми, про схильність вирішувати проблеми за допомогою насильства, про тенденції використовувати приниження партнера по спілкуванню, як засіб стабілізації самооцінки, про наявність тенденцій садизму. За даними дослідження у жінок це показник виявився у 4,0 % осіб, в чоловічій – 20,0 % ($p \leq 0,05$).

6. Шкала вольового контролю емоційних реакцій. Дана шкала призначена для вимірювання схильності випробуваного контролювати поведінкові прояви емоційних реакцій, але ця шкала має зворотний характер. Показники нижче 50 Т-балів по даній шкалі свідчать про невиразність тенденцій, про жорсткій самоконтроль поведінкових емоційних реакцій, чуттєвих потягів, що виявлено у 40,0 % жінок та 28,0 % чоловіків ($p \leq 0,05$). Показники в межах 50–60 Т-балів, свідчать про намагання особи самостійно контролювати поведінку та емоційні прояви. Так, виявлено, що вольовий контроль середнього рівня притаманний 44,0 % жінок і 64,0 % чоловіків ($p \leq 0,05$). Показники в межах 60–70 Т-балів, свідчать про слабкість вольового контролю емоційної сфери, про небажання чи нездатності контролювати поведінкові прояви емоційних реакцій. Крім того, це свідчить про схильність реалізовувати негативні емоції безпосередньо в поведінці, без затримки, про не сформованість вольового контролю своїх потреб і чуттєвих потягів. Досліджувані за такими результатами розподілилися наступним чином: жінки – 12,0 %, чоловіки – 8,0 % ($p \leq 0,05$).

7. Шкала схильності до делінквентної поведінки. Дана шкала вимірює готовність (схильність) досліджуваних до реалізації делінквентної поведінки, тобто виявляє «делінквентний потенціал», який лише за певних обставин може реалізуватися в житті. Результати нижче 50 Т-балів свідчать про не вираження зазначених тенденцій, що в поєднанні з високими показниками за шкалою соціальної бажаності може свідчити про високий рівень соціального контролю.

Таких осіб серед досліджуваних становило: серед жінок 32,0 %, серед чоловіків – 24,0 % ($p \leq 0,05$). Результати, що знаходяться в діапазоні 50–60 Т–балів, свідчать про наявність деліквентних тенденцій у досліджених і про низький рівень соціального контролю, що встановлено у 64,0 % жінок та 68,0 % чоловіків ($p \leq 0,05$). Результати вище 60 Т–балів свідчать про високу готовність до реалізації деліквентної поведінки. Таку схильність продемонстрували 4,0 % досліджуваних жінок і 8,0 % чоловіків ($p \leq 0,05$).

Висновки. Узагальнюючи отримані дані, можна зазначити, що складові психосоціальної дезадаптації в ситуації невизначеності притаманні всім досліджуваним особам. В той же час, більш високий рівень тривожності спостерігається у жінок, ніж чоловіків ($p \leq 0,05$). Рівень фрустрованості жінок також вищий ніж чоловіків, хоча найвищих результатів, що свідчать про можливий розвиток психічних розладів, серед досліджуваних не виявлено. Агресивність, навпаки, більш притаманна чоловікам. За показником ригідності психіки жінки показали вищі результати аніж чоловіки, що дозволяє останнім бути більш мобільними у ситуації невизначеності. Виявлено, що за шкалою схильності до подолання соціальних норм та правил та шкалою схильності до адиктивної поведінки чоловіки показали вищі результати готовності.

За шкалою схильності до саморуйнівної поведінки лише 8,0 % жінки мають високий рівень готовності до таких дій, серед чоловіків таких осіб не виявлено. Результати шкали схильності до агресії та насильства підтвердили результати, отримані за допомогою методики самооцінки психічних станів Г. Айзенка, а саме наявність низького рівень агресії у жінок та чоловіків. Вищий рівень вольового контролю емоційних реакцій, в ході дослідження, виявлено серед жінок, які більш жорстко контролюють прояви своїх поведінкових емоційних реакцій. Таким чином, можна зазначити, що в цілому психосоціальна дезадаптація особи в ситуації невизначеності впливає на формування девіантних форм поведінки, у свою чергу на формування девіантної поведінки дезадаптованої особистості

впливає стан невизначеності. Перспективи подальшого дослідження у даному напрямку полягають у вивченні взаємозв'язку психологічних особливостей та рівня задоволеності особистості в ситуації невизначеності.

Список використаних джерел.

1. Action plan for the implementation of the Mental Health Development Concept for the period until 2030, approved by the Cabinet of Ministers of Ukraine № 1215 from October 6, 2021. [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1215-2021- %D1 %80#Text](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1215-2021-%D1%80#Text) [in Ukrainian]
2. Kurova A.V. (2021). The situation of uncertainty in the paradigm of modern societal challenges. Scientific Bulletin of the Uzhhorod National University, 2021. №. 4. P. 51-55. <https://doi.org/10.32782/psy-visnyk/2021.4.10> [in Ukrainian]
3. Prib H., Beheza L., Markova M., Raievska Y., Lapinska T., Markov A. (2023). Psycho-emotional burnout of the personality in the conditions of war // Journal of Intellectual Disability – Diagnosis and Treatment. 2023. V. 11, № 1. P. 36–46. <https://doi.org/10.6000/2292-2598.2023.11.01.5> [in English]
4. Markov A. R. (2024). Information and psychological security of the individual: analysis of threats, risks and prospects in the light of modern realities. Mental health of the individual and the organization: a collective monograph. Academy of Labor, Social Relations and Tourism / For general ed. : G. A. Priba, L. E. Begezy. – Kyiv: «Tipography AMG» LLC, 2024. P. 194–205. <http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.29969.61284/2> [in Ukrainian]
5. Prib G.A., Raevska Y.M., Begeza L.E. (2022). Socio-psychological features of personality adaptation in the conditions of hostilities. Academic notes of TNU named after V.I. Vernadskyi. Series: Psychology, 2022. – V 33 (72). № 2. P. 104–109. <https://doi.org/10.32838/2709-3093/2022.2/17> [in Ukrainian]
6. Deviant behavior: sociological, psychological and legal aspects: materials of scientific and practical conference. (Kharkiv, April 10, 2015) / Ministry of Internal Affairs of Ukraine, Kharkiv National University of Internal Affairs, Faculty of Law and

Mass Communications, Department of Sociology and Psychology; Sociological Association of Ukraine. – Kh.: KhNUVS, 2015. 166 p. <https://univd.edu.ua/general/publishing/konf/84.pdf> [in Ukrainian]

7. Kanafotska L. M. (2024). Theoretical analysis of the concept of «deviation» in adolescence. Mental health of the individual and the organization: a collective monograph. Academy of Labor, Social Relations and Tourism / For general ed. : G. A. Priba, L. E. Begezy. – Kyiv: Typography AMG LLC, 2024. P. 150–155. <http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.29969.61284/2> [in Ukrainian]

8. Ethical principles of psychologists and code of conduct. (2016). American Psychological Association. Effective June 1, 2003 (as amended 2010, 2016). Effective January 1, 2017. Available from: <https://www.apa.org/ethics/code/ethics-code-2017.pdf> [in English]

9. «Code of Ethics» (2016). Protocol 10, Available from: <https://www.socosvita.kiev.ua/sites/default/files/KodeksEtyky.pdf> [in Ukrainian]

10. Regulations on academic integrity.(2018). Academy of Labour Social Relations and Tourism, protocol 7. Available from: <https://drive.google.com/file/d/1roDEHIZC9MERTAjCeIP41Bgp249Ree38/view?usp=sharing> [in Ukrainian]

11. Zlyvkov V.L., Lukomska S.O., Fedan O.V. (2016). Psychodiagnostics of personality in crisis life situations / V.L. Zlyvkov, S.O. Lukomska, O.V. Fedan. – K.: Pedagogical thought, 2016. 219 p. [in Ukrainian]

12. Klimchuk V.O. (2009). Mathematical methods in psychology. A guidebook for students of psychological specialties. – K.: Osvita Ukrainy. 2009. 288 p. [in Ukrainian]

Теоретико-емпіричний аналіз психоемоційних станів жінок зрілого репродуктивного віку

Рубан Г.О.

кандидат медичних наук

*Здобувач другого(магістерського) рівня вищої освіти
Академія праці, соціальних відносин і туризму, м. Київ*

Актуальність. У науково-психологічних дослідженнях період гестації розглядається як особливий екзистенційно значущий етап онтогенезу жінки, що супроводжується трансформаціями особистісного, емоційного та тілесного досвіду. З одного боку, вагітність асоціюється з позитивними емоційними переживаннями, пов'язані з очікуванням материнства, з іншого – супроводжується відповідальністю за життя та благополуччя плода. Вагітність як період соціогнезу позначена інтенсивними різномодальними психоемоційними переживаннями, що мають виражену індивідуальну варіативність і специфічну сенсорну насиченість. У структурі індивідуально-психічного досвіду вагітної жінки домінують емоції тривоги, радості, очікування, а також соматичні відчуття, які набувають символічного значення в контексті формування материнської ідентичності.

Мета дослідження. Теоретично проаналізувати й емпірично визначити особливості психоемоційних станів жінок зрілого репродуктивного віку. Результати дослідження. Психологічні особливості перебігу вагітності у жінок зрілого репродуктивного віку. Вагітність у жінок зрілого репродуктивного віку (від 40+ років) характеризується специфічним поєднанням особистісних, психоемоційних та соціально-психологічних особливостей, зумовлених індивідуально-психологічними, соціально-психологічними та соматичними чинниками. Однією з провідних характеристик є екзистенційна значущість вагітності. Для більшості жінок у віці 40+ рішення про материнство має усвідомлений, довгоочікуваний і ціннісно значущий характер. Вагітність

розглядається як важливий життєвий етап, що супроводжується рефлексією щодо сенсу материнства, переосмисленням життєвих пріоритетів і відповідальності за майбутнє дитини. Водночас, попри високий рівень психологічної готовності до материнської ролі, спостерігається зростання тривожності, пов'язаної з фізичним станом, перебігом вагітності, пологами та здоров'ям плода. Емоційний стан вагітних жінок зрілого віку часто має амбівалентний характер. Поряд із позитивними емоціями очікування дитини актуалізуються переживання страху, невпевненості та сумнівів щодо власної здатності повноцінно виконувати материнські функції в умовах вікових змін. Це супроводжується підвищеною емоційною реактивністю, схильністю до коливань настрою, зростанням чутливості до соціального оточення та посиленою потребою в емоційній підтримці з боку близьких і фахівців. Важливу роль у психологічному переживанні вагітності відіграють соціально-психологічні чинники. Для багатьох жінок досвід професійної самореалізації та соціальної стабільності може зумовлювати внутрішній конфлікт між збереженням професійної ідентичності та прийняттям материнської ролі. Окрім того, вагітність у зрілому віці нерідко супроводжується відчуттям соціального тиску або латентної стигматизації, пов'язаної з поширеними уявленнями про «нормативний» вік материнства. Підвищений рівень тривожності та емоційного напруження може проявлятися у вигляді психосоматичних реакцій: розлади сну, апетиту, підвищена втомлюваність та різноманітні соматичних скарг. Наявність об'єктивних медичних ризиків, характерних для вагітності у цьому віці, додатково посилює психологічне навантаження та актуалізує потребу у психологічному супроводі. Процес формування материнської ідентичності у жінок зрілого репродуктивного віку відзначається високим рівнем рефлексивності та усвідомленості. Він включає переосмислення власного життєвого шляху, особистісних цінностей і соціальних ролей. Усвідомлення підвищеної відповідальності за материнство сприяє активному пошуку інформації, залученню до програм психопрофілактики та

відповідальній підготовці до пологів і подальшого материнства. У медико-психологічній літературі науковцями та лікарями-акушерами гінекологами психічні стани вагітних жінок вивчаються за наступними векторами: психологічний супровід у репродуктивній медицині (В. М. Астахов, О. В. Бацилєва, І. В. Пузь [1]), клініко-патогенетичні аспекти акушерських і перинатальних ускладнень у жінок з урахуванням психоемоційного стану та їх медико-психологічна корекція (В. Г. Сюсюка [7]), психологічні проблеми вагітності та перинатального періоду (І. С. Тимків [11]), особливості психологічного здоров'я жінок репродуктивного віку (А. В. Картушинська [4]), характеристики реакцій тривоги у вагітних з надмірною вагою (К. В. Тарасенко [10]), вплив тривожності жінок під час вагітності на стан новонароджених та перебіг їх раннього неонатального періоду (В. Г. Сюсюка, Ю. В. Котлова [8]), психологічна допомога жінкам, які страждають безпліддям, в умовах медичної установи (Т. Д. Перепелюк [6]) та ін. Таким чином, автори визначають емоційний стан вагітних як адаптаційний, що має індивідуально-психологічні відмінності обумовлені певними чинниками.

Для жінок під час вагітності характерні особливості емоційного реагування:

- підвищена емоційна чутливість: жінки можуть відчувати більш інтенсивні емоції, ніж зазвичай. Це може проявлятися у вигляді частих змін настрою, від радості та ейфорії до смутку та роздратування;
- тривога та занепокоєння: вагітність може викликати тривогу та занепокоєння щодо здоров'я дитини, майбутніх пологів, фінансових питань та змін у житті;
- депресія: у деяких жінок може розвинутиися депресія під час вагітності. Симптоми можуть включати постійний смуток, втрату інтересу до звичних занять, розлади харчової поведінки та сну, а також відчуття безнадійності;

- зміна інтересів: жінки можуть відчувати зміни у своїх інтересах та пріоритетах. Деякі можуть зосередитися на підготовці до народження дитини, інші – на кар'єрі або особистому розвитку;
- підвищена потреба в підтримці: вагітні жінки можуть відчувати більшу потребу в підтримці з боку партнера, сім'ї та друзів;
- фізичні зміни: гормональні зміни та фізичний дискомфорт, пов'язані з вагітністю, також можуть впливати на емоційний стан жінки;
- зв'язок з дитиною: жінки часто відчують сильний значущий емоційний зв'язок зі своєю дитиною під час вагітності. Це може проявлятися у вигляді турботи про здоров'я дитини, розмов з животом та уявлення про майбутнє з дитиною.

Як свідчать результати теоретичних й емпіричних досліджень (В. М. Астахов, О. В. Бацилєва, А. В. Картушинська, О. А. Нікіфорова, І. В. Пузь, В. Г. Сюсюка, Г. В. Шпатаковська та ін.), показники страху, тривоги та емоційного напруження у вагітних жінок є статистично вищими у порівннні з жінками, які не є вагітними. Серед психоемоційних переживань домінують страхи, пов'язані з можливими ускладненнями перебігу вагітності, загрозою втрати дитини, ризиком летальних наслідків, процесом пологів і больовими відчуттями, а також сумніви щодо власної готовності та спроможності до виконання материнської ролі. У жінок зрілого репродуктивного віку тривожність під час вагітності формується під впливом сукупності факторів, які мають як медико-біологічний, так і психологічний та соціальний характер. До основних детермінант підвищеної тривожності належать такі: По-перше, значущим джерелом тривоги є очікування можливих ускладнень перебігу вагітності, що можуть негативно позначитися на стані здоров'я плода та новонародженого. Спектр переживань у цьому контексті є досить широким і охоплює занепокоєння щодо впливу професійних навантажень, перенесених або можливих інфекційних захворювань, відсутності профілактичних щеплень у минулому, а також страхи щодо захворювання на грип,

краснуху та інші інфекції під час вагітності. По-друге, одним із факторів тривожності є незапланована або «спонтанна» вагітність. У такій ситуації жінка часто ретроспективно аналізує власну поведінку до моменту підтвердження вагітності, зокрема вживання алкоголю, тютюну чи медикаментозних засобів, що за несприятливої суб'єктивної оцінки може призводити до різкого зростання тривоги та панічних реакцій. По-третє, одним із найбільш поширених і стійких чинників тривожності є страх за здоров'я майбутньої дитини, який може мати дифузний характер і супроводжувати весь період вагітності. Також, вираженими є генетичні страхи, пов'язані з імовірністю народження дитини з вродженими вадами або порушеннями розвитку, які сприймаються як незворотні та зумовлені генетичними чинниками. По-четверте, окреме місце у структурі тривожності займає страх пологів, що включає очікування інтенсивного фізичного болю, переживання безпорадності та втрати контролю над власним тілом у процесі пологів. По-п'яте, в умовах воєнного стану рівень тривожності істотно посилюється страхом невизначеного майбутнього, що зумовлюється очікуванням глибоких і часто непередбачуваних змін у сімейному та соціальному житті. До провідних чинників тривоги належать загрози безпеці, вимушена нестабільність житлових умов, ризики матеріального неблагополуччя, а також необхідність адаптації до нових форматів сімейної взаємодії в ситуації тривалої стресової напруги. Окреме місце посідають побоювання, пов'язані з обмеженням або призупинкою професійної самореалізації, що в умовах війни набуває додаткового психологічного навантаження та підсилює загальне відчуття екзистенційної невпевненості. Таким чином, сукупність вищезазначених факторів виникнення тривожності потребують психологічного аналізу чинників психоемоційного реагування жінок зрілого репродуктивного віку під час вагітності (табл. 1).

Чинники, що впливають на психоемоційне реагування жінок зрілого репродуктивного віку під час вагітності:

– підвищена тривожність щодо здоров'я: жінки старшого репродуктивного віку можуть відчувати більшу тривогу щодо ризиків, пов'язаних з вагітністю у пізньому віці, таких як генетичні аномалії, ускладнення під час пологів та проблеми зі здоров'ям дитини;

– емоційна нестабільність: гормональні зміни, посилені переживаннями щодо вагітності, можуть призводити до більш виражених перепадів настрою, ніж у молодших жінок;

Таблиця 1

**Чинники психоемоційного реагування
жінок зрілого репродуктивного віку під час вагітності**

Індивідуально-психологічні чинники	Соціально-психологічні чинники
- тривожність щодо здоров'я, - емоційна нестабільність, - сильне бажання мати дитину, - страх перед «старінням» або відчуття енергії, - усвідомлене ставлення до вагітності, - попередній досвід, - зміни пріоритетів	- фінансова тривожність або стабільність, - соціальна підтримка, почуття самотності, - оцінне ставлення соціального оточення

– більш усвідомлене ставлення до вагітності: жінки зрілого віку часто більш усвідомлено ставляться до вагітності, ретельніше планують її та мають чіткіші очікування. Це може впливати на емоції жінок, вони стають більш зосередженими на майбутньому та відповідальності, підсилюється функція контролю;

– «сильне» бажання мати дитину: жінки старшого репродуктивного віку, які зазвичай вже мають певний життєвий досвід, можуть відчувати сильніше бажання мати дитину у порівнянні з молодшими жінками, що може впливати на їхні емоції, вони стають більш чутливими до будь-яких проблем, пов'язаних з вагітністю;

– виражена тривожність (чи, навпаки, відсутність тривожності) про фінансову стабільність: жінки зрілого віку часто мають стабільне фінансове

забезпечення, але можуть відчувати більшу відповідальність за забезпечення дитини, що може викликати додатковий стрес;

- попередній досвід: жінки, які вже мають дітей, можуть порівнювати цю вагітність з попередніми, що може впливати на їхні емоції. Жінки, які мали попередні втрати вагітності, можуть відчувати підвищену тривогу;

- соціальна підтримка: жінки зрілого віку можуть мати більшу соціальну підтримку з боку партнерів, сім'ї та друзів, що може позитивно впливати на їхній емоційний стан. У той же час, жінки також можуть відчувати у свою адресу оцінювальне/оцінююче ставлення «чужого» соціального середовища;

- зміни в пріоритетах: жінки можуть переглядати свої життєві пріоритети, зосереджуючись на сім'ї та материнстві, що може викликати як позитивні, так і негативні емоції;

- страх старіння: жінки можуть відчувати страх старіння та втрату привабливості («молодості»), що може впливати на їх самооцінку та емоційний стан. Чи, навпаки, відчувати підвищену «наявність сил та енергії, легкість», що стає «емоційним джерелом» в період вагітності.

Таким чином, вагітність у жінок старшого репродуктивного віку супроводжується підвищеним рівнем тривожності, насамперед пов'язаним із побоюваннями щодо соматичного та психічного здоров'я матері й дитини, можливих ускладнень перебігу вагітності та пологів, а також генетичних ризиків. Значний вплив на психоемоційний стан має попередній репродуктивний досвід: як позитивний (наявність дітей), що сприяє більшій впевненості, так і травматичний (втрати вагітності), який асоціюється з підвищеним рівнем тривоги. Емоційна сфера жінок характеризується більшою лабільністю, що зумовлено поєднанням гормональних змін і високої суб'єктивної значущості вагітності, а також інтенсивними переживаннями відповідальності за майбутнє материнство.

Фінансова стабільність, притаманна багатьом жінкам зрілого віку, не усуває повністю тривожності, а трансформує її у переживання підвищеної

відповідальності за матеріальне та емоційне благополуччя майбутньої дитини. Соціальна підтримка з боку партнера та близького оточення виступає важливим ресурсом емоційної стабілізації, водночас оцінювальне ставлення соціального середовища може бути додатковим стресогенним чинником. Перегляд життєвих пріоритетів у напрямі сім'ї та материнства супроводжується амбівалентними переживаннями, поєднуючи почуття сенсу й наповненості з внутрішніми сумнівами та страхами, зокрема пов'язаними з віковими змінами та самосприйняттям. Для певної частини жінок характерні переживання самотності та соціальної ізоляції, зумовлені невідповідністю життєвих етапів із найближчим соціальним оточенням, що потребує врахування у психологічному супроводі вагітності. Результати емпіричного дослідження психоемоційних станів у жінок зрілого репродуктивного віку. Емоційний стан жінок старшого репродуктивного віку під час вагітності є складним і багатовимірним утворенням, у якому поєднуються фактори підвищеної вразливості та значні особистісні ресурси, що потребують теоретико-емпіричного вивчення. Тому, для емпіричного дослідження психоемоційних станів жінок зрілого репродуктивного віку стало застосування тесту «Самооцінка психічних станів» Г. Айзенка, що дозволяє діагностувати такі психічні стани, як: тривожність, фрустрація, агресивність і ригідність. Ці стани часто посилюються у жінок внаслідок переживання репродуктивних викликів, змін гормонального фону, переоцінки життєвих цінностей і зростання відповідальності за професійну та сімейну сфери життя. Жінки після 40 років у переважній більшості мають достатній рівень особистісної рефлексивності для аналізу власних переживань, що підвищує достовірність результатів. Простота застосування, зрозумілість формулювань, відсутність надмірного когнітивного навантаження та інформативність тесту забезпечують його доцільність й знижує ризик втоми респондентів та підвищує достовірність отриманих результатів. Це особливо важливо оскільки жінки можуть перебувати в умовах хронічного стресу або соматичного дискомфорту. Аналіз результатів

тесту «Самооцінка психічних станів» (Г. Айзенк) з урахуванням вікових особливостей (40+ років) респондентів засвідчив переважання середнього рівня вираженості більшості психічних станів у всіх вікових групах, що вказує на відносно контрольований, хоча й напружений психоемоційний фон. За шкалою «Тривожність» простежується тенденція до зростання високого рівня: від 23,0 % у групі 40–42 роки до 30,0 % у жінок віком 45 років і старше. Це може свідчити про накопичення тривожних переживань, пов'язаних із віковими, соматичними та соціальними чинниками, а також із загальною нестабільністю життєвих умов. Водночас середній рівень тривожності залишається домінантним у всіх вікових підгрупах, що вказує на відносну збереженість механізмів психологічної регуляції.

Таблиця 2

Рівні вираженості психічних станів за тестом Г. Айзенка у респондентів різних вікових груп (у %)

Психічний стан / Вікова група	Низький рівень, %	Середній рівень, %	Високий рівень, %
Тривожність			
40–42 роки	28,0	49,0	23,0
43–44 роки	24,0	50,0	26,0
45 років і старше	21,0	49,0	30,0
Фрустрація			
40–42 роки	31,0	47,0	22,0
43–44 роки	28,0	48,0	24,0
45 років і старше	25,0	46,0	29,0
Агресивність			
40–42 роки	44,0	41,0	15,0
43–44 роки	42,0	40,0	18,0
45 років і старше	39,0	41,0	20,0
Ригідність			
40–42 роки	29,0	51,0	20,0
43–44 роки	27,0	50,0	23,0
45 років і старше	24,0	48,0	28,0

Подібна вікова динаміка спостерігається і за шкалою «Фрустрація». У віковій групі зростає частка респондентів із високим рівнем фрустрації, що може бути пов'язано з обмеженням ресурсів, підвищеним навантаженням та суб'єктивним переживанням бар'єрів у реалізації життєвих і особистісних планів. У іншій групі (40–42 роки) частіше фіксується низький рівень фрустрації, що свідчить про більшу гнучкість у подоланні труднощів.

За шкалою «Агресивність» у всіх вікових групах переважає низький та середній рівні, що вказує на відсутність виражених агресивних тенденцій у більшості респондентів. Разом із тим, із віком спостерігається незначне зростання високих значень агресивності, що може розглядатися як реакція на тривале емоційне напруження та накопичений стан фрустрації.

Аналіз шкали «Ригідність» засвідчив зростання показників високого рівня. У жінок віком 45 років і старше частіше фіксуються ознаки ригідності, що може відображати зниження психологічної гнучкості та підвищену потребу у стабільності й передбачуваності в умовах хронічного стресу. Водночас домінування середнього рівня ригідності в усіх групах свідчить про збереження здатності до адаптації у переважної більшості опитаних.

Загалом отримані результати вказують на те, що вік є чинником, який помірно модифікує інтенсивність психічних станів. У «старших» вікових підгрупах посилюються тривожність, фрустрація та ригідність, тоді як агресивність залишається відносно контрольованою, що відображає специфіку адаптації жінок зрілого репродуктивного віку в умовах тривалого психоемоційного напруження.

Аналіз результатів тесту «Самооцінка психічних станів» (Г. Айзенк) з урахуванням місця проживання респондентів засвідчив наявність помірних відмінностей у вираженості окремих психічних станів за збереження загальної тенденції до домінування середнього рівня у більшості показників.

**Рівні вираженості психічних станів за тестом Г. Айзенка у респондентів
залежно від місця проживання (у %)**

Психічний стан / Проживання	Низький рівень, %	Середній рівень, %	Високий рівень, %
Тривожність			
Місто	26,0	50,0	24,0
Селище	23,0	49,0	28,0
Село	21,0	47,0	32,0
Фрустрація			
Місто	30,0	48,0	22,0
Селище	27,0	47,0	26,0
Село	25,0	45,0	30,0
Агресивність			
Місто	43,0	41,0	16,0
Селище	41,0	40,0	19,0
Село	38,0	42,0	20,0
Ригідність			
Місто	28,0	51,0	21,0
Селище	26,0	50,0	24,0
Село	24,0	48,0	28,0

За шкалою «тривожності» встановлено поступове зростання високого рівня від міських мешканок до жінок, які проживають у сільській місцевості. У мешканок міста високий рівень тривожності зафіксовано у 24,0 % випадків, тоді як у жінок із сільської місцевості цей показник зростає до 32,0 %. Це може бути зумовлено обмеженим доступом до медичних, соціальних і психологічних ресурсів у сільській місцевості, а також вищою залежністю від зовнішніх факторів нестабільності.

Очікувана тенденція простежується і за шкалою «фрустрації». Респонденти із високим рівнем фрустрації зростає від 22,0 % у міських мешканок до 30,0 % у жінок, які проживають у селі. Це може відображати суб'єктивне переживання обмежених можливостей для реалізації життєвих потреб і цілей у менш урбанізованих середовищах. За шкалою «агресивності» у всіх підгрупах

переважають низький та середній рівні, що свідчить про відсутність виражених проявів агресивності. Разом із тим, у жінок, які проживають у селищах і сільській місцевості, спостерігається зростання високого рівня агресивності, що може розумітись як реакція на хронічне напруження та накопичену фрустрацію. Аналіз шкали «ригідності» показав, що у міських мешканок частіше фіксується середній рівень ригідності, тоді як у жінок із сільської місцевості зростають високі значення (28 %). Це може свідчити про більшу психологічну жорсткість і меншу готовність до змін в умовах обмежених ресурсів та підвищеної потреби у стабільності.

Загалом результати вказують на те, що місце проживання є значущим контекстуальним чинником формування психічних станів досліджуваних. У менш урбанізованих середовищах спостерігається тенденція до зростання тривожності, фрустрації та ригідності, тоді як у міських мешканок частіше зберігається помірний, більш врівноважений психоемоційний стан, що може бути пов'язано з доступністю ресурсів підтримки та адаптації.

Розглянемо результати тестування з урахуванням кількості попередніх пологів. Аналіз показав, що більшість психічних станів у всіх групах представлені також середнім рівнем, що свідчить про відносно стабільний, хоча й напружений психоемоційний фон жінок. За шкалою «тривожності» (табл.4) спостерігається зменшення показників низького рівня і одночасного збільшення високого рівня з ростом паритету: у групі жінок із першими пологами високий рівень тривожності зафіксовано у 22,0 % випадках, тоді як у групі третіх і наступних пологів – у 31,0 % жінок. Це може відображати підвищене навантаження та більшу відповідальність у жінок з більшим репродуктивним досвідом.

**Рівні вираженості психічних станів жінок зрілого репродуктивного віку
залежно від кількості попередніх пологів (у %)**

Психічний стан / Кількість пологів	Низький рівень, %	Середній рівень, %	Високий рівень, %
Тривожність			
Перші пологи	30,0	48,0	22,0
Другі пологи	25,0	50,0	25,0
Треті та наступні пологи	22,0	47,0	31,0
Фрустрація			
Перші пологи	33,0	46,0	21,0
Другі пологи	28,0	48,0	24,0
Треті та наступні пологи	26,0	45,0	29,0
Агресивність			
Перші пологи	46,0	40,0	14,0
Другі пологи	42,0	41,0	17,0
Треті та наступні пологи	39,0	42,0	19,0
Ригідність			
Перші пологи	31,0	50,0	19,0
Другі пологи	28,0	51,0	21,0
Треті та наступні пологи	25,0	48,0	27,0

Схожа тенденція простежується за шкалою «фрустрації»: кількість високих значень зростає з підвищенням кількості попередніх пологів (21,0 % у групі перших пологів і 29,0 % у групі третіх і наступних), що може свідчити про накопичення життєвих обмежень та зростання суб'єктивного сприйняття перешкод.

За шкалою «агресивності» у всіх підгрупах переважають низький та середній рівні. Водночас у жінок із першим репродуктивним досвідом спостерігається низький рівень (46,0 %) показників за шкалою, тоді як у групі третіх і наступних пологів збільшується кількість високих значень (19,0 %), що може відображати реакцію на хронічну психоемоційну напругу та збільшене побутове навантаження.

Аналіз шкали «ригідності» показав, що в жінок із першим репродуктивним досвідом частіше фіксується середній рівень ригідності, тоді як у групі третіх і наступних пологів зростає частка високих значень (27,0 %). Це може вказувати на зниження психологічної гнучкості та підвищену потребу у стабільності в умовах підвищеного навантаження. Таким чином, застосування тесту «Самооцінка психічних станів» Г. Айзенка у вибірці жінок зрілого репродуктивного віку є методично доцільним і дозволяє отримати інформативні дані щодо вираженості тривожності, фрустрації, агресивності та ригідності як показників психоемоційного стану в умовах підвищеного життєвого й репродуктивного навантаження.

Висновки. Узагальнений аналіз результатів засвідчив домінування середнього рівня більшості психічних станів у всіх досліджуваних підгрупах, що вказує на відносно контрольований, проте напружений психоемоційний фон жінок зрілого репродуктивного віку. Віковий чинник помірно модифікує інтенсивність психічних станів: у старших вікових підгрупах (45 років і старше) спостерігається тенденція до зростання високих рівнів тривожності, фрустрації та ригідності, тоді як агресивність залишається переважно в межах низьких і середніх значень. Це свідчить про збереження соціально прийнятних форм емоційної регуляції на тлі зростання внутрішньої напруги. Місце проживання виступає значущим контекстуальним чинником психічних станів. У жінок, які проживають у сільській місцевості, виявлено вищі показники тривожності, фрустрації та ригідності порівняно з міськими мешканками, що може бути пов'язано з обмеженістю ресурсів підтримки, підвищеною залежністю від зовнішніх умов та потребою у стабільності. Кількість попередніх пологів є диференціальним фактором психічних станів. Зі зростанням паритету посилюються прояви тривожності, фрустрації та ригідності, що відображає накопичення психоемоційного та побутового навантаження. Водночас агресивність у всіх підгрупах залишається відносно контрольованою. Отримані

теоретичні та емпіричні результати підтверджують науковий аналіз та висновок – психоемоційні стани жінок зрілого репродуктивного віку виникають під впливом вікових, індивідуально-психологічних та соціально-психологічних чинників.

Список використаних джерел.

1. Астахов В. М., Бацилєва О. В., Пузь І. В. Психологічний супровід у репродуктивній медицині: монографія. Київ, 2023. 125 с.
2. Бацилєва О. В., Пузь І. В. Психологічні аспекти вагітності жінок пізнього репродуктивного віку. Проблеми сучасної психології. 2014. № 25. С. 45–56. DOI: <https://doi.org/10.32626/2227-6246.2014-23.%25p>
3. Войцеховська Н. В. Перинатальна психологія: навч. посіб. / Н. В. Войцеховська. Київ: Центр учбової літератури, 2012. 40 с.
4. Картушинська А. В. Особливості психологічного здоров'я жінок репродуктивного віку: дис. д-ра філософії. Ніжин: Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, 2023. 239 с.
5. Коренєва Ю. П. Психологічні особливості перебігу вагітності у пізньому репродуктивному віці. Молодий вчений. 2017. № 3. С. 260–263.
6. Перепелюк Т. Д. Психологічна допомога жінкам, які страждають безпліддям, в умовах медичної установи. Психологічні студії. Луцьк: Волинський національний університет імені Лесі Українки. 2023. № 3. URL: <http://journals.vnu.volyn.ua/index.php/psychology/article/view/1356/1262>
7. Сюсюка В.Г. Клініко-патогенетичні аспекти акушерських і перинатальних ускладнень у жінок з урахуванням психоемоційного стану та їх медико-психологічна корекція: дис. ... д-ра мед. наук: 14.01.01. Запоріжжя, 2018. 395 с.
8. Сюсюка В. Г., Котлова Ю. В. Вплив тривожності жінок під час вагітності на стан новонароджених та перебіг їх раннього неонатального періоду.

Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. 2014. № 1. С. 117-120.

9. Стовбан І.В.1, Стовбан М.П.2, Медведовська Н.В. Вплив соціально-економічних та трудових факторів на репродуктивне здоров'я жінок у період війни. Актуальні проблеми профілактичної медицини. 2025. № 29 (2025), с. 120-132. URL: <https://journals.meduni.lviv.ua/index.php/appm/article/view/174>

10. Тарасенко К. В. Характеристика реакції тривоги у вагітних з надмірною вагою. Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України. Київ : Інтермед, 2007. С. 653-655.

11. Тимків І. С. Психологічні проблеми вагітності та перинатального періоду. Буковинський медичний вісник. 2014. Т. 18, № 1 (69). С. 182-185.

12. Шпатаковська Г. В. Дослідження психоемоційного стану жінок у період адаптації до вагітності. Вісник Одеського національного університету. Психологія. Том 14, № 26. 2019. С. 102 – 110.

Інноваційні підходи у соціальній інтеграції та психологічній адаптації українців у новому соціокультурному середовищі

Тарасенко О.І.

*здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти
Академія праці, соціальних відносин і туризму, м. Київ*

Актуальність. Проблематика соціальної інтеграції особистості зумовлена масштабною вимушеною міграцією громадян України до країн Європи внаслідок повномасштабної війни та складними соціально-психологічними процесами, що супроводжують адаптацію в нових соціокультурних умовах. Перебування у статусі вимушених мігрантів пов'язане з пролонгованим стресом, травматичним досвідом війни, втратою звичних соціальних ролей, професійної ідентичності та усталених мереж соціальної підтримки. У сукупності ці фактори істотно ускладнюють процес включення особистості у приймаюче суспільство та підвищують ризики соціальної ізоляції, маргіналізації й вторинної травматизації. За таких умов особливої ваги набуває проблема забезпечення психологічної стабілізації як базового підґрунтя подальшої соціальної інтеграції. Без відновлення відчуття безпеки, суб'єктності та контролю над власним життям інтеграційні заходи у сфері працевлаштування, освіти чи соціальної участі мають обмежену ефективність. Водночас наявні практики підтримки українців за кордоном у багатьох випадках характеризуються фрагментарністю, короткостроковою орієнтацією та відсутністю системного міждисциплінарного підходу. Соціальна допомога, психологічні сервіси та інтеграційні програми нерідко функціонують ізольовано, що не відповідає комплексній природі адаптаційних процесів вимушених мігрантів. Це актуалізує потребу в науковому осмисленні інтеграції як цілісного соціально-психологічного феномену та розробленні сталих моделей підтримки, зокрема в контексті діяльності громадських організацій як важливих суб'єктів інтеграційних процесів.

Повномасштабна війна в Україні спричинила одну з найбільших хвиль вимушеної міграції в Європі з часів Другої світової війни. Мільйони українців опинилися в нових соціокультурних, правових та економічних реаліях, що актуалізувало питання не лише їхнього тимчасового захисту, а й довгострокової інтеграції у приймаючі суспільства. У цьому контексті соціальна інтеграція перестає бути суто гуманітарним завданням і набуває стратегічного значення для стабільності європейських держав, розвитку ринку праці та соціальної згуртованості. Разом з тим емпіричні спостереження свідчать, що без системного врахування психологічного стану вимушених мігрантів інтеграційні політики та програми не досягають очікуваних результатів.

Звернення до сучасних наукових досліджень вказує на послідовну трансформацію підходів до соціальної інтеграції вимушених мігрантів у європейських країнах. Так, роботи Berry (1997) акцентують увагу на тому, що інтеграція є багатовимірним процесом, який включає не лише поведінкові, але й психосоціальні компоненти адаптації, що визначають здатність особистості до міжкультурної взаємодії та соціального функціонування. У подальших розширеннях цієї концепції дослідники Ager та Strang (2008) виокремлюють ключові складові інтеграції, серед яких соціальні зв'язки, правовий статус, доступ до ринку праці та культурні навички, що стають критеріями вимірювання довгострокової інтеграційної успішності. Останні публікації із соціальної політики та міграційних студій підкреслюють, що успішність інтеграційних програм значною мірою залежить від синхронізації міждержавних політик, громадських ініціатив і локальних практик (Castles, de Haas & Miller, 2020). У той же час сучасні дослідження в галузі психологічної адаптації мігрантів (Smith et al., 2021) звертають увагу на вагомий вплив психологічної стабілізації на процес адаптації, зокрема у вимірі зниження ризику розвитку посттравматичних реакцій і підвищення когнітивної та емоційної гнучкості. У наукових обґрунтуваннях європейські соціологи й психологи відзначають, що інтеграційні моделі, які

ігнорують міждисциплінарну природу адаптації, зазнають значних обмежень у практичному впровадженні та досягненні сталих результатів. Дослідження Schwab (2022) щодо інтеграційних екосистем у мультикультурних контекстах демонструє, що традиційні політики «асиміляції» поступаються більш адаптивним моделям взаємного включення, які базуються на діалозі культурних цінностей та спільних суспільних практиках. Публікації останніх років також підкреслюють зростання ролі громадських організацій як каталізаторів інноваційних інтеграційних практик (Koehler & Fix, 2023), що безпосередньо корелює з емпіричними спостереженнями щодо діяльності українських і міжнародних НГО у приймаючих країнах ЄС і Швейцарії.

Системний аналіз сучасної літератури дозволяє дійти висновку, що *інтеграційні моделі майбутнього мають поєднувати соціально-структурні чинники та психосоціальну підтримку*, оскільки саме така синергія створює передумови для стійкого соціального включення та суб'єктної активності вимушених мігрантів у новому соціокультурному середовищі.

Мета дослідження. Полягає в аналізі інноваційних підходів до соціальної інтеграції та психологічної адаптації українців у новому соціокультурному середовищі.

У науковому дискурсі соціальна інтеграція розглядається як багатовимірний процес включення індивіда у соціальні, економічні, культурні та інституційні структури приймаючого суспільства. Вона передбачає не лише доступ до матеріальних і соціальних ресурсів, а й формування відчуття соціальної приналежності, визнання та значущості.

Результати дослідження. *Психологічна адаптація* охоплює сукупність внутрішніх процесів, спрямованих на подолання стресу, наслідків травматичного досвіду, втрати звичних соціальних ролей і відновлення суб'єктності. Для вимушених мігрантів соціальна інтеграція та психологічна адаптація перебувають у тісному взаємозв'язку: психологічна дестабілізація істотно знижує здатність до

навчання, працевлаштування, міжкультурної комунікації та соціальної активності. Таким чином, інтеграцію українців у новому соціокультурному середовищі доцільно розглядати як *інтегративну модель*, у межах якої соціальні та психологічні компоненти є нероздільними й взаємодоповнюючими.

Основні виклики інтеграції українців у новому середовищі. Аналіз практичного досвіду роботи з українськими громадами за кордоном дозволяє виокремити низку системних викликів: багаторівнева травматизація, зумовлена воєнними подіями, втратаю дому та соціальних зв'язків; фрагментарність інтеграційних програм і відсутність єдиного координаційного підходу; орієнтація державних і недержавних політик на короткострокову підтримку замість стратегічного розвитку; недостатня інтеграція психологічних сервісів у програми працевлаштування та освіти; ризик соціальної ізоляції та формування замкнених «паралельних спільнот».

Зазначені фактори свідчать про необхідність переосмислення існуючих моделей інтеграції та переходу до більш системних і стійких рішень.

Інноваційні підходи до соціальної інтеграції. Одним із ключових інноваційних зрушень у сучасних інтеграційних практиках є перехід від патерналістської моделі допомоги до моделі партнерства та підсилення (empowerment). У межах цього підходу українці в міграції розглядаються не як пасивні отримувачі допомоги, а як активні учасники соціально-економічних процесів. До найбільш ефективних інноваційних інструментів належать: гібридні інтеграційні платформи, що поєднують офлайн- та онлайн-формати взаємодії; менторські й наставницькі програми за принципом «peer-to-peer»; професійні спільноти та галузеві нетворкінги; міжсекторальні форуми, які об'єднують державні інституції, бізнес і громадські організації.

Зазначені підходи сприяють не лише адаптації, а й активному включенню українців у локальні соціальні та професійні мережі приймаючих суспільств.

Психологічна адаптація як стратегічний компонент інтеграції. Психологічна адаптація має розглядатися не як допоміжний сервіс, а як

структуруючий елемент інтеграційної політики. Практика соціально-психологічної роботи з вимушеними мігрантами засвідчує, що найбільш ефективними є: групові формати психологічної підтримки, які знижують рівень соціальної ізоляції; інтеграція психологічних модулів у програми кар'єрного консультування та професійної адаптації; нормалізація психологічної вразливості без стигматизації; розвиток навичок саморегуляції та відновлення відчуття контролю над власним життям. Психологічна стабілізація безпосередньо впливає на швидкість і якість соціальної інтеграції та рівень соціальної активності вимушених мігрантів.

Роль громадських організацій та лідерів спільнот. Громадські організації відіграють домінуючу роль у формуванні інтеграційних екосистем. Вони виконують функції: соціальних навігаторів; фасилітаторів між інституціями; перекладачів між культурами та соціальними системами. Завдяки гнучкості, міжсекторальності та близькості до реальних потреб громад саме громадські організації стають простором для апробації інноваційних інтеграційних рішень, які згодом можуть бути масштабовані на рівень державної політики.

Висновки. У статті проаналізовано сучасні виклики соціальної інтеграції та психологічної адаптації українців, які перебувають у вимушеній міграції в європейських країнах, зокрема у Швейцарії. Обґрунтовано необхідність переходу від фрагментарних моделей підтримки до системних, інноваційних і міждисциплінарних підходів. Визначено роль психологічної стабілізації як базового чинника успішної інтеграції та окреслено функцію громадських організацій як ключових фасилітаторів інтеграційних процесів. Соціальна інтеграція українців у новому середовищі є комплексним і довгостроковим процесом, що потребує системного наукового підходу, орієнтованого на партнерство, підсилення та розвиток людського капіталу. Подальші дослідження доцільно спрямувати на оцінку ефективності конкретних інтеграційних практик,

а також на розроблення універсальних індикаторів успішної психологічної та соціальної адаптації.

Список використаних джерел.

1. Berry J. W. Immigration, Acculturation, and Adaptation. Applied Psychology, 1997.
2. Ager A., Strang A. Understanding Integration: A Conceptual Framework. Journal of Refugee Studies, 2008.
3. UNHCR. Operational Guidelines for the Protection of Persons in Situations of Forced Displacement.
4. Castles S., de Haas H., Miller M. The Age of Migration. Palgrave Macmillan.

Оцінка результатів розвитку конкурентоспроможної особистості в сучасному суспільстві

Франчук І. В.

*Здобувач другого(магістерського) рівня вищої освіти
Академія праці, соціальних відносин і туризму, м. Київ*

Бондар С.І.

*Кандидат психологічних наук, доцент
Академія праці, соціальних відносин і туризму, м. Київ*

Петько Л.В.

*Кандидат педагогічних наук, доцент
Академія праці, соціальних відносин і туризму, м. Київ*

Актуальність. Соціально-психологічні чинники розвитку конкурентоспроможності особистості взаємопов'язані. Так, типологічні особливості безробітного такі як екстраверсія чи інтроверсія, дозволяють йому спрямовувати мотивацію на розвиток складових конкурентоспроможності. У свою чергу, розвиток мотивації особи, яка шукає роботу, є важливим чинником пошуку можливих варіантів досягнення подальшої соціальної успішності. Одним з методів, який спричиняє становлення та розвиток мотивації до успіху, є присутність інтересу до певного виду роботи та трудової діяльності, та здобуток в ній результативного ефекту. Саме це спонукає особистість до діяльності у відповідному напрямі, а також збільшує її вмотивованість до такої роботи. При цьому мотивація до успіху може перейти на потужну особистісну потребу, яка з часом визначатимуть конкурентоспроможність особистості в сучасному суспільстві.

Рушійною силою досягнення вершин професіоналізму особистості як соціального чинника є самовдосконалення та саморозвиток, що забезпечує підвищення загального інтелектуального рівня особистості, розширює її кругозір та коло спілкування, оскільки освічена людина вільно орієнтується в сучасних

складних умовах. У результаті покращується психологічний стан, підвищується мотивація безробітного до успіху у контексті активного пошуку роботи та майбутнього працевлаштування.

Як зазначають науковці [9–14], ситуація безробіття належить до психологічно травмуючих, що викликають зміни у самосвідомості людини. Перебування в ситуації безробіття спричиняє значні зміни у мотиваційній сфері і самооцінці безробітного. Це підтверджено результатами емпіричного дослідження. Нами з'ясовано, що співвідношення мотивації до успіху та рівня самооцінки здатності до самовдосконалення з рівнем конкурентоспроможності безробітного в умовах сучасного ринку праці сприяють більш високим результатам щодо пошуку роботи та працевлаштування. Тому розвиток конкурентоспроможної особистості розглядається як взаємодія та єдність соціальних і психологічних чинників, які мають вплив на індивідуально-психологічну сферу особистості, що в сукупності дає можливість визначати якість та успішність безробітного до пошуку роботи та працевлаштування. Зазначені чинники конкурентоспроможності є взаємозалежними та взаємозумовленими, лише в сукупності забезпечують успішну професійну діяльність у нових економічних умовах і конкурентоспроможність особистості на ринку праці.

Аналіз практичної роботи у та результати наукових досліджень переконують в тому, що успішність психологічної роботи з такою категорією як безробітні в значній мірі залежить від впровадження програм психологічного супроводу. Важливу роль у забезпеченні ефективної зайнятості безробітних і вивільнюваних працівників відіграє переорієнтація і перепідготовка людей на нові професії, місця роботи. Це в свою чергу вимагає відповідного зростання професійної компетентності профконсультантів (психологів) служби зайнятості, їх уміння правильно зорієнтувати безробітного на потрібні й близьким його індивідуально-психологічним можливостям професії, вакансії. Тобто, психологічний супровід стає одним з ключових елементів управління рухом

робочої сили відповідно до потреб ринку праці, а психодіагностика – одним із засобів його здійснення. Проте використання форм і методів психологічного супроводу, дає можливість визначати схильність клієнта служби зайнятості до тієї чи іншої сфери діяльності, професії, робочого місця і запропонувати йому оптимальні варіанти відповідно до його властивостей [1–8].

Особливу практичну значимість програми психологічного супроводу індивідуально-психологічних особливостей людини набуває в умовах розширення системи й обсягів переорієнтації, перепрофілювання та перепідготовки безробітних і вивільнюваних працівників в умовах кризи. Успішне вирішення цих завдань неможливе без знання індивідуально-психологічних й особистісних властивостей клієнта, його мотивації і професійного рівня. Таку інформацію можна отримати за допомогою психодіагностичних методик. За допомогою психодіагностичного інструментарію може бути отримана інформація для прогнозування успіхів у працевлаштуванні й діяльності, для рекомендацій щодо переорієнтації та перенавчання особистості.

Мета. Дослідити результати розвитку конкурентоспроможної особистості в сучасному суспільстві.

Результати дослідження. Результати діагностування досліджуваних експериментальної групи (ЕГ) і контрольної групи (КГ) після проведення формувального етапу. Так, на питання «Як Ви вважаєте, Ви загалом соціально успішна особистість чи ні?» розподіл відповідей такий: в ЕГ 24 (75,0 %) безробітних відповіли, що «так», а 8 (25,0 %), що «ні»; у КГ 15 (46,88 %) досліджуваних відповіли, що «так», проте 17 (53,12 %), що «ні». В ЕГ переважна більшість безробітних після проведення тренінгової програм стали вважати себе соціально успішними. У безробітних з КГ відсоткові значення щодо розуміння власної соціальної успішності майже не змінилися. Щодо встановлення рівня професіоналізму у ході бесід з безробітними встановлено: в ЕГ 26 (81,25 %)

досліджуваних вважають, що мають високий і достатній рівень професіоналізму у своїй галузі, 6 (18,75 %) визначають власний рівень професіоналізму як низький; у КГ 20 (62,50 %) безробітних вважають, що мають високий і достатній рівень професіоналізму у своїй галузі, а 12 (37,50 %), що – низький. Отже, щодо розуміння рівнів професіоналізму судження досліджуваних і в ЕГ, і в КГ майже не змінилися: переважна більшість досліджуваних вважають себе достатньо професійними фахівцями. Узагальнені результати діагностування досліджуваних ЕГ та КГ за опитувальниками і методикою надано у табл. 1.

У досліджуваних ЕГ за всіма середніми показниками ($\bar{X}$) опитувальників і методики визначення підвищення. Так, середній показник щодо мотивації успіху та остраху невдач після формувальних заходів підвищився на 2,63 бали і став 15,31. Він характеризує мотивацію до успіху. Отже формувальні заходи психолога сприяли підвищенню середнього рівня мотивації у безробітних ЕГ. У досліджуваних КГ середній показник ($\bar{Y}$) зменшився на 0,59 бали і характеризує не виражений мотиваційний полюс, але з тенденцією мотивації на успіх.

Таблиця 1

**Результати діагностування після формувального етапу
(середні показники)**

Показники	ЕГ ($\bar{X}$)		КГ ($\bar{Y}$)	
	на початку	у кінці	на початку	у кінці
Мотивація	12,68	15,31	11,59	11,00
Рівень самооцінки здатності до самовдосконалення	39,85	47,75	40,72	43,50
Рівень конкурентоспроможності	85,69	110,5	79,28	82,55

Відзначимо, що у досліджуваних ЕГ значно підвищилися середні показники рівнів самооцінки здатності до самовдосконалення і рівнів

конкурентоспроможності: на 7,9 (47,75-39,85) і на 24,81 (110,5-85,69) відповідно. Середній показник самооцінки здатності до самовдосконалення став 47,75 бали і характеризує рівень декілька вищий за середній. Середній показник і 110,5 бали характеризує рівень конкурентоспроможності вищий за середній. У досліджуваних КГ значних змін у середніх показниках рівнів самооцінки здатності до самовдосконалення і рівнів конкурентоспроможності у результаті повторного діагностування не встановлено. Представимо наочно розвиток конкурентоспроможності в ЕГ та КГ досліджуваних на початку (до) і в кінці (після) формувального етапу емпіричного дослідження використовуючи середні показники досліджуваних за методикою «Оцінка рівня конкурентоспроможності особистості» на рис. 1.

Таким чином, після проведення з досліджуваними ЕГ тренінгової програми, у них значно підвищився середній показник рівня конкурентоспроможності від середнього до вищого за середній. У досліджуваних КГ середні показники майже не змінилися. Ефективність розробленої та апробованої тренінгової програми перевіримо за допомогою t-критерія Стюдента. Для цього складемо дві статистичних гіпотези.

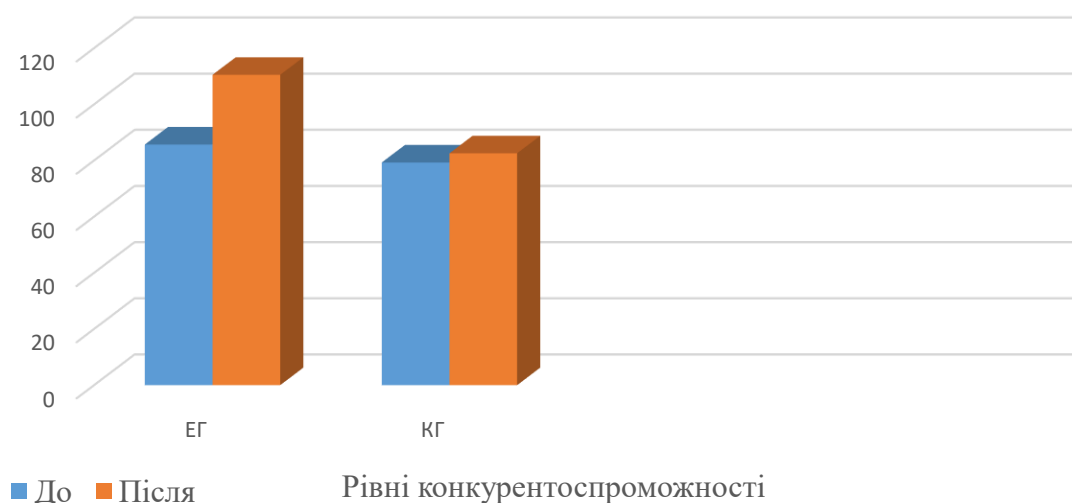


Рис. 1. Розвиток конкурентоспроможності особистості

H_0 (нульова гіпотеза) – середні показники мотивації (рівня самооцінки до самовдосконалення, рівня конкурентоспроможності) у досліджуваних ЕГ (КГ) на початку і в кінці формувального етапу не відрізняються;

H_1 (альтернативна гіпотеза) – середні показники мотивації (рівня самооцінки до самовдосконалення, рівня конкурентоспроможності) у досліджуваних ЕГ (КГ) на початку і в кінці формувального етапу мають суттєві відмінності. За результатами діагностування в кінці формувального етапу t -критерії Стюдента і порівнюємо їх з критичним значенням на рівні достовірності 0,05 за ступенями свободи $\alpha = 32+32-2 = 62$. На рівні значущості 0,05 виконується нерівність $t_{\text{емпіричне}} \geq t_{\text{крит}}$ тому маємо підстави стверджувати, що середні показники мотивації (рівня самооцінки до самовдосконалення, рівня конкурентоспроможності) у досліджуваних ЕГ на початку і в кінці формувального етапу мають суттєві відмінності. Отже, тренінгова програма в ЕГ досліджуваних була ефективною.

Таблиця 2

**Значення t – критерія Стюдента для досліджуваних ЕГ
(на початку і в кінці формувального етапу)**

Показники	ЕГ				$t_{\text{емпіричне}}$	Порівняння $t_{\text{критичне}} = t_{0,05;62} = 2,000$
	$\bar{X}$	S_x^2	$\bar{Y}$	S_y^2		
Мотивація	12,31	9,13	15,31	9,22	$t = 3,507$	$t_{\text{емпір}} \geq t_{\text{крит}}$
Рівень самооцінки здатності до самовдосконалення	39,85	36,11	47,75	18,00	$t = 8,672$	$t_{\text{емпір}} \geq t_{\text{крит}}$
Рівень конкурентоспроможності	85,69	594,35	110,5	130,06	$t = 5,277$	$t_{\text{емпір}} \geq t_{\text{крит}}$

Встановлено, що для мотивації і рівня конкурентоспроможності для досліджуваних КГ підтверджена нульова гіпотеза: середні показники мотивації і

рівня конкурентоспроможності у досліджуваних КГ на початку і в кінці формувального етапу не відрізняються.

Для рівня самооцінки здатності до самовдосконалення у досліджуваних КГ підтверджена альтернативна гіпотеза: середні показники рівня самооцінки до самовдосконалення у досліджуваних КГ на початку і в кінці формувального етапу мають суттєві відмінності. Це пояснено тим, що така категорія досліджуваних як безробітні при знаходженні на обліку у центрах зайнятості під впливом соціальних факторів опосередковано підвищують власну самооцінку до самовдосконалення з метою подальшого працевлаштування.

Таблиця 3

**Значення t – критерія Стюдента для досліджуваних КГ
(на початку і в кінці формувального етапу)**

Показники	КГ				$t_{\text{емпіричне}}$	Порівняння, $t_{\text{критичне}} =$ $t_{0,05;62} =$ 2,000
	$\bar{X}$	S_x^2	Y	S_y^2		
Мотивація	11,59	4,22	11,00	6,19	$t = 1,035$	$t_{\text{емпір}} \leq t_{\text{крит}}$
Рівень самооцінки здатності до самовдосконалення	40,72	42,42	43,50	47,35	$t = 5,148$	$t_{\text{емпір}} \geq t_{\text{крит}}$
Рівень конкурентоспроможності	79,28	902,59	82,55	74,05	$t = 0,454$	$t_{\text{емпір}} \leq t_{\text{крит}}$

Показником ефективності проведення програм психологічного супроводу безробітних можна вважати зміну їх емоційно-психологічного стану, готовність до розробки і прийняття самостійних рішень щодо вибору чи зміни професії, професійного навчання, працевлаштування, створення в процесі взаємодії простору для розвитку безробітного, передумов конструктивного вирішення його проблем. При цьому психолог має виходити з того, що у безробітного завжди є можливості для вирішення своїх проблем, а завдання психолога полягає у

виявленні прихованих потенційних ресурсів безробітного, його можливостей і здібностей, які дозволяють сформулювати мету і рухатися далі. Вважаємо, що психолог має вести бесіди з безробітним саме про його ресурси, потенційні можливості, а не про обмеження, формулювати позитивне ставлення до професійного майбутнього.

Важливо, щоб безробітний сам сформулював свою мету і знаходив шляхи її реалізації, а психолог виступав при цьому лише порадиником. У психологічній роботі з безробітними, у першу чергу, наголос має робитися на особистість безробітного, на його особистісний потенціал – той необхідний інструмент, який людина використовує для своєї самореалізації у професійній діяльності. Визначення особистісного потенціалу (за допомогою психодіагностичного інструментарію) безробітних та сфери їх інтересів стосовно певної професійної діяльності дозволяє сформувати напрями розвитку конкурентоспроможності кожного безробітного таким чином, щоб розвивати його сильні сторони і компенсувати слабкі. Це дає можливість підвищити їх конкурентоспроможність і активність у пошуку роботи, працевлаштуванні.

Результати проведеного дослідження дозволяють констатувати, що впровадження програм психологічного супроводу в психологічній роботі має проводитися на таких рівнях: а) мотиваційному (підвищення активності і мотивації у пошуку роботи, самопізнанні і саморозвитку, актуалізації потреби в роботі тощо); б) когнітивному (підвищення самооцінки, впевненості в собі, корекція уявлень про себе у навколишньому світі); в) емоційному (корекція емоційно-психологічного стану, формування навичок для його регуляції); г) поведінковому (формування ефективних умінь та навичок ефективної поведінки на ринку праці відповідно своїх індивідуально-психологічних особливостей та можливостей).

Висновки. Доведено, що ефективною формою розвитку конкурентоспроможної особистості є тренінгова програма. Метою програми став

розвиток компонентів конкурентоспроможності особистості в умовах кризи. До завдань програми віднесено такі: 1) посилення самоефективності як складової мотиваційного компонента розвитку конкурентоспроможності; 2) розвиток інноваційного потенціалу особистості як основного ресурсу діяльнісного компоненту розвитку конкурентоспроможності; 3) посилення комунікативних навичок та навичок соціальної взаємодії як складових індивідуально-психологічного компонента розвитку конкурентоспроможності. Результати запропонованої тренінгової програми «Психологічний супровід процесу розвитку конкурентоспроможності особистості в сучасному суспільстві» та оцінка її ефективності дали змогу виявити достовірні кількісні і якісні зміни в експериментальній групі, на відміну від контрольної, що, на нашу думку, пояснюється позитивним впливом роботи психолога з цією категорією досліджуваних. Так, дослідження на основі статистично значущих показників показало, що в безробітних експериментальної групи значно підвищилися середні показники мотивації, рівнів самооцінки здатності до самовдосконалення та рівнів конкурентоспроможності. У контрольній групі статистично значущі зміни щодо зазначених критеріїв не спостерігалися. Отримані дані можуть бути застосовані та поширені в системі підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників центрів зайнятості з метою забезпечення їх комплексної підготовки до здійснення ефективної професійної діяльності.

Список використаних джерел.

1. Бегеза Л.Є. Психологія особистості безробітного/Соціально-психологічний супровід в роботі фахівців служби зайнятості: монографія за заг. ред. Г.А. Пріба; Є.М. Калюжна. Київ: ІПК ДСЗУ, 2020. С. 69–111.
2. Дорожкін В. Р. Соціально-психологічна адаптація внутрішньо переміщених осіб до особливостей сучасного ринку праці / Соціально-психологічний супровід в роботі фахівців служби зайнятості: монографія за заг. ред. Г. А. Пріба; Є. М. Калюжна. Київ: ІПК ДСЗУ, 2020. С. 40–68.

3. Карамушка М. І. Психологічні особливості розвитку соціально активної молоді. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. – Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України. Київ, 2020. 257 с.

4. Кас'янова С. Б. Емоційний інтелект у системі особистісних ресурсів безробітного. Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії у галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 053 «Психологія». Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, Київ, 2020. 309 с.

5. Матвієнко Л. І. Особливості мотивації безробітних із числа внутрішньо переміщених осіб до активного пошуку роботи. Ринок праці і зайнятість в Україні: реалії та перспективи: колективна монографія / За наук. ред. С. Кожем'якіної, С. Калініної. К.: ІПК ДСЗУ, 2018. 424 с. Розділ 4.1. С.214–221.

6. Матвієнко Л. І., Ортікова Н. В. Поняття кар'єри і кар'єрного зростання фахівців державної служби зайнятості / Л.І. Матвієнко, Н.В. Ортікова // Актуальні проблеми психології: збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. Київ; Ніжин : ПП Лисенко, 2017. Том IX. Загальна психологія. Історична психологія. Етнічна психологія. Вип. 10. С.114–122.

7. Мілютіна К. Л. Особливості життєвої стратегії особистості у сфері зайнятості в умовах соціальної нестабільності. Ринок праці та зайнятість населення. К.: ІПК ДСЗУ, 2015, Випуск 2. С. 54–58.

8. Пріб Г. А., Бегеза Л. Є. Професіогенез особистості: соціально-психологічні аспекти. Проблеми сучасної психології. 2019. № 2. С. 102–107.

9. Психологічні детермінанти розвитку організаційної культури : монографія / Л. М. Карамушка, О. В. Креденцер, К. В. Терещенко [та ін.]; за ред. Л. М. Карамушки. Київ: Педагогічна думка, 2015. 288 с.

10. Психологічний інструментарій для фахівців служби зайнятості: методичні рекомендації / за заг. ред. Г. А. Пріба; автори-упорядники: В. Р.

Дорожкін, Я. Ц. Зелінська, Є. М. Калюжна, Л. І. Матвієнко, Г. А. Приб, Г. В. Циганенко. Київ: ПП К ДСЗУ, 2019. 152 с.

11. Рибалка В. В. Психологія честі та гідності особистості: культурологічні та аксіологічні аспекти: [наук.-метод. пос.] / В.В. Рибалка. Київ: ТОВ “Інформаційні системи”, 2011. 428 с.

12. Ткалич М. Г. Психологія гендерної взаємодії персоналу організацій : [монографія] / М. Г. Ткалич. Київ-Запоріжжя : ЗНУ, 2015. 315 с.

13. Шевченко Н. Ф., Задорожна М. М. Психологічні чинники формування відповідальності як загальної компетенції студентів. Проблеми сучасної психології. 2018. № 1. С. 196–201.

14. Karamushka L., Baranova V., Klochko A. Management style as a factor in the development of organizational culture of extracurricular educational institutions. Zjazd polskiego stowarzyszenia psychologii organizacji. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin, al. Raławickie 14, 20–950. Lublin, Gmach CTW 24–25 maja 2018. S. 78.

Особливості ціннісних орієнтацій щодо сім'ї та шлюбу у сім'ях, де є діти з розладами аутистичного спектра

*Царгородська А.О.
Здобувач другого(магістерського) рівня вищої освіти
Академія праці, соціальних відносин і туризму, м. Київ*

Актуальність. Виховання дитини з розладами аутистичного спектра (РАС) створює значні психоемоційні та соціальні виклики для сімей, впливаючи на ціннісні орієнтації щодо сім'ї та шлюбу, ментальне здоров'я батьків і загальну життєстійкість родини. Зростання кількості дітей із діагнозом РАС як в Україні, так і в світі, підтверджене сучасними епідеміологічними дослідженнями, підкреслює необхідність адресної психологічної підтримки подружніх пар. Такі сім'ї часто стикаються з підвищеною тривожністю, гіперпротекцією, дисбалансом ролей у подружжі та соціальною ізоляцією, що призводить до деструктивних змін у ціннісній сфері. Зокрема, спостерігається надмірний акцент на стабільності та безпеці за рахунок самореалізації, що суттєво ускладнює адаптацію до умов кризового батьківства. Як зазначає О.М. Ходаківська, психологічні особливості сімей, які виховують дитину з інвалідністю, включають емоційне виснаження та накопичення хронічного стресу [6].

Стан вивчення теми свідчить про значну увагу до проблеми психологічної підтримки сімей з дітьми з РАС як у зарубіжній, так і у вітчизняній науковій літературі, однак багато аспектів залишаються недостатньо розробленими, особливо в контексті українського соціокультурного середовища. Зарубіжні дослідники акцентують увагу на моделях адаптації батьків до стресових умов виховання: наприклад, Р.П. Гастінгс аналізує взаємозв'язок між проблемами поведінки дитини та ментальним здоров'ям подружжя, виявляючи значну кореляцію зі стресом [10]. Б. Ван Дер Колк розглядає вплив психологічних травм на організм і пропонує тілесно-орієнтовані підходи до їх подолання в сім'ях з особливими дітьми [2]. Серед вітчизняних авторів О.Л. Вознесенська досліджує

можливості арт-терапії як засобу зниження емоційного напруження в таких родинях [3], тоді як М.Й. Боришевський підкреслює роль ціннісних орієнтацій у процесі особистісного становлення, яке може порушуватися в умовах кризи [5]. І.Д. Бех акцентує на духовних цінностях як регуляторах поведінки та мотивації в складних життєвих ситуаціях [1]. Попри наявні напрацювання, більшість досліджень зосереджені на окремих аспектах – емоційному стані батьків, виховних стилях чи соціально-педагогічній підтримці, – без створення комплексних програм, адаптованих до соціокультурних і економічних реалій України. Відсутність системних, науково обґрунтованих програм психологічної допомоги, які б враховували гендерні відмінності, ступінь тяжкості розладу та вплив оточення, актуалізує потребу в розробці комплексних рішень. Такі рішення мають бути спрямовані не лише на корекцію емоційного стану, а й на збереження сімейного ресурсу, зміцнення подружніх стосунків і підвищення психологічної стійкості родини загалом.

Мета дослідження. Вивчення особливостей ціннісних орієнтацій щодо сім'ї та шлюбу у сім'ях, де є діти з розладами аутистичного спектра, з акцентом на аспекти ментального здоров'я та життєстійкості, а також розробка програми психологічної підтримки подружніх пар як засобу корекції та профілактики деструктивних змін у ціннісній сфері. Для досягнення мети виконано наступні завдання: визначено особливості деструктивних змін у ціннісній сфері на основі теоретичного та емпіричного аналізу; виявлено ключові потреби подружніх пар у психологічній підтримці; розроблено та обґрунтовано програму підтримки з інтеграцією когнітивно-поведінкових, арт-терапевтичних та тілесно-орієнтованих методів.

Результати дослідження. Теоретичний аналіз літератури дозволяє стверджувати, що цінності та ціннісні орієнтації становлять собою динамічну, ієрархічно організовану систему, яка виконує регулятивну, мотиваційну, адаптивну та інтегративну функції в психічній структурі особистості. Ця система

не є статичною: вона здатна зазнавати суттєвих деформацій під впливом тривалих стресових факторів, зокрема хронічного психоемоційного навантаження. Класичні праці М. Вебера демонструють, як цінності як основа соціальної дії можуть трансформуватися в кризових умовах, змінюючи пріоритети поведінки індивідів і груп [4]. Подібні ідеї розвиває Б. Ван Дер Колк, акцентуючи увагу на тому, що накопичена психологічна травма впливає не лише на емоційний стан, а й на глибокі переконання людини щодо того, що є важливим у житті, призводячи до переорієнтації на базові потреби безпеки та стабільності [2].

У контексті сімей, які виховують дітей з розладами аутистичного спектра, ці деформації проявляються особливо виразно. Хронічний стрес, пов'язаний із постійною турботою про дитину, пошуком спеціалізованої допомоги та соціальними обмеженнями, призводить до зміщення ієрархії цінностей. Домінуючими стають термінальні цінності, безпосередньо пов'язані з виживанням і благополуччям родини, насамперед «здоров'я дитини» та «стабільність сім'ї». Ці пріоритети виходять на перші позиції, відображаючи природну захисну реакцію батьків на ситуацію невизначеності та загрози. Водночас інструментальні та термінальні цінності, орієнтовані на індивідуальний розвиток – такі як «самореалізація», «кар'єра», «творчість» чи «суспільне визнання» – суттєво знижуються в ієрархії, часто опиняючись на нижчих щаблях. Як зазначає М.Й. Боришевський, подібні зсуви можуть порушувати процес особистісного становлення, оскільки духовні та громадянські цінності, що сприяють гармонійному розвитку, поступаються місцем вузько спрямованим захисним орієнтаціям [5].

Така трансформація не є ізольованою: вона тісно пов'язана з моделями адаптації батьків до кризового батьківства. Е. Шухардт у своїй концепції спіралі адаптації описує етапи, через які проходять родини – від початкового шоку та заперечення до можливого досягнення солідарності, – але без адекватної підтримки цей процес часто зупиняється на стадіях тривоги та виснаження,

фіксуючи деформовану ціннісну структуру. Отже, теоретично обґрунтовано, що в сім'ях з дітьми з РАС ціннісна сфера набуває захисного характеру, коли пріоритет віддається колективному благополуччю родини за рахунок індивідуальних аспірацій батьків, що в довготривалій перспективі може призводити до емоційного вигорання та зниження якості подружніх стосунків.

Емпіричне дослідження проводилося на базі благодійних організацій та центрів підтримки сімей з дітьми з РАС у м. Київ та Київській області. Вибірка формувалася за допомогою снігової кулі (snowball sampling), що є ефективним для роботи з вразливими групами, як зазначає І.В. Макаренко [43]. Загальний обсяг вибірки склав 30 респондентів (15 матерів і 15 батьків), які є членами подружніх пар (або колишніми партнерами у випадку розлучень). Критерії включення: наявність дитини з діагнозом РАС (підтвердженням медичними документами), вік дитини від 4 до 12 років (середній вік – 7,5 років), стаж батьківства від 5 до 15 років (середній – 9,2 роки), проживання в Україні не менше 5 років. Виключалися респонденти з гострими психічними розладами або без згоди на участь.

Для емпіричного дослідження було обрано чотири психодіагностичні інструменти: методика вивчення ціннісних орієнтацій М. Рокіча (Rokeach Value Survey, адаптована версія для української вибірки); методика аналізу сімейних взаємин (АСВ); шкала тривожності Спілбергера (STAI); напівструктуровані глибинні інтерв'ю.

**Середні ранги ключових термінальних та інструментальних цінностей
(n=30)**

Цінність	Середній ранг	Стандартне відхилення	Ранг для матерів (n=15)	Ранг для батьків (n=15)
Термінальні:				
Здоров'я	2,1	1,2	1,8	2,4
Щасливе сімейне життя	3,4	1,5	3,0	3,8
Любов	4,2	1,8	3,9	4,5
Стабільність	5,1	2,0	4,7	5,5
Матеріальний добробут	12,5	3,1	12,8	12,2
Інструментальні:				
Відповідальність	2,5	1,3	2,2	2,8
Терпимість	3,8	1,6	3,5	4,1
Взаємодопомога	4,1	1,9	3,7	4,5
Чесність	6,3	2,2	6,0	6,6
Амбітність	13,7	3,0	14,0	13,4

Методика вивчення ціннісних орієнтацій М. Рокіча надала можливість систематично оцінити ієрархію цінностей респондентів, розділених на дві категорії: термінальні цінності (які відображають кінцеві цілі життя, такі як ідеали та прагнення) та інструментальні цінності (які стосуються засобів і способів досягнення цих цілей, наприклад, особистісних якостей чи поведінкових норм).

Аналіз дескриптивної статистики результатів продемонстрував чітке зрушення пріоритетів від матеріальних і зовнішньо-орієнтованих аспектів життя до емоційних, сімейних і реляційних. Це свідчить про адаптивну переорієнтацію цінностей у відповідь на хронічний стрес і виклики, з якими стикаються сім'ї з дітьми з РАС.

Зокрема, серед термінальних цінностей найвищі середні ранги (тобто найвищі пріоритети) отримали «здоров'я» (середній ранг 2,1), «щасливе сімейне життя» (3,4) та «любов» (4,2). Ці показники підкреслюють фокус респондентів на збереженні фізичного та емоційного благополуччя як основи для сімейної

стабільності, що є логічним у контексті постійних турбот про здоров'я дитини та гармонію в родині. Навпаки, найнижчі пріоритети присвоєно матеріально-орієнтованим цінностям, таким як «матеріальне благополуччя» (середній ранг 12,5) та «кар'єра» (14,3), що вказує на зменшення акценту на фінансовому успіху чи професійному зростанні на користь внутрішніх сімейних ресурсів.

Щодо інструментальних цінностей, які визначають практичні засоби реалізації життєвих цілей, аналогічна тенденція спостерігається в пріоритеті якостей, пов'язаних з міжособистісною взаємодією та адаптацією. Найвищі середні ранги тут належать «відповідальності» (2,5), «терпимості» (3,8) та «взаємопідтримці» (4,1), що відображає необхідність розвивати емпатію, стійкість і співпрацю в щоденних сімейних взаємодіях, особливо в умовах непередбачуваної поведінки дитини з РАС. На противагу цьому, цінності, орієнтовані на індивідуалізм і амбіції, такі як «амбітність» (середній ранг 13,7) та «незалежність» (15,2), опинилися в нижній частині ієрархії, що може бути пояснено обмеженими можливостями для самостійного розвитку через пріоритетність сімейних обов'язків.

Загалом, ці результати ілюструють адаптивну еволюцію ціннісної системи респондентів, де домінують орієнтації на емоційну стабільність і сімейну солідарність, як реакцію на психосоціальні виклики. Це узгоджується з теоретичними положеннями про трансформацію цінностей у кризових ситуаціях і слугує основою для подальшого кореляційного аналізу з іншими методиками дослідження.

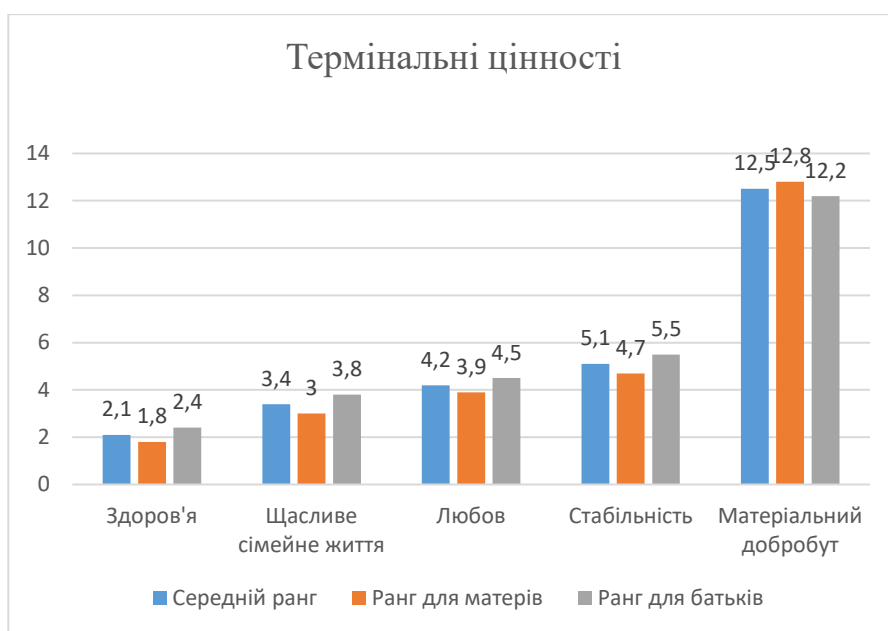


Рис. 1. Середні ранги ключових термінальних цінностей (n=30)

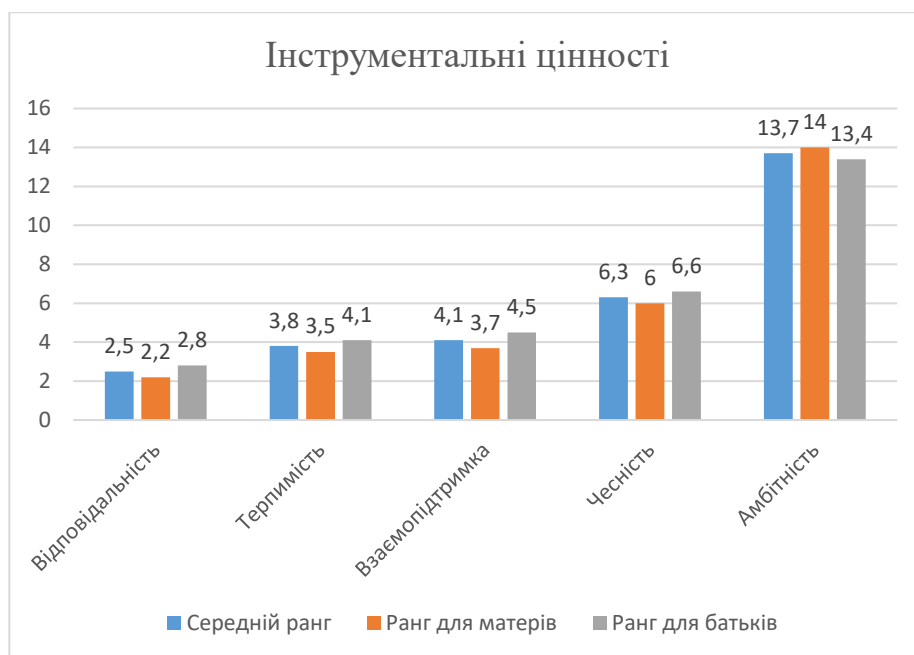


Рис. 2. Середні ранги ключових інструментальних цінностей (n=30)

Т-критерій виявив значущі гендерні відмінності: матері надають вищий пріоритет «любові» ($t=2,14$, $p<0,05$) порівняно з батьками. ANOVA показала вплив стажу батьківства на цінність «стабільність» ($F=3,45$, $p<0,05$): у респондентів зі

стажем >10 років ранг нижчий (вищий пріоритет). Кореляційний аналіз Spearman: сильна негативна кореляція між рангом «щасливе сімейне життя» та стажем батьківства ($r_s = -0,62, p < 0,01$), що вказує на посилення сімейних пріоритетів з часом.

Методика аналізу сімейних взаємин (АСВ) є валідним інструментом для оцінки стилів виховання та виявлення дисгармоній у сімейних відносинах. Вона базується на опитувальнику з 130 тверджень, які дозволяють оцінити особливості взаємодії батьків із дітьми, зокрема в контексті виконання виховних функцій. Методика використовує кілька ключових шкал, кожна з яких вимірює певний аспект виховного процесу, зокрема: гіперпротекцію (надмірну опіку), гіпоопіку (недостатню опіку), потурання (надмірне задоволення потреб дитини), ігнорування потреб, надмірні вимоги-заборони, надмірні санкції та нестійкість стилю виховання. Кожна шкала оцінюється в діапазоні від 0 до 20 балів, де вищі бали свідчать про більшу вираженість дисгармонії у відповідному аспекті сімейних відносин. Цей інструмент є особливо цінним для аналізу сімей, які виховують дітей із розладами аутистичного спектра (РАС), оскільки дозволяє виявити специфічні викривлення у виховних стилях, зумовлені психосоціальним навантаженням.

Результати дескриптивного статистичного аналізу даних, отриманих за методикою аналізу сімейних взаємин АСВ, продемонстрували чіткі тенденції у виховних стилях батьків із вибірки. Найвищі середні бали були зафіксовані за шкалами «гіперпротекція» (14,2), «потурання» (12,8) та «надмірні вимоги» (11,5). Ці показники вказують на те, що в сім'ях, які виховують дітей із РАС, домінуючим стилем виховання є надмірна опіка, що проявляється в надмірному контролі, захисті та турботі про дитину. На противагу цьому, найнижчі середні бали були отримані за шкалами «гіпоопіка» (5,3) та «ігнорування потреб» (6,1). Ці результати вказують на те, що в досліджуваних сім'ях рідко спостерігається недостатня увага до дитини чи байдужість до її потреб.

**Середні бали за ключовими шкалами Методики аналізу сімейних взаємин
АСВ (n=30)**

Шкала	Середній бал	Стандартне відхилення	Бал для матерів (n=15)	Бал для батьків (n=15)
Гіперпротекція	14,2	3,4	15,1	13,3
Потурання	12,8	3,1	13,5	12,1
Надмірні вимоги-заборони	11,5	2,8	12,0	11,0
Надмірні санкції	9,7	2,5	10,2	9,2
Нестійкість стилю	8,4	2,3	8,8	8,0
Гіпоопіка	5,3	1,9	4,9	5,7

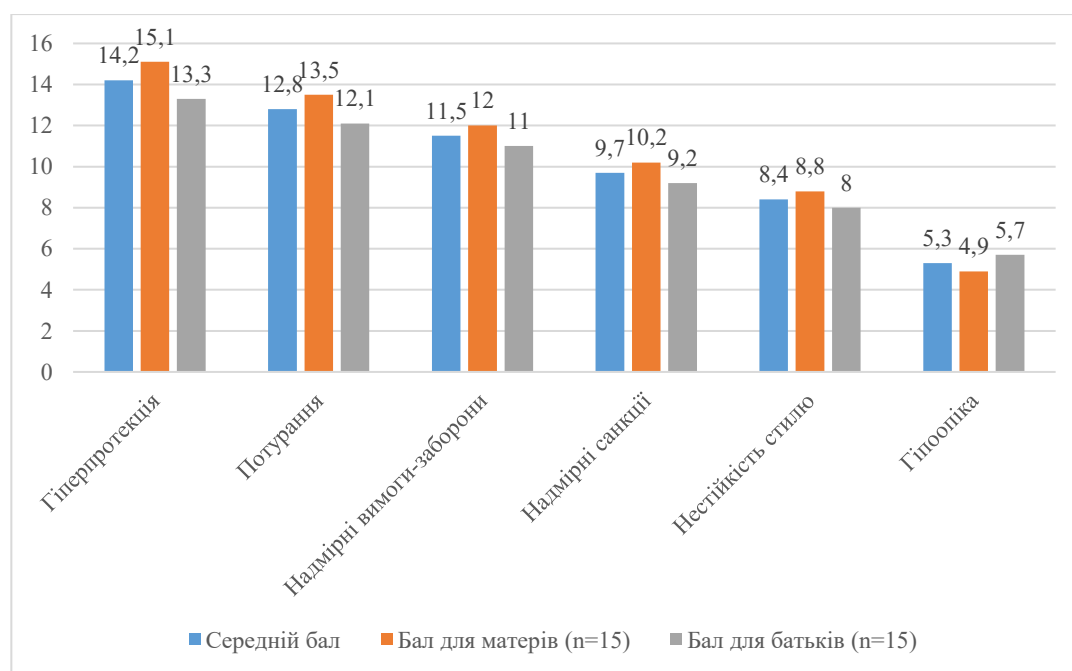


Рис. 3. Середні бали за ключовими шкалами Методики аналізу сімейних взаємин АСВ (n=30)

Результати статистичного аналізу, включаючи t-критерій, ANOVA та кореляційний аналіз Spearman, надали цінну інформацію про специфіку сімейної

динаміки та її зв'язок із психологічними особливостями батьків. Застосування t-критерію для незалежних вибірок показало статистично значущі відмінності за шкалою «гіперпротекція» між матерями та батьками ($t = 2,56, p < 0,05$). Матері отримали вищі середні бали за цією шкалою порівняно з батьками, що свідчить про їхню більшу схильність до надмірної опіки над дитиною з РАС. Ця різниця може бути зумовлена соціокультурними факторами, які в українському контексті часто покладають основну відповідальність за догляд за дитиною на матерів. Однофакторний дисперсійний аналіз (ANOVA) виявив значущий вплив ступеня тяжкості РАС на показники за шкалою «потурання» ($F = 4,12, p < 0,01$). Для оцінки взаємозв'язків між виховними стилями та ціннісними орієнтаціями було використано кореляційний аналіз за методом Spearman, який є доречним для роботи з порядковими даними, такими як ранги цінностей за методикою М. Рокіча.

Аналіз виявив позитивну кореляцію між показниками за шкалою «гіперпротекція» методики АСВ та рангом цінності «відповідальність» за методикою Рокіча ($r_s = 0,58, p < 0,01$). Результати дескриптивного статистичного аналізу показали високий рівень тривожності серед батьків дітей із РАС. Високий рівень ОТ (>46 балів) спостерігався у 50,0 % респондентів, тоді як розподіл за рівнями тривожності показав: 20,0 % респондентів мали низький рівень ОТ, 30,0 % – помірний і 50,0 % – високий. Ці дані вказують на те, що половина батьків у вибірці мають стійку схильність до тривожних реакцій, що може бути пов'язано з тривалим впливом хронічного стресу, зумовленого особливостями виховання дитини з РАС.

Для оцінки відмінностей у рівнях тривожності між матерями та батьками було застосовано t-критерій для незалежних вибірок. Результати показали статистично значущі відмінності за шкалою ситуативної тривожності ($t = 2,78, p < 0,01$), де матері продемонстрували вищі показники порівняно з батьками.

Розподіл рівнів тривожності за шкалою Спілбергера (n=30)

Рівень	Ситуативна тривожність (СТ)		Особистісна тривожність (ОТ)	
	Кількість (%)	Середній бал	Кількість (%)	Середній бал
Низький (<30)	3 (10,0)	25,4	6 (20,0)	27,8
Помірний (31–45)	9 (30,0)	38,2	9 (30,0)	39,5
Високий (>46)	18 (60,0)	58,7	15 (50,0)	55,3

Однофакторний дисперсійний аналіз (ANOVA) був використаний для оцінки впливу соціально-економічного статусу (СЕС) на рівень особистісної тривожності (ОТ). Результати показали статистично значущий вплив СЕС на ОТ ($F = 3,89$, $p < 0,05$), причому вищі показники тривожності спостерігалися у батьків із низьким соціально-економічним статусом. Для оцінки взаємозв'язків між тривожністю та ціннісними орієнтаціями батьків було використано кореляційний аналіз за методом Spearman, який є доречним для порядкових даних, таких як ранги цінностей за методикою М. Рокіча.

Аналіз виявив значущу позитивну кореляцію між високим рівнем особистісної тривожності (ОТ) та рангом цінності «стабільність» ($r_s = 0,65$, $p < 0,01$). Інтерв'ю проводилися з батьками дітей із розладами аутистичного спектра (РАС) з метою виявлення ключових аспектів їхньої психоемоційної адаптації, сімейної динаміки та трансформації ціннісних орієнтацій під впливом хронічного стресу.

Було виділено п'ять ключових тем, які охоплюють основні аспекти їхнього життя в контексті виховання дитини з РАС. Частота згадування кожної теми серед респондентів була розрахована як відсоток від загальної кількості учасників, що дозволило оцінити їхню значущість у вибірці.

Ключові теми та приклади цитат на результатами напівструктурованого інтерв'ю (n=30)

Тема	%	Приклад цитати
Емоційна підтримка	85,0	«Сім'я – це коло прийняття, де не страшно»
Функціональне партнерство	70,0	«Шлюб як союз виживання: разом легше вистояти»
Переосмислення ролей	65,0	«Я став не тільки годувальником, а й терапевтом»
Соціальний тиск	60,0	«Оточення тисне осудом, змушуючи замикатися»
Стабільність	75,0	«Пріоритети змінилися на безпеку та ресурсність»

Виявлені теми ілюструють процес «гнучкого переосмислення традицій», коли батьки адаптуються до викликів РАС через трансформацію сімейних ролей, цінностей і стратегій взаємодії. Гнучке переосмислення традицій проявляється у зміні гендерних ролей, посиленні партнерської співпраці та акценті на емоційній і соціальній стабільності. Водночас соціальний тиск і стигматизація додають додатковий стрес, що вимагає цілеспрямованої психологічної та соціальної підтримки.

Висновки. Проведене дослідження дозволило всебічно вивчити особливості ціннісних орієнтацій щодо сім'ї та шлюбу в сім'ях, де виховуються діти з розладами аутистичного спектра (РАС), з урахуванням впливу хронічного стресу на ментальне здоров'я батьків та загальну життєстійкість родини. Аналіз джерел підтвердив, що ціннісна сфера батьків у таких сім'ях набуває вираженого захисного характеру: відбувається зміщення ієрархії цінностей у бік термінальних орієнтацій на здоров'я дитини, стабільність і щасливе сімейне життя, тоді як цінності, пов'язані з індивідуальною самореалізацією, кар'єрою та суспільним визнанням, суттєво знижуються в пріоритеті. Ця трансформація є адаптивною реакцією на тривалі психоемоційні навантаження, однак у довготривалій перспективі може призводити до емоційного вигорання, зниження якості подружніх стосунків та фіксації дисгармонійних моделей взаємодії. Емпіричні

дані, отримані на вибірці з 30 респондентів, виявили чіткі закономірності. У ієрархії термінальних цінностей домінують здоров'я, щасливе сімейне життя та любов, тоді як матеріально- та кар'єрно-орієнтовані цінності відсунуті на останні позиції. Серед інструментальних цінностей пріоритет мають відповідальність, терпимість і взаємопідтримка, натомість амбітність та незалежність займають нижчі місця. Отримані результати свідчать про необхідність комплексної психологічної допомоги, спрямованої не лише на корекцію емоційного стану батьків, а й на збереження та зміцнення сімейного ресурсу.

Список використаних джерел.

1. Бех І.Д. Духовні цінності в розвитку особистості. Педагогіка і психологія. 1997. №1. С. 124–129.
2. Ван Дер Колк Б. Тіло веде лік. Харків: Vivat, 2023. 622 с.
3. Вознесенська О.Л. Арт-терапія в роботі з сім'ями дітей з особливими потребами: практичні аспекти. Психологічний часопис. 2019. №5 (25). С. 45–53.
4. Вебер М. Вибране: Протестантська етика та дух капіталізму. Київ: Атопол., 2018. 651 с.
5. Боришевський М.Й. Ціннісні орієнтації в особистісному становленні. Педагогіка і психологія. 2021. №1. С. 5–12.
6. Ходаківська О.М. Психологічні особливості сім'ї з дитиною-інвалідом. Проблеми сучасної психології. 2019. Вип. 5. 10 с.
7. Beck A.T. Cognitive Therapy and the Emotional Disorders. New York: Penguin Books, 1976. 356 p.
8. Young J.E., Klosko J.S., Weishaar M.E. Schema Therapy: A Practitioner's Guide. The Guilford Press, 2003. 436 p.
9. Левін П.А. Зцілення від травми. Київ: Видавництво Ростислава Бурлаки, 2022. 155 с.
10. Hastings R.P. Child behaviour problems and partner mental health as correlates of stress in mothers and fathers of children with developmental disabilities. Journal of Intellectual Disability Research. 2013. Vol. 47. P. 231–237.

Психоемоційні особливості осіб, які працюють з групами ризику інфікування ВІЛ

Чумаченко Н.Л.

*Здобувач другого(магістерського) рівня вищої освіти
Академія праці, соціальних відносин і туризму, м. Київ*

Лапінська Т.В.

*Доктор філософії з спеціальності «Психологія»
Академія праці, соціальних відносин і туризму, м. Київ*

Актуальність. Аналіз літературних джерел засвідчив, що поняття емоційна регуляція (як загальна емоційна здатність) та управління емоціями (як структурний компонент емоційного інтелекту) є концептуально близькими та в ряді випадків – функціонально тотожними.

Обидва терміни базуються на ключовому концепті володіння емоціями, що передбачає здатність особистості усвідомлювати, контролювати та модулювати власні емоційні стани. Водночас між цими поняттями існує структурна відмінність. У межах моделі емоційного інтелекту управління емоціями розглядається як трьохкомпонентний конструкт, що включає: регуляцію власних емоцій; контроль емоційної експресії; управління емоціями інших осіб [1, 2]

У структурі емоційної регуляції, натомість, виокремлюються два основні компоненти: саморегуляція; вираження емоцій. Процес управління емоціями умовно поділяється на два етапи: рефлексивний етап – усвідомлення та ідентифікація емоційних переживань; активізаційний етап – вибір відповідних регулятивних стратегій та психотехнік.

Емоційно-регулятивні стратегії класифікуються за типом: ситуативні (адаптація до конкретних обставин), антистресові (зниження рівня емоційного напруження), стратегії міжособистісної взаємодії (регуляція емоцій у соціальних ролях) [3, 4, 5].

Невміння управляти власними емоціями може призводити до виникнення дезадаптивних феноменів, таких як: «теплова смерть почуттів» – емоційне виснаження, втрата емоційної чутливості; «шокові емоції» – неконтрольовані афективні реакції, що порушують адаптивну поведінку.

Водночас надмірне захоплення техніками саморегуляції без критичного осмислення їх застосування може спричинити небажані наслідки, зокрема формування «холодної пози» – емоційної відстороненості, що порушує автентичність міжособистісної взаємодії та знижує рівень емпатії.

Таким чином, розвиток емоційної саморегуляції потребує збалансованого, конструктивного підходу, що враховує як індивідуальні особливості особистості, так і контекст професійної діяльності.

Мета дослідження. Дослідити особливості емоційного реагування (вигорання) та розвиток вмінь управління емоціями осіб, які працюють з групами підвищеного ризику інфікування ВІЛ, розробці програми тренінгу й надання психологічних рекомендацій. *Методи дослідження:* аналіз і узагальнення наукових джерел, методи емпіричного дослідження, методи статистичної обробки та інтерпретації даних. Проведено аналіз теоретико-методологічних підходів до розуміння емоційного реагування особистості; проведено психологічне дослідження для виявлення причин невміння управляти емоціями у осіб, які працюють з групами підвищеного ризику інфікування ВІЛ, визначено чинники, які зумовлюють відсутність усвідомлення та контролю за формою прояву емоцій.

Результати дослідження. Результати дослідження свідчать, що у 68 % респондентів емоції не перешкоджають професійному спілкуванню. Водночас 14 % учасників мають труднощі у повсякденній комунікації, а у 18 % емоційні чинники ускладнюють соціальну взаємодію. Основними бар'єрами у встановленні емоційних контактів є: недостатнє вміння керувати емоціями (20 %); домінування негативних емоцій (16 %); неадекватне емоційне вираження та емоційна дистанційованість (12 %); емоційна негнучкість та невиразність (8 %).

Згідно з методикою 72 % респондентів не мають ознак емоційного вигорання; 10 % демонструють середній рівень; 14 % – високий рівень; 4 % – критичний рівень емоційного виснаження.

Симптоматика емоційного вигорання. Відсутність симптомів варіюється від 58,0 % до 88,0 % залежно від типу. Найменш вираженими є: тривожність і депресія, емоційний дефіцит, стан «загнаності у кут», незадоволеність собою, емоційне відчуження (12–18,0 %).

Психосоматичні та психовегетативні порушення. У 42,0 % респондентів виявлено порушення: 10,0 % – симптоми на стадії формування; 32,0 % – сформовані симптоми, що проявляються на рівні фізичного та психічного самопочуття; механізм формування – умовно-рефлекторний зв'язок із професійними стресорами.

Неадекватне вибіркове емоційне реагування. Цей симптом, тісно пов'язаний з емоційною саморегуляцією, виявлено у 38,0 % досліджуваних. Він свідчить про втрату здатності диференціювати між економним проявом емоцій та дезадаптивною емоційною реакцією.

Критичні симптоми емоційного вигорання. У 28,0 % осіб спостерігаються: переживання психотравмуючих обставин, розширення сфери емоційної економії, деперсоналізація.

Найбільш критичні прояви: психосоматичні порушення – 26,0 %; неадекватне емоційне реагування – 14,0 %; особистісне відчуження – 12,0 %.

Психоемоційне виснаження. Високий рівень – 6,0 %, критичний – 16,0 %. У 30,0 % респондентів симптоми проявляються на трьох рівнях: емоційному, когнітивному, поведінковому.

Результати методики «Синдром вигорання в професіях системи «людина–людина» узгоджуються з даними інших досліджень: низький рівень емоційного виснаження – 72,0 %; середній – 16,0 %; високий – 12,0 %. Деперсоналізація: низький рівень – 74,0 %; середній – 14,0 %; високий – 12,0 %. Редукція особистих

досягнень: низький рівень – 78,0 %; середній – 10,0 %; високий – 12,0 %. Кореляційний аналіз. Гіпотеза про зв'язок між емоційною саморегуляцією та професійним вигоранням підтверджена. Коефіцієнти кореляції: деперсоналізація та особистісне відчуження – $r = 0,81$; особистісне віддалення – $r = 0,75$. Деперсоналізація проявляється у деформації міжособистісних стосунків, що є критично неприйнятним у роботі з ВІЛ-позитивними пацієнтами. Неадекватне емоційне реагування ($r = 0,94$) є ключовим маркером вигорання, що потребує корекції.

Розроблено групову програму тренінгу управління емоціями, яка базується на: психологічних теоріях, психотерапевтичних підходах, практичних рекомендаціях для фахівців.

Висновки. Управління емоціями, професійним стресом та синдромом професійного вигорання розглядається як здатність особистості ефективно застосовувати внутрішні ресурси саморегуляції, не перекладаючи відповідальність за емоційний стан на зовнішні обставини чи інших осіб. Такий підхід сприяє формуванню психологічної стійкості, підвищенню рівня емоційної компетентності та зниженню ризику розвитку емоційного виснаження в умовах професійної діяльності, пов'язаної з підвищеним ризиком інфікування ВІЛ.

У межах психопрофілактичної роботи виокремлюються дві основні форми спеціалізованих програм, спрямованих на розвиток навичок емоційної саморегуляції: індивідуальні програми – реалізуються на рівні окремої особистості, самостійно або за участі фахівця-психолога. Такі програми адаптовані до потреб працівників, які функціонують в умовах підвищеного ризику інфікування ВІЛ, з урахуванням специфіки їх професійного навантаження та емоційних викликів; групові програми – впроваджуються на рівні структурних підрозділів медико-психологічних, соціальних або реабілітаційних установ. Вони можуть бути організовані та реалізовані психологами для окремих професійних груп, що працюють із представниками вразливих категорій населення.

З метою підтримки фахівців, які здійснюють професійну діяльність в умовах підвищеного ризику інфікування ВІЛ, розроблено групову тренінгову програму з управління емоціями, яка може бути інтегрована в роботу відповідних медико-психологічних та реабілітаційних закладів. Програма спрямована на розвиток навичок конструктивного емоційного реагування, підвищення рівня емоційної саморегуляції, зниження професійного стресу та профілактику синдрому емоційного вигорання.

Список використаних джерел.

1. Пов'якель Н. С. Емоційний інтелект як основа психологічного здоров'я особистості. Психологічні перспективи. 2021. № 37. С. 85–91.
2. Goleman D. Emotional Intelligence. New York: Bantam Books, 1995.
3. Mayer J. D., Salovey P. Emotional Intelligence: Theory, Findings, and Implications. Psychological Inquiry. 1997. Vol. 15 (3). P. 197–215.
4. Голубєва Н. Емоційний інтелект у структурі особистості: теоретичний аспект. Психологічні науки: проблеми і здобутки. 2019. № 3. С. 27–34.
5. Жук А. В., Янчук Т. О. Емоційний інтелект як чинник подолання дистресу у студентів університетів. Березневий науковий дискурс 2024: Детермінанти посилення ролі освіти у формуванні особистості в умовах викликів сьогодення: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 22 березня 2024 р.). Львів : ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2024. С. 78–81.

Рольова компетентність, як чинник успішного вирішення особистістю життєвих проблем

Морозова О.В.

кандидат психологічних наук

Академія праці, соціальних відносин і туризму, м. Київ

Шевченко Н.В.

Здобувач другого(магістерського) рівня вищої освіти

Академія праці, соціальних відносин і туризму, м. Київ

Актуальність. Особливою важливістю проблеми життєвої компетентності особистості для сучасного суспільства є підвищення рівня динаміки і системності соціальних змін, ускладнених соціальних практик, плюралізацією життєвих стратегій і стилів. У такому мінливому та плинному світі виникає гостра суперечність між, з однієї сторони, новою системою вимог та, з іншої, – можливостями особистості, ускладняється і загострюється проблема особистісного самовизначення і самоздійснення. Усе це викликає необхідність формування в особистості життєвої компетентності, а саме рольової компетентності як цілісної інтегративної якості, що системно характеризує її реальну здатність адекватно і відповідно реагувати на стрімкі соціальні зміни та адаптуватись до них, усвідомлювати загрози розвитку людства, враховувати соціальні й індивідуальні потреби і можливості особистісної самореалізації і здійснювати на цій основі відбір способів і засобів досягнення бажаного майбутнього, а також застосовувати набуті знання, уміння й навички адекватно різним життєвим ситуаціям [1–7].

Вивченню поняття соціально – психологічної компетентності присвячена велика кількість робіт (А. Журавльов, Лепіхова, Л. Петровська, Н. Калініна, Ю. Корольова, В. Куніцина та інші). Соціально – психологічна компетентність (від лат. *competens* – відповідний, здатний) – здатність індивіда ефективно взаємодіяти з оточуючими його людьми в системі міжособистісних відносин. До

складу даного феномену входять: уміння орієнтуватися в соціальних ситуаціях, здатність правильно визначати особистісні особливості та емоційні стани інших людей, уміння вибирати адекватні способи взаємодії. В. М. Куніцина соціально – психологічну компетентність визначає, як систему знань про соціальну дійсність та про себе, систему складних соціальних умінь і навичок взаємодії, сценаріїв поведінки в типових соціальних ситуаціях, що дозволяють швидко і адекватно адаптуватися, приймати рішення, враховуючи наявну ситуацію. Окрім цього, це уявлення про різноманітність соціальних ролей і способи взаємодії. У зарубіжних джерелах зустрічається тлумачення соціальних ролей з позиції «компетентності взаємодії». Так, М. Атаї та Дж. Дарлі під поняттям рольової компетентності розуміють здатність створювати нові зразки виконання ролі, реконструювання знайомих, набутих в практиці прикладів, що дають можливість діяти в нових специфічних ситуаціях взаємодії. Серед базових компонентів компетентності розглядаються «здатність відображати перспективу іншого» та вміння «самоконтролю». Нарешті, четвертим компонентом рольової компетентності є здатність до рольової децентрації та прийняття ролі інших. Уміння приймати ролі інших розглядається як основна мета соціалізації особистості, в концепції Дж. Г. Міда Таке уміння вважається за досить цінну рису людини і допомагає їй адаптуватися в соціумі, зокрема уникати рольових конфліктів [1–7]. Тому в сучасних умовах набуття особистістю рольової компетентності стає об'єктивним запитом як індивідуального, так і соціального життя.

Мета. Дослідити рольову компетентність як чинник успішного вирішення особистістю життєвих проблем та надати рекомендації. *Методи дослідження.* У дослідженні використано аналіз наукових джерел, опитувальник рольової компетентності П. П. Горностая та методика вивчення динаміки здібностей О. Л. Музики (особистісно-ціннісний компонент). Дослідження проводилось серед студентів, на базі професійно-технічного училища. Вибірка складалась з 24 осіб віком 16 – 21 років. Використано аналіз літератури, опитувальник рольової

компетентності П.П. Горностая. Для дослідження успішності вирішення особистістю життєвих проблем використовуємо методику вивчення динаміки здібностей О. Л. Музики, зокрема особистісно-ціннісний компонент.

Результати дослідження. Виходячи із визначення поняття рольової компетентності (це здатність особистості розв'язувати життєві проблеми, пов'язані з рольовою поведінкою, із функціонуванням життєвих ролей. Вона включає здатність оперативно володіти своїми психологічними ролями, бути повноправним суб'єктом цих ролей, включати рольову поведінку в процес власної життєдіяльності й життєтворчості, що сприяє гармонійній рольовій самореалізації).

Рольову компетентність можна розглядатися не просто як функціональну надбудову над особистістю, а як інтегральну характеристику самої особистості вже можна сказати, що ця властивість забезпечує успішне вирішення особистістю життєвих проблем. Рольова компетентність включає в себе рольову варіативність, рольову гнучкість, рольову глибину та здатність до рольової децентрації та прийняття ролі інших. Ці характеристики і забезпечують функціонування життєвих ролей. Дані характеристики забезпечують різноманітність репертуару психологічних ролей особистості, багатство її рольової поведінки, вміння легко переходити від однієї ролі до іншої, розвиненість глибинної структури ролей, опора в рольовій поведінці не лише на рольові очікування навколишніх осіб, а й на такі особистісні складові, як рольова ідентичність, рольова Я–концепція, рольове переживання, вміння приймати ролі інших, що є досить цінною рисою особистості і допомагає їй адаптуватися в соціумі, зокрема уникати рольових конфліктів. Все це і є умовами успішного вирішення особистістю життєвих проблем.

Для того, щоб графічно зобразити отримані дані, числові показники перевели у відсотки та порівняли рівень рольової компетентності та рівень успішності вирішення життєвих проблем, що представлено на рис. 1. З даних рис.

1. видно, що в цілому динаміка рівня рольової компетентності та рівень успішності вирішення життєвих є подібною. Наше дослідження мало на меті підтвердити взаємозв'язок рольової компетентності та успішного вирішення особистістю життєвих проблем. Отримані результати можна вважати підтвердженням даного висловлювання.

Рекомендації для психологів щодо підвищення рольової компетентності особистості.



Рис. 1. Порівняння рівня рольової компетентності та рівня успішності вирішення життєвих проблем

1. Теоретичне повідомлення про необхідні для роботи поняття психології творчості, психології ролей і їх зв'язок з творчістю (зокрема, про творчість в стані вселеної ролі). Після теоретичного вступу здійснюється рефлексія проблем і труднощів, з якими особистість стикається в практичній діяльності, щоб гостріше відчувати потребу в самовдосконаленні, актуалізувати проблеми і перевести

неусвідомлену скруту (хоч би частково) в область у область свідомості. Необхідно записувати і труднощі і обговорювати їх в групі. Доцільно перефразовувати проблеми в термінах психології творчості і психології ролей.

2. Володіти простими навиками творчого спілкування (комунікативний тренінг), і навиками управління власними психологічними ролями (тренінг рольової компетентності). Завдання цього етапу – переконатися, що людина в процесі професійного спілкування дуже часто не користується великим арсеналом ролевих і комунікативних засобів, а тяжіє до застиглих стереотипних форм, нетворчим підходом. Здійснюється спроба здолати ці шаблони і підійти до справи по-новому.

3. Основний матеріал, на якому здійснюються вправи, – це набір «трансакцій», тобто пара «звернення – відповідь». У кожній трансакції закладений потенційний конфлікт. Використовується метод ролевої гри: всі учасники розбиваються на пари, вибирають по одній трансакції, знайомляться з «роллю» і своїми словами починають діалог, імпровізуючи продовження за власним розсудом. У першій вправі не дається жодної спеціальної інструкції. Після того, як короткий діалог завершений, кожна пара міняється між собою ролями і повторює вправу. Далі йде групове обговорення отриманих вражень і аналіз придбаного досвіду. Якщо в процесі обговорення (тут і надалі) виникає стихійна дискусія, керівникові не слід її забороняти, а навпаки, стимулювати, направляючи учасників на досягнення основної мети – пошук творчих способів вирішення педагогічних завдань.

4. Для кожної нової вправи беруться інші трансакції, можна утворювати нові пари учасників. Це робиться для запобігання виробленню шаблонних способів дій. У подальших двох вправах дається нова інструкція. Спочатку ставиться завдання «зіграти» різні емоційні стани: гнів, веселість, тривогу, роздратування і тому подібне. Далі використовуються елементи трансакціонального аналізу і відтворюються три его-стані: «Батька», «Дорослого», «Дитини». У обговоренні

після кожної вправи з'ясовується, як відрізняються різні стани по ефективності педагогічного спілкування. Одночасно перевіряється легкість переходу із стану в стан, чи не було «сповзання» в одні полягання, «застрягання» в них, а також скрути при відтворенні інших.

5. В подальшому робота направлена на поглиблення комунікативних навичок і рольової компетентності. Вона здійснюється на такому ж матеріалі трансакцій з подальшим обговоренням, але тут ставиться складніше завдання. Спочатку пропонується вести діалог, моделюючи різні стилі спілкування. Потім слід уявити себе в ролі майстра і зіграти ситуацію «від його імені». Нарешті, дається завдання використовувати в рольовій грі одну з тактик поведінки в конфліктних і інших складних ситуаціях. Основна мета вправ – навчитися приймати ефективні педагогічні рішення і обирати найбільш доцільні способи поведінки в конфліктній ситуації.

6. Наступний етап направлений на вироблення конструктивних і проєктивних умінь. Основний метод цього етапу – дискусія у формі «мозкового штурму». Тема дискусії – довільна, єдина умова, щоб вона була пов'язана з проблемами діяльності (бажано, неординарними, небуденними), націлена на спосіб їх рішення. У роботі можна використовувати вже придбаний досвід рольової компетентності і «зіграти роль» творчого інтелектуала, якому по-плечу вирішення найскладніших завдань.

7. Заключний етап присвячений виробленню прогностичних умінь і узагальненню всієї роботи. Основний метод – «уявний експеримент». Матеріалом для нього служать вже знайомі нам трансакції, але міняється методика роботи. Необхідно почати діалог в ролях (як в першій вправі), але не доводити його до логічного завершення, а припинити після 2–3 фраз. Далі кожен з учасників мислено продовжує діалог як за себе, так і за свого партнера, записуючи текст на листку. Після завершення діалогу партнери показують один одному свої записи і перевіряють, наскільки точно їм удалося спрогнозувати поведінку іншої людини.

У подальшому обговоренні учасники діляться досвідом і з'ясовують причини невдач. Вправу доцільно повторити кілька разів.

8. В кінці здійснюється узагальнення і рефлексія результатів, придбаного досвіду і вироблених умінь. Знову актуалізуються проблеми і труднощі, про які йшла мова на першому етапі і робиться спроба пов'язати їх з результатами роботи. Зіставляються записи про труднощі на початку і в кінці роботи. Різниця між глибиною рефлексії проблем показує ту дорогу, яку учасники семінару виконали у власному самопізнанні.

9. Виконання даних рекомендацій дає можливість значною мірою реалізувати творчі ресурси особи, які зазвичай далеко не завжди використовуються в повсякденній практиці. Це допомагає не лише ефективніше вирішувати цілий ряд професійних завдань, але перебудувати своє відношення до діяльності.

Висновки. У дослідженні уточнено поняття життєвих ролей як соціально-психологічних утворень, що пов'язані зі стилем та смислом життя, а також із життєвим сценарієм особистості. Визначено рольову компетентність як інтегральну здатність ефективно розв'язувати життєві проблеми, що охоплює варіативність, гнучкість, глибину, децентрацію та прийняття ролей інших. Емпіричні результати засвідчили, що досліджувані здатні рефлексувати актуальні уміння й ціннісні компоненти, необхідні для успішного вирішення життєвих завдань, а також виокремлювати перспективні якості для майбутнього розвитку. Встановлено, що рольова компетентність позитивно впливає на успішність подолання життєвих проблем, хоча прямої залежності між рівнем компетентності та результативністю не виявлено. Практичне значення роботи полягає у розробці рекомендації для психологів щодо підвищення рольової компетентності особистості.

Список використаних джерел.

1. Горностай П. П. Ролевий конфлікт та проблема вибору // Психологія на перетині тисячоліть.— К.: Гнозис, 2007.— Т.1.— С. 319–326.
2. Горностай П. П. Рольова соціалізація особистості: психотерапевтичний ракурс //Наукові записки Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка.— К.: Нора-Друк, 2001.— В. 21.— С. 91–100.
3. Гофман И. Подання себе іншим у повсякденному житті / І. Гоффман / переклад. з англ. та вступ. стаття А.Д. Ковальова. — К.: Преса, 2000.
4. Здібності, творчість, обдарованість: теорія, методика, результати досліджень / За ред. В. О. Моляко, О. Л. Музики. — Житомир: Вид-во Рута, 2006. — 320 с.
5. Келлі Дж. Психологія особистості. Теорія особистісних конструктів. Харків.: Мова, 2000.
6. Мадді С. Р. Теорії особистості: порівняльний аналіз / Пер. з англійської. — К.: Рута, 2002.
7. Personality, roles, and social behavior / Ed. by W. Ickes & E. S. Knowles.— N.Y., etc.: Springer, 1982.— 362 p.

Сучасні інтегративні моделі формування та розвитку адикції

Шевченко С.М.

*Здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти
Академія праці, соціальних відносин та туризму, м. Київ*

Актуальність. Дослідження людської поведінки залишається одним із важливих напрямів наукового аналізу. Сучасні соціально-політичні, воєнні реалії України формують критичні умови, які істотно детермінують поведінку кожної людини. Спроби адаптуватися до стресового впливу часто супроводжуються компенсаторними механізмами у формі втечі від реальності через психоактивні речовини, їжу, надмірну працю, соціальні мережі, ігри тощо.

Останніми роками кількість наукових праць, присвячених профілактиці поведінкових залежностей, неухильно збільшується. Ці роботи розвиваються в різних напрямках і спираються на різноманітні теоретичні підходи, що закономірно призводить до різного трактування ключових термінів. Така різноманітність є невід’ємною частиною наукового прогресу, оскільки розширення знань відбувається через дискусії, критичний аналіз і появу нових концепцій. Різні точки зору дозволяють глибше зрозуміти феномен поведінкових залежностей та закладають основу для більш ефективних профілактичних стратегій.

Зростання актуальності проблеми залежності спричинило інституціоналізацію нового наукового напрямку – адиктології. У вересні 2023 року Інститутом психології ім. Г. С. Костюка НАПН України було вперше в Україні проведено конференцію з адиктології. За результатами конференції було зазначено, що адиктивна поведінка це комплексний феномен, який потребує ґрунтового підходу до вивчення причин та психологічних механізмів її формування, психологічних особливостей прояву, наслідків [1, с. 145].

Дедалі частіше поведінкові залежності аналізують через призму класифікації DSM-5, що може кардинально змінити підходи до їх запобігання та терапії. Одночасно спостерігається тривожна тенденція – швидке зростання числа людей з адиктивними поведінками, що сприяє виникненню нових, ще маловивчених або навіть не ідентифікованих соціальних явищ. Наприклад, явище «замінної адикції» як соціальний тренд, коли після публічної відмови від однієї залежності (від алкоголю) людина може фанатично переключатися на іншу (здоровий спосіб життя); що може формувати викривлене сприйняття «здорового способу життя» та формування соціально-схвальних, але потенційно шкідливих моделей поведінки.

Суспільне життя в Україні сьогодні характеризується глибокою нестабільністю. Комплекс факторів, включаючи війсьні дії, прямий ризик для життя, підвищену агресивність соціального середовища, насильство, криміналізацію, втрату довгострокових перспектив та відсутність безпеки, формує хронічну травматичну реальність. Такі умови діють як каталізатор для виникнення різних форм залежної поведінки.

Мета дослідження. Проаналізувати основні сучасні наукові уявлення про природу залежностей та формування адиктивної поведінки, прослідкувати зміну парадигми в психології до розуміння адикції як динамічного, багаторівневого та циклічного процесу.

Результати дослідження. Досить довгий час феномен адикції або адиктивної поведінки розглядався в межах окремих наукових підходів – біологічного (медицина), психологічного та соціального. У кожному із цих підходів використовувалася власна методологія досліджень, що обумовило різне розуміння причини адикцій, способів її контролю та їх подолання. Проте сьогодні в науковому середовищі сформувалась думка, що залежна поведінка є багатфакторним, динамічним явищем, яке виникає на перетині цих підходів. Відповіддю на це усвідомлення стали сучасні інтегративні моделі, які є

об'єднаним підходом, що має усунути спрощені пояснення та створити комплексну картину феномену адикції. Окрім того, ці моделі стають теоретичною основою для ефективної взаємодії між лікарем, психологом, реабілітологом та соціальним працівником. Вони вказують, що успіх в подоланні залежності можливий лише при координації зусиль, спрямованих одночасно на біологічне лікування, психотерапію та соціальну реінтеграцію.

Варто зазначити, що сучасні інтегративні моделі є і відповіддю на виклики нових форм залежностей. Традиційні моделі часто виявляються недостатніми для пояснення поведінкових адикцій (наприклад, залежність від інтернету, шопінгу). До того ж, інтегративні моделі, які враховують спільні нейробіологічні механізми та універсальні психосоціальні фактори, надають інструменти для розуміння сучасних викликів.

Також, варто зазначити, що розуміння того, яке саме поєднання факторів – генетична схильність, травматичний досвід, соціальне середовище, особливості особистості – призвело до адикції у конкретної особистості, є ключем до ефективної допомоги. Інтегративний підхід таким чином акцентує увагу на необхідності персоналізованої профілактики та терапії, дозволяє розробити індивідуальні стратегії втручання, які цілеспрямовано будуть впливати на всі ланки проблеми.

В сучасній Україні в умовах тривалого стресу, травматизації населення та соціальної нестабільності ризик розвитку адикцій різко зростає (що підтверджується науковими дослідження останніх чотирьох років війни). Інтегративні моделі допомагають зрозуміти як масові травматичні події взаємодіють з індивідуальною вразливістю, можуть породжувати нові або загострювати старі залежності. А це, в свою чергу, дозволить вибудовувати профілактичні програми, адаптовані до конкретних кризових умов.

Враховуючи все вище наведене, можна констатувати, що сучасні інтегративні моделі розглядають людину не як носія окремої проблеми, а як

цілісну, хоча й дезорганізовану систему, яка намагається адаптуватися до внутрішніх та зовнішніх умов існування найкращим, з її точки зору, способом.

Розглянемо основні аспекти сучасний інтегративних моделей.

1. *Біопсихосоціальна модель.* Основний принцип біопсихосоціальної (інтеграційної) моделі виражає концепцію єдності душі і тіла. Всі області розвитку людини та фактори середовища є в постійному взаємозв'язку[2]. Цей підхід визначає людину як цілісний організм, у якому біологічні, психологічні та соціальні чинники перебувають у постійному взаємозв'язку. Відповідно до цього уявлення про здоров'я людини, причини захворювань та надання їй допомоги залежить від особливостей та стану кожного з перелічених чинників[3]. Таким чином, розвиток особистості, її здоров'я, адаптація до життя чи поява залежностей або захворювання є індивідуальними процесами, що залежать від комбінації генетичних та соціальних факторів. А значить, відсутній один уніфікований процес, який викликає хворобу чи залежність, натомість існує багато факторів ризику, які у різних комбінаціях і в кожному окремому випадку викликають захворювання чи залежність.

Цей підхід є найбільш комплексним підходом до розуміння адикції. Перша складова – біологічні фактори – внутрішні, фізіологічні причини, що роблять мозок вразливим до адикції. Це генетика та схильність, нейробіологія мозку, фізіологічні особливості (стать, вік, наявність інших захворювань тощо). Друга складова – психологічні фактори – внутрішні ментальні та емоційні процеси, що впливають на поведінку. Це особистісні риси (імпульсивність, перфекціонізм), психічні розлади (коморбідність), копінг-механізми, когнітивні спотворення. І третя складова – соціальні фактори – зовнішній вплив та середовище в якому живе людина. Це соціальне оточення, доступність певних речовин та нормалізоване або схвалюване вживання, сімейне виховання, економічні чинники, культурний контекст.

Отже, ця модель показує, що адикція виникає в результаті складного переплетіння факторів з трьох взаємопов'язаних сфер: біологічної, психологічної та соціальної.

2. *Інтегративна модель «Трьох шляхів»* Кеннета Блюма або Модель системної нейронауки про залежність. Ця модель інтегрує генетику, неробіологію та психологічні фактори, розуміючи залежність як біопсихосоціальний розлад. Головна ідея полягає в тому, що дефіцит природних нейрохімічних речовин задоволення (зокрема, дофаміну) в системі винагороди мозку робить людину вразливою до штучних стимулів, таких як психоактивні речовини або навіть поведінкові звички (азартні ігри, їжа тощо).

У 1990 році Кеннет Блум виявив ген, відповідальний за схильність до адикцій. Цей ген присутній не лише у алкоголіків та наркоманів, а й у гравців, осіб із компульсивним переїданням, гіперсексуальністю та іншими формами залежної поведінки. Генетична передумова, у поєднанні з несприятливим соціальним середовищем, формує стійку схильність до девіантної та протиправної поведінки [4, с. 36]. А вже у 1995 році Кеннет Блум представив концепцію «Синдром дефіциту винагороди» (RDS), щоб підкреслити гіпофункціональність дофамінергічних мозкових ланцюгів, що клінічно представлено як зниження здатності відчувати задоволення [5].

Така вразливість реалізується через три взаємопов'язані «шляхи». Перший – схильність або генетично-нейрохімічний шлях (це фундамент моделі). У деяких людей є генетичні особливості, що призводять до природнього дефіциту дофамінових рецепторів D2 або низького базового рівня дофаміна (в системі винагороди). Як наслідок, людина має синдром дефіциту задоволення, що створює біологічну потребу в пошуку зовнішніх стимулів для підняття рівня дофаміну.

Другий – сприйняття та копіну або психологічно-емоційний шлях. Генетична схильність поєднана з психологічними факторами приводить до

залежності. Наприклад, людина відчуває тривожність і використовує речовини для самолікування цього стану. Або використовує дезадаптивні стратегії подолання стресу (копінг): обирає речовини, які швидко і потужно знімають напругу та приносять задоволення. Або дитяча травма, яка є потужним чинником, що пошкоджує систему винагороди та збільшує ризик залежності.

Третій – сприйняття та підтримка або соціально-поведінковий шлях. Середовище, в якому живе людина, може активувати генетичну схильність та підсилити психологічні фактори. Наприклад, спілкування в середовищі, де вживання речовин є нормою; доступність речовин; сімейні звички; відсутність соціальної підтримки, стабільності або можливостей, що може стати тригером для втечі у залежну поведінку [6].

Таким чином складається «порочне коло» залежності. Людина з генетичною залежністю (шлях 1) та психологічними проблемами (шлях 2) живе в стресовому середовищі (шлях 3). Вона вживає речовину, яка штучно підвищує рівень дофаміну в її дефіцитній системі винагороди. Мозок запам'ятовує, що це потужний стимул і формується умовний рефлекс. Згодом мозок знижує власне виробництво нейромедіаторів, що поглиблює дефіцит, і людина відчуває потребу у речовині або у збільшенні речовини. Формується фізіологічна і психологічна залежність.

Отже, інтегративна модель «трьох шляхів» Кеннета Блюма показала, що залежність виникає на перетині генетичної вразливості, психологічних особливостей особистості та впливу середовища. Вона заклала основу для сучасного гуманного та науково обґрунтованого підходу до лікування та профілактики залежностей, зосереджуючись на усуненні причин, а не лише на наслідках.

3. *Модель епідеміології залежності Брюса Александера*, відомої як «Синдром розірваного кола» (Dislocation Theory). Канадський психолог Брюс Александер довів, що залежність – це спосіб адаптації до реальності. Якщо

реальність допомагає людині бути тверезою, тоді вона лишається тверезою. А якщо реальність сприяє тому, аби людина свої потреби задовольняла через наркотик, тоді в людини є значно більше шансів, щоб узалежнитись. «Втрата психологічної, соціальної та економічної інтеграції в сім'ю та культуру і почуття відчуження, ізоляції та безсилля» є попередниками залежності [7]. Олександр зосереджується не на індивідуальній патології мозку чи генетиці, а на соціальному та культурному середовищі як першопричині епідемії залежностей у сучасних суспільствах.

В основна ідея цієї моделі полягає в тому, що залежність – це не хвороба окремої людини, а симптом хворобливого «розірваного» суспільства. Людина потрапляє в залежність через дефіцит психологічної інтегрованості, ідентичності та усвідомлених зв'язків в сучасному суспільстві.

Ключовим поняттям є «розрив» (dislocation). Розрив – це стан, в якому людина позбавлена стабільної, усвідомленої соціальної екосистеми («кола»). «Психосоціальна інтеграція є важливою частиною добробуту людини, і що дислокація – стійка відсутність психосоціальної інтеграції – є нестерпно болючою» [7]. Термін психосоціальна інтеграція вказує на істотне задоволення, яке люди можуть відчувати, якщо вони живуть у суспільстві, яке відповідає їх основним потребам для чотирьох речей: приналежність, ідентичність, значення та мета. Несприятливий дитячий досвід і травми є факторами, які можуть сприяти схильності до зловживання психоактивними речовинами та/або залежності і часто виникають у стресових громадських середовищах і призводять до почуття виключення, ізоляції та безсилля. Отже, соціальне та культурне середовище має вирішальне значення для визначення того, чи буде людина розвивати схильність до зловживання психоактивними речовинами та/або залежності.

Як це відбувається на практиці. Людина, яка переживає «розрив», відчуває стрес, ізоляцію, відчуженість, марність життя та втрату контролю, фактично втрату фундаменту, опори в житті. Людина починає шукати способи адаптуватися

до стресу, відновити почуття зв'язку, контролю і полегшення, та вдається псевдоадаптації через залежність (психоактивні речовини, захоплюючі види поведінки). Проте залежність сама по собі поглиблює ізоляцію, руйнує соціальні зв'язки, заважає підтримувати здорові стосунки в соціумі. Це створює рух по колу: розрив – залежність як спробу впоратися – поглиблення розриву через залежність – збільшення залежності.

Свою гіпотезу Брюс Александер вирішив перевірити на пацюках (знаменитий експеримент «Парк щурів» (Rat Park)). Експеримент продемонстрував, що середовище є вирішальним; не речовина сама по собі викликає неконтрольоване вживання, а ізоляція та позбавленість середовища. Саме тому в умовах соціальної та екологічної інтегрованості навіть потенційно наркотична речовина не стає об'єктом залежності. Отже, для зниження рівня залежності ця теорія надає пріоритет зв'язку, соціальній інтеграції та почуттю приналежності як важливого для психічного благополуччя та відновлення від залежності [7].

Можна констатувати, що дана модель зміщує фокус з особистості на суспільство; залежність розглядається як нормальна реакція нормальних людей на ненормальні, дезінтегровані умови існування; розширює розуміння залежності (пояснює не лише хімічні, а й поведінкові залежності, які також є способом втечі від стресу); створюється нова парадигма профілактики та лікування – створення «здорового середовища» та соціальну реінтеграцію; по-суті, щоб перемогти залежність, треба зцілити суспільство.

4. *Теорія «Всебічної пастки»* (Comprehensive Trap або I-PACE Model) для поведінкових залежностей. Ця психологічна теорія пояснює механізми виникнення та підтримання поведінкових залежностей (від ігор, соцмереж, шопінгу тощо). Модель I-PACE (Інтеракція-Особистість-Афект-Когніції-Виконання) була розроблена німецьким дослідником проф. Маттіасом Брандтом і є провідною теоретичною рамкою для розуміння розладів, пов'язаних з інтернет-

користуванням. Це модель взаємодії особистості, емоцій, когнітивних процесів та поведінки щодо певних розладів, пов'язаних з використанням Інтернету.

Ця модель описує пастку, в яку потрапляє людина, а саме: специфічне поведінка спочатку приносить задоволення (поведінка є «виходом» або «винагородою»), але потім, через комплекс психологічних механізмів, перетворюється на неконтрольовану залежність (поведінка перестає приносити задоволення, але стає єдиним можливим способом впоратися з життям, а зупинитися неможливо через потужні прагнення та емоційну залежність). Всебічною або комплексною вона є тому, що задіяні всі ключові аспекти психіки – особистість, емоції, мислення, поведінка.

Основні компоненти моделі I-PACE такі: компонент Р (Person) – особа, який представляє особистість людини (особистісні чинники, біопсихосоціальні чинники); компонент А (Affect) – афективний, який описує дисфункціональне подолання стресових ситуацій людиною (позитивне або негативне підсилення); компонент С (Cognition) – когнітивний, який вказує на когнітивні помилки людини при подоланні стресових ситуацій (когнітивні упередження, дисфункціональні схеми), а також реактивність на подразники; компонент Е (Execution) – виконавча функція, який пояснює порушення в процесі прийняття рішень, особливо в ризикованих ситуаціях (втрата контролю, порушення функціонування). Взаємодія між компонентами, що відбувається в певних ситуаціях, призводить до адиктивної поведінки, оскільки задоволення та компенсація формуються у зв'язку з певними видами поведінки [8].

Оновлена версія моделі I-PACE буде дійсна не тільки для конкретних розладів інтернет-використання, але й для інших видів звикання, адже ця оновлена модель зосереджується на індивідуальних психолого-нейробіологічних механізмах звикання [9].

Слід відзначити, що дана модель прямо вказує на цілі для терапії: робота з афектом, корекція когніцій, модифікація поведінки, робота з особистісними

факторами. Отже, теорія «Всебічної пастки» (I-PACE) – це комплексна модель, яка пояснює як залежна поведінка затягує людину цілісно, охоплюючи її особистість, емоції, мислення та дії. Вона наочно демонструє, що робота з залежностями потребує дотику до глибинних психологічних механізмів. Ця модель є науково обґрунтованою основою для сучасної психотерапії поведінкових залежностей.

5. *Діатез-стресова модель (Diathesis-Stress Model)*. Модель діатезу-стресу є психологічним поясненням психічних станів та психологічних розладів, яке передбачає, що ці стани та розлади виникають, коли людина з уже існуючим фізичним фактором піддається тій чи іншій формі емоційного або фізичного стресу. Іншими словами, це говорить про те, що розлади є результатом як генетичного складу людини, так і навколишнього середовища [10]. Діатез (вразливість) – внутрішня, часто прихована схильність та стрес (пусковий механізм) – зовнішній або внутрішній фактор, що активує цю вразливість.

Діатез – це «ґрунт», на якому може вирости залежність. Наприклад, генетичний діатез (спадкова схильність до адикції, природні толерантність до речовин); або психологічний діатез (особистісні риси, психопатологія, дисфункціональні когнітивні схеми), або соціальний діатез (травматичний досвід, дисфункційна родина). Стрес у разі адиктивної поведінки це часто: життєві кризи, хронічний стрес, соціальний тиск, знайомство з об'єктом залежності). Як формується залежність за цією моделлю. У людини є діатез (наприклад, генетична схильність та дитяча травма); виникає критичний стресор (розлучення); вона вживає алкоголь (відбувається негативне підсилення – втеча від болю та отримання миттєвого полегшення); закріплюється патерн; розвивається толерантність та потреба в більших дозах, як наслідок залежності.

Існує точка зору, що модель діатезу-стресу залежностей складається з трьох взаємопов'язаних процесів: генетики, середовища та фармакологічного впливу наркотиків або залежної поведінки. Наркотичні речовини змушують мозок

пристосовуватися до зміни природного балансу ендогенних нейромедіаторів. Зловживання стимуляторами, що викликають залежність, призводить до загального зниження кількості, активності та ефективності катехоламінів мозку, таких як дофамін, змушуючи мозок покладатися на зовнішні речовини, що модифікують катехоламіни (наприклад, кокаїн), щоб функціонувати. Залежність клітин мозку від зовнішніх хімічних речовин для функціонування називається алостаз, що є основною особливістю залежного мозку і, безумовно, частиною моделі діатезу-стресу залежності [11]. Отже, діатез стресова модель вказує, що залежність це результат поєднання вразливої особистості з потужним життєвим викликом (стресом). Це знімає стигму та дозволяє будувати ефективну, спрямовану на причини допомогу.

Висновки. Сучасні інтегративні моделі дозволяють подолати редукціонізм у розумінні адикцій, пропонуючи цілісний, системний підхід. Вище наведені моделі розглядають адиктивну поведінку як результат складних нелінійних взаємодій між особистістю та середовищем; інтегрують біологічні, психологічні та соціальні детермінанти; розуміють адикцію як динамічний процес із фазами розвитку та змін. Вони підкреслюють, що формування та розвиток залежності є адаптаційним процесом (хоча і дезадаптивним за наслідками), через який особистість намагається впоратися з внутрішніми та зовнішніми викликами. Це розуміння відкриває нові можливості для ефективної профілактики, лікування та реабілітації, що ґрунтуються на повазі до складної природи людського досвіду та потенціалу до змін.

Список використаних джерел.

1. Пасічник Л. Психологічні особливості поведінки особистості з різними адикціями. *Психологічні перспективи*. 2024. Вип. 43. С. 143–160 URL: [/www.researchgate.net/publication/381721241_psihologichni_osoblivosti_povedinki_o_sobistosti_z_riznimi_adikciami](http://www.researchgate.net/publication/381721241_psihologichni_osoblivosti_povedinki_o_sobistosti_z_riznimi_adikciami) (дата звернення: 18.12.2025)
2. Поліщук Н.Є. Біопсихосоціальна модель допомоги: основні принципи діагностики та лікування. *НейроNews: психоневрологія та нейропсихіатрія*. 2013.

Спеціальний випуск 6-2. URL: <https://neuronews.com.ua/ua/archive/2013/6-2/article-1241/biopsihosocialna-model-dopomogi-osnovni-principi-dagnostiki-ta-likuvannya#gsc.tab=0> (дата звернення: 18.12.2025)

3. Не діагнозом єдиним або що означає біопсихосоціальна модель допомоги для українців? URL: <https://www.mh4u.in.ua/shukayu-dopomogu/ne-diagnozom-yedynum-abo-shho-oznachaye-biopsyhosocialna-model-dopomogy-dlya-ukrayincziv/>

4. Аркуша Л., Чернов О. Адиктивна поведінка та її вплив на кримінальну активність. *Юридичний вісник*. 2025. № 5. С. 18–39

5. Futuristic Exploration of Addiction Neuroscience in the Genomic Era URL: <https://www.dovepress.com/futuristic-exploration-of-addiction-neuroscience-in-the-genomic-era-peer-reviewed-fulltext-article-PRBM> (date of access: 18.12.2025)

6. Neurobiology of Addiction URL: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK597351/> (date of access: 18.12.2025)

7. Dismantling Addiction Services: Neoliberal, Biomedical and Degendered Constraints on Social Work Practice URL: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8953955/> (date of access: 18.12.2025)

8. Interaction of Person-Affect-Cognition-Execution (I-PACE) Model on Addictive Behavior URL: file:///C:/Users/lanat/Downloads/Interaction_of_Person-Affect-Cognition-Execution_I.pdf (date of access: 18.12.2025)

9. The Interaction of Person-Affect-Cognition-Execution (I-PACE) model for addictive behaviors: Update, generalization to addictive behaviors beyond internet-use disorders, and specification of the process character of addictive behaviors URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0149763419303707>

10. Diathesis–stress model URL: <https://www.ebsco.com/research-starters/psychology/diathesis-stress-model> (date of access: 18.12.2025)

11. Diathesis Stress Model of Addiction: Etiology of Substance-Related and Addictive Disorders URL: https://www.naadac.org/assets/2416/2017-02-09_diathesis_qandas.pdf (date of access: 18.12.2025)

Внутрішньо-особистісні чинники, що впливають на вибір стратегії поведінки апліканта у процесі пошуку роботи

Шинкар В. О.

*Здобувач другого(магістерського) рівня вищої освіти
Академія праці, соціальних відносин і туризму, м. Київ*

Актуальність. В психології не припиняється інтенсивний пошук основних механізмів та закономірностей, ведучих факторів загального психічного розвитку та окремих його сфер.

У сучасній психології особистість розглядають як особливу самокеровану систему, здійснюючу ряд специфічних функцій як на рівні регуляції окремих психічних явищ, так і в цілому у життєдіяльності людини.

Деякі дослідники відмічають важливу особливість особистісного розвитку людини в умовах економічної та соціальної нестабільності. Вона полягає у тому, що психіка людини у цих умовах відчуває надмірне навантаження, модель поведінки однієї людини значно відрізняється від моделі поведінки іншої людини. Крім цього людина у будь – якому випадку психологічно стомлюється від постійних змін, в тому числі від зміни суспільних цінностей, змін престижу професій, зміни роботи. У нестабільних соціально – економічних умовах, коли занижена ціна робочої сили, робітники не отримують доходів, які б забезпечували прийнятий у суспільстві стандарт добробуту [1]. Наслідками даного процесу являється зниження мотивації, у тому числі професійної, зниження самооцінки особистості, впевненості у власну компетентність, відсутність конструктивної стратегії особистісної поведінки. Все це приводить до неадекватності інтерпретації та оцінці соціальних змін, соціальній пасивності індивіда. В результаті чого одна людина успішна, а інша навпаки. Тобто стратегії поведінки різноманітні і ведуть до самих різних результатів.

Однією із детермінант вибору конструктивної стратегії поведінки є активність. Активність особистості виявляється як у загальному життєвому тонусі

людини, у кількості притаманній їй « життєвої енергії», у ступені прикладених зусиль, так і в її спрямованості. Активність може бути глобальною, спрямованою на пізнання, зміни, перетворення світу в цілому, або ж тільки на конкретні життєві обставини [2]. Активність являє собою вищий, особистісний рівень способу задоволення системи цінностей, в якій інтегруються уявлення особистості про свої потреби, здібності і можливості, пов'язані з рівнем домагань. Внутрішній світ особистості відображується в активності та самореалізації. Між внутрішнім світом і зовнішнім існують рівні саморегуляції, які виступають психологічною основою життєвої активності особистості (імпульсивно – ситуативний, довільно – вольовий, креативно-творчий) [3]. Активність має конструктивну та деструктивну спрямованість. Існують також і різні рівні активності: потенційна, низька, середня, висока [4, 5]. Тому в сучасних умовах вивчення особливостей стратегій поведінки апліканта в ситуації пошуку роботи стає об'єктивним запитом як індивідуального, так і соціального життя.

Мета дослідження. Визначити внутрішньо особистісних чинників, що впливають на вибір стратегії поведінки апліканта у процесі пошуку роботи.

Методи дослідження. Емпіричне дослідження проводилося з залученням 100 безробітних осіб. Порівняння особливостей когнітивної репрезентації проводилося опитувальником «Аплікант», рівня екстра / інтроверсії аплікантів тестом Айзенка, рівень нейротизму тестом «Аплікат», рівень прагнення до самоактуалізації тестом САО, рівень інтернальності/екстернальності методикою діагностики рівня суб'єктивного контролю Дж. Роттера. Кореляційний аналіз проводився методом рангової кореляції Спірмена).

Результати дослідження. Головним етапом формування поведінкової стратегії безробітного є мотивація як індивідуалізований механізм співвідношення зовнішніх та внутрішніх факторів, що визначають наступну трудову поведінку.

Конструктивні стратегії поведінки аплікантів характеризуються сприятливою оціночною реакцією на ситуацію безробіття, яка проявляється в думках, почуттях і цілеспрямованій поведінці.

З проведеного опитування (Аплікант) можна підсумувати наступне (додаток № А), що емоційна реакція безробітних на втрату роботи, які мають різні стратегії поведінки в процесі пошуку роботи мають суттєві розбіжності. Так у 1 і 2 групах безробітних, що мають стратегії поведінки «відмова від роботи» і «хаотичний пошук роботи» досить виразно простежуються „чорні» мотиви в їх емоційних реакціях на втрату роботи. Страх, сором, вина, презирство, відраза, горе – страждання – ці емоційні реакції підкреслювалися найчастіше в обох групах. У третій вибірці, стратегія – « орієнтація на одержання другої професії» домінують зовсім інші емоційні реакції на втрату роботи: інтерес, радість, презирство.

Досить виразно домінують позитивні емоційні реакції на втрату роботи у четвертої групи аплікантів, що мають поведінкову стратегію «цілеспрямований, активний пошук роботи»: інтерес, радість, сором. В п'ятій виборці гнів, відраза, подив, страх займають перші позиції.

Таким чином, можна твердити, що негативні емоційні реакції на ситуацію безробіття переважають у аплікантів, що мають 1, 2, 5 стратегії поведінки, а у 4 та 3 групи аплікантів, що мають конструктивні поведінкові стратегії спостерігається тенденція адекватної оцінки ситуації безробіття. 57,0 % безробітних відчують радість та інтерес після втрати роботи, тобто не сприймають втрату роботи як кінець життя, а навпаки, як можливість знайти себе у новому амплуа. Вони же, як правило, досить активно приступають до пошуку нової роботи, і сам процес пошуку приносить їм задоволення. Ці люди рідко потрапляють на другу фазу безробіття.

1 вибірка – поведінкова стратегія «відмова від пошуку роботи»: найбільш позитивно сприймають таку складову безробіття, як час для вирішення багатьох

назрілих проблем; отримання часу для відпочинку; досить високі показники і у таких складових «Я можу виконувати будь – яку роботу, що не суперечить нормам моралі, аби за неї гарно платили», «Я можу скористатися деякими соціальними пільгами»; найбільш негативну оцінку отримали такі складові безробіття як сприйняття низькооплачуваної роботи як приниження своєї гідності, вимушеність досягати успіху в умовах конкуренції, невідповідність сучасним вимогам.

2 вибірка – поведінкова стратегія «хаотичний пошук роботи»: найбільш позитивно сприймають таку складову безробіття, як одержання тимчасового перепочинку від роботи, часу для вирішення назрілих питань, можливості отримати соціальні пільги; найбільш негативну оцінку отримали такі складові безробіття як сприйняття низькооплачуваної роботи як приниження своєї гідності та непотрібність своїй країні, суспільству.

3 вибірка – поведінкова стратегія «орієнтація на одержання другої професії»: найбільш позитивно сприймають таку складову безробіття, як необхідність досягнення успіху в умовах конкуренції і ситуацію безробіття як додатковий стимул для розвитку своєї особистості; досить високі показники і в таких складових безробіття як підтримання самоповаги та можливість отримати нову професію, зайнятися підприємницькою діяльністю, розуміння, що певною мірою не відповідаю вимогам ринку праці; найбільш негативну оцінку отримали такі складові безробіття як втрата відчуття перспективи, впевненості у майбутньому; також досить виразно оцінено зі знаком мінус такі складові безробіття, як непотрібність своїй країні, суспільству.

4 вибірка – поведінкова стратегія «активний цілеспрямований пошук роботи»: найбільш позитивно сприймають таку складову безробіття, як необхідність досягнення успіху в умовах конкуренції і ситуацію безробіття як додатковий стимул для розвитку своєї особистості, в подоланні труднощів можливість краще пізнати себе має високу оцінку серед аплікантів цієї групи; досить високі показники і в таких складових безробіття як підтримання

самоповаги та можливість отримати нову професію, розуміння, що в житті є цінності, крім тих, що бачив раніше; найбільш негативну оцінку отримали такі складові безробіття як втрата відчуття перспективи, впевненості у майбутньому, сприймання низькооплачуваної роботи, як приниження своєї гідності, непотрібність своїй країні, суспільству.

5 вибірка – поведінкова стратегія «згода на будь – яку роботу»: найбільш позитивно сприймають таку складову безробіття, як можливість отримання деяких соціальних пільг, одержання нової спеціальності; досить високі показники і у таких складових «Я можу виконувати будь – яку роботу, що не суперечить нормам моралі, аби за неї гарно платили», «Я згоден працювати на нижчу зарплату аби забезпечити виживання себе і своєї сім'ї»; найбільш негативну оцінку отримали такі складові безробіття як втрата відчуття перспективи, впевненості у майбутньому, відчуття дискримінації на ринку праці із – за свого віку, досвіду роботи; важливим етапом трансформації свідомості безробітного в його поведінковій стратегії та дії є ціле покладання – визначення мети та планування майбутньої трудової поведінки безробітного шляхом аналізу власних ресурсів та виявлення альтернатив та різних варіантів дій щодо пошуку роботи та працевлаштування.

Загальне сприйняття ситуації безробіття.

1. Ситуація містить в собі можливості змін на краще в моєму житті.

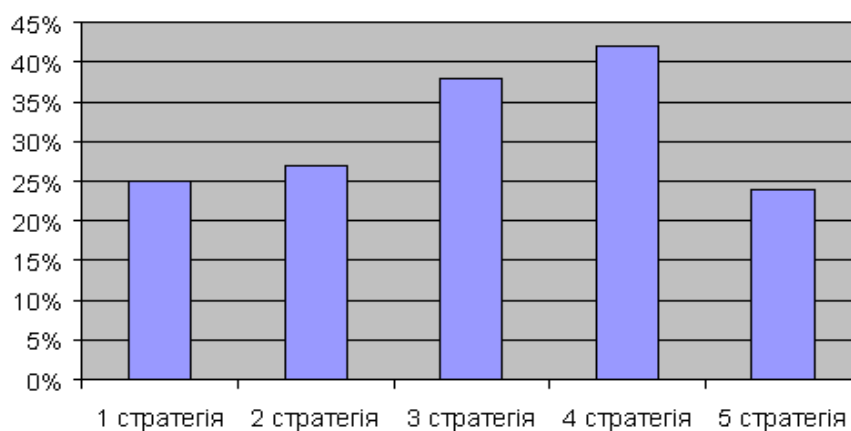


Рис. 2. Сприйняття ситуації безробіття як можливість позитивних змін у житті

2. Ситуація руйнує моє життя.

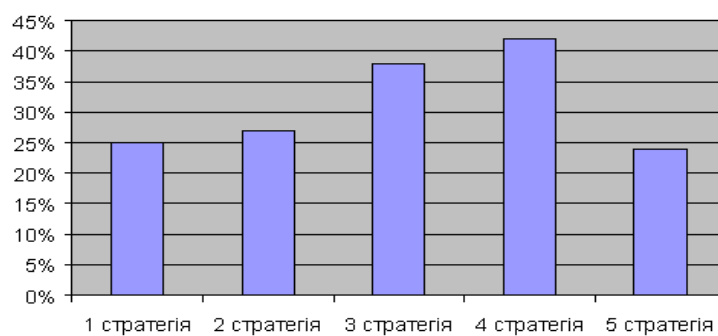


Рис. 3. Сприйняття ситуації безробіття як руйнуючої

3. Ситуація сприяє моєму особистісному зростанню і зміцненню.

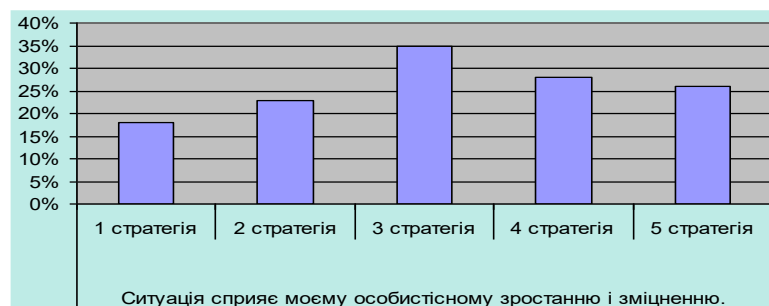


Рис. 4. Сприйняття ситуації безробіття як можливості для особистісного зростання і зміцнення

4. Ситуація шкодить моєму фізичному, психічному, соціальному і духовному здоров'ю.

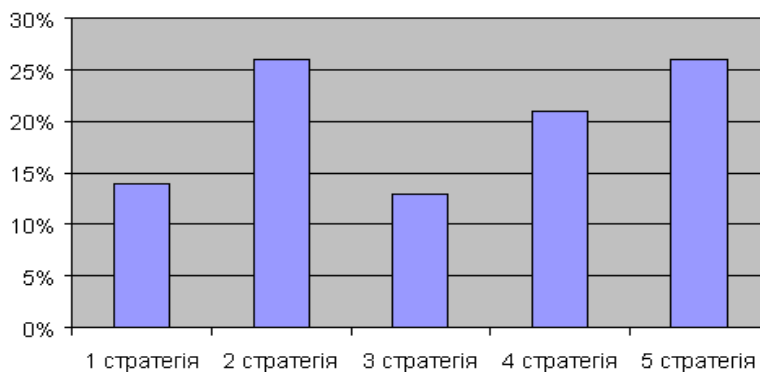


Рис.5. Сприйняття ситуації безробіття як такої, що шкодить фізичному, психічному, соціальному і духовному здоров'ю

Загальне сприйняття ситуації безробіття групами аплікантів з 3,4 поведінковими стратегіями позитивне, вони вважають втрату роботи та пошук нової як можливість змінити на краще своє життя, випробувати свої сили, розкрити свій внутрішній потенціал. Майже половина інших опитуваних (стратегії поведінки № 1,2,5) оцінюють ситуацію безробіття як важку, руйнуючу їх життя, яка спричиняє шкоду їх здоров'ю. Одержані результати можна прокоментувати наступним чином. *Стратегія поведінки «відмова від пошуку роботи»*: найвищі бали отримали такі теми : одержання соціальної допомоги, побутові проблеми, особистісні сімейні проблеми; досить неважливим вважають для себе з цієї групи безробітні: необхідність зміни професії, пошук роботи, тему соціальної викину тості. *Стратегія поведінки « хаотичний пошук роботи»*: найвищі бали отримали такі теми : результати пошуку роботи, одержання соціальної допомоги, фінансові труднощі; неактуальними аплікати вважають такі теми як: спокій, взаємостосунки з колишніми колегами, проблему самоповаги. *Стратегія поведінки «орієнтація на отримання другої професії»*: найбільш актуальні теми цієї групи : необхідність пошуку роботи, результат цього пошуку,

проблема самоповаги, власних перспектив, одержання додаткової освіти; найменше балів отримали теми: спокій, особистісні, сімейні та побутові проблеми. *Стратегія поведінки «цілеспрямований активний пошук роботи»*: актуальні теми цієї групи: необхідність пошуку роботи, результат цього пошуку, проблема самоповаги, власних перспектив; неактуальними для себе аплікати вважають теми: особистісні, сімейні та побутові проблеми. *Стратегія поведінки «згода на будь – яку роботу»*: актуальними аплікати вважають теми: матеріальне положення, побутові та сімейні проблеми; несуттєвими є теми: необхідність зміни професії, взаємовідносини з колишніми колегами, спокій. *Стратегія поведінки «відмова від пошуку роботи»*: досить позитивно аплікантами сприймається спілкування з друзями, сім'єю, а також з працівниками служби зайнятості. Також безробітні відмічають, що покращення настрою, хороше самопочуття у них викликає відпочинок; сильну нервову напругу безробітні переживають, коли згадують про звільнення з попередньої роботи, а також взагалі думки про роботу, відчуття фізичної/ психічної виснаженості в кінці робочого дня.

Висновки. Психічним станам безробітних можна надати нас тупну характеристику: *стратегія поведінки «хаотичний пошук роботи»*: позитивний вплив на психічний стан безробітних викликають: спілкування в сім'ї, з друзями, відпочинок, реалізація та розвиток свого таланту, здібностей, а також повсякденна діяльність. Негативний вплив на психічний стан аплікантів справляють думки про звільнення з попередньої роботи, відчуття фізичної/ психічної виснаженості в кінці дня. *Стратегія поведінки «орієнтація на отримання другої професії»*: досить позитивно аплікантами сприймається спілкування з друзями, сім'єю, а також з працівниками служби зайнятості. Також безробітні відмічають, що можливість реалізувати, розвивати свій талант, здібності також у них викликає натхнення. Найбільш негативне враження на психічний стан аплікантів викликають думки про звільнення з попередньої роботи. *Стратегія поведінки «цілеспрямований активний пошук роботи»*: позитивному психічному стану

аплікантів сприяють думки про роботу, спілкування з працівниками служби зайнятості, зі своєю сім'єю, друзями. Негативному психічному стану цієї групи сприяє думки про звільнення з попередньої роботи, стосунки з комунальними службами. *Стратегія поведінки « згода на будь – яку роботу»*: найбільш сприятливими для позитивного психічного стану у нинішній ситуації безробітні цієї групи вважають думки про роботу, а також спілкування з друзями, сім'єю. Негативом для свого психічного стану у ситуації безробіття аплікати цієї групи також вважають думки про звільнення з останнього місця роботи, а також стосунки з комунальними службами. Практичне значення роботи полягає у розробці практичних рекомендацій, щодо роботи з аплікантами в ситуації безробіття.

Список використаних джерел.

1. Волочков А.А. Активність суб'єкта як фактор психічного розвитку (гіпотези, моделі, факти), Психологічний журнал, 2024. № 3, т. 24. С.25–41.
2. Ринок праці України у 2020 році, Аналітично – статистичний збірник, К.: ДЦЗ, 2020.
3. Киричук О.В., Блажкун Т.Д. Критерії та показники активності аплікантів у пошуку роботи, – бюлетень, К.: ІПКДСЗУ, № 2, 2003. С.27–29.
4. Киричук О.В. Психологія особистості,- К.: ІПКДСЗУ, 2003. 243 с.
5. Осницький А.К., Чуйкова Т.С. Саморегуляція активності суб'єкта у ситуації втрати роботи – Для тих, хто працює з безробітними. Випуск № 3/ під ред В.А. Шугайло: Дніпропетровськ, 2011. 156 с.

Емпіричне дослідження емоційного вигорання науково-педагогічних працівників медичних закладів вищої освіти

Яременко Л.М.

*Доктор медичних наук, професор
Здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти,
Академія праці, соціальних відносин і туризму, м. Київ*

Жук А.В.

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ

Актуальність. У сучасних умовах глибоких соціальних трансформацій, економічної нестабільності та тривалих кризових явищ проблема емоційного вигорання набуває особливої актуальності, зокрема в професіях соціально спрямованого типу. Інтенсифікація професійної діяльності, зростання інформаційного навантаження, високі вимоги до результативності та відповідальності фахівців призводять до поступового виснаження емоційних і психологічних ресурсів особистості. Сучасні емпіричні дослідження засвідчують високу поширеність синдрому емоційного вигорання серед викладачів закладів вищої освіти, що негативно впливає як на якість професійної діяльності, так і на психологічне благополуччя педагогів [1; 2].

Особливої уваги проблема емоційного вигорання потребує в контексті діяльності науково-педагогічних працівників медичних закладів вищої освіти, професійна діяльність яких поєднує освітню, наукову та клінічну складові. Така діяльність характеризується високим рівнем відповідальності, емоційної включеності, постійною міжособистісною взаємодією та необхідністю прийняття рішень в умовах обмеженого часу й підвищеного стресу. Дослідження свідчать, що саме викладачі вищої школи є однією з найбільш уразливих професійних груп щодо розвитку емоційного вигорання [1; 3].

У сучасних наукових працях наголошується, що важливу роль у зниженні інтенсивності проявів емоційного вигорання відіграють соціальна підтримка,

сформовані навички емоційної регуляції та психологічні ресурси особистості. Водночас дефіцит підтримки, хронічна перевтома, тривала тривожність і відсутність ефективних механізмів саморегуляції істотно підвищують ризик розвитку синдрому вигорання у викладачів [3; 4]. Саме тому проблема збереження психічного здоров'я науково-педагогічних працівників розглядається як одна з ключових у сучасних дослідженнях педагогічної та організаційної психології.

Додаткового загострення проблема емоційного вигорання набула в умовах пандемії COVID-19 та воєнних подій в Україні, що зумовили масове впровадження дистанційного й змішаного навчання. Зміна формату освітнього процесу, зростання навантаження, технічні труднощі, зниження якості зворотного зв'язку зі студентами та тривале перебування в умовах невизначеності посилили емоційне виснаження та професійний стрес викладачів [5]. У таких умовах особливої значущості набувають дослідження, спрямовані на виявлення психологічних чинників, що впливають на розвиток емоційного вигорання, а також ресурсів його подолання.

Для українського контексту важливими є дослідження, присвячені особливостям прояву емоційного вигорання викладачів закладів вищої освіти з урахуванням соціальних, освітніх і культурних умов. Вітчизняні наукові праці аналізують динаміку емоційного вигорання педагогів, його зв'язок із професійним стажем, умовами праці та індивідуально-психологічними характеристиками особистості [6; 7]. Такі дослідження підкреслюють необхідність системного підходу до профілактики вигорання в освітньому середовищі.

Теоретичні та прикладні аспекти впливу емоційного вигорання на професійну самосвідомість і особистісний розвиток працівників освіти широко представлені в роботах українських дослідників. Зокрема, показано, що високий рівень емоційного вигорання негативно позначається на професійній мотивації, самооцінці, задоволеності діяльністю та перспективі професійного розвитку педагогів [8; 10].

Окрему групу становлять дослідження, присвячені профілактиці емоційного вигорання та підвищенню стресостійкості педагогів в умовах сучасних соціальних викликів, зокрема воєнного стану. У цих роботах наголошується на важливості психологічної підтримки, розвитку навичок саморегуляції та формування ресурсного середовища в освітніх закладах [9].

Таким чином, актуальність емпіричного дослідження стану емоційного вигорання науково-педагогічних працівників медичних закладів вищої освіти зумовлена високою поширеністю цього феномену, специфікою професійної діяльності викладачів медичного профілю та необхідністю науково обґрунтованого пошуку шляхів профілактики й корекції емоційного вигорання у стресогенних умовах.

Мета дослідження. Здійснити емпіричне дослідження стану емоційного вигорання науково-педагогічних працівників медичних закладів вищої освіти.

Результати дослідження. Аналітичний огляд сучасних вітчизняних і зарубіжних науково-психологічних досліджень, присвячених проблемі емоційного вигорання, дозволив обґрунтувати логіку та послідовність подальшого емпіричного етапу роботи. У ході теоретичного аналізу було встановлено, що, незважаючи на значну кількість публікацій з означеної проблематики, сучасні трансформації професійної діяльності науково-педагогічних працівників, зумовлені пандемією COVID-19, тривалим дистанційним навчанням та воєнним станом в Україні, потребують поглибленого емпіричного вивчення.

Емпірична частина дослідження була організована поетапно та включала:

- добір психодіагностичного інструментарію, що відповідає меті та завданням дослідження, а також наукове обґрунтування його доцільності;
- проведення діагностичного обстеження рівня емоційного вигорання науково-педагогічних працівників із подальшою кількісною та якісною обробкою отриманих результатів;

- виявлення можливих кореляційних зв'язків між показниками емоційного вигорання та окремими особистісними характеристиками (емоційна стійкість, тривожність, фрустрованість, оптимістичність).

Вибіркову сукупність становили 30 науково-педагогічних працівників віком від 35–50 років, які здійснюють професійну діяльність у Національному медичному університеті імені О. О. Богомольця. Збір емпіричних даних здійснювався шляхом безпосередньої взаємодії з респондентами в освітньому середовищі. Дослідження проводилося в період з 1 лютого по 1 травня 2025 року.

Для реалізації мети дослідження було використано комплекс взаємодоповнюючих методів і методик. Зокрема, застосовувалася авторська анкета, розроблена на основі аналізу сучасних вітчизняних наукових джерел, спрямована на виявлення рівня обізнаності науково-педагогічних працівників щодо сутності емоційного вигорання, його проявів, причин виникнення та суб'єктивно значущих стресогенних чинників професійної діяльності [11]. Анкета містила 10 відкритих запитань і дозволяла здійснити кількісний контент-аналіз відповідей.

Для діагностики структурних компонентів синдрому емоційного вигорання використано методику визначення професійного вигорання в адаптації Л. М. Карамушки та Т. В. Зайчикової, розроблену на основі трикомпонентної моделі К. Масlach [12, 13]. Методика дає змогу оцінити рівень емоційного виснаження, деперсоналізації та редукції професійних досягнень у педагогічній діяльності та широко застосовується в українських психологічних дослідженнях [14]. Методика дозволяє оцінити вираженість таких складових синдрому, як емоційне виснаження, деперсоналізація та редукція особистісних досягнень. Варіант опитувальника для викладачів містить 22 твердження, відповіді на які фіксуються за шкалою частоти проявів від «ніколи» до «завжди». Отримані результати інтерпретувалися відповідно до нормативних показників кожної зі шкал, що дало змогу визначити рівень сформованості окремих компонентів емоційного вигорання. Сума балів порівнюється з ключем, де для «емоційного

виснаження»: 0–16 балів -низький рівень прояву; 17–26 – середній; 27 та більше – високий; для «деперсоналізації»: 0-6 балів – низький рівень; 7–12 – середній; 13 та більше – високий; для «редукції особистісних досягнень»: 0–31 балів – високий, 38–32 – середній, 39 і більше – низький.

З метою поглибленого аналізу динамічних аспектів емоційного вигорання та особливостей його фазового розвитку застосовувалися підходи до діагностики емоційного вигорання педагогів, описані в працях А. В. Величка [13, 15]. Методика дозволяє виявити специфіку проявів емоційного напруження, резистентності та виснаження в умовах тривалої професійної діяльності. Вона розглядає вигорання як поетапний процес і дозволяє визначити сформованість фаз напруження, резистентності та виснаження, а також окремих симптомів у межах кожної з них. Інтерпретація результатів здійснювалася відповідно до рекомендованих автором шкал оцінювання. Означена методика містить 84 твердження, (на які потрібно зреагувати погодженням чи ні) спрямована на діагностику трьох фаз та 12 симптомів емоційного вигорання, таких як:

- напруження (переживання психотравмуючих обставин, незадоволеність собою, тривожність та депресія);
- резистенція (неадекватна вибіркова емоційна реакція, емоційно-моральна дезорієнтація, розширення сфери економії емоцій, редукція професійних обов'язків);
- виснаження (емоційний дефіцит, відстороненість, особистісна відстороненість, психосоматичні порушення).

При обробці результатів дослідження потрібно спочатку визначався ступінь вираженості кожного з симптомів за шкалою (менше 9 балів – симптом не сформований, 10–15 – симптом формується, 16 і більше – наявний). Наступним кроком у інтерпретації визначався за шкалою від 1 до 120 балів фази розвитку емоційного вигорання (напруження, резистенція, виснаження): 36 балів – фаза не сформована, 37–60 – фаза у стадії формування, 61 та більше – фаза сформована.

Для дослідження особистісних характеристик, що можуть виступати внутрішніми чинниками впливу на інтенсивність емоційного вигорання, використовувалися окремі шкали багатовимірного особистісного опитувальника Р. Кеттела, адаптованого та апробованого в українських психологічних дослідженнях [16, 17]. Було залучено шкали, спрямовані на оцінку емоційної стійкості, рівня тривожності, оптимістичності та саморегуляції поведінки [18, 19]. Можливо використовувати окремі шкали опитувальника, хоча на думку науковців, такий підхід може бути не настільки точним та повним як весь опитувальник. Але для більш ретельного вивчення детермінант емоційного вигорання, зважаючи на тему нашого дослідження, потрібно визначити, які особистісні властивості є психологічними чинниками впливу (гальмування процесу чи сприяння йому) на інтенсивність емоційного вигорання працівників освітніх закладів. Численні дослідження доводять, що домінуючим фактором емоційного вигорання є особистісний фактор. Тому нами вибрано:

- шкали С+, С-, за допомогою яких можна визначити загальну емоційну стійкість людини, здатність контролювати свою поведінку, наполегливість у досягненні мети;
- шкали D+D- для діагностики рис людини, яка постійно проявляє тривожність, активність на слабкі провокуючі стимули, нетерплячість;
- шкали F+F-, які дають інформацію про ступінь оптимізму людини, спокою, енергійності, комунікабельності, гнучкості у вирішенні проблем.

Для створення оптимального психологічного настрою на подальшу роботу та уточнення даних, які могли здаватися нечіткими або соціально бажаними, проводилася частково стандартизована бесіда. У процесі спілкування застосовувалися такі методики: активне слухання та постановка уточнюючих запитань, як відкритого, так і закритого типу.

Під час планування та реалізації дослідження дотримувалися таких науково-етичних принципів: інформована згода – всі викладачі брали участь добровільно

після ознайомлення з темою, метою та завданнями дослідження; конфіденційність – учасники були запевнені, що всі їхні персональні дані будуть використані виключно в межах дослідження; наукова доброчесність – обробка даних здійснювалася прозоро, на основі отриманих результатів психодіагностики.

Повага до особистості учасників – на початку дослідження були встановлені правила щодо добровільності, відвертості, можливості у будь-який момент припинити участь, а також індивідуальної інтерпретації результатів, яких дотримувалися протягом усього дослідження.

Саме дотримання цих принципів, а також ретельне планування етапів дослідження та узгодження методичного інструментарію з керівником, забезпечили його професіоналізм та етичність.

Емпіричний етап почався з аналізу відповідей на авторську анкету методом кількісного контент-аналізу. Було встановлено високий рівень обізнаності респондентів (96,3 %) щодо поняття «емоційне вигорання», що охоплювало спектр від наукового визначення («інтелектуальне, ментальне, фізичне, фізіологічне та емоційне виснаження, що виникає внаслідок тривалого стресу») до побутового («прес», «бич часу, про який говорять усі»). Найчастіше використовувалися терміни «виснаження», «знесилення», «пожирач енергії», «знеструмлення». Найбільш складними для пояснення були поняття «редукція» (61,2 % опитаних асоціювали його з префіксом «РЕ», що означає «рух назад») та «деперсоналізація» («відчуття часткового зникнення або стирання рис особистості»). Деякі педагоги, особливо з додатковою психологічною освітою, використовували власні тлумачення на кшталт «хворобливе переживання власного «Я» або «дегуманізація».

Емоційне виснаження, як правило, пов'язане з професійною діяльністю. Встановлено, що 57,1 % викладачів відзначили високий негативний вплив роботи (4–5 балів на шкалі), що пояснюється інтенсивністю професійних навантажень та перенасиченістю стресовими ситуаціями, особливо протягом останніх чотирьох років.

До основних чинників, що сприяють такому рівню емоційного виснаження, відносилися: перевантаженість паперовою роботою та звітами, конфлікти з колегами, тривалий дистанційний формат навчання, технічні проблеми, очікування неприємних новин від керівництва, безвідповідальне ставлення студентів, обмежене коло спілкування та рутинність. Реакції на стресогенні фактори підтвердили потребу у терміновому впровадженні профілактичних заходів: прояви дратівливості, емоційних спалахів, сльози, скарги друзям, байдужість або відстороненість.

Результати показали, що 68,7 % респондентів відчували вплив проблем на фізичний та психічний стан поза роботою, тоді як тільки 28,9% змогли ефективно протистояти стресу, застосовуючи медитацію, зустрічі з друзями, мобільний детокс, консультації з психологом та обмеження контактів з неприємними людьми. Педагогічне спілкування формує комплекс психічних характеристик викладача, таких як роздратованість, несправедливість, уїдливість.

Відповіді на питання, що відображали пропозиції щодо зниження стресогенного впливу: зменшення непотрібної документації, організація роботи в аудиторіях, підвищення поваги керівництва до персоналу, забезпечення технічних умов перегукувалися з відповідями на питання, які аспекти роботи викликають у вас найбільше незадоволення, виснаження. Викликало насторогу те, що 43,1 % респондентів зазначили, що оточення не надає достатньої підтримки у складних ситуаціях, а іноді навіть потребує такої підтримки від них самих. Відповіді були щирими завдяки дружнім відносинам із досліджуваними та серйозності наших намірів допомогти.

Аналіз показав переважання середніх рівнів усіх трьох параметрів методики (51,4 % – виснаження; 59,9 % – деперсоналізація; 64,5 % – редукція особистісних досягнень). Водночас високий рівень емоційного виснаження (27,1 %) впливає на міжособистісну взаємодію та якість професійної діяльності. Деперсоналізація залишалася переважно середньою, що деякі науковці трактують як психологічний

захист. Редукція особистісних досягнень виявлялася у всіх респондентів незалежно від стажу і потребує додаткового вивчення, оскільки відсутність задоволення професійною діяльністю формує негативні особистісні наслідки.

Емоційне вигорання є компонентом психічного виснаження разом із фізичним та когнітивним. Його можна умовно поділити на: фізичний (змореність, безсоння, виснаження), поведінковий, психологічний (тривожність, нудьга, зниження ентузіазму, невпевненість, підозрілість, труднощі прийняття рішень, негативна установка на майбутнє). Діяльність викладачів, здебільшого жінок, надзвичайно енерговитратна, потребує напруження психофізичних ресурсів. Спрямована перш за все на досягнення результату, що у сучасних умовах ускладнюється через погане технічне забезпечення, перебої з електрикою, зв'язком, відсутність студентів або сирени. Тому нервова система і психіка викладачів, що функціонують у режимі постійної активності, зазнають впливу додаткових травмуючих факторів – карантину та воєнного стану.

Сучасна освіта в Україні орієнтована на студент-центризм, що змушує педагогів протистояти негативним впливам оточення (нахабність студентів, невихованість, вимогливість батьків), при цьому вони позбавлені можливості отримувати емоційний відгук та позитивну енергію від студентів (наприклад, «чорні екрани» у Zoom, байдужість, безвідповідальність,). Постійний контроль з боку адміністрації, страх скарг від студентів та їхніх батьків формує негативні емоції, які часто спрямовуються не назовні, а на себе («емоційний перенос»). Як зазначали респонденти: «Навіщо переживати?», «Усі невдячні», «Мої ініціативи нікому не потрібні», що змінює ставлення до студентів і до професійної діяльності загалом. Виявлена також невелика група (5 осіб), яка настільки поглиблено занурюється у роботу, що забуває про відпочинок і власні потреби («перфекціоністи-трудоголіки»), що є додатковим предиктором формування професійного вигорання. Практично у всіх опитаних спостерігаються втома, байдужість, змореність, що не зникають після нетривалого відпочинку. Перевтома

та виснаження психофізичних ресурсів проявляються у взаємодії з оточенням, а викладач не відчуває потенціалу для розвитку та перспектив у професійній діяльності. Дослідження також показало, що більш високий рівень емоційного вигорання корелює з віком (35–40 років), стажем роботи (особливо понад 5 років; після 15 років спостерігається «педагогічна криза»), сімейним станом («одинаки», втрата близьких), рівнем ерудованості (нижчий у тих, хто не займається саморозвитком), локусом контролю (інтернали мають нижчий показник), а також рівнем домагань.

Висновок. Отримані результати підтверджують актуальність проблеми емоційного вигорання серед науково-педагогічних працівників медичних закладів вищої освіти та засвідчують необхідність розробки цілеспрямованих програм профілактики й психологічної підтримки. Зниження рівня емоційного виснаження, формування навичок саморегуляції та підвищення психологічної стійкості викладачів є важливою умовою забезпечення якості освітнього процесу в сучасних умовах.

Список використаних джерел.

1. Pakdee S., Cheechang P., Thammanoon R. et al. Burnout and well-being among higher education teachers: Influencing factors of burnout // BMC Public Health. 2025. Vol. 25, Article 1409. <https://doi.org/10.1186/s12889-025-22602-w>
2. Teachers' burnout – the role of social support, gratitude, hope, entitlement and loneliness. International Journal of Applied Positive Psychology. 2024. Vol. 9, P. 827–849. <https://doi.org/10.1007/s41042-024-00154-5>
3. Burnout in teachers: the role of emotion regulation, empathy, and educational level taught. School Mental Health. 2025. Vol. 17, P. 1014–1025. <https://doi.org/10.1007/s12310-025-09794-7>
4. Murafa S.V., Barkova N.N., Karpenko A.V. Problems of Emotional Burnout of Higher School Teachers and Practical Ways to Solve Them. Bulletin of

Practical Psychology of Education. 2024. Vol. 21, No. 2, P. 102–112.
<https://doi.org/10.17759/bppe.2024210213>

5. Особливості проявів та профілактики емоційного вигорання викладачів закладів вищої освіти / Ігумнова О., Шлінчак Т. *Psychology Travelogs*. 2023. № 2. С. 51-61. <https://doi.org/10.31891/PT-2023-2-16>

6. Динаміка емоційного вигорання у учасників освітнього процесу / Катеринчук І.О, Грицук О.В. *Молодий вчений*. 2025. № 1(132). С. 101–106. <https://doi.org/10.32839/2304-5809/2025-1-132-30>

7. Емоційне вигорання викладачів як наслідок професійної діяльності / Каткова Т.А. *Проблеми сучасної психології*. <https://doi.org/10.32626/2227-6246.2009-6.%25p>

8. Метельська Н. Й. Особливості самоставлення працівників освіти з різним рівнем прояву емоційного вигорання. *Психологія і особистість*. 2023. С. 150-164. <https://doi.org/10.33989/2226-4078.2023.1.274741>

9. Денищук І. П, Попередження емоційного вигорання та підвищення стресостійкості педагогів під час війни. *Імідж сучасного педагога*. 2023. С. 89–95. [https://doi.org/10.33272/2522-9729-2023-3\(210\)-89-95](https://doi.org/10.33272/2522-9729-2023-3(210)-89-95)

10. Метельська Н. Й. Вплив емоційного вигорання на розвиток професійної самосвідомості педагогічних працівників. *Психологія і особистість*. 2015. № 1. С. 97-108. <https://doi.org/10.33989/2226-4078.2015.1.149525>

11. Жогно Ю., Грицук О. Професійне вигорання у педагогів: методологія дослідження. Львів, 2020. 160 с.

12. Карамушка Л. М., Зайчикова Т. В. Професійне вигорання педагогів: теорія та практика. К., 2020. 220 с.

13. Величко А. В. Психологічні аспекти професійного вигорання. Х., 2019. 180 с.

14. Метельська Л. І. Емоційне вигорання педагогів: теоретичні та прикладні аспекти. Львів, 2015. 250 с.

15. Ігумнова О. В., Шлінчак О. М. Емоційне вигорання викладачів: український контекст. Львів, 2023. 160 с.
16. Метельська Л. І. Професійна самосвідомість та вигорання у викладачів ЗВО. Київ, 2023. 190 с.
17. Булатевич Н., Калошин В. Соціально-психологічні чинники вигорання в освіті. К., 2021. 190 с.
18. Павленко В. Професійне вигорання та соціально-психологічні фактори. Харків, 2020. 210 с.
19. Чепелева Н., Грисенко Н. Психологічні детермінанти емоційного вигорання викладачів. К., 2022. 175 с.

ВИСНОВКИ

В умовах збройного конфлікту клінічна медицина функціонує в режимі тривалого кризового навантаження, що зумовлює її трансформацію з переважно реактивної системи надання допомоги у комплексну модель безперервного клінічного супроводу пацієнтів. Ця модель охоплює ургентну медичну допомогу, спеціалізоване та високоспеціалізоване лікування, інтенсивну терапію, профілактику ускладнень, лікування супутньої соматичної та психічної патології, а також довготривалу медичну реабілітацію. Доведено, що бойова травма та політравма мають специфічні клінічні особливості, які визначають тяжкість перебігу захворювання, високий ризик ускладнень і необхідність застосування мультидисциплінарного підходу. Поєднання травматичних ушкоджень із хронічними соматичними захворюваннями суттєво ускладнює лікувальну тактику, підвищує ризик декомпенсації життєво важливих функцій і потребує індивідуалізації клінічних рішень.

Професійне самоздійснення фахівців юридичної сфери визначається як динамічний процес формування і розвитку особистісно-професійної траєкторії діяльності фахівця під впливом як індивідуально-психологічних, так і соціально-психологічних чинників. Обґрунтування п'ятирівневої моделі організації мотивації фахівців юридичної сфери до професійного та особистісного самоздійснення забезпечує послідовність професійного розвитку: від діагностики мотиваційної сфери та професійних потреб до розробки мотиваційних впливів на основі зворотного зв'язку. Такий підхід дозволяє уникнути формалізації мотивації, підвищує її психологічну адресність і сприяє формуванню усвідомленої внутрішньої мотивації до професійного зростання.

Емоційний інтелект є ключовим психологічним ресурсом, який визначає успішність соціально-психологічної адаптації жінок-мігранток у новому середовищі. Його розвиток сприяє подоланню стресу, збереженню внутрішньої

рівноваги, формуванню конструктивних соціальних зв'язків і підтриманню професійної ідентичності, що особливо важливо в умовах вимушеного переселення. Функціонально-структурна модель емоційного інтелекту враховує як внутрішньоособистісні, так і міжособистісні аспекти емоційної компетентності, об'єднуючи дев'ять взаємопов'язаних компонентів – від усвідомлення та регуляції власних емоцій до інтеграції емоційного досвіду у процес прийняття рішень.

Виявлені закономірності створюють підґрунтя для формулювання узагальнених висновків щодо взаємозв'язку тривожності та якості сну. У більшості досліджуваних осіб було виявлено підвищений рівень тривожності, що підтверджує поширеність тривожних проявів у дорослій неклінічній популяції та актуальність вивчення їх впливу на ментальне здоров'я. Встановлено, що переважна більшість осіб із підвищеним рівнем тривожності мають порушену якість сну. Найбільш вираженими є труднощі із засинанням і порушення денного функціонування, що свідчить про зниження відновлювальної функції сну.

Найвищі показники соціальної підтримки характерні для жінок, які здійснюють виключно грудне вигодовування, тоді як у групі штучного вигодовування зафіксовано найнижчі значення. Соціально-психологічні чинники мають комплексний вплив на психоемоційний стан жінки-годувальниці та визначають успішність грудного вигодовування: емоційна стабільність, підтримка сім'ї та суспільства, культурні установки й доступність професійної допомоги та ін. Важливо розглядати їх у взаємозв'язку, адже саме баланс між внутрішніми ресурсами жінки та зовнішнім середовищем забезпечує здоровий розвиток дитини й психологічне благополуччя матері.

Мультисенсорний підхід виявляється найефективнішим завдяки одночасному залученню різних сенсорних каналів, що забезпечує глибше та повніше сприйняття інформації. Поліпшення сенсорної обробки позитивно позначається на мотивації дитини, розвитку вищих психічних функцій та

формуванні її впевненості. Комбінування різних підходів особливо актуальне в умовах інклюзивної освіти, де важливо враховувати індивідуальні особливості кожного дошкільника.

До найбільш значущих небезпечних психосоціальних чинників тяжкості наслідків стресу відносять всеосяжні екзистенційні загрози, які атакують фундаментальні основи психологічного добробуту людини: безпеку, стабільність та надію на майбутнє. Запропонована ієрархія небезпечних психосоціальних чинників тяжкості наслідків стресу, що демонструє зв'язок психологічний стан людини в умовах війни та комплексом окремих стресорів, які пов'язані складною динамікою між екзистенційними страхами, реальними втратами, поведінковими реакціями та наявними ресурсами стійкості. Ключовими рушіями психологічного дистресу є екзистенційні загрози, пов'язані з майбутнім та економічною стабільністю.

Домінуючими стратегіями копінг-поведінки в приватних підприємців є «проблемно-орієнтована», «емоційно-орієнтована» та «копінг-стратегія, орієнтована на уникнення». Встановлено, що приватні підприємці з низькою стресостійкістю у меншій мірі застосовують проблемно-орієнтовану копінг-стратегію та частіше обирають копінг-стратегію, орієнтовану на уникнення. Приватні підприємці обирають «проактивне подолання», «рефлексивне подолання», «стратегічне планування», «превентивне подолання», «пошук інструментальної підтримки», «пошук емоційної підтримки».

У рамках психоаналізу розлади харчової поведінки постають не як ізольоване поведінкове порушення, а як складне психічне утворення, тісно пов'язане з процесами становлення особистості, формування ідентичності та способами вибудовування відносин з Іншим. Такий підхід дозволяє розглядати симптом в контексті цілісної психічної організації суб'єкта. У психоаналітичній парадигмі симптоми розладу харчової поведінки мають глибинне символічне значення та є сценою, на якій розігруються фундаментальні психічні конфлікти –

сепарації та індивідуації, автономії та залежності, формування ідентичності та меж Я.

У сучасних умовах воєнного стану працівники фармацевтичних компаній зазнають впливу комплексу професійних та загальносоціальних стресорів, що істотно підвищує ризики зниження їхнього психологічного благополуччя. Стійкість до стресу постає як інтегративний психологічний ресурс, який охоплює механізми емоційної регуляції, когнітивної гнучкості, смислотворення, застосування копінг-стратегій та отримання соціальної підтримки. Зазначений ресурс може виконувати буферну функцію, послаблюючи негативний вплив стресових чинників на загальний рівень благополуччя особистості.

Результати демонструють картину психологічного функціонування особистості: посттравматичне зростання позитивно пов'язане з резильєнтністю. Чим вищий рівень резильєнтності, тим більша ймовірність трансформації травматичних подій у позитивні особистісні зміни. Помірний рівень стресу не знижує, а інколи навіть стимулює посттравматичне зростання, виступаючи тригером адаптивних механізмів. Резильєнтність виконує буферну (захисну) функцію, пом'якшуючи вплив стресу та сприяючи конструктивній інтеграції досвіду. Загалом отримані результати вказують на гармонійне функціонування ключових психологічних компонентів, що забезпечують відновлення, адаптацію та конструктивне особистісне зростання після стресових і травматичних подій.

Аналіз ціннісних орієнтацій показав, що як чоловіки, так і жінки зосереджуються на основних життєвих цінностях, важливих для раннього дорослого віку, зокрема на збереженні здоров'я, побудові близьких стосунків, досягненні стабільності та особистісній самореалізації. Серед способів досягнення цих цілей є відповідальність, раціональність і життєрадісність. У чоловіків більш вираженою є орієнтація на раціональне осмислення ситуації як основний спосіб подолання труднощів, тоді як жінки більше уваги приділяють саморегуляції та підтриманню позитивного емоційного стану. Отримані

результати свідчать про доцільність урахування гендерних особливостей у процесі надання психологічної допомоги, зокрема відмінностей у переживанні травми, рівнях тривожності та ціннісно-смысловій сфері особистості.

Доведено, що психологічна адаптація внутрішньо переміщених осіб до нових умов соціально-економічного середовища буде проходити успішніше, позитивно відбиватиметься на психічних станах якщо процес взаємодії з новим середовищем буде заснований на результатах комплексної всебічної кваліфікованої допомоги психологів, соціальних працівників, волонтерів тощо.

Дослідження дозволило всебічно вивчити особливості ціннісних орієнтацій щодо сім'ї та шлюбу в сім'ях, де виховуються діти з розладами аутистичного спектра, з урахуванням впливу хронічного стресу на ментальне здоров'я батьків та загальну життєстійкість родини. Ціннісна сфера батьків у таких сім'ях набуває вираженого захисного характеру: відбувається зміщення ієрархії цінностей у бік термінальних орієнтацій на здоров'я дитини, стабільність і щасливе сімейне життя, тоді як цінності, пов'язані з індивідуальною самореалізацією, кар'єрою та суспільним визнанням, суттєво знижуються в пріоритеті. Ця трансформація є адаптивною реакцією на тривалі психоемоційні навантаження, однак у довготривалій перспективі може призводити до емоційного вигорання, зниження якості подружніх стосунків та фіксації дисгармонійних моделей взаємодії.

У психосоціальній дезадаптації в ситуації невизначеності більш високий рівень тривожності спостерігається у жінок. Рівень фрустрованості жінок також вищий ніж чоловіків. Агресивність, навпаки, більш притаманна чоловікам. За показником ригідності психіки жінки показали вищі результати аніж чоловіки, що дозволяє останнім бути більш мобільними у ситуації невизначеності. Виявлено, що за шкалою схильності до подолання соціальних норм та правил та шкалою схильності до адиктивної поведінки чоловіки показали вищі результати готовності.

Виявлено, що віковий чинник помірно модифікує інтенсивність психічних станів: у старших підгрупах (45 років і старше) спостерігається тенденція до зростання високих рівнів тривожності, фрустрації та ригідності, тоді як агресивність залишається переважно в межах низьких і середніх значень. Це свідчить про збереження соціально прийнятних форм емоційної регуляції на тлі зростання внутрішньої напруги. Місце проживання виступає контекстуальним чинником психічних станів. У жінок, які проживають у сільській місцевості, виявлено вищі показники тривожності, фрустрації та ригідності порівняно з міськими мешканками, що може бути пов'язано з обмеженістю ресурсів підтримки, підвищеною залежністю від зовнішніх умов та потребою у стабільності. Кількість попередніх пологів є диференціальним фактором психічних станів. Зі зростанням паритету посилюються прояви тривожності, фрустрації та ригідності, що відображає накопичення психоемоційного та побутового навантаження. Агресивність у всіх підгрупах залишається відносно контрольованою.

Доведено, що ефективною формою розвитку конкурентоспроможної особистості є тренінгова програма. Метою програми є розвиток компонентів конкурентоспроможності особистості в умовах кризи. До завдань програми віднесено: 1) посилення самоефективності як складової мотиваційного компонента розвитку конкурентоспроможності; 2) розвиток інноваційного потенціалу особистості як основного ресурсу діяльнісного компоненту розвитку конкурентоспроможності; 3) посилення комунікативних навичок та навичок соціальної взаємодії як складових індивідуально-психологічного компонента розвитку конкурентоспроможності.

Управління емоціями, професійним стресом та синдромом професійного вигорання розглядається як здатність особистості ефективно застосовувати внутрішні ресурси саморегуляції, не перекладаючи відповідальність за емоційний стан на зовнішні обставини чи інших осіб. Такий підхід сприяє формуванню

психологічної стійкості, підвищенню рівня емоційної компетентності та зниженню ризику розвитку емоційного виснаження в умовах професійної діяльності, пов'язаної з підвищеним ризиком інфікування ВІЛ.

Уточнено поняття життєвих ролей як соціально-психологічних утворень, що пов'язані зі стилем та смислом життя, а також із життєвим сценарієм особистості. Визначено рольову компетентність як інтегральну здатність ефективно розв'язувати життєві проблеми, що охоплює варіативність, гнучкість, глибину, децентрацію та прийняття ролей інших. Встановлено, що рольова компетентність позитивно впливає на успішність подолання життєвих проблем, хоча прямої залежності між рівнем компетентності та результативністю не виявлено.

Сучасні інтегративні моделі дозволяють подолати редукціонізм у розумінні адикцій, пропонуючи цілісний, системний підхід. Вище наведені моделі розглядають адиктивну поведінку як результат складних нелінійних взаємодій між особистістю та середовищем; інтегрують біологічні, психологічні та соціальні детермінанти; розуміють адикцію як динамічний процес із фазами розвитку та змін. Формування та розвиток залежності є адаптаційним процесом (хоча і дезадаптивним за наслідками), через який особистість намагається впоратися з внутрішніми та зовнішніми викликами.

ЧАСТИНА 2.
МАТЕРІАЛИ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
«MENTAL HEALTH: ОСОБИСТІСНИЙ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВИМІРИ»
10 жовтня 2025 року, УКРАЇНА, м. КИЇВ

**Психологічні чинники емоційного вигорання у викладачів медичних
університетів**

Бегеза Л.Є.

*Доктор психологічних наук, професор
Академія праці, соціальних відносин і туризму, м. Київ*

Жук А.В.

*Здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти
Академія праці, соціальних відносин і туризму, м. Київ*

Яременко Л.М.

*Здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти
Академія праці, соціальних відносин і туризму, м. Київ*

Актуальність. Проблеми емоційного вигорання (ЕВ) серед викладачів медичних університетів зумовлена специфікою їхньої професійної діяльності, яка поєднує високі вимоги до наукової, педагогічної та часто клінічної роботи. Викладачі медичних ЗВО є ключовою ланкою у формуванні майбутніх медичних фахівців, тому їхній психоемоційний стан безпосередньо впливає на якість освітнього процесу та власне здоров'я. Дослідження психологічних чинників, які сприяють розвитку ЕВ у цій професійній групі, є критично важливим для розробки ефективних профілактичних та корекційних програм.

Мета дослідження. Аналіз та систематизація психологічних чинників емоційного вигорання у викладачів медичних університетів. Результати дослідження. Психологічна специфіка праці викладачів-медиків та ключові внутрішні (особистісні) та зовнішні (ситуаційні) психологічні чинники спричиняють емоційне вигорання у викладачів медичних університетів.

Емоційне вигорання визначається як синдром, що включає емоційне виснаження, деперсоналізацію та редукцію професійних досягнень [1, с. 45]. Для викладачів медичних закладів цей синдром має особливі підстави.

По-перше, викладачі медичних університетів часто стикаються з високим рівнем емоційного навантаження, пов'язаного з викладанням клінічних дисциплін, де обговорюються складні клінічні випадки, страждання пацієнтів та питання життя і смерті. Це вимагає постійної емоційної залученості та співчуття (емпатії), що виснажує емоційні ресурси [2].

По-друге, має місце подвійне професійне навантаження:

1. Педагогічна діяльність, яка включає підготовку лекцій, семінарів, перевірку робіт, консультації студентів, участь у методичній роботі кафедри і навчального закладу.

2. Наукова діяльність, що базується на проведенні експериментальних та клінічних досліджень, написання статей, наукових кваліфікаційних робіт.

3. Клінічна діяльність характеризується проведенням клінічної та лікувальної роботи з пацієнтами у клінічних базах медичних установ.

Таке поєднання призводить до хронічного дефіциту часу та відчуття нескінченності робочих обов'язків, що є прямим шляхом до емоційного виснаження.

Ключові психологічні чинники емоційного вигорання можна умовно поділити на особистісні (внутрішні) та організаційно-ситуаційні (зовнішні).

До особистісних чинників відносяться:

1. Перфекціонізм та гіпервідповідальність є одним із головних чинників у викладачів з високими внутрішніми стандартами якості та надмірною відповідальністю за результат навчання студентів, та проявляють схильність до перенапруги та самокритики. Прагнення до ідеальних показників у всіх сферах діяльності (навчання, наука, клінічна робота) створює постійний внутрішній тиск.

2. Емпатійна втома притаманна викладачам, які мають високий рівень емпатії та постійно стикаються зі стресом студентів (особливо під час іспитів чи клінічної практики) або працюють безпосередньо з пацієнтами, можуть переживати вторинну травматизацію та виснаження емпатійних ресурсів [3].

3. Низька психологічна стійкість (копінг-стратегії) характеризується неефективними механізмами подолання стресу (наприклад, уникнення, самозвинувачення) замість конструктивного розв'язання проблем, що посилюють негативні наслідки робочого навантаження.

4. Екстернальний локус контролю характеризується переконанням, що професійний успіх більше залежить від зовнішніх обставин (керівництво, фінансування, якість студентів), а не від власних зусиль, може призводити до відчуття безпорадності та редукції професійних досягнень.

До організаційно-ситуаційних чинників відносяться:

1. *Рольовий конфлікт та нечіткість ролей*, що характеризується відсутністю чіткого розмежування обов'язків між науковою, педагогічною та клінічно-лікувальною роботою, а також суперечливими вимогами від різних адміністративних ланок (деканат, кафедра, МОН), що викликають внутрішню напругу.

2. *Відсутність соціальної підтримки*, що характеризується недостатністю підтримки з боку колег, керівництва або сім'ї, що значно посилює вплив стресових факторів. Соціальна підтримка є буфером, що знижує ймовірність розвитку ЕВ [4, с. 88].

3. Одним із компонентів ЕВ є *несправедлива система оцінювання та заохочення*, що включає систему оплати праці, кар'єрного зростання або нагородження та сприймається як несправедлива, це викликає цинізм та деперсоналізацію.

Наслідки емоційного вигорання для викладача включають зниження задоволеності роботою, погіршення фізичного та психічного здоров'я, а також

зниження якості освітнього процесу (наприклад, формальне ставлення до студентів).

Для ефективної профілактики необхідно впроваджувати комплексні заходи, які включають:

1. *Організаційні* – це оптимізація навчального навантаження, чітке визначення посадових обов'язків, запровадження справедливої системи заохочень.

2. *Психологічні (індивідуальні)* – це тренінги з управління стресом, розвиток навичок саморегуляції, підвищення психологічної стійкості, навчання ефективним копінг-стратегіям, підвищення рівня усвідомленості (майндфулнес).

3. *Соціально-психологічні* – це створення груп підтримки, менторські програми, сприяння позитивному мікроклімату в колективі кафедри та лікувального закладу.

Таким чином, емоційне вигорання у викладачів медичних університетів є багатофакторним явищем, де ключову роль відіграють як особистісні риси (перфекціонізм, емпатійність), так і ситуаційні фактори (подвійне навантаження, рольовий конфлікт). Розуміння цих чинників дозволяє розробити цілеспрямовані та ефективні інтервенції для збереження їхнього професійного здоров'я та підвищення якості медичної освіти.

Список використаних джерел.

1. Малишева К.В. Психологія професійного здоров'я: монографія. Київ: Університет «Україна», 2022. 210 с.

2. Олійник І.П. Емпатійна напруга та вигорання у фахівців соціономічних професій. Вісник психології і педагогіки. 2023. Вип. 12 (1). С. 110–125.

3. Петренко В.А., Ковальчук Л.М. Вплив організаційного стресу на розвиток синдрому емоційного вигорання. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 12. Психологічні науки. 2024. № 4 (49). С. 13–21.

4. Степаненко М.О. Професійний стрес та його профілактика: навчальний посібник. Львів: Нова книга, 2021. 300 с.

Психологічні чинники виникнення та переживання стресу у фахівців медичної сфери

Борець О.А.

*Доктор філософії з спеціальності «Психологія»
Академія праці, соціальних відносин і туризму, м. Київ*

Карнаух Т.В.

*Здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти
Академія праці, соціальних відносин і туризму, м. Київ*

Актуальність. Медична професія є однією з найбільш стресогенних у сучасному суспільстві. Щоденна взаємодія з пацієнтами, необхідність прийняття критичних рішень, емоційне навантаження та постійна відповідальність за життя людей створюють умови для виникнення хронічного стресу. Особливо актуальним це питання стало в умовах пандемії COVID-19, воєнних дій та реформування системи охорони здоров'я в Україні. Психологічні чинники, що спричиняють стрес, мають комплексний характер і потребують глибокого аналізу для розробки ефективних механізмів профілактики та подолання.

Мета дослідження. Визначити основні психологічні чинники, що спричиняють стрес у медичних працівників, та проаналізувати їх вплив на професійну діяльність і психоемоційний стан фахівців.

Результати дослідження. Стрес – це реакція організму на зовнішні або внутрішні подразники, що порушують його гомеостаз. За Лазарусом і Фолкманом (1984), стрес виникає тоді, коли індивід оцінює ситуацію як загрозливу і не має достатніх ресурсів для її подолання [6, с. 19].

Сучасні наукові джерела визначають стрес як стан, що виникає при загрозі гомеодинамічному балансу організму під дією різних внутрішніх чи зовнішніх чинників. У медичній сфері стрес застосовується як універсальний адаптаційний механізм, що забезпечує виживання за рахунок активації нейроендокринної системи, що включає гіпоталамо-гіпофізарно-наднирникову вісь [3].

Короткочасний (гострий) стрес забезпечує мобілізацію ресурсів організму, покращуючи когнітивні та фізичні функції, проте хронічний чи надмірний стрес призводить до виснаження адаптаційних резервів та розвитку патологічних змін, так званого алостатичного навантаження. Хронічна активація стрес-системи пов'язана з порушенням регуляції кортизолу, змінами вегетативної нервової системи, дисфункцією імунітету та розвитком патологічних соматичних та психічних станів, включаючи депресію, тривожні розлади, серцево-судинні захворювання тощо [7; 8].

У медичній практиці прояви стресу різноманітні і можуть характеризуватись наступними аспектами:

- психологічні маркери (суб'єктивне відчуття шуму, депресія, емоційне виснаження, порушення сну, зниження когнітивних функцій);
 - фізіологічні маркери (зміни варіабельності серцевого ритму, підвищення артеріального тиску, прискорене серцебиття, порушення імунної відповіді);
 - біохімічні маркери (підвищення рівня кортизолу, катехоламінів, салівації)
- [7; 9].

Особливе значення у медичній сфері має стрес у медичних працівників, який може призвести до професійного вигорання, зниження якості надання медичної допомоги та підвищення ризику помилок.

У медичній сфері стресогенні ситуації є повсякденними: невизначеність діагнозу, ризик помилки, етичні дилеми, смерть пацієнта, конфлікти з родичами хворих тощо.

Згідно досліджень Асонова Д. та Стаднюк Л.А. ключовими психологічними чинниками стресу у медичних працівників є [1; 4]:

- емоційне навантаження: постійна взаємодія з пацієнтами, переживання їх болю, страху, втрати;
- висока відповідальність: ризик фатальних помилок, необхідність швидкого прийняття рішень;

- перевантаження: надмірна кількість пацієнтів, ненормований графік, нічні зміни;
- недостатня підтримка: відсутність психологічної допомоги, низький рівень соціального визнання;
- особистісні чинники: тривожність, перфекціонізм, низька стресостійкість, емоційна вразливість;
- організаційні проблеми: бюрократія, нестача ресурсів, конфлікти в колективі;
- кризові ситуації: пандемії, війна, надзвичайні події, що підвищують рівень тривоги та невизначеності.

Брак балансу між роботою та особистим життям, а також індивідуальні риси, як-от відсутність покликання до професії, можуть посилювати негативні ефекти [1; 5].

Хронічний стрес негативно впливає на професійну ефективність, спричиняючи зниження продуктивності, проблеми з концентрацією та вигоряння, а також завдає шкоди психічному здоров'ю, викликаючи тривогу, депресію, дратівливість та загострення психологічних розладів. Наслідки включають також проблеми зі сном, погіршення пам'яті, зниження мотивації та загального самопочуття.

Стрес у медичному середовищі – це серйозна проблема, тому вкрай важливою є необхідність визначити ключові шляхи профілактики та подолання стресу, засновані на сучасних дослідженнях та практиках.

По-перше, профілактика стресу, яка передбачає організацію робочого часу і має на меті скорочення тривалості змін та забезпечення регулярних перерв, а також передбачає гнучкий графік роботи та можливість вибору змін. По-друге, психологічна підтримка, яка включає регулярні зустрічі з психологом чи коучем, та наявність груп підтримки та супервізій для обговорення складних випадків. По-третє, навчання стрес-менеджменту, що передбачає тренінги з управління

емоціями, тайм-менеджментом та техніками релаксації, а також розвиток навичок саморегуляції та стійкості до стресу. І останній, не менш важливий за попередні, пункт – це створення сприятливого робочого середовища, що включає підтримку з боку керівництва та колег, а також визнання досягнень та вкладів співробітників [2].

Проблему подолання стресу, що вже виник, пропонується вирішити наступними заходами [5, с.21–25]:

- фізичною активністю (регулярні вправи, йога, прогулянки, спосіб зняти напругу та покращити настрій);
- методами релаксації (медитація, дихальні практики, прогресивна релаксація м'язів);
- наданням професійної допомоги (звернення до психотерапевта за ознаками вигорання або депресії, або використання програм Employee Assistance Program (EAP), якщо вони доступні);
- зміною професійного навантаження (перерозподіл обов'язків, тимчасове зниження навантаження чи перехід на менш стресову посаду).

Ці заходи допомагають не тільки зберегти психічне здоров'я медичних працівників, а й підвищити якість медичної допомоги.

Висновки. Психологічні чинники стресу у медичних працівників мають багатогранний характер і значно впливають на їхню професійну ефективність та психічне здоров'я. Системне вирішення цієї проблеми потребує комплексного підходу, що включає як індивідуальні, так і організаційні стратегії. Підвищення психологічної грамотності, створення умов для емоційного відновлення та підтримки – ключові елементи збереження здоров'я медичних фахівців.

Список використаних джерел.

1. Стаднюк Л. А., Давидович О.В., Приходько В.Ю., Олійник М.В., Ширяєва М.І. Синдром емоційного вигорання: фактори, що сприяють його виникненню і попередженню. Вісник наукових досліджень. 2017. № 1. С. 145–149.

Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vndt_2017_1_35 (дата звернення: 25.09.2025)

2. Хромцева О. Поняття професійного вигорання медичних працівників та дослідження його феноменології. *European Journal of Management Issues*, 2019. № 27 (3–4). С. 63–72. DOI: <https://doi.org/10.15421/191907>. (дата звернення: 03.10.2025)

3. Agorastos A., Chrousos G.P. Neuroendocrinology of stress: Stress-related continuum of chronic disease development. *Molecular Psychiatry*. Jan 2022. Vol. 27, No 1. P. 502-513. DOI: 10.1038/s41380-021-01224-9. (дата звернення: 25.09.2025)

4. Assonov, D. Емоційне вигорання медичних працівників: моделі, фактори ризику та протективні фактори. *Психосоматична медицина та загальна практика*. 2021. 6(2), e0602295. DOI: 10.26766/pmgrp.v6i2.295. (дата звернення: 03.10.2025)

5. Balakirjeva K. Profilaktyka ta podolannjia profesjnoho ta emocijnoho vyhorannjia. Kyiv: UNDP; 2020. URL: <https://www.slideshare.net/undpukraine/ss-48391940>. (дата звернення: 05.10.2025)

6. Lazarus R.S., Folkman S. *Stress, Appraisal, and Coping*. Springer Publishing Company, 1984. 456 p.

7. McEwen B.S., Akil H. Revisiting the Stress Concept: Implications for Affective Disorders. *J Neurosci*. 2020, Jan 2. Vol. 40, No 1. P. 12–21. DOI: 10.1523/JNEUROSCI.0733-19.2019. (дата звернення: 26.09.2025)

8. O'Connor D.B., Thayer J.F., Vedhara K. Stress and Health: A Review of Psychobiological Processes. *Annu Rev Psychol*. 2021, Jan 4. Vol. 72. P. 663-688. DOI: 10.1146/annurev-psych-062520-122331. (дата звернення: 26.09.2025)

9. Shah K., Kumari R., Jain M. Unveiling stress markers: A systematic review investigating psychological stress biomarkers. *Dev Psychobiol*. 2024 Jul. Vol. 66, No 5: e22490. DOI: 10.1002/dev.22490. (дата звернення: 25.09.2025)

Емоційний інтелект як фактор адаптації жінок у міграційних умовах

Борець О.А.

*Доктор філософії з спеціальності «Психологія»
Академія праці, соціальних відносин і туризму, м. Київ*

Мироновська О.В.

*Здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти
Академія праці, соціальних відносин і туризму, м. Київ*

Актуальність. Емоційний інтелект (ЕІ) розглядається як ключовий психологічний ресурс, який визначає здатність особистості до саморегуляції, ефективної міжособистісної взаємодії та адаптації в умовах зміни соціального та культурного середовища. Особливої значущості розвиток ЕІ набуває у контексті вимушеної міграції, оскільки він безпосередньо впливає на ефективність соціально-психологічної адаптації, рівень внутрішньої стійкості та здатність подолати стресові ситуації.

Мета дослідження. Визначення рівня сформованості емоційно-рефлексивної сфери жінок-мігранток, які перебувають у Польщі та Німеччині, а також внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в Україні, із застосуванням методики оцінки емоційного інтелекту Н. Холла.

Результати дослідження. Методика дослідження передбачала вимір п'яти компонентів ЕІ: емоційної обізнаності, контролю емоцій, самомотивації, емпатії та розпізнавання емоцій інших людей. Було проведено детальний порівняльний аналіз середніх значень компонентів емоційного інтелекту у різних групах, що надало змогу окреслити специфічні закономірності їхнього розвитку в умовах адаптації до нових соціокультурних контекстів (табл. 1). Результати дослідження свідчать, що жінки-мігрантки, які перебувають у Польщі, мають найнижчий загальний рівень ЕІ серед усіх груп, який становить 24 бали, що відповідає нижчому за середній рівню. Спостерігається суттєва нерівномірність розвитку

компонентів: найвищим є показник емпатії (14 балів), що відображає збережену здатність до співпереживання та ефективної міжособистісної взаємодії.

Таблиця 1

Середні значення показників емоційного інтелекту жінок різних вибірок

Компоненти емоційного інтелекту	Польща	Німеччина	ВПО
Емоційна обізнаність	5,0	9,0	10,0
Контроль емоцій	4,0	7,0	4,0
Самотивація	3,0	7,0	4,0
Емпатія	6,0	11,0	10,0
Розпізнавання емоцій інших	6,0	9,0	11,0
Загальний бал EQ	24,0	35,0	35,0

Водночас низькі показники самотивації (3 бали) та обмежений контроль емоцій (7 балів) свідчать про труднощі у внутрішній мобілізації ресурсів, емоційне виснаження та недостатню здатність до саморегуляції. Рівень емоційної обізнаності становив 11 балів, а розпізнавання емоцій інших – 7 балів, що демонструє базові навички сприйняття емоційного стану оточення, але водночас недостатню точність і ефективність реакцій.

Такий профіль вказує на диспропорції між високим потенціалом у міжособистісній сфері та обмеженими внутрішніми ресурсами для саморегуляції, що може ускладнювати адаптацію та інтеграцію у нове середовище.

Жінки, які перебувають у Німеччині, демонструють більш збалансовану структуру ЕІ з загальним показником 35 балів, що відповідає середньому рівню. Найвищими є показники емпатії (11 балів) та самотивації (7 балів), що свідчить про здатність усвідомлювати власні емоційні стани, підтримувати внутрішню активність та налагоджувати соціальні контакти. Контроль емоцій також склав 7 балів, емоційна обізнаність – 9 балів, розпізнавання емоцій інших – 9 балів. Відносно рівномірний розвиток компонентів ЕІ створює передумови для

ефективної адаптації, підтримання психологічного балансу та реалізації проактивних стратегій подолання стресових ситуацій. Така структура ЕІ відображає наявність достатнього психологічного ресурсу для соціальної інтеграції та підтримки внутрішньої стійкості в умовах вимушеної міграції.

Внутрішньо переміщені жінки характеризуються загальним рівнем ЕІ 35 балів, однак із специфічними відмінностями у структурі компонентів. Найвищі показники отримали розпізнавання емоцій інших людей (11 балів) та емпатія (10 балів), що свідчить про здатність ефективно зчитувати емоційні сигнали оточення, проявляти співпереживання та надавати підтримку. Емоційна обізнаність досягла 10 балів, тоді як контроль емоцій і самомотивація становили лише 4 бали, що вказує на обмежену здатність до внутрішньої регуляції та мобілізації ресурсів. Такий профіль демонструє високий потенціал для соціальної взаємодії, водночас підкреслює необхідність цілеспрямованої психологічної підтримки для розвитку самоконтролю, стійкості та внутрішньої мотивації.

Висновки. Зіставлення результатів усіх груп показує, що емоційний інтелект жінок-мігранток та ВПО є динамічним і неоднорідним. Найнижчий рівень ЕІ спостерігається у Польщі, що свідчить про складність адаптаційного процесу та підвищене емоційне навантаження. Жінки в Німеччині демонструють середній рівень із відносно збалансованою структурою компонентів, що забезпечує ефективну адаптацію. ВПО мають високий потенціал для соціальної взаємодії, проте обмежені можливості для саморегуляції та мобілізації внутрішніх ресурсів.

Результати підкреслюють значущість емпатії та розпізнавання емоцій оточення як основи для ефективної міжособистісної взаємодії. Контроль емоцій та самомотивація визначають внутрішню стабільність та здатність долати стресові ситуації, що особливо важливо у контексті вимушеної міграції. У практичній площині це означає, що для забезпечення психологічної стійкості та ефективної адаптації необхідно цілеспрямовано працювати над розвитком внутрішніх

ресурсів, навичок самоконтролю та підтримання мотиваційного потенціалу. Дослідження дозволяє окреслити ключові напрямки психологічної підтримки жінок-мігранток і ВПО, спрямованої на розвиток емоційного інтелекту як основного чинника успішної соціально-психологічної інтеграції та подолання наслідків вимушених життєвих змін.

Список використаних джерел.

1. Євченко І. М. Емоційний стан українців під час російсько-української війни. Психологічні виміри особистісної взаємодії суб'єктів освітнього простору в контексті гуманістичної парадигми. 2022. 45 с.
2. Максьом К.В. Емоційний інтелект: основні концептуальні підходи та структурна модель соціально-психологічного феномену. Актуальні проблеми психології: збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Т. VI: Психологія обдарованості. Вип. 14. Київ; Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2018. С. 348–355.
3. Петруня В.П. Емоційний інтелект у контексті психології особистості. Київ: Ніка-Центр, 2021. 246 с.
4. Brackett, M. A., Rivers, S. E., Shiffman, S., Lerner, N., & Salovey, P. (2006). Relating emotional abilities to social functioning: A comparison of self-report and performance measures of emotional intelligence. *Journal of Personality and Social Psychology*, 91, 780–795.

Взаємозв'язок порушення сну з тривожними станами

Борець О.А.

*Доктор філософії з спеціальності «Психологія»
Академія праці, соціальних відносин і туризму, м. Київ*

Рудова А.Г.

*Здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти
Академія праці, соціальних відносин і туризму, м. Київ*

Актуальність. Якість і тривалість сну безпосередньо впливають на ефективність когнітивних, емоційних та поведінкових функцій людини. Тривога часто пов'язана з проблемами зі сном. Надмірне занепокоєння та страх ускладнюють засинання та пробудження сну протягом ночі. Недосипання може посилити тривожність, провокуючи негативне замкнене коло, що включає безсоння та тривожні розлади.

Сон необхідний для консолідації пам'яті, що є фундаментальною складовою для виживання та високого рівня функціонування людини. Порушення сну може призводити до зниження когнітивних функцій і підвищення ризику хвороби Альцгеймера та пов'язаної з нею деменції.

Повноцінний відпочинок відіграє ключову роль у регуляції емоцій і підтриманні психосоціального благополуччя. Основні психічні розлади не тільки порушують сон, але й дефіцит сну підвищує ризик тривожних розладів, великої депресії, біполярного афективного розладу, розладів, пов'язаних із вживанням психоактивних речовин, посттравматичного стресового розладу, самогубств [3].

Мета дослідження. Виявлення взаємозв'язку між показниками порушення сну та рівнем тривожності в осіб молодого віку.

У сучасних емпіричних даних підтверджується вплив стресових подій та психічних розладів на сон. Результати міжнародного дослідження, проведеного у квітні 2023 року серед українського населення, віком від 18 до 79 років, в умовах воєнного стану свідчать, що через рік після початку повномасштабного

вторгнення Росії 39,4 % українців мали скорочену тривалість сну (≤ 6 годин), а 38,5 % – безсоння. Порухення сну частіше спостерігалися у жінок, осіб із тривожними та депресивними симптомами, пережитими травматичними подіями та посттравматичним стресовим розладом. Дослідження також продемонструвало, що інсомнія та коротка тривалість сну тісно пов'язані зі зниженням якості життя у фізичній, психологічній та соціальній сферах [5].

Актуальні дослідження підтверджують, що тривалість сну має суттєвий вплив на рівень тривожності. Так, у національно репрезентативному дослідженні серед дорослого населення США встановлено, що коротка тривалість сну (< 7 годин) достовірно пов'язана з підвищеним ризиком тривожних проявів. Особливо вираженим цей зв'язок виявився серед молодих осіб, які частіше демонстрували симптоми тривожності як при короткому, так і при надмірно тривалому сні. Отримані результати узгоджуються з іншими емпіричними даними, які свідчать, що саме у молодому віці тривога й порушення сну формують взаємозалежний цикл, який негативно впливає на психоемоційне благополуччя та адаптивні ресурси особистості [4; 5].

Також є дослідження Животовської А. І. «Вплив якості сну на якість життя пацієнтів з тривожними розладами» (2022), в якому було обстежено 81 пацієнта з тривожними розладами та диссомнією за допомогою клініко-психопатологічного, психодіагностичного та статистичного методів. Використовували шкали PSM-25 (рівень стресу), HADS (тривога та депресія), HAM-A (соматичний і психічний компоненти тривоги), SF-36 (якість життя) та PSQI (якість сну). Пацієнтів поділили на три групи за рівнем стресу: низький (25 осіб), середній (29 осіб) і високий (27 осіб) [2]. Тривожна симптоматика переважала над депресивною. Показники HAM-A зростали зі збільшенням рівня стресу ($p < 0,001$). Підвищення стресового навантаження асоціювалося з погіршенням якості життя та сну. Виявлено сильну негативну кореляцію між якістю життя та порушеннями сну, а також між інтенсивністю болю та якістю сну [2].

Тривожні розлади є найпоширенішими розладами психічного здоров'я у світі і виникають у близько 33,7 % населення протягом життя. Вони порушують повсякденне функціонування людини і проявляються завищеним та постійним почуттям страху та занепокоєння, що не відповідають фактичній загрозі. Разом із депресивними розладами вони становлять 10,0 % років прожитих з інвалідністю в усьому світі. Епідеміологічні дослідження показують, що серед осіб з тривогою скарги на порушення сну мають високу поширеність в загальній популяції. Безсоння є одним з головних предикторів виникнення тривоги, яке пов'язане з психічним гіперзбудженням, занепокоєнням та негативними думками. Повідомляється, що порушення сну є поширеним симптомом, наслідком або супутнім захворюванням при діагностованих тривожних розладах. Водночас, гостра або короткочасна депривація сну виступає в ролі анксіогенного фактора, що призводить до підвищення тривожності [1]. Аналіз узагальнених наукових даних свідчить, що існує чіткий взаємозв'язок між якістю сну та рівнем тривожності. Часті стресові події, інформаційне перевантаження та порушення режиму дня, характерні для сучасного способу життя молоді, спричиняють скорочення тривалості сну або його фрагментацію. Це, у свою чергу, посилює тривожність, емоційне напруження та погіршує психоемоційне благополуччя. Наведені дослідження показують, що зі зростанням рівня стресу погіршується якість сну і життя, а тривожна симптоматика стає більш вираженою. Таким чином, порушення сну не лише є наслідком підвищеної тривоги, а й підсилюють її прояви, утворюючи замкнене коло, що потребує психологічної корекції та профілактики, що стане предметом подальших досліджень.

Висновки. Сон – це не просто період відпочинку, а фундаментальний процес, що забезпечує відновлення психічних і фізичних ресурсів. Він сприяє зміцненню пам'яті, регуляції емоцій та підтриманню оптимальної роботи організму. Порушення сну можуть серйозно впливати на ці процеси, викликаючи зниження концентрації, проблеми з настроєм і загальне погіршення якості життя.

Хоча зв'язок між сном і тривогою може створювати складнощі, він одночасно відкриває можливості для позитивних змін. Усвідомлення цієї взаємозалежності дозволяє людям активно керувати тривожністю та сприяти якісному сну, що покращує загальне самопочуття. Подолання порушень сну та тривоги – процес індивідуальний, але важливий для кожного. Робота над обома аспектами є ключем до зміцнення психічного здоров'я та підвищення якості життя. Завдяки розумінню цього взаємозв'язку та впровадженню спеціальних стратегій можна значно наблизитися до стану спокою і гармонії, який приносить здоровий нічний сон.

Список використаних джерел.

1. Животовська А. І. Хронобіологічні аспекти порушення сну при тривожних розладах. Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. 2023. Т. 23, № 4 С. 99–104. DOI: 10.31718/2077-1096.23.4.99.
2. Животовська А. І. Вплив якості сну на якість життя пацієнтів з тривожними розладами. Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. 2022. Т. 22, № 3–4. С. 53–58. DOI: 10.31718/2077-1096.22.3.4.53.
3. Соловійова С. Сон як невід'ємна складова фізичного та психічного здоров'я. НейроNEWS: психоневрологія та нейропсихіатрія. 2023. № 9 (145). С. 5–6. URL:https://neuronews.com.ua/ua/archive/2023/9_%28145_%29/pages-5-6/son-yak-nevid-iemna-skladova-fizichnogo-ta-psihichnogo-zdorov-ya#gsc.tab=0 (дата звернення: 08.10.2025).
4. Wang, X., Zhong, Y., Wang, R., Zhang, D., Li, Y., Pan, Y., Li, Y. Association between sleep duration and anxiety among adults in the United States: a nationally representative cross-sectional study. *Psychology Research and Behavior Management*. 2025. Vol. 18. P. 1155–1167. DOI: 10.2147/PRBM.S516062.
5. Wang, S., Hicks, M. H.-R., Barrett, E., Martsenkovskyi, D., Holovanova, I., Marchak, O., Ishchenko, L., Fiedler, N., Haque, U. Sleep duration, insomnia, and associated factors among Ukrainians 1 year after Russia's full-scale invasion. *Psychosomatic Medicine*. 2024. Vol. 86, No. 8. P. 690–699. DOI: 10.1097/PSY.0000000000001337.

Психологічні особливості комунікації матері та дитини в період грудного вигодовування

Воробей В.О.

*Здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти
Академія праці, соціальних відносин і туризму, м. Київ*

Актуальність. Грудне вигодовування (ГВ) є не лише біологічною потребою новонародженого, а й одним із психоемоційних чинників, що формує взаємодію матері та дитини. У період ГВ закладаються основи емоційної безпеки, довіри та соціальної взаємодії, що мають подальший вплив на психічний розвиток особистості.

Емоційний зв'язок у період лактації. Перші 10–12 місяців життя дитини є важливими для формування первинної прив'язаності [2]. У цей період між матір'ю та немовлям встановлюється емоційний зв'язок, що реалізується через тілесний контакт, зорову фіксацію, голосову модуляцію та ритм годування. Дитина сприймає емоційний стан матері як орієнтир для власного емоційного реагування, що зумовлює формування базової довіри [4]. У той же час, у період ГВ можна констатувати такі психоемоційні стани матері, які стають викликами: хронічна втома через нічні годування (недосипання, фізичне виснаження); підвищений рівень тривожності (чи достатня кількість молока, чи правильно відбувається доглядають за дитиною); відчуття соціальної ізоляції (менша кількість соціальних контактів, «оцінка» соціального (родинного) оточення щодо правильності поведінки з немовлям); можлива відсутність психологічної підтримки та допомоги в побуті.

Мета дослідження. Психологічні особливості комунікації матері та дитини в період грудного вигодовування.

Результати дослідження. Значущим чинником, що впливає як на психоемоційний стан жінки (матері)-годувальниці, так і на процес лактації (тобто вироблення молока) є вплив надзвичайних ситуацій. Наукові розробки [3; 5],

практика акушерів-гінекологів та педіатрів [1] вказують, що лише у невеликої кількості матерів-годувальниць можливе тимчасове зниження інтенсивності виділення молока внаслідок психоемоційного напруження, стресу, а також спостерігаються зміни хімічного складу або якості грудного молока. Оскільки, оптимізація лактаційного процесу може забезпечуватись шляхом регулярного прикладання немовляти до грудей, що стимулює вироблення необхідної кількості грудного молока та сприяє стабілізації лактаційної функції [1; 3; 5].

Нейроендокринні механізми комунікації. Під час грудного вигодовування в організмі матері активізується секреція окситоцину та пролактину. Окситоцин, відомий як «гормон прихильності», сприяє формуванню емоційної близькості, зниженню тривожності та підвищенню рівня задоволення. Пролактин, у свою чергу, забезпечує стан спокою та умиротворення. Обидва гормони мають антагоністичний вплив на кортизол – основний гормон стресу. Таким чином, грудне вигодовування виконує функцію природного механізму стресорегуляції як для матері, так і для дитини [6].

Психоемоційний стан матері. Материнство, особливо в період лактації, супроводжується значним емоційним навантаженням. Відчуття відповідальності, фізичне виснаження та соціальні очікування можуть спричиняти підвищену тривожність, емоційну нестабільність або навіть післяпологову депресію. Грудне вигодовування, за умови емоційної підтримки з боку партнера та фахівців, може виступати стабілізуючим чинником, що сприяє психоемоційному благополуччю матері [7]. Психоемоційний стан жінки-матері в період грудного вигодовування є динамічним, оскільки поєднує фізіологічні, гормональні та соціально-психологічні чинники.

Сутність комунікації матері й дитини. Період грудного вигодовування є не лише фізіологічним процесом забезпечення немовляти харчуванням, але й унікальним етапом формування первинних комунікативних зв'язків між матір'ю

та дитиною. Саме в цей час відбувається закладання основ емоційної прив'язаності, довіри та безпечного типу взаємодії.

Комунікація у системі «мати – дитина» охоплює: вербальні сигнали (інтонація, м'яка мова, звуки, спів); невербальні прояви (погляд, міміка, дотик, поза, контакт «шкіра до шкіри»); емоційно-поведінкові реакції (посмішка, заспокоєння, обійми, ніжність).

Ці елементи утворюють первинний діалог між дорослим і немовлям, який сприяє регуляції емоцій дитини, розвитку її сенсорного досвіду та становленню базової довіри до світу. Основні стратегії комунікації матері та дитини у період грудного вигодовування:

1. Стратегія емоційної синхронізації. Мати налаштовується на емоційні сигнали дитини (плач, рухи, погляд) і відповідає відповідними діями – ласкавими словами, усмішкою, лагідними дотиками. Це створює відчуття безпеки й прийняття.

2. Стратегія тілесного контакту («контакт шкіра до шкіри»). Фізична близькість активує вироблення окситоцину у матері та дитини, що посилює емоційний зв'язок, сприяє заспокоєнню, кращому засвоєнню молока та стабілізації дихання й серцевого ритму дитини.

3. Стратегія невербального діалогу. Використання зорового контакту, інтонації, мімічних реакцій. Дитина з ранніх місяців навчається розпізнавати вираз обличчя матері, її голос, що формує основи комунікативної компетентності.

4. Стратегія вербальної підтримки. Розмови матері з дитиною під час годування, ніжні слова, спів або читання вголос створюють атмосферу спокою, сприяють розвитку мовлення і пізнавальної активності немовляти.

5. Стратегія ритуалізації догляду. Повторювані дії (спокійний голос, певна послідовність рухів під час годування) створюють передбачуване середовище, формуючи у дитини відчуття стабільності [1; 3; 5].

Таким чином, стратегії комунікації матері та дитини під час грудного вигодовування відіграють одну із головних ролей у становленні та формуванні подальшої психоемоційної взаємодії з соціальним середовищем, розвитку мовленнєвого ресурсу та особистісного потенціалу дитини. У той же час, комунікація матері та дитини сприяє формуванню таких психологічних конструктів, як: емоційна прив'язаність; почуття безпеки; базова довіра до світу (за Е. Еріксоном); психічний розвиток; зниження рівня тривожності.

Значення для розвитку дитини. Регулярна тілесна близькість під час годування сприяє розвитку сенсорної інтеграції, емоційної регуляції та соціального навчання. Немовля навчається самозаспокоєнню через ритм годування, що формує основу для подальшого розвитку здатності до саморегуляції. Крім того, грудне вигодовування сприяє формуванню позитивного образу «значущого іншого», що є фундаментальним для подальших міжособистісних стосунків.

Висновки. Грудне вигодовування є важливим психобіологічним процесом, що забезпечує не лише фізіологічні потреби дитини, а й формує основу для емоційного розвитку, соціальної адаптації та психічного здоров'я. Ефективна комунікація між матір'ю та дитиною в цей період сприяє формуванню емоційної стабільності та гармонійного розвитку особистості.

Список використаних джерел.

1. Бабич Лідія, Кривов'яз Тетяна, Дебела Вікторія, Краснікова Марина, Кудлай Маргарита. Актуальність грудного вигодовування, переваги, можливі перешкоди, шляхи сприяння поширеності. URL: <https://uabm.org.ua/statements.html>
2. Боулбі Дж. Прив'язаність і втрата. Т. 1. Прив'язаність. Нью-Йорк: Basic Books, 1969. 429 с.
3. Годування дітей до 2 років під час війни. Що робити в надзвичайній ситуації з дитиною на руках, як організувати годування й убезпечити малечу?

ЮНІСЕФ. URL: https://www.unicef.org/ukraine/stories/breastfeeding-2yo-war-circumstances?gad_source=1&gad_campaignid=23050094099&gbraid=0aaaaabxifh0zaytqyahqc16izgyl3d85a&gclid=cj0kcqjwgpzibhcoarisabzm7ve6k7ar1j9zc331oc7tzzmldlgqejgjo53xawjdzhxcii4lsdrk2uuaat26ealw_wcb

4. Еріксон Е. Дитинство і суспільство. Нью-Йорк: Norton, 1950. 384 с.

5. Козар О. Як грудне вигодовування підтримує психічне здоров'я матері та дитини? URL: <https://www.bsmu.edu.ua/blog/yak-grudne-vygodovuvannya-pidtrymuje-psyhichne-zdorovya-materi-ta-dytyny/>

6. Увнас-Моберг К. Фактор окситоцину: як активувати гормон спокою, любові та зцілення. Кембридж: Da Capo Press, 2003. 240 с.

Dennis C. L., McQueen K. The relationship between infant-feeding outcomes and postpartum depression: A qualitative systematic review // Pediatrics. 2009. Vol. 123, No. 4. P. e73

Особливості сенсомоторного розвитку дітей дошкільного віку

Гаврилюк Т.О.

*Здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти
Академія праці, соціальних відносин і туризму, м. Київ*

Актуальність. В даних тезах викладено результати аналізу наукових статей і публікацій, які розглядають тематику сенсомоторного (сенсорного і моторного) розвитку дітей дошкільного віку. У науковій літературі розглянуто особливості формування сенсорної інтеграції, типи порушень і як саме пов'язані з сенсомоторними труднощами і моторикою, мовленими і поведінковим розвитком, проводилися емпіричні дослідження та інтервенції, застосовувані в освітньо-реабілітаційному просторі. Розглянутий науковий матеріал став підставою для аналізу даної тематики та спонукає зробити практичні висновки і створювати певні рекомендації для педагогів, психологів, ерготерапевтів.

Мета дослідження. Дослідити сенсомоторний розвиток дітей дошкільного віку.

Важливим аспектом досліду була теоретична та практична аспекти різних науково-педагогічних підходів щодо розвитку та корекції сенсорної інтеграції в умовах дошкільної освіти. Прослідковується, що однаковим для всіх підходів є метод сенсорного та мультисенсорного стимулювання, різні прийоми та способи інтегрування сенсорної інформації до мозку дитини, що значно підвищує його пластичність. Практична цінність комплексної психолого-педагогічної допомоги дітям у розвитку та корекції сенсорної інтеграції, заснованої на особистісно-орієнтованому підході. На підставі аналізу психолого- педагогічної літератури спостерігаються подальші кроки в дослідженні та пошуках діагностичних критеріїв. оцінювання сенсорного розвитку і спонукає створювати умови його розвитку [1].

Результати дослідження. В науковій літературі проблеми сенсорного розвитку та досліджували Дж. Айрес, Р. Шааф, Люсі Дж. Міллер, М. Монтессорі, В. Сухомлинський та ін. Основним завданням сенсорного виховання дітей раннього віку на думку Т. Паніманської є : формування перцептивних (обслідницьких) дій; формування системи сенсорних еталонів; розвиток уміння самостійно використовувати сенсорні еталони у власній діяльності [2]. Н. Соколова розглядаючи сенсорний розвиток, визначила, що це оволодіння дитиною певних властивостей і якостей об'єктів, які були створені людством у ході соціального розвитку [3]. Основою теорії сенсомоторного розвитку є процес, під час якого нервова система отримує інформацію від рецепторів та сенсорних систем (зорової, слухової, тактильної, пропріоцептивної (глибока чутливість), вестибулярної, смакової, нюхової) та моторики, що одночасно поступає по декількох сенсорних каналах, і об'єднує цю інформацію в єдине ціле, організовує та інтерпретує так, щоб дитина змогла її використовувати в цілеспрямованій діяльності. Пізнаючи довкілля дитина розвиває тілесні відчуття, що створює безпеку, цілісність та контроль над власним тілом, яка формує базову емоційну стабільність.[7] Також зазначаються особливості сенсомоторного розвитку, які проявляються у вигляді надчутливості або недостатній чутливості до дотиків, недорозвиненій дрібній та грубій моториці, труднощі з балансом, підвищена рухова збудливість або навпаки гальмування моторне, проблеми з увагою і участю в групових іграх. Ці прояви можуть поєднуватися з мовленевими порушеннями або поведінковими складнощами [4].

Окремо можна виділити досвід науковців (аналіз публікацій), практичні знання фахівців (учителів-дефектологів, логопедів, практичного психолога), аналіз динаміки розвитку, де описується використання сенсорний підхід, ігрові сенсорні програми, вправи на розвиток вестибулярної та пропріоцептивної систем, відзначили позитивний впливу у дітей з РАС чи особливими освітніми проблемами [5]. Українські автори наголошують на необхідності комбінувати

стандартизовані методики, клінічне спостереження а природному середовищі та опитування батьків та вихователів. Окремо вказують на необхідність в уніфікованих локалізованих інструментів для українського контексту, що ускладнює ранню диференційну діагностику. Часто використовуються адаптовані інструменти із зарубіжної літератури без повної локалізації, що створює ризики для коректної інтерпретації результатів [6]. Подальшими дослідження даної тематики потребує спрямованості у проведення контрольованих інтервенційних досліджень сенсомоторних програм з тривалим спостереженням. Вивчення нейрофізіологічних механізмів впливу вестибулярної/пропріоцептивної стимуляції на когнітивні й емоційні процеси у дітей дошкільного віку.

Висновки. Сенсомоторний розвиток докільця є критичною складовою загального психомоторного та соціально-емоційного розвитку. Дослідження дозволило сформулювати, що рівень сенсорного розвитку дитини, а саме, як дитина бачить, чує, відчуває оточуючий світ залежить розумовий, фізичний та естетичний розвиток [7]. В Україні накопичено практичні напрацювання й методики для діагностики та корекції сенсомоторних особливостей, але для посилення доказовості потрібні більш якісні дослідження, стандартизація інструментарію та впровадження міждисциплінарних підходів у практику дошкільних закладів.

Список використаних джерел.

1. Нижник Т.О. Підходи щодо розвитку та корекції сенсорної інтеграції у дітей дошкільного віку. Інноваційна педагогіка. Випуск 56 Том 1 . Видавничий дім «Гельветика», 2023. С. 111.
2. Поніманська Т.І. Дошкільна педагогіка. URL: <http://surl.li/qizwjv>
3. Соколова Н. С. Сенсорний розвиток, як важлива складова формування особистості дитини. На урок: вебсайт. URL: <https://naurok.com.ua/sensorniy-rozvitok-yak-vazhliva-skladova-formuvannya-osobistosti-ditini-204818.html>

4. Данилюк І.В., Буркало Н.І. Сенсорна інтеграція та її значення для розвитку дитини. Psychological journal Volume 10 Issue 2 (82) 2024 DOI: <https://doi.org/10.31108/1.2024.10.2>
5. Юрченко Л.О., Олтаржевська Л.В., Малюченко Т.А. Діти з розладами аутистичного спектра : комплексний підхід . Тернопіль : Мандрівець. 2024.
6. Носко Ю.М., Куртова Г.Ю., Давидова Н.А. Удосконалення сенсорного виховання дітей дошкільного віку. DOI:10.5281/zenodo.7424643.2022
7. Мацюк З.С., Фенко М.Я. Сенсорна інтеграція в дітей: порушення та шляхи подолання розладів шкільних навичок. Inclusion and Diversity, випуск 5, 2025.

Копінг-стратегії приватних підприємців в умовах стресостійкості

Годунов В.Ю.

*Здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти
Академія праці, соціальних відносин і туризму, м. Київ*

Актуальність. Серед сучасних авторів питанню та вимогам щодо професійних якостей приватних підприємців приділяють увагу Р. Томсет, Р. Шварц, Д. Гудзенко та ін. Аналізом специфіки професійних якостей приватних підприємців у різний час займалися психологи і педагоги Ф. Брукс, Г. Вейнберг, Н. Вірт, Е. Дейкстра, С. Макконнелл, М.Л. Смульсон, Б. Шнейдерман та ін.. Аналіз літератури показує, проблема стресу та професійного стресу була предметом спеціальних досліджень багатьох зарубіжних науковців (Дж. Брайт, Дж. Грінберг, Р.Лазарус, Г. Сельє, В. та ін.). Протягом останніх років проблема професійного стресу та стресостійкості почала активно розроблятися і українськими дослідниками (Т. Зайчикова, Л. Карамушка, Г. Ложкін, К. Малишева, С. Максименко, О.Марковець, Н. Перегончук, В. Паньковець, Я. Плужник, О. Раковчена, О. Самара, О. Склень та ін.). Проблемі гумору як особливому типу копінг-поведінки присвячені роботи українських дослідників Е. Носенко, С. Скворцова, О. Зайви. С. Скворцовим, які здійснили роботу по адаптації методики «Стилі гумору (HSQ)» Р. Мартіна в Україні та проведено дослідження щодо особливостей використання почуття гумору, як ресурсу психологічного подолання. Означені підходи дозволяють трактувати стресостійкість як інтегральну характеристику психічного розвитку, що формується в процесі онтогенезу людини на основі генетично зумовлених індивідуальних характеристик в умовах конкретного соціального оточення. Як інтегративна властивість особистості вона передбачає взаємодію з усіма структурними характеристиками психіки як під час, так і після дії стресогенних факторів. До її функцій відносять: спрямованість на подолання перешкод;

актуалізацію діяльності в екстремальних умовах; стабілізацію внутрішніх механізмів емоційно-вольової саморегуляції [1-7].

Мета дослідження. Виявити особистісні чинник, що впливають на вибір вибір копінг-стратегії в умовах стресостійкості.

Результати дослідження. Емпіричне дослідження впливу стресостійкості на вибір копінг-стратегії приватних підприємців було проведено на вибірці, яка склала 56 приватних підприємців. Середній вік опитуваних – 28,6 років, середній стаж роботи приватним підприємцем – 5,5 років. Емпіричне дослідження проводилося у три етапи. На першому, підготовчому етапі, було підібрано пакет психодіагностичних методик. *Методи дослідження.* Укладений психодіагностичний інструментарій включав наступні методики: шкала організаційного стресу Д Макліна; методика «Копінг-стратегії в стресових ситуаціях» С. Нормана, Д. Ендлера, Д. Джеймса, М. Паркера; методика «Проактивні стратегії копінг-поведінки» Е.Грінгласа, Р.; методика «Стили гумору» Р. Мартіна.

На основі вивчення впливу стресостійкості на вибір копінг-стратегії сформовано наступні узагальнення. 1) Стресостійкість – це здатність свідомо протистояти тривалому стресу. В цілому стресостійкість розглядають як індивідуальну здатність організму зберігати нормальну працездатність; як здатність до соціальної адаптації, збереження значущих міжособових зв'язків, забезпечення успішної самореалізації, досягнення життєвих цілей, збереження працездатності і здоров'я. Серед функцій стресостійкості особистості виділяють: спрямованість на подолання перешкод; актуалізацію діяльності в екстремальних умовах; стабілізацію внутрішніх механізмів емоційно-вольової саморегуляції; забезпечення здатності до постійного відтворення високого рівня професійної мотивації.

Особливу категорію ресурсів, необхідних для розвитку стресостійкості працівників, становлять стратегії і моделі поведінки подолання («копінг-

стратегії»). Встановлено, що характер і способи переборювання стрес-ситуацій залежать від життєвої позиції, активності особистості, від її потреб у самореалізації своїх потенціалів і здібностей. Всі поведінкові стратегії поведінки, які також проявляються у ситуаціях подолання стресів, можна поділити на три групи: стратегії вирішення проблем, пошуку соціальної підтримки, уникнення. Кожна з названих стратегій може бути застосована залежно від стресової ситуації, та бути ефективною для її вирішення і подолання. В одному випадку людина може самотійно подолати виникаючі труднощі, в іншому – їй потрібна підтримка оточуючих, у третьому випадку – особа свідомо уникає загострення проблемної ситуації, заздалегідь визначивши її наслідки.

У результаті вивчення взаємозв'язку між рівнем стресостійкості та копінг-стратегіями у приватних підприємців було встановлено, що приватні підприємці з низькою стресостійкістю у меншій мірі застосовують проблемно-орієнтовану копінг-стратегію ($r_s = -0,417$, $p \leq 0,01$) та частіше обирають копінг-стратегію, орієнтовану на уникнення ($r_s = 0,278$, $p \leq 0,05$).

У результаті вивчення взаємозв'язку між рівнем стресостійкості та проактивними копінг-стратегіями було виявлено, що чим нижче рівень стресостійкості, тим рідше приватних підприємців звертаються до проактивних стратегій копінг-поведінки, таких як «проактивне подолання» ($r_s = -0,614$, $p \leq 0,01$), «рефлексивне подолання» ($r_s = -0,486$, $p \leq 0,01$), «стратегічне планування» ($r_s = -0,295$, $p \leq 0,05$), «превентивне подолання» ($r_s = -0,289$, $p \leq 0,05$), «пошук інструментальної підтримки» ($r_s = -0,306$, $p \leq 0,05$) та «пошук емоційної підтримки» ($r_s = -0,370$, $p \leq 0,01$). У результаті вивчення взаємозв'язку між рівнем стресостійкості та стилями гумору було встановлено, що низький рівень стресостійкості у приватних підприємців прямо корелює з агресивним ($r_s = 0,326$, $p \leq 0,01$) та самопринизливим ($r_s = 0,249$, $p \leq 0,05$) стилями гумору, які є непродуктивними стратегіями в подоланні стресових ситуацій.

Висновки. Серед індивідуальних методів розвитку стресостійкості приватних підприємців виокремлено: метод глибокого дихання та аутогенне тренування, методи саморегуляції (дихальні і релаксаційні техніки, візуалізація, самонавіювання та методи нейролінгвістичного програмування). Важливим для розвитку стресостійкості особистості, є оволодіння прийомом концентрації. Для боротьби зі шкідливими наслідками стресу доцільними також є інтегральні методи підвищення стресостійкості. Серед них значний інтерес становлять методи рефлексопрофілактики і рефлексотерапії. Рекомендації щодо розвитку стресостійкості особистості та формування у працівників приватних підприємців конструктивних копінг-стратегій поведінки у стресових ситуаціях базуються на наступних заходах: збереження психічного та морального здоров'я, гармонійного самоствавлення, підвищення самооцінки, впевненості в собі, подолання комплексів неповноцінності; формування оптимістичного ставлення до оточуючого середовища та його подій; контроль за харчуванням, вживання достатньої кількості вітамінів та мінералів; заняття фізичними вправами; дотримання засад здорового способу життя. Важливим також є вміння розподіляти навантаження, дотримуватися режиму праці та відпочинку. За умови дотримання вказаних рекомендацій та активного виконання вправ на саморегуляцію, розслаблення, релаксацію, аутогенне тренування, ауторегуляцію дихання можна значно підвищити рівень стресостійкості та сприяти формуванню адекватних стратегій поведінки у подоланні стресових ситуацій. Таким чином, працівникам приватних підприємств слід приділяти увагу не тільки підвищенню власної стресостійкості, а й збагачувати власний досвід успішного вирішення стресових проблем, вчитися правильно та адекватно поводитися у різних життєвих ситуаціях.

Список використаних джерел.

1. Аршава І. Ф. Емоційна стійкість людини та її діагностика: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. психол. наук: спец 19.00.02 «Психофізіологія»

І. Я. Аршава. – К.: Інститут психології ім. Г.С. Костюка АПН України, 2007. – 38 с.

2. Чала О. О. Вплив копінг-стратегій на деструктивну конфліктність представників юнацького віку / О. О. Чала // Педагогічна освіта: теорія та практика. Педагогіка. Психологія: зб. наук. пр. – 2010. – Вип. 2 (14). – С. 95–98.

3. Сікунка С. Теоретичний аналіз психологічних факторів формування стресостійкості як умова психологічного здоров'я [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://naub.oa.edu.ua/2014/teoretychnyj-analiz-psyholohichnyh-chynnykiv-formuvannya-stresostijkosti-yak-umova-psyholohichnoho>

4. Вдовиченко О. В. Особливості копінг-поведінки особистості в життєвих та професійних ситуаціях / О. В. Вдовиченко // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер. : Психологічні науки. – 2013. – Вип. 114. – С. 17–20.

5. Корнієнко І. О. Стратегії копінг-поведінки особистості студента у ситуації неспіху : Автореф. дис. канд. психол. наук : 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. – Інститут психології ім. Г. С. Костюка АПН України/І. О. Корнієнко. – К., 2010. – 20 с.

6. Циганчук Т. В. Динаміка переживання стресу студентів: індивідуально-психологічні характеристики / Т. В. Циганчук // Актуальні проблеми психології : зб. наук. пр. / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України; за ред. Максименка С. Д.. – 2010. – Вип. X(16). – С. 564–574.

7. Шепель К. Особливості прояву копінг-стратегій особистості у процесі соціальної взаємодії / К. Шепель // Психолінгвістика. Психологія Мовознавство. Соціальні комунікації : Збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. «Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди». – Переяслав-Хмельницький, 2010. – Вип. 5. – С. 80–84.

Рекомендації у роботі з молоддю щодо профілактики конфліктних ситуацій

*Грігоріані Д.
Здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти
Академія праці, соціальних відносин і туризму, м. Київ*

Актуальність. Фундаментальні дослідження проблеми присвячені праці таких вчених, як: Ананьєв Б.Г., Виготський Л.С., Гіппократ, Т.В. Говорун, О.М. Кікінеджі, Ковальов, Павлов І.П., Русалов В.М., Ш.Берн, Сеченов І.М., роботи в галузі конфліктології: Анцупов А.Я., Бабосов Є.М., Бородкін Ф. Різні автори по-різному визначають конфлікт і конфліктні ситуації. На думку К. Хорні, конфлікт виникає в системі взаємин індивіда з соціальним оточенням, а не як ефект конфронтації з цим оточенням. Е. Фром, полемізуючи з З. Фрейдом, стверджував, що в процесі свого розвитку людина приходить до відокремлення та індивідуалізації. Це здійснюється в постійному конфлікті особи з соціальним середовищем. Спираючись на затвердження Ч. Дарвіна про те, що інстинкт боротьби за виживання забезпечує існування і розвиток виду, В. Макдугалл неправомірно поширив його на суспільство. Створена ним теорія інстинктів соціальної поведінки визначили соціотропний напрям у психологічних дослідженнях конфліктів. Основою розуміння конфлікту в рамках необіхевіористичної орієнтації є теорія «фрустрації-агресії», сформульованої в 40-і роки Н. Міллером і Дж. Доллардом. Ключове місце у цій теорії займає припущення про те, що будь-яка умова, що перешкоджає досягненню мети може викликати фрустрацію і привести до появи агресії – прагненню зруйнувати або усунути перешкоду. Дослідженням психоаналітичної орієнтації властиве біопсихологічне трактування причин конфліктів. Відповідно до неї, конфлікти є наслідок невідповідності моральних суспільних умов і обставин, з одного боку, вимогам природних інстинктів – з іншого. Як вважав З. Фрейд, конфлікт виникає тоді, коли сила впливу суспільних умов істотно перевищує здатність людини до сублімації. Такі конфлікти можуть виражатися в неврозах,

злочинній поведінці і т. ін. Слідом за З. Фрейдом, австрійський психолог А. Адлер розглядав джерело конфліктів у незахищеності особистості перед навколишнім світом, усвідомленні своєї неповноцінності і недосконалості, у прагненні зміцнитися шляхом переваги над іншими [1-8].

Мета дослідження. Запропонувати рекомендації у роботі з молоддю «Запобігання конфліктних ситуаціях та особливості їх вирішення.

Результати дослідження. Дослідження проводилося зі здобувачами Академії праці, соціальних відносин та туризму. Всього прийняло участь 158 молодих осіб. Для участі у дослідженні усі опитуванні надалі інформаційну згоду на участь у дослідженні. Групу А склали 80 осіб чоловічого полу. Групу Б склали 78 жінок. Для реалізації дослідження обрано наступні методики: 1) Особистісний опитувальник Г.Айзенка; 2) Опитувальник А. Баса–А. Дарки; 3) Діагностики схильності особистості до конфліктної поведінки; 4) Методика психологічної діагностики копінг-поведінки Е. Хейма. Статистична обробка даних проводилася за допомогою розрахунку t – критерію Стьюдента. Аналіз отриманих даних дозволив виявити основні типи темпераменту досліджених студентів, їх агресивні і ворожі реакції, схильність до опозиційної поведінки, схильності особистості до конфліктної поведінки.

Знання про можливі варіанти та наслідки завершення конфліктів допомагають вибрати найкращі засоби впливу на конфліктуючі сторони. Наслідки конфліктів залежно від їхнього змісту: 1) повна ліквідація конфронтації через взаємне примирення; 2) зникнення конфронтації, коли один з учасників перемагає, а інший визнає себе переможеним або коли обидві сторони програють чи задовольняють свої домагання; 3) послаблення конфлікту взаємними поступками; 4) трансформація конфлікту, перехід його в змінений або принципово новий конфлікт; 5) поступове згасання конфлікту; 6) механічне знищення конфлікту (ліквідація підрозділу, організації, звільнення учасника). 7. Розв'язання конфлікту з урахуванням етики стосунків конфліктуючих сторін.

Будь-який конфлікт має розв'язуватися відповідно до етичних норм. Статусний бік конфлікту стосується умов та принципів відносин керівника й підлеглого, старшого та молодшого за віком, більш або менш компетентного та ін. Діловий конфлікт спирається на обмін думками і пов'язаний з низкою етичних умов. Це взаємне прагнення слухати, адекватно сприймати інформацію. Важливу роль тут відіграють рефлексія та емпатія. Етика доказів змушує спиратися не тільки на логіку думки, а й на поважне ставлення до опонента. Етика критики спрямовує її не на особистість опонента, а на аналіз справи. Етика згоди має на меті досягнення ефективного результату, підкріплення взаємних симпатій.

Запропоновано практичні рекомендації у роботі з молоддю «Запобігання конфліктних ситуаціях та особливості їх вирішення». Практичні рекомендації у складаються з трьох змістовних: загальні підходи роботи з молоддю з різними типами темпераменту; попередження конфліктів (профілактика); розв'язання та вирішення конфліктів. Загальні підходи роботи з молоддю з різними типами темпераменту включають: тактовно й опосередковано запобігати «зривам», враховувати мотиви поведінки, залучати до активної діяльності, пов'язаної з виявом ініціативи; уникнення різких емоційних реакцій, спрямованих безпосередньо на молодь; інколи впливати на опосередковано, через колектив.

Напрямами роботи з попередження конфліктів є: 1) створення об'єктивних умов, які перешкоджають виникненню та деструктивному розвитку перед конфліктних ситуацій; 2) оптимізація організаційно-управлінських умов створення та функціонування організацій; 3) усунення соціально-психологічних чинників виникнення конфліктів; 4) блокування особистісних чинників виникнення конфліктів. Здебільшого профілактику конфліктів треба здійснювати одночасно за всіма зазначеними напрямками.

Висновок. Розв'язання, вирішення – це заключна стадія розвитку конфлікту. Розв'язання та вирішення конфліктів складається з наступних тактик: 1. Розв'язання конфлікту на основі його сутності та змісту. 2. Розв'язання конфлікту

з урахуванням його цілей. 3. Розв'язання конфлікту з урахуванням його функцій. 4. Розв'язання конфлікту з урахуванням емоційно-пізнавального стану учасників. 5. Розв'язання конфлікту з урахуванням властивостей його учасників. 6. Розв'язання конфлікту з урахуванням його можливих наслідків. 7. Розв'язання конфлікту з урахуванням етики стосунків конфліктуючих сторін.

Список використаних джерел.

1. Горностай П.П. Особистість та роль: Рольовий підхід у соціальній психології особистості/П.П. Горностай – К.: Інтерпрес ЛТД, 2017. – 312 с.
2. Москаленко В. В., Романова В. Г. Особливості структури гендерних образів в уявленнях підлітків // Психологія. Зб. наукових праць НПУ ім. М. Драгоманова. Вип. 14. – К.: НПУ ім. Драгоманова, 2001. – С. 138–153.
3. Романова В. Г. Дослідження андрогінності в гендерній ідентифікації підлітків // Психологія. Зб. наукових праць НПУ ім. М. Драгоманова. Вип. 13. – К.: НПУ ім. Драгоманова, 2001. – С. 292–309.
4. American Hieritage Dictionary of English Language/параметри доступу до сайту: <http://americanheritage.yourdictionary.com/>
5. Lazarus, RS, Smith, C.A. (1990). Emotion and adaptation. In: L.A. Pervin (Ed.) Handbook of personality: Theory and research (pp. 609–637). New York: Guilford.
6. Naan, N. (1965). Coping and defense mechanisms related to personality inventories. Journal of Consulting Psychology, 29, 373–378.
7. Войцеховська О. Сучасні напрямки досліджень копінг-стратегій особистості / О. Войцеховська, Г. Закалик // Педагогіка та психологія професійної освіти. – 2022. – №2. – С. 95–104.
8. Compas B.E. Coping with stress під час дитинства і adolescence: проблеми, прогрес, і потенційний в теорії і розвідки / B.E.Compas, J.K.Connor-Smith, H.Saltsman, A.H.Thomsen, M.E.Wadsworth // Psychological Bulletin. – 2001. – Vol.127, №1. – P. 87–127.

Психологічні наслідки тривалого стресу: емоційне вигорання волонтерів

*Добровольська В.О.
Здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти
Академія праці, соціальних відносин і туризму, м. Київ*

Актуальність. Тривалий стрес є одним із найпоширеніших і водночас найнебезпечніших психологічних явищ, які можуть відчувати волонтери, особливо ті, що працюють у кризових, військових або гуманітарних умовах, що є сукупністю соціальних, культурних, освітніх, психологічних та моральних чинників, які створюють сприятливе середовище для всебічного розвитку людини, збереження її гідності, прав і свобод. Вони охоплюють такі аспекти, як доступ до освіти, охорони здоров'я, культури, інформації, духовного та морального виховання. Гуманітарні умови формують основу для гармонійного співіснування в суспільстві, забезпечують підтримку соціально вразливих груп, сприяють розвитку особистості й утвердженню гуманістичних цінностей.

Емоційне вигорання можна розглядати як психологічну реакцію на тривалий стрес професійної або соціальної взаємодії, який з'являється у відчутті спустошеності, байдужості, втраті сенсу діяльності та емоційній нечутливості. У контексті волонтерської роботи даний феномен набуває особливого значення, адже волонтери зазвичай не мають стабільного фінансового стимулу чи інституційної підтримки, натомість їхня мотивація ґрунтується на внутрішніх цінностях – бажанні допомогти, почутті обов'язку, емпатії. Саме тому, коли ці ресурси вичерпуються, наслідки можуть бути глибшими, ніж у звичайних професійних середовищах [2, с. 105].

Спочатку волонтер може відчувати підйом, ентузіазм, відчуття важливості своєї місії. Проте, зустрівшись із реаліями – постійним браком ресурсів, емоційним болем інших людей, нерозумінням або байдужістю з боку суспільства – людина поступово втрачає енергію. Виникає хронічна втома,

знижується мотивація, з'являється відчуття безсилля. Часто волонтери починають дистанціюватися від тих, кому допомагають, що є захисним механізмом психіки. Однак ця емоційна дистанція призводить до зниження якості взаємодії, втрати емпатії та співчуття – ключових якостей у волонтерській роботі.

Одним із найнебезпечніших аспектів вигорання є втрата сенсу діяльності волонтера. Волонтер може почати сумніватися у важливості своєї роботи, відчувати, що його зусилля марні. Таке відчуття породжує апатію, депресивні стани, а іноді й психосоматичні розлади – безсоння, головний біль, розлади травлення, ослаблення імунітету. На думку С. Білозерської [1, с. 28], це є наслідком порушення балансу між віддачею та відновленням енергії. Людина постійно віддає, але не отримує достатньої підтримки, емоційного зворотного зв'язку чи визнання [1, с. 28].

Крім того, важливо враховувати соціальний контекст волонтерства. Багато волонтерів працюють у команді, де можуть виникати конфлікти, розбіжності в поглядах, перевантаження через нерівномірний розподіл обов'язків. Це підсилює стресові фактори та сприяє розвитку взаємного емоційного виснаження. Також відсутність чіткої організаційної структури чи керівництва у деяких волонтерських об'єднаннях створює відчуття хаосу, що поглиблює психологічну нестабільність.

Особливо гостро проявляється посттравматичний компонент стресу у волонтерів, які працюють у зонах бойових дій, з пораненими, внутрішньо переміщеними особами або сім'ями загиблих. Контакт із людським горем, травмою, смертю створює сильний емоційний тиск, що може призвести до симптомів вторинної травматизації – коли волонтер починає переживати чужі травми як власні. У таких випадках навіть короткий період відпочинку не допомагає, адже психіка продовжує «прокручувати» побачене та почуте [3, с. 98].

Мета дослідження. Виявити психологічні наслідки тривалого стресу: емоційне вигорання волонтерів.

Результати дослідження. Нижче наведено узагальнену табл. 1, яка відображає основні психологічні наслідки тривалого стресу серед волонтерів та можливі прояви емоційного вигорання.

Таблиця 1

Основні психологічні наслідки тривалого стресу серед волонтерів

Сфера прояву	Опис наслідків	Приклади проявів тривалого стресу серед волонтерів
Емоційна сфера	Зниження здатності до співпереживання, апатія, емоційна спустошеність	Втрата інтересу до допомоги людям, дратівливість, байдужість до проблем оточення
Когнітивна сфера	Порушення концентрації, песимізм, зниження критичного мислення	Помилки в організації допомоги, труднощі з прийняттям рішень, негативне сприйняття майбутнього
Фізична сфера	Хронічна втома, безсоння, соматичні розлади	Погіршення здоров'я, часті застуди, головні болі, виснаження
Мотиваційна сфера	Втрата інтересу до діяльності, відчуття безглуздості роботи	Відмова від участі у волонтерських проєктах, зниження залученості
Соціальна сфера	Конфліктність, ізоляція, зниження довіри до колег і суспільства	Уникання спілкування, напруження в команді, дистанціювання від групи
Екзистенційна сфера	Криза сенсу, депресивні думки, внутрішня порожнеча	Відчуття безнадії, втрати мети життя, емоційна «черствість»

Таблицю складено автором на основі опрацьованої літератури [4; 5]

Висновки. Отже, емоційне вигорання волонтерів – це багатогранне явище, яке не обмежується лише емоційним виснаженням. Емоційне вигорання включає когнітивні, фізичні та соціальні аспекти, що взаємопов'язані та взаємно підсилюють одне одного. Для протидії наслідкам емоційного вигорання

волонтерів необхідно створювати системи психологічної підтримки, забезпечувати навчання з управління стресом, формувати здорове робоче середовище й заохочувати практики самодопомоги та рефлексії волонтерів. Адже лише емоційно стабільний та психологічно підтриманий волонтер здатний забезпечувати ефективне виконання допоміжної діяльності, одночасно зберігаючи власну психічну рівновагу та функціональну працездатність.

Список використаних джерел.

1. Білозерська С. Особливості емоційного вигорання волонтерів в умовах війни. Психологія особистості фахівця в умовах воєнного часу та поствоєнної реабілітації: матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції (з міжнародною участю) Львів (27 жовтня 2023 року), Львів 2023. С. 28–31.
2. Льошенко О., Кондратьєва В. Діагностика, профілактика, корекція синдрому «емоційного вигорання». Вісник Львівського університету. Серія «Психологічні науки». 2021. Вип. 10. С. 105–112.
3. Мельник І. Соціально-психологічні чинники емоційного вигорання у волонтерів в умовах війни. Розвивальний потенціал сучасної соціальної роботи: методологія та технології: матеріали IX Всеукраїнської з міжнародною участю науково-практичної конференції з соціальної роботи 15- 16 березня 2024 року, м. Київ С. 98–100
4. Рудницький О. Психоемоційне вигорання особистості : теоретичні аспекти проблеми. Психологічні перспективи. 2024. № 43. С. 161–180.
5. Шкраб'юк В. С. Емоційне вигорання особистості: психологічний аналіз проблеми. Молодий вчений. 2020. № 10 (2). С. 293–296.

Minimizing the impact of challenges faced by internally displaced persons in ukraine

*Harkavets S.O.
Doctor of Psychological Sciences, Professor,
Professor at the Department of Psychology and Sociology
Volodymyr Dahl East-Ukrainian National University, Kyiv*

The social group of citizens known as internally displaced persons (IDPs) in Ukraine emerged in the spring and summer of 2014 when the Russian federation engaged in covert aggression and began overtly annexing Ukrainian territories. Hundreds of thousands of Ukrainian citizens were forced to relocate and seek refuge in areas under Ukrainian control, searching for new homes as staying in temporarily occupied territories was deemed unacceptable. To address this, the Parliament of Ukraine enacted the relevant law «On Ensuring the Rights and Freedoms of Internally Displaced Persons» [1], outlining the fundamental regulations governing the rights and freedoms of such Ukrainian citizens.

Moreover, currently, the social-psychological (in a narrow sense, victimological) risks of IDPs in the new conditions of their livelihood remain unexplored, characterized by uncertainty, complexity, and significant social diversity.

Indeed, those who can actively adapt to such living conditions demonstrate the ability to navigate the complexity and uncertainty in the coordinates of their own existence. On the other hand, archaic individuals tend to adapt solely to maintaining balance and avoiding uncertainty, clinging to a life in a stable and simple world divided into black and white, self and others. However, this is a matter of personal attitudes and their changes due to socio-psychological influences [4].

From the standpoint of the classical victimological approach, such differentiation implies the existence of two social groups – those with low victimogenic vulnerability and those with increased vulnerability. It should be noted that victimogenic vulnerability of an individual refers to a low threshold of their mental, physical, socio-psychological

characteristics that contribute to the transformation or increase their susceptibility to becoming a victim of a certain crime, or more broadly, a victim of a natural disaster, technological catastrophe, or various social misfortunes [3].

Those who are capable of perceiving complexity, uncertainty, and diversity demonstrate low victimogenic vulnerability, while those inclined to simplify always increase their own victimogenic vulnerability. Therefore, analyzing the social activity of IDPs, it becomes clear that individuals capable of constructively perceiving modern challenges exhibit greater psychological and victimological competence than those who procrastinate in this regard [2].

The existing socio-psychological hazards accompanying the life of Ukrainian citizens who belong to the social group of internally displaced persons (IDPs) include:

1. Enhancing the legal status of IDPs so that citizens do not feel like «social marginal». This challenge was highly mentally taxing, as IDPs had to decide where to move – to the central or western regions of Ukraine or abroad. The farther from their homes, the greater the mental strain, uncertainty, and perceived risk on a subjective level. However, those who dared to go abroad showed less victimization tendency than those who stayed. Being abroad was more advantageous in terms of both security and economy. However, not every IDP had this opportunity, considering existing legal restrictions.

2. Solving the problem of employment at a new place of residence, providing the opportunity to have a decent job and financial security. There were several options, including staying with relatives, in humanitarian centers, in various religious missions, in dormitories, in rented apartments and houses, in acquired homes, etc. However, being in new living conditions significantly increased psychological tension, as each person needs a certain amount of time to adapt and settle in a new place, establish constructive communication with others, understand the complexity of the social situation, etc.

3. Focusing on the problems of the present, without distracting the attention of the IDPs regarding the soon return to the de-occupied territories. Nothing is worse than

giving hope and then betraying it with subjective or objective incapacity. Individual victimization significantly increases when expectations do not align with reality. Therefore, communication between state institutions and IDPs should build trust, avoiding disappointment, resentment, feelings of betrayal, and humiliation. The bitter experience of 2014-2022, when most IDPs were left without proper resolution of housing issues, compensation for lost property, etc., serves as a vivid example.

4. *Personal capacity.* Those who expected nothing from the government independently built their futures, promptly sensing real threats and reducing victimogenic risks (e.g., leaving conflict zones immediately, finding safe temporary conditions, etc.). Those who still believed in «state conscience» succumbed to secondary victimization, fostering learned helplessness and losing faith in the future. Uncontrollable situations lead people to give up, become helpless, and drift with the current. It is worth noting that individuals with an internal locus of control are significantly less vulnerable to this syndrome than those with an external locus of control. The stronger an individual's internal locus of control, the less likely they are to be victimized. In real life, some individuals prove capable of personal self-realization, while others become irrationally helpless.

5. *Psychological and victimological education.* Conducting individual and group sessions (training) aimed at overcoming the knowledge deficit regarding understanding dangerous challenges and an individual's psychological propensity to transform into a victim of circumstances and their own helplessness. Psychological and victimological education sessions should explain and convey necessary information to IDPs about the internal psychological potentials of personality, the development of individual psychological and stress resilience, resilience, flexibility, understanding victimogenic challenges, recognizing dangers or victim risks, etc. Through such sessions, one can ensure the acquisition of emotional regulation skills, self-help methods, and the analysis of one's own activity, resulting in a low threshold of victimogenic vulnerability.

Based on the analysis of the victimization challenges currently faced by internally displaced persons (IDPs) in Ukraine, it is imperative to consider proactive measures to prevent their victimization. We believe that the initial step should involve enhancing the legal status of IDPs to ensure they do not feel marginalized within society. Legislation should explicitly outline the special protections afforded to IDPs regarding the inviolability of their personhood, rights, and freedoms, automatically recognizing them as victims of Russian aggression.

The second step entails facilitating employment opportunities in their new places of residence, enabling them to secure meaningful work and financial stability. This step is crucial as employment fosters essential social interactions for individuals, thereby elevating their resilience against victimization. It is important to note that compared to Ukrainian citizens who have emigrated abroad, IDPs within Ukraine face less secure circumstances.

The third step is to address present challenges without diverting the focus of IDPs from the urgent need to return to de-occupied territories. Betraying hope due to subjective or objective constraints only exacerbates an individual's vulnerability to victimization. Therefore, communication from state institutions with IDPs should aim to build trust rather than engendering disappointment, resentment, or feelings of betrayal and humiliation. The stark experiences of 2014-2022, during which many IDPs were left unaided (with unresolved housing issues and inadequate compensation for lost property), serve as poignant examples.

The fourth step involves fostering personal agency. Individuals who did not rely on state support and took initiative in building their futures were better equipped to recognize and mitigate real threats, thereby reducing their susceptibility to victimization. Conversely, those who maintained faith in the state's support often experienced secondary victimization, exhibiting learned helplessness and losing hope for the future. Uncontrollable circumstances can compel individuals to resign themselves to helplessness, but it's essential to recognize that learned helplessness manifests both

cognitively («I can't change anything», «I don't know how to cope») and emotionally («nothing brings me joy anymore», «I'm tired of everything»). Empowering individuals to address their immediate challenges enhances their resilience and decreases their vulnerability to victimization in social contexts. Moreover, individuals with an internal locus of control are typically less vulnerable to learned helplessness compared to those with an external locus of control.

The fifth step entails providing psychological and victimological education. Through individual and group sessions, IDPs can acquire the knowledge and skills necessary to understand victimization challenges and resist becoming passive victims of circumstances. These sessions should focus on enhancing emotional regulation, self-help strategies, and critical analysis of personal agency, thus bolstering resilience against victimization.

References.

1. On ensuring the rights and freedoms of internally displaced persons [Electronic resource]: Law of Ukraine dated October 20, 2014 No. 1706-VII in the current version dated 03.08.2023 / Verkhovna Rada of Ukraine. Legislation of Ukraine – Resource access mode: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1706-18#Text>. (access date 08.25.2025).

2. Volchenko L. P., Garkavets S. O. Peculiarities of the formation of socio-normative ideas of high school students in conditions of social crisis: monograph. Severodonetsk: Publishing House of the SNU named after V. Dal, 2016 200 p.

3. Garkavets S. O. Victimology: a textbook. Luhansk: Publishing House of the SNU named after V. Dal, 2006. 116 p.

4. Garkavets S. O., Volchenko L. P. The problem of attitudes and their changes due to socio-psychological influences // *Habitus. Scientific journal*. Issue 30. Helvetica Publishing House, 2021. P. 227-230. <https://doi.org/10.32843/2663-5208.2021.30.39>

Психологічні механізми подолання стресу

Житинська М.О.

*Кандидат педагогічних наук, доцент
Академія праці, соціальних відносин і туризму, м. Київ*

Кириленко Р.В.

*Здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти
Академія праці, соціальних відносин і туризму, м. Київ*

Актуальність. Проблематика стресу та психоемоційного стану населення України сьогодні є надзвичайно актуальною через тривалий вплив пандемії COVID-19 та наслідки повномасштабного військового вторгнення. Масштабні дослідження показують значне підвищення рівнів стресу, тривожності та симптомів ПТСР серед різних категорій громадян, включно з внутрішньо переміщеними, біженцями, а також членами родин військовослужбовців. Особливо вразливою категорією є матері загиблих та безвісти зниклих захисників, які переживають не лише біль втрати, а й тривалу невизначеність, почуття безсилля, соціальну ізоляцію та внутрішній протест проти реальності, що склалася. У цьому контексті актуальним є аналіз можливостей використання арт-терапії та метафоричних асоціативних карт (МАК) як ефективних психотерапевтичних інструментів, що забезпечують безпечний простір для проживання горя, прийняття втрати та поступового відновлення внутрішньої опори особистості. Міжнародний досвід та сучасні емпіричні дані підтверджують, що застосування таких методів сприяє зниженню рівня тривоги та депресивних проявів, формуванню відчуття контролю над власним життям і відновленню психологічної стабільності.

Дослідження українських науковців, зокрема Л. Сак та Н. Малюк [1], підкреслюють важливість психологічних ресурсів у подоланні дистресу, спричиненого війною і аналізують ефективні стратегії самодопомоги цивільного населення в умовах тривалого стресового навантаження.

Мета дослідження. Теоретично обґрунтувати у науковому аналізі ефективність використання арт-терапевтичних методів і МАК як засобів психоемоційної стабілізації та відновлення внутрішніх ресурсів особистості в умовах воєнного стресу.

Сучасні підходи до розуміння психологічних механізмів подолання стресу базуються на концепції адаптивних і дезадаптивних копінг-стратегій, запропонованих Р. Лазарусом та С. Фолкманом [2]. Копінг розглядається як динамічний процес, у межах якого особистість мобілізує внутрішні ресурси для збереження психічної рівноваги в ситуаціях напруження, невизначеності або травми. З позицій когнітивно-біхевіорального підходу основними механізмами ефективного подолання стресу є: усвідомлення власних емоційних реакцій і їх прийняття; переосмислення травматичного досвіду за допомогою когнітивної реструктуризації; активне відновлення контролю над подіями життя та використання соціальної підтримки як ресурсу стабілізації. У випадку травматичних подій, пов'язаних із війною, механізми подолання набувають особливої глибини, оскільки людина стикається не лише з потужним емоційним навантаженням, а й із втратою базових відчуттів безпеки та прогнозованості майбутнього. Психологічна допомога в таких умовах має бути спрямована на поступове відновлення зв'язку з власними почуттями, тілесними відчуттями та смислами життя.

Результати досліджень. Важливий внесок у дослідження психологічних механізмів подолання стресу в умовах війни здійснила О. Вознесенська [3, 5], яка має понад двадцятирічний досвід арт-терапевтичної практики з різними групами населення, включно з дорослими, дітьми, ветеранами та членами їхніх сімей. У своїх працях дослідниця підкреслює, що арт-терапія виступає універсальним інструментом роботи з психологічною травмою, який сприяє м'якому проживанню болісних емоцій, відновленню відчуття цілісності та формуванню нових життєвих орієнтирів. Емпіричні спостереження О. Вознесенської

підтверджують ефективність творчого процесу як ресурсного методу зміцнення особистості, що забезпечує можливість працювати з образом «Я», розвивати діапазон комунікативних моделей поведінки, формувати нові стратегії адаптації та будувати життєві смисли через створення власних творчих продуктів. Поєднання арт-терапії з іншими емпірично обґрунтованими стратегіями, такими як соціальна підтримка, розвиток саморегуляції та підвищення психологічної обізнаності населення, формує цілісну модель психоемоційної реабілітації особистості в умовах воєнних викликів і сприяє інтеграції травматичного досвіду та поверненню людини до активного, наповненого життя.

На основі узагальнення сучасних емпіричних досліджень (Bondarchuk, Balakhtar, Pinchuk, Pustovalov, Pavlenok, 2023 [4]; Вознесенська, 2023 [6]) сформульовано низку практичних рекомендацій щодо подолання дистресу в умовах війни. Передусім важливим чинником психоемоційної стабілізації є підсилення соціальної підтримки, що передбачає створення офлайн-груп взаємодопомоги, навчання волонтерів навичкам емпатійного слухання та налагодження мереж емоційної підтримки для різних груп населення, зокрема для осіб, які пережили втрати. Не менш значущим напрямом є розвиток навичок саморегуляції, що включає навчання дихальним технікам, прогресивній м'язовій релаксації, медитаціям, заземленню та іншим прийомам самодопомоги, інтегрованим у навчальні заклади, соціальні та медіаплатформи. Стимулювання фізичної активності також виступає дієвим механізмом зниження рівня напруги та тривоги, адже навіть короткі прогулянки чи вправи сприяють покращенню загального психологічного стану. Особливу ефективність демонструють короткі техніки самодопомоги, які можна комбінувати, наприклад дихання + рух або заземлення + медитація.

Підвищення обізнаності та мотивації населення через науково обґрунтовані підходи допомагає знизити скепсис щодо ефективності психоемоційних практик. За результатами досліджень Bondarchuk та співавт. (2023)[4], стратегії соціальної

підтримки й адаптації виявилися найефективнішими для зменшення впливу стресу та самотності на психологічне благополуччя дорослих. Ці висновки мають безпосереднє значення для розробки програм підтримки жінок і матерів, які зазнали втрат під час війни.

Психологічна допомога матерям і жінкам загиблих та безвісті зниклих воїнів має ґрунтуватися на поєднанні емпатійного супроводу й терапевтичних методів, що не травматизують. Використання МАК і арт-терапії дає змогу віднайти внутрішні ресурси, вивільнити пригнічені емоції та повернути сенс життя. З огляду, на вищесказане, можемо зробити власне висновок, що методологія роботи з травмою в арт-терапії заснована на понятті посттравматичного зростання як переживання позитивних змін в результаті психотравмівної події та саморегуляції як природна здатність людини до самозцілення, що заснована на внутрішніх ресурсах її тіла, пробудження та усвідомлення яких сприяє подоланню наслідків травми, містить екзистенційну складову роботи з травмою: травма надає людині шанс для зміни себе та свого життя. Важливою складовою ефективності таких інтервенцій є безпечний терапевтичний простір, де жінка може говорити символами, кольором, образом, а не лише словами. Подальші дослідження повинні спрямовуватись на створення адаптованих протоколів роботи з цією цільовою групою, що поєднують гуманістичний підхід, творчі техніки та системну підтримку спільнот.

Висновки. Методологія арт-терапії у роботі з травмою ґрунтується на принципах посттравматичного зростання та саморегуляції, що дозволяє активізувати внутрішні ресурси людини, сприяє подоланню наслідків психотравмівної події та містить екзистенційну складову: травма дає шанс для зміни себе та свого життя. Психологічна допомога матерям і жінкам загиблих та безвісті зниклих воїнів повинна поєднувати емпатійний супровід та терапевтичні методи, які не травматизують, зокрема арт-терапію та МАК, що дозволяють віднайти внутрішні ресурси, вивільнити пригнічені емоції та відновити сенс

життя. Арт-терапія є ресурсним методом, оскільки активізує творчий потенціал психіки, стимулює самозцілення та залучення внутрішніх ресурсів людини. Використання творчості дозволяє досліджувати несвідомі процеси, приховані ідеї та бажані соціальні ролі, а символічна мова мистецтва дає можливість відтворювати почуття та внутрішні моделі поведінки через створені образи. Арт-терапія як засіб невербального спілкування особливо цінна для тих, хто не може вербалізувати травматичний досвід, створює умови для співпереживання, зближення та безумовного прийняття клієнта. Художні образи, рух, музика та інші творчі форми у процесі арт-терапії виступають матеріальним полем для метафоричної взаємодії, допомагають по-новому поглянути на ситуацію та знайти шляхи її вирішення, мобілізуючи внутрішні механізми саморегуляції та зцілення. Ефективність арт-терапевтичних інтервенцій значною мірою залежить від створення безпечного терапевтичного простору, де клієнт може висловлювати себе символами, кольором та образом, а не лише словами. Подальші дослідження повинні бути спрямовані на розробку адаптованих протоколів роботи з цією цільовою групою, які інтегрують гуманістичний підхід, творчі техніки та системну підтримку спільнот.

Список використаних джерел.

1. Сак Л., Малюк Н. Дослідження психологічних ресурсів українців у подоланні дистресу, спричиненого війною, аналіз досвіду цивільного населення у самодопомогі. // Psychosomatic Medicine and General Practice. – 2025. – Т. 10, № 2. Доступно за посиланням: <https://e-medjournal.com/index.php/psp/article/view/617/>
2. Лазар, Р. С., і Фолкман, С. (1984). Подолання труднощів та адаптація. У В. Д. Джентрі (Ред.), Довідник з поведінкової медицини (стор. 282–325). Нью-Йорк: Гілфорд.
3. Вознесенська О. Л., Сидоркіна М. Ю. Арт-терапія у подоланні психічної травми: практичний посібник. 2-ге вид., випр. та доповн. Київ: Золоті ворота, 2016. 202 с.

4. Бондарчук О. В., Балахтар О. В., Пінчук О. В., Пустовалов О. В., Павленок О. В. Адаптація копінг-стратегій для зменшення впливу стресу та самотності на психологічне благополуччя дорослих // Електронна бібліотека НАПН України. – 2022. – URL: <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/738204/>
5. Енциклопедичний словник з арт-терапії / за заг. наук. ред. О. Л. Вознесенської, О. М. Скар. Київ: Золоті ворота, 2017. 312 с.
6. Вознесенська О. Л. Арт-терапія в часи війни: можливості опанування наслідків психотравм // Стратегічні орієнтири освіти та реабілітації в умовах воєнного стану та повоєнного часу: проблеми, рішення, перспективи : збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 26–27 жовтня 2023 р.). – Запоріжжя: Вид-во Хортицької національної академії, 2023. – С. 379–381. – Електронний ресурс: <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/757432/>
7. Appleton V. Avenues of hope: Art therapy and the resolution of trauma // Journal of the American Art Therapy Association. 2001. Vol. 18, Issue 1. P. 6–13.
8. Орос М. М., Галь А. В. Стрес, дистрес, його види та корекція // Ліки України. 2021. №7(253). С. 32–35.
9. Дубчак Г. М. Аналіз стратегії копінг-поведінки студентів // Aktualni Problemy Psykholohii. 2018. V(18). С. 55–63.
10. Логинов Ю. А. Психологічні особливості самодопомоги осіб в кризових ситуаціях. Луцьк: Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2024.
11. Боско В. І. Профілактика емоційного вигорання в екстремальних психологічних методах самопізнання і самодопомоги Н. Пезешкіана. 2023.

Життєстійкість особистості в умовах війни: соціально-психологічні чинники та можливості розвитку

*Житинська М.О.
Кандидат педагогічних наук, доцент*

*Янович Р.Є.
Здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти
Академія праці, соціальних відносин і туризму, м. Київ*

Актуальність. Сучасний світ характеризується високим рівнем соціальних і психологічних викликів: війни, глобальні пандемії, економічна нестабільність, зростання нерівності та вимушена міграція стали невід’ємною частиною життя мільйонів людей. В Україні повномасштабна війна зумовила виникнення глибокої та тривалої суспільної кризи, що суттєво вплинула на психоемоційний стан населення. Постійні стресові фактори – небезпека для життя, втрата близьких, руйнування житла, зміна соціального оточення – актуалізували потребу у внутрішніх ресурсах, які дозволяють людині зберігати стабільність та ефективність у критичних умовах. Одним із ключових психологічних феноменів, що забезпечує таку здатність, є життєстійкість особистості. Вона розглядається як інтегральна характеристика, що поєднує здатність витримувати стресові впливи, переосмислювати їх та трансформувати у передумови для особистісного зростання. У контексті війни життєстійкість стає визначальним чинником психологічного благополуччя, підтримання соціальних зв’язків, збереження суб’єктивного відчуття контролю над життям і реалізації конструктивних стратегій адаптації. Дослідження, проведені в Україні, підтверджують, що люди з вищим рівнем життєстійкості здатні ефективніше протистояти тривалому стресу, демонструють меншу вразливість до емоційних розладів і вищий рівень соціальної інтегрованості. Водночас феномен життєстійкості потребує глибшого вивчення у зв’язку з унікальним контекстом війни, коли адаптаційні ресурси піддаються тривалій перевірці.

Мета дослідження. Застосовано комплекс методів: теоретичні – аналіз вітчизняної та зарубіжної літератури з проблематики життєстійкості, систематизація та узагальнення наукових підходів; емпіричні – психодіагностичне тестування («Тест життєстійкості» С. Мадді у адаптації Д. Леонтьєва), глибинні інтерв'ю для виявлення суб'єктивних проявів життєстійкості та усвідомлення особистісних ресурсів; математичні та статистичні – описова статистика, порівняльний аналіз. Вибірку становили співробітники гуманітарної організації, які в умовах війни зазнають високого професійного навантаження та психологічного тиску, пов'язаного з особистими втратами.

Результати дослідження: Отримані дані свідчать, що життєстійкість є багатовимірним феноменом, що інтегрує низку особистісних і соціально-психологічних чинників: усвідомлення власних ресурсів виявилось ключовим предиктором життєстійкості. Ті, хто чітко ідентифікував внутрішні та зовнішні ресурси (соціальні зв'язки, професійні компетентності, навички саморегуляції), демонстрували вищу здатність долати стрес та відновлюватися після кризових подій; активна суб'єктна позиція у життєдіяльності забезпечувала відчуття контролю й відповідальності, сприяючи конструктивному подоланню труднощів; соціальна підтримка (з боку колег, родини, спільноти) значно підсилювала витривалість. В умовах війни колективні форми солідарності виконували не лише роль зовнішньої допомоги, а й внутрішнього ресурсу, що формує відчуття належності та безпеки; особливості організації життєвого простору (структурування часу, підтримання професійної діяльності, пошук сенсів у повсякденності) безпосередньо впливали на рівень життєстійкості.

На основі отриманих результатів була розроблена та апробована програма підвищення життєстійкості, що включала такі навчально-розвивальні модулі: усвідомлення та актуалізація особистісних ресурсів; розвиток навичок саморегуляції та стрес-менеджменту; групові заняття для посилення соціальної підтримки; інтеграцію стратегій організації життєвого простору (планування,

постановка цілей, пошук нових сенсів). Аналіз ефективності програми показав, що її учасники продемонстрували зростання показників життєстійкості, більш адекватне ставлення до стресових ситуацій та готовність застосовувати конструктивні стратегії подолання.

Висновки: Життєстійкість виступає провідним ресурсом особистості в умовах тривалих соціально-психологічних криз, зокрема під час війни. Її формування та розвиток безпосередньо залежать від усвідомлення власних ресурсів, активної життєвої позиції, наявності соціальної підтримки та здатності до конструктивної організації життєвого простору. Практичне значення дослідження полягає у можливості застосування розробленої програми психологами гуманітарних організацій, освітніх та корпоративних установ. Отримані результати можуть слугувати підґрунтям для подальшої розробки тренінгових і психопрофілактичних програм, спрямованих на зміцнення психологічного здоров'я та формування життєстійкості населення України в умовах війни.

Список використаних джерел.

2. Александрова Л. А. Життєстійкість особистості: теоретичні та прикладні аспекти // Психологічний журнал. – 2019. – № 5. – С. 15–27.
3. Гуменюк Т. Д. Психологічні чинники розвитку життєстійкості в умовах соціальних криз // Вісник Київського національного університету імені Т. Шевченка. Серія «Психологія». – 2022. – № 1 (14). – С. 35–42.
4. Kobasa S. C., Maddi S. R., Puccetti M. Personality and health: A prospective study // Journal of Personality and Social Psychology. – 1982. – Vol. 42 (1). – P. 168–177.
5. Maddi S. R. Hardiness: The courage to grow from stresses // Journal of Positive Psychology. – 2006. – Vol. 1 (3). – P. 160–168.
6. Frankl V. E. Man's Search for Meaning. – Boston : Beacon Press, 2006. – 184 p.

7. Kobasa S. C. Stressful life events, personality, and health: An inquiry into hardiness // Journal of Personality and Social Psychology. – 1979. – Vol. 37 (1). – P. 1–11.
 8. Сергієнко Н. П. Життєстійкість як ресурс подолання стресу в умовах війни // Психологія і суспільство. – 2023. – № 2. – С. 57–66.
 9. Hobfoll S. E. Conservation of resources: A new attempt at conceptualizing stress // American Psychologist. – 1989. – Vol. 44 (3). – P. 513–524.
 10. Швалб Ю. М. Психологія життєвого світу особистості. – Київ : Інфосфера, 2012. – 216 с.
- Tillich P. The Courage to Be. – New Haven : Yale University Press, 2000. – 191 p.

Розлади харчової поведінки у жінок середнього віку: комплексний підхід до аналізу

Зінченко І.А.

*Здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти
Академія праці, соціальних відносин і туризму, м. Київ*

Актуальність. Проблема розладів харчової поведінки (РХП) є однією з ключових у сучасній клінічній та віковій психології. Упродовж останніх десятиліть спостерігається зростання кількості випадків анорексії, булімії, компульсивного переїдання серед жінок вікової категорії 35–50 років. Саме середній вік є періодом суттєвих біопсихосоціальних змін – гормональних, емоційних, соціальних – які можуть впливати на ставлення до власного тіла, самооцінку та харчову поведінку. Актуальність дослідження зумовлена не лише поширеністю розладів, а й необхідністю глибшого розуміння їх психологічних механізмів для ефективної профілактики та психотерапії.

Мета дослідження. Аналіз чинників формування розладів харчової поведінки у жінок середнього віку та систематизація підходів до їх психокорекції у межах сучасних напрямів психологічної науки.

Результати дослідження. Аналіз наукових джерел показав, що розлади харчової поведінки становлять групу психогенних поведінкових синдромів, які виявляються порушеннями у споживанні їжі – від надмірного обмеження до компульсивного переїдання.

Клініко-психологічні характеристики. Згідно з DSM-5 [1], до розладів харчової поведінки належать: анорексія нервова, булімія нервова, розлад компульсивного переїдання та інші специфічні форми. Для жінок середнього віку типові не класичні форми, а латентні: періодичне голодування, надмірне обмеження калорій, нав'язливі дієти, емоційне переїдання або залежність від «здорового» харчування (орторексія). Психоаналітичний підхід. Психоаналітична

концепція пояснює розлади харчової поведінки як символічний прояв несвідомих конфліктів, що виникають у процесі раннього розвитку. Психоаналітичні дослідження показали, що порушення ранніх дитячо-батьківських стосунків виступають основною причиною розладів харчової поведінки. Невідповідний або фруструючий материнський об'єкт спричиняє психічну депривацію дитини, внаслідок чого у неї формуються захисні поведінкові патерни, що згодом проявляються як ПХП. Взаємодія з їжею та спосіб її споживання стають символічним відображенням стосунків із деструктивним материнським об'єктом. За Фройдом, їжа є першим джерелом задоволення немовляти, тому проблеми харчування у дорослому віці можуть бути пов'язані з фіксацією на оральній стадії психосексуального розвитку. Ж. Лакан розглядав тіло як дзеркало бажання, через яке жінка намагається знайти визнання від Іншого. Отже, відмова від їжі або переїдання – це несвідомий спосіб контролювати тілесність і водночас комунікувати внутрішній конфлікт [4].

Когнітивно-поведінковий підхід. Когнітивно-поведінкова модель розглядає розлади харчової поведінки як наслідок дисфункціональних переконань щодо власного тіла, ваги й контролю. Жінки середнього віку часто переживають зниження самооцінки через зміни зовнішності та соціального статусу, що формує негативну тілесну схему. РХП у цьому випадку стає способом емоційної регуляції. Психотерапевтична робота спрямована на зміну автоматичних думок, навчання здоровим стратегіям саморегуляції та підвищення впевненості [2].

Гуманістичний та екзистенційний підхід. Представники гуманістичної психології (К. Роджерс, В. Франкл) наголошують, що розлади харчової поведінки пов'язані з відчуженням від власного «Я» та дефіцитом смислу життя. Для жінок середнього віку типовими є екзистенційні кризи, пов'язані з переоцінкою життєвих цінностей, втратою соціальних ролей і страхом старіння. Психотерапевтичне завдання полягає в тому, щоб допомогти клієнтці відновити

контакт із власними потребами, прийняти своє тіло та знайти внутрішній сенс життя.

Системно-сімейний підхід. Згідно з сімейною системною терапією, РХП можуть бути проявом дисфункцій у міжособистісних стосунках. Симптом виконує стабілізуючу функцію в сімейній системі: наприклад, жінка через харчову поведінку може несвідомо регулювати емоційний баланс у родині. У сім'ях, де існує надмірний контроль або високі очікування щодо зовнішності, підвищується ризик виникнення РХП. Сімейна терапія спрямована на поліпшення комунікації, відновлення емоційної підтримки та корекцію системних ролей [5]. Біопсихосоціальна модель пояснює розлади харчової поведінки як результат взаємодії біологічних, психологічних і соціальних чинників. Біологічно у жінок середнього віку важливу роль відіграють гормональні зміни, коливання рівня серотоніну та спадкові особливості. Психологічні чинники включають тривожність, перфекціонізм, емоційну нестабільність, соціальні – культурні стандарти краси та вплив медіа. Комплексна психотерапія з урахуванням цих аспектів є найефективнішою [3, 6].

Висновки. Розлади харчової поведінки у жінок середнього віку є багатовимірним феноменом, що виникає на перетині внутрішньоособистісних конфліктів, когнітивних викривлень, соціального тиску та біологічних змін. Їх дослідження має велике значення для клінічної практики, оскільки дозволяє розробляти більш цілісні програми профілактики та психотерапевтичної підтримки. Оптимальним підходом є інтеграція когнітивно-поведінкових, психоаналітичних та гуманістичних методів, спрямованих на відновлення самоприйняття, емоційної рівноваги та тілесної гармонії.

Список використаних джерел.

1. Американська психіатрична асоціація. Довідник діагностичних критеріїв DSM-5-TR. Львів : Манускрипт, 2024. 1120 с.

2. Beck A. T., Fairburn C. G. Cognitive Behavior Therapy and Eating Disorders. New York : Guilford Press, 2011. 324 p.
3. Engel G. L. The need for a new medical model: A challenge for biomedicine. Science. 1977. Vol. 196, No 4286. P. 129–136.
4. Lacan J. Écrits: A Selection. New York : W. W. Norton & Company, 1977. 927 p.
5. Minuchin S. Families and Family Therapy. Cambridge, MA : Harvard University Press, 1985. 268 p.
6. Treasure J., Zipfel S., Micali N., Wade T., Stice E., Claudino A. Eating disorders. The Lancet. 2021. Vol. 397, No 10288. P. 1412–1428.

Професійна спрямованість та самоздійснення фахівців юридичної сфери

*Зубленко А.А.
Здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти
Академія праці, соціальних відносин і туризму, м. Київ*

Актуальність. У сучасній психології професійна діяльність розглядається як цілісна система реалізації особистісного потенціалу в межах соціально значущої ролі, що передбачає виконання спеціалізованих функцій на основі професійних компетентностей, цінностей та етичних норм. Для представників юридичної професії така діяльність набуває особливої ваги, оскільки поєднує високий рівень когнітивної складності, моральної відповідальності та соціального впливу.

Одним із ключових психологічних чинників, що визначає професійну діяльність юриста, є професійна спрямованість. У контексті юридичної діяльності професійна спрямованість не лише формує внутрішню мотивацію до правозастосування, нормотворчості чи правозахисту, але й впливає на стиль мислення, етичну позицію та здатність до професійної рефлексії фахівців юридичної сфери. Дослідження професійної спрямованості є актуальним як для розуміння психологічних механізмів професійного розвитку юриста, так і для вдосконалення освітніх програм, спрямованих на підготовку та формування професійної ідентичності майбутніх юристів.

Професійна спрямованість особистості є одним із значущих соціально-психологічних чинників, що визначають професійну діяльність (професійна поведінка) юриста. У науковій літературі професійна діяльність розглядається як системна форма реалізації особистісного потенціалу в межах соціально значущої ролі, що передбачає виконання спеціалізованих функцій, заснованих на професійних знаннях, навичках і етичних стандартах. У контексті юридичної

професії вона охоплює не лише застосування правових норм, а й активне включення у правотворчі, правозахисні, консультативні та аналітичні процеси, що формують правове середовище суспільства.

Водночас професійна спрямованість має власну структуру, зміст і динаміку, що відрізняє її від загальних мотиваційних установок. Її аналіз нерозривно пов'язаний із такими категоріями, як професійне самовизначення – усвідомлення себе як представника юридичної професії – та професійне становлення, що охоплює процес формування компетентностей, етичних орієнтирів і професійної ідентичності.

Результати дослідження. У сучасних умовах трансформації правового поля та зростання вимог до професійної компетентності юриста особливого значення набуває дослідження психологічних чинників, що забезпечують ефективність професійної діяльності та професійно-особистісну реалізацію фахівця.

Психологічні особливості професійного становлення та індивідуально-особистісної реалізації фахівців юридичної сфери: професійне самовизначення – усвідомлення себе (особистісна ідентифікація) як представника юридичної професії, вибір спеціалізації, формування професійних цілей; професійна ідентичність – інтеграція професійної ролі в структуру особистості, відчуття належності до юридичної спільноти; професійна спрямованість фахівців юридичної сфери; самоздійснення – реалізація особистісного потенціалу через професійну діяльність, досягнення внутрішньої гармонії та соціального визнання.

Поняття «професійна спрямованість» у психологічній літературі аналізується та трактується як специфічна форма загальної спрямованості особистості, що проявляється та реалізується у професійній сфері [4; 7; 8]. Вона включає мотиваційні компоненти, інтереси, цінності, професійні ідеали та цілі, які визначають вибір професії, характер професійного самовизначення, формують внутрішню готовність до виконання професійних функцій та динаміку професійного становлення особистості (у

юридичній сфері це проявляється в орієнтації на правозахисну, нормотворчу, судову, адвокатську або аналітичну діяльність). Провідним чинником професійної спрямованості фахівця є стійка мотиваційна структура, яка визначає вибір професії, характер професійного самовизначення та динаміку самоздійснення особистості в юридичній сфері. Самоздійснення, у свою чергу, розглядається як процес реалізації внутрішнього потенціалу особистості через професійну діяльність, що відповідає ціннісним орієнтирам та соціальній значущості обраної професії. Самоздійснення, згідно з концепцією О. Кокуна, С. Максименка, А. Маслоу, Т. Савченко є вищим рівнем особистісного розвитку, що передбачає реалізацію власного потенціалу в соціально значущій діяльності. У професійному контексті юриста самоздійснення охоплює не лише досягнення професійної майстерності, а й формування етичної позиції, професійної ідентичності та здатності до рефлексії [5; 7; 10].

Взаємозв'язок професійної спрямованості та самоздійснення. Професійна спрямованість виступає передумовою самоздійснення, оскільки визначає вектор професійного розвитку та забезпечує мотиваційну основу для досягнення особистісно значущих цілей (рис. 1).



Рис. 1. Передумовчі компоненти професійної спрямованості у формуванні самоздійснення фахівця юридичної сфери

У юридичній діяльності взаємозв'язок професійної спрямованості та самоздійснення спостерігається через: усвідомлення соціальної ролі юриста; формування професійної ідентичності; розвиток етичної рефлексії; прагнення до професійної автономії та соціального визнання [1; 2; 9].

Опираючись на вищезазначене, професійна спрямованість є однією із компонентів самоздійснення фахівця юридичної сфери, а також є складовою мотиваційної структури особистості, що визначає орієнтацію (спеціалізацію) фахівця у професійній (юридичній) діяльності. Тому, мотиваційна спрямованість фахівця включає: мотиваційні компоненти – внутрішні спонукальні сили, що активізують професійну активність (прагнення до справедливості, правозахисту); інтереси – стійке зацікавлення правовими питаннями, нормотворчістю, судовою практикою тощо; цінності – етичні та соціальні орієнтири, які визначають зміст і межі професійної поведінки юриста.

Практичні аспекти формування професійної спрямованості. У системі юридичної освіти та професійного розвитку важливо створювати умови для формування усвідомленої професійної спрямованості. До таких умов належать: інтеграція психологічних тренінгів у навчальні програми; моделювання професійних ситуацій; розвиток навичок етичної рефлексії; підтримка індивідуального самопізнання та самовизначення [1; 2; 3]. Таким чином, професійна спрямованість є важливою передумовою та підґрунтям формування і розвитку самоздійснення (професійного самоздійснення) фахівців юридичної сфери. Умови, які сприяють самоздійсненню фахівців юридичної сфери, належать: високий рівень правової компетентності; мотивація до професійного вдосконалення; підтримка професійного середовища; наявність умов для самостійного прийняття рішень; відповідність професійної діяльності особистісним цінностям.

Водночас, існують бар'єри, що можуть ускладнювати процес самоздійснення: професійне вигорання, рольові конфлікти, деформація правосвідомості, обмеження автономії та недостатня психологічна підтримка.

Соціально-психологічні чинники розвитку самоздійснення фахівців юридичної сфери: освітній процес та навчальне середовище – навчальні програми, тренінги, наставництво, які сприяють формуванню професійної спрямованості та розвитку компетентностей; формування етичної рефлексії – здатність аналізувати власні дії та рішення з позиції професійної етики, що зміцнює внутрішню узгодженість; ідентифікація соціальної значущості юриста – усвідомлення суспільної ролі юриста, що формує мотивацію до самореалізації та професійної відповідальності [1; 2; 3].

Висновки. Професійна спрямованість та самоздійснення є взаємопов'язаними психологічними феноменами, що визначають якість професійного становлення фахівця юридичної сфери. Соціально-психологічне дослідження даних понять дозволяє глибше зрозуміти механізми професійного розвитку, оптимізувати освітні стратегії та сприяти формуванню індивідуально-особистісної сфери юристів.

Список використаних джерел.

1. Гребенюк О. В. Психологічні чинники професійного становлення правника. Вісник Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія». 2021. Вип. 15. С. 78–85.
2. Ковальчук О. М. Професійне самовизначення особистості в умовах трансформації правової освіти. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Психологія. 2020. Вип. 7. С. 112–118.
3. Козяр М. М. Формування професійної спрямованості майбутніх юристів у процесі фахової підготовки. Психологія і суспільство. 2018. № 1. С. 134–140.
4. Кокур О. М. Психологія професійного становлення сучасного фахівця: монографія. К.: ДП «Інформ-аналіт. Агентство. 2012. 200 с.

5. Кокун О.М. Життєве та професійне самоздійснення як предмет дослідження сучасної психології. Практична психологія та соціальна робота. 2013. № 9. С. 1–5.
6. Левченко О. В. Психологічні аспекти самоздійснення особистості в професійній діяльності. Актуальні проблеми психології. 2022. Т. 2. С. 56–63.
7. Максименко С.Д. Генеза здійснення особистості. К.: ТОВ «КММ», 2006. 240 с.
8. Раєвська Я. М. Теорія і практика професійного становлення фахівців соціальної сфери до міжпрофесійної взаємодії : монографія. Кам'янець-Подільський: Видавець Панькова А. С., 2020. 348 с.
9. Савченко Л. О. Професійна ідентичність юриста: психологічні аспекти. Юридична психологія. 2019. № 2(27). С. 45–52.
10. Савченко Т.Л. Генеза терміну «самоздійснення особистості» та роль уваги у цьому процесі. Актуальні проблеми психології. Том V. Випуск 13. С. 251–257.

Стресостійкість та психологічне благополуччя у працівників фармацевтичних компаній під час війни

Кулик О.

*Здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти
Академія праці, соціальних відносин і туризму, м. Київ*

Актуальність. Повномасштабна війна в Україні сформувала тривалий і надзвичайно інтенсивний контекст стресового впливу, у якому поєднуються загрози фізичній безпеці, вимушені зміни способу життя, фінансова нестабільність, розриви соціальних зв'язків, інформаційна перенасиченість і постійна невизначеність. У цих умовах стрес дедалі частіше набуває характеру хронічного процесу, що позначається на психічному здоров'ї, працездатності та якості життя людей. Особливої уваги вимагають професійні групи, діяльність яких забезпечує функціонування критичної інфраструктури. До них належать працівники фармацевтичних компаній, які в період війни стикаються не лише із загальносоціальними стресорами, а й зі специфічними викликами професійного середовища.

Професійна діяльність працівників фармацевтичної сфери у воєнний час ускладнюється необхідністю підтримувати безперервність ланцюгів постачання, забезпечувати стандарти якості, здійснювати комунікацію з медичною спільнотою та населенням, адаптувати операційні процеси до змін у логістиці, ресурсних обмежень і ризиків для персоналу та корпоративної інфраструктури. Додатковими чинниками напруження є обмежений час на планування, потреба у швидких рішеннях та моральні дилеми (зокрема пріоритизація поставок або виконання робочих завдань під час повітряних тривог). Усе це створює передумови для зниження рівня психологічного благополуччя, а також підвищує ризики виснаження й професійного вигорання. Актуальність теми визначається сукупністю соціальних, професійних і клініко-психологічних чинників. По-перше, воєнний період супроводжується зростанням тривожних і депресивних

симптомів, порушень сну, соматизації та проявів вигорання, що безпосередньо впливає на продуктивність праці й безпеку процесів у сферах, пов'язаних із охороною здоров'я. По-друге, працівники фармацевтичних компаній є важливою ланкою системи забезпечення медичної допомоги; зниження їхнього психологічного благополуччя може відображатися на якості управлінських та операційних рішень, взаємодії у командах і дотриманні протоколів, а отже – на доступності та безпечності лікарських засобів. По-третє, сучасне розуміння психологічного благополуччя виходить за межі «відсутності симптомів» і включає позитивні показники функціонування: енергійність, інтерес до життя, відчуття сенсу, здатність підтримувати соціальні зв'язки, задоволення діяльністю. По-четверте, у вітчизняній науці залишається недостатньо досліджень, що фокусуються саме на фармацевтичній галузі в умовах війни, тоді як увага частіше спрямовується на військових, медиків і волонтерів.

Мета дослідження. Дослідити стесостійкість та психологічне благополуччя у працівників фармацевтичних компаній під час війни.

Теоретичні підходи до розуміння стресу в роботі подано у триєдиній логіці: фізіологічній, когнітивно-оцінювальній та ресурсній. Класичний фізіологічний підхід (Г. Сельє) розглядає стрес як неспецифічну реакцію організму та описує загальний адаптаційний синдром, підкреслюючи ризик виснаження за тривалого перебування на стадії резистентності без відновлення. Когнітивно-оцінювальний підхід (Р. Лазарус, С. Фолкман) акцентує роль первинної та вторинної оцінки події (загроза/виклик/втрата) і наявних ресурсів подолання; у цій логіці стрес може модифікуватися через зміни в оцінці, копіngu, підтримці та навичках саморегуляції. Ресурсний підхід (теорія збереження ресурсів С. Хобфолла) трактує стрес як наслідок втрати ресурсів, загрози втрати або недостатнього їх приросту після інвестицій; у воєнних умовах це включає матеріальні, соціальні, часові, емоційні та статусні ресурси, а для фармацевтичних працівників – також

організаційні ресурси (чіткість процедур, підтримка керівництва, доступ до безпечних умов праці, передбачуваність змін).

Стійкість до стресу (стресостійкість) інтерпретується як інтегративний ресурс, що включає емоційно-регуляторний компонент (стабілізація емоцій, відновлення рівноваги, толерантність до невизначеності), когнітивний (гнучкість мислення, реалістична оцінка, планування та переоцінка), мотиваційно-смысловий (цілі, професійна місія, внутрішня мотивація), поведінковий (ефективні копінг-стратегії, самоорганізація, використання підтримки) та соціальний (мережа підтримки, довіра, якість комунікації). Підкреслено, що стресостійкість не означає «відсутності переживань», а відображає здатність переживати складні емоції без дезорганізації й поступово відновлюватися. В умовах війни зростає значущість толерантності до невизначеності та моральної стійкості – здатності зберігати професійні й етичні стандарти за дефіциту та тиску часу.

Психологічне благополуччя описано через гедоністичну та евдемоністичну традиції. Перша фокусується на позитивних емоціях, задоволеності життям і балансі афектів; друга (К. Ріфф) – на позитивному функціонуванні (самоприйняття, автономія, особистісне зростання, цілеспрямованість, позитивні стосунки, контроль над середовищем). Для операціоналізації обрано Індекс благополуччя ВООЗ-5 (WHO-5), який оцінює суб'єктивне благополуччя через показники енергійності, життєвого тону, інтересу, спокою та відпочинку.

Важливо підкреслити, що у воєнному контексті психологічне благополуччя працівників фармацевтичних компаній формується не лише під впливом індивідуальних особистісних характеристик, а й у тісному взаємозв'язку з організаційним середовищем. Чіткість ролей і процедур, прогнозованість управлінських рішень, доступність комунікації з керівництвом та відчуття психологічної безпеки в команді можуть суттєво посилювати або, навпаки, послаблювати індивідуальні ресурси стресостійкості. У ситуаціях, коли

організаційна підтримка є недостатньою, навіть високий рівень особистісної стійкості до стресу може не забезпечувати належного рівня благополуччя в довгостроковій перспективі.

Мета запланованого дослідження – теоретично та емпірично вивчити вплив стійкості до стресу на рівень психологічного благополуччя працівників фармацевтичних компаній під час війни. Об'єкт – психологічне благополуччя працівників у воєнних умовах; предмет – вплив стресостійкості на благополуччя. Емпіричний дизайн передбачає вибірку $N=70$ та застосування двох інструментів: опитувальника «Стійкість до стресу» і WHO-5. Планується описова статистика, перевірка розподілу та кореляційний аналіз (Пірсона або Спірмена), за потреби – регресійна оцінка внеску стресостійкості у варіацію благополуччя. Підкреслено етичні засади: добровільність, інформована згода, конфіденційність, неможливість ідентифікації респондентів, а також мінімізація ризику повторної травматизації.

Висновки. З позицій клінічної психології доцільно також враховувати, що зниження показників благополуччя за індексом WHO-5 може виступати раннім індикатором ризику розвитку тривожних, депресивних або психосоматичних проявів. У цьому сенсі результати дослідження можуть бути корисними не лише для організаційного управління, а й для побудови системи психологічного моніторингу та своєчасного спрямування працівників до консультативної чи психотерапевтичної допомоги. Таким чином, вивчення зв'язку між стресостійкістю та психологічним благополуччям має міждисциплінарне значення і поєднує організаційний, клінічний та профілактичний підходи. Практична значущість очікуваних результатів полягає у можливості розроблення програм психологічної підтримки персоналу фармацевтичних компаній (стрес-менеджмент, саморегуляція, психологічна безпека команд, комунікація, профілактика вигорання) та у формуванні підходів до раннього виявлення груп ризику за показниками благополуччя.

Інструменти психологічної діагностики стрес-індукованих станів у дорослих під час війни

Ларіонова Н.А.

Кандидат медичних наук

Здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти

Академія праці, соціальних відносин і туризму, м. Київ

Актуальність. Воєнні конфлікти супроводжуються значними психологічними наслідками для цивільного населення, які проявляються у формуванні стрес-індукованих станів різної інтенсивності та тривалості. На відміну від локальних криз, війна створює хронічний стресовий контекст, що поєднує загрози фізичній безпеці, втрати, вимушену міграцію, соціально-економічну нестабільність та тривалу невизначеність. За таких умов особливої актуальності набуває проблема адекватної психологічної діагностики, здатної забезпечити своєчасне виявлення психоемоційних порушень у цивільних осіб та стати підґрунтям для надання психологічної допомоги. Історично психологічна діагностика наслідків війни формувалася переважно у межах клінічного підходу, орієнтованого на військовослужбовців. Під час Першої та Другої світових воєн увага зосереджувалася на клінічному описі симптомів і спостереженні за поведінкою, тоді як цивільне населення тривалий час залишалося поза фокусом системних досліджень. Формування концепції посттравматичного стресового розладу та її включення до діагностичних класифікацій сприяло розвитку стандартизованих інструментів, що дозволили кількісно оцінювати психічні порушення. Наприкінці ХХ – на початку ХХІ століття відбувся перехід до використання самозвітних шкал, придатних для масового скринінгу цивільних груп у зонах конфліктів.

Сучасні воєнні умови висувають нові вимоги до діагностичних інструментів: вони мають бути короткими, чутливими, етично безпечними та придатними для дистанційного застосування. У цьому контексті ключову роль відіграють стандартизовані шкали, зокрема PCL-5, DASS-21, GAD-7 та PHQ-9. Шкала PCL-5 орієнтована на оцінку посттравматичної симптоматики та дозволяє

виявляти прояви ПТСР у цивільних осіб, які зазнали травматичного впливу. DASS-21 забезпечує комплексну оцінку депресії, тривоги та стресу, що є особливо важливим в умовах хронічного воєнного напруження. GAD-7 і PHQ-9 застосовуються для цільового скринінгу генералізованої тривоги та депресивних симптомів відповідно. Порівняльний аналіз цих інструментів свідчить про доцільність їх комбінованого використання для отримання більш повної картини психоемоційного стану.

Окрему увагу у воєнному контексті слід приділяти діагностиці психосоматичних порушень, які часто є наслідком тривалого стресу. У цивільних осіб стрес-індуковані стани можуть проявлятися через соматичні скарги, порушення сну, хронічну втому та функціональні розлади. Це зумовлює необхідність інтегрованого підходу, що поєднує психологічні та медичні методи оцінювання.

Важливим аспектом сучасної діагностики є врахування вікових, гендерних і соціальних відмінностей. Молоді дорослі частіше демонструють підвищену тривожність та емоційну нестабільність, тоді як особи старшого віку схильні до соматизації стресу. Гендерні відмінності проявляються у більш високих показниках тривоги та депресії у жінок і специфічних поведінкових реакціях у чоловіків. Соціальні чинники, зокрема досвід внутрішнього переміщення та рівень соціальної підтримки, істотно впливають на результати діагностики та потребують контекстуальної інтерпретації. Сучасний етап розвитку психологічної діагностики характеризується активним впровадженням цифрових технологій і інструментів штучного інтелекту. Онлайн-опитувальники, мобільні застосунки та AI-аналіз поведінкових і мовленнєвих патернів розширюють можливості масового скринінгу цивільного населення. Водночас використання таких технологій потребує дотримання етичних стандартів і не може замінювати професійну психологічну оцінку. Перспективним напрямом є поєднання симптомно-орієнтованих шкал з ресурсно-орієнтованими інструментами. У цьому контексті важливе місце посідає опитувальник «Стійкість до стресу», який

дозволяє оцінити адаптаційний потенціал особистості. Його використання у майбутньому емпіричному дослідженні серед цивільних мешканців обласних центрів України дасть змогу доповнити симптомну діагностику оцінкою психологічних ресурсів і сформулювати підґрунтя для розроблення програм психологічної підтримки в умовах війни.

Особливості уваги та тривожності у внутрішньо переміщених осіб

Московко Н.М.

*Здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти
Академія праці, соціальних відносин і туризму, м. Київ*

Актуальність. Концентрація уваги – це не зупинка думок на одній точці, а їх рух в єдиному напрямку. Для того щоб увага особистості до якого-небудь предмету підтримувалася, його усвідомлення повинне бути динамічним процесом. Людина повинна на наших очах розвиватися, виявляти перед собою все новий зміст. Лише те, що змінюється і оновлюється здатне підтримувати увагу. Одноманітність притупляє увагу, монотонність вгашає її. У випадку для внутрішньо переміщених осіб це є пагубним та спричиняє затяжні депресивні стани. Події, які примушують людей зриватись з місць, залишати свої домівки, настільки виходять за межі нормального життя, що відчуються як надзвичайно стресові для всіх, хто опинився в таких ситуаціях (незважаючи на те чи від'їжджали вони через тривожні відчуття, чи через реальну загрозу життю під час розгортання військових дій). Психологи так само мають зважати на те, що переселенці опиняються у таких стресових умовах щонайменше декілька разів: до переселення, під час переселення і після свого переселення [1–5].

Мета дослідження. Здійснити комплексне емпіричне дослідження психічних станів внутрішньо переміщених осіб, запропонувати рекомендацій щодо роботи з внутрішньо переміщеними особами.

Методи та матеріал дослідження. У дослідженні прийняло участь 43 особи віком від 28 до 45 років. Досліджені користувалися послугами та відвідували волонтерський пункт регіону, в якому отримували допомогу соціально-психологічного характеру. Комплексне дослідження психічних станів внутрішньо переміщених осіб проводилося за допомогою наступних методик: методика дослідження концентрації уваги; методика дослідження тривожності (Ч. Спілбергер); Використано якісний та кількісний аналіз отриманих результатів

а також методи математичної статистики перевірки запропонованої гіпотези. Вікові показники розділилися наступним чином: 28–30 років – 6 чоловік; 31–33 роки – 7 чоловік; 34–36 років – 11 чоловік; 37–39 років – 9 чоловік; 40–43 роки – 10 чоловік.

Результати дослідження. Рівень концентрації уваги до психологічного впливу на внутрішньо переміщених осіб був наступним. Дуже низький рівень спостерігався у 8 чоловік, низький рівень у 10 досліджуваних, середній рівень виявився у 19 внутрішньо переміщених осіб, високий рівень у 6 досліджуваних та жодного дуже високого рівня. Концентрація – це зосередженість, тобто центральний факт, в якому висловлюється увагу. Сконцентрованість уваги означає, що є фокус, в якому зібрана психічна або свідома діяльність. Увага характеризується зосередженістю на конкретному об'єкті психічної діяльності, має певну інтенсивність, а отже певний ступінь концентрації. Чим сильніше зосередження, тим більше внаслідок негативної індукції гальмується дія побічних подразників, тим цілеспрямованою й продуктивнішою стає сама діяльність. В результаті психологічних впливів та проведення повторного збору емпіричних даних ми отримали дуже низький рівень у 3 досліджуваних, низький рівень у 5 осіб, середній рівень концентрації уваги у 12 чоловік, високий рівень у 21 особи та дуже високий рівень у 2 досліджуваних. Зосередженість уваги та її стійкість у процесі діяльності можуть порушуватися: сила і тривалість зменшуються, увага слабшає, людина відволікається від об'єкта діяльності. Відволікання настає тоді, коли відсутні чинники, які сприяють зосередженості та стійкості уваги, у випадку внутрішньо переміщених осіб це тяжкі життєві обставини.

За допомогою методики Ч. Спілбергера досліджений рівень особистісної та реактивної тривожності до психологічних впливів на внутрішньо переміщених осіб та після. Особистісна тривожність – підвищена схильність до переживань тривоги і занепокоєння без достатніх підстав.

Низький рівень такої тривожності спостерігався у 19 досліджуваних до початку психологічних впливів та у 29 після. Середній рівень був притаманний 15 та 9 досліджуваним на першому та другому етапі дослідження відповідно.

Таблиця 1

Порівняльні показники рівня концентрації уваги до та після психологічних впливів

Рівень концентрації уваги	Результати на початок дослідження		Результати на кінець дослідження	
	N	%	N	%
Дуже низький	8	19,0	3	7,0
Низький	10	23,0	5	12,0
Середній	19	44,0	12	28,0
Високий	6	14,0	21	49,0
Дуже високий	—	—	2	5,0

Таблиця 2

Порівняльні показники рівня особистісної тривожності до та після психологічних впливів

Особистісна тривожність	Результати на початок дослідження		Результати на кінець дослідження	
	N	%	N	%
Низький рівень	19	44,0	29	67,0
Середній рівень	15	35,0	9	21,0
Високий рівень	9	21,0	5	12,0

Високий рівень с особистісної тривожності характерний для 9 внутрішньо переміщених осіб до комплексної психологічної роботи та 5 після. Особистісна тривожність – це стійка індивідуальна особливість людини, що характеризує її

тенденцію сприймати певний діапазон ситуацій як загрозливих, небезпечних для самооцінки і самоповаги.

Реактивна тривожність як стан характеризується суб'єктивно пережитими емоціями: напругою, занепокоєнням, заклопотаністю, нервозністю. Цей стан виникає як емоційна реакція на стресову ситуацію. Низький рівень реактивної тривожності спостерігається у 3 досліджуваних на початку та у 9 на кінець дослідження. Середній рівень реактивної тривожності був притаманний 12 досліджуваним на першому етапі та 21 на другому етапі дослідження. До психологічних впливів високий рівень реактивної тривожності притаманний 29 досліджуваним, після – 13 вимушеним переселенцям.

Таблиця 3

Порівняльні показники рівня реактивної тривожності до та після психологічних впливів

Реактивна тривожність	Результати на початок дослідження		Результати на кінець дослідження	
	N	%	N	%
Низький рівень	3	7,0	9	21,0
Середній рівень	12	28,0	21	49,0
Високий рівень	29	67,0	13	30,0

Висновки. Високо тривожні особистості схильні сприймати загрозу самооцінці і життєдіяльності та реагувати вираженим станом тривоги. Якщо результати тесту виявляють високий рівень особистісної тривожності, то це дає підставу прогнозувати виникнення станів тривожного ряду в різноманітних ситуаціях, пов'язаних з оцінкою компетенції і престижу. Ті, хто отримує підтримку, відчувають менші наслідки від шоку. На жаль, «відлуння» війни не завжди дають

знати про себе відразу, тому на першому місці має стояти соціально-психологічна допомога, і саме комплексний підхід у роботі з вимушеними переселенцями у всіх закладах куди вони звертаються.

Список використаних джерел.

1. Внутрішньо переміщені особи: від подолання перешкод до стратегії успіху: монографія / О. Ф. Новікова, О. І. Амоша, В. П. Антонюк та ін. ; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. Київ, 2016. 448 с.
2. Гридковець Л., Вебер Т., Журавльова Н., Запорожець О., Климишин О., Креймейер Д., Мокроусова А., Пророк Н., Сиротич Н., Сіренко Т., Царенко Л., Шапошник Н. Основи реабілітаційної психології: подолання наслідків кризи. Навчальний посібник. Том 3. Київ, 2018. 236 с.
3. Закон України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», грудень 2015 р.
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/170618#Text>
4. Пріб Г.А. Психологічна підтримка працевлаштування внутрішньо переміщених осіб. Ментальне здоров'я особистості та організації: колективна монографія. Академія праці, соціальних відносин і туризму / За заг. ред: Г. А. Пріба, Л. Є. Бегези. Київ: Вид-во «Лів-принт», 2024. С. 293–303.
<http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.29969.61284>
5. Пріб Г.А., Бегеза Л.Є. Сприяння федерації професійних спілок України у наданні підтримки внутрішньо переміщеним особам в Україні. Технічний звіт РО 40405574 від 16.01.2023 р. Академія праці, соціальних відносин і туризму. 2023. 29 с. <http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.36478.97606>

Тривожність як чинник психічних станів вагітних жінок зрілого репродуктивного віку

Рубан Г.О.

Кандидат медичних наук

*Здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти
Академія праці, соціальних відносин і туризму, м. Київ*

Актуальність. У контексті сучасної перинатальної психології вагітність жінок зрілого репродуктивного віку (після 40 років) розглядається як складний психофізіологічний та соціально значущий процес, що супроводжується психоемоційними, когнітивними та поведінковими реакціями. Зрілість жінки, життєвий досвід, сформована система цінностей і соціальних ролей зумовлюють унікальність переживання материнства в цьому віковому періоді. Водночас вагітність у зрілому віці може супроводжуватись підвищеним рівнем тривожності, екзистенційними роздумами, а також потребою в психологічній підтримці значущих людей. У науково-психологічних дослідженнях період гестації розглядається як особливий, екзистенційно значущий етап онтогенезу жінки, що супроводжується трансформаціями особистісного, емоційного та тілесного досвіду. З одного боку, вагітність асоціюється з позитивними емоційними переживаннями, пов'язані з очікуванням материнства, з іншого – супроводжується відповідальністю за життя та благополуччя плода. Вагітність як період соціогенезу позначається інтенсивними різномодальними психоемоційними переживаннями, що мають виражену індивідуальну варіативність і специфічну сенсорну насиченість. У чуттєвій структурі вагітної жінки домінують емоції тривоги, радості, очікування, а також тілесні відчуття, які набувають значення сенсу в контексті формування материнської ідентичності.

Визначено психологічні особливості вагітності жінок зрілого репродуктивного віку:

1. Екзистенційна значущість вагітності (переважно вагітність є свідомим рішенням, та визначається високим рівнем психологічної готовності до материнства, однак, спостерігається зростання тривожності щодо стану здоров'я, пологів і здоров'я майбутньої дитини);

2. Емоційна амбівалентність (інтенсивна емоційна реактивність, що може проявлятися у формі перепадів настрою, переживання страху, невпевненості, сумнівів щодо власної здатності виконувати материнські функції в умовах вікових змін; спостерігається підвищеної чутливості до соціального оточення, потреби в підтримці);

3. Соціально-психологічні чинники (вплив вагітності у зрілому віці на професійну діяльність та самореалізацією, що може викликати внутрішній конфлікт між кар'єрою та материнством; відчуття соціальної оцінки в контексті традиційних уявлень про «оптимальний» вік для народження дітей);

4. Формування материнської ідентичності та образу «Я-мати» (у жінок зрілого репродуктивного віку процес формування материнської ідентичності може мати глибший рефлексивний характер, часто включає переосмислення власного життєвого шляху, цінностей і ролей; високий рівень відповідальності сприяє активному пошуку інформації, участі в програмах психопрофілактики, підготовці до пологів);

5. Психосоматичні аспекти (підвищений рівень тривожності може спричинити психосоматичні реакції: порушення сну, апетиту та ін.).

Досліджуючи прояви психоемоційних станів жінок у період вагітності авторами (К. П. Гавриловська, Т. Г. Герасимова, І. А. Літвякова, О. А. Нікіфорова та ін.), «... визначено характерні особливості емоційного реагування жінок під час вагітності:

– ригідно-імпульсивний тип реагування (нестриманість, несприйнятливність зовнішнього впливу, лабільність настрою, уразливість, вразливість, почуття

ізолюваності та самотності, боротьба із заборонами та небажаними обмеженнями);

- здатність до опору стресам (зростає домінантність, егоцентризм, що пояснюється боротьбою існування);

- у вагітних, на відміну від невагітних, найбільш високий психічний неспокій і нижчим є психічний спокій, відчуття сили та енергії;

- переважає агресивно-оборонна позиція, нестійкість стану, його диспропорційність...» [3, с. 85; 5, с. 806; 6].

На думку В. В. Абрамченко, М. А. Кочневої, Г. В. Шпатаковської психоемоційні зміни під час вагітності можна пояснити змінами функціонального стану нервової системи, які проявляються у підвищеній чутливості та вразливості, тривожності, що значно посилюється у даний період. Спостерігаються страхи, побоювання ускладнень, втрати дитини, смерті, пологів, болю, невпевненість у своїх материнських якостях [6; 9, с. 104].

Акушерсько-гінекологічна практика та соціологічне дослідження благодійного фонду «280 днів» [6] вказують, що питаннями, які найчастіше викликають занепокоєння у вагітних є: індивідуально-психологічні: власне здоров'я; здоров'я дитини (в тому числі, у випадках попереднього негативного досвіду вагітності); взаємодія з дитиною після пологів; страх пологів, страх кесарського розтину; соціально-психологічні: матеріальне забезпечення; комунікація з чоловіком і членами родини; нестабільність в країні, війна.

Психічні стани вагітних жінок вивчались в аспекті їх патологічних проявів, порушень діяльності ЦНС, неврологічних розладів, негативних емоційних станів (тривога, емоційна напруженість обтяжена акушерсько-гінекологічним анамнезом) тощо (Г. І. Іщенко, А. Ю. Гільман, К. В. Мазяр, В. Г. Сюсюка та ін.). До негативних психічних станів вагітних жінок належать підвищена дратівливість, поганий настрій, пригніченість, підозрілість та депресивність. Вплив стресів, чутливість до надзвичайних ситуацій, реагування на факти воєнних

подій, наявність депресій, нервових зривів може призвести до передчасних пологів, появи ризику загрози викидня тощо (О. В. Бацилева, Г. В. Католик, А. Ю.Ковтун, І. В. Крушельницька, І. В.Пелех, І. В. Пузь).

У той же час, на думку В. Г. Сосюки «... тривожність, в цілому, грає і позитивну роль в плані мобілізації сил для досягнення кінцевої мети і підвищення відповідальності перед важливими подіями, тобто вона сприяє адаптації жінки до вагітності та до появи дитини. Хоча тривога відображає нормальну реакцію організму, зокрема психіки, на мінливі умови середовища та вплив стресу, однак при тривалому їх впливі або наявності неадекватної адаптаційної моделі поведінки, вона втрачає свої саногенні властивості та переходить в тривожний розлад, часто поєднуючись з депресією та інсомнією». Таким чином, тривога лежить в основі будь-яких змін психічного стану та поведінки, що обумовлені стресом [7, с. 58].

У дослідженнях І. А. Літвякової, В. Р. Ушакової проаналізовано фактори, що детермінують тривожність у майбутніх мам, а саме: можливі ускладнення під час вагітності; незапланована вагітність; побоювання щодо наявності генетичних аномалій у плода; боязнь пологів; естетичні страхи; страх про здоров'я майбутньої дитини; боязнь відповідальності за долю дитини; сумніви у власних батьківських здібностях і можливостях забезпечити належні умови виховання; загальна екзистенціальна невизначеність щодо подальших життєвих перспектив [6; 8, с. 35].

Напередодні пологів зростають захисні реакції вагітних жінок: регрес, витіснення, інфантилізм, емоційна нестійкість, незадоволеність та амбівалентність, а також спостерігаються: порушення сну, висока стомлюваність, підвищений рівень тривожності за самопочуття та стан дитини [5, с. 807].

Висновки. Таким чином, емоційне реагування та тривожність жінок зрілого репродуктивного віку під час вагітності має характерні особливості, що зумовлені як індивідуально-психологічними, так і соціально-психологічними чинниками, а

саме: вагітність сприймається усвідомлено (може спричинити переоцінку життєвих пріоритетів) та з відповідальним ставленням до майбутнього материнства, що може впливати на емоційну амбівалентність. Підвищена тривожність щодо здоров'я матері та дитини спостерігається через усвідомлення вікових ризиків, можливих ускладнень, а також може обумовлюватись попереднім досвідом материнства чи втратою вагітності. Емоційна нестабільність може бути більш вираженою, що пов'язано з гормональними змінами та психологічним навантаженням. Турбота про фінансову стабільність та забезпечення майбутньої дитини може спричиняти додатковий стрес, попри наявне стабільне матеріальне становище. Почуття самотності може виникати через соціальне відчуження та впливати на соціально-психологічну комунікацію і взаємодію. Соціальна підтримка партнера, родини та друзів позитивно впливає на стабілізацію емоційного стану.

Список використаних джерел.

1. Бацилєва О. В., Пузь І. В. Психологічні аспекти вагітності жінок пізнього репродуктивного віку. Проблеми сучасної психології. 2014. № 25. С. 45–56. DOI: <https://doi.org/10.32626/2227-6246.2014-23.%25p>.
2. Войцеховська Н. В. Перинатальна психологія: навч. посіб. / Н. В. Войцеховська. Київ: Центр учбової літератури, 2012. 240 с.
3. Гавриловська К. П. Порівняльний аналіз емоційних станів молодих матерів із різним соціальним статусом. Прикладні аспекти психології особистісного зростання. Житомир: ЖДУ імені І. Франка, 2015, Випуск 15 С. 83–86.
4. Коренєва Ю. П. Психологічні особливості перебігу вагітності у пізньому репродуктивному віці. Молодий вчений. 2017. № 3. С. 260–263.
5. Літвякова І. А. Дослідження впливу емоцій на стан особистості. Молодий вчений. 2017. № 11. С. 806-809.

6. Нікіфорова О. А. Психологічні особливості прояву психоемоційних станів жінок у період вагітності. Кв.робота. Київ. 2022. 84 с.
7. Сюсюка В.Г. Клініко-патогенетичні аспекти акушерських і перинатальних ускладнень у жінок з урахуванням психоемоційного стану та їх медико-психологічна корекція: дис. ... д-ра мед. наук: 14.01.01. Запоріжжя, 2018. 395 с.
8. Ушакова В. Р. Вплив подружніх відносин на зміни психоемоційної та особистісної сфер вагітних жінок. Медична психологія. 2014. Т. 9, № 3. С. 33–40.
9. Шпатаковська Г. В. Дослідження психоемоційного стану жінок у період адаптації до вагітності. Вісник Одеського національного університету. Психологія. Том 14, № 26. 2019. С. 102 – 110.

Дослідження психологічних чинників розвитку конкурентоспроможної особистості

Франчук І.В.

*Здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти
Академія праці, соціальних відносин і туризму, м. Київ*

Актуальність. В умовах інтенсивного соціально-економічного розвитку України модернізація виробничих галузей набуває незворотного характеру. Це обумовлює потребу у формуванні конкурентоспроможних і висококваліфікованих фахівців, які володіють ґрунтовними професійними знаннями, здатні орієнтуватися у суміжних сферах діяльності та демонструють готовність до безперервного професійного самовдосконалення. Ефективність професійної діяльності сучасного спеціаліста визначається гармонійним поєднанням зовнішніх чинників (політичних, економічних, правових) та внутрішніх детермінант, що охоплюють індивідуально-психологічні особливості особистості, її онтогенетичний професійний розвиток, а також необхідність збереження фізичного й психічного здоров'я. Аналіз сучасних наукових джерел свідчить, що проблема конкурентоспроможності особистості знайшла відображення у працях як зарубіжних, так і вітчизняних дослідників. Зокрема, досліджено сутність конкурентоспроможності як соціально-психологічного феномену (С. Кас'янова, О. Смирнова, Е. Хайрулліна та ін.), а також розкрито значення її формування у структурі соціальної зрілості особистості (В. Радул, Л. Сергеева та ін.) [1–6]. Теоретичні, методологічні та методичні аспекти конкурентоспроможності фахівців висвітлені у працях зарубіжних науковців, серед яких Д. Джоббер (D. Jobber), П. Дойль (P. Doyle), М. Портер (M. Porter), Л. Мітіна, Р. Фатхутдинов та інші.

Психологічні особливості професійного розвитку фахівців у контексті конкурентоспроможності, з урахуванням різних галузей професійної діяльності та

наукових підходів, досліджували українські науковці: Г. Костюк, Л. Карамушка, О. Киричук. Упродовж останніх років проблематика конкурентоспроможності особистості стала предметом наукових праць В. Базелюка, В. Бикової, Я. Гончаренко, О. Креденцер.

Аналіз наукової літератури засвідчує, що проблемі розвитку конкурентоспроможності особистості в сучасному суспільстві приділено недостатньо уваги, хоча вона й представлена у низці психологічних досліджень. Попри зростаючий інтерес науковців до процесу формування конкурентоспроможності, наявні результати досліджень не можна вважати вичерпними. Залишається низка аспектів, що потребують ґрунтовного теоретичного осмислення та систематизації, серед яких особливе значення має проблема розвитку конкурентоспроможної особистості як складного соціально-психологічного феномену [6–11]. Теоретичну основу роботи становлять наукові положення щодо взаємозв'язку та взаємозумовленості професійного й особистісного розвитку фахівців (Б. Ананьєв, В. Семиченко); концептуальні засади особистісного (Л. Виготський, С. Рубінштейн, В. Рибалко), компетентнісного (Е. Зеєр, Л. Карамушка) та діяльнісного (Г. Костюк, О. Леонтьєв) підходів; теорії конкурентоспроможності, зокрема теорія «конкурентних переваг» М. Портера; сучасні наукові підходи до проблеми формування конкурентоспроможного фахівця (Л. Мітіна, Л. Сергєєва), у тому числі в умовах функціонування служби зайнятості (В. Дорожкін, Г. Пріб, М. Ткалич) [1–11]. Методологічну основу дослідження складають принципи єдності психіки та діяльності, розвитку психіки, системно-структурний принцип, принцип особистісного підходу, а також положення про єдність природного й набутого, індивідуального та соціального у процесі становлення особистості.

Мета дослідження. Дослідити соціально-психологічні чинники розвитку конкурентоспроможної особистості в сучасному суспільстві. *Гіпотеза*

дослідження це припущення, що процес розвитку конкурентоспроможної особистості набуде ефективності за таких соціально-психологічних чинників: соціальна успішність, рівень професіоналізму особистості, типологічні особливості особистості, мотивація, рівень самооцінки здатності до самовдосконалення. *Методи дослідження.* Дослідження проводилось з 80-и безробітних особах, які були зареєстровані та перебували на обліку в центрі зайнятості. Для вирішення поставлених завдань та перевірки гіпотези було використано комплекс методів, вибір яких залежав від змісту проблеми та етапу дослідження:

1) теоретичні методи: аналіз, узагальнення, систематизація та інтерпретація наукових джерел;

2) емпіричні методи: бесіда, опитування, психодіагностичні методики: «Виявлення типологічних особливостей особистості» К.-Г. Юнга, «Оцінка рівня конкурентоспроможності особистості», методика визначення рівня самооцінки здатності до самовдосконалення, «Мотивація успіху та острах невдач» О. Реана;

3) методи математичної обробки даних: описові статистики, кореляційний аналіз, перевірка статистичних гіпотез за t-критерієм Стюдента. Математична обробка даних здійснювалась за допомогою комп'ютерного пакета статистичних програм Excel.

Результати дослідження. У дослідженні встановлено, що переважна більшість – 61 (76,25 %) безробітних вважають себе соціально неуспішними, у зв'язку з відсутністю роботи і зниженням матеріального рівня. Отже, зниження соціального статусу у суспільстві, усвідомлення себе соціально неуспішним є одним із соціальних чинників розвитку майбутньої конкурентоспроможності особистості. Згідно з отриманими даними методики «Виявлення типологічних особливостей особистості» визначено, що у безробітних переважає така типологічна особливість як інтроверсія встановлена у 42 (52,5 %) досліджуваних, екстраверсія визначена у 24 (30,0 %) досліджуваних та амброверсія – у 14 (17,5

%). За результатами дослідження можна зробити висновок, що безробітні, які мають переважаючу інтроверсію мовчазні, важко заводять нові знайомства мають високий рівень тривожності та не люблять ризикувати. Отже, їм важко конкурувати на ринку праці із людьми, які відносяться до екстравертів. Досліджувані з вираженою екстраверсією, у свою чергу, більш легко зав'язують контакти, легкі у спілкуванні та мають тенденцію до лідерства.

Обробка емпіричних даних за методикою «Оцінка рівня конкурентоспроможності особистості» виявила те, що більшість досліджуваних мають низький, визначений у 18 (22,5 %) досліджуваних та середній, встановлений у 30 (40,00 %) безробітних рівні конкурентоспроможності, а високий рівень конкурентоспроможності має лише 8 (10,0 %) досліджуваних із загальної кількості. Нижчий за середній рівень конкурентоспроможності визначено у 9 (11,2 %) досліджуваних, а вищий за середній – у 15 (18,7 %) безробітних. У досліджуваних не встановлено дуже низького рівня, рівня нижчого за середній, рівнів вищий за середній та дуже високого. Отже, можна зробити висновок, що більшість із безробітних мають середній рівень конкурентоспроможності, який в подальшому може вплинути на їх пошук роботи та працевлаштування.

У контексті дослідження рівень конкурентоспроможності досліджуваних характеризує їхній рівень професіоналізму. Дійсно, професіоналізм впливає на конкурентоспроможність особистості. За результатами дослідження опитувальника «Мотивація успіху та страх невдач» О. Реана отримано такі результати: 18 (22,5 %) досліджуваних мають виражену мотивацію до невдачі; у 9 (11,2 %) безробітних мотиваційний полюс яскраво не виражений, але при цьому можна вважати мають певну тенденцію мотивації до невдачі; у 30 (40,0 %) досліджуваних мотиваційний полюс яскраво не виражений, але при цьому можна вважати мають певну тенденцію мотивації до успіху; проте у 23 (26,2 %) із загальної кількості досліджуваних виявлена мотивація до успіху. Обробка

емпіричних даних згідно опитувальника «Мотивація успіху та страх невдач» О. Реана виявила те, що у безробітних переважає тенденція мотивації до успіху. При такій тенденції мотивації особистість має можливість досягти чогось конструктивного і позитивного. В основі активності людини лежить надія на успіх і потребу в досягненні успіху. Досліджувані з тенденцією до мотивації успіху і з виявленою мотивацією до успіху зазвичай упевнені в собі, в своїх силах, відповідальні, ініціативні та активні. Їх відрізняє наполегливість в досягненні мети, цілеспрямованість. Отже, у більшості досліджуваних наявна мотивація позитивно впливає на їхню конкурентоспроможність та майбутнє працевлаштування. Досліджувані, в яких рівень мотивації відноситься до мотивації невдачі, характеризуються такими особливостями: починаючи справу вони вже наперед бояться можливої невдачі, також думають про шляхи уникнення цієї гіпотетичної невдачі, а не про способи досягнення успіху. Все це призводить до того, що вони вже не налаштовані до активного пошуку роботи та майбутнє працевлаштування.

Результатами дослідження визначення рівня самооцінки здатності до самовдосконалення, виявлено, що більшість безробітних мають середній рівень самооцінки здатності до самовдосконалення (встановлено у 44 (55,0 %) досліджуваних), рівень нижче за середній визначено у 16 (20,0 %) безробітних, низький рівень встановлений у 12 (15,0 %) безробітних, проте високий рівень встановлено лише у 8 (10,0 %) досліджуваних. У досліджуваних за результатами діагностування не було встановлено показників дуже низького рівня, декілька нижчого за середній і декілька вищого за середній, вищий за середній і дуже високий рівнів. За результати дослідження рівня самооцінки здатності до самовдосконалення у безробітних визначено середній рівень цієї здатності. Отриманий результат впливає на особистість у позитивному напрямку, що допомагає при пошуку роботи, спілкуванні з людьми, надає впевненість у собі та характеризує прагнення бути кращим.

Висновки. Доведено, що більшість безробітних мають середній рівень самооцінки здатності до самовдосконалення (55,0 % досліджуваних), рівень нижче за середній визначено у 20,0 % безробітних, низький рівень встановлений у 15,0 % безробітних, проте високий рівень встановлено лише у 10,0 % досліджуваних. Емпірично підтверджено, що соціально-психологічними чинниками розвитку конкурентоспроможності особистості в сучасному суспільстві є соціальна успішність, рівень професіоналізму особистості, типологічні особливості особистості, мотивація, рівень самооцінки здатності до самовдосконалення.

Список використаних джерел.

1. Бегеза Л.Є. Психологія особистості безробітного/Соціально-психологічний супровід в роботі фахівців служби зайнятості: монографія за заг. ред. Г.А. Пріба; Є.М. Калюжна. Київ: ІПК ДСЗУ, 2020. С. 69–111.
2. Дорожкін В. Р. Соціально-психологічна адаптація внутрішньо переміщених осіб до особливостей сучасного ринку праці / Соціально-психологічний супровід в роботі фахівців служби зайнятості: монографія за заг. ред. Г. А. Пріба; Є. М. Калюжна. Київ: ІПК ДСЗУ, 2020. С. 40–68.
3. Карамушка М. І. Психологічні особливості розвитку соціально активної молоді. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. – Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України. Київ, 2020. 257 с.
4. Кас'янова С. Б. Емоційний інтелект у системі особистісних ресурсів безробітного. Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії у галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 053 «Психологія». Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, Київ, 2020. 309 с.
5. Матвієнко Л. І. Особливості мотивації безробітних із числа внутрішньо переміщених осіб до активного пошуку роботи. Ринок праці і зайнятість в Україні:

реалії та перспективи: колективна монографія / За наук. ред. С. Кожем'якіної, С. Калініної. К.: ІПК ДСЗУ, 2018. 424 с. Розділ 4.1. С.214–221.

6. Мілютіна К. Л. Особливості життєвої стратегії особистості у сфері зайнятості в умовах соціальної нестабільності. Ринок праці та зайнятість населення. К.: ІПК ДСЗУ, 2015, Випуск 2. С. 54–58.

7. Пріб Г. А., Бегеза Л. Є. Професіогенез особистості: соціально-психологічні аспекти. Проблеми сучасної психології. 2019. № 2. С. 102–107.

8. Психологічні детермінанти розвитку організаційної культури: монографія [Електронний ресурс] / Л. М. Карамушка, О. В. Креденцер, К. В. Терещенко [та ін.]; за ред. Л. М. Карамушки. Київ: Педагогічна думка, 2015. 288 с.

9. Психологічний інструментарій для фахівців служби зайнятості: методичні рекомендації / за заг. ред. Г. А. Пріба; Київ: ІПК ДСЗУ, 2019. 152 с.

10. Рибалка В. В. Психологія честі та гідності особистості: культурологічні та аксіологічні аспекти: [наук.-метод. пос.] / В.В. Рибалка. Київ: ТОВ “Інформаційні системи”, 2011. 428 с.

11. Ткалич М. Г. Психологія гендерної взаємодії персоналу організацій : [монографія] / М. Г. Ткалич. Київ-Запоріжжя : ЗНУ, 2015. 315 с.

Особливості ціннісних орієнтацій щодо сім'ї та шлюбу у сім'ях, де є діти з розладами аутистичного спектру

*Царгородська А.О.
Здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти
Академія праці, соціальних відносин і туризму, м. Київ*

Актуальність. Сім'я є центральним осередком формування та реалізації цінностей, які визначають моральні, духовні та соціальні орієнтири особистості. У сім'ях, що виховують дітей із розладами аутистичного спектру (РАС), ціннісні орієнтації набувають особливого значення через високий рівень психосоціального навантаження, зумовленого унікальними викликами виховання таких дітей. Цінності, такі як любов, взаємопідтримка та відповідальність, стають основою для адаптації батьків до складних обставин, сприяючи збереженню сімейної гармонії та психологічного благополуччя. Водночас стресогенні фактори, такі як емоційне виснаження, зміна сімейних ролей чи соціальна ізоляція, можуть ускладнювати реалізацію цінностей, що вимагає цілеспрямованої психологічної підтримки [4]. Актуальність дослідження зумовлена зростанням кількості дітей із РАС в Україні та світі, а також недостатньою увагою до психологічних особливостей сімей, які стикаються з цими викликами. Вивчення ціннісних орієнтацій у таких сім'ях дозволяє не лише зрозуміти механізми їхньої адаптації, а й розробити практичні рекомендації для зміцнення сімейних ресурсів. Теоретичний аналіз і емпіричне дослідження ціннісних орієнтацій дають змогу виявити провідні цінності, що допомагають сім'ям справлятися зі стресом, а також визначити напрями психологічної корекції для профілактики деструктивних змін у ціннісній сфері.

Мета дослідження. Визначення особливостей ціннісних орієнтацій щодо сім'ї та шлюбу у сім'ях, які виховують дітей із РАС, та розробці програми психологічної підтримки для зміцнення їхньої адаптації та гармонії.

Результати дослідження. Цінності є стійкими переконаннями, що визначають мотивацію, поведінку та взаємодію людини із соціальним

середовищем. Вони виконують чотири ключові функції: регулятивну (спрямовують поведінку), мотиваційну (стимулюють досягнення цілей), адаптивну (допомагають долати труднощі) та інтегративну (об'єднують індивідуальні та соціальні аспекти). Ціннісні орієнтації, як похідні від цінностей, є динамічними пріоритетами, що формуються під впливом індивідуального досвіду, соціалізації та культурного контексту [5]. У психологічному контексті цінності розглядаються як основа морально-етичного простору, що допомагає людині приймати рішення та адаптуватися до життєвих викликів. Філософські підходи, такі як аксіологічний (М. Вебер, Т.М. Брагіна), підкреслюють універсальність цінностей, тоді як соціально-психологічний (Є.І. Головаха) акцентує на їхній залежності від соціального середовища, а особистісно-орієнтований (А. Адлер, Дж. Боулбі) – на зв'язку з індивідуальними потребами та емоційними зв'язками [4]. У сім'ях із дітьми з РАС цінності, такі як любов і взаємопідтримка, стають ключовими для подолання психосоціального стресу.

Сім'я є первинним осередком реалізації цінностей, де через виховання, емоційні зв'язки та спільну діяльність формуються моральні та соціальні орієнтири. Однак психосоціальне навантаження, спричинене вихованням дитини з РАС, економічними труднощами чи соціальною ізоляцією, трансформує сімейну структуру та функції [3]. Стрес може призводити до дисбалансу ролей, коли один із батьків бере на себе основну відповідальність за догляд, що послаблює подружню гармонію. Емоційна функція сім'ї зазнає змін через виснаження, а виховна та соціалізаційна функції ускладнюються через брак ресурсів. Водночас цінності, такі як відповідальність і турбота, допомагають сім'ям зберігати згуртованість. Психологічна підтримка, зокрема арт-терапія, тренінги та соціально-педагогічний супровід, сприяє відновленню сімейних функцій і зміцненню ціннісних орієнтацій [2].

Сім'ї, які виховують дітей із РАС, стикаються з унікальними психологічними викликами, такими як хронічний стрес, емоційне виснаження,

тривога, депресія та почуття провини. Модель адаптації Е. Шухардт описує етапи переживань батьків: шок, заперечення, пошук, злість, депресія, примирення та солідарність [5]. Ці етапи відображають динаміку емоційних реакцій, які впливають на ціннісні орієнтації та подружні стосунки. Наприклад, почуття провини може ускладнювати взаємодію із соціумом, а стрес – послаблювати емоційну близькість між партнерами. Ресурси, такі як арт-терапія, інклюзивна освіта та групові заняття, допомагають батькам переробляти емоції та зміцнювати сімейні зв'язки. Динаміка подружніх стосунків залежить від здатності партнерів знаходити спільні цінності та працювати над гармонією, попри стрес [1].

Висновки. Цінності та ціннісні орієнтації є основою психологічного благополуччя та адаптації сімей, які виховують дітей із РАС. Вони виконують регулятивну, мотиваційну, адаптивну та інтегративну функції, допомагаючи батькам долати виклики та зберігати сімейну гармонію. Психосоціальне навантаження, зумовлене вихованням дитини з РАС, трансформує сімейні ролі та функції, але цінності, такі як любов і взаємопідтримка, сприяють адаптації.

Список використаних джерел.

1. Бех І.Д. Духовні цінності в розвитку особистості. Педагогіка і психологія. 1997. №1. С. 124-129.
2. Вознесенська О.Л. Арт-терапія в роботі з сім'ями дітей з особливими потребами: практичні аспекти. Психологічний часопис. 2019. № 5 (25). С. 45–53.
3. Колупаєва А.А. Діти з особливими потребами та організація їх навчання. Київ: Науковий світ, 2021. 260 с.
4. Ходаківська О.М. Психологічні особливості сім'ї з дитиною – інвалідом. Проблеми сучасної психології. 2022. Вип. 5. С. 10.
5. Shuchardt, E. A model of parental adaptation to children with disabilities: The spiral of experiences. Journal of Family Psychology, 2020, Vol. 14, pp. 231–245.

Особливості емоційного реагування осіб, які працюють з групами ризику інфікування ВІЛ

Чумаченко Н.Л.

*Здобувач другого(магістерського) рівня освіти
Академія праці, соціальних відносин і туризму, м. Київ*

Актуальність. Емоції відіграють ключову роль у внутрішній регуляції психічної діяльності та поведінки людини, спрямованої на задоволення актуальних потреб. Вони виступають сигналами про сприятливий або несприятливий розвиток подій, визначають позицію особистості в системі міжособистісних взаємин і забезпечують корекцію поведінки в умовах спілкування та професійної діяльності.

Актуальність теми зумовлена тим, що окремі емоції можуть мати деструктивний вплив на поведінку особистості в соціумі. Тому важливо навчитися керувати емоціями, аби запобігти руйнуванню міжособистісних зв'язків. Це особливо важливо для фахівців, які працюють з групами підвищеного ризику інфікування ВІЛ. Емоції становлять одну з найдавніших форм психічної активності людини, що виникла на ранніх етапах еволюційного розвитку. Засновник експериментальної психології Вільгельм Вундт підкреслював надзвичайну різноманітність емоційних переживань, зазначаючи, що кількість відтінків емоційного тону перевищує 50 000, що значно перевищує лексичні можливості природної мови для їх точного опису [1]. У межах теорії диференціальних емоцій, запропонованої Керролом Ізардом, емоції розглядаються як базові психофізіологічні системи, що формують мотиваційну основу людської поведінки. Автор виокремлює десять фундаментальних емоцій, які мають універсальний характер і відіграють ключову роль у регуляції адаптивної активності індивіда: радість, смуток, гнів, відраза, презирство, страх, сором, зніяковілість, провина, подив та інтерес [2]. Наукові дослідження емоційної сфери особистості проводили такі вчені, як Л. С. Виготський, Є. Л.

Ільїн, А. С. Нікіфоров, В. К. Вілюнас, Б. І. Додонов [3; 4; 5; 6; 7]. Проте питання управління емоціями залишається недостатньо вивченим. Зокрема, не визначено чітко, чи є тотожними поняття «регуляція емоцій», «саморегуляція» та «управління емоціями», а також чи має управління емоціями власні складові або є частиною емоційного інтелекту. У зв'язку з цим, дана робота присвячена теоретико-методологічному та практичному аналізу психологічного феномену управління емоціями.

Мета дослідження. Дослідити особливості емоційного реагування та рівень емоційного вигорання у працівників, які працюють з групами ризику інфікування ВІЛ, а також розробити тренінгову програму та надати психологічні рекомендації щодо розвитку навичок управління емоціями. *Методи та матеріал дослідження.* Базою дослідження став обласний центр профілактики ВІЛ-інфекції та боротьби зі СНІДом. У дослідженні взяли участь 100 осіб (80 жінок, 20 чоловіків), які працюють в умовах підвищеного ризику інфікування ВІЛ. З усіх обстежених стаж до 5 років мають 25 осіб, від 3 до 5 років – 30 особи, понад 5 років – 45 осіб. Дослідження виконувалося за допомогою: методика діагностики «перешкод» у встановленні емоційних контактів В. В. Бойка (фактори: невміння управляти емоціями, неадекватний прояв емоцій, «негнучкість» емоцій, домінування негативних емоцій, небажання зближуватися з людьми); методика «Діагностики рівня емоційного вигорання»; методика «Визначення психічного «вигорання»; методика «Синдром «вигорання» в професіях системи «людина – людина».

Результати дослідження. Здатність до емоційної саморегуляції є важливим чинником ефективної комунікативної взаємодії серед осіб, які працюють в умовах ризику інфікування ВІЛ. Зокрема, 68,0 % респондентів зазначили, що емоції не перешкоджають їхньому спілкуванню, 14,0 % повідомили про наявність труднощів у повсякденній комунікації, а 18,0 % вказали на суттєве ускладнення соціальної взаємодії внаслідок емоційних чинників. Серед основних бар'єрів у встановленні емоційних контактів було ідентифіковано такі: невміння керувати

емоціями та їх дозування – виявлено у 20,0 % досліджуваних; домінування негативних емоцій – у 16,0 %; неадекватне емоційне вираження та емоційна закритість – у 12,0 %; емоційна негнучкість, нерозвинутість та невиразність – у 8,0 %.

Застосування методики для діагностики рівня емоційного вигорання дозволило встановити, що 72,0 % респондентів не мають ознак синдрому емоційного вигорання. Водночас 10,0,0 % осіб демонструють середній рівень емоційного виснаження, 14,0,0 % – високий рівень, а 4,0 % – критичний рівень, що свідчить про необхідність психологічної підтримки та інтервенцій. Аналіз окремих симптомів емоційного вигорання показав, що їх повна відсутність варіюється в межах 58–88,0 % залежно від типу симптому. Найменш вираженими серед досліджуваної групи є такі прояви, як: тривожність і депресивні стани, емоційний дефіцит, відчуття «загнаності у кут», незадоволеність собою, емоційне відчуження. Ці симптоми спостерігаються у 12–18,0 % респондентів. Особливу увагу слід приділити психосоматичним та психовегетативним порушенням, які виявлено у 42,0 % досліджуваних. З них у 10,0 % симптоми перебувають на стадії формування, а у 32,0 % – вже сформовані. Вони проявляються на рівні фізичного та психічного самопочуття і, як правило, мають умовно-рефлекторну природу, що пов'язана з негативними емоційними реакціями на професійні стресори. У процесі дослідження було виявлено, що одним із провідних симптомів, які безпосередньо корелюють із рівнем сформованості навичок емоційної саморегуляції, є неадекватне вибіркове емоційне реагування. Цей симптом зафіксовано у 38,0 % респондентів і розглядається як достовірний маркер синдрому емоційного вигорання. Його прояв полягає у втраті здатності розрізняти між адаптивним економним проявом емоцій та дезадаптивною емоційною реакцією, що є ознакою порушення емоційної регуляції.

У 28,0 % осіб, які працюють в умовах ризику інфікування ВІЛ, спостерігаються такі симптоми: переживання психотравмуючих обставин,

розширення сфери емоційної економії, деперсоналізація, що свідчить про глибокі зміни в емоційно-особистісній сфері.

Серед домінуючих компонентів синдрому емоційного вигорання було ідентифіковано наступні критичні прояви: психосоматичні та психовегетативні порушення – у 26,0 % досліджуваних; неадекватне вибіркове емоційне реагування – у 14,0 %; особистісне відчуження та деперсоналізація – у 12,0 %.

Отримані результати свідчать про високий рівень емоційного навантаження серед працівників, які функціонують у професійних умовах з підвищеним ризиком інфікування ВІЛ, та підтверджують необхідність впровадження системних заходів психологічної підтримки, спрямованих на розвиток навичок емоційної саморегуляції та профілактику емоційного вигорання. Результати дослідження, проведеного за методикою «Визначення психічного вигорання», засвідчили, що високий рівень психічного вигорання на робочому місці спостерігається у 6,0 % респондентів, а критичний рівень – у 16,0 %. У 30,0 % досліджуваних, які демонструють виражені ознаки психоемоційного виснаження, симптоматика проявляється на трьох системно-структурних рівнях: емоційному, когнітивному та поведінковому.

Дані, отримані за методикою «Синдром вигорання в професіях системи «людина–людина», демонструють високий ступінь кореляції з результатами діагностики емоційного вигорання. Зокрема: низький рівень емоційного виснаження (емоційний дефіцит, емоційне відчуження, неадекватне вибіркове емоційне реагування) виявлено у 72,0 % респондентів; середній рівень – у 16,0 %; високий рівень – у 12,0 %. Аналогічна динаміка простежується щодо деперсоналізації: низький рівень (особистісне відчуження, особистісне віддалення) – у 74,0 %; середній рівень – у 14,0 %; високий рівень – у 12,0 %.

Щодо редукції особистих досягнень: низький рівень (зниження професійної мотивації, редукція професійних обов'язків) – у 78,0 %; середній рівень – у 10,0 %; високий рівень – у 12,0 %.

Загальна картина свідчить про те, що значна частина працівників перебуває на різних стадіях емоційного вигорання та демонструє недостатній рівень сформованості навичок емоційної саморегуляції. Кореляційний аналіз підтвердив статистично значущу залежність між рівнем емоційного самоконтролю та проявами професійного вигорання. Зокрема, коефіцієнт кореляції між деперсоналізацією та емоційною саморегуляцією становить $r = 0,81$, а між особистісним віддаленням – $r = 0,75$. Особливу увагу слід приділити симптому неадекватного вибіркового емоційного реагування, який має високу кореляцію ($r = 0,94$) з рівнем емоційної саморегуляції. Цей симптом вказує на втрату здатності розрізняти між економним проявом емоцій (як формою адаптивної стриманості) та неадекватною емоційною реакцією, що є ознакою дезадаптації. У професійному контексті така поведінка може бути сприйнята оточуючими як негативне ставлення, що провокує фрустрацію серед пацієнтів і колег. З метою профілактики розвитку зазначених симптомів доцільно впроваджувати програми розвитку антистресових навичок, емоційної грамотності, а також критичного аналізу ситуацій, що дозволяє уникати імпульсивного прояву негативних емоцій у професійному середовищі. Формування навичок конструктивного емоційного реагування є ключовим чинником збереження психічного здоров'я та професійної ефективності працівників, які функціонують в умовах підвищеного ризику інфікування ВІЛ.

Висновки. У межах дослідження здійснено теоретичний аналіз сучасного стану наукової розробки проблеми емоційного реагування, зокрема синдрому професійного вигорання, а також механізмів формування навичок емоційної саморегуляції у фахівців, які працюють із представниками груп підвищеного ризику інфікування ВІЛ. На основі теоретичних положень розроблено програму тренінгових занять, спрямовану на зниження негативних проявів емоційного реагування в професійній діяльності та розвиток конструктивних навичок управління емоціями. Програма включає психологічні рекомендації щодо профілактики емоційного виснаження та підвищення емоційної компетентності

працівників. У ході емпіричного етапу дослідження проведено кореляційний аналіз взаємозв'язку між рівнем сформованості навичок емоційної саморегуляції та проявами емоційного вигорання у професійній діяльності. Результати експериментального дослідження підтвердили висунуту гіпотезу: недостатній рівень уміння управляти емоціями є значущим чинником розвитку синдрому професійного вигорання серед осіб, які працюють в умовах ризику інфікування ВІЛ.

Список використаних джерел.

1. Пов'якель Н. С. Емоційний інтелект як основа психологічного здоров'я особистості. Психологічні перспективи. 2021. № 37. С. 85–91.
2. Goleman D. Emotional Intelligence. New York: Bantam Books, 1995.
3. Mayer J. D., Salovey P. Emotional Intelligence: Theory, Findings, and Implications. Psychological Inquiry. 1997. Vol. 15 (3). P. 197–215.
4. Голубєва Н. Емоційний інтелект у структурі особистості: теоретичний аспект. Психологічні науки: проблеми і здобутки. 2019. № 3. С. 27–34.
5. Жук А. В., Янчук Т. О. Емоційний інтелект як чинник подолання дистресу у студентів університетів. Березневий науковий дискурс 2024: Детермінанти посилення ролі освіти у формуванні особистості в умовах викликів сьогодення: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 22 березня 2024 р.). Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2024. С. 78–81.
6. Важливі навички в період стресу. Досвід проведення навчання груповому курсу управління стресом для дорослих самодопомога+ (Self-Help+). Психосоматична медицина та загальна практика. 2021. Т. 6, № 2. DOI: <https://doi.org/10.26766/pmgrp.v6i2.427>.
7. Зарицька В. В. Емоційний інтелект як складова готовності особистості до професійної діяльності. Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Серія «Психологія». 2014. № 49. С. 42–51.

Аспекти рольової компетентності, як чинника успішного вирішення особистістю життєвих проблем

Шевченко Н.В.

*Здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти
Академія праці, соціальних відносин і туризму, м. Київ*

Актуальність. Дослідження зумовлене особливою важливістю проблеми життєвої компетентності особистості для сучасного суспільства, що характеризується підвищеним рівнем динаміки і системністю соціальних змін, ускладненням соціальних практик, плюралізацією життєвих стратегій і стилів. У такому мінливому та плинному світі виникає гостра суперечність між, з однієї сторони, новою системою вимог та, з іншої, – можливостями особистості, ускладняється і загострюється проблема особистісного самовизначення. Усе це викликає необхідність формування в особистості життєвої компетентності, а саме рольової компетентності як цілісної інтегративної якості, що системно характеризує її реальну здатність адекватно і відповідально реагувати на стрімкі соціальні зміни та адаптуватись до них, усвідомлювати загрози розвитку людства, враховувати соціальні й індивідуальні потреби і можливості особистісної самореалізації і здійснювати на цій основі відбір способів і засобів досягнення бажаного майбутнього, а також застосовувати набуті знання, уміння й навички адекватно різним життєвим ситуаціям чи то актуальним, чи то перспективним [1–4].

На сьогоднішній час молоде покоління входить у досить непростий соціальний світ, який характеризується постійними змінами, ускладненням соціальних зв'язків, розмитістю критеріїв оцінювання соціального успіху та престижності тощо. Складність сучасних технологій ставить підвищені вимоги до професійної компетентності учасників виробництва, а складність та багатоплановість соціально-культурного життя вимагає високого рівня життєвої компетентності. У такому соціумі молодій людині важко адаптуватись, визначати

власні життєві орієнтири, здобувати відповідний соціальний статус, реалізовувати свої соціальні здібності. Тому, щоб уникнути багатьох ризиків та проблем, які можуть значно послабити життєві позиції сучасної людини, їй потрібно засвоїти основи функціонування соціального світу, бачити його реальний стан, вміти взаємодіяти з ним у конкретних ситуаціях, знаходити в ньому своє місце та відповідати на його очікування, виконуючи соціальні статуси та ролі, прагнути до удосконалення соціальних взаємин та бути готовим до практичних дій, реалізуючи при цьому свої особистісні якості, життєвий потенціал та бажання. Отже, сучасне соціальне життя передбачає, що кожна юна людина повинна бути соціально компетентною особистістю [5–7].

Рольові теорії особистості були сформовані американськими соціологами Жд. Г. Мідом та Р. Мінтоном, а також активно розроблював основні положення Т. Парсонс. Таким чином, рольова теорія особистості оперує двома основними поняттями: соціальний статус та соціальна роль. Г. Блумер також є відомим представником рольової теорії особистості. Структура особистості Я. Л. Морено. Рольова теорія П. П. Горностая особистості базується на понятті локус рольового конфлікту, який визначає основну стратегію поведінки особистості в умовах рольового розвитку. В нашій роботі, а також при плануванні та проведенні дослідження ми спираємось саме на рольову теорію особистості, що побудована на концепції рольового конфлікту та базовому понятті «локус рольового конфлікту», яка має всі ознаки теорії особистості. Вона містить основні необхідні компоненти такої теорії, а також практичні аплікації – концепцію особистісної психопатології в рамках рольової парадигми та систему рольової психотерапії, яка може успішно працювати з такою патологією та рольовою дисгармонією [1–7]. Отже, в сучасних умовах набуття особистістю рольової компетентності стає об’єктивним запитом як індивідуального, так і соціального життя.

Мета дослідження. Дослідити аспекти рольової компетентності, як чинника успішного вирішення особистістю життєвих проблем

Результати дослідження. З метою вивчення рольової компетентності як чинника успішного вирішення особистістю життєвих проблем у дослідженні використано аналіз наукових джерел, опитувальник рольової компетентності П. П. Горностая та методика вивчення динаміки здібностей О. Л. Музики (особистісно-ціннісний компонент). Дослідження проводилось серед студентів, на базі професійно-технічного училища. Вибірка складалась з 24 осіб віком 6–21 років. Для реалізації поставлених завдань і перевірки гіпотези були використані *методи дослідження*, а саме: аналіз літератури, вивчення існуючих методик для вимірювання переживання рольової неоднозначності в поведінці прийняття ролі, опитувальника рольової компетентності П.П. Горностая. Для дослідження успішності вирішення особистістю життєвих проблем використовуємо методику вивчення динаміки здібностей О.Л.Музики, зокрема особистісно-ціннісний компонент.

Під час дослідження ми отримали такий розподіл результатів за опитувальником рольової компетентності П.П. Горностая: встановлено, що за шкалою I дуже високий рівень рольовій компетентності мали 4 досліджених, відповідно високий – 11, середній – 6, низький – 3. Дуже низький рівень рольовій компетентності не виявлено. У свою чергу за шкалою 2 дуже високий рівень рольовій компетентності мали 2 досліджених, відповідно високий – 7 середній – 7, низький – 5. Дуже низький рівень рольовій компетентності у досліджених не виявлено.

Виявлено, що у відсотковому відображенні показники рівня рольової компетентності у досліджених значно відрізняються. Так, низький рівень виявлено за шкалою I у 8,3 %, за шкалою II – 20,8 %. Відповідно середній рівень: 25,0 % та 37,5 %. Високий 45,8 % та 29,2 %. Дуже високий: 16,7 % та 8,3 %. Таким чином, можна зазначити, що у досліджених за шкалою I переважав низький та середній рівень рольової компетентності, за шкалою II високий та дуже високий рівень рольової компетентності.

Визначено, що у досліджених за I шкалою переважає високий рівень 45,8 % рольової компетентності, зокрема рольова гнучкість, чутливості, глибини та властивості до рольових переживань, тобто респонденти здатні розв'язувати життєві проблеми, пов'язані з рольовою поведінкою та з певними труднощами, не завжди легко включаються в процес власної життєдіяльності. У свою чергу у досліджених за II шкалою переважав середній рівень – 37,5 %, що характеризує рольову глибину та властивість до рольових переживань. У досліджених переважав високий рівень рольової компетентності. У свою чергу дуже низький рівень рольовій компетенції у досліджені не виявлено.

Виявлено, що у досліджуваних не спостерігались складнощі при складанні особистісно-ціннісного компоненту. Всі виокремили конкретні якості, за допомогою яких успішно вирішують життєві проблеми та оцінили ступінь розвитку цих якостей у себе. Так, високий рівень успішності вирішення життєвих проблем виявлено у 16 (67,0 %) досліджених. У свою чергу середній рівень успішності вирішення життєвих проблем у 8 (33,0 %) досліджуваних.

Висновки. Встановлено, що досліджувані чітко рефлексують власні уміння та якості, які є актуальними на даний момент часу. Здатність виокремити особистісно-ціннісні компоненти за допомогою яких досягається успіх та здатність адекватно їх оцінити вже свідчать про потенційну можливість успішного вирішення особистістю життєвих проблем. Також виявлено, що досліджувані виокремили перспективні якості, розвиток яких забезпечить ще більший успіх у вирішенні життєвих проблем.

В цілому динаміка рівня рольової компетентності та рівень успішності вирішення життєвих є подібною. Виявилось, що всі досліджувані мають тенденцію до успішного вирішення життєвих проблем. Рольова компетентність дійсно впливає на успішність вирішення особистістю життєвих проблем, але не вдалося відстежити тенденцію – чим вищий рівень рольової компетентності, тим успішніше особистість буде вирішувати життєві проблеми. Отже, гіпотеза

підтвердилась частково. За результатами дослідження розроблено рекомендації для психологів щодо підвищення рольової компетентності особистості.

Список використаних джерел.

1. Горностай П. П. Рольовий конфлікт та проблема вибору // Психологія на перетині тисячоліть.— К.: Гнозис, 2007.— Т.1.— С. 319–326.
2. Горностай П. П. Рольова соціалізація особистості: психотерапевтичний ракурс // Наукові записки Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка.— К.: Нора-Друк, 2001.— В. 21.— С. 91–100.
3. Гофман И. Подання себе іншим у повсякденному житті / І. Гофман / переклад. з англ. та вступ. стаття А.Д. Ковальова. — К.: Преса, 2000.
4. Здібності, творчість, обдарованість: теорія, методика, результати досліджень / За ред. В. О. Моляко, О. Л. Музики. — Житомир: Вид-во Рута, 2006. — 320 с.
5. Келлі Дж. Психологія особистості. Теорія особистісних конструктів. Харків.: Мова, 2000.
6. Мадді С. Р. Теорії особистості: порівняльний аналіз / Пер. з англійської. — К.: Рута, 2002.
7. Personality, roles, and social behavior / Ed. by W. Ickes & E. S. Knowles.— N.Y., etc.: Springer, 1982.— 362 p.

Особистісні чинники, що впливають на вибір стратегії поведінки апліканта у процесі пошуку роботи

Шинкар В.О.

*Здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти
Академія праці, соціальних відносин і туризму, м. Київ*

Актуальність. Принцип детермінізму С.Л. Рубінштейна «будь – яке зовнішнє – тільки через внутрішнє» став основою обговорення проблеми суб'єкта у психології 1990 років. Принцип «зовнішнє через внутрішнє» був у певній мірі пов'язаний з найбільш ранньою концепцією активної особистості за А.Ф. Лазурським – особистості, яка орієнтована на перетворення соціального оточення, активність якої є «міра стійкості суб'єкта до впливів оточуючого середовища та міра впливу на середовище». У свою чергу, у концепції інтегральної індивідуальності (початок 1970) В.С. Мерлін акцентує увагу на моментах самоорганізації та саморозвитку цієї багаторівневої системи. Особливу увагу при цьому приділяється підрівню властивостей особистості, а «особистість характеризує як суб'єкта, який активно перетворює дійсність, тому система її психічних властивостей являється саморегулюючою». На цій основі з'являються варіанти полісистемного підходу у дослідженні людської природи та джерел її активності, «насправді людині притаманні форми активності, що обумовлені і зовнішніми, і внутрішніми джерелами одночасно». Науково-теоретичною основою роботи стали роботи А.А. Волочкова, Н.І. Петрова, Крутінь, М. Туленкова, В.С. Лозниці, О.В. Киричука, Ю.Л. Трофімова, А.К. Осницького, Т.С. Чуйкової, А.К. Альбуханової, Г.В. Залєвського та ін. У роботі мова йдеться не тільки про когнітивну репрезентацію аплікантами соціально – психологічної ситуації безробіття, а й свого внутрішнього світу, за умови різних поведінкових стратегій на ринку праці [1-5].

Мета дослідження. Вивчення особистісних чинників, що впливають на вибір стратегії поведінки апліканта у процесі пошуку роботи.

Результати дослідження. З метою проведення емпіричного дослідження обстежено 100 безробітних осіб. Методи дослідження: порівняння особливостей когнітивної репрезентації проводилося опитувальником «Аплікант», рівня екстра / інтроверсії аплікантів тестом Айзенка, рівень нейротизму тестом «Аплікат», рівень прагнення до самоактуалізації тестом САО, рівень інтернальності/екстернальності методикою діагностики рівня суб'єктивного контролю Дж. Роттера. Кореляційний аналіз проводився методом рангової кореляції Спірмена). Поведінка окремої людини розуміється як вчинки та дії, тобто, зовнішні прояви діяльності, або як видима система певних цілеспрямованих дій, завдяки яким реалізується її внутрішні спонукання. З точки зору психології термін «стратегія поведінки» являє собою зовнішній прояв людської діяльності, у якій простежується конкретна позиція людини, її установка. Активність особистості виявляється як у загальному життєвому тонусі людини, у кількості притаманній їй « життєвої енергії», у ступені прикладених зусиль, так і в її спрямованості. Активність може бути глобальною, спрямованою на пізнання, зміни, перетворення світу в цілому, або ж тільки на конкретні життєві обставини. Активність являє собою вищий, особистісний рівень способу задоволення системи цінностей, в якій інтегруються уявлення особистості про свої потреби, здібності і можливості, пов'язані з рівнем домагань. Внутрішній світ особистості відображується в активності та самореалізації. Індивідуально – психологічні характеристики особистості мають значний вплив на показники її активності. Залежить це від динамічних особливостей психіки. Темперамент не є чимось зовнішнім у характері людини, а органічно входить у його структуру. Від того, як довго особистість здатна бути в активному стані, як швидко вона може переключатися з однієї справи на іншу, чи легко переходить до сну виділяють той чи інший тип нервової системи. Активність як психологічна характеристика темпераменту свідчить про те, наскільки інтенсивно (енергійно) людина впливає

на зовнішній світ та долає перешкоди у досягненні мети (наполегливість, цілеспрямованість, зосередженість).

Саме тип нервової системи багато у чому зумовлюють поведінку особистості у різних життєвих ситуаціях, у тому числі має суттєве значення на активність апліканта в процесі пошуку роботи.

Анатомія діяльності людини та поведінки – мотиваційна сфера – явище, яке посідає досить суттєве місце в життєвій психології людини. Поведінка безробітного, активність пошуку нового місця роботи багато залежить від структури його мотиваційної сфери, а саме від його розуміння сенсу життя.

Мотиваційна сфера особистості – вся сукупність її мотивів, які формуються та розвиваються на протязі її життя. Мотивація – це сукупність спонукальних факторів, що викликають активність особистості та визначають спрямованість її діяльності. Загалом можна твердити, що процес праці мотивований багатьма чинниками. Мотив праці як правило є інтегральним. Але, залежно від скерованості особистості, від домінуючих у її свідомості цінностей і тих обставин, у яких вона перебуває на даний момент, існує домінуючий, провідний мотив праці. Найкращою буде така система стимулювання до активності безробітних у процесі пошуку роботи, яка забезпечує кожній конкретній особистості комфортні умови життєдіяльності залежно від домінуючих потреб. При вивченні психології активності особистості звертається увага насамперед на такі соціально зумовлені характеристики особистості, як життєва позиція, ціннісна орієнтація, роль мікросоціуму у становленні активної життєвої позиції особистості, вплив «Я»-образу та «Я» – концепції на трудову активність. Життєва позиція особистості не просто характер, її внутрішній світ, а й розкриття міри участі людини у вирішенні суспільних суперечок та використанні цієї активності для власного всебічного розвитку. Активність включає ініціативу, що виходить з потреб, домагання і відповідальність, у формі якої особистість враховує об'єктивну життєву необхідність. Ситуація, у якій знаходиться людина багато у чому визначає рівень

її активності у пошуку роботи. Одна і та ж людина може мати різну поведінку у певній ситуації (наприклад, втрати роботи) залежно від різноманітних обставин: добре / складне матеріальне становище, підтримка/ не підтримка близьких, відповідальність/невідповідальність за когось ще та ін. Самоактуалізація дає людині більшу можливість піднятися над своєю самістю, самовпевненістю, егоїзмом. Самоактуалізуватися – означає стати тією людиною, якою вона може стати, досягти вершини свого потенціалу. Самоактуалізація – це не кінцевий стан, а процес актуалізації своїх можливостей. Реалізація вищих потреб – це фактор душевного здоров'я і благополуччя людини, тому не дивно, що показники буття корелюють з такими усвідомленими рисами і якостями особистості, як нейротизм, психотизм, інтернальність і емоційна стійкість. Юнг вважав, що у кожної людини домінує та або інша особливість, яка в поєднанні з інтро- або екстраверсією індивідуалізує його шлях розвитку.

Висновки. Потреба в самоактуалізації з'являється у здорових людей. Якщо умови життя заважають самоактуалізації, відбувається конфлікт між особистістю та суспільством, і ця незадоволеність породжує неврози. Активна життєва позиція по відношенню до дійсності, вивчення і подолання реальності, а не втеча від неї, здатність бачити події свого життя такими, якими вони є, не використовуючи психологічний захист, розуміння того, що за негативною емоцією приховується проблема, яку необхідно вирішити, готовність йти назустріч проблемам, негативним емоціям, щоб знайти і зняти бар'єри особистісного зростання – усе це дає змогу людині досягти розуміння себе, сенсу життя, внутрішньої гармонії і самоактуалізації. Шлях до самоактуалізації особистості проходить через навчання – професійне чи самонавчання, прагнення до самовдосконалення, розвитку, знаходження свого місця в житті. Одним із значущих мотивів до праці є реалізація потенціалу особистості у професійній діяльності. Робота для людини має велике значення на шляху до її самоактуалізації.

Список використаних джерел.

1. Волочков А.А. Активність суб'єкта як фактор психічного розвитку (гіпотези, моделі, факти), Психологічний журнал, 2024. № 3, т. 24. С.25–41.
2. Ринок праці України у 2020 році, Аналітично-статистичний збір., К.: ДЦЗ, 2020.
3. Киричук О.В., Блажкун Т.Д. Критерії та показники активності аплікантів у пошуку роботи, – бюлетень, К.: ІПКДСЗУ, № 2, 2003. С.27–29.
4. Киричук О.В. Психологія особистості. – К.: ІПКДСЗУ, 2003. 243 с.
5. Осницький А.К., Чуйкова Т.С. Саморегуляція активності суб'єкта у ситуації втрати роботи – Для тих, хто працює з безробітними. Випуск № 3/ під ред. В.А. Шугайло: Дніпропетровськ, 2011. 156 с.

Наукове видання

МЕНТАЛЬНЕ ЗДОРОВ'Я ТА ЖИТТЄСТІЙКІСТЬ ОСОБИСТОСТІ

Монографія

За загальною редакцією

Г.А. Пріба, Л.Є. Бегези

Матеріали друкуються в авторській редакції.

*Автори несуть відповідальність за достовірність фактичних
даних і мовностилістичний рівень матеріалів.*

Формат 60x84/16.

Папір офсетний Рукопис. друк. 23,5 арк.

Тираж 100 примірників.

Підписано до друку 20 січня 2026 р.

Надруковано з макету замовника

Друкарня Фізична особа-підприємець Гуляєва В. М.

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 6205

Київська обл., м. Обухів, вул. Стусова гора, 4

067-178-37-97

drukaryk.com